

ORGANIZADORA

PROF^A. MARIA CÉLIA DELDUQUE

PROF^A. SANDRA MARA C. ALVES

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS:

uma coletânea dos trabalhos de
pesquisa de profissionais do SUS



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasília
Programa de Direito Sanitário
Prodisa

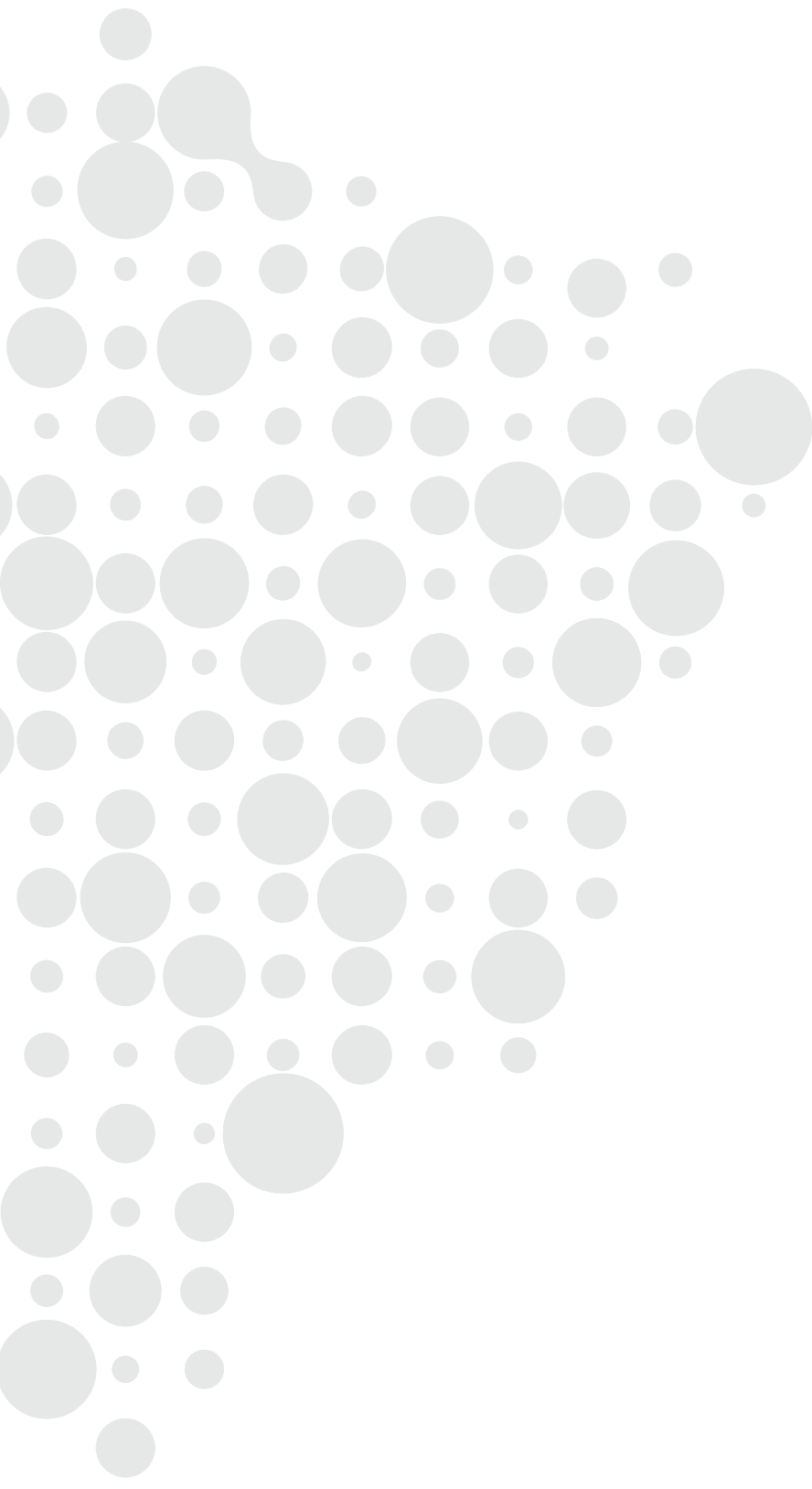


PROADI SUS
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do Sistema Único de Saúde



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS:

**uma coletânea dos trabalhos de
pesquisa de profissionais do SUS**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

A judicialização da saúde nos municípios
brasileiros [livro eletrônico] : uma coletânea
dos trabalhos de pesquisa de profissionais do
SUS / organização Maria Célia Delduque,
Sandra Mara C. Alves. -- Brasília, DF :
CONASEMS, 2023.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-85-63923-46-2

1. Administração municipal - Brasil 2. Direito
à saúde - Aspectos constitucionais - Brasil
3. Saúde pública 4. Serviços de saúde - Administração
5. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Delduque,
Maria Célia. II. Alves, Sandra Mara C.

23-181879

CDU-34:351.77(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Saúde : Direito 34:351.77(81)

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

Esta publicação é fruto de parceria entre o Hospital do Coração (Hcor) por meio do PROADI-SUS, o CONASEMS e o Programa de Direito Sanitário da FIOCRUZ-Brasília, com o apoio do Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS

Wilames Freire Bezerra - Presidente

Charles Cézar Tocantins - Vice-Presidente

Cristiane Martins Pantaleão - Vice-Presidente

Hcor - Associação Beneficente Síria

Alexandre Biasi – Superintendente de Ensino e Pesquisa

Joslene Menezes Rodrigues – Gerente Executiva de Responsabilidade Social

Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do Instituto de Ensino

Prodisa-Fiocruz

Sandra Mara Campos Alves - Coordenadora

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS: uma coletânea dos trabalhos de profissionais do SUS

ORGANIZAÇÃO

Maria Célia Delduque

Sandra Mara C. Alves

REVISÃO TÉCNICA

Ana Carolina da Gama Galdino

Fernanda Vargas Terrazas

EDIÇÃO

Mariana de Queiroz Pedroza

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Sense Design & Comunicação

REVISÃO DE PORTUGUÊS

Karla Amorim Sancho

GESTORES DO PROJETO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SANITÁRIO COM ÊNFASE EM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Hcor

Bernardete Weber

Cynthia Helena Merlin

Flávia Saraiva Leão Fernandes

CONASEMS

Fernanda Vargas Terrazas

Prodisa-Fiocruz

Maria Célia Delduque,

Maria Ester S.N. Rodrigues

Sandra Mara Campos Alves

AUTORES

Adriana de Lima Costa

Adriana Falcão Raposo

Adriana Martins de Paula

Alessandra Aparecida Farias

Alex Rodrigues Freitas

Alex Vinícius Nunes Novaes Machado
Alexandre Lencina Fagundes
Alexandro Figueiredo Rosas
Alexsandra da Rocha Fontes
Alice Buss Cruz Ribeiro
Aline Correia dos Santos
Amanda de Andrade Lima
Amanda Medeiros
Amarildo de Sousa
Ana Paula Custódio Carneiro
André Luiz de Lima Vaz
Andrei Popovski Kolaceke
Anna Katarina Lima Pinheiro de Galiza
Anselmo Barbosa Oliveira
Antonio Julio Dias Junior
Antônio Williams Vieira Vaz
Arlete do Monte Massela Malta
Bárbara Florêncio
Bárbara Puel Broering
Bruna Fontenele de Oliveira
Camilla Cristina de Oliveira Nunes
Carla Beatriz da Silva Rodrigues
Carla Patricia Batista dos Santos
Carlos Rodrigues Galvão Júnior
Carlla Ribeiro Portugal da Silva
Carilane Laranjeira Tomiello
Carolina Albina do Nascimento
Carolina Souza Andrade Licio
Caroline de Castro Feller
Clarissa Almeida do Nascimento
Clécio Pereira Lima

Cledemário Raphael Cursino de Brito Jorge
Clésio Alves da Silva
Cristiane Cruz dos Santos Mello
Cristiane e Silva Santos
Cristina Elias Maroun
Cydia Emy Pereira Ribeiro
Daniela Costa dos Santos
Daniela Minetto
Danielle Moraes Gomes
Darliana de Almeida Oliveira
Dayane da Silva Lima
Diego Maurício Portela Dutra
Diogo Demarchi Silva
Diogo Nobrega Correa Lima
Diogo Rogers Pantoja Ferreira
Djan Barbosa de Freitas
Elaine Cristina Toni Xavier
Eliete Silva Nunes
Elisiane Bello Jakybalis
Eloise Fragnani Medeiros
Eunice Alves Mascarenhas
Éric Dantas Azevedo
Érlin Rasniévski
Estefferson Darley Fernandes Nogueira
Evaldo Eufrásio Vasconcelos
Fabiana Francisca Tavares Bezerra
Felipe Paulino Alves Soares
Fernanda Cardoso da Silva Feijó
Fernanda Marroco
Fernando Rocha
Flávio Henrique Falcão Araújo

Francisco das Chagas Teixeira Neto
Francisco Glérison Vieira
Francisco José Leal de Vasconcelos
Gerald Saraiva Silva de Sordi
Geraldo Jorge Filho
Guilherme Bampa Taiar
Guilherme Davi da Silva
Guilherme de Andrade Lima
Grasiela Pomini
Gustavo Vasconcelos Tannus
Heleneide Henrique Soares
Henriete Santos
Henrique Luis Follador
Heryland Martins
Indaiára Viero Perazzoli
Indangélica Ribeiro
Isabelle Lins Filgueiras Almeida
Izaura do Bomfim Oliveira Ferreira
Jackson Luis Arpini
Jaelia Campos Meireles Damasceno
Jaqueline de Carvalho Peçanha
Jefferson Celli Honório
João Rodrigues Neto
João Vitor Burgos Mota
José Alfredo Curado Fleury Júnior
Joselisses Abel Ferreira
Josivan Carneiro Garcês
Jucyara Apollyana Gomes Ramos
Juliana Gonçalves Oliveira
Juliana Pereira Nascimento Pedroza
Jussinaldo Duarte Santos

Kaoye Guazina Oshiro
Karen Cristina Giraldi Uhlick
Kátlei Magáli Kussler
Kênia Silveira Carvalho
Larissa Maria Kerber
Leonardo Alves Vilarino
Leonardo Campos Simões
Lícia Mara Nascimento de Vasconcelos Fidelis
Lidia Maria Dantas
Lidiane Nascimento Cassimiro
Lilian Soares Gozi Scarpelli Ferro
Lorena Rodrigues de Oliveira
Lorrayna Magenski
Luciana Emília de Carvalho Torres Galindo Coutinho
Luciana Lima Pinheiro Caúla Reis
Luciana Rodrigues Pereira
Luciane Curtinovi Nunes
Luís Eduardo Ferreira Falcão
Luiz Marcelo Cabral Tavares
Luiz Octávio Martins Mendonça
Lydiane Karla Lôbo Marques
Magaly Botelho Lemes Lopes
Mara Eny Azevedo Amaral Braga
Marcel Jandson Menezes
Marcelo Almeida Fonseca Azevedo
Marcelo Poeys Dair
Márcia Ferreira Leite Pereira
Márcia Lúcia de Souza Lima
Márcio Rogério Silva Barros
Marcondes Soares Vanderlei
Marcos Antonio Maestri Miguel

Marcos Hiago do Nascimento Oliveira
Marcos Sena da Silva
Marcus Senna Calumby
Maria Angélica Benetasso
Maria Carolina F. de Lima
Maria Cláudia Mulinari
Maria Cristina da Silva Rocha Ferreira
Maria do Socorro Araújo Cunha
Maria Emília Pereira Pinheiro Fonseca
Maria Ermínia Ciliberti
Maria José Machado de Souza
Maria Lucilene Ribeiro das Chagas
Mariane Cristina Ciota
Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Mário Victor da Silva Bomfim Oliveira
Mariza Kalix de Miranda
Maycon Lucena Paulo
Mayra Kelly Pereira da Silva Rosa
Michelle Pimentel da Silva Dutra
Michelly Poliana Viguiato Pricinotto
Míriam Fabiana Rodrigues da Cruz Riberio
Mona Lisa dos Santos Góes
Mônica de Oliveira Lima
Murilo Evangelista Barbosa
Murilo Silveira Soares dos Santos
Myllena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira
Nicoli Prado Bugoni
Nivaldo Izidoro Alves Junior
Patrícia da Silva Ferreira
Patrícia Marques Magalhães
Paulo Roberto da Silva Abrahao

Pedro Paulo Chrispim
Raul Sousa Silva Jr
Renata de Melo Belarmino
Ricardo Venero Soares
Rodrigo César de Moura Castro Alves
Rodrigo Macedo Dantas
Rogério Rodrigues de Mendonça
Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior
Rondinelly da Silva e Souza
Rubens Griep
Sabrina Nascimento de Freitas
Sandro Rogério Cardoso de Paulo
Sebastião Quaresma Júnior
Selene Umeda Teruya
Sergio Missirian
Sidnei Louro Jorge Júnior
Silvia Luciane Machado de Oliveira
Simone Aparecida Gonçalves Soares de Souza
Simone Cortez de Sena
Suzy Oliveira Ribeiro
Sheila Salvino
Sylvia Patrícia Dantas Pereira
Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior
Tatiana Favorito
Tenille de Azevedo Ramos
Terezinha Rêgo
Thais Gaspar dos Reis Ferreira
Thaís Silva de Moura Barros
Thaíse Dias Soares Santos
Veruska Queiroz de Castro
Valéria Alexandrina Silva Batista

Vanderlei Silva
Vanessa da Silva Veiga
Vanessa Siqueira Aquiar
Vinícius de Paula Gonzaga
Viviane Augusta Maciel Baltar
Viviane Gonçalves Carneiro de Souza
Viviane Paula Fiorentin
Zuila Jaqueline Lima Montel

ORIENTADORES/SUPERVISORES

Cássia de Fátima Rangel Fernandes.
Gisele de Jesus Silva
Ivan Pricken de Bem
Leticia Cabrini Girotto
Letícia de Oliveira Fraga
Luciane Anita Savi
Maria Ione Silva Barros
Moacyr Rey Filho
Sandra Mara Campos Alves.
Tarsila Costa do Amaral

Apresentação

A judicialização da saúde em nível municipal vem apresentando números cada vez maiores de demandas judiciais, reclamando medicamentos e outros insumos para a saúde. Isso implica um crescente desembolso de recursos municipais, sempre escassos, criando a urgência na capacitação dos gestores e trabalhadores municipais de saúde para o enfrentamento desse fenômeno. O CONASEMS apontou para essa necessidade e o Ministério da Saúde, atento à demanda, firmou parceria com a Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração (HCor) objetivando a execução de projeto de capacitação em Direito Sanitário, no âmbito do PROADI-SUS. O CONASEMS atuou na qualidade de parte interessada e a Fundação Oswaldo Cruz, como instituição de ensino responsável pela certificação do curso.

Desse esforço surgiu o Curso de Especialização em Direito Sanitário para gestores e trabalhadores do SUS com ênfase em judicialização da saúde. A oferta foi iniciada em 2019 para 250 alunos de nível superior, especialmente aqueles que atuavam na área jurídica ou da saúde das secretarias municipais e estaduais de saúde ou de seus conselhos representativos, abrangendo todas as regiões do país.

O curso teve sua conclusão em 2020, com a avaliação de um Projeto de Intervenção por uma banca de examinadores. No referido projeto os especializandos – além de conhecer o território em que se daria a intervenção – igualmente analisaram a judicialização em cada município estudado, a fim de gerar um diagnóstico da situação. O intuito foi o de propor uma forma de enfrentamento, capaz de diminuir o acúmulo de determinações judiciais em desfavor do município na área da saúde.

Sabe-se que um curso de pós-graduação não agrega apenas conhecimentos ao con-
cluente. De modo mais sutil, opera em nível individual como um aumento da auto-
estima e autoconfiança. É capaz de fazer o egresso estar disposto a dar saltos de qua-

lidade em sua atividade profissional e propor alternativas a problemas no âmbito da saúde do seu município e estado.

O curso foi uma experiência exitosa. Com metodologia de ensino semipresencial, pôde promover nos alunos uma postura crítica quanto à judicialização da saúde, especialmente no nível municipal. Além disso, desenvolveu uma maturidade para o enfrentamento de meses de dedicação ao curso, ao tempo em que eram estimulados a propor soluções para as demandas judiciais em desfavor dos municípios estudados, com base nos marcos teóricos e ensinamentos metodológicos que absorviam no decorrer do curso.

Fruto desse esforço conjunto entre corpo docente, discente, conteudistas, tutores e pessoal de apoio foi a conclusão de 30 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) aprovados perante examinadores convidados, que com escrutínio acadêmico avaliaram as pesquisas sob os parâmetros exigidos nas escolas mais reconhecidas do país, como a Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela certificação dos concluintes.

Ao estudar a judicialização da saúde, no âmbito municipal, o curso promoveu o maior número de estudos sobre o tema nas municipalidades já produzidos academicamente, com a vantagem de haver sido utilizada uma metodologia única aos 30 trabalhos, o que oportuniza a comparação entre cidades e o conhecimento dos artifícios de enfrentamento de cada um deles.

Mas algo tão grandioso e importante não é feito por profissionais isolados e desconectados. Por isso, consideramos importante citar e agradecer a todos os professores/conteudistas que com desprendimento e compromisso construíram as bases teóricas do aprendizado, aos tutores/orientadores que ao longo de vários meses acompanharam os alunos na honrosa missão de ensinar. Um agradecimento a Profa. Maria Célia Delduque, que soube fazer a regência dessa enorme equipe de executores do projeto, coordenando cada etapa do curso.

Um agradecimento ao HCor, nomeadamente a Dra. Bernardete Weber, a Dra. Cynthia Helena Merlin e Dra. Flávia Saraiva Leão Fernandes pela presteza, competência e cordialidade com nossos gestores municipais, em momento de aprendizagem e crescimento.

Não se pode deixar de agradecer o empenho da Fundação Oswaldo Cruz Brasília, por sua diretora, a Dra. Fabiana Damásio Passos, por seu compromisso em apoiar o curso e certificar os concluintes.

Uma palavra de agradecimento especialíssimo a Dra. Fernanda Terrazas, assessora jurídica do CONASEMS, por sua perspicácia e visão estratégica ao defender, meses antes, a realização desse curso e os objetivos que deveriam ser alcançados.

Da mesma forma, nossos especiais agradecimentos ao Ministério da Saúde por, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES), entender a importância desse projeto e apoiar a sua realização.

O livro que ora chega aos interessados e estudiosos no tema da judicialização no âmbito do SUS, está sendo oferecido ao público pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) com muita honra e alegria, na certeza que seus ensinamentos e experiências relatadas servirão como guia a todos os municípios o Brasil.

Wilames Freire Bezerra

Presidente do CONASEMS

Sumário

Apresentação	13
Capítulo 1 – Região Norte	18
Município de Manaus-AM	19
Município de Paragominas-PA	43
Município de Rio Branco-AC	61
Capítulo 2 – Região Nordeste	79
Município de Aracajú-SE (1)	80
Município de Aracajú-SE (2)	97
Município Cabo de Santo Agostinho-PE	108
Município de Campina Grande-PB	125
Município de Eunápolis-BA	142
Município de Juazeiro do Norte-CE	156
Município de Natal-RN	169
Município Nossa Senhora do Socorro-SE (1)	194
Município Nossa Senhora do Socorro-SE (2)	212
Município de Parnaíba-PI	232
Município de Patos-PB	247
Município de Recife-PE	268
.....	

Município de Salvador-BA	285
Município de São Luís-MA	311

Capítulo 3 – Região Sul **337**

Município de Canoas-RS	338
Município de Curitiba-PR	355
Município de Fraiburgo-SC	370
Município de São Bento do Sul-SC	384
Município de São José-SC	411

Capítulo 4 – Região Sudeste **439**

Município de Catanduva-SP	440
Município de Divinópolis-MG	463
Município de Rio de Janeiro-RJ	526
Município de Vila Velha-ES	543

Capítulo 5 – Região Centro-Oeste **568**

Município de Bataguassu-MS	569
Município de Goiânia-GO	589
Município de Campo Grande-MS	631
Município de Jataí-GO	654

Capítulo 1

REGIÃO NORTE

Município de Manaus-AM

Município de Paragominas-PA

Município de Rio Branco-AC





A judicialização na saúde no Município de Manaus/AM: propostas de enfrentamento

Arlete do Monte Massela Malta¹

Carolina Albina do Nascimento²

Cledemário Raphael Cursino de Brito Jorge³

Eunice Alves Mascarenhas⁴

Francisco das Chagas Teixeira Neto⁵

Luiz Octávio Martins Mendonça⁶

Marcos Antonio Maestri Miguel⁷

Orientador: Prof. MSc. Ivan Pricken de Bem

A escolha de Manaus como cenário para uma proposta de intervenção ocorreu pelo fato de ser um município de grande porte, por estar inserido na Região Norte, onde existem muitas limitações do ponto de vista estrutural, logístico, com grandes barreiras geográficas, dificuldades de fixação de mão de obra especializada e enormes extensões territoriais que, por muitas vezes, isolam totalmente alguns municípios.

¹ Graduada em Direito pela UNIP – SP e Medicina pela UMC–SP. Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela AMB e pós-graduada em Direito Médico, Direito Sanitário, Perícias Médicas e Medicina Legal pela FCMS-CSP. Assessora Técnico- Jurídica na SMS do município de Itapevi/ SP.

² Graduada em Direito pela UNESC. Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela UNESC-ES. Auxiliar Administrativo da SMS de Cariacica/ES.

³ Graduado em Direito e pós-graduado em Direito Público pela ACES. Assessor Jurídico da SMS de Arcoverde-PE.

⁴ Graduada em Enfermagem pela UFAM e Direito pelo CIESA. Pós-graduada em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde pela FGV e em Direito Tributário e Legislação de Impostos pelo CIESA. Assessora Jurídica da SMS de Manaus-AM.

⁵ Graduado em Enfermagem e Pedagogia pela UVA-CE. Pós-graduado em Administração de Serviços de Saúde e Saúde Pública pela UNAERP. Mestre em Ciências da Saúde pela UFT. Doutorando em Saúde Pública pela UCES Buenos Aires-Argentina. Coordenador de Vigilância em Saúde no Município de Brasília-TO.

⁶ Graduado em Direito pela UNIRIO, pós-graduado em Direito das Famílias e das Sucessões pela PUC-Rio. Mestrando em Saúde Coletiva pela UERJ. Assessor Especial da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde da SES do Rio de Janeiro-RJ.

⁷ Graduado em Educação Física pela UDESC e Direito pela UNOESC. Procurador do município de Fraiburgo-SC.

Por todo este conjunto de desafios, os autores optaram por utilizar como cenário de práticas o município de Manaus.

A metodologia para a elaboração do projeto de intervenção utilizou para a pesquisa documental bases acadêmicas consolidadas como Google Acadêmico, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para a busca de dados demográficos, judiciais e de saúde foram utilizadas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde (MS) por meio das bases do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Tribunal de Justiça do Amazonas e suas respectivas Comarcas, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) e os Sistema de Informações do Ministério da Saúde tais como: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC); Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Em setembro de 2018, foi inaugurado o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS), por meio de um convênio entre o município de Manaus e o Tribunal de Justiça do Amazonas, sendo um integrante do setor jurídico da SEMSA o Presidente do NAT-JUS.

Desse modo, a partir da criação do núcleo, as demandas que envolvem a saúde, são direcionadas para o setor específico, formado por uma equipe multidisciplinar.

Na esfera judiciária do Estado do Amazonas, como inexistia vara especializada para conduzir as demandas judiciais na área da saúde, o NAT-JUS se tornou uma ferramenta fundamental no gerenciamento do trâmite das respostas técnicas da SEMSA em relação aos mandados judiciais recebidos.

A origem deste projeto de intervenção partiu do levantamento de processos judiciais sentenciados entre janeiro e dezembro de 2018 disponíveis na base de dados do NAT-JUS. Foram contempladas as seguintes variáveis contidas no banco de dados: representação do autor, prestação de saúde solicitada, sentença proferida e qual serviço fora utilizado, se Justiça Federal ou Estadual.

A partir da observação da realidade encontrada, foram delineadas, de maneira bem objetiva, as características das demandas judiciais no município no ano de 2018, demonstrando a relevância do problema a ponto de ter sido priorizado para a proposição desta proposta de intervenção.

Para a avaliação do conjunto de ações de enfrentamento a serem propostas, foram elaborados indicadores nas três dimensões da intervenção proposta: indicadores de processo, indicadores de resultados e indicadores de impacto.

A elaboração desta proposta de intervenção objetivou principalmente a qualificação permanente das práticas locais, como também a pretensão de sua aplicação futura como uma ferramenta de gestão estratégica pela gestão municipal.

As ações judiciais na realidade do município de Manaus

A judicialização da saúde é uma realidade enfrentada em todo país e a cada ano tem se mostrado crescente, comprometendo significativamente os orçamentos públicos da saúde.

Esse fenômeno é traduzido pela busca do direito à saúde por meio do Poder Judiciário, especialmente quando a tecnologia em saúde pleiteada não está disponível no SUS.

Os reflexos desse fenômeno impactam, tanto o Judiciário quanto o Poder Público e os cidadãos. Para o Judiciário, o impacto se dá porque existe volume crescente de demandas na área da saúde, abarrotando as varas cíveis e de fazenda pública com um número muito grande de processos, comprometendo a tão buscada célere prestação jurisdicional. No Poder Público, o dispêndio de recursos com o pagamento das condenações provenientes de ações dessa natureza é da ordem de bilhões de reais. Para os cidadãos, contribuintes que são, tais recursos poderiam ser revertidos em favor de investimentos na saúde pública.

Vale salientar que o Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, intitulado: “Responsabilidade Solidária dos entes federados, pelo dever de prestar assistência à saúde”, assim decidiu:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (1).

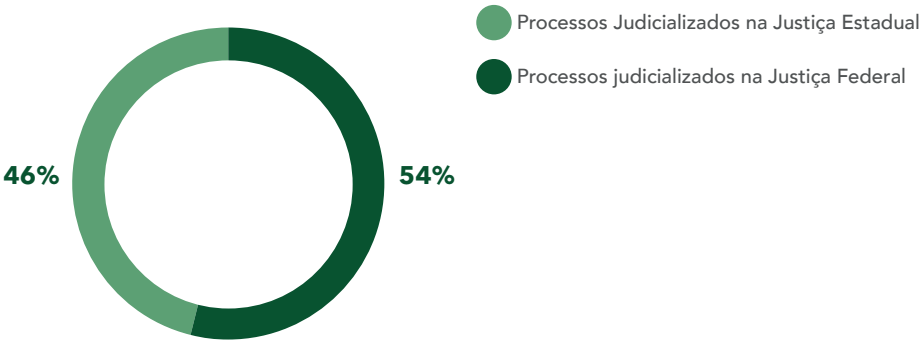
A reafirmação da responsabilidade solidária entre os entes federados trouxe consequências negativas para o município de Manaus, tendo em vista que diferentemente da maioria das capitais do país, Manaus responde tão somente pela atenção básica por sua condição de município. Por essa razão, não possui capacidade instalada capaz de atender as demandas de média e alta complexidade.

É muito comum o município de Manaus ser condenado em demandas judiciais para o fornecimento de tecnologias em saúde para as quais não tem capacidade financeira de executar e nem estrutura logística operacional para o cumprimento da decisão. São muitos os exemplos: medicamentos de alto custo, ausente na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), procedimentos médicos de alta complexidade que emanam a necessidade de profissionais especializados e/ou equipamentos inexistentes no âmbito do município.

A impossibilidade do município de Manaus decorre de sua habilitação que consiste na Gestão Plena da Atenção Básica, feita por meio da SEMSA que desenvolve ações de saúde conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, preconizadas na Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde primária nos termos da Portaria de Consolidação nº 02 de 28 de setembro de 2017 (2).

O Gráfico 1, a seguir demonstra em termos de percentual que no período compreendido de janeiro a dezembro do ano de 2018, o município de Manaus figurou no polo passivo em 85 ações judiciais envolvendo direito à saúde. Dessas, 46 tramitaram na Justiça Federal e 39 na Justiça Estadual.

GRÁFICO 1. Demandas judiciais propostas em desfavor da SEMSA, de janeiro a dezembro de 2018.



Fonte: SEMSA/Manaus.

O Quadro 1, abaixo, apresenta os principais pedidos nas ações demandadas na justiça federal e estadual em desfavor da SEMSA, também no ano de 2018.

QUADRO 1. Objeto material das ações demandadas na justiça federal e estadual em desfavor da SEMSA, no ano de 2018.

JUSTIÇA FEDERAL	
Medicamento	22
Tratamento Fora de Domicílio (TFD)	11
Procedimento Cirúrgico	5
Exames especializados	4
Tratamento Clínico	3
Equipamento de Suporte	1
Total	46
JUSTIÇA ESTADUAL	
Medicamento	12
Tratamento fora de domicílio (TFD)	4
Procedimento cirúrgico	2
Exames especializados	7
Tratamento clínico	3
Internação compulsória	4
Consulta Médica	2

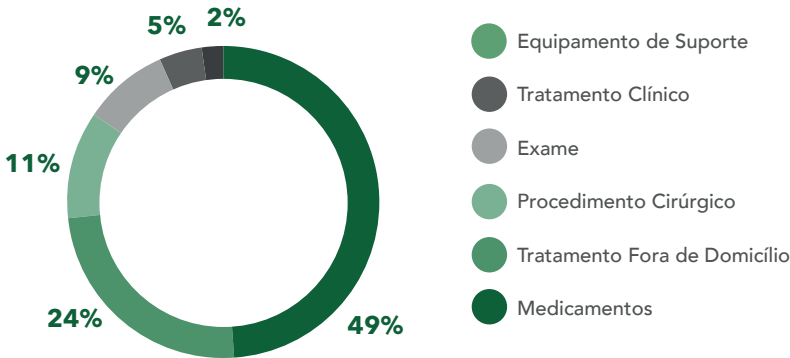
Fornecimento de fralda	2
Transporte adaptado	3
Total	39

Fonte: SEMSA/Manaus.

Em termos proporcionais, a demanda por medicamentos concentra a grande maioria dos pedidos feitos por meio do Poder Judiciário ao município de Manaus. Essa situação repete uma tendência nacional. No gráfico 2 e no Gráfico 3 a seguir, que mensuram a proporção dessas demandas quanto a sua finalidade, a supremacia que a solicitação de medicamentos representa ante aos outros pedidos é considerável. 49% da totalidade dos processos judiciais diz respeito a pedidos por medicamentos que não estão sendo ofertados em caráter regular pelo SUS em Manaus, seja por se tratarem de medicamentos de alto custo, seja por não fazerem parte do RENAME, seja por não estarem regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou mesmo por pertencerem a outros componentes da assistência farmacêutica que são de responsabilidade do Estado e/ou da União.

Na análise qualitativa das ações, cujo pedido versa sobre fornecimento de medicamentos, não foi encontrado prevalência de um medicamento específico, sendo estes de natureza variadas.

GRÁFICO 2. Pedidos ajuizados na Justiça Federal, em desfavor da SEMSA, no ano de 2018.

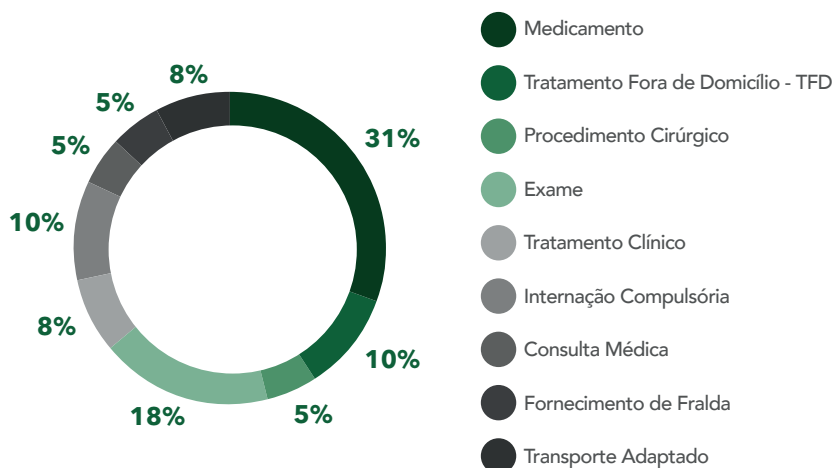


Fonte: SEMSA/Manaus

A situação se repete na instância estadual, a maioria dos pedidos diz respeito a solicitação de medicamentos, 31% do total das demandas.

Por ser mais acessível aos usuários de uma forma geral e mais presente ao seu cotidiano, na Justiça Estadual também surgem demandas mais individualizadas que não aparecem para a Justiça Federal, como a solicitação de fraldas, transporte adaptado para portadores de deficiência, consultas de especialidades médicas e as internações compulsórias para pacientes psiquiátricos.

GRÁFICO 3. Pedidos ajuizados na Justiça Estadual, em desfavor da SEMSA, no ano de 2018.



Fonte: SEMSA/Manaus.

Quanto à representação dos autores nos processos, em razão da impossibilidade de acesso aos sistemas de automação do Poder Judiciário, não foi possível aferir esta variável. Sabe-se, no entanto, que a maioria dos processos tem como patrocinador a Defensoria Pública, seja a estadual e/ou a federal, de acordo com a sua respectiva competência legal. Os cidadãos que buscam as defensorias públicas são hipossuficientes economicamente.

As decisões judiciais proferidas nas ações ajuizadas em 2018, na Justiça Federal e Estadual em Manaus, estão distribuídas em: a) pedido de antecipação da tutela concedido e confirmados na sentença, em grau de recurso; b) pedido de antecipação de tutela concedido,

processo em andamento; c) processos em que foi reconhecida a ilegitimidade do município com prosseguimento do feito; e d) pedido de antecipação da tutela indeferido.

No Quadro 2 é possível verificar detalhadamente quais as principais decisões proferidas.

QUADRO 2. Decisões judiciais, em desfavor da SEMSA, proferidas nas Justiças Federal e Estadual, no ano de 2018.

JUSTIÇA FEDERAL	
Pedido de antecipação da tutela concedida e confirmada na sentença, em grau de recurso.	17
Pedido de antecipação de tutela concedido, processo em andamento.	18
Processos em que foi reconhecida a ilegitimidade do município com prosseguimento do feito.	02
Pedido de antecipação da tutela indeferido.	02
Total	39
JUSTIÇA ESTADUAL	
Pedido de antecipação da tutela concedida e confirmada na sentença, em grau de recurso.	18
Pedido de antecipação da tutela concedida e confirmada na sentença, transitado em julgado.	07
Processos em que foi reconhecida a ilegitimidade do município com prosseguimento do feito.	03
Pedido de antecipação da tutela indeferido.	01
Pedido de antecipação da tutela com posterior indeferimento do pleito.	01
Total	30

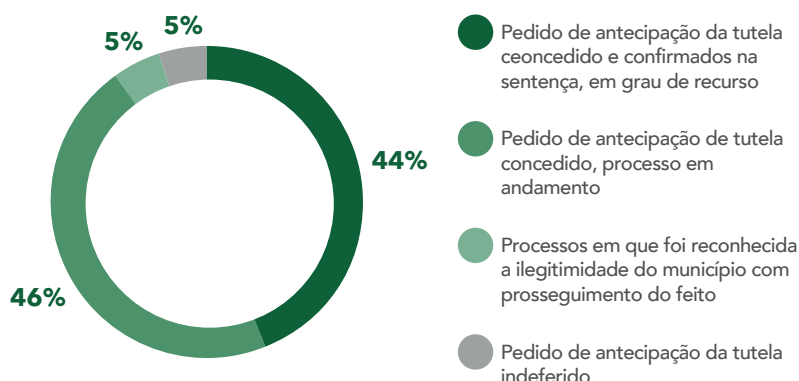
Fonte: SEMSA/Manaus.

Vale destacar que o quantitativo de decisões não corresponde ao número de ações ajuizadas na medida em que alguns processos estão em segredo de justiça e outros foram extintos sem o julgamento do mérito.

Quando foram mensurados os resultados das decisões judiciais em proporções, na Justiça Federal, a grande maioria das manifestações foram por tutela antecipada.

No Gráfico 4 também chama a atenção que, em apenas 5% dos processos, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade do ente município como polo passivo. Isso demonstra que a responsabilidade solidária que atualmente encontra respaldo na jurisprudência do STF ainda não é efetivamente levada em consideração no rol de deliberações da Justiça Federal no município de Manaus-AM.

GRÁFICO 4. Resultado das decisões judiciais que possuíram a SEMSA de Manaus como demandada, na Justiça Federal, no ano de 2018.

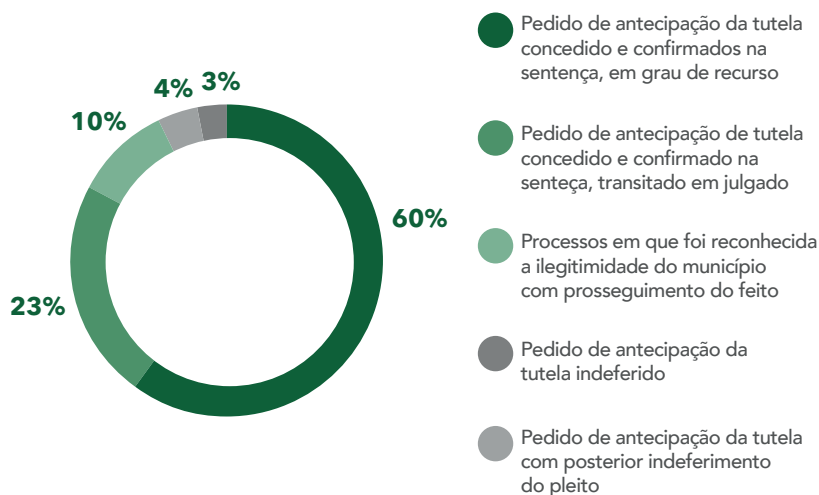


Fonte: SEMSA/Manaus.

Em relação às decisões proferidas pela Justiça Estadual, o próximo gráfico aponta para uma realidade similar, ou seja, a maioria das decisões também foram por tutela antecipada, 60% do total.

Em relação ao reconhecimento da ilegitimidade do município para compor o polo passivo da ação, a Justiça Estadual apresentou resultados mais otimistas quanto ao reconhecimento do princípio da responsabilidade solidária quando comparada às decisões em igual período da Justiça Federal. O Gráfico 5 mostra que nesse caso, os magistrados estaduais decidiram que em 10% dos casos o município não possuía legitimidade para arcar com a demanda solicitada.

GRÁFICO 5. Resultado das decisões judiciais da Justiça Estadual, em desfavor da SEMSA, no ano de 2018.



Fonte: SEMSA/Manaus.

O município de Manaus está exposto a um excesso de ações judiciais provenientes de demandas por ações e serviços de saúde que são de responsabilidade de outros entes federados, apontando para decisores com um frágil conhecimento da legislação do SUS. Há fragilidade produzida pelo distanciamento entre as partes envolvidas – magistrados e gestores – o que acaba por esvaziar o diálogo e possibilitar a disseminação de deliberações que comprometem os orçamentos municipais e invertem a lógica de que o interesse individual jamais poderia se sobrepor ao interesse coletivo.

Processos estratégicos para minimizar a judicialização em Manaus

Em vista do cenário de fragilidade do papel do Estado e o ativismo político dos tribunais, faz-se necessário esquematizar e aprofundar o debate em torno dos processos estratégicos de enfrentamento da judicialização do direito à saúde, principalmente no que tange aos municípios de pequeno e médio porte, que acabam sofrendo mais com decisões desproporcionais, principalmente em relação às competências do SUS.

Há muito tempo que se discute meios de enfrentamento ao fenômeno da judicialização da saúde para pensar em processos estratégicos, a fim de minimizar o impacto ocasionado ao planejamento estratégico-orçamentário das Secretarias de Saúde e, sobretudo, no prejuízo da implementação de políticas sociais coletivas.

As reiteradas reivindicações dos gestores para que sejam ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência e a necessidade de prestigiar sua capacidade gerencial, as políticas públicas existentes e a organização do sistema público de saúde, deram ensejo a Recomendação n.º 31, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomendou aos magistrados ouvir, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência. Porém, infelizmente tal prática não vem sendo adotada (3).

Mas, foi a partir da publicação da Resolução n.º 238, de 6 de setembro de 2016, que restou instituído, no âmbito do Judiciário, a criação dos NAT-JUS, pelos quais os tribunais passaram a criar sítios eletrônicos, objetivando o acesso ao banco de dados com pareceres, notas técnicas e julgados na área da saúde, para consulta pelos magistrados e demais operadores do direito, mantido pelo CNJ e, nos casos desejados, pelos próprios tribunais locais (4).

Em Manaus, houve a criação do Comitê Executivo Estadual de Saúde de Manaus (CEES/AM) e a implantação do NAT-JUS/AM, como medidas de enfrentamento à judicialização no município.

Os membros do NAT-JUS/SEMSA foram designados por meio da Portaria n.º 532/2018 ASTEC/SEMSA e, ao receberem as demandas por meio digital e físico, manifestam-se por meio de respostas técnicas, elaboradas em padrão científico, de forma célere e cumprindo os prazos estabelecidos na portaria que regulamenta o serviço, com manifestação sempre consubstanciada em elementos fáticos, em atenção ao Pedido de Manifestação Técnica (PMT), apresentada pelos entes requerentes.

Uma resposta igualmente alternativa de solução dos conflitos entre o Poder Público, o Poder Judiciário e o cidadão que demanda por saúde é a mediação sanitária. Este

instrumento emergiu no cenário político institucional como válvula de escape para o aumento do número de ações judiciais com temática da saúde.

Nesse contexto, a mediação sanitária e os meios consensuais para resolução de conflitos passaram a ser uma alternativa eficaz para a diminuição do impacto da judicialização da saúde nos tribunais de justiça e, sobretudo, na gestão pública do SUS, uma vez que o Poder Judiciário não responde em tempo hábil à demanda do cidadão e as decisões judiciais impactam no planejamento estratégico-orçamentário das secretarias de saúde e, sobremaneira, desviam a aplicação de recursos financeiros das políticas assistenciais coletivas em prol da efetivação do direito individual à saúde.

Em Manaus, ainda não existe o Comitê de Mediação Sanitária instituído e o debate quanto à sua implantação ainda não tomou dimensões que permitam estabelecer um prazo para tal. Mas, representa uma necessidade urgente da gestão municipal do SUS iniciar conversas entre seus órgãos para o planejamento da instalação de um núcleo de Mediação Sanitária, com a participação ativa de todos os órgãos de controle externo, judiciário e sociedade civil organizada.

A título de sugestões e críticas, após o diagnóstico situacional da SEMSA de Manaus, e, principalmente, considerando a recente implementação do NAT-JUS/SEMSA, sugere-se a instituição de uma Câmara de Mediação Sanitária, tendo por norte as experiências exitosas do Rio de Janeiro, com a criação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde em 2010 (CRLS) e a Câmara de Mediação da Bahia.

Partindo da caracterização das demandas judiciais que acometem a SEMSA e a percepção de todos os determinantes que estejam direta ou indiretamente fomentando estas demandas, é possível se estabelecer um plano de trabalho planejado, voltado para a prevenção de problemas que deixarão de culminar em ações judiciais, reduzindo assim o intervencionismo do Poder Judiciário na gestão do SUS no município.

Como primeiro passo para o planejamento foi realizado diagnóstico situacional, que apontou alguns problemas de natureza logística, estrutural, operacional e ambiental que impactam diretamente a qualidade da saúde ofertada aos usuários de Manaus com consequente judicialização. São eles:

- Esgotamento sanitário precário: a população manauara conta, atualmente, com apenas 19,2 % de área coberta pelo esgotamento sanitário. A capital amazonense figura como um dos piores locais para a coleta de esgoto. A maior parte dos esgotos é despejada diretamente nos igarapés, lagos e no Rio Negro (5);
- Crescimento populacional desordenado: a crise econômica dos anos vinte do século passado, a escassez de recursos, o crescimento populacional da corrente migratória dos ribeirinhos e nordestinos para Manaus contribuíram imprescindivelmente para a crise de falta de moradia, neste cenário surge a cidade flutuante, com casas sustentadas por palafitas nas margens e até leitos de rios, igarapés e riachos. A aglomeração na cidade atingiu proporções gigantescas, se estendendo em direção às águas dos igarapés (6);
- Baixíssima cobertura de Atenção Primária em seu território: Manaus-AM, em dezembro de 2018, possuía apenas 45,41% de seu território coberto pela assistência da Atenção Básica e apenas 32,23% de cobertura com equipes da ESF conforme dados do DAB/MS (7);
- Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC) como principal porta de entrada do SUS no município: Manaus apresenta uma reduzida quantidade de atendimentos na Atenção Básica em comparação ao número de atendimentos na MAC;
- Inexistência de autonomia da gestão municipal nas Unidades Hospitalares no município: mesmo contando em seu território com um total de 18 hospitais (8), nenhum está sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde;
- Baixíssimas coberturas vacinais: a cobertura vacinal geral, envolvendo todos os imunobiológicos do Calendário Nacional de Imunização para o ano base de 2018 (último ano com dados definitivos registrados), foi de 77,89 conforme dados do PNI. A cobertura mínima preconizada pelo MS para todos os imunobiológicos, salvo algumas exceções como a BCG e Vacina Influenza para Idosos, é de 95% (9);

- Alta população flutuante: além de Manaus possuir diversas dificuldades relacionadas ao seu território, como as barreiras geográficas que dificultam muito o acesso a determinadas áreas, existe também uma população flutuante muito grande que constantemente está em processo de mudança, principalmente pessoas que residem provisoriamente em Manaus por conta de trabalhos temporários.

Diante do cenário apresentado, algumas propostas de enfrentamento ao problema devem ser consideradas, levando-se em conta o limite das possibilidades e as conjunturas locais que permeiam o processo de tomada de decisões no território:

- Atualizar a REMUME e introduzir os protocolos clínicos e terapêuticos a serem utilizados por todos os profissionais prescritores da Atenção Primária em Saúde como forma de padronizar as condutas, facilitando assim a aquisição de medicamentos e agilizando o acesso da população ao elenco de medicamentos padronizados;
- Promover um amplo debate intersetorial envolvendo as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Economia, Meio Ambiente, Educação, Sociedade Civil organizada por meio de entidades de representação de classes, representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário e órgãos de controle, organizações não governamentais e demais atores interessados para o fomento a investimentos em saneamento básico como estratégia de redução de danos ambientais, como também redução de transmissão de doenças de veiculação hídrica;
- Discutir com os diversos segmentos sociais, políticos e administrativos, estratégias para a criação de uma Política Habitacional Municipal voltada à qualificação de domicílios com condições adequadas para seus residentes e substituição gradual de habitações que apresentem risco aos que nelas habitem;
- Iniciar um novo processo de territorialização do município para a implantação de novas equipes da ESF, promovendo um aumento da cobertura de atenção primária no município, o que possibilitará uma maior aproximação

da população com o serviço de saúde, facilitando o acesso e diminuindo o vazio assistencial atual;

- Discutir com as diversas instâncias da gestão tripartite do SUS o modelo de gestão de Manaus, sobretudo das Unidades de MAC, buscando uma gestão autônoma, participativa e que possibilite ao município gerir todas as Unidades próprias do SUS no seu território, exercendo o dispositivo legal que prevê a gestão única e descentralizada do SUS a cargo da gestão municipal;
- Inverter a organização atual dos serviços e promover a Atenção Primária como principal porta de entrada do SUS no território, como a ordenadora e coordenadora do cuidado, sempre na perspectiva de fortalecimento de vínculos dos usuários com os serviços de saúde e a construção de confiabilidade dos mesmos nos profissionais que os atendem;
- Desenvolver uma grande ação municipal voltada para o aumento das coberturas vacinais com identificação de bolsões de suscetíveis, com atualização de dados vacinais da população, busca ativa em escolas e comunidades ribeirinhas dentre outras iniciativas que resgatem estes índices de cobertura e minimizem a exposição da população a doenças imunopreveníveis;
- Intensificação da atualização constante dos cadastros de usuários no Sistema Informatizado de Atendimento da Atenção Básica (E-SUS AB) pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família para tornar possível o conhecimento de todos os usuários de cada área e microárea, tornando possível assim o devido acompanhamento e monitoramento destas pessoas, sobretudo os grupos mais vulneráveis como gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, crianças e adolescentes;
- Investimento em ações de promoção de saúde com o intuito de provocar mudança de hábitos, construindo comportamentos mais saudáveis, reduzindo danos, possibilitando o aumento da autoestima de cada sujeito e sua participação na construção da qualidade de sua própria saúde;

- Divulgação por parte da SEMSA da legislação sanitária como um todo nas escolas, associações comunitárias e em conjunto com os membros dos diversos órgãos de controle, como forma de elucidar dúvidas sobre o princípio da responsabilidade solidária na área da saúde e principalmente, sobre as obrigações de cada ente federado na garantia de acesso a serviços e ações de saúde no SUS;
- Aproximação por parte da SEMSA juntamente ao Poder Judiciário para facilitar a argumentação em casos de solicitações que esbarrem em algum marco regulatório do próprio SUS e que seja de desconhecimento do magistrado;
- Identificar fragilidades existentes na RAS local e que podem ser reparadas com base em investimentos pontuais e adequados à realidade orçamentária e financeira de Manaus, principalmente de equipamentos e insumos necessários para a realização de exames e procedimentos de média complexidade.
- Fortalecer o Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário, com alocação de recursos humanos, para a elaboração de pareceres técnicos em todos os processos judiciais que envolvam o direito à saúde.
- Criar o Comitê Municipal de Mediação Sanitária como estratégia de aproximação dos diversos atores envolvidos na dinâmica do problema da judicialização, quais sejam: os usuários, a gestão do SUS no âmbito municipal, os diversos órgãos de controle e o sistema de justiça, objetivando um maior número de resolução de conflitos pela via administrativa.

O monitoramento a ser proposto por este projeto resulta do acompanhamento e matriciamento das ações propostas ao longo de um período, sempre objetivando a redução das demandas judiciais na área da saúde para o município de Manaus.

Os indicadores para avaliar o processo de execução das ações propostas permitem a identificação de algum problema que, no tempo presente, possa comprometer até mesmo a execução das demais ações. São indicadores voltados para o monitoramento das fases de planejamento e fases iniciais do projeto em si. São propostos os seguintes indicadores de processo:

- N.º de Comissão Terapêutica criada até dez/2021 para elaboração da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) – Meta: 01 Comissão criada até dez/2021;
- N.º de Planos Municipais de Saneamento e Habitação elaborados e/ou revisados juntamente com a sociedade até dez/2022 – Meta: 01 Plano Municipal de Saneamento e 01 Plano Municipal de Habitação atualizados conforme as demandas apontadas pela sociedade civil organizada até dez/2022;
- N.º de Projetos de Expansão da ESF elaborados até dez/2021 – Meta: 500 equipes implantadas até dez/2024;
- N.º de Hospitais sob gestão municipal até dez/2024 – Meta: 100% dos Hospitais Públicos existentes no território sob gestão municipal até dez/2024;
- N.º de estudos de dimensionamento de pessoal realizados até dez/2024 – Meta: 01 estudo de dimensionamento realizado até dez/2021;
- N.º de Comitês de Mediação Sanitária implantado até dez/2024 – Meta: 01 Comitê de Mediação Sanitária implantado até dez/2024.

Quanto aos indicadores de resultados, estes avaliam em médio prazo se as ações propostas obtiveram influência positiva perante a realidade inicial encontrada e a ser transformada. Portanto, para a diminuição das ações judiciais na área da saúde em Manaus, devem ser observados, num médio prazo de tempo, os seguintes indicadores:

- Proporção (%) de atendimentos que tiveram a atenção básica como porta de entrada no SUS em Manaus numa série histórica de 5 anos;

$$\frac{\text{N.º de atendimentos da Atenção Básica}}{\text{N.º total de atendimentos na área da saúde}} \times 100$$

Meta: Atenção Básica como porta de entrada em, no mínimo, 80% dos atendimentos de saúde no município até dezembro de 2024.

- Proporção (%) de ações de Promoção de Saúde no conjunto de ações executadas pela Atenção Básica em Manaus numa série histórica de 5 anos;

$$\frac{\text{N.º de ações de Promoção de Saúde informadas}}{\text{N.º total de atendimentos da Atenção Básica informados}} \times 100$$

Meta: Ações de Promoção de Saúde representando, no mínimo, 50% das ações realizadas pela Atenção Básica no município até dezembro de 2024.

- Proporção (%) de medicamentos pertencentes a REMUME prescritos pelos profissionais da Rede Municipal em Manaus numa série histórica de 5 anos;

$$\frac{\text{N.º de medicamentos da REMUME prescritos}}{\text{N.º total de prescrições dispensadas pela Assistência Farmacêutica Municipal}} \times 100$$

Meta: Dispensação de 100% de medicamentos pela Assistência Farmacêutica municipal que pertencem à REMUME até dezembro de 2024.

- N.º de ações educativas e de divulgação do SUS nas escolas e comunidade em geral até dez/2024.

Meta: Uma ação mensal para divulgação do SUS até dez/2024 em escolas, associações, etc.

Quanto aos indicadores de impacto, estes representam a análise futura e o efeito das ações executadas num espaço de tempo mais longo, ou seja, estes indicadores irão avaliar se as ações executadas tiveram força e potência para transformar a realidade inicial encontrada. Para esta avaliação, utilizaremos os seguintes indicadores:

- Cobertura de Estratégia Saúde da Família em Manaus em dez/2028 – Meta: 90% de cobertura do território do município de Manaus com Estratégia Saúde da Família até dez/2028.
- Cobertura com Agentes Comunitários de Saúde em Manaus em dez/2028 – Meta: 100% de cobertura do território do município de Manaus com Agentes Comunitários de Saúde até dez/2028.

- Proporção (%) da RCL de Manaus com saúde até dez/2028 – Meta: 25% de aplicação da RCL em ações e serviços de saúde até dez/2028.
- Cobertura Vacinal Geral do município de Manaus até dez/2028 – Meta: 95% de cobertura geral de vacinas no município de Manaus até dez/2028.
- Proporção (%) de residências com serviço de saneamento básico no município de Manaus até dez/2028 – Meta: 50% do território de Manaus com cobertura de saneamento básico até dez/2028.
- N° de demandas judiciais na área da saúde com o município de Manaus no Polo Passivo da ação até dez/2028 – Meta: 30 ações/ano até dez/2028.

A intenção é ousada, mas somente com o envolvimento de todos os segmentos da gestão local será possível transformar esta realidade. Este monitoramento tem caráter flexível, permitindo a reprogramação de prazos mediante uma impossibilidade em sua execução, desde que a intencionalidade do projeto como um todo não seja comprometida nem alterada.

Como todo projeto, este reproduz uma realidade futura da gestão pública, e como tal, resultante de um conjunto de fatores que direta ou indiretamente podem repercutir em seu desenvolvimento. É vulnerável a interesses políticos, a novas prioridades que possam surgir no transcorrer do tempo de execução, a limitações orçamentárias e financeiras, a intempéries não previstas que podem ocorrer, enfim, todas estas situações devem ser consideradas para o planejamento situacional das ações contidas neste trabalho.

Considerações Finais

Ao final desta caminhada, após uma trajetória de pesquisas de dados, informações, peculiaridades e diversidades do município de Manaus, chegamos a este momento convictos de que o desafio de enfrentar a judicialização na área da saúde, sobretudo num território que apresenta inúmeras barreiras das mais variadas origens como naturais, geográficas, sociais, econômicas, de infraestrutura dentre outras, é muito grande.

Além de todas as ações de enfrentamento descritas neste trabalho, muitas são as recomendações que estão intrinsecamente associadas e que devem também ser levadas em consideração no momento de execução desta iniciativa, tais como:

- Que as fragilidades dos serviços de saúde local podem ser enfrentadas com um planejamento estratégico administrativo e financeiro com metas objetivas, eficazes e determinadas com previsão de prazo a serem cumpridas de acordo com o binômio necessidade/possibilidade;
- Que a falta de entendimento da extensão do direito à saúde por parte do Poder Judiciário pode ser enfrentada fazendo alinhamento entre todos os atores envolvidos (SEMSA, Poder Judiciário, MP, Defensorias Públicas, OAB etc.);
- Que o NAT-JUS é uma importante ferramenta para informação e uso dos Magistrados, assim como a criação do Comitê de Mediação Sanitária;
- Que a inclusão da União e/ou Estado no rol de responsáveis, na reafirmação do princípio da responsabilidade solidária, depende exclusivamente do entendimento do Poder Judiciário, e os municípios ainda estão reféns de uma situação que deveria não mais se repetir, onde todos deveriam ser responsabilizados na medida de suas competências, capacidade orçamentária e concentração de receitas;
- Que a falta de capacidade técnica e financeira pode ser enfrentada com investimentos planejados em capacitação, situação que somente pode ser suprida com dotação orçamentária compatível com a necessidade emergente e manutenção e ou vinculação de receitas exclusivamente para este fim;
- Que a desigualdade quanto às decisões judiciais “fura fila”, que beneficiam alguns em detrimentos de muitos, depende da sensibilidade do próprio Poder Judiciário e da compreensão de que a saúde é um direito universal, mas não deve ser absoluto, a considerar o entendimento nas decisões “da reserva do possível” e o interesse público e a dotação orçamentária e ou capacidade financeira de cada ente federado condenado;

- Que a tutela antecipada deve ser proferida somente após a oitiva do NAT-JUS e não estando presente o risco de morte e atentatório, garantir o alinhamento prévio com todos os atores envolvidos;
- Que garantir o direito à saúde não implica necessariamente em fornecer o tratamento/medicamento, mas em disponibilizar os caminhos necessários e os procedimentos legais adequados para a resolução do problema, à luz do princípio da integralidade, e que não coloquem em risco a saúde do paciente e nem da população de uma forma isonômica e sustentável, respeitando o interesse público;
- Por fim, se a Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação, não quer dizer que o Estado tem que atender de forma individualizada, privilegiada, em detrimento da maioria da população, também necessitada, eis que também fere o mesmo mandamento constitucional.

Portanto, a forma pela qual o Estado deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva ser realizada de forma global e atender aos planos orçamentários traçados nos artigos 165 e 167 da Constituição Federal.

Decisões judiciais não criam recursos nem podem obrigar o Estado a fornecer de uma hora para outra o medicamento. A crescente judicialização da dispensação de medicamentos redundará na desestabilização da própria política pública que engendra a aplicação dos recursos financeiros e destinação da medicação. Assim, o fornecimento de fármacos não listados nos protocolos clínicos não deve ser imputado aos órgãos públicos de saúde, em respeito ao planejamento da distribuição de recursos elaborado pelo Poder Executivo, visando o menor custo com o alcance dos fins estipulados, pois, do contrário, beneficiar-se-ia o indivíduo de forma particular e privilegiada em detrimento da grande massa de necessitados.

A máxima de que “prevenir é melhor que remediar” nunca foi tão atual e sábia na perspectiva de redução da morbimortalidade, e por meio desta redução obtêm-se

qualidade de vida que naturalmente irá impactar negativamente no número de demandas judiciais no município, pois a principal porta de entrada do SUS sempre deve ser a Atenção Primária, e não, o Poder Judiciário.

Referências

- 1 - Brasil. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário nº 855178, de 05 de março de 2015**. Recurso Extraordinário. Constitucional e Administrativo. Direito a Saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão Geral Reconhecida. Reafirmação de Jurisprudência. Diário Oficial da União [Internet] Brasília, 05 mar 2015. [Acesso em: 20 fev 2020] Disponível em: <<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311628839/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-rg-re-855178-pe-pernambuco-0005840-1120094058500/inteiro-teor-311628848?ref=juris-tabs>>.
- 2 - Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 02 de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União [Internet] Brasília, 28 set 2017. [Acesso em 24 fev 2020]. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html>.
- 3 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça, **Recomendação nº 31, de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Diário Oficial da União [Internet] Brasília, 30 mar 2010. [Acesso em: 24 fev 2020] Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=877>>.
- 4 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça, **Resolução nº 238, de 06 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. Diário Oficial da União [Internet] Brasília, 06 set 2016. [Acesso em: 24 fev 2020] Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.
- 5 - Secretaria de Meio Ambiente de Manaus (BR). Prefeitura de Manaus [Internet]. **Manaus, 2019**. [citado 07 ago. 2019]. Disponível em: <<http://semmas.manaus.am.gov.br/areas-protegidas/>>.
- 6 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus (BR). Prefeitura de Manaus. [Internet]. Manaus, 2019. [citado 08 ago. 2019]. Disponível em: <<http://semulsp.manaus.am.gov.br>>.
- 7 - Departamento da Atenção Básica (BR). **Histórico de cobertura AB** [Internet]. Brasília, 2019. [citado 05 out 2019]. Disponível em: <<https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml>>.

8 - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (BR). **Indicadores Tipo de Estabelecimentos** [Internet]. Brasília, 2019. [citado, 05 out 2019]. Disponível em: <http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=05&VListar=1&VEstado=13&VMun=130260&VSu bUni=&VComp=>>.

9 - DATASUS (BR). **Coberturas Nacionais de Vacinação** [Internet]. Brasília, 2019. [citado, 05 out 2019]. Disponível em: <tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAM>.



Análise da judicialização da saúde do Município de Paragominas/PA

Aline Correia dos Santos¹

Jaqueline de Carvalho Peçanha²

Maria Cláudia Mulinari³

Maria do Socorro Araújo Cunha⁴

Simone Aparecida Gonçalves Soares de Souza⁵

Thaíse Dias Soares Santos⁶

Viviane Gonçalves Carneiro de Souza⁷

Orientadora: Profa. MSc Ione Silva Barros

O município de Paragominas-PA foi escolhido para a realização do projeto de intervenção por ser um município localizado no interior do Pará, em uma região distante dos grandes centros, mas com uma importante infraestrutura de saúde, contando com 15 postos de saúde, sendo 13 na zona urbana e dois na zona rural, além de um Hospital Municipal, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um Hospital Regional que atende todo o nordeste do Estado. A Prefeitura possui 740 servidores da saúde, com 26 médicos no total (1).

¹ Graduada em Direito pela UNIEVANGÉLICA-Anápolis. Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Jaraguá-GO.

² Graduada em Administração pela FUMEC e em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos do município de Paragominas-PA.

³ Graduada em Pedagogia pela UFSM e em Direito pela UCPEL. Coordenadora da Assessoria Jurídica do Estado do Rio Grande do Sul.

⁴ Graduada em Economia pela UERN. Secretária Municipal de Saúde de Lucrécia-RN.

⁵ Graduada em Nutrição pela UNIPAR. Secretária Municipal de Saúde de Roncador-PR.

⁶ Graduada em Enfermagem pela UNINOVE de São Paulo. Secretária Municipal de Saúde de Formosa do Rio Preto-BA.

⁷ Graduada em Enfermagem pela UNIFAL. Secretária Municipal de Saúde de Várzea da Palma-MG.

O estudo foi desenvolvido com uma abordagem qualitativa com o propósito de realizar um projeto de intervenção na judicialização da saúde no município de Paragominas. Isso foi feito a partir da coleta de dados por meio de pesquisa *on-line* no sítio do Tribunal de Justiça do Pará e da análise de documentos do acervo da Prefeitura de Paragominas.

Para alcançar o objetivo proposto foi empregada a abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa “[...] tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre o indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” (2).

Sendo uma pesquisa de abordagem qualitativa, a mesma não tem como intenção principal realizar representatividade numérica e sim aprofundar a compreensão de um aspecto de determinada organização, etc.

Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (3).

A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados e se concentra na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.

Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador (4).

Quanto à natureza, trata-se de pesquisa aplicada, pois o estudo concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. A pesquisa está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções.

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como descritiva e quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa é documental e foi realizada em livros e artigos científicos capazes de dar sustentação teórica ao tema abordado. Compreende-se que:

[...] a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (5).

A metodologia empregada para a coleta de dados de fonte primária foi a pesquisa documental em parte do acervo da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Saúde e Poder Judiciário do estado do Pará, especialmente por meio de análise física em planilhas como o quantitativo de processos ajuizados no ano de 2018, referentes à judicialização da saúde no município de Paragominas.

Visando, também, realizar uma análise mais aprofundada da judicialização no município de Paragominas sobre erros médicos, fornecimento de medicamentos, transferências hospitalares, leito de UTI e tratamento médico, foi realizada uma pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do Pará, em que se buscou por processos relacionados a demandas na área da saúde no município de Paragominas, durante o ano de 2018. Os dados encontrados foram organizados em planilhas para posterior análise.

No que se refere à investigação *in loco*, o objetivo foi de colher informações específicas sobre o tema, podendo deste modo contribuir com dados detalhados. Após reunir as informações foi realizada a análise dos dados, objetivando organizar e sintetizá-los de tal forma que possibilitasse o fornecimento de informações importantes.

Diagnóstico da judicialização no município

Como consequência da redemocratização nacional trazida pela nova ordem constitucional que reconheceu a proteção do direito à saúde a todo cidadão brasileiro, bem

como o estabelecimento do dever do Estado em garantir o direito nas suas dimensões preventivas e assistenciais, o município de Paragominas, assim como as demais unidades da federação brasileira, sofre com o fenômeno da judicialização da saúde.

O fenômeno se caracteriza pela tomada de decisões estratégicas no âmbito da saúde pelo Poder Judiciário, que por meio de determinações judiciais que obrigam o poder público a fornecer medicamentos, insumos, equipamentos e cirurgias aos que o acessam, sem considerar o impacto orçamentário que essas decisões causam no âmbito do Poder Executivo.

No município de Paragominas a ação do Judiciário, ainda que pautada na legislação constitucional e legal, não considera a escassez de recursos, a falta de previsão orçamentária, a não previsão em listas e protocolos do Sistema Único de Saúde, quando diante de si há uma demanda.

A pesquisa revelou 18 processos sobre saúde, como demonstra a Tabela 1 a seguir:

TABELA 1. Número de processos sobre saúde/assunto no município de Paragominas no ano de 2018

ASSUNTO	QUANTIDADE
Ação de Indenização – Erro Médico	03
Ação Civil Pública – Fornecimento de Medicamentos	05
Ação Civil Pública – Transferência Hospitalar	05
Ação Civil Pública – Leito de UTI	01
Ação Civil Pública – Tratamento Médico	03
Mandado de Segurança	01
Total	18

Fonte: Tribunal de Justiça do Pará.

Os números de processos judiciais referente ao ano de 2018 que tiveram como tema a saúde em Paragominas apontam que o município não se encontra em situação calamitosa, pois em que pese enfrentar um índice crescente, os números são bem menores em comparação a outras unidades da federação.

Essas ações, conforme se atesta da análise dos processos, são julgadas pela 1ª Vara Cível e Empresarial, que também responde pela Fazenda Pública, denominação dada pela Resolução n.º 026/2014- GP do Tribunal de Justiça do Pará.

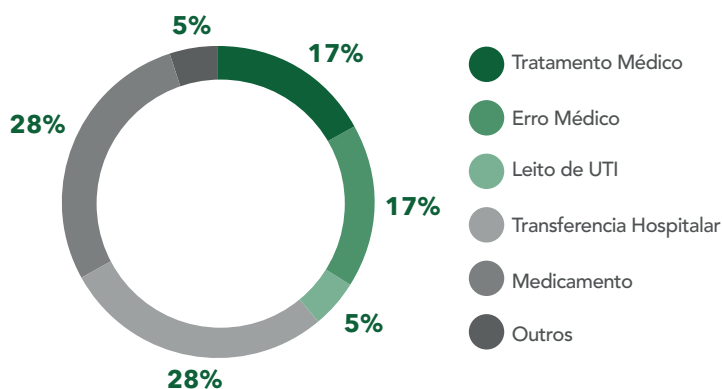
Em consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Pará, no ano de 2018, identificou-se 200 (duzentas) ações judiciais em que o município de Paragominas figurou como réu. Desse montante, apenas 18 (dezoito) ações são referentes à judicialização da saúde, ou seja, o pedido está diretamente associado a um serviço ou ação de saúde a ser prestado pela municipalidade.

Dos processos analisados percebe-se que os pedidos mais prevalentes se referem ao fornecimento de medicamentos e transferências para hospitais de grande porte, num percentual de 27,77% de todos os processos analisados.

Em seguida, o Gráfico 1 ilustra que a ocorrência de pedidos de tratamento médico e ações de indenizações por erro médico que correspondem a 16,66 % das demandas. Estas demandas demonstram que o quadro de pessoal da área de saúde deve ser incrementado com a contratação de novos quadros de médicos especialistas. As ocorrências relacionadas ao erro médico implicam na responsabilização civil dos profissionais, porém, também podem ser mediadas por meio de um programa de formação contínua dos recursos humanos da área de saúde, seja por intermédio de especializações, de termos de cooperação com municípios com atuação de referência da área de saúde, dentre outras possibilidades.

Outros pedidos que foram formulados em face da municipalidade dizem respeito aos leitos de UTI, 5,55%, e outros pedidos avulsos, igualmente com 5,55%.

GRÁFICO 1. Principais pedidos em ações ajuizadas no ano de 2018 em desfavor do município de Paragominas-PA.



Fonte: Tribunal de Justiça do Pará.

Vale salientar que o fornecimento de medicamentos aos usuários do SUS encontra previsão na Lei n.º 8.080/90, art. 6º e que, “[...] no que se refere à assistência farmacêutica existente no Brasil, é necessário ressaltar que o Ministério da Saúde tem grande atuação em ações desenvolvidas para garantir o acesso aos medicamentos demandados pela população”.

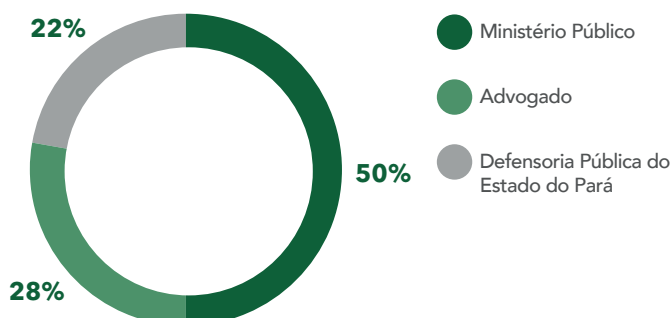
A transferência hospitalar também é considerada um direito fundamental do cidadão, já que implica sobre a manutenção da saúde do paciente e, dependendo da gravidade do caso, pode significar aumento das chances de saúde e/ou sobrevida.

Todas as demandas que deram origem às ações pesquisadas são legítimas de representação ativa do Ministério Público, conforme asseguram os artigos 127, 129, II, e 196 da Constituição Federal. As fontes legais mencionadas são a base da teoria de que todo cidadão tem direito à saúde, que deve ser ofertada pelo Estado, sendo esse um de seus deveres. A Constituição Federal menciona também a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, se preciso for, por vias processuais em forma de ação civil pública.

As demandas legais na área de saúde contra a municipalidade, em sua maioria, são ajuizadas pelo Ministério Público, num percentual de 50%. Em segundo lugar, correspondendo a 28% do universo pesquisado, estão as ações ajuizadas por advogado privado.

A pesquisa revelou que a Defensoria Pública corresponde ao menor percentual nessa área, que corresponde a 22% do total de ações. Identifica-se que as ações em saúde foram majoritariamente ajuizadas pelo *parquet*, mesmo que na defesa de direitos individuais.

GRÁFICO 2. Representação de ações ajuizadas contra o município de Paragominas no ano de 2018.



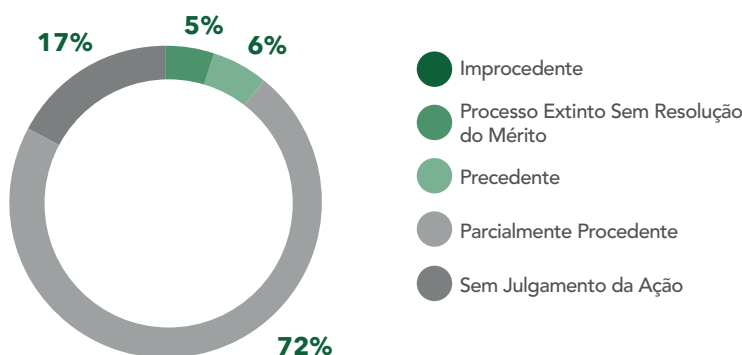
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Tribunal de Justiça do Pará.

A realidade vivenciada no município de Paragominas, em relação à representação do autor das ações de judicialização da saúde, corresponde ao cenário nacional em que o Ministério Público figura como representante da maioria das ações civis públicas e/ou mandados de segurança.

A pesquisa revelou que, quanto à efetividade da ação judicial, na maioria dos casos há concessão de tutela de urgência, ou de forma liminar. Quanto ao mérito, tendem a ser procedentes as demandas em que há comprovadamente risco de morte ou danos irreversíveis dos pacientes, porém, as ações julgadas como parcialmente procedentes

correspondem à 72% do universo de ações ajuizadas no exercício de 2018, como demonstra o Gráfico 3:

GRÁFICO 3. Sentenças.



Fonte: Tribunal de Justiça do Pará.

Apenas 5% do total de ações referentes à judicialização da saúde no município de Paragominas foi extinto sem resolução do mérito, o que significa que o município teve algum percentual de custo com todas as demais ações ajuizadas, ou seja, 95%. Esses custos, que não foram previstos no orçamento destinado à saúde, podem impactar negativamente o planejamento municipal, motivo pelo qual se faz necessário o desenvolvimento de ações capazes de minimizar o fenômeno da judicialização da saúde.

Assim, com a criação de comitês, o entabulamento de convênios são alternativas possíveis que podem ser adequadas ao estreitamento de laços e construção de procedimentos padrões com a Secretaria Estadual de Saúde, nas questões que envolvem o fornecimento de medicamentos e serviços de média e alta complexidade, sob responsabilidade do Estado, buscando formas de atendimento administrativo, ou cumprimento de forma menos onerosa ao erário, evitando os bloqueios e sequestros de valores. Isso passa pela qualificação dos trabalhos da secretaria e pela melhor organização de suas redes de atenção à saúde.

Nos estudos em geral, assim como nos próprios dados do Fundo Nacional de Saúde, identifica-se algumas das causas que levam à judicialização, tais como: a desorgani-

zação da oferta de serviços; a falta de estruturação das redes de atenção; a falta de estruturas físicas de atendimento; a falta de profissionais especializados e o subfinanciamento da saúde.

Nesse diapasão, torna-se evidente a necessidade de implantação de estratégias que visem, senão acabar com a judicialização, no mínimo diminuir seus efeitos, posto que danosa, visto que desorganiza totalmente o Sistema de Serviços de Saúde.

Processos estratégicos para o enfrentamento da judicialização em Paragominas

No caso específico de Paragominas, os dados apresentados neste trabalho demonstram que, apesar da rede de atenção à saúde, especialmente nos serviços especializados, não possuir cobertura integral, a judicialização não chega a ter um alto índice de ações, podendo ser contida mediante estratégias colaborativas com os órgãos atuantes na cadeia de serviços de saúde. Convém registrar que o fato de não haver no município de Paragominas um número elevado de ações judiciais de saúde, não significa que a municipalidade não tenha um gasto elevado e significativo nessas ações e que o mesmo não possa comprometer e desorganizar seu orçamento e planejamento.

Em vista disso é que se torna necessário medidas que possam minimizar os efeitos da judicialização.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu a Recomendação n.º 31/2010, a fim de orientar os tribunais de justiça a celebrar convênios para apoio técnico, formados por médicos e farmacêuticos com a finalidade de oferecer uma assessoria técnica aos magistrados e demais operadores do direito como forma de dar-lhes um suporte em suas decisões nas ações movidas sobre saúde, e assegurar mais eficiência na solução dessas demandas. Assim, surgiram os Núcleos de Apoio Técnico (NAT).

Esta Recomendação foi elaborada com a observância dos seguintes fatores: 1. Elevado número de processos judiciais sobre o tema da saúde; 2. Alto impacto orçamentário para cumprimento das decisões; 3. Relevância da matéria diante da finalidade de assegurar vida digna aos cidadãos; 4. Carência de informações clínicas prestadas aos juízes

do Brasil sobre os problemas de saúde; 5. Necessidade de prévia análise e registro da Anvisa para a comercialização de medicamentos no Brasil, nos termos do art. 12 da Lei n.º 6.360/1976 c/c a Lei n.º 9.782/1999; 6. Reivindicações dos gestores para que sejam ouvidos antes da prolação de decisões judiciais; 7. Importância de assegurar a sustentabilidade e gerenciamento do SUS.

A criação dos NAT ganhou relevância em 2011 quando o CNJ, mediante a Recomendação n.º 36, ratificou a importância da sua criação como apoio aos juízes na prolação de decisões na área de saúde.

Neste estudo, identificou-se que em Paragominas não há um Núcleo de Assessoramento para apoio dos municípios, o que poderia ser implementado com forma de auxiliar o Judiciário nas questões de judicialização, principalmente para atuar de forma preventiva no sentido de não deixar que as ações avolumem e nem que o município passe a sofrer as consequências disso, tal como outros nas mais diversas unidades da federação.

A mediação sanitária é também uma possibilidade para buscar solucionar controvérsias na área de saúde e assegurar a garantia de acesso e efetividade nas ações e serviços de saúde independentemente do Judiciário. Conforme referido por Wesley Carlos Ribeiro, a mediação como meio de resolução de conflitos na área de saúde:

Esforços têm sido empreendidos por juristas e profissionais de diferentes áreas almejando alcançar meios e formas que possibilitem um melhor equacionamento entre a previsão e garantia de direitos na legislação e o acesso efetivo ao exercício de tais direitos no cotidiano das pessoas e instituições (6).

A mediação é mais uma das ferramentas utilizadas para compor conflitos e pode ser usada no âmbito do SUS para auxiliar o gestor a equacionar problemas na área. É uma forma de resolução de controvérsia, no qual as partes envolvidas no problema buscam a autocomposição com a ajuda de um mediador.

No âmbito do SUS a mediação sanitária pode ser usada como forma de se evitar a judicialização. No âmbito da Secretaria Estadual de Saúde pode haver um Comitê que busca resolver, de forma compositiva, o problema de saúde. Tal alternativa é salutar e pode ser concretizada em Paragominas, que ainda não tem Comitê.

Outra possibilidade de minimização dos efeitos de judicialização é a instituição de Comitês de Saúde de que trata a Resolução n.º 238 de 06/09/2016, do Conselho Nacional de Justiça que “Dispõe sobre a criação e manutenção pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara da fazenda pública” (7).

Conforme noticiado por Ronald Santos, Presidente do CNJ em 16/09/2016, em matéria do site do próprio Conselho:

A publicação da Resolução n.º 238 é um avanço no âmbito dos Conselhos de Saúde dos estados. É importante que o CNJ busque esse diálogo com o controle social, além de construir mecanismos para garantir o direito à saúde e isso passa pelo diálogo com os conselhos de saúde e essa Resolução estrutura essa conversa (8).

Os comitês regionais ou estaduais de saúde são alternativas que podem ser implementadas em Paragominas, para tratar da questão da judicialização da saúde, pois a interlocução entre todos os envolvidos pode, a partir da realidade local e regional, construir soluções mais bem adequadas para evitar ou minimizar os problemas de saúde e de judicialização da saúde do município.

Importante registrar que a formação do comitê não pode ser *proforma*, tem que existir o compromisso efetivo dos envolvidos na análise e enfrentamento dos problemas e na criação de soluções efetivas que cheguem ao cidadão que necessita do atendimento do SUS.

Paragominas já pode efetivar esse comitê, já que é uma realidade em inúmeras unidades da federação e apresenta alternativas de trabalho e solução para a questão da judicialização.

Assim, a criação de comitês e o estabelecimento de termos de cooperação ou de convênios são alternativas possíveis que podem ser adequadas ao estreitamento de laços e construção de procedimentos padrões com a Secretaria Estadual de Saúde, nas questões que envolvem o fornecimento de medicamentos e serviços de média e alta complexidade sob responsabilidade do Estado, buscando formas de atendimento administrativo ou cumprimento de forma menos onerosa ao erário, evitando os blo-

queios e sequestros de valores. Isso passa pela qualificação dos trabalhos da secretaria e pela melhor organização de suas redes de atenção à saúde.

Além da criação dos Comitês de Saúde, o município também pode criar e desenvolver um programa de formação do quadro médico, seja para a oferta de especializações ou outras formas de qualificação como, por exemplo, as especializações técnicas. Essa medida possui potencial para a redução dos casos de erro médico, que demandam em percentual de ações ajuizadas contra o município. Além disso, também atuaria na redução das demandas por atendimento médico, uma vez que o investimento em formação de recursos humanos de saúde resultaria no aumento de especialistas.

Outra medida possível é a contratação de médicos especialistas, que atuariam no atendimento à demanda reprimida em Paragominas.

Por meio dos dados coletados sobre o município e a gestão pública de Paragominas o que se pode afirmar é que, apesar do volume de ações que correspondem à judicialização da saúde em 2018 ser menor que outras unidades da federação, os casos registrados representam custos à gestão municipal que não foram previstos no orçamento do exercício. Portanto, é necessária a atenção para o desenvolvimento de estratégias e ações que possam reduzir essas ocorrências.

Além disso, o objetivo principal da gestão pública deve ser o alcance do bem-estar social e por isso o município deve assegurar ao munícipe o pleno direito à saúde.

A coleta de dados revelou que a população atingida pelo fenômeno da judicialização da saúde corresponde a um volume pouco expressivo, o que está relacionado ao percentual do orçamento público destinado à área de saúde. Esse investimento se converte em atendimento de qualidade à maioria da população. Porém, compreendemos que é importante que o município atue para minimizar ainda mais esse número, priorizando um mapeamento diagnóstico que pode utilizar como base os pontos críticos e aprimorar as sugestões apresentadas nesse estudo para detectar as distorções na assistência e corrigi-las.

As ações que visem a redução da judicialização da saúde em Paragominas devem ser desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo a mesma se articular

com outras secretarias, como a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEJUR), Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Por meio do desenvolvimento de um plano de ação para minimizar ou erradicar a judicialização no município, o cidadão não precisará recorrer ao Judiciário para acessar o seu direito à saúde, pois essa prática gera desgaste para a população e para a gestão pública, uma vez que atrapalha as políticas de saúde e desorganiza o sistema e o orçamento público.

Como sugestão primária para a resolução dos conflitos existentes, compreende-se que o município deve buscar o saneamento e encaminhamento pelo diálogo institucional com os demais envolvidos no processo, e nesse sentido, a providência que julga-se pertinente e adequada é o estreitamento de laços com o Ministério Público Estadual, que é quem ajuíza a maioria das ações contra o município.

A criação de comitês e entabulamento de convênios são alternativas possíveis. Além disso, é adequado o estreitamento de laços e construção de procedimentos padrões com a Secretaria Estadual de Saúde nas questões que envolvem o fornecimento de medicamentos e serviços de média e alta complexidade, sob responsabilidade do Estado.

Há que se fugir da lógica do mero cumprimento das ordens judiciais recebidas e buscar formas de atendimento administrativo, ou cumprimento de forma menos onerosa ao erário, evitando os bloqueios e sequestros de valores. Isso passa pela qualificação do trabalho e dos trabalhadores da secretaria de saúde e pela melhor organização de suas redes de atenção à saúde.

Mas, o importante é buscar alternativas viáveis e alinhadas às necessidades e peculiaridades regionais, avaliando as necessidades dos munícipes e direcionando para um melhor atendimento. Entretanto, todas as sugestões apresentadas necessitam de constante acompanhamento e avaliação para que, quando necessário, ocorram as devidas correções.

Para que haja melhorias no Sistema de Saúde é necessária a organização, a integração e o compromisso de todos os atores públicos e privados que compõem a rede de saúde, para estabelecimento de políticas públicas que permitam a prevenção, promoção e melhoria da saúde no Brasil.

A discussão da judicialização da saúde não pode ficar limitada apenas à avaliação dos critérios de decisão e da adoção da Saúde Baseada em Evidências, é preciso qualificar aqueles que atuam na área para que seja possível antecipar problemas e, principalmente, encontrar a solução mais eficiente e menos onerosa aos entes públicos e às operadoras de planos de saúde.

Outro ponto extremamente importante é a atuação dos médicos, pois esses profissionais são grandes fomentadores da judicialização da saúde. Ocorre que só existe instauração de um processo judicial quando há uma prescrição indicando tratamento ou tecnologia não incorporada no SUS ou não contemplada nos contratos ou no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desta forma, a maneira como atuam os profissionais da área médica merece importante atenção da sociedade, principalmente no que toca à influência das suas prescrições com a atuação dos laboratórios farmacêuticos.

As demandas judiciais vêm apresentando pedidos de ações e serviços de saúde cada vez mais diversos. A fim de que sejam estabelecidos critérios conforme cada caso, o que combateria a expansão desenfreada e sem critérios da judicialização da saúde, mostra-se adequada a adoção pelo Judiciário de convênios e assessorias especializadas em saúde, já que os magistrados não têm conhecimento suficiente na área da saúde.

O enfrentamento da resistência do sistema de justiça pode ser feito com formação profissional no campo do Direito Sanitário, considerando a complexidade das questões que permeiam o debate do direito à saúde e que, portanto, exigem do operador do direito e demais profissionais envolvidos formação especializada com o tema. Conforme lembra o CONASS, é preciso uma prática conjunta para o melhor entendimento dos magistrados sobre o SUS e os seus critérios de escolhas para a assistência à saúde, assim como de legislação sanitária para os profissionais de saúde, a fim de alcançar patamares mais elevados de segurança, qualidade e efetividade (8).

Uma das formas de superação do ativismo judicial nesse campo é a criação de fóruns permanentes de diálogo entre a gestão de saúde e o sistema de justiça. Além do compartilhamento de experiências, informações e ideias sobre a atuação dos advogados públicos e do SUS. O fórum pode enriquecer o debate sobre a judicialização da saúde, para dar novos rumos ao seu atual panorama (8).

A adoção de uma parceria dos tribunais com especialistas da área da saúde permitiria que as decisões proferidas levassem em consideração a real necessidade do fornecimento da ação ou serviço de saúde pleiteada para garantia da saúde, de modo que os pedidos excessivos e supérfluos seriam rejeitados, já que esses especialistas têm conhecimento aprofundado do tema. A correta interpretação do art. 196 da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não permite concluir que os cidadãos tenham direito a todo e qualquer tratamento de saúde, ainda que não incorporado ao sistema público de saúde. Não existe direito absoluto, justamente em função da limitação dos recursos públicos disponíveis, especialmente quando se trata de direito prestacional, em que o Estado deve prover e assegurar prestações positivas aos cidadãos. Não há como assegurar toda e qualquer prestação a todos os cidadãos, justamente em face da ausência de recursos suficientes (9).

A questão da judicialização da saúde remete fortemente ao financiamento do SUS, entendendo que os recursos da saúde concorrem com os de outras políticas públicas e, mesmo no setor saúde, há prioridades que precisam ser eleitas. Quanto mais insumos e mais tecnologias incorporam-se ao sistema, maior a necessidade de financiamento deste, tendo em vista que os novos medicamentos e serviços dificilmente substituirão os anteriores. Assim, os recursos necessários ao financiamento da saúde, considerando todos os princípios organizacionais do SUS, são crescentes, mas limitados, o que coloca em xeque o crescente número de ações judiciais impetradas nos últimos tempos (10).

Cada realidade tem suas nuances e precisa ser entendida no seu contexto e trabalhada amiúde, mas tem características e situações que devem e podem ser analisadas por todos para que sejam melhoradas as condições de saúde e reduzir os percentuais de judicialização, já que esse fenômeno interfere sobremaneira nas políticas de saúde.

Desde 2010, o CNJ tem liderado e estimulado de maneira mais sistemática a atuação do Judiciário, buscando estabelecer uma política judiciária para a saúde. As estratégias oriundas dessas medidas envolvem desde a criação do Fórum Nacional do Judiciário para a saúde até Comitês Estaduais de Saúde e recomendações e enunciados sobre como os juízes podem decidir as demandas que lhes são apresentadas. Desde então, em meio a avanços e desafios, o CNJ tem estimulado, discutido, desenvolvido e implementado diversas ações e estratégias que visam, em alguma medida, oferecer parâmetros e diretrizes para a atuação judicial em saúde.

Considerações Finais

A elaboração do presente trabalho possibilitou a análise e identificação das ações judiciais interpostas em face do município de Paragominas, com o intuito de estabelecer estratégias, e propor um projeto de intervenção, para evitar ou reduzir a judicialização da saúde no município.

Foi possível atestar que apesar de Paragominas possuir uma população de mais de 100.000 habitantes, tem um baixo índice de judicialização da saúde, se comparado a outras unidades da federação brasileira.

Em que pese não ter sido possível aprofundar no funcionamento da organização da rede de saúde, na oferta de cada serviço e na atuação dos profissionais de saúde em cada segmento do atendimento, conclui-se que a rede de assistência à saúde do município está bem estruturada e funcionando adequadamente e, ainda, que os profissionais de saúde atentem a quase totalidade de necessidades da população, que não precisa recorrer ao Judiciário para ver atendidas as suas necessidades.

Pelos relatórios analisados, verificou-se que o investimento financeiro da municipalidade na área da saúde supera de forma significativa o percentual mínimo exigido constitucionalmente, que é de 15%. Nos últimos cinco anos (anteriores à data da redação deste trabalho), o município de Paragominas tem superado em mais de 10% o mínimo exigido. Esse fato, também remete à conclusão, presumida é claro, de que o

principal reflexo do investimento financeiro significativo na área de saúde é a baixa incidência de judicialização e de desassistência de saúde no município.

O ano de 2018 foi objeto de análise em relação à judicialização em Paragominas e foi possível identificar que foram ajuizadas apenas 18 (dezoito) ações contra o município. Dentre essas, se observou que 5 (cinco) ações foram para solicitação de medicamentos e outras 5 (cinco) para transferência hospitalar. Esse é um indicativo de que o município deve voltar sua atenção para esse dado, para evitar que ações deste tipo passem a ser corriqueiras, como são no resto do país. Por isso, foi proposto a criação de um núcleo para fazer esse acompanhamento e saneamento dos problemas surgidos, atuando numa publicidade informativa eficaz e eficiente à população e dialogando com os interlocutores, mediante um Comitê de Saúde, a fim de buscar soluções resolutivas extrajudiciais para os requerimentos de saúde, eventualmente levados aos órgãos para serem judicializados.

Contudo, não se pode olvidar que todo esse trabalho tem um custo. Dessa forma, as políticas do SUS precisam ser fortalecidas, pois muito já foi feito até então, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

Referências

- 1 - Paragominas. **Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas** [Internet]. Pará. 2014. [citado em 06 set 2019]. Disponível em: <<https://www.paragominas.pa.gov.br>>.
- 2 - Maanen JV. **Reclaiming Qualitative methods for organizational research: a preface**. Adm Sci Quart. 1979;24(4):520-38.
- 3 - Goldberg C. **Estratégia e humanismo** [internet]. 2020. [citado em 31 jun. 2020]. Disponível em: <<http://www.guiarh.com.br/y66.htm>>.
- 4 - Minayo MCS (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes; 2001.
- 5 - Boccato VRC. **Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação**. Rev Odontol Univ São Paulo. 2006; 18(3): 265-74.
- 6 - Weslley CR. **A mediação como meio de resolução de conflitos na área da Saúde**. São Paulo: Universidade Federal de Alfenas; 2018.
- 7 - Brasil. Resolução nº 238, de 06 de setembro de 2016. **Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública** [Internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 2016. [citado em 30 jan. 2020] Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.
- 8 - Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Recomendação nº 31, de 31 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde [internet]. Brasília: CNSS; 2010. [citado em 28 out 2019]. Disponível em: <http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/conass- direito_a_saude-ART_10B.pdf>.
- 9 - Morozowski A. **Judicialização da saúde** [internet]. 2019 [citado em 15 jul. 2020]. Disponível em: <<https://valor.globo.com/opiniao/coluna/judicializacao-da-saude.ghtml>>.
- 10 - Pinheiro MC. **Núcleos de assessoramento técnico: estratégia à judicialização da saúde?** [internet]. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública; 2016 [citado em 10 jul. 2020]. Disponível em: <<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2490/1/Mariana%20Pinheiro.pdf>>.



Projeto de intervenção no Município de Rio Branco/AC: Diagnóstico e caminhos para o enfrentamento da judicialização da saúde

Cristiane e Silva Santos¹

Isabelle Lins Filgueiras Almeida²

Mário Victor da Silva Bomfim Oliveira³

Patrícia Marques Magalhães⁴

Silvia Luciane Machado de Oliveira⁵

Orientador: Prof. MSc Ivan Pricken de Bem

O Curso de Especialização em Direito Sanitário com foco na judicialização teve como Trabalho de Conclusão um projeto de intervenção, em que grupos de alunos deviam eleger um município e fazer um estudo voltado às necessidades de saúde e o impacto das decisões judiciais no cotidiano da saúde municipal.

Para isso formamos o grupo batizado por Ambuá, do tupi guarani centopeia, em analogia ao artrópode que possui dezenas de braços/pernas que caminham de forma ritmada para um mesmo destino, tal como os cinco idealizadores deste projeto.

¹ Graduada em Direito pela UBM /RJ, pós-graduada em Direito Administrativo pela UBM-RJ. Assessora jurídica da SMS de Pirai-RJ.

² Graduada em Direito pela UFPB, pós-graduada em Direito do Trabalho pela ESMAT. Assessora jurídica da SMS de Sapé-PB.

³ Graduado em Direito pela FANESE. Advogado do COSEMS-BA.

⁴ Graduada em Enfermagem pela UEMS, pós-graduada em Saúde da Mulher pela UNIDERP-MS e mestre em Saúde da Família pela UFMS. Secretária Municipal de Saúde do Município de Antônio João-MS.

⁵ Graduada em Enfermagem pela UNICNEC. Secretária Adjunta de Saúde de Osório-RS.

A metodologia adotada partiu do perfil epidemiológico da população para, em seguida, traçar informações sobre quais medidas de saúde eram essenciais ao cuidado dos usuários locais, buscando saber as causas das principais demandas sanitárias do município para, a partir de então, programar um projeto exitoso de redução desse passivo judicial.

Os dados epidemiológicos do Município de Rio Branco foram obtidos por meio da análise apresentada no Plano de Saúde Municipal exposto pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco para os anos de 2014/2017 (1).

Utilizamos os últimos dados do SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) e atestamos que houve um crescimento de 2008 e 2012 no número de óbitos do município, fato que serviu de ponto de partida para detectarmos as fragilidades sanitárias e analisarmos as possibilidades de enfrentamento apresentadas no projeto (2).

Com base em tais elementos verificamos que um dos principais problemas enfrentados pelo município, no que tange às questões de saúde, é a disseminação de doenças contagiosas (leishmaniose, tuberculose e doenças diarreicas) potencializadas pelas condições de vida precárias e a baixa efetividade das políticas de controle, causando um impacto grande na morbidade da população.

A coleta de dados das demandas judiciais foi realizada com base nos processos em tramitação no ano de 2018, valendo-nos dos sítios eletrônicos da justiça estadual e contatos diretos com a Secretaria de Saúde de Rio Branco e a Procuradoria Geral local – responsáveis pelo controle direto de tais misteres e, inequivocamente, os mais aptos para precisar a quantidade total de demandas por ano.

Por fim, para buscas bibliográficas e direcionamentos de enfrentamento recorreu-se à base de dados do Scielo, Google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e banco virtual de monografias de algumas universidades brasileiras, uma vez que não havia muito material físico ao alcance para embasar e orientar a pesquisa.

Diagnóstico da Judicialização no Município

É importante registrar que enfrentamos grandes dificuldades na elaboração deste capítulo, posto que a disponibilização dos dados da judicialização da saúde pelo município só se efetivou mediante apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Registre-se, ainda, que o site do tribunal local (TJAC) não permite pesquisa por assunto ou pelo nome das partes, dificultando deveras o levantamento, não havendo como localizar demandas específicas de saúde contra a Prefeitura de Rio Branco ou Secretaria de Saúde em 2018 por meio de uma pesquisa livre.

Das informações levantadas constatou-se que o Município de Rio Branco, dentro desse turbilhão nacional de judicialização, possui um índice de judicialização da saúde moderado, apoiando-se em um judiciário acreano responsável que acata a tripartição de atribuições do SUS e não direciona penalidades de alto custo para os entes municipais.

Contudo, apesar do índice abaixo da média de judicialização, foi possível verificar que a maior problemática enfrentada judicialmente na área da saúde pelo município reside na dispensação de fraldas geriátricas, seguida por pleitos de medicamentos extra SUS. Da análise do levantamento das demandas atualmente ativas contra a saúde local, verificou-se que de cada 4 processos ajuizados, 2,8 demandam dispensação de fraldas e 1,2 medicamentos não incorporados (baixo custo).

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público rio-branquense é atuante e tem postura conciliadora, o que reduz o índice de judicialização, mas mascara o problema, visto que, assim como a judicialização, cria uma porta de entrada errada e perniciosa ao sistema, quebrando a isonomia de tratamento.

O relato recebido é de que tanto o *parquet* quanto os defensores públicos, ao buscar administrativamente a solução dos litígios, interferem nas listas de esperas já existentes, burlando o tratamento isonômico, ferindo a porta de entrada via SUS/regulação, manipulando o êxito do sistema e a programação financeira do gestor.

Assim, apesar do município contar com índice aceitável de judicialização, há de se observar que a problemática se encontra apenas maquiada por meio de demandas administrativas perante órgãos de fiscalização e apoio judicial à hipossuficientes.

O raciocínio advém da pouca notificação pela via da ouvidoria da Secretaria de Saúde que, apesar de implantada e em funcionamento, é preterida pelos usuários, que deixam de se valer de um serviço que funciona como uma ponte entre o usuário e a gestão de saúde, sem que se faça necessário burlar a porta de entrada, nem filas de espera.

Assim, apesar de contar com um diagnóstico judicial menos lesivo que a maioria dos municípios brasileiros, Rio Branco ainda precisa rever esse conjunto de ações que fazem parte do universo “porta de entrada extra SUS”, de forma a evitar desequilíbrio de verbas e desarmonia no tratamento isonômico obrigatório.

No âmbito do universo de demandas ajuizadas contra o Município de Rio Branco no ano de 2018, 51 recaíram sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, sendo: 42 referentes a pedidos trabalhistas diversos de servidores, 4 referentes a pedidos de indenizações de pessoas jurídicas e físicas (advindas ou não de condutas sanitárias) e 5 referentes a pedidos de fornecimento de medicamentos, insumos médico-hospitalares e fraldas higiênicas.

A grande parte das demandas ajuizadas no município, versam sobre medicamentos e fraldas geriátricas descartáveis, sendo o pleito de material de higiene pessoal o mais demandado, seguido pela busca de medicamentos não dispensados.

A demanda maior por fralda advém de usuários idosos, por estarem em situação de vulnerabilidade física temporária (acamados), por incontinência urinária senil, ou agravos de saúde definitivos que os impedem de realizar as necessidades fisiológicas em sanitários, seguidos, em menor número, por deficientes físicos.

Embora haja o desconto de até 90% na aquisição particular de fraldas em algumas farmácias particulares do município (programa “Farmácia Popular”) ainda assim há demanda judicial pleiteando-as. Tal fato se deve a condição financeira de muitos dos usuários que sequer podem pagar pela diferença do valor da fralda.

Entretanto, apesar de no Estado do Acre 98% da população utilizar o SUS, o número expressivo de judicialização é maior a nível estadual, ficando com a capital e os demais municípios apenas as demandas de atenção básica, em especial os pedidos descritos, como as fraldas e os medicamentos.

Sobre a representação processual, verificou-se que o Ministério Público Estadual do Acre exerce o papel de representante na maioria das demandas sanitárias opostas contra o Município de Rio Branco, seguido pela Defensoria Pública Estadual.

Quanto às decisões judiciais sanitárias contra a fazenda pública municipal, estas surgem, na maioria dos casos, quando há ausência de prestação adequada dos serviços públicos ou quando surgem de novas tecnologias de saúde ainda não acobertadas pelo SUS, levando os cidadãos a buscar a satisfação almejada perante o Judiciário – sob o agasalho do art. 196 da CF e sob o manto da Lei n.º 8.080/90 (3).

Tais decisões, como é cediço, em razão da integralidade e universalidade do direito à saúde, são predominantemente favoráveis aos autores e acabam por gerar problemas para o SUS, pois, repita-se, comprometem gravemente o orçamento destinado à saúde.

Isto porque soluções judiciais que envolvem recursos públicos e políticas sociais devem adotar critérios racionais e uma análise de cada caso, não se podendo adotar uma única solução para cada peculiaridade.

No universo das decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário em sede de 1ª instância – Comarca de Rio Branco-AC (Ações de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência, Mandados de Segurança e Ações Ordinárias C/C Tutela de Urgência) e 2ª instância – Tribunal de Justiça do Acre (Apelações e Agravos de Instrumentos Cíveis), em que se pleiteiam do Poder Executivo um direito à saúde, verificamos a quase inexistência de indeferimentos autorais, a não ser, é claro, os casos com defeitos processuais intrínsecos, a exemplo do processo abaixo, cujo objeto é fornecimento de fraldas geriátricas:

Processo: 0604107-91.2018.8.01.0070 – (...) x MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E ESTADO DO ACRE – FORNECIMENTO DE 160 FRALDAS GERIÁTRICAS. LIMINAR INDEFERIDA. “Verifica-se nos autos que o pedido de provimento de urgência formulado pelo(a) autor(a) confunde-se com o próprio mérito da demanda e, caso

concedido, esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que não é cabível em face da Fazenda Pública. Sendo assim, e considerando tudo mais que dos autos consta, haja vista que a sua eventual concessão esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (grifo nosso).

Dessa forma, ainda que o município de Rio Branco não possua demandas judiciais em números exponenciais, é comum que nas existentes, como nos demais municípios brasileiros, haja confirmação e abuso da legitimidade do Poder Judiciário para intervenção em decisões da administração pública.

Ora, é uníssono nos magistrados rio-branquenses a inobservância dos limites públicos gerenciais mínimos, não havendo preocupação em buscar informações que evitem desequilibrar a destinação de verba nem atingir políticas públicas exitosas, já que o cumprimento implica em realocação dos já escassos recursos públicos. Veja-se, por amostragem, decisões que retratam o afirmado:

0601464-63.2018.8.01.0070 – (...) x MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – FORNECIMENTO DE 360 FRALDAS MENSAIS, TAMANHO M ADULTO E KITS DE HIGIENE PESSOAL.” Em que pese o insumo requerido encontrar-se fora da lista de insumos disponibilizados pelo município, não cabe ao Poder Judiciário analisar a sua necessidade, ou se existe outro que o substitua, pois tal responsabilidade é atribuição exclusiva dos profissionais que assistem a parte. Portanto, se prescreveu tal tratamento é porque considerou que é o mais apropriado às peculiaridades clínicas do autor. Além disso, cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um ou outro tratamento [...] ademais, sendo o direito à saúde alçado à condição de direito fundamental, não pode o ente público, alicerçado a reserva do possível, postergar o cumprimento de seus deveres constitucionais. [...] Julgo procedente a ação (grifo nosso).

APELAÇÃO N.º 0603816-62.2016.8.01.0070 – (...) X ESTADO DO ACRE E MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. MEDICAMENTOS EXTRA SUS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ESTADO. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. LISTA DO SUS. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tocante à alegação de que fora da lista do SUS os medicamentos bem como necessário comprovar a ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS, entendo despro-

vindo de razão o ente público Apelante, na conformidade da tese pacificada e definida pelo Tribunal da Cidadania[...], afastando a tese de impossibilidade estatal quanto à referida obrigação, sem olvidar a problemática da escassez de recursos financeiros e da reserva do possível, facultado ao Poder Judiciário o controle de políticas públicas nas hipóteses de prejuízo aos direitos à dignidade humana, à saúde e outros, sem malferir o princípio constitucional da separação dos poderes (grifo nosso).

Portanto, é nítido que apesar de apresentar um índice abaixo da média nacional em termos de judicialização, o Município de Rio Branco também é refém das decisões pautadas por interpretações genéricas de conceitos e princípios constitucionais e do SUS, tais como a solidariedade dos entes, a integralidade e a universalidade.

Tal assertiva é tão verdadeira que quaisquer das decisões escolhidas para amostragem deste trabalho, é possível localizar a mesma “ladainha” jurisprudencial correspondente ao descrito:

1001682-08.2019.8.01.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE x ESTADO DO ACRE E MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. EM FAVOR DE (...). MEDICAMENTO FORTEC COLTER PEN 250 MG- TERIPATIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSE. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. ASTREINTES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. “Diante desses fatos, a substituída procurou o Centro de Referência de Medicamentos Especializado CREME, bem como a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, onde informaram que o referido medicamento não faz parte da lista do SUS (pp. 09/10 e 21/24 dos autos principais) [...] Em sendo assim, há de se ter em conta que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade dos entes de direito público na efetivação dos direitos relativos à sociedade, notadamente, aos idosos, crianças e adolescentes, é da União, Estados, Município e Distrito Federal, de forma solidária. Por isso, devem prestar o atendimento necessário na área da saúde, incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de medicamentos, suplemento alimentar, insumos, equipamentos, exames e procedimentos médicos”. [...] Agravo não provido (grifo nosso).

0601836.80.2016.8.01.0070 – (...) x MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E ESTADO DO ACRE – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CADEIRA DE RODAS E FRALDAS. “Como é sabido, o direito à saúde, como consectário natural do direito à vida, é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal em seu art. 196 [...] Compete, portanto, aos referidos entes públicos (União, Estados e Municípios, solidariamente), dentro dos limites que lhe são impostos, a obrigação de assegurar aos cidadãos o recebimento de medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação, que não possam ser adquiridos sem que haja comprometimento do sustento próprio e dos dependentes, na forma dos arts. 6º e 196, ambos da Constituição Federal. Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade dos Requeridos, tendo em vista a relevância pública do direito à saúde, de sorte que nossos Tribunais vem decidindo exatamente pelo dever não só do Estado, mas de todos os entes da Federação solidariamente, em fornecer medicamentos e insumos àqueles que não possuem condições de arcar com a aquisição [...] A resistência dos Réus quanto aos objetos desta demanda é inoportuna, vez que se utilizaram de argumentos frágeis que não se sustentam diante da origem da obrigação e princípios que socorrem aos autores. [...] Por sua vez, a Lei n.º 8.080/1990 disciplina o Sistema Único de Saúde, atribuindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, de forma que o cidadão pode optar por aquele que venha a prestar assistência à sua saúde. A Constituição Estadual, da mesma forma, prevê, em seu art. 181, que cabe ao Estado zelar pela saúde e o bem-estar da população. Estas normas são claras ao definirem a responsabilidade do Poder Público na satisfação, preservação e efetivação dos direitos referentes à vida e a saúde das pessoas [...] Julgo procedente o pedido formulado (grifo nosso).

Por conseguinte, do estudo das decisões do município retira-se que a linha condenatória do Poder Judiciário de Rio Branco é a mesma seguida por quase todo o judiciário nacional, qual seja: decisões quase sempre a favor dos usuários (ressalvados erros judiciais autorais), desconsiderando a destinação de verbas (previsão legal), planejamentos (decisões baseadas em estudos), legislação federal (lista de dispensação SUS), separação dos poderes (Constituição Federal), entre outros.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Em vista da crescente judicialização, instrumentos foram sendo criados para minimizar o fenômeno, sendo alguns mais eficazes que outros. Os Núcleos de Assistência Técnica, por exemplo, foram instituídos, mediante Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando auxiliar os magistrados nas demandas que tivessem por objetivo o direito à saúde. Nesse sentido, os núcleos surgem para proporcionar às assessorias dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais suporte técnico para a avaliação, sob o ponto vista médico/técnico, das demandas judiciais sanitárias, sejam tutelas de urgências ou não (4).

Assim, o NAT-JUS é um serviço de natureza consultiva, disponibilizado também ao Ministério Público e Defensorias Públicas, podendo agir mediante provocação na emissão de pareceres em matérias de maior complexidade técnica – que envolvam prestação de serviços públicos de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, leitos em unidades de terapia intensiva (UTI), tratamento médico, insumo nutricional, entre outros.

É importante salientar que, conforme preceitua a resolução, os pareceres técnicos dos NATs deverão sempre ser elaborados de acordo com critérios da Medicina Baseada em Evidências, entendendo-se esta como aquela que integra as melhores evidências de pesquisa em relação à enfermidade do paciente.

Ainda segundo a resolução, cada tribunal deverá instituir sua própria unidade, por meio de seus respectivos Comitês Estaduais de Saúde, observando na sua criação os termos do parágrafo segundo do art. 156 do CPC, que prevê o seguinte:

§2º. Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

Registre-se que, como forma de apoiar e incentivar a criação dos NATs estaduais, o CNJ instituiu um núcleo de apoio nacional (regulamentado por meio do Provimento n.º 84/2019, expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça), disponibilizado em seu sítio eletrônico, por meio do qual os magistrados de todo o país podem contar com o serviço de diversos profissionais de saúde, durante 24 horas, sete dias por semana. Tal núcleo funciona com profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência, com base em protocolos médicos e nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecendo o respaldo técnico necessário para atestar se a demanda é, de fato, urgente.

Para isso, foi desenvolvida uma plataforma digital, fruto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Saúde, para oferecer fundamentos científicos para as decisões dos magistrados de todo o país em julgamento de demandas de saúde. O banco de dados nacional abriga pareceres técnico-científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área da saúde, emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico (NAT-JUS), Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) selecionados e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS) (CONITEC), além de julgados na área da saúde.

No Acre, o NAT-JUS foi lançado oficialmente em fevereiro de 2017, no intuito de possibilitar que todas as ações judiciais de saúde distribuídas perante o Poder Judiciário local, que demandassem prestações em face do Sistema Único de Saúde (SUS), pudessem contar com parecer técnico com referências e coberturas locais (5).

Contudo, apesar do lançamento ter ocorrido há três anos, na prática, o núcleo sequer fora instalado, existindo apenas “no papel”. Tanto que, em reunião datada de 15 de outubro de 2019, foram retomadas as tratativas para real instalação do NAT-JUS.

Mesmo assim, conforme o estabelecido no antigo Termo de Cooperação Técnica n.º 17/2012, firmado entre o Estado do Acre e o Tribunal de Justiça do Estado, o NAT-JUS deverá ser coordenado por um magistrado e composto por técnicos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, com experiência em gestão, funcionando junto à Secretaria de apoio aos órgãos julgadores e administrativos (6).

Nos termos fixados na portaria de criação, o fluxo interno deve ser o seguinte: recebida a solicitação de parecer técnico, o magistrado coordenador determinará a distri-

buição imediata do pedido a um dos técnicos, verificando a matéria e volume afeto a cada profissional de saúde, salvo os períodos de plantão, em que a ação será remetida ao profissional plantonista. Assim, a partir do recebimento do pedido, o técnico do NAT-JUS terá um prazo de três dias úteis para emitir o Parecer Técnico, salvo os casos que forem sinalizados como urgentes pelo próprio solicitante ou verificados como risco à vida do paciente, os quais deverão ser atendidos em no máximo 48 (quarenta e oito) horas e encaminhados por meio preferencialmente eletrônico (5).

Quanto à composição, a portaria ainda especifica que aos profissionais designados é vedado possuir relação de qualquer natureza com a indústria farmacêutica, laboratórios ou profissional prescritor que possa vir a configurar conflito de interesses. Disciplina também que o técnico do NAT-JUS é responsável por esclarecer situação que sugira conflito de interesse decorrente dessas vedações, podendo declarar-se suspeito ou impedido em caso concreto (6).

Outra ferramenta instituída como tábua de apoio às lides sanitárias são os comitês de mediação sanitária, cujo conceito, funcionalidade e repercussões serão percorridos a seguir.

A literatura reconhece três formas de resolução de conflitos: a) as resoluções estatais – ou heterocomposição dos conflitos, como são conhecidas as decisões judiciais; b) as resoluções estatais negociadas entre as partes, realizadas no âmbito jurisdicional, como o do Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União; e c) em âmbitos extrajudiciais, privados ou não (7).

As relações em saúde transcendem a ótica bilateral do médico com o paciente para envolver muitos outros atores presentes em um sistema de saúde, criando condições favoráveis à judicialização. É nessa esteira que surge o comitê de mediação sanitária, funcionando como mediação entre órgãos para conflitos, servindo de ponto de intercessão/decisão baseado em um debate entre as partes envolvidas.

Graças à incentivos e reconhecimento de legalidade pelo Judiciário, Ministério Público e Defensorias Públicas, os comitês de mediação têm ganhado força e ajudado o SUS na resolução de conflitos, instituindo grupos de negociações, realizando trabalhos a

partir da demanda individual, mediando conflitos entre os usuários do SUS e os gestores da saúde, evitando, efetivamente, o aumento de lides judiciais.

No município de Rio Branco, contudo, não há essa ferramenta, nem tampouco de comissão que possa ao menos dialogar extrajudicialmente com os usuários antes que estes busquem auxílio judicial, mas conta tão somente com as audiências administrativas com o Ministério Público e denúncias por meio da Ouvidoria.

Perpassada a análise e “anamnese” estrutural e processual do município, a apresentação e críticas das ferramentas estratégicas existentes no cenário nacional, é igualmente importante apresentar as medidas impositivas, para a conjuntura rio-branquense, que não conta com as ferramentas estratégicas nacionais de enfrentamento e redução de passivos judiciais.

É importante ressaltar que a judicialização na saúde tem se mostrado um caminho sem volta, não só no território rio-branquense, mas em todo território nacional. Crescem em número exponencial as demandas que versam sobre pedidos sanitários, consoante a Tabela 1, construída com base em dados de 2017, apresentadas na 14ª edição do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (4):

TABELA 1. Justiça em números - Ano base 2017.

ASSUNTO	QUANTIDADE
Saúde (direito administrativo e outras matérias de direito público)	103.907
Fornecimento de medicamentos-SUS	312.147
Tratamento médico-hospitalar-SUS	98.579
Tratamento médico hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos-SUS	214.947
Assistência à Saúde	28.097
Ressarcimento ao SUS	3.489
Reajuste da tabela do SUS	2.439
Convênio médico com o SUS	1.037
Repasse de verbas do SUS	786
Terceirização do SUS	676

Planos de saúde (direito do consumidor)	427.267
Serviços hospitalares – Consumidor	23.725
Planos de saúde (benefício trabalhista)	56.105
Doação e transplante órgãos/tecidos	597
Saúde mental	4.612
Controle social e Conselhos de saúde	2.008
Hospitais e outras unidades de saúde	8.774
Erro médico	57.739
Total	1.346.931

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, esse caminho sem volta precisa ser um caminho sem saída? A resposta é, obviamente, negativa. Sentenças judiciais nascem de lides, lides nascem de desencontros de intenções, desencontros nascem da falta de assertividade e diálogo.

Portanto, tem-se como primeiro passo para a solução/enfrentamento do conflito, o incentivo ao diálogo. Diálogo esse que deve ser multidirecionado, mediado, assistido, ou seja, coordenado de forma a aglutinar o máximo de envolvidos possível.

Na prática, deve funcionar da seguinte forma, seguindo a cadeia de acontecimentos proposta:

- i. confirmação gerencial de objetos idênticos nas demandas repetitivas por meio de reunião envolvendo os setores envolvidos para entender se *a priori* trata-se apenas de erro em procedimentos internos;
- ii. abertura de linha de comunicação com os atingidos (usuários) para entender a raiz do problema, o motivo da frequência e autenticidade dos pleitos, na tentativa de frear a intervenção dos órgãos de defesa de direitos (Ministério Público e Defensoria Pública);
- iii. bombardeamento, em caso de abertura de demandas administrativas, aos citados órgãos de defesa com informações sobre a litude e plausibilidade dos pleitos, seja por intermédio de reuniões, informes e palestras, de forma a exaurir todos os vieses de questionamento - impedindo ao máximo o ajuizamento de demandas;

- iv. nos casos em que as etapas anteriores sejam malsucedidas, apresentação ao Judiciário de forma transparente a política do SUS para o problema e as formas de solução possíveis;

Essa é, portanto, a primeira linha de enfrentamento almejada, tendo, inclusive, de certa forma, já sido iniciada em Rio Branco, visto que a secretaria de saúde local conseguiu estreitar o debate em círculo, construindo uma relação de confiança com os órgãos de controle. Tanto que no decorrer do estudo, observou-se que houve, em 2018, uma redução gradativa no índice de judicialização.

Todavia, ainda que essa estratégia de enfrentamento esteja em adoção, é importante ressaltar a necessidade de aprimoramento na metodologia. Isto porque observamos que a secretaria de saúde ainda não dispõe de setor específico para tal gerenciamento, valendo-se apenas um servidor para atender todas as demandas administrativas, obrigando-os a renunciar dos direcionamentos e gerência à Procuradoria Geral quando as demandas são judicializadas (o que reforça a sugestão de necessidade de criação de banco de dados próprio).

Um setor de gerenciamento de crises, formado por uma equipe multidisciplinar, trabalhando juntamente com a ouvidoria e demais setores, criaria um espaço profícuo para soluções rápidas e praticamente sem custo.

Tal medida permitiria que o esforço iniciado nas tratativas pré-judicialização pudessem ser aproveitadas nas demandas judiciais, mediante uma articulação entre a Secretaria de Saúde, a Procuradoria e o Judiciário.

É inegável a necessidade do ente municipal sanitário estar à frente do desenrolar das lides judiciais, tanto para efeito de contingenciamento (desdobramento das decisões) quanto forma de prestar uma efetiva resposta à população local em relação aos tratamentos alternativos – àqueles despendidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) - esclarecendo competências e complexidade.

Destarte, aplicadas essas medidas, indubitável será o estreitamento da relação com a população, com os órgãos de defesa dos direitos e com o próprio Judiciário, desa-

celerando o ritmo das demandas judiciais e dando mais efetividade às políticas do SUS existentes.

Necessário também a utilização de um Sistema de Informatização alinhado a um programa desenvolvido juntamente aos profissionais e técnicos, inclusive o jurídico do município, atendendo as demandas da gestão. Um programa que permita ter acesso aos atendimentos do usuário na rede e/ou ter como alimentar com estes dados, quando necessário verificando o histórico do usuário/paciente dentro da rede pública municipal de saúde. Tal expediente possibilitaria conhecer o caminho percorrido pelo usuário/paciente até o pedido de judicialização.

Outro recurso necessário seria a instauração de um meio administrativo para que o usuário pudesse encaminhar a sua solicitação à esta equipe multiprofissional para análise e parecer de ação, evitando uma possível judicialização. Para esse recurso poder-se-ia agregar o serviço de ouvidoria existente, atrelando-o, quem sabe, à equipe de multiprofissionais, em que profissionais capacitados e treinados pudessem atender às demandas e encaminhar ao corpo de técnicos para o conhecimento e análise e resposta ao usuário.

Importante seria, ainda, a criação de uma estratégia de controle, produção de planilhas de controle de processos por solicitação de demandas por determinado medicamento, cirurgias etc., possibilitando um controle social de política pública a ser desenvolvida em determinada comunidade.

Por fim, a busca por parcerias com universidades locais, por meio de convênio para que estagiários do curso de direito, assistência social e administração, possam atuar junto à Secretaria de Saúde e à Procuradoria dando suporte ao corpo técnico da equipe multiprofissional.

Considerações Finais

O trabalho buscou realizar um estudo aprofundado na capital acreana, buscando entender o funcionamento sanitário, traçar informações sobre medidas de saúde essenciais, entendendo as falhas de gestão que geram judicialização e as causas das principais demandas sanitárias.

Malgrado toda a *via crucis* enfrentada no levantamento de dados - em virtude de: i) informação falseada passada por antiga integrante do grupo, ii) quase ausência de cooperação da secretaria municipal de saúde e iii) desprezo completo da procuradoria municipal - foi possível diagnosticar, traçar o mapa, entender a fonte dos problemas e estabelecer caminhos e soluções de progresso.

Conclui-se que Rio Branco está em fase incipiente de judicialização, diferente de grande parte das cidades brasileiras, com um número reduzido de demandas sob a responsabilidade exclusiva do município, um número razoável de demandas em solidariedade com outros entes (estado/União) e um subterfúgio involuntário em demandas de grande porte por posicionamentos singulares dos magistrados locais (tendência condenatória maior do Estado do Acre do que do Município de Rio Branco).

Entretanto, visualizamos que essa realidade trouxe o que identificamos como uma “despreocupação preocupante” por parte da administração da saúde rio-branquense, que apesar de manter um diálogo aberto com órgãos de defesa de direitos (Ministério Público e Defensoria Pública Estadual), não estruturou setor para tratar dos casos reincidentes, para conciliar previamente, para dar viés de resolutividade ou gerenciar crises, valendo-se apenas de um servidor para encaminhar todas as lides.

Urge para o município estruturar equipe multiprofissional, com sistema informatizado e técnicos da área da saúde, administrativa e jurídica, com função precípua de avaliar a plausibilidade das demandas, conciliar, analisar a possibilidade de atendimento do SUS e estreitar a relação com a Procuradoria Geral, evitando que as decisões processuais e defesas sejam feitas por um órgão distante da realidade diária e sem vivência do setor da saúde.

Além disso, conclui-se pela necessidade de criar uma rotina organizacional que compreenda, no mínimo, uma estratégia de controle, com produção de planilhas temáticas por objeto pretendido visando um controle social da política pública a ser desenvolvida para evitar o alastramento de passivos.

Outra saída engrandecedora apresentada no trabalho é o aproveitamento de estudos em parcerias com universidades locais, por meio de convênios que deem suporte técnico, suprimindo o déficit de mão de obra qualificada que suportam a maioria das repartições públicas. Tal saída é amplamente difundida em outras localidades, se mostra pouco dispendiosa e de grande retorno final.

Por fim, conclui-se que, tomadas essas medidas, ainda, haveria a necessidade de focar no monitoramento dos recursos incrementados, traçando ações estratégicas a partir dos indicadores de acompanhamento das lides, de forma a identificar ações que possam repercutir em passivos futuros, antecipando o aparecimento do problema e o diálogo com o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual, dentre outros.

Referências

- 1 - Prefeitura de Rio Branco. **Plano Municipal de Saúde**. 2014-2017. [internet] [acesso em 20 junho 2019]. Disponível em: <<http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/portal/legislacao/plano-municipal-de-saude-2014-2017/>>.
- 2 - Ministério da Saúde. DATASUS. **Departamento de Informática do SUS**. 2019. [internet] [acesso em 20 de junho 2019]. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sim/cnv/obt10ac.def>>.
- 3 - Brasil. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990. Congresso Nacional; 1990.
- 4 - **Conselho Nacional de Justiça**. NAT-JUS Nacional. [internet]; [acesso em 24 de março 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.
- 5 - **Tribunal de Justiça do Estado do Acre** [internet] [acesso em 31 de outubro de 2019]. Disponível em: <<https://www.tjac.jus.br/>>.
- 6 - Ministério Público do Estado do Acre. **Termo de Cooperação Técnica nº17/2012 – Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público**. [internet], [acesso em 30 de março de 2020]. Disponível em: <https://www.mpac.mp.br/wp-content/uploads/TJAC_.pdf>.
- 7 - D'Antonio, Suzete Souza. **Mediação Sanitária: diálogo e consenso possível**. Cadernos Ibero-Americanos De Direito Sanitário, vol. 5, n.º 2, pp. 8-22, 2016.

Capítulo 2

REGIÃO NORDESTE



Município de Aracaju-SE (1)

Município de Aracaju-SE (2)

Município de Cabo de Santo Agostinho-PE

Município de Campina Grande-PB

Município de Eunápolis-BA

Município de Juazeiro do Norte-CE

Município de Natal-RN

Município de Nossa Senhora do Socorro-SE (1)

Município de Nossa Senhora do Socorro-SE (2)

Município de Parnaíba-PI

Município de Patos-PB

Município de Recife-PE

Município de Salvador-BA

Município de São Luís-MA



Aracaju, a capital da qualidade de vida frente à judicialização da saúde

Darlina de Almeida Oliveira¹

Eliete Silva Nunes²

Gerald Saraiva Silva de Sordi³

Jackson Luis Arpini⁴

João Vitor Burgos Mota⁵

Juliana Pereira Nascimento Pedroza⁶

Luiz Marcelo Cabral Tavares⁷

Orientadora: Profa. MSc Letícia de Oliveira Fraga

O objetivo deste trabalho foi identificar por meio da ferramenta de monitoração as demandas judiciais provenientes do sistema de saúde do município de Aracaju/SE, apontados pela parceria realizada por intermédio do Termo de Cooperação entre o município e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde (CRLS) que visa solucionar e diminuir a judicialização no município.

¹ Graduada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Gestão Pública Municipal pela UFF de Volta Redonda. Membro da Comissão de Licitação da SMS de Macaé-RJ.

² Graduada em Enfermagem e em Licenciatura em Enfermagem pela Universidade Regional do Nordeste. Secretária Municipal da Saúde do Município de Esperança-PB.

³ Graduação em Farmácia Bioquímica pela UNG, mestre em Ciências pelo IPEN-USP. Coordenador da CIR da região de Vitória da Conquista-BA e membro da Diretoria do COSEMS-BA.

⁴ Graduado em Odontologia pela UPF, pós-graduado em Saúde Pública, pela Faculdade de Ribeirão Preto e em Gestão de Serviços de Saúde pela URI-Campus de Erechim-RS. Coordenador de Saúde na SMS de Erechim-RS.

⁵ Graduado em Direito pela UNIT – Aracaju-SE, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela UNISBA. Diretor do Núcleo Jurídico da SMS de Aracaju-SE.

⁶ Graduada em Enfermagem pela Unicesumar. Secretária Municipal de Saúde do Município de Cruzeiro do Sul-AC.

⁷ Graduado em Direito pela UFRJ, pós-graduado em Direito Processual pela UFJF e mestre em Direito pela UERJ. Procurador do Estado de Minas Gerais e Secretário de Estado Adjunto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

O município de Aracaju foi escolhido por possuir um alto nível de monitoramento da judicialização e por ser uma capital nacional, possuindo complexidade inerente às demais capitais do país, além de apresentar similaridades com municípios de menor ou igual porte.

A metodologia adotada foi de estudo descritivo que resultou em um projeto de intervenção junto à situação de judicialização no sistema público de saúde do município de Aracaju-SE.

Durante a pesquisa, foram abordadas questões institucionais, demonstração da ferramenta de monitoramento da judicialização, diagnóstico da rede, pontos de enfrentamento focado nas situações judiciais e melhoria nos resultados das condições peculiares ao município. Tais informações foram coletadas junto à Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, Defensoria Pública, Procuradoria Municipal e Poder Judiciário.

Os dados sobre processos judiciais foram coletados de acordo com as informações existentes do planilhamento dos processos ajuizados em face do município de Aracaju, a partir de 2017, ano em que se iniciou a monitoração das demandas judiciais e demais documentos.

As análises foram realizadas a partir dos critérios: quantitativo de demandas judiciais ajuizadas desde 2017 juntamente ao Tribunal de Justiça de Sergipe, organizados em planilhamento próprio da Procuradoria do Município e Secretaria Municipal de Saúde; dados disponibilizados em sítio eletrônico pela Prefeitura Municipal e relatórios da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju; consulta na forma eletrônica: IBGE, Ministério da Saúde e outros e consulta processual no *site* e-processos.

Foi feita avaliação das demandas judicializadas no âmbito do direito à saúde no município, individualizando os levantamentos quantitativo de casos, suas especificidades e estimativa de resultados, bem como suas repercussões em razão da judicialização.

Após a compilação dos dados e análises, estes também foram correlacionados com as iniciativas já aplicáveis e disponíveis ao Município de Aracaju-SE., para se obter a noção do impacto, sob o aspecto da judicialização no município, bem como a sugestão de novos e mais eficientes meios de solucionar e minimizar os problemas.

O levantamento propiciou o direcionamento para as áreas em conformidade com as necessidades processuais, com encaminhamento para soluções desde os órgãos administrativos (compra/processo licitatório) até mesmo os órgãos jurídicos para defesa, a fim de obter o controle da judicialização do município.

Diante dos dados da situação encontrada, foi possível propor soluções para o enfrentamento aos desafios, bem como sugestões para melhorias. A partir das propostas elaboradas para a situação identificada no município, a experiência poderá ser reaproveitada e adotada para outras localidades cujos problemas se apresentem de forma semelhante.

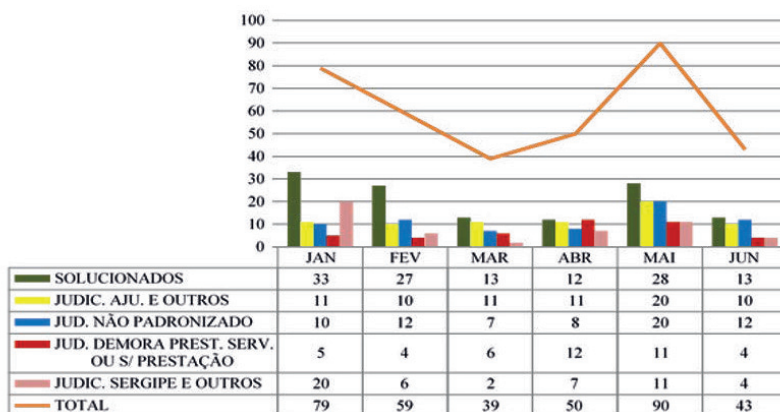
Diagnóstico da Judicialização no Município

Com o crescimento exponencial da judicialização da saúde no Brasil, que acarreta, por via de consequência, significativo impacto orçamentário na pasta da saúde dos respectivos entes federativos, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS), desde 2017, iniciou uma operação com vistas à identificação dos principais problemas reclamados pelos usuários perante a via judicial, mecanismo que possibilitou a posterior materialização de estratégias para o enfrentamento direto do fenômeno. Até a data referida, não havia registro de dados para o controle das demandas judiciais.

Diante disso, foi indispensável reforçar toda a estrutura administrativa da SMS, no sentido de possibilitar melhor enfrentamento dessa realidade, medida que se revestiu, na prática, a partir da implantação e do incremento de unidades especializadas dentro dos diversos setores da SMS para tratar da temática em comento, o que permitiu a identificação e a catalogação dos principais dados atinentes à problemática da judicialização da saúde, bem como trouxe mais subsídios técnicos para a defesa processual da Prefeitura, papel desempenhado pela Procuradoria Geral do Município (PGM).

Paralelamente, a SMS ainda contou com a reestruturação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), que tem o propósito de atuar junto à Defensoria Pública do Estado de Sergipe na pré-judicialização, evitando que reclamações sejam levadas à esfera judicial, reforço que gerou resultados positivos na promoção à saúde.

FIGURA 1. Gráfico do comparativo mensal (CRLS) - exercício 2018.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019-2020).

A consolidação dos dados aponta os resultados alcançados diante da reestruturação da Câmara de Resolução e Litígios em Saúde (CRLS) conforme Figura 1.

De início, a barra intitulada “solucionados” retrata o resultado positivo daqueles cidadãos que, inicialmente, buscaram a Defensoria Pública do Estado de Sergipe para ajuizar uma ação visando à garantia dos seus direitos à saúde. É nesse momento, antes do ajuizamento da ação, que a CRLS aciona, administrativamente, a Rede Municipal da Saúde de Aracaju e a Rede Estadual de Saúde de Sergipe, na tentativa de resolução pela via correta do Sistema Único de Saúde (SUS).

No tocante à barra intitulada “judic. Aju e outros”, percebe-se que a mesma demonstra os resultados daquelas demandas não solucionadas administrativamente, ajuizadas pela Defensoria em face do Município de Aracaju e/ou estado/União. Os números traduzem em menor quantidade, se comparados com os casos “solucionados”, mas atestam que mesmo com a CRLS atuante, algumas demandas persistem em não serem solucionadas pela via administrativa do SUS.

Já a barra “judic. Sergipe e outros” fornece, em números, as demandas não solucionadas administrativamente, ajuizadas pela Defensoria em face do Estado de Sergipe, da União e dos municípios do estado, com a exceção do Município de Aracaju, justi-

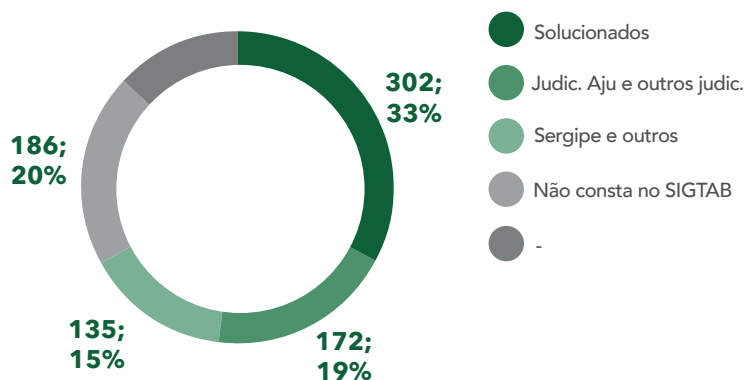
ficando-se tal exceção por existirem as competências de cada ente, estabelecidas pela Constituição Federal.

Ainda analisando os dados fornecidos pelo gráfico, a barra intitulada “não consta no SIGTAP” refere-se aos procedimentos médicos e cirúrgicos pleiteados pelos usuários que buscaram a Defensoria Pública, entretanto as tentativas administrativas engendradas pela CRLS para evitar o ajuizamento da ação não alcançaram resultado positivo, haja vista que tais procedimentos não se encontram inseridos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

A penúltima barra “prest. Serv. Em atraso ou sem prestador” traduz as ações da Câmara de Resolução em Litígios de Saúde (CRLS) que não atingiram, administrativamente, os anseios do cidadão, seja por ausência de prestador credenciado pelo Município de Aracaju ou pela não prestação dos serviços em tempo hábil, considerando o estado de saúde do cidadão, o que acarreta o ajuizamento da ação por parte da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, a qual representa o cidadão judicialmente.

Por derradeiro, a barra intitulada “total” revela, em números, a atuação mensal da função precípua que a CRLS possui, que é a oportunidade de buscar solucionar os anseios do cidadão, administrativamente, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual.

FIGURA 2. Gráfico do consolidado da CRLS - exercício 2018.

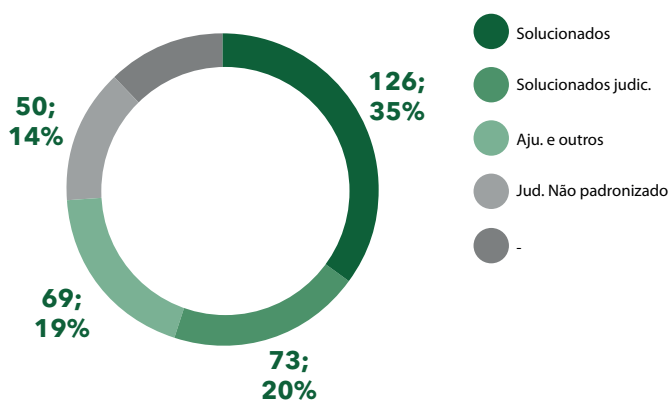


Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

O gráfico da Figura 2 aponta, em termos percentuais, os números já apresentados pelo gráfico da Figura 1, para melhor análise dos resultados alcançados pela Câmara de Resolução em Litígios de Saúde. Depreende-se, portanto, que do total catalogado pela CRLS, 33% dos usuários alcançaram o objetivo principal da função da câmara e, sobretudo, a imprescindibilidade do trabalho, perante a resolutividade dos anseios dos cidadãos que buscam o acesso ao SUS.

É de fundamental importância salientar a figura da referida câmara, pois sua atuação administrativa proporciona maior efetividade dos recursos públicos diretamente voltados às políticas sociais e econômicas da saúde, garantindo o acesso universal aos direitos sociais constitucionais.

FIGURA 3. Gráfico do consolidado da CRLS - exercício 2019.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

O consolidado apresentado no gráfico da Figura 3 traduz, em termos percentuais, os dados catalogados pela CRLS durante o exercício de 2019, mais especificamente a barra denominada “solucionados”, no importe de 35%, enfatizando o fundamental trabalho desenvolvido pela equipe composta por profissionais de saúde, multidisciplinarmente, o que diminui os gastos públicos, sejam eles inerentes aos recursos voltados à saúde, sejam aqueles destinados ao funcionalismo do Poder Judiciário.

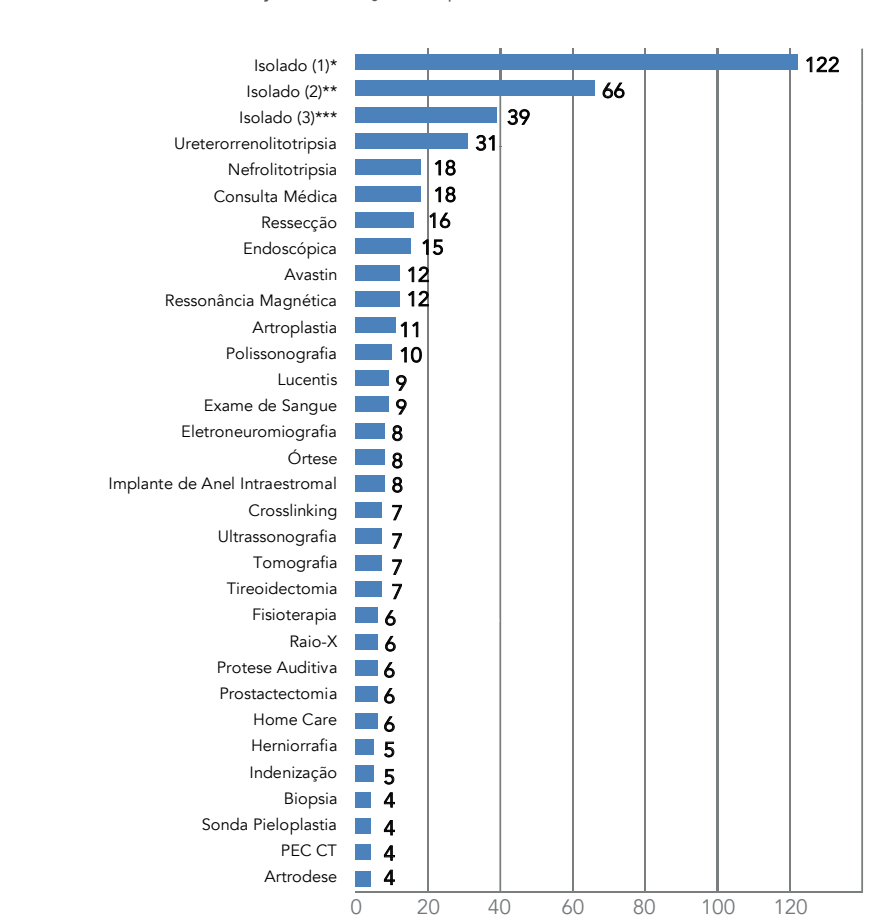
Desde 2017, ao catalogar todas as demandas judiciais constantes nos gráficos já apresentados, sejam elas da justiça estadual ou da justiça federal, identificou-se um dado curioso: os procedimentos, medicamentos ou insumos que foram ajuizados apenas uma única vez.

Para maior clareza, de acordo com o gráfico da Figura 4, logo a seguir, atesta-se que o maior índice de ocorrência dos procedimentos no exercício de 2018 são os chamados “isolado 1”, o que se traduz em procedimentos diversos demandados judicialmente pelos usuários uma única vez, diferentemente do procedimento situado na quarta colocação do *ranking*, denominado ureterorrenolitotripsia, que foi demandado em 31 (trinta e uma) ações judiciais.

A análise elaborada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, diante de tal atestação, é que os recursos orçamentários destinados à Rede Municipal de Saúde de Aracaju acabam sendo usados para ao cumprimento de demandas judiciais que determinam a realização de procedimentos que não são de competência do Município de Aracaju e não observam as obrigações tripartites, ou seja, acabam refletindo negativamente na rede de assistência à saúde da população de modo geral.

Outro fator que merece destaque na análise dos dados é a flagrante inobservância por parte dos magistrados da disponibilidade de alternativas terapêuticas na Rede Municipal de Saúde, tendo em vista que são proferidas decisões com o fito de determinar a realização de procedimentos oriundos da rede privada de saúde, portanto, sem levar em consideração as diretrizes políticas do SUS.

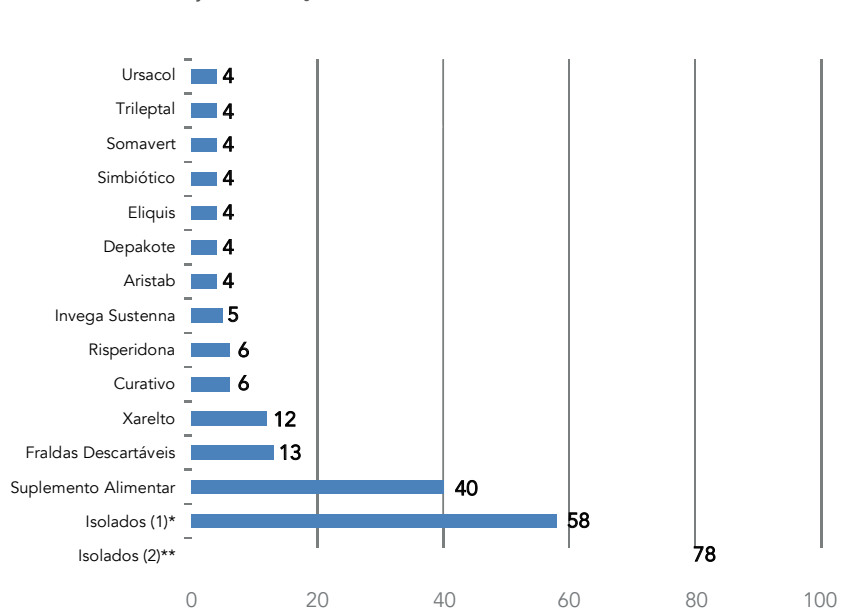
FIGURA 4. Gráfico da judicialização de procedimentos no ano de 2018.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

Para melhor entendimento dos dados apresentados no gráfico da Figura 4, mais especificamente os intitulados de “isolado”, é pertinente esclarecer que foram consolidados os diferentes procedimentos que tiveram um único ajuizamento no decorrer do ano de 2018 (isolado 1*), assim como aqueles diferentes procedimentos que tiveram apenas duas ocorrências (isolado 2**) e, por derradeiro, aqueles diferentes procedimentos que tiveram apenas três ocorrências (isolado 3**).

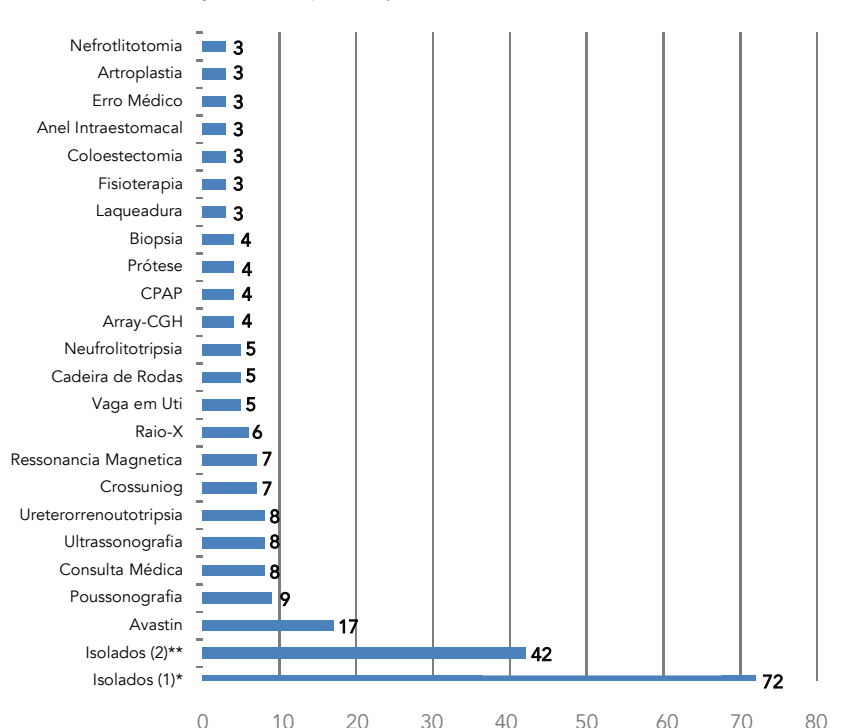
FIGURA 5. Gráfico da judicialização de medicamentos em 2018.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019-2020).

Para melhor entendimento dos dados apresentados no gráfico da Figura 5, mais especificamente os intitulados de “isolado”, consolidaram-se os diferentes medicamentos que tiveram um único ajuizamento no decorrer do ano de 2018 (isolado 1*), assim como aqueles diferentes medicamentos que tiveram apenas duas ocorrências (isolado 2**).

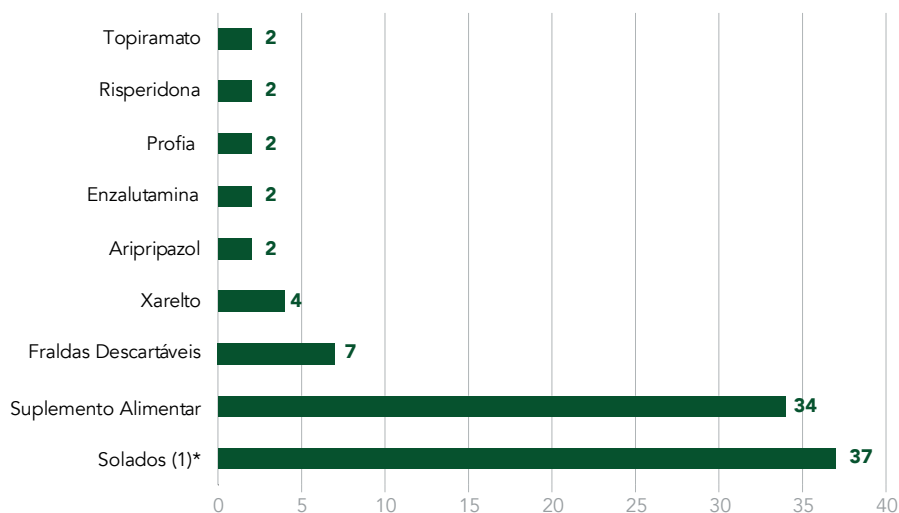
FIGURA 6. Gráfico da judicialização de procedimentos em 2019.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

Para melhor entendimento dos dados apresentados no gráfico da Figura 6, mais especificamente os intitulados de “isolado”, consolidaram-se os diferentes procedimentos que tiveram um único ajuizamento no decorrer do ano de 2019 (isolado 1*), assim como aqueles diferentes procedimentos que tiveram apenas duas ocorrências (isolado 2**).

FIGURA 7. Gráfico de medicamentos demandados uma vez em 2019.

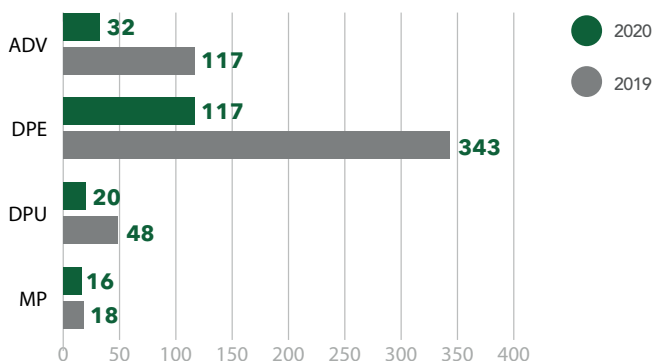


Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

Para melhor entendimento dos dados apresentados no gráfico da Figura 7, mais especificamente os intitulados de “isolado”, consolidaram-se os diferentes medicamentos que tiveram um único ajuizamento no decorrer do ano de 2019 (isolado 1*).

Os dados apresentados a seguir se referem à catalogação das demandas judiciais no quesito representação da parte autora, ou seja, de que maneira o cidadão acionou a justiça visando à garantia de seus direitos.

FIGURA 8. Gráfico da representação do autor (2018/2019).



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

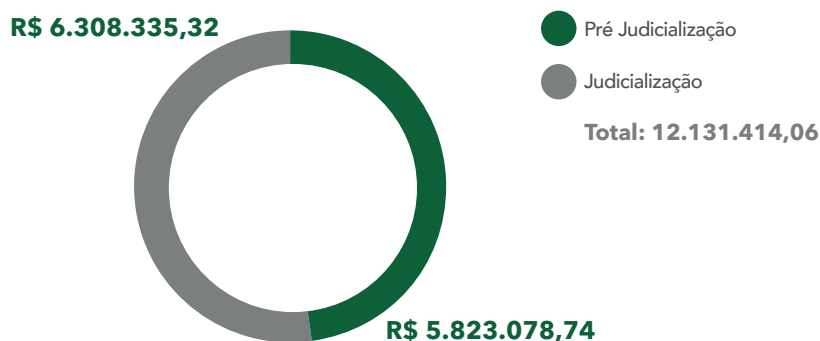
Na Figura 8, a barra intitulada “ADV” significa que o cidadão acionou a justiça sendo representado por um advogado particular, daí denota-se que a incidência no ano de 2018 foi maior que no ano de 2019.

A barra intitulada “DPE” significa que o cidadão acionou a justiça sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que se demonstrou, dentre todos os meios representativos que o cidadão possui para acionar a justiça, aquele de maior incidência. Diante das estatísticas apresentadas na relacionada barra, atesta-se que o trabalho realizado pela Câmara de Resolução em Litígios de Saúde (CRLS) é imprescindível, pois esta atua no órgão com maior ênfase na busca dos direitos e garantias constitucionais dos cidadãos.

A barra intitulada “DPU” significa que o cidadão acionou a justiça sendo representado pela Defensoria Pública da União, que ajuíza ações para satisfação das necessidades de saúde garantidas na Constituição Federal, sem a assistência técnica oferecida pela CRLS, situação que se revela de menor incidência.

Por fim, a barra intitulada “MPE” significa que o cidadão, na busca da resolução dos seus anseios de saúde, acionou o Ministério Público do Estado de Sergipe para garantir a prestação de qualquer dos serviços prestados pela SMS. Verifica-se estatisticamente que o MPE é o órgão que menos é acionado para garantia do direito à saúde.

FIGURA 9. Gráfico do resultado das ações da CRLS - 2019.

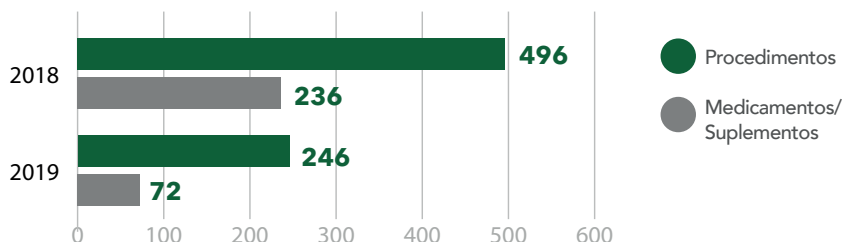


Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

A Figura 9, acima, apresenta os resultados das ações da CRLS em 2019. A função pre-cípua da referida Câmara é buscar solucionar, administrativamente, os casos daqueles cidadãos que recorrem à Defensoria Pública do Estado de Sergipe para a garantia dos seus anseios no tocante à prestação dos serviços de saúde, no âmbito da Rede Municipal da Saúde de Aracaju.

A pré-judicialização, ou seja, a busca da solução administrativa para atender aos anseios de saúde do cidadão antes da tutela judicial, demonstra-se imprescindível para a garantia da efetiva e correta utilização dos recursos destinados às políticas públicas de saúde.

FIGURA 10. Gráfico do consolidado judicialização.



Fonte: Tribunal de Justiça de Sergipe (2019- 2020).

Com os esforços proferidos por todas as equipes envolvidas na judicialização da saúde, constatou-se, por meio dos dados coletados nos anos de 2018 e 2019, que os números da judicialização sofreram queda considerável para a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju. É o que atesta a Figura 10, acima.

As medidas adotadas no enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde no decorrer dos anos proporcionaram à Administração Pública Municipal elaborar um cronograma com o intuito de atacar os pontos críticos identificados e mais demandados, criando mecanismos para conter o crescimento exponencial.

Assim, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju realizou uma verificação na programação dos medicamentos/insumos e dos procedimentos médicos/cirúrgicos, os quais são de obrigação para fornecimento do Município de Aracaju, dando início à identificação dos pontos em que a SMS poderia agir para promover a redução de gastos totais em compras judiciais, para que os recursos sejam aplicados nos programas essenciais da Rede Municipal de Saúde de Aracaju e, assim, seja prestado o melhor serviço de saúde possível, respeitando os princípios e diretrizes do SUS.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde, no intuito de prestar melhor serviço à sociedade e perante ao número decrescente da judicialização da saúde no município, na contramão da realidade enfrentada pela maioria dos gestores de saúde, deve apresentar novas estratégias de diagnóstico e enfrentamento que objetivem a qualificação de todo o aparato que envolve a pré-judicialização. Deste modo, é preciso que tenha intervenções que garantam o atendimento dos usuários na via administrativa, e, por consequência, a concessão da tutela buscada juntamente ao Poder Público por meio ordinário.

Dentro dessa perspectiva, resta claro que uma das formas de melhor promover o desenvolvimento da pré-judicialização é por meio da realização de parcerias que tenham por objeto a criação de intervenções que gerem resultados positivos do ponto de vista de economicidade e eficiência.

Na prática, as soluções digitais podem ser válidas para o enfrentamento da judicialização da saúde, tanto no município quanto em outras esferas de gestão do SUS. Assim é que, na atual gestão da Secretaria Municipal da Saúde, a intervenção manual do monitoramento de dados da judicialização, iniciada desde 2017, com a simples identificação das demandas, já demonstrou um satisfatório resultado no regresso da judicialização da saúde.

Considerações Finais

O projeto de intervenção analisou o fenômeno da judicialização no município de Aracaju.

Paralelamente, foi produzida uma análise da sistemática que envolve a rede de saúde do município estudado, especialmente de todo o aparato que envolve a fase anterior à judicialização de qualquer demanda referente à matéria de saúde por parte dos usuários do SUS, mecanismo que, manifestadamente, reduziu o índice de processos

judiciais em que a municipalidade em questão figura como parte demandada e melhorou a prestação dos serviços de modo geral, principalmente do ponto de vista da economicidade e da eficiência.

Nesse diapasão, foi demonstrada a importância da intervenção de todas as partes envolvidas no cenário da judicialização, principalmente dos trabalhadores da saúde e dos órgãos competentes, razão pela qual foram citadas proveitosas parcerias realizadas no âmbito da municipalidade em testilha para diminuir a judicialização da saúde, como a criação do NAT- JUD e da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde.

Ademais, restou demonstrada a imprescindibilidade da realização, por parte dos gestores de saúde, do monitoramento de todas as demandas judiciais que figuram como partes demandadas, tudo para que se tenha uma avaliação individualizada, caso a caso, e posteriormente se promovam as correspondentes intervenções para que sejam evitados novos acionamentos na justiça de pedidos que podem ser, muitas vezes, resolvidos pela via administrativa.

Por isso, é somente com base na qualificação da gestão e dos serviços em saúde, seja dos trabalhadores ou do aparato material/administrativo que envolve o sistema, e da realização de competentes parcerias que se pode propiciar o equilíbrio do sistema de saúde, promovendo-se políticas que visem à sustentabilidade da assistência e ao atendimento dos usuários de forma eficiente e visando sempre ao melhor aproveitamento dos recursos financeiros, o que não é possível caso se tenha um cenário de crescente judicialização.

Vale salientar que boa parte dessa necessidade se deve ao grande acervo legislativo que trata sobre o direito à saúde e às especificidades que cada caso requer, pois há dificuldade na compreensão do funcionamento do Sistema Único de Saúde de modo geral, seja por parte dos usuários ou até mesmo dos próprios especialistas em saúde, daí depreende-se a importância desta obra, que apresenta de forma clara e objetiva informações e a experiência diária de um município que, na contramão da realidade nacional, diminuiu consideravelmente a judicialização da saúde, isto tudo apenas

com medidas de enfrentamento que exigiram sensibilidade por parte da gestão ao identificar os principais problemas e assim criar mecanismos de intervenção simples, mas eficientes.

Diante disso, este projeto de intervenção levanta uma sugestão temática para futura pesquisa em razão de sua relevância para o ordenamento jurídico e ante a escassez de abordagem na corrente doutrinária: o controle interno exercido pelos gestores de saúde para identificar as principais deficiências na prestação de serviços aos usuários do SUS e a correspondente promoção de intervenções que visem à economicidade, à eficiência e à solução dos problemas pela via administrativa, mecanismos indispensáveis à proteção da rede de saúde e que diminuem o fenômeno da judicialização.



A judicialização em saúde no Município de Aracaju-SE

Alexsandra da Rocha Fontes¹

Anselmo Barbosa Oliveira²

Cristina Elias Maroun³

Danielle Moraes Gomes⁴

Diogo Nobrega Correa Lima⁵

Rubens Griep⁶

Zuila Jaqueline Lima Montel⁷

Orientadora: Profa. Dra. Luciane Anita Savi

A escolha do município de Aracaju para este trabalho teve como motivação o conhecimento da realidade do município que encanta a todos. Conhecendo as características do lugar, objeto desta pesquisa, não há como não tornar-se um apaixonado pela cidade.

Os dados relacionados às demandas judiciais, possibilitaram a proposição de alternativas para o enfrentamento da judicialização da saúde com base na organização do sistema e do acesso aos serviços de saúde.

¹ Graduada em Enfermagem pela FAESF. Enfermeira da SMS de Oeiras-PI.

² Graduado em Administração e em Direito pela Universidade Tiradentes. Coordenador da Assessoria Jurídica na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.

³ Graduada em Direito pela PUC de Minas Gerais. Assessora jurídica da SMS de Belo Horizonte-MG.

⁴ Graduada em enfermagem pelo CEUMA, pós graduada em Saúde da Família e Auditoria, Planejamento e Gestão. Secretária Adjunta de Saúde no Município de Pinheiro-MA.

⁵ Graduado em Farmácia pela UFAL. Sou servidor da SMS e de Arapiraca-AL no componente especializado da assistência farmacêutica.

⁶ Graduado em Enfermagem e Obstetrícia pela UNIOESTE e em Gestão Pública pelo IFPR. Enfermeiro da SMS de Cascavel-PR.

⁷ Graduada em Direito pela UNAMA. Assessora jurídica junto à SMS de Castanhal-PA.

A coleta de dados foi realizada por meio de fontes primárias obtidas por meio de sítios eletrônicos oficiais do Governo do Estado de Sergipe, da Prefeitura Municipal de Aracaju, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (<<https://cidades.ibge.gov.br>>) e do Departamento de Informática do SUS, bem como por meio de fontes secundárias obtidas nas Bases de Dados LILACS, Medline e Scielo a partir dos unitermos referenciados no DeCS/MeSH Judicialização da Saúde, Judicialização da Saúde Pública, Judicialização da Assistência Farmacêutica e Judicialização do Direito à Saúde.

Para análise do material empírico, adotou-se os procedimentos apresentados por Minayo (1), destacando-se o ordenamento do conjunto do material obtido por meio da pesquisa documental em planilha do Microsoft Excel® 2010, a pré-análise a partir dos objetivos gerais definidos para a pesquisa por meio da leitura flutuante, a classificação dos dados por meio da leitura horizontal e identificação das categorias empíricas e a leitura transversal do conjunto de dados e o recorte em tópicos de informação.

Essa análise permitiu o ordenamento e a classificação das demandas judiciais existentes.

Os dados coletados referem-se à judicialização do acesso amplo a medicamentos e procedimentos, considerados os processos que constem como parte demandada o Município de Aracaju, distribuídos junto às Varas de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública no ano de 2018.

Os dados foram obtidos por meio de levantamento efetuado na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, por intermédio do compartilhamento de informações e de levantamento dos dados disponíveis no órgão.

Diagnóstico da Judicialização no Município

Com o crescimento exponencial na judicialização da saúde no Brasil, acarretando significativo impacto orçamentário, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, iniciou uma operação, desde o ano de 2017 visando a organização dos setores envolvidos no tema.

Em 2017, não havia em alguns setores vitais da SMS, dados situacionais. Foi identificado que a Assessoria Jurídica não dispunha de qualquer registro de dados e, sobretudo, qualquer controle das demandas judiciais em andamento, muito menos qualquer conhecimento sobre a quantidade de demandas geradas em desfavor do SUS municipal.

Identificada a problemática da judicialização no município, reforçou-se a estrutura administrativa no sentido do enfrentamento da realidade vivenciada, em especial, com o incremento do setor técnico e jurídico especializado, o que acarretou mais subsídios para a defesa processual do município, papel esse desempenhado pela Procuradoria Geral do Município de Aracaju (PGM).

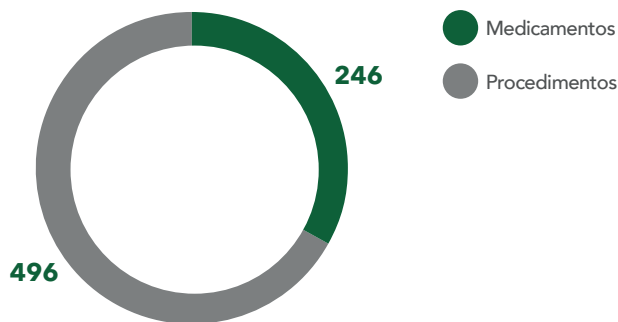
A partir de 2017, a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju deu início a uma série de ações internas visando catalogar e acompanhar todas as demandas judiciais nas quais figuravam no polo passivo o Município de Aracaju.

Houve a reestruturação da Câmara de Resoluções e Litígios de Sergipe (CRLS), com o propósito de atuar junto à Defensoria Pública do Estado de Sergipe na fase conhecida como “pré-judicialização”, viabilizando a resolução da demanda por meio da apresentação das opções terapêuticas disponíveis no SUS, antes da eventual evolução para um processo judicial.

Ainda como forma de enfrentamento, a SMS intensificou a participação juntamente ao Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário (NAT-JUD), com o fito de fornecer profissionais especializados e capazes de produzir informações técnicas diretamente ao Poder Judiciário, para tornar as decisões judiciais mais qualificadas, principalmente sob o ponto de vista técnico do funcionamento do SUS.

O procedimento de catalogação realizado pela Assessoria Jurídica da SMS de Aracaju resultou na tabulação de 742 pedidos judicializados em face do município, quer como parte única ou em solidariedade com outro ente, em tramitação nas varas de Aracaju, sendo 246 ações com pedidos de medicamentos e insumos, e 496 com pedidos que versavam sobre a oferta de procedimentos e exames.

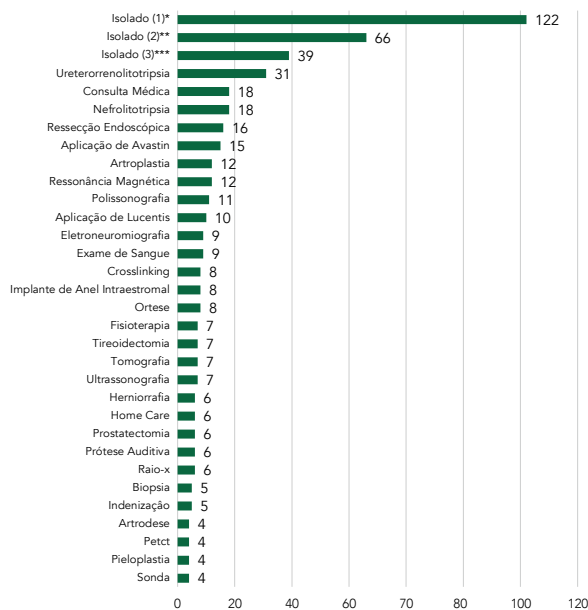
GRÁFICO 1. Demandas judicializadas em 2018.



Fonte: Assessoria Jurídica da SMS de Aracaju/SE.

Os pedidos judicializados, não estavam estipulados na tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

GRÁFICO 2. Judicialização de Procedimentos em 2018.



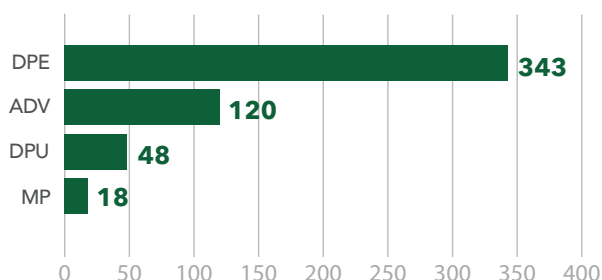
* Referem-se a procedimentos que foram solicitados apenas 1, 2 ou 3 vezes

Fonte: Assessoria Jurídica da SMS de Aracaju/SE.

Já em relação aos medicamentos, a maioria engloba medicamentos que não estão estabelecidos na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos), ou aqueles que são de responsabilidade do estado de Sergipe, mas que acabam sendo cobrados do município.

A distribuição dos processos considerando o representante do autor/paciente demonstra que cerca de 77% dos demandantes estão representados pelas instituições públicas como a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Estado, e apenas cerca de 23% estão assistidos por advogados privados.

GRÁFICO 3. Representação das demandas por proponente.



Fonte: Assessoria Jurídica da SMS de Aracaju/SE.

O crescimento das demandas judiciais na saúde é um tema atual, crescente e de grande relevância, que impacta o sistema de saúde, o sistema judiciário e o Poder Executivo. Enquanto os gestores da saúde tentam equilibrar os já escassos orçamentos, que muitas vezes são comprometidos por decisões judiciais que envolvem somas vultosas, os operadores do sistema de justiça buscam ponderar o que é realmente relativo à saúde e o que é peculiar ao SUS para decidir as demandas levadas à via judicial.

Com base nos dados elencados neste trabalho, observou-se que as decisões judiciais que envolvem o município de Aracaju fundam-se na necessidade apresentada pelo autor/paciente. Contudo, com a implantação do NAT-JUD percebeu-se uma tendência decrescente das concessões dos pleitos, ao considerar as notas técnicas emitidas pelo

núcleo. Assim, os processos judiciais passam a ser analisados também com o olhar da tecnicidade, responsabilidade do ente, capacidade e repartição de competências, de forma a tornar o acesso mais equânime.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Por meio da Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010 (2), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou aos tribunais que fossem adotadas medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, visando assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.

Uma dessas recomendações foi a indicação para celebração de convênios que objetivassem disponibilizar apoio técnico especializado em saúde, composto por médicos e farmacêuticos, a fim de auxiliar os magistrados na construção de um juízo de valor quanto à valoração das reais necessidades de cada postulante, principalmente em relação ao quadro clínico e alternativas terapêuticas.

A Resolução n.º 107, de abril de 2010 (3), do CNJ, instituiu o Fórum Nacional de Saúde com o escopo de estudar a judicialização da saúde e propor soluções para diminuir os conflitos nas demandas de saúde e dar efetividade ao direito à saúde, bem como estabeleceu a necessidade de criação dos Comitês de Saúde Estaduais, como instância adequada para encaminhar soluções para a melhor forma da prestação jurisdicional na área da saúde.

Em 2016, o CNJ editou a Resolução n.º 238, de 9 de setembro de 2016 (4), dispondo sobre a criação dos comitês estaduais da saúde, sob a responsabilidade de cada tribunal de justiça e tribunal regional federal.

Dentre as atribuições do Comitê Estadual, está a de auxiliar o tribunal na criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS).

Outra disposição da resolução foi a determinação para que os tribunais estaduais e federais, onde houvesse mais de uma vara de fazenda pública, promovessem a especia-

lização de uma dessas varas em vara especializada em matéria de saúde pública, o que até o momento não foi realizado no Estado de Sergipe.

Visando dar cumprimento à Resolução n.º 238, de 9 de setembro de 2016 (4), que disciplina a criação e manutenção, pelos tribunais de Comitês Estaduais da Saúde, a ainda diante das diretrizes formuladas pela Resolução n.º 107, de 6 de abril de 2010 (3) e da Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010, o Tribunal de Justiça de Sergipe, em 30 de novembro de 2016, celebrou com a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, com a Secretária Estadual de Saúde, com a Procuradoria-Geral do Município de Aracaju e com a Secretária Municipal de Saúde de Aracaju, Acordo de Cooperação Técnica visando a instituição do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário (NAT/JUD).

Diante da assinatura do acordo, foi editada a Resolução n.º 31/2016, de 19 de dezembro de 2016 (5), do Tribunal de Justiça de Sergipe que homologou o Regimento Interno do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário para demandas de saúde no âmbito do Tribunal de Justiça.

Somente em 11 de dezembro de 2018, com a assinatura do 2º termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica e edição da Resolução n.º 1/2019, de 10 de janeiro de 2019 (6), foi incluído dentre a finalidade do NAT/JUD o assessoramento também à Justiça Federal de primeiro grau da Seção Judiciária de Sergipe, e as demandas em face do IPESAÚDE (Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe), quanto a sua atuação em saúde pública.

O modelo adotado no NAT/JUD tem auxílio da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, que cederam os profissionais da área da saúde, tendo o Tribunal de Justiça disponibilizado a estrutura física onde o núcleo funciona, sendo no próprio Tribunal, além de convênios com outras instituições públicas.

No Município de Aracaju não existe Comitê de Mediação Sanitária, porém existe a Câmara de Resoluções de Litígios da Saúde formada na Defensoria Pública do Estado (7) e existe em tramitação no Comitê Estadual de Saúde uma proposta do Tribunal de Justiça do Estado em criar um Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Saúde (CEJUSC Saúde).

A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde da Defensoria Pública do estado de Sergipe foi criada por meio de resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Resolução n.º 10/2018, de 12 de setembro de 2018 (7) e regulamentada pela Portaria n.º 01/2018, de 30 de novembro de 2018 (8), e destina-se a atender à população que necessita da prestação de produtos e serviços do Sistema Único de Saúde, sejam medicamentos, suplementos alimentares, próteses, órteses, quimioterapia, radioterapia, procedimentos cirúrgicos, exames, entre outros.

O objetivo principal é propor uma solução administrativa permitindo o acesso dos usuários pela própria rede SUS, a fim de reduzir e/ou eliminar os custos financeiro e temporal que envolvem uma demanda judicial. As demandas que não têm resolução administrativa pela Câmara de Resolução de Litígios de Saúde são encaminhadas para judicialização.

A CRLS, a exemplo do NAT/JUD, é composta por equipe técnica especializada com profissionais cedidos da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.

Considerações Finais

O presente trabalho abordou a judicialização na saúde no Município de Aracaju-SE. Sabe-se que a judicialização na área da saúde tem crescido sobremaneira no Brasil, fato que afeta o planejamento dos entes federativos para a área da saúde.

Constatou-se que o maior número de demandas judiciais está concentrado nos pleitos por medicamentos e procedimentos, de modo que o enfrentamento ao problema requer a tomada de algumas decisões por parte dos gestores, bem como dos magistrados.

Nesse sentido, sugere-se que haja um diálogo intersetorial, a fim de haver maior esclarecimento sobre os procedimentos do SUS, devendo haver ainda respeito a esse regramento, bem como aplicação razoável e proporcional nas decisões, que por vezes determinam prazos impraticáveis para cumprimento.

Notou-se ainda, a necessidade de atualização da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e de demais procedimentos do SUS com maior frequência, a fim de diminuir as demandas judiciais sobre o assunto.

É cediço que o direito à saúde está constitucionalmente consagrado e destinado a todos os cidadãos, porém as demandas judiciais acabam por comprometer tal prestação, já que direciona o dinheiro do município ao cumprimento de demandas judiciais, comprometendo o orçamento de um indivíduo em detrimento dos demais. Assim, as ações propostas no trabalho visam mitigar a incidência de demandas judiciais, a fim de que todos os municípios sejam contemplados com o direito constitucional à saúde no Município de Aracaju.

Referências

- 1 - Minayo MCS. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. Ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: ABRASCO; 2014.
- 2 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Recomendação 31, de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. [Internet]. [citado 29 jan. 2020]. Brasília: Diário Oficial da União; 1 abr. 2010. Disponível em: <http://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf>.
- 3 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Resolução 107, de 6 de abril de 2010**. Institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. [Internet]. [citado 29 jan. 2020]. Brasília: Diário Oficial da União; 7 abr. 2010. Disponível em: <http://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_107_06042010_11102012191858.pdf>.
- 4 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Resolução 238, de 9 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. [Internet]. [citado 29 jan. 2020]. Brasília: Diário Oficial da União; 10 set 2016. Disponível em: <http://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_238_06092016_09092016173942.pdf>.
- 5 - Poder Judiciário do Estado de Sergipe (BR). **Resolução 31, de 19 de dezembro de 2016**. Homologa o Regimento Interno do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário para demandas de saúde (NAT/JUD). [Internet]. [citado 29 jan. 2020]. São Luis: Diário Oficial do Estado; 20 dez 2016. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/tjnet/publicacoes/visualizar_publicacao.wsp?tmp.idPublicacao=3023>.

6 - Poder Judiciário do Estado de Sergipe (BR). **Resolução 1, de 10 de janeiro de 2019**. Alterar, acrescentar e revogar dispositivos do Regimento Interno do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário para demandas de saúde – NAT/JUD, homologado pela Resolução nº 31/2016. [Internet]. [citado 29 jan. 2020]. Diário Oficial do Estado; 11 jan. 2019. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/tjnet/publicacoes/visualizar_publicacao.wsp?tmp.idPublicacao=26827>.

7 - Defensoria Pública do Estado de Sergipe (BR). **Resolução 10/2018**. Dispõe acerca da Criação e funcionamento da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde – CRLS da Defensoria Pública do Estado de Sergipe e dá outras providências. [internet]. [citado 29 jan. 2020]. Aracaju: Diário Oficial do Estado; 2010. Disponível em: <<http://www.defensoria.se.def.br/wp-content/uploads/2018/12/RESOLU%C3%87%C3%83%C2%BA-010.2018.pdf>>.

8 - Defensoria Pública do Estado de Sergipe (BR). **Portaria 01/2018**. Dispõe acerca do atendimento inicial, da documentação necessária à resolução administrativa e o fluxo-grama de atendimento da Câmara de Resolução de Litígios e dos CATES. [internet]. [citado 29 jan. 2020]. Aracaju: Diário Oficial do Estado; 2010. Disponível em: <<http://www.defensoria.se.def.br/wp-content/uploads/2018/12/Portaria-01.2019-CRLS.pdf>>.



A judicialização da saúde no Município de Cabo de Santo Agostinho

Alexandre Lencina Fagundes¹

Geraldo Jorge Filho²

Guilherme de Andrade Lima³

Sheila Salvino⁴

Tatiana Favorito⁵

Orientadora: Profa. MSc Leticia de Oliveira Fraga

Devido às particularidades do município do Cabo de Santo Agostinho, principalmente seu valor histórico, juntamente com a notável concentração industrial, turística e populacional dentro da região metropolitana da capital Recife, capital de Pernambuco, atrelado à possibilidade de acesso aos dados, optou-se pela sua escolha como objeto de estudo.

A metodologia para o projeto foi aproximada a uma pesquisa analítica, com abordagem qualiquantitativa, de caráter exploratório e descritivo, que culminou em um projeto de intervenção junto à problemática de judicialização no âmbito do sistema público de saúde municipal.

¹ Graduado em farmácia-bioquímica pela UFSM-RS. Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde-SC.

² Graduado em Administração pela UFPE, pós-graduado em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal pela UNINTER, em Direito Sanitário pela Fiocruz, em Contabilidade Pública e em Controladoria Governamental pela UFPE. Servidor da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco cedido à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

³ Graduado em Direito pela AESO e pós-graduado em Direito Público pela UNINASSAU. Assessor jurídico do COSEMS-PE.

⁴ Graduada em Filosofia pela UEMG e em Direito pela Faculdade Pitágoras, pós-graduada em Filosofia pela UFOP e em Direito Tributário pela FUMEC/OAB-MG. Assessora administrativa da SMS de Divinópolis-MG.

⁵ Graduada em Farmácia pela UNOPAR e pós graduada em Organização em Saúde pela UNICENTRO de Guarapuava-PR, e em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana pela Fiocruz. Chefe da Comissão de Farmácia Terapêutica.

Foi realizada durante a pesquisa, a coleta e análise de dados judiciais relativos ao município. Tais informações foram coletadas junto à Prefeitura, Secretarias Municipais, Defensoria Pública, Procuradoria Municipal e o Poder Judiciário, atentando a cada especificidade pelo contingente de trabalho, atuação, organização da rede pública de saúde, sobretudo da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Para a elaboração deste estudo elegeu-se como fontes primárias de pesquisa: legislações e atos normativos, artigos científicos, dissertações, publicações, documentos técnicos oficiais e processos judiciais; e como fontes secundárias foram levantados e analisados documentos produzidos pela gestão municipal e disponíveis na internet, a exemplo de informações relativas ao município, no sítio do Ministério da Saúde. Todos os dados coletados foram organizados, criando-se planilhas e gráficos para facilitar a análise e a apresentação em forma de tabelas, figuras e gráficos.

As análises foram realizadas a partir dos critérios: 1 - quantitativo de demandas judiciais ajuizadas desde 2018 perante dados ofertados pela Procuradoria do Município e Secretaria Municipal de Saúde, assim como em buscas virtuais, tendo em vista a utilização do sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) já implantado; 2 - dados disponibilizados pela prefeitura do município (2.1) em seu site eletrônico e/ou (2.2) Departamento de controle equivalente, quando disponibilizados; 3 - consulta na forma *on-line* a *site* do Ministério da Saúde e outros; 4 - consulta processual no *site* e processos eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e; 5 - por meio de visitas *in loco* para demais coleta de dados e informações.

Foi feita avaliação das demandas judicializadas no âmbito do direito à saúde na municipalidade, individualizando o levantamento quantitativo de casos, suas especificidades e estimativa de resultados, bem como sua repercussão em razão da judicialização.

Após a compilação dos dados e análises, também foram correlacionados com as políticas públicas já aplicáveis e disponíveis ao município do Cabo de Santo Agostinho, para se obter a noção do impacto, sob o aspecto da judicialização no município, bem como a sugestão de novos e mais eficientes meios de solucionar e/ou minimizar a problemática.

Por fim, diante do diagnóstico municipal, foi possível propor eventuais sugestões para soluções de enfrentamento aos desafios identificados. Das propostas elaboradas e sua viabilidade na municipalidade, surge o indicativo de que a experiência possa ser reaproveitada e adotada para outras localidades, cujos problemas se apresentem de forma semelhante.

Diagnóstico da Judicialização no Município

A par das mudanças dos cargos de direção da Administração Municipal ocorrida em outubro de 2019, sem que a Secretaria Municipal de Saúde tenha se configurado como exceção, em parte pela falta de registros dos processos pertinentes à judicialização, não foi possível chegar a todos os dados que se prestassem a proporcionar um retrato robusto da judicialização em Cabo de Santo Agostinho.

Esforços não foram medidos para buscar, pela via do acesso ao sistema de processos judiciais eletrônicos (PJE) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), os processos judiciais. Foram realizadas buscas na tentativa de localizar demandas na Vara da Fazenda Pública, que tivessem relação com a Comarca do Cabo de Santo Agostinho-PE. Foram feitas recorrências junto à SETIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação) e a própria diretoria do TJPE, contudo as mesmas restaram limitadas e sem muito sucesso; pois a ideia inicial era desvendar as informações a respeito dos processos, representação processual (Defensoria, Atermação em Juizado Especial, Advogado Particular, Ministério Público), origem do profissional prescriptor (SUS ou rede privada), natureza da decisão de obrigação de fazer (liminar ou sentença – se já julgado e qual seu resultado) e status da demanda. Porém, tal pretensão restou frustrada.

Sem a indicação dos nomes dos demandantes e, principalmente, do número dos processos, os resultados encontrados limitaram o estudo, configurando-se pouco relevante a ideia inicial, dado o quantitativo diminuto identificado. Todavia, ainda assim, foi extraído e identificado a problematização do referido município, que parte inicialmente de uma questão de controle e organização, refletindo majoritariamente no

acompanhamento e gestão de exames e procedimentos de análise aos cidadãos necessitados, que se utilizam do SUS.

Outra ressalva a ser apresentada decorre do fato de que pelas informações foi possível apenas consolidar o quantitativo de atendimentos prestados, não sendo possível precisar a quantidade de processos propriamente ditos e nem de pacientes atendidos, haja vista que, com alguma frequência, um mesmo paciente demanda mais de um serviço.

Registra-se, inicialmente, que foi procedida visita *in loco* no Município do Cabo de Santo Agostinho, precisamente em 31 de julho de 2019 na Secretaria Municipal de Saúde.

Certifica-se que com a visita ao Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, verificou-se dificuldade na obtenção de dados e informações juntamente aos órgãos, tendo sido observado, ainda, que o município não tem em sua composição ou, por definição de competência, setor específico que responda ou possua aptidão técnica para atuar, responder, esclarecer ou deliberar sobre o atendimento das demandas referentes a serviços e atendimentos de saúde e/ou ordens originárias do Poder Judiciário, ainda que segundo alegações dos servidores em contato, possuem boa relação de troca de informações com a Defensoria Pública e Ministério Público.

Verdade é, que durante a fase de coleta de dados e realização de diligências juntamente ao Município de Cabo de Santo Agostinho-PE, percebeu-se que a Secretaria Municipal de Saúde e a própria Procuradoria Municipal possuem problemas de registro e manejo eficiente de dados. Para se ter ideia, em momento algum nos contatos junto ao ente e as entidades do município foi mencionado ou atestado o acionamento do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS) para compreender os fatores técnicos dos casos específicos, bem como no auxílio e/ou intervenção dos processos aos magistrados, que não utilizam da oitiva prévia do gestor a respeito à competência ou alternativa terapêutica.

O Ministério Público, por sua vez, vale-se preferencialmente pelo ajuizamento de uma ação civil pública que repercutiu na formação de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), no que diz respeito à necessidade de realização de exames e procedimentos para a população, onde até então foi e continua sendo a maior quantidade de demandas

ajuizadas. Contudo, não se teve ciência de eventual provocação formal de informações prévias do gestor a fim de sanar o desequilíbrio do sistema.

Decerto que a proposta do trabalho tinha como escopo principal debruçar-se sobre o recorte da judicialização ocorrida no exercício de 2018 traçando um comparativo de sua evolução quando confrontados com os dados de 2019, mas a expectativa era de encontrar algum registro, seja de quantitativo de demandas judicializadas, seja do impacto financeiro por elas ocasionado, com o propósito de atestar que o município não escapa à realidade observada em grande parte dos demais municípios brasileiros, especialmente aqueles de médio porte como é o caso de Cabo de Santo Agostinho.

De início, é preciso ponderar que os dados analisados são produto de informações esparsas e não suficientemente consolidadas que foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo de Santo Agostinho e do trabalho de ‘garimpo’ realizado juntamente ao *site* do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), por meio de consulta processual unificada e da análise individual no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE). Logo, dada a deficiência do primeiro e as limitações de acesso do segundo, não foi possível afirmar que os dados são suficientes para traçar o perfil da judicialização no Município de Cabo de Santo Agostinho-PE.

Outro pormenor que não foi possível conhecer, em razão da escassez de informações, foi a origem do médico prescriptor. Saber se a judicialização decorre majoritariamente de demandas geradas por requisições emitidas no âmbito do serviço público ou se são oriundas da rede privada ou suplementar possui muita relevância na definição de estratégias para seu enfrentamento e, infelizmente, não foi possível.

Isso porque, se a origem da prescrição é a rede pública, várias perspectivas se abrem para a análise do fenômeno. Podem apresentar-se como fatores ensejadores da judicialização: a baixa capacidade instalada e represamento de demanda; a falta de fluxo assistencial motivada pela falta de prestador contratado ou município de referência (PPI); a solicitação indiscriminada de exames decorrente da falta de protocolos clínicos; e a solicitação indiscriminada de exames em razão da falta de adesão aos protocolos eventualmente existentes.

Sendo a judicialização majoritariamente procedente de prescrições da rede privada, as estratégias de enfrentamento seguem noutra direção, com destaque para o reforço de qualidade nas defesas processuais do municípios, notadamente com a demonstração de que eventual deferimento do pedido cria uma situação de privilégio para os pacientes que não são exclusivamente dependentes do SUS, na medida que, no âmbito do sistema, existe uma regulação de acesso que a todos submete, consistindo eventual concessão numa espécie de ‘clientela fechada,’ tão combatida no âmbito do SUS.

Contudo, ainda que não sejam eficientes para conhecer a exata dimensão da judicialização no município, os dados entabulados se mostraram suficientes para a identificação do grau de prevalência de algumas demandas e, logo, a possibilidade de enfrentamento da judicialização por meio de aprimoramento do serviço de regulação do acesso aos serviços de saúde.

O recorte da judicialização havida no Município de Cabo de Santo Agostinho-PE nos meses de abril a dezembro de 2019 assim se apresenta:

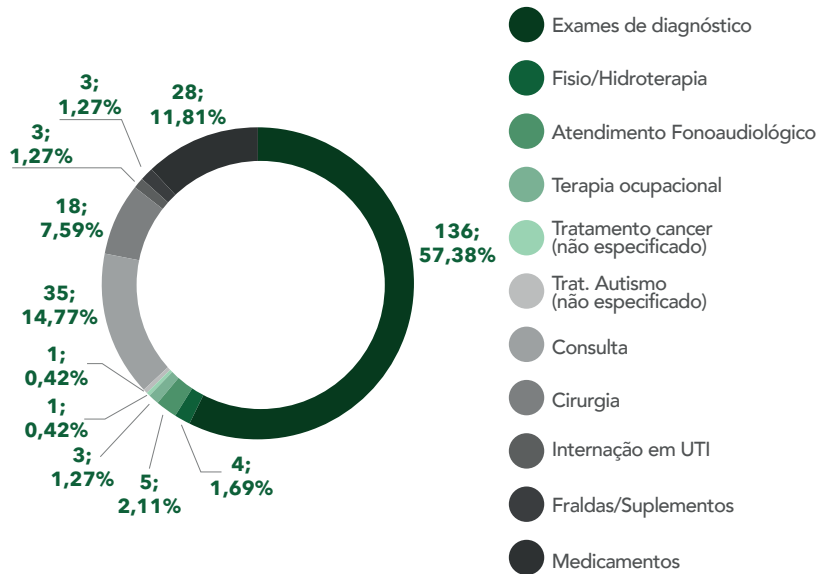
TABELA 1. Recorte da judicialização do Cabo de Santo Agostinho – (abr. a dez. de 2019).

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
EXAMES DE DIAGNOSTICO													
Ecocardiograma	-	-	-	2	5	3		1				1	12
Ressonância Magnética	-	-	-	18	17	11	8		1		2		57
Histeroscopia	-	-	-		2	1					1		4
Teste Ergométrico	-	-	-	2	1							1	4
Tomografia/Angiotomografia	-	-	-	3	4	4	1		1				13
Ultrassonografia com Doppler	-	-	-	2	2	1						1	6
Ultrassom	-	-	-	1	5		2					01	9
Exames Oftalmológicos	-	-	-	2	2	3				1			8
Audiometria/Impedancia/Otoneuro	-	-	-		5								5
Eletroencefalografia	-	-	-	3	2		1						6
Polissonografia	-	-	-	3									3
Estudo Genético - EXOMA	-	-	-	1									1
Exames Laboratoriais	-	-	-	1			1						2
ECG	-	-	-	2									2
RX	-	-	-	2									2
Endoscopia	-	-	-			1							1
PAAF	-	-	-				1						1
TOTAL DE EXAMES DE DIAGNOSTICO	-	-	-	42	45	24	14	1	2	1	3	4	136
FISIO/HIDROTERAPIA	-	-	-	1	1		1				1		4
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO	-	-	-	2		1	1					1	5
TERAPIA OCUPACIONAL	-	-	-	2		1							3
TRATAMENTO CANCER (NÃO ESPECIFICADO)	-	-	-								1		1
TRAT. AUTISMO (NÃO ESPECIFICADO)	-	-	-								1		1
CONSULTA				8	7	8	5	1		1		5	35
CIRURGIA				6	6	3	3						18
INTERNAÇÃO EM UTI					1		2						3
FRALDAS/SUPLEMENTO				1	1	1							3
MEDICAMENTOS					4	4	3	2			4	11	28
TOTAL GERAL	-	-	-	62	65	42	29	4	2	2	10	21	237

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo de Santo Agostinho e obtidas por meio do sistema web de consultas processuais do TJPE.

Conforme a Tabela 1, das 237 demandas judicializadas, os principais pedidos identificados no recorte utilizado são: disponibilização de exames de diagnóstico (57%), disponibilização de consultas médicas especializadas (15%) e fornecimento de medicamentos (12%).

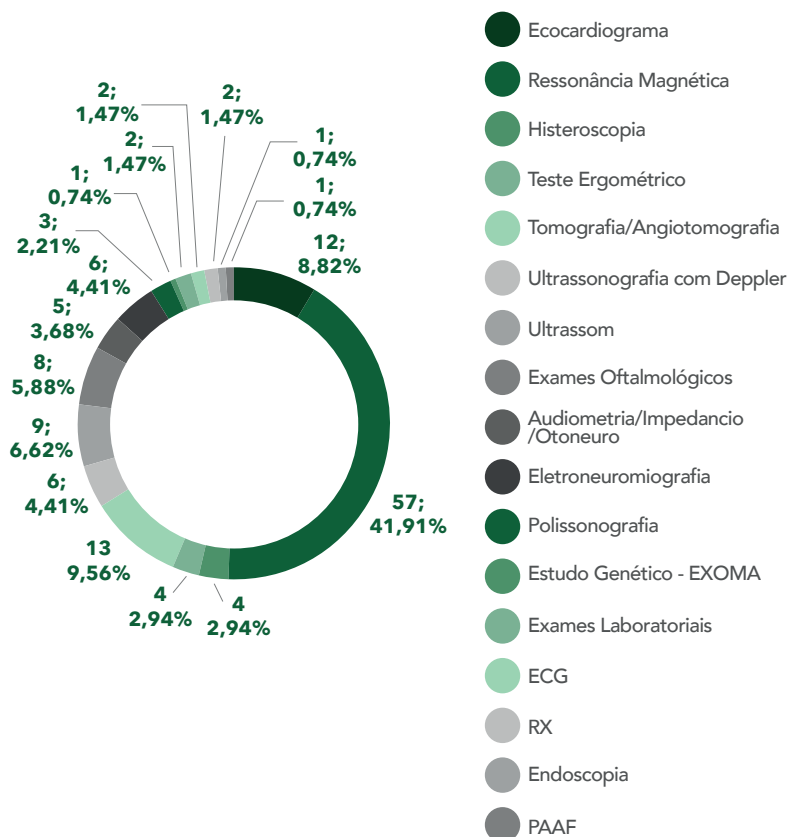
FIGURA 1. Recorte da judicialização do Cabo de Santo Agostinho (abr. a dez. de 2019).



Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo de Santo Agostinho e obtidas por meio do sistema web de consultas processuais do TJPE.

Por sua vez, no recorte de exames de apoio diagnóstico ilustrado pela Figura 1, chama a atenção a prevalência das ações cujo objeto é a realização de Ressonância Magnética, a saber: 57 pedidos ou 42% do referido recorte.

FIGURA 2. Judicialização de exames de apoio diagnóstico do Cabo de Santo Agostinho (abr. a dez. de 2019).



Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo de Santo Agostinho e obtidas por meio do sistema web de consultas processuais do TIPE.

A Figura 2 apresenta a judicialização de exames de apoio diagnóstico do Cabo de Santo Agostinho. Esses exames fazem parte do rol de procedimentos do SUS e são ofertados aos munícipes de Cabo de Santo Agostinho por meio do processo de regulação de vagas pelo município, disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde em centros próprios e contratualizados.

Outro dado que se mostrou quantitativamente proeminente é o número de demandas por consultas especializadas que foram judicializadas, sendo este o segundo objeto mais pleiteado.

É sabido que existe uma dificuldade compartilhada entre os municípios brasileiros, especialmente aqueles mais afastados dos grandes centros, de fixar profissionais médicos na rede pública, sendo esta dificuldade mais acentuada em relação aos especialistas. Logo, não raro, a demanda reprimida por consultas especializadas se apresenta bastante robusta e o gerenciamento das filas virtuais se apresenta como algo dificultoso.

A judicialização desta modalidade de atendimento é emblemática, pois, para além de eventual falta de capacidade instalada suficiente para responder à demanda, existe um processo relativamente recente de ‘especialização da medicina’ e de retração do número de generalistas e clínicos gerais. Num cenário de especialização e subespecialização ascendente, o fracionamento do saber coloca a demanda por consultas especializadas na ordem do dia.

Romper com esse processo que já está sedimentando culturalmente e, por consequência, está alterando o perfil das demandas por atendimento médico.

Decerto que esforços esparsos de fortalecimento da atenção básica, por meio da sua estratégia primeira: a saúde da família, embora sejam qualitativamente relevantes, tem pouco fôlego para conter um movimento que se consolida e que agrada aos menos críticos. Contudo, o modelo de atenção básica deve ser corporativamente defendido, sob pena de inviabilizar a plena implementação do SUS, sobretudo quanto à efetivação do princípio da integralidade.

Além dos medicamentos não figurarem entre os objetos de demandas mais reincidentes, identificou-se que, no geral, os pedidos são bastante pulverizados, não sendo possível salientar a ocorrência de um padrão de pedidos ou prevalência de determinado medicamento. Importante reforçar, também, que a ausência de série histórica para poder estabelecer comparativos dentro de um recorte temporal no qual fosse possível afastar a sazonalidade e identificar padrões impõe limites à análise e exige cautela nas conclusões.

Não obstante, as mencionadas limitações, o recorte utilizado no trabalho permitiu identificar uma maior incidência de judicialização na demanda pelo medicamento Eltrombopague Olamina, (cinco das 23 ocorrências), destinado ao tratamento da Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), uma doença autoimune gerada por um descontrole da produção de anticorpos que destroem e ocasionam um índice elevado de sangramento em diversas regiões do corpo.

Como o medicamento foi incorporado ao SUS apenas no final de 2018, com decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), publicada no dia 12 de dezembro de 2018, no Diário Oficial da União (DOU) (1), certamente a judicialização do fármaco em 2019, ainda foi motivada pela indisponibilidade do medicamento na rede pública, haja vista que, para a garantia da disponibilização das tecnologias incorporadas no SUS, está estipulado no artigo 25 do Decreto n.º 7.646/2011 o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação de sua oferta à população brasileira (2).

Outra situação relevante é a existência de poucos processos judiciais pleiteando o fornecimento de medicamentos que estão contemplados na RENAME e que são de uso extremamente comum, tais como: Losartana (1 caso), Clonazepam (1 caso), Atenolol (1 caso) e Anlodipino (1 caso).

Diante da falta de acesso ao processo, interpreta-se essas ocorrências como ter decorrido de eventual indisponibilidade temporária dos fármacos na rede pública, do fato de o demandante ser egresso da rede privada e, nesta condição, não ter buscado acesso direto à assistência farmacêutica pública ou, ainda, de falha no processo de comunicação entre o ente público e judiciário.

Os dados coletados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cabo de Santo Agostinho-PE não possibilitaram apurar o perfil da representação dos pacientes que judicializam demandas de saúde em quantidade suficiente para traçar um perfil minimamente conclusivo.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

As dificuldades encontradas para concretizar o projeto demonstraram a imprescindível necessidade do Município de Cabo de Santo Agostinho-PE se organizar no sentido de monitorar e avaliar o fenômeno da judicialização das políticas públicas em seu território.

Coincidiu ainda que o município, por período de aproximadamente um ano, desde outubro de 2018, teve o chefe do Executivo preso pela Polícia Federal e afastado de suas atividades. No seu retorno em outubro de 2019, exonerou todo o quadro de funcionários, o que certamente impactou a organização e arquivo de dados dos processos judicializados.

Em decorrência da falta de estrutura funcional, o município, na atual conjectura, não possui qualquer condição de, por si próprio, monitorar e avaliar o perfil das demandas judiciais atinentes à área da saúde pública, o que é inconcebível e temerário para um município com mais de 200 mil habitantes.

A falta de informações detalhadas a respeito da dinâmica de enfrentamento da judicialização no Município de Cabo de Santo Agostinho-PE permitiu apontar diferentes estratégias.

De início, é necessário salientar que a qualidade das respostas ofertadas pelo município em momento prévio à judicialização é de extrema importância. Nas oportunidades em que o município tem para se manifestar, toda a complexidade da demanda deve ser abordada, notadamente:

1. Eventual existência de oferta de tratamento eficiente para atender a demanda;
2. Identificação do caráter frívolo da demanda (p. ex. demandas da dermatologia estética);
3. Indicação do ente responsável pelo fornecimento do objeto da demanda (nos casos em que for pertinente);

4. Alegação e comprovação de que o atendimento da demanda judicializada tem o condão de prejudicar a assistência à saúde da coletividade.

A mera manifestação de indisponibilidade do medicamento ou de algum procedimento não se presta a inibir a judicialização que assiste com alguma frequência mais o conforto do que a efetiva necessidade.

As diligências feitas juntamente ao Município de Cabo de Santo Agostinho-PE apontaram que o trabalho da equipe que faz o manejo das demandas judiciais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde consiste tão somente na operacionalização do cumprimento das sentenças e liminares dentro dos prazos especificados (quando conseguem) sem, contudo, utilizar os dados da judicialização para repensar a rede de assistência e afastar, ainda que em parte, a incidência de demandas judicializadas.

O atual contexto da judicialização da saúde verificado no Cabo de Santo Agostinho-PE urge que o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, insira em seu organograma um setor específico para lidar exclusivamente com o recebimento e resposta às demandas relacionadas ao direito à saúde e políticas públicas da saúde.

A criação do Setor de Judicialização é uma ferramenta indispensável na qualificação das demandas judiciais de saúde pública na medida em que atua no controle quantitativo e qualitativo das ações judiciais desta área, capaz de auxiliar o gestor municipal do SUS nas respostas aos órgãos externos, além de monitorar e avaliar o fenômeno jurídico-social.

As minúcias técnicas da área da saúde aliada ao forte apelo social a ela atinente exige que o ente público invista na qualificação dos seus servidores que, por sua vez, serão responsáveis pelo refinamento técnico das suas manifestações e defesas.

Com a criação do Setor de Judicialização, o Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, seja dentro da própria procuradoria ou vinculada à Secretaria Municipal de Saúde poderá controlar os prazos judiciais para cumprimento das decisões, qualificar as respostas prestadas ao Poder Judiciário à luz da legislação estruturante do SUS e prestar subsídios contundentes à Procuradoria do Município para a defesa em juízo.

De posse de instrumento de diagnóstico o Setor de Judicialização poderá criar planilha ou ferramenta equivalente que informe o nome do usuário ou autor da ação, pedido, doença, origem da prescrição, representante processual, unidade judiciária, conteúdo da decisão e o julgamento da ação.

Outra forma de controlar tais dados da judicialização é a implantação de processo administrativo eletrônico (PAE) pelo município, por meio do qual será possível obter relatórios específicos sobre o tema. O uso do PAE é de extrema importância, sobretudo como respaldo para eventual ação judicial interposta por cidadão que postula necessidades, onde por exemplo, já poderia ter procurado a Farmácia Municipal para utilizar os medicamentos disponíveis na rede pública para o tratamento de determinada patologia e caso negativo seria possível derrubar a alegação de que já utilizou sem sucesso das alternativas do SUS.

Ao passo que essa repartição consolide sua atuação com o registro dos dados e acompanhamento dos casos será possível avaliar e criar estratégias que atendam à realidade peculiar do município em estudo.

Ademais, a atuação do Setor de Judicialização compreende a abordagem aos autores envolvidos na judicialização, como diálogo permanente com os magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, procuradores e, inclusive, com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.

Diante do contexto da judicialização da saúde no município de Cabo de Santo Agostinho-PE não foi possível prever, num primeiro momento, a criação de Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) ou Câmara de Mediação Sanitária sem que antes seja criado o Setor de Judicialização, já que é preciso partir da premissa de que a Secretaria Municipal de Saúde precisa primeiramente dimensionar as demandas judiciais de saúde em termos quantitativo e qualitativo e monitorar a atuação dos atores (juiz, promotores, advogado, defensores e procuradores) para somente então, avaliar a viabilidade das ferramentas estratégicas.

Convém salientar que a adoção de medidas preventivas à judicialização consiste na valiosa ferramenta para o enfrentamento da cultura do ajuizamento de ações rela-

cionadas ao direito à saúde, todavia, sua implementação passa necessariamente pela estruturação de outros componentes e organização do fluxo interno.

Caso o município de Cabo de Santo Agostinho-PE obtivesse condições de definir o perfil das demandas judiciais de saúde seria possível a criação de uma Câmara de Mediação Sanitária que conduzisse o usuário a buscar as alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento de sua doença, o que consequentemente contribuiria para a otimização das políticas públicas de saúde pelo gestor municipal.

Não resta dúvidas que a Câmara de Mediação Sanitária enquanto vinculada ao município poderia ainda oferecer suporte a Defensoria Pública e ao Ministério Público – representantes processuais que mais ajuízam ações sobre direito à saúde em Cabo de Santo Agostinho-PE – para racionalizar o acesso à saúde aquele que buscasse assistência fora do Sistema Único de Saúde ou que necessite judicializar.

Considerações Finais

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o município pernambucano de Cabo de Santo Agostinho, retratar e analisar o seu perfil em relação à judicialização da saúde sob a ótica da caracterização dos principais aspectos desse fenômeno, da forma como a judicialização da saúde afeta a estrutura do Sistema Único de Saúde no município e dos possíveis caminhos a seguir para mitigar seus efeitos.

A maior parte dos problemas decorrentes da judicialização da saúde no município estudado decorreram de falhas nos processos de regulação de exames diagnósticos, principalmente os de ressonância magnética, ecocardiograma, tomografia/angiotomografia, e ultrassonografia com doppler, ofertados pelo Estado de Pernambuco por meio de disponibilização de vagas no processo de regulação que é realizado pelo município.

Em razão das perspectivas estruturais, conclui-se que o município de Cabo de Santo Agostinho-PE não tem desenvolvido medidas para o enfrentamento da judicialização da saúde, talvez pelo cenário conturbado na política local, bem como pela falta de integração dos poderes.

Dessa maneira, a implantação de um setor específico para acompanhamento e controle dos dados e das demandas judiciais, bem como a criação da Câmara de Mediação Sanitária seriam de grande valia para qualificar o perfil das demandas judiciais, podendo atuar como meio para preveni-las, reduzindo custos com a judicialização e diminuindo o risco de majoração do fenômeno.

Importante salientar que mesmo com as limitações impostas ao trabalho, verificou-se que o município de Cabo de Santo Agostinho-PE possui enorme potencial para implantação de processos estratégicos voltados à judicialização em razão de possuir demandas identificadas como de baixa complexidade, sobretudo passíveis de solução com uma boa gestão e direcionamento de verbas a fins específicos.

Futuras pesquisas deverão focar os esforços em levantar um conjunto mais robusto de dados e informações que serão relevantes para, baseando-se em um diagnóstico mais preciso, promover uma melhor compreensão e ampliar o entendimento acerca dos efeitos diversos provocados pela ação do Poder Judiciário na organização da estrutura de saúde do município. Destaque-se que este projeto aponta estratégias e metodologias com intuito de organizar e fortalecer a gestão da pasta da saúde municipal.

Referências

- 1 - Brasil. Ministério da Saúde. **Eltrombopague olamina é incorporado ao SUS para portadores de doença sanguínea**. [acesso 15 jan. 2020]. Disponível em: <<http://conitec.gov.br/ultimas-noticias-3/eltrombopague-olamina-e-incorporado-ao-sus-para-portadores-de-doenca-sanguinea>>.
- 2 - Brasil. **Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011**. Dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS e dá outras providências. [acesso em 22 fev 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7646.htm>.



Projeto de intervenção no Município de Campina Grande: Mitigando os efeitos da judicialização da saúde

Alexandro Figueiredo Rosas¹

Daniela Costa dos Santos²

Lidiane Nascimento Cassimiro³

Luís Eduardo Ferreira Falcão⁴

Rodrigo Macedo Dantas⁵

Sidnei Louro Jorge Júnior⁶

Orientadora: Profa. Dra. Luciane Anita Savi

O presente estudo tratou de uma pesquisa exploratória sobre o conjunto de dados disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande-PB que, gentilmente, cedeu às informações necessárias para a identificação das ações judiciais cujo objeto é o fornecimento de medicamentos, em trâmite no ano de 2018. Tal abordagem foi escolhida a fim de proporcionar maior familiaridade com o problema, com a finalidade de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.

¹ Graduado em Fisioterapia pela UniEVANGÉLICA, e pós-graduado em Saúde Pública e Saúde da Família pela UniEVANGÉLICA. Secretário Municipal de Saúde de Campo Limpo de Goiás-GO.

² Graduada em Farmácia-Bioquímica, Mestre em Ciências Farmacêuticas e Doutoranda em Biotecnologia aplicada à Judicialização da Saúde, pela UFOP.

³ Graduada em Saúde Coletiva pela UFRGS. Assessora técnica no COSEMS-RS.

⁴ Graduado em Direito pela Mackenzie. Assessor técnico de Gabinete e membro do Núcleo de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo.

⁵ Graduada em Direito pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna. Superintendente de Administração e Planejamento na SMS do de Eunápolis-BA.

⁶ Graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFRN. Secretária Municipal de Saúde no Município de Monte Alegre-RN.

O município de Campina Grande, na Paraíba, foi escolhido pelo seu porte e também pelo fato de ser referência regional para a média e alta complexidade no SUS.

Buscou-se investigar os dados sobre os processos judiciais que pleiteavam produtos ou serviços para a saúde junto à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde que, por sua vez, realizou o detalhamento de todos os processos judiciais e disponibilizou os arquivos. Na Procuradoria Geral do Município de Campina Grande-PB a busca foi infrutífera porque não existe banco de dados organizado com as demandas de judicialização do SUS.

As ações judiciais identificadas limitaram-se à categoria dos medicamentos e os dados obtidos foram analisados. Por fim, foram elencadas sugestões de melhorias e intervenções que pudessem contribuir no cenário da judicialização de medicamentos encontrado no município em estudo.

Diagnóstico da Judicialização no Município de Campina Grande

A realidade local do município apontou para uma efetiva carência no que se refere à prestação de serviços de saúde, que se torna evidente por meio do ajuizamento de demandas sanitárias em face do Município de Campina Grande.

A coordenação da assistência farmacêutica, juntamente com a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, organizou estratégias administrativas e logísticas para atender as demandas judiciais, principalmente para fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares.

No ano de 2015, fortaleceu-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde a “Farmácia Jurídica”, para atender às demandas motivadas por ordens judiciais, mas considerando os aspectos técnicos e legais que regulam o fornecimento de produtos para a saúde, em especial os medicamentos. Ressalta-se que em algumas das demandas analisadas, não é possível considerar que houve uma análise técnica mais a fundo dos medicamentos requeridos e, por isso, entende-se que cabe às secretarias de saúde organizar o aten-

dimento observando a legislação sanitária, a fim de proteger o cidadão de prejuízos à saúde decorrentes do uso inadequado dos produtos concedidos judicialmente.

Em síntese, quando uma nova demanda que envolve fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares chega à Secretaria, são entregues cópias de todo o processo para a farmacêutica responsável, que realiza o cadastro das ações judiciais com informações como: data de ajuizamento da demanda, número do processo, a vara judiciária respectiva, o autor do processo, o tipo de solicitação e o atual estágio da demanda.

Tomando por base tal cadastro, a Farmácia Jurídica informa à Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF para providenciar eventuais estoques dos produtos para o cumprimento da ação.

A responsabilidade pelo estoque de medicamentos, contratos de fornecimento e toda previsão orçamentária específica para o atendimento dessas demandas é da CAF a qual, após avaliação e autorização, encaminha o medicamento ou o material hospitalar para a Farmácia Jurídica.

Nota-se que a experiência local concluiu que a participação do profissional farmacêutico foi essencial para este fluxo operacional, uma vez que, por conhecer os aspectos técnicos das solicitações, reduziu o número de erros nos cadastros. O cadastramento é etapa chave da organização e do planejamento da Secretaria de Saúde para os cumprimentos, uma vez que desencadeia os processos de aquisição e orienta os demais fluxos operacionais envolvidos no cumprimento das ordens judiciais, além do planejamento financeiro e orçamentário.

O procedimento, assim estabelecido, garante celeridade ao fornecimento do medicamento ou dos materiais solicitados, evitando-se descumprimento da decisão judicial e as indesejáveis consequências do seu não atendimento, procurando trazer maior eficiência administrativa ao município. Acaso se aguardasse para que fosse realizado processo licitatório posterior, fatalmente os exíguos prazos estabelecidos pelo Poder Judiciário não seriam cumpridos.

Em 2018, conforme informações prestadas pela Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, com base em relatórios internos emitidos

pelo Sistema que gerencia a Secretaria, gastou-se diretamente R\$ 2.595.876,46 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais, quarenta e seis centavos) com demandas judiciais para fornecimento de medicamentos, procedimentos hospitalares e equipamentos.

Mediante registros da Farmácia Jurídica, identificou-se que foram atendidos cerca de mil demandantes durante o ano de 2018, cumprindo com quase todas as demandas pleiteadas judicialmente, sempre objetivando o cumprimento integral, onde são distribuídos mensalmente cerca de 2.300 itens entre medicamentos, suplementos e materiais hospitalares.

No que se refere aos medicamentos menos onerosos e de maior facilidade de aquisição, a CAF consegue suprir a demanda de forma satisfatória. No entanto, as demandas judiciais de medicamentos de maior custo ou materiais hospitalares são mais onerosos e de difícil aquisição, tornando-se de difícil cumprimento. A Tabela 1, a seguir, evidencia algumas dessas situações:

TABELA 1. Demandas Judiciais mais onerosas em Campina Grande – PB.

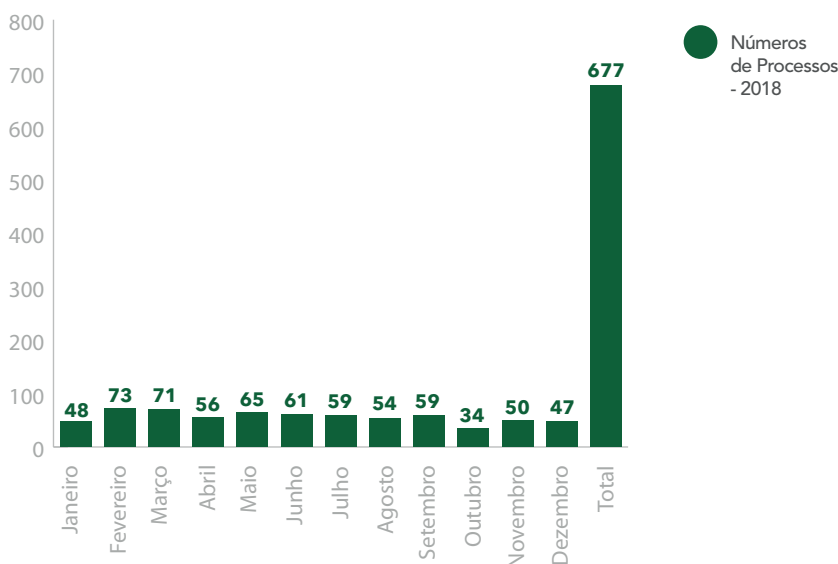
PROCESSO N.º	ITEM	VALOR DO TRATAMENTO
082113-22.2017.8.15.0001	Ventavis (iloprostá) - medicamento indicado para o tratamento da hipertensão pulmonar.	R\$ 81.642,36 (oitenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
082113-22.2017.8.15.0001	Bomba de insulina, cateter e acessórios.	R\$ 34.360,00 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais)

Fonte: Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande – PB.

Observa-se que essas demandas acarretam gastos elevados prejudicando todo um planejamento voltado para as ações de saúde e causando grande impacto orçamentário, e que na totalidade das demandas, fica estabelecida pelo juiz do caso a obrigação de adquirir ou realizar procedimentos mediante a dispensa de licitação, com a finalidade de imprimir celeridade a todo o processo de atendimento.

No ano de 2018, verificou-se que o ajuizamento mensal de demandas em face do Município de Campina Grande, em matérias afetas à Secretaria Municipal de Saúde, foi regular durante todos os meses, em uma média de 56 processos por mês, conforme Figura 1:

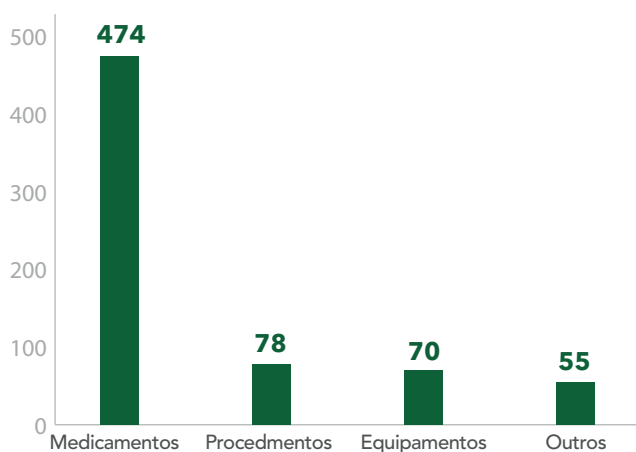
FIGURA 1. Comparativo Mensal dos Processos Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde (2018).



Fonte: Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande – PB.

A Figura 2 mostra que – de todos os 677 processos ajuizados em 2018 – 474 foram pedidos de medicamentos, o que corresponde à 70% (setenta por cento) de todas as demandas movidas em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande:

FIGURA 2. Ações Judiciais Relacionadas à Saúde em 2018.



Fonte: Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande – PB.

Dos processos movidos em face do Município de Campina Grande-PB, vale evidenciar que a sua grande maioria é ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, órgão que representa cidadãos que não possuem recursos suficientes para arcar com advogados particulares, e que necessariamente se encontram em relação de hipossuficiência financeira.

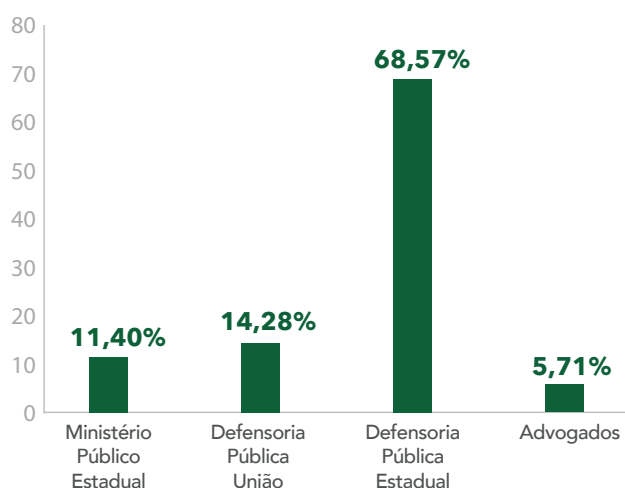
O ajuizamento pela Defensoria Pública Estadual nos leva à conclusão de que a União, na maior parte das vezes, é excluída das demandas, na medida em que apenas a Defensoria da União possui legitimidade para atuar no âmbito da Justiça Federal. A Defensoria Pública da União, nesses casos, seria legitimada para representar cidadãos hipossuficientes que possuam interesse em ajuizar demandas na Justiça Federal, cuja competência é atraída principalmente em decorrência da presença da União Federal no polo passivo da demanda.

É interessante observar que a Justiça Comum (Estadual) possui um acesso mais fácil que a Justiça Federal, sobretudo pela quantidade de Varas e por sua amplitude geográfica. As Seções Judiciárias, como são chamadas as Varas da Justiça Federal, costumam estar presentes apenas em grandes centros. Por outro lado, as Varas da Justiça Comum,

ainda que efetivamente mais concentradas em cidades maiores, encontram-se distribuídas pela grande maioria dos Municípios do Brasil.

Ademais, é competência inerente à Defensoria Pública Estadual ou da União, a representação de todo e qualquer cidadão que não se encontre em condições de arcar com as despesas processuais. Por sua vez, o Ministério Público acaba agindo de forma suplementar, apenas quando a atuação da Defensoria Pública é insuficiente ou inexistente.

FIGURA 3. Órgãos que ajuizaram processos de Campina Grande.



Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande-PB.

Como pode-se observar na Figura 3 os maiores protagonistas na proposição de ações judiciais são as Defensorias Públicas, em particular a Estadual, seguido pelo Ministério Público Estadual. Esses órgãos têm grande importância na defesa do direito à saúde, porém, ainda não é homogêneo nestas instituições o conhecimento técnico mínimo em relação aos fundamentos, organização, estrutura e funcionamento do SUS, de modo que não são raras as decisões processuais equivocadas que acabam trazendo prejuízo ao coletivo em favor de situações individuais. Nesse sentido, é necessário estimular debates, principalmente para esclarecimentos sobre questões técnicas, bem como sobre as consequências que as decisões judiciais produzem nos serviços prestados pelo SUS.

Analizando as decisões de forma geral, é perceptível que na maior parte delas, não há uma análise criteriosa sobre o caso concreto e muitas vezes o que prevalece são as ações de natureza individual. Como por exemplo a decisão que concedeu o pedido de Antecipação de Tutela nos autos do Processo n.º 0815739-56.2018.8.15.0001, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, em que o autor requer fornecimento de medicamento denominado Lucentis ou Eylia:

Processo n.º 0815739-56.2018.8.15.0001

“DECISÃO

Vistos etc.

(...), qualificado nos autos, através da Defensoria Pública desta Comarca, sob o pálio da gratuidade processual, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, pugnando pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA visando o fornecimento de medicamento para tratamento da patologia de que é portador.

Passo a decidir o pedido de tutela de urgência antecipada.

A parte autora trouxe aos autos documentos de profissional médico a demonstrar, desde logo, que a medicação pretendida é imprescindível para o tratamento a que está submetida, constando em laudo médico, onde se comprova que a promovente se apresenta com a patologia denominada DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE, CID H 35.3, necessitando com urgência de tratamento para controle da doença com o medicamento denominado LUCENTIS OU EYLIA, conforme posologia prescrita, considerando que o tratamento indicado não está sendo cumprido dado a insuficiência de recursos financeiros da parte requerente, e caso não tenha o seu pedido atendido poderá ter a sua saúde prejudicada em definitivo.

Dispõe o artigo 196 da Carta Magna que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco e de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Estabelecido, então, o princípio do atendimento integral, que constitui diretriz das ações e serviços públicos de saúde (art. 198), firma-se a competência solidária entre

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o seu cumprimento e desenvolvimento, contida no art. 23, inc. II da Constituição Federal.

Como sempre tenho lembrado, analisando a regra insculpida no art. 196, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 393.175 - AgR, em que foi Relator o ínclito Ministro Celso de Melo, manifestou entendimento de que o “caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impositergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o fornecimento de medicamentos gratuitos aos mais necessitados não pode se restringir à relação constante na Portaria nº 1.318/2002, do Ministério da Saúde. Senão, vejamos:

(...) “uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS nº 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida”. (ROMS nº 17.903 – MG, Relator: Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgado em 10/08/2004).

Não há notícia de que o SUS forneça fármaco para tratamento da moléstia aqui referida diferente do prescrito pelo médico que assiste a paciente, o que pode ser demonstrado, se for o caso, pelo ente público promovido a qualquer tempo até a contestação.

Diante da situação fática e jurídica trazida aos autos, me parece prudente a imediata concessão da tutela de urgência antecipada, visando a disponibilidade dos medicamentos necessários à paciente, sob pena da possibilidade da omissão se caracterizar como ato que viola o direito à saúde, permitindo-se, porém, o fornecimento de medicações com o mesmo princípio ativo, sem privilégio da marca dos medicamentos prescritos.

Se por qualquer motivo o ente público responsável pelo fornecimento da medicação não dispõe dessas medicações necessitadas pela parte autora, deve adquiri-las o mais rápido possível para fornecê-las à paciente, ora autora, impedindo o progresso da moléstia de que está acometida.

No atual CPC, ao que parece, ocorreu uma aproximação entre tutela antecipada e tutela cautelar, espécies de tutelas provisórias fundadas na urgência, isto é, na necessidade de uma rápida solução, mesmo com natureza de provisoriedade, que deve

ser aplicada a determinada situação grave e que não pode esperar o trâmite regular do processo sem a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, ou claro risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, o art. 300, caput, da lei processual civil, elenca os requisitos comuns para a concessão da tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, como sendo a evidência da probabilidade do direito (*fumus boni iuris*); e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*).

Ante o exposto, nos termos do art. 294, e seu parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC, concedo a tutela de urgência antecipada, em parte, para determinar que o Município de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde do Município, forneça o medicamento descrito nos autos na forma requerida, ou outra equivalente com o mesmo princípio ativo (genérico), em 48 horas, independente de instauração de processo licitatório, a partir da notificação da (o) Secretária de Saúde do Município, ou quem suas vezes fizer, sob pena de bloqueio em conta do Município de Campina Grande/PB, em valores necessários ao fornecimento do medicamento solicitado e indicado na exordial, sem prejuízo de possível apuração do descumprimento desta ordem e de adoção de medidas para efetivação da jurisdição.

Oficie-se à (ao) Secretário de Saúde, ou quem suas vezes fizer, comunicando esta decisão e requisitando o cumprimento do preceito no prazo concedido, remetendo cópias de todos os dados do paciente, inclusive laudo e receita médica, endereço e telefone de contato.

Cite-se, observado o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, e as demais formalidades legais, devendo se fazer, preferencialmente, por meio eletrônico.

Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de demanda em que não é possível se esperar uma oportunidade futura para a autocomposição, tendo em vista a urgência de que se reveste a pretensão.

Cumpra-se. Urgente.

Campina Grande, 26 de setembro de 2018.

Juiz Ruy Jander Teixeira da Rocha.” (1).

Em verdade, o que ocorre são decisões eminentemente padronizadas, com fundamento no art. 198 da Constituição Federal, que preveem a aparente solidariedade entre os entes (União, Estados e Municípios). Desta forma, o Poder Judiciário atribui, com

lastro na referida solidariedade, a qualquer um dos entes o dever de fornecer o medicamento ou a cirurgia pretendida, desconsiderando toda a hierarquização do SUS.

Na maioria das vezes, a parte requerente sequer se dirige à estrutura consolidada do SUS (posto de saúde, centros de especialidades etc.), optando diretamente em ir ao seu médico particular, ou hospital particular, no qual solicita o orçamento e ajuíza a demanda.

Em síntese, para parte da sociedade, o SUS apenas é útil naquilo que os interesses particulares dos envolvidos competem. Quanto à adoção dos procedimentos padrões, trata-se de imediato rechaçar os argumentos lançados pelos entes públicos.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Com o crescimento exponencial das demandas judiciais voltadas para a saúde, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em setembro de 2016, reconheceu a necessidade de criação dos Comitês Estaduais, conforme a Resolução nº 238/2016, que determina que os Tribunais de Justiça e Regionais criem e mantenham os Comitês Estaduais da Saúde, bem como a criação de uma vara especializada em demandas da saúde (2).

Os comitês de saúde são órgãos colegiados compostos de magistrados (estaduais e federais), gestores da área de saúde, demais atores do Sistema de Justiça (Ministério Público, Defensoria, Advogados Públicos, OAB) e um integrante do conselho estadual de saúde que represente os usuários do sistema público de saúde.

Neste contexto, o NAT-JUS da Paraíba foi instituído, sendo conceituado pelo próprio Tribunal de Justiça da Paraíba-TJPB como “sendo responsável pela elaboração de documentos técnicos e especializados na área da saúde, com o fim de auxiliar magistrados na formação de um juízo de valor, por ocasião da apreciação de questões clínicas apresentadas nas ações judiciais, envolvendo a assistência à saúde pública”, conforme a Recomendação n.º 238/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (2).

De acordo com o site do NAT-JUS da Paraíba, a sua composição seria de juízes, representantes do Ministério Público, Defensores, representantes de Secretarias de Estado e Municipais da Saúde; representante dos Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia; dentre outros membros da sociedade civil. Observa-se, em verdade, que tal composição remete ao Comitê de Saúde, vez que o NAT-JUS é especificamente responsável pela análise técnica e médica dos casos, não sendo composto por magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo (3).

Conforme as estatísticas apresentadas pelo NAT-JUS PB, em todo o Estado da Paraíba, no ano de 2017, foram 2.485 processos relacionados ao fornecimento de medicamentos e 601 processos relacionados a procedimentos (cirurgias, materiais médico-hospitalares, exames, etc.). Já no ano de 2018 (até 20/04) foram 706 processos relacionados ao fornecimento de medicamentos e 297 processos relacionados a procedimentos (cirurgias, materiais médico-hospitalares, exames etc.) (3).

Segundo o coordenador do Comitê, o juiz Marcos Coelho de Salles, a proposta é fazer que cada magistrado, com competência em judicialização de saúde, possa estabelecer um canal de debate com os executivos municipais.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) foi instalado na Comarca de Campina Grande no ano de 2018, e tem como missão primordial a resolução de conflitos utilizando meios alternativos ao judicial (4).

Uma solução possível para a judicialização envolve a implantação e a efetivação da Mediação Sanitária em todo o Município de Campina Grande, tendo em vista que há desconhecimento dos profissionais acerca dos medicamentos disponibilizados pelo município.

Neste mesmo contexto, verifica-se que o município é demandado por medicamentos que são da competência do Estado da Paraíba, reforçando-se o desconhecimento acerca da estrutura do SUS.

A constância das demandas judiciais em face do poder público municipal tem causado grande preocupação, em razão do desequilíbrio no planejamento e das consequências que podem advir em face do eventual descumprimento.

As decisões costumam desconsiderar a capacidade física e operacional do município, seja em razão da interpretação extensiva da solidariedade estabelecida no art. 198 da Constituição Federal, que acaba por desconsiderar toda a hierarquização prevista na Lei Federal n.º 8.080/1990. Assim, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os advogados, ao ajuizarem as demandas de forma indistinta, impactam e influenciam diretamente na organização, no planejamento coletivo da saúde em um cenário de recursos finitos.

O que se observa em relação à judicialização de medicamentos, é que rotineiramente os produtos acabam sendo fornecidos por valores superiores, e muitas vezes adquiridos sem compras públicas planejadas.

Um adequado planejamento realizado pelo Poder Público exige uma licitação prévia, realizada nos moldes da Lei Federal n.º 8.666/93, com levantamentos de preços e ampla participação de empresas, o que possibilita a concorrência para o fornecimento dos medicamentos, e inexoravelmente, uma redução no custo. Tão importante quanto a lei citada, é a observação das regras estabelecidas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), uma vez que no Brasil este mercado é regulado e existem regras específicas para a comercialização, inclusive no que tange o cumprimento de ordens judiciais pelo governo.

As aquisições realizadas sem planejamento podem ocorrer de duas formas: ou mediante dispensa de valor, atualmente (2018) no montante de R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), ou em uma suposta aplicação do art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações, que permite a aquisição de bens para solucionar emergência que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. Em ambas as hipóteses, não há a ampla concorrência nem a disputa inerente ao procedimento licitatório, implicando em aquisições em valores superiores ao de eventuais processos licitatórios.

Outro caminho que costuma ser adotado pelo Poder Judiciário é o sequestro das contas do Poder Público, a fim de que tais recursos sejam destinados diretamente ao prestador de serviços ou à parte autora. Nesta hipótese, os custos são ainda mais elevados, pois geralmente os orçamentos são realizados de forma unilateral, sem qualquer cotejamento de valores.

Assim, as demandas judiciais que envolvem medicamentos já previstos nas políticas públicas, por exemplo, poderiam ser evitadas por meio de um adequado planejamento, evitando-se que, em âmbito municipal, no caso de medicamentos integrantes do componente básico da assistência farmacêutica, houvesse desabastecimento.

Para tanto, far-se-ia necessário que o município projetasse as demandas dos medicamentos, possibilitando identificar, por exemplo, se há um excesso de solicitação administrativa de medicamentos próprios de hipertensão, o que, por outro viés, poderia justificar a adoção de políticas públicas para prevenir o adoecimento da população.

Uma das formas mais eficazes de planejamento consiste no Pregão Eletrônico para constituir Ata de Registro de Preços. Por intermédio de tal procedimento, o município não adquiriria de imediato os medicamentos pretendidos, e, por conseguinte, não correria riscos de expirar a validade, entre outras inconveniências, tais como estrutura para armazenagem e distribuição, orçamento disponível etc. À medida em que houvesse a demanda, os vencedores do pregão teriam que disponibilizar os itens licitados, cujos pagamentos seriam feitos de forma paulatina.

Eventualmente, ainda que o município realize o seu planejamento e tenha em estoque ou para pedido imediato os medicamentos da sua competência, ou seja, integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, são judicializados pedidos de medicamentos não padronizados, o que atrai a necessidade de profissional farmacêutico qualificado, que esteja apto a justificar a necessidade de utilização do medicamento que esteja arrolado na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).

A falta de treinamento dos profissionais que lidam com a saúde pública também é um viés que precisa ser enfrentado pela Secretaria Municipal de Saúde. O profissional de saúde habitualmente possui formação específica para lidar com as questões médico-farmacêuticas. Entretanto, quando da análise das normas que regem o Sistema Único de Saúde, faz-se mister o adequado treinamento.

Deve-se salientar que quando uma decisão judicial desconsidera a organização do sistema público de saúde, há prejuízo na execução de ações de saúde planejadas com os recursos disponíveis, considerando que esses recursos financeiros são finitos, ou seja, quando se atende necessidades individuais com recursos coletivos não destinados a

este fim, algum serviço regular do sistema poderá ser prejudicado. Portanto, cabe ao gestor a difícil atribuição de remanejar recursos em prejuízo ao planejamento inicial da secretaria.

Mediante esse cenário, podemos observar que existem fragilidades nas políticas públicas de saúde, o que conduz ao surgimento de meios alternativos para tentar dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. O próprio Código de Processo Civil de 2015 prevê, dentre suas normas fundamentais, que cabe ao Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e estabelece, ainda, que os entes públicos criarão Câmara de Mediação e Conciliação.

É nessa visão que Campina Grande necessita alinhar uma aproximação entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, por meio dos operadores do direito, profissionais da saúde e a sociedade, para que juntos possam buscar meios alternativos para tentar diminuir os conflitos com o fenômeno da judicialização e otimizar o direito à saúde de uma forma coletiva.

Ademais, faz-se imprescindível a qualificação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde acerca das normas do SUS, a fim de atuarem como multiplicadores dos mecanismos de entrada do SUS, possibilitando a resolução dos problemas de forma administrativa, por intermédio do adequado planejamento e divulgação de ações.

Considerações Finais

A banalização da judicialização na área da saúde pública tem transformado a busca do Poder Judiciário não apenas para os casos não solucionados na via administrativa, mas também naqueles procedimentos e medicamentos básicos, que se encontram facilmente disponíveis no SUS, com acesso rápido e eficiente por parte da população que busca o sistema público de saúde.

Os operadores do direito precisam, inicialmente, entender melhor o direito sanitário, para evitar levar adiante demandas não planejadas, inclusive aquelas que coagem a administração pública a despender recursos financeiros, lesando de forma irreversível a coletividade.

As relações de medicamentos (nacionais, estaduais ou municipais) precisam servir como parâmetro quando a autoridade judicial se depara com demandas envolvendo medicamentos e o Poder Público, a fim de averiguar se efetivamente o medicamento solicitado não se faz presente nas referidas relações. Neste contexto, os magistrados precisam de maiores subsídios em suas deliberações.

Agindo-se assim será possível alcançar uma padronização nas políticas de saúde, inclusive por meio de uma súmula vinculante que garanta aos entes públicos o dever de fornecer apenas os medicamentos que se encontrem sob a sua responsabilidade.

A excessiva judicialização prejudica diretamente a maior parte da população, já que está provado que as pessoas que mais buscam a justiça para obtenção de tratamentos, no âmbito do SUS, são aquelas que possuem maior grau de instrução e por muitas vezes melhor poder aquisitivo, o que permitiria que patrocinassem seus tratamentos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, as camadas mais desprestigiadas da população acabam prejudicadas tanto por não terem os recursos e as informações necessárias para ingressar no Poder Judiciário quanto pelo fato dos recursos financeiros que seriam destinados à coletividade estarem sendo concentrados no atendimento de demandas individuais.

Referências

- 1 - Brasil. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande. Decisão de Antecipação de Tutela – **Processo nº 0815739-56.2018.815.0001. Processo Judicial Eletrônico – PJE**. [Internet]. Campina Grande, 26 set 2018 [citado em 14 mar 2020]. 80 Disponível em: <<https://pje.tjpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>>.
- 2 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 238** de 06 de setembro de 2016. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. (9 set 2016): 8-9. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_238_06092016_09092016173942.pdf>.
- 3 - Tribunal de Justiça da Paraíba (BR). **João Pessoa, 2019**. [citado 14 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpb.jus.br/natjus/>>.
- 4 - Tribunal de Justiça da Paraíba (BR). **Notícias: Mais dois CEJUSCs são inaugurados em Campina Grande para incentivar a conciliação** [Internet]. João Pessoa, 2019. [citado 04 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpb.jus.br/noticia/mais-dois-cejuscs-sao-inaugurados-em-campina-grande-para-incentivar-a-conciliacao>>.



A judicialização no Município de Eunápolis - Bahia: Uma proposta de intervenção

Carlos Rodrigues Galvão Júnior¹

Carolina Souza Andrade Licio²

Fernanda Cardoso da Silva Feijó³

Guilherme Bampa Taiar⁴

Jaelia Campos Meireles Damasceno⁵

Maria Emília Pereira Pinheiro Fonseca⁶

Orientadora: Profa. MSc. Tarsila Costa do Amaral

A escolha do Município de Eunápolis-BA considerou a opção do Estado da Bahia pelo estímulo ao caráter cooperativo do pacto federativo entre estado e municípios, por meio de consórcios interfederativos de saúde, bem como da Lei n.º 13.204/2014 (1), que modificou a estrutura organizacional da administração pública estadual da Bahia e, em 2015, o Decreto n.º 16.075 (2), criando macrorregiões de saúde, culminado com a desconcentração administrativa e recomposição das redes de atenção à saúde em territórios maiores, mantendo-se, no entanto, a estrutura antiga dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS), criados pela CIB n.º 275, de 15 de agosto de 2012, cuja finalidade

¹ Graduado em Fisioterapia pela UniEVANGÉLICA, e pós-graduado em Saúde Pública e Saúde da Família pela UniEVANGÉLICA. Secretário Municipal de Saúde de Campo Limpo de Goiás-GO.

² Graduada em Farmácia-Bioquímica, Mestre em Ciências Farmacêuticas e Doutoranda em Biotecnologia aplicada à Judicialização da Saúde, pela UFOP.

³ Graduada em Saúde Coletiva pela UFRGS. Assessora técnica no COSEMS-RS.

⁴ Graduado em Direito pela Mackenzie. Assessor técnico de Gabinete e membro do Núcleo de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo.

⁵ Graduada em Direito pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna. Superintendente de Administração e Planejamento na SMS do de Eunápolis-BA.

⁶ Graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFRN. Secretária Municipal de Saúde no Município de Monte Alegre-RN.

é acompanhar as atividades de regulação, de vigilância sanitária e a dispensação de medicamentos e outras ações que contribuem para o fortalecimento da gestão dos Municípios (3).

Para a realização do estudo, foi utilizado a abordagem exploratória-descritiva quantitativa com a finalidade de descrever o perfil da judicialização da saúde em Eunápolis-BA, por meio de descrição de variáveis. Assim, elementos importantes levantados puderam subsidiar o perfil da judicialização da saúde pública local e a elaboração de uma proposta de intervenção.

O universo da pesquisa foi delimitado pela busca de processos judiciais relacionados à saúde no período de 2018. A unidade de análise de pesquisa definida foi processo judicial eletrônico. Os dados coletados foram constituintes de um banco de dados do Sistema Judiciário Estadual baiano, por meio de consulta eletrônica nos endereços eletrônicos <https://www.tjba.jus.br/jurisprudencia/> e <http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/>, constituindo-se em uma consulta pública. Mediante a grande dificuldade encontrada nos referidos sítios por processos judiciais referentes ao ano de 2018, mediante as suas recentes inserções e problemas correlatos, realizou-se um levantamento direto, por intermédio de busca ativa na Procuradoria Geral do Município de Eunápolis.

Com a colaboração de seus servidores, foi possível realizar um levantamento e busca eletrônica por processos de judicialização da saúde referentes ao ano de 2018, em desfavor do SUS do Município de Eunápolis-BA.

Os processos encontrados foram submetidos a uma análise para elaboração de um banco de dados por meio da identificação das seguintes variáveis:

- número do processo eletrônico;
 - litisconsórcio;
 - representação do autor (Ministério Público, Defensoria Pública, Núcleo de Assistência Jurídica e Advogado);
 - natureza: individual ou coletiva;
 - tipo de demanda de saúde pleiteada;
-

- argumentos do autor (negativa de fornecimento pela via administrativa, princípio, jurisprudência; hipossuficiência; risco de agravar o quadro de saúde do paciente; produção de prova; doutrina);
- campo jurídico (tipo de decisão e se: deferida, indeferida, parcialmente deferida, processo extinto, argumentos do magistrado: jurisprudências, julgamento do mérito e extinção do processo, confirmação de tutela antecipada, necessidade de produção de prova, princípio);
- argumentos da defesa: ilegitimidade passiva, substituto terapêutico existente no SUS, demanda de saúde não padronizada nas políticas públicas, princípio da integralidade, reserva do possível, orçamento limitado, ausência limitado, perda do objeto da ação, jurisprudência, lesão à ordem social e econômica, ressarcimento pela União para demandas de saúde não incorporadas.

A análise dos dados limitou-se às sentenças, acórdãos e liminares e não foi realizada a leitura de outras peças processuais. O banco de dados foi elaborado a partir das variáveis descritas definidas para esta pesquisa e, após digitação e verificação dos dados, foi construída uma matriz geral de análise de sentenças, acórdãos e liminares. Após a construção das matrizes de análises, os dados foram analisados por meio de distribuição de frequências simples e relativas. O *software Microsoft Office Excel 2017* foi utilizado para a construção do banco de dados e das matrizes de análises descritas. As análises foram sintetizadas e foram elaborados tabelas e gráficos para apresentação dos resultados e discussão.

Também foi discutido o caso da ação civil pública que tramita perante a Justiça Federal da 1ª Região, que culminou com a concessão de medicamento à base de Canabidiol (CBD) e Tetraidrocanabinol (THC), a alguns pacientes em Eunápolis, objetivando também a obrigação da União de realizar a sua incorporação nas políticas públicas de saúde.

Diagnóstico da Judicialização no Município

Considerando o universo amostral do estudo, pode-se dizer que o fenômeno da judicialização da saúde em relação ao Município de Eunápolis envolve, em sua maioria, a Justiça Estadual. O único processo ajuizado na Justiça Federal foi encontrado por meio da busca ativa e exclusiva na internet.

Os processos de judicialização da saúde de Eunápolis dividiram-se de forma ligeiramente homogênea entre as categorias definidas, com destaque relevante para medicamentos especializados, cirurgias e Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Já com relação ao polo passivo da ação, a maioria dos casos apresentou a situação do litisconsórcio passivo entre município e estado, mas em algumas situações apenas o Município de Eunápolis figurou.

Considerando a busca ativa na internet, foi encontrado um processo no âmbito da Justiça Federal, em que a União apareceu isolada no polo passivo e cujo pedido tratava-se de fornecimento de medicamento e a sua incorporação nas políticas públicas de saúde. O referido pedido de origem em Eunápolis, cuja autoria é do Ministério Público Federal, tratou do fornecimento de medicamentos à base do Canabidiol, tendo sido previamente deferido pelo magistrado.

Por fim, não foram identificadas ações de natureza coletiva ou ações estruturantes, a exemplo das ações civis públicas. Os processos identificados possuem natureza individual e foram, em sua maioria, representados por advogados privados.

Verificou-se que no fenômeno da judicialização que acontece em Eunápolis-BA não foge à regra do que ocorre no âmbito nacional que:

- há nichos de intermediação de advogados especializados;
- realização de eventos prestigiosos para magistrados, promotores e alguns defensores, quase sempre com a ausência de profissionais de saúde, principalmente médicos;
- pareceres a custos elevados que, teoricamente, deveriam ter papel técnico consultivo, mas aparentam ter papel decisório e influenciador na decisão

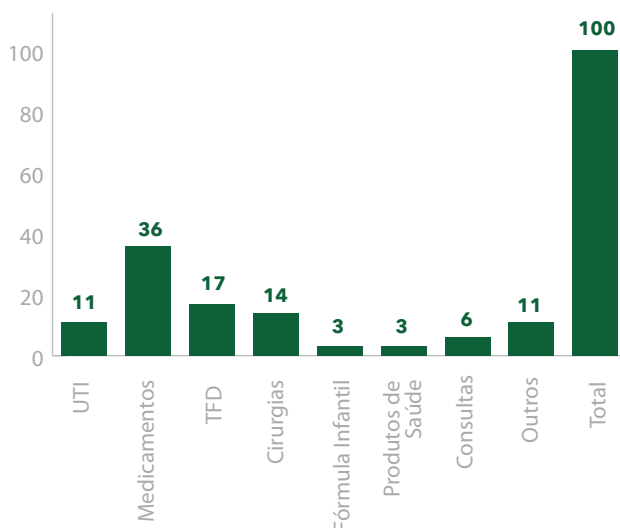
- do magistrado, portanto, tendo características deliberativas e, muitas vezes, utilizado em concorrência a via ordinária do exame de incorporação de tecnologias em saúde no SUS, instituído e executado legalmente pela Conitec;
- há concentração maciça de energia no debate a exceção à regra e não na busca por resolutividade das fragilidades da regra, possivelmente, mediante todo papel influenciador e mercadológico dos mercados farmacêuticos, médicos, advocatícios, prestígios de agendas do Sistema de Judiciário;
 - ausência da discussão de um novo pacto federativo e definição clara da integralidade;
 - pouco ou nenhuma ação de mediação sanitária efetiva realizada, bem como raras ações de federalização;
 - Atenção Primária e Assistência Farmacêutica permanecem fora do enfoque e nas discussões como possível e talvez o melhor caminho de solução e aprimoramento deste problema, atingindo desde a prevenção a promoção da saúde, transitando pelo processo de educação de toda a população e uso racional dos medicamentos.

Ao todo, foram encontrados e confirmados, por meio dos sites do sistema de justiça, 32 processos específicos da saúde. Dentre os processos judiciais não contabilizados, prevaleceram demandas relacionadas a atos administrativos, bem como licitações e contratos imobiliários.

Os principais pedidos encontrados foram relacionados a medicamentos especializados, cirurgias e tratamentos via TFD, representando 36%, 17% e 14% do total de demandas, respectivamente (Figura 1).

No geral, consistem em medicamentos especializados e serviços que ultrapassam a capacidade de oferta e técnica do município. Não foi possível verificar, no entanto, se as ações, serviços e produtos de saúde listados nos processos são de responsabilidade exclusiva do município ou concorrente em relação ao estado.

FIGURA 1. Principais tipos de demandas de saúde judicializadas em Eunápolis em 2018.



Fonte: Elaborado pelos autores.

A contagem levou em conta cada pedido e as respectivas ações e/ou serviços de saúde nele identificadas, ou seja, se em um mesmo pedido constasse mais de um insumo e/ou serviço de saúde, estes foram computados individualmente às respectivas categorias.

Os dados encontrados corroboram com o perfil da gestão do sistema público de saúde local, bem como com as características geográficas e econômicas do município. O fato do maior quantitativo encontrado ter sido de ações judiciais envolvendo a realização de cirurgias e tratamentos envolvendo TFD, além de alguns medicamentos especializados, ora previstos, ora não previstos nas políticas públicas, vão ao encontro do fato de Eunápolis ser um Município que possui gestão plena em saúde, aderindo ao pacto de gestão com teto de média e alta complexidade (MAC) no ano de 2018.

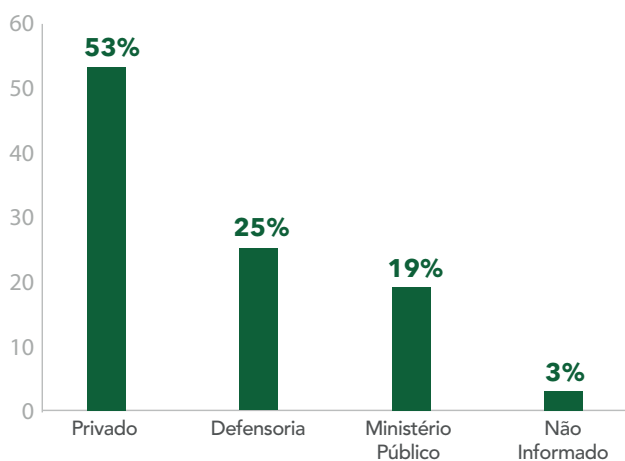
Em suma, como o município detém a autonomia e gerência organizacional dos serviços de saúde, acaba sendo referência deste tipo de prestação de serviços de média e

alta complexidade na região e, por consequência, aumenta a probabilidade de figurar no cenário de escolha do usuário do SUS quando este aciona o Sistema de Justiça objetivando esses tipos de demandas.

Também há o risco de que as decisões judiciais promovam efeitos sistêmicos imprevisíveis ou a própria desorganização administrativa, principalmente ao se considerar as diferentes capacidades Institucionais dos entes federados (4).

Quanto à representação autor/paciente, verificou-se uma atuação maior de representatividade por parte da advocacia privada (Figura 2), representando 53% do total de demandas judiciais relacionadas à saúde em Eunápolis.

FIGURA 2. Tipos de autores das ações de judicialização da saúde em Eunápolis em 2018.



Fonte: Elaborado pelos autores.

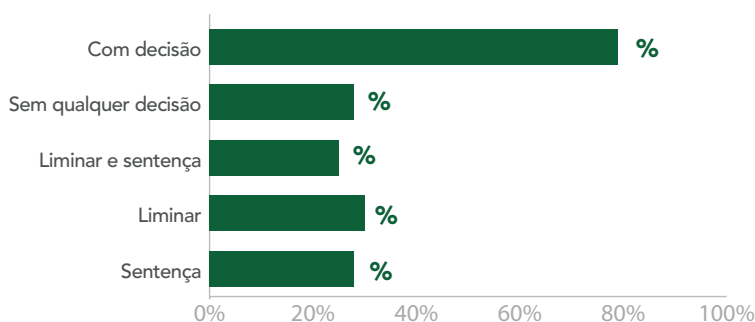
É importante ressaltar que apenas dois casos não se enquadram no contexto específico que consiste em buscas por insumos e ações de saúde, mas tangenciam a área do Direito à Saúde. O primeiro versa sobre indenização por dano moral decorrente de atendimento prestado em serviço público de saúde municipal e o segundo sobre indenização por dano moral decorrente da morte de um paciente durante o trâmite de ação judicial objetivando a realização de tratamento de saúde em serviço especia-

lizado, contudo o óbito teria ocorrido antes do cumprimento da decisão. Não menos importante, ainda considerando este referido processo, mesmo com a perda do objetivo da ação, a sentença judicial consiste na extinção processual, porém com aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer por parte dos réus.

Quanto à representação processual, grande parte dos autores são representados por advogados privados, seguido pela Defensoria Pública Estadual e em terceiro lugar o Ministério Público Estadual. Estes dados são de extrema importância para definição de estratégias a serem sugeridas como de intervenção por este grupo de pesquisa ao Município, pois tratam-se de demandas individuais que, exceto em situações de falhas administrativas, levam à desorganização do SUS, com realocação inadequada de recursos, principalmente da Atenção Primária à Saúde para outros níveis de atenção à saúde.

Cerca de 78% do total de processos judiciais possuía algum tipo de decisão, sendo 21,8% decisões liminares e sentenças, 31,2% decisões liminares e 25% decisões de sentenças (Figura 3). Além disso, 22% do total das ações judiciais levantadas não apresentou qualquer decisão.

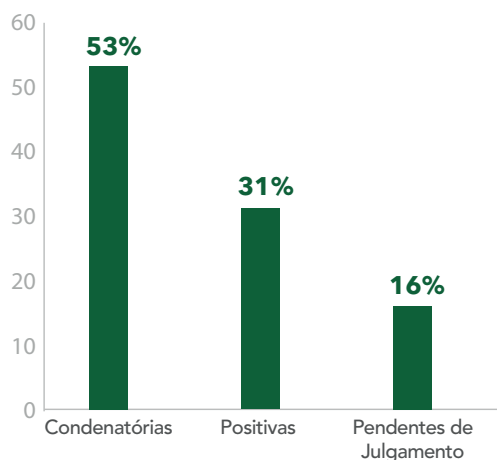
FIGURA 3. Perfil das decisões judiciais em judicialização da saúde ocorridas em Eunápolis em 2018.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação às decisões judiciais, foram classificadas da seguinte forma: condenatórias, positivas, ou seja, aquelas que por alguma razão desobrigam ou deixam de condenar o município e, por fim, os pendentes de julgamento. Nesse sentido, foram obtidos os dados descritos na Figura 4 a seguir:

FIGURA 1. Análise dos tipos de decisões judiciais encontradas na judicialização da saúde em Eunápolis em 2018.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Dentre as possibilidades de intervenção para a redução da judicialização da saúde sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça, a única identificada na amostragem foi a oitiva do Núcleo de Assistência Técnica, o NAT-JUS, previamente à concessão de tutela antecipada ou sentenciamento.

O NAT-JUS do Estado da Bahia tem a atribuição de prestar informações técnico-especializadas em Saúde Baseada em Evidências aos magistrados, relativas ao setor público (SUS) ou à saúde suplementar. Foi instituído pelo Decreto Judiciário n.º

287/2012 (5), sob a nomenclatura de Plantão Médico para Assessoramento ao Juiz. Por meio do Decreto n.º 877/2015 (6), passou a denominar-se Núcleo de Assessoria Técnica – NAT. Posteriormente, passou a ser denominado de Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT-JUS, por meio do Decreto Judiciário n.º 795/2017 (7) em atendimento à Resolução CNJ n.º 238/2016 (8). O NAT-JUS é composto por uma equipe multidisciplinar diretamente vinculada à Presidência do Tribunal e conta com cooperação de magistrados.

Em um dos despachos analisados, um magistrado utilizou como fundamento para consulta do órgão, a Resolução CNJ n.º 238/2016 (8), bem como o Decreto Judiciário n.º 795/2017 (7) da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. Além disso, por meio de pesquisa no sistema processual eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi possível consultar despachos, decisões interlocutórias, manifestações simples e sentenças, em suma, atos judiciais públicos. Por essa razão, não foi possível o acesso aos pareceres proferidos pelo NAT-JUS na íntegra, apenas o despacho de encaminhamento ao órgão e a repercussão de sua manifestação técnica ao magistrado mediante o deslinde do caso, quando este fora utilizado como fundamento principal para o ato judicial.

Do total de processos judiciais analisados, 25% foram encaminhados para o NAT-JUS. Aprofundando a análise, apurou-se que 9,3% da amostragem deste trabalho não apresentou decisões influenciadas direta ou indiretamente pelas intervenções do órgão auxiliar. Deste universo, destaca-se um processo no qual o autor foi a óbito antes do proferimento da decisão judicial e depois da manifestação técnica do NAT-JUS. Quanto aos demais processos, não houve manifestação do juízo sobre a decisão do órgão, pois aguardava contestação dos réus, estado e município.

Considerando, o estudo do caso objeto do processo judicial n.º 000009-35.2018.8.05.0079, o NAT-JUS parece ter corroborado com a tese do autor, ao repisar que o único medicamento indicado seria o Ranibizumabe. Já no segundo analisado, processo judicial n.º 8000583-58.2018.8.05.0079, o NAT-JUS se manifesta em seu parecer técnico sugerindo ao magistrado que fizesse a solicitação de justificativa técnica plausível para a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados na ação. E, também, compara a avaliação de estudos de eficácia do medicamento oxibutinina

intravesical, até aquele momento não registrado na ANVISA, e seus denominados substitutos terapêuticos registrados, concluindo que não há diferenças significativas entre eles.

Em outro processo judicial analisado, n.º 8000597-76.2017.8.05.0079, o parecer do NAT-JUS sugere que o caso concreto reportado na solicitação não se enquadra no conceito de urgência/emergência, fato este que parece ter ensejado a adoção de providências preliminares pelo magistrado, o qual decidiu por determinar a realização de exames prévios para verificação do estado de saúde do paciente. No processo judicial n.º 8000630-32.2018.8.05.0079, há citação por parte do magistrado do parecer do NAT-JUS utilizado no julgamento de sua sentença.

Por fim, no último processo analisado n.º 8000578-36.2018.8.05.0079, foram endereçados quesitos ao Núcleo, que se manifestou em relação ao enquadramento do caso concreto classificado como urgência/emergência, sobre o qual houve a manifestação de que a condição de saúde da paciente, por estar obesa, não conseguiria se deslocar até a capital do Estado e retornar no mesmo dia, influenciando, assim, sobre quantidade necessária de diárias de TFD, do tipo pernoites.

Não foi identificada a existência de comitês ou ações de mediação sanitária para resolução de conflitos correlacionados com as medidas de aprimoramento da judicialização da saúde.

O próprio fato de não existir uma comissão de mediação ou qualquer outra forma de intervenção no fenômeno da judicialização pode ser objeto de crítica. Contudo, chama atenção a existência de ações judiciais em que o município é chamado pelo próprio magistrado *ex officio* a se manifestar em processo, fato este que pode representar certa passividade do setor jurídico municipal, talvez pela pouca especialização na área do direito sanitário. Além disso, há relatos em decisões pelo próprio magistrado da baixa qualidade técnica nas defesas processuais, principalmente em relação ao Estado.

Outro ponto a ser considerado é o impacto das manifestações técnicas do NAT-JUS nas decisões judiciais, não considerando apenas se houve decisão judicial favorável ou não, mas em sua qualificação como instrumento assessor e técnico que pode estar sendo utilizado de maneira concorrente e/ou em substituição à via legal de avaliação

e incorporação de tecnologia em saúde, como as ações previstas e executadas pela CONITEC, conforme fundamento da Lei n.º 12.401/2012 (9), que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Considerações Finais

A judicialização da Saúde em Eunápolis divide-se de forma ligeiramente homogênea, na qual destaca-se a judicialização de medicamentos especializados, cirurgias e tratamento fora do domicílio. No ano de 2018, a maioria dos processos ajuizados foram referenciados à Justiça Estadual, onde a maioria dos casos apresentou a situação de litisconsórcio passivo entre município e estado.

Ao todo foram localizados 42 processos, sendo 32 específicos da saúde e nos quais verificou-se a representação privada em 53% e o mesmo percentual (53%) de decisões condenatórias.

Finalmente, após tais análises situacionais o presente trabalho apresenta a proposta de intervenção a qual objetiva solucionar tais nós críticos do fenômeno da judicialização da saúde em Eunápolis, por meio da criação e efetivação do Comitê de Mediação Sanitária.

Mediante a criação do Comitê de Mediação Sanitária, a despeito da inadequação do de sua nomenclatura, é possível efetivar um veículo de comunicação e informação acessível à população, culminando em uma possível regressão e qualificação dos casos processuais na saúde. O Comitê também poderia monitorar, avaliar e qualificar as respostas ao judiciário, bem como subsidiar novas estratégias de diagnóstico e enfrentamento da judicialização da saúde no município.

Referências

- 1 - Governo do Estado da Bahia (BR). **Lei n.º 13.204 de 11 de dezembro de 2014**. Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras providências [internet]. Diário Oficial do Estado. Salvador, 11 dez 2014 [citado 23 jun. 2019]. Disponível em: <<http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/LEI13204.pdf>>.
- 2 - Casa Civil (BR). **Decreto n.º 16.075 de 14 de maio de 2015**. Define o âmbito de atuação territorial dos Núcleos Regionais de Saúde, instituídos pela Lei n.º 13.204, de 11 de dezembro de 2014, e dá outras providências [internet]. Diário Oficial do Estado. Salvador, 14 maio 2015 [citado 23 jun. 2019]. Disponível em: <<http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-16075-de-14-de-maio-de-2015>>.
- 3 - Comissão Intergestores Bipartite em Saúde. **Resolução CIB n.º 275, de 15 de agosto de 2012**. Aprova as regiões de saúde do Estado da Bahia e a instituição das Comissões Intergestores Regionais [internet]. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 15 ago. 2012 [citado 23 jun. 2019]. Disponível em: <<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/resolucao-ba.pdf>>.
- 4 - Paixão ALSD. **Reflections on the judicialization of the right to health and its implications in the SUS**. *CienSaudeColet*, vol. 24, n.º 6. 2019 [citado em 14 fev 2020], pp. 2167-2172. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019000602167&lng=en&tlng=en>.
- 5 - Justiça Federal. Seção Judiciária da Bahia. Competência. **Decreto Judiciário n.º 287, de 14 de fevereiro de 2012**. Institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia o Plantão Médico, a fim de subsidiar o magistrado com informações técnico-especializado. [citado 29 maio 2020]. Disponível em: <<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=8234&tmp.secao=9>>.
- 6 - Justiça Federal. Seção Judiciária da Bahia. Competência. **Decreto Judiciário n.º 877, de 14 de outubro de 2015**. Alterar a denominação do Plantão Médico de assessoria ao juiz, instituído pelo Decreto Judiciário n.º 287/2014, que passa a ser denominado de Núcleo de Assessoria Técnica - NAT. [citado 29 maio 2020]. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/248568728/decreto-judiciario-n-877-14->>.
- 7 - Justiça Federal. Seção Judiciária da Bahia. Competência. **Decreto Judiciário n.º 795, de 30 de agosto de 2017**. Dispõe sobre a estrutura e funcionamento do NAT-JUS do tribunal de Justiça da Bahia [citado 29 maio 2020]. Disponível em: <<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv>>.

8 - Justiça Federal. Conselho Nacional de Justiça. Competência. **Resolução CNJ n.º 238, de 06 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. [citado 29 maio 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?>>>.

9 - Brasil. **Lei Federal nº 12.401, de 28 de abril de 2011**. Altera a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. [citado 29 maio 2020] Disponível em. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_-htm>.



Projeto de intervenção para enfrentamento da judicialização da saúde no Município de Juazeiro do Norte-CE

Elaine Cristina Toni Xavier¹

Estefferson Darley Fernandes Nogueira²

Kênia Silveira Carvalho³

Marcel Jandson Menezes⁴

Mariane Cristina Ciota⁵

Michelly Poliana Vigiato Pricinotto⁶

Sylvia Patrícia Dantas Pereira⁷

Orientador: Prof. MSc. Moacyr Rey Filho

O município de Juazeiro do Norte foi escolhido por se tratar de um município de médio porte, que por meio de ações locais conseguiu uma diminuição nos casos de judicialização em saúde.

A metodologia se deu por intermédio de uma pesquisa exploratória pela internet, utilizando-se de sites como do município e Diário Oficial de Juazeiro do Norte, Instituto

¹ Graduada em Design de Interiores pela UNIVEM, pós-graduada em Micropolítica da Gestão do Trabalho em Saúde do SUS pela UFF, Diretora de Saúde de Lucianópolis-SP e integrante do quadro da Diretoria do COSEMS-SP.

² Graduado em Direito pela UNICAP-PE. Procurador do Município de Afogados da Ingazeira-PE.

³ Graduada em Gestão em Saúde Pública pela CEFET-PA, pós-graduado em Gestão Regional de Saúde pelo SENAC-MG e em Gestão Hospitalar pela ESP-MG. Subsecretária de Assistência em Saúde no Município de Contagem-MG.

⁴ Gem Farmácia e Bioquímica, com pós-graduação em Gestão Pública e Farmácia Clínica e Cuidados Farmacêuticos, pelo IMME. Secretário de Saúde do Município de Laranjal do Jari-AP e Presidente do COSEMS-AP.

⁵ Graduada em Direito pela UNOCHAPECO. Diretora do Departamento de Saúde Pública do Município de Xaxim-SC.

⁶ Graduada em Direito pela UNIPAR, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, pelo Instituto Paranaense de Ensino. Secretária Municipal de Saúde de Cianorte-PR.

⁷ Graduada em Farmácia e em Direito pela UFRN. Membro do UNICAT, órgão da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

Brasileiro de Geografia e Estatística e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará entre outras informações.

Foi feita uma análise de planilha com dados genéricos da demanda judicializada da Defensoria Pública do Estado fornecida pela Secretaria de Saúde do Município, bem como dados enviados pela Procuradoria Geral do Município, perante aos processos judiciais locais. O período temporal privilegiado foi o ano de 2018.

Os dados foram organizados com base no diagnóstico realizado, onde o grupo propôs algumas medidas para a diminuição de ações judiciais, assim como a organização do processo de trabalho já existente no município.

Diagnóstico da judicialização no município de Juazeiro do Norte

Buscando entender o contexto da judicialização da saúde no município de Juazeiro do Norte, foi solicitado ao município o levantamento das demandas judiciais do ano de 2018. Durante a coleta de dados, observou-se uma fragmentação dos registros e controle entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Procuradoria-Geral do Município (1). Optou-se, portanto, pela utilização dos dados disponibilizados pela Procuradoria em função de serem mais completos.

No ano de 2018, foram registradas 59 ações judiciais relacionadas à saúde pública no município de Juazeiro do Norte. Seis dessas ações solicitavam mais de um tipo de demanda. Figuravam em todas elas, no polo passivo, o município de Juazeiro do Norte e o Estado do Ceará (1).

Das ações judiciais da saúde analisadas, propostas durante o ano de 2018, observou-se que as solicitações são bastante diversificadas e guardam relação, em sua maioria, com assistência à saúde, assistência farmacêutica, órteses e apoio à nutrição por alguma deficiência de saúde (1).

Os requerimentos apresentados à Justiça somam um total de 59 processos assim distribuídos: 23 de medicamentos (40% do total), 9 solicitações de órtese/cadeira de rodas

(16% do total), 7 solicitações de suplementação alimentar (11% do total), 7 solicitações de procedimentos cirúrgicos (11% do total), 5 solicitações de internação compulsória (9% do total), outras demandas agrupadas como oxigenioterapia, insumos, fraldas e outros, somam 8 solicitações (13% do total) (1).

Foram analisadas todas as solicitações para verificar se as demandas apresentadas se referiam ou não a medicamentos, produtos e procedimentos ofertados pelo SUS. Apurou-se que das 59 solicitações, 30 (50,85%) eram itens disponibilizados pelo SUS, enquanto 29 (49,15%) não eram. Dentre os não disponibilizados, destacam-se alguns medicamentos, suplementos alimentares, fraldas e algumas internações compulsórias (1).

Na análise específica de medicamentos, das 23 solicitações, verificou-se que apenas 3 (13%) são fornecidos pelo SUS, enquanto 20 (87%) não foram encontrados na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME 2017) vigente à época do ajuizamento das ações (1).

No ano de 2018, foram interpostas 59 ações judiciais, em 58 destas (98% do total) o autor/paciente foi representado pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPGECE) e apenas 1 autor/paciente foi representado por advogado particular (2% do total). Não houve ações interpostas por outras representações, a exemplo do Ministério Público Estadual, no referido período, em face do município de Juazeiro do Norte (1).

Quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, apurou-se que 33 ações (56% do total) foram julgadas procedentes. Em 15 ações (25% do total) não havia ainda sentença proferida; 4 ações (7% do total) foram extintas sem resolução do mérito por óbito da parte autora; 4 ações (7% do total) foram extintas sem resolução de mérito por desistência da parte autora e por resolução da demanda com recursos próprios dos autores. Por fim, 3 ações (5% do total) foram julgadas improcedentes. Salienta-se que esses dados foram coletados junto à Procuradoria-Geral do Município somente em maio de 2020 (1).

Dentre alguns dos achados interessantes, vale citar que a União não figurou no polo passivo de nenhum dos processos analisados, nem mesmo naqueles em que se pleiteavam medicamentos não disponibilizados no âmbito do SUS, a exemplo do Spiriva

Respimat 2,5mcg (Brometo de Tiotrópio), o que está em conformidade com o fato da quase totalidade dos processos terem sido ajuizados pela Defensoria Pública do Estado que, por sua vez, não possui prerrogativa para fazer representações judiciais contra a União (1).

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Há autores que defendem que o acesso ao Poder Judiciário para a obtenção de insumos para a saúde encontra guarida entre os magistrados, fazendo com que haja um crescente ajuizamento de ações judiciais em saúde, constituindo-se uma outra porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) (2).

Em função disso, observa-se que, em ampla escala, tem ocorrido certa transferência, no que concerne à garantia da assistência à saúde especialmente, do Poder Executivo para o Poder Judiciário, com importante destaque para a atuação das Defensorias Públicas.

Noutro pórtico, há quem considere a judicialização não ser *per si* maléfica ou benéfica, uma vez que ela aponta para falhas da gestão que necessitam ser urgentemente corrigidas, a exemplo da judicialização de medicamentos contemplados nos Componentes da Assistência Farmacêutica (3), os quais deveriam ser regularmente disponibilizados à população. Nesse sentido, ela provoca melhorias (4). Noutro, contribui para a desorganização das finanças públicas e do gerenciamento do SUS (5).

Por assim ser, o enfrentamento da judicialização da saúde requer, de todos os atores envolvidos, principalmente dos gestores públicos, um amplo conhecimento de suas causas, bem como habilidade para a implementação de um diálogo interinstitucional efetivo que, de fato, produza estratégias capazes de mitigar esse fenômeno ou, pelo menos, reduzir o alcance das suas consequências, haja vista terem se tornado, em sua maioria, comprometedoras da sustentabilidade e do gerenciamento do sistema (5).

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando subsidiar os magistrados, assegurando-lhes maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde, bem como considerando o grande número de processos em tramitação no Judiciário brasileiro, além do representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos, publicou a Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010 (6), por meio da qual:

Recomendou aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais a celebração de convênios que objetivassem a disponibilização de apoio técnico, composto por médicos e farmacêuticos, para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação de questões clínicas apresentadas pelas partes nas ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais.

É importante ressaltar que a Recomendação n.º 31 do CNJ (6) não se limitou a trazer orientações no sentido da criação de câmaras técnicas vinculadas aos tribunais estaduais e federais, ela também procurou incorporar uma análise mais criteriosa à atividade judicante dos magistrados, quando da apreciação de demandas da saúde, além de recomendar a inclusão da disciplina de Direito Sanitário aos cursos de formação de juízes, entre outras medidas.

Ainda objetivando a redução e o aprimoramento no julgamento das demandas da saúde, o CNJ publicou a Resolução n.º 107 (7), de 6 de abril de 2010, que estabeleceu a necessidade de instituição de Comitês de Saúde Estaduais, bem como a Resolução n.º 238 (8), de 6 de setembro de 2016, que dispôs sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, além da especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de Fazenda Pública.

Destaque-se, também, que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.105 (8), de 16 de março de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, o qual trouxe em seu bojo uma grande ênfase às formas extrajudiciais de resolução de conflitos, a saber, a Mediação e a Conciliação, nesse contexto também considerada a Lei n.º 13.140 (9), de 26 de junho de 2015, popularmente conhecida como Lei da Mediação, as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, bem como o próprio Judiciário e demais instituições do Sistema de Justiça, a exemplo das Defensorias Públicas e Ministério

Público, já vinham se organizando nesse sentido, haja vista compreenderem ser a resolução extrajudicial de conflitos uma das estratégias viáveis para a redução da judicialização na área da saúde (9).

De acordo com Celestino (10), no Estado do Ceará, o Comitê Executivo em Saúde foi criado em 22 de março de 2011, sendo composto por representantes da Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará, Secretaria de Estado da Saúde Pública do Ceará, Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza, Operadoras de Planos de Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar – Núcleo Ceará e do Conselho Regional de Medicina, bem como por representantes dos usuários da Saúde Suplementar, os quais desempenham suas funções no comitê de forma voluntária.

Ainda conforme Celestino (10), o Comitê Executivo em Saúde do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, publicou duas recomendações no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a saber, a Recomendação n.º 01/2017 (11), que dispõe sobre a utilização do relatório médico para o ajuizamento de ações em matéria de saúde suplementar, e a Resolução n.º 2/2017 (12), que dispõe sobre a utilização do relatório médico para o ajuizamento de ações em matéria de saúde pública.

Importante ressaltar que também é atribuição dos Comitês Executivos de Saúde auxiliar os Tribunais de Justiça de seus respectivos estados na criação dos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS). Em linhas gerais, esses núcleos são constituídos, em sua maioria, por profissionais médicos e farmacêuticos das secretarias estaduais e municipais de saúde, por meio de termos de cooperação técnica, com a função precípua de elaborarem pareceres, tendo como norte a Medicina Baseada em Evidências (MBE), para subsidiar tecnicamente a decisão dos magistrados nas demandas de saúde.

No Ceará, o NAT-JUS foi criado em 11 de novembro de 2016, por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2016, firmado entre o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o Estado do Ceará, o Município de Fortaleza e o Hospital Universitário Walter

Cantídio – UFC/EBSERH. Posteriormente, foi publicada a Portaria TJCE n.º 1.536 (13), em 8 de setembro de 2017, disciplinando o funcionamento do NAT-JUS/CE.

Conforme Celestino (10), o NAT-JUS/CE é composto por 3 (três) médicos e 3 (três) farmacêuticos, com a função de elaborarem pareceres e notas técnicas destinados a auxiliar tecnicamente os magistrados nas decisões que envolvam matérias de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Entretanto, não obstante a sua importância nesse contexto, o NAT-JUS/CE concentra suas atividades apenas na Comarca de Fortaleza e Região Metropolitana, podendo ser consultado por Magistrados das Varas e Juizados da Fazenda Pública, da Turma Recursal da Fazenda Pública e Desembargadores das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará.

A Coordenação do Comitê Executivo da Saúde do Ceará anunciou a expansão das atividades para a Zona Judiciária 1, que compreende o município de Juazeiro do Norte e outras 28 comarcas da região. A experiência bem-sucedida observada com os juízes de Fortaleza e Região Metropolitana é que tem permitido essa expansão para o interior do estado. A previsão para início das atividades do NAT-JUS/CE, em Juazeiro do Norte, é março/2020.

Espera-se, portanto, que com a expansão dos trabalhos do NAT-JUS/CE à comarca de Juazeiro do Norte, possa haver um incremento na redução do número de processos judiciais de saúde no referido município, bem como em todos os municípios que compõem a Zona Judiciária 1.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Juazeiro do Norte não dispõe de um Comitê de Mediação Sanitária formalmente constituído. Entretanto, desde 2017, a SMS vem trabalhando em parceria com a Defensoria Pública do Governo do Estado do Ceará (DPGECE), de modo que, no decorrer desse período, vários casos que chegaram à Defensoria foram resolvidos de forma extrajudicial, contribuindo para a redução da judicialização no município (14).

Importante ressaltar que já se encontra em andamento um projeto com vistas à oficialização dessas ações de cooperação existentes entre a SMS e a Defensoria. No momento, porém, o que há são protocolos e rotinas de atendimento, a exemplo de um plantão semanal que servidores da Assistência Farmacêutica e da Assessoria Jurídica

da SMS realizam nas dependências da Defensoria, além da permanente disponibilidade via internet (14).

Entretanto, analisando a Tabela 1, elaborada com dados da DPGECE de posse da SMS, onde constam as resoluções extrajudiciais ocorridas no triênio 2017-2019, verifica-se que os resultados alcançados são expressivos, principalmente no ano de 2017, onde o número de casos resolvidos extrajudicialmente foi superior ao de demandas judicializadas em Juazeiro do Norte.

TABELA 1. Atendimento realizados pela Defensoria Pública do Governo do Estado do Ceará no triênio 2017-2019.

DESFECHOS	2017	2018	2019
Resoluções extrajudiciais	43	27	49
Judicializados	28	77	70
Desistências	170	78	192
Outros*	83	44	42
Total	324	226	353

*Demandas direcionadas aos Planos de Saúde (Extrajudicial e Judicial) e arquivadas.

Fonte: Defensoria Pública do Governo do Estado do Ceará-DPGECE

Noutro pórtico, de acordo com informações da Procuradoria-Geral do Município de Juazeiro do Norte, no ano de 2018, foram judicializados 59 casos de demandas de saúde, número menor que o informado pela SMS, com base em dados da DPGECE. Essa divergência aponta para uma fragilidade da SMS com relação à necessidade de melhor sistematizar e gerenciar os dados e informações referentes à judicialização da saúde no município.

Importante ressaltar que as resoluções extrajudiciais consideradas são aquelas decorrentes de uma intervenção da Defensoria ou do Ministério Público.

Outro dado que merece ser destacado é o número de desistências ocorridas no período, pois é comum as pessoas procurarem a Defensoria em busca de assessoria para

a obtenção de assistência à saúde sem recorrer anteriormente à SMS. Essas pessoas são encaminhadas pelos servidores da SMS às Unidades de Saúde, confirmando-se a eficácia dos plantões semanais de servidores da saúde junto à Defensoria.

Há ainda casos em que a assistência buscada não é no âmbito da saúde, e sim, de cunho social, as quais também são contabilizadas como desistência. Por fim, são considerados como desistências todos aqueles casos em que não há motivos que justifiquem a intervenção da Defensoria Pública.

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte tem envidado esforços no sentido de mitigar a judicialização da saúde, o que pode ser confirmado, por exemplo, ao se observar o baixo número de processos judiciais de saúde ajuizados contra o município no ano de 2018, conforme informações da Procuradoria-Geral do Município. Cenário diferente do que se verifica na maioria dos municípios brasileiros: uma demanda crescente pelos mais diversos tipos de procedimentos e medicamentos, os quais, na maioria das vezes, não estão inseridos no contexto da Atenção Básica ou sequer são disponibilizados no âmbito do SUS.

No município há um canal de diálogo bem estabelecido entre a SMS e as instituições do Sistema de Justiça, a exemplo da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público, demonstrando protagonismo por parte da SMS e interesse genuíno na resolução das demandas de saúde dos seus munícipes.

Todavia, esse protagonismo poderia ser ainda maior se o atendimento semanal na Defensoria Pública fosse realizado dentro das instalações da Secretaria de Saúde, pois traria benefícios para a população, não apenas na percepção da resolução da sua demanda, como também evitaria múltiplos deslocamentos.

No caso da real impossibilidade de resolução da demanda, o cidadão pleiteante, de posse de uma declaração da SMS, na qual seriam explicitados os motivos pelos quais não foi possível o atendimento, poderia se dirigir à Defensoria Pública. Esta, por sua vez, atenderia apenas aqueles que já tivessem recorrido à SMS para solucionar suas demandas de saúde, uma vez que estas estariam devidamente documentadas com a referida declaração.

O município de Juazeiro do Norte não conta com outras formas de mitigação da judicialização.

Considerações Finais

O fenômeno da judicialização da saúde tem se tornado um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos em todas as esferas de governo. Entretanto, no município de Juazeiro do Norte, considerando o porte do município em termos de população, foi verificado um número diminuto de processos judiciais pleiteando assistência à saúde no ano de 2018, seja na forma de medicamentos e produtos para saúde ou de serviços.

Tal fato, certamente, está relacionado com a ampla cobertura que se observa, principalmente, na Atenção Básica e na Média/Alta Complexidade, corroborando com o entendimento de que o fortalecimento do SUS implica diretamente na redução da judicialização da saúde no setor público, o que deve ser buscado por todas as instâncias de governo e, principalmente, pela sociedade, haja vista ser esta a principal beneficiária de um sistema de saúde público, gratuito e eficiente.

Um outro ponto que merece ser destacado são os esforços envidados pela SMS de Juazeiro do Norte no sentido de estabelecer um diálogo interinstitucional com os diversos atores do Sistema de Justiça, notadamente com a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, o que também contribuiu para a redução da judicialização da saúde no município, conforme foi atestado pelo presente trabalho. Iniciativa esta que deve ser continuada e aperfeiçoada pela gestão.

Noutro pórtico, levando-se em consideração, de uma forma geral, os efeitos danosos à execução da política pública de saúde decorrentes da sua judicialização, esta deve ser acompanhada pelo gestor de forma sistemática e com bastante atenção, haja vista envolver o dispêndio imediato de recursos públicos, além das implicações administrativas e jurídicas decorrentes do processo judicial em si. Nesse sentido, ao analisar as informações enviadas pela SMS para a elaboração deste trabalho, verificou-se a ausência de ferramentas de gestão voltadas a esse fim, o que foi identificado como uma

fragilidade da Secretaria, pois, apesar da pequena quantidade de processos de saúde identificados no período considerado, é fundamental que o gestor disponha de meios que possam lhe assegurar o acesso imediato a essas informações e de forma detalhada.

Em razão disso, foram feitas sugestões para serem analisadas e implantadas pela gestão, obviamente de acordo com as suas necessidades e conveniências, bem como adequadas às particularidades da sua estrutura organizacional e funcional. Entretanto, reitera-se a importância da SMS otimizar a sua instrumentalização para o enfrentamento da judicialização da saúde, aqui contempladas tanto as ações preventivas existentes, quanto às ações voltadas para a realização de diagnósticos situacionais e cumprimento das decisões judiciais quando estas surgirem.

Como resultados dessa conduta, em apertada síntese, poderá ser observado um incremento na racionalização do uso dos recursos públicos destinados à saúde, bem como a redução ou manutenção do baixo percentual de judicialização observado no ano de 2018. Isso considerando que as demandas de saúde da população variam no decorrer do tempo.

Por fim, é importante ressaltar que o SUS, apesar dos seus 30 anos de existência, é um sistema ainda em construção, de modo que seu futuro dependerá do grau de comprometimento de governantes, gestores e da sociedade em geral. Comprometimento este aqui interpretado como maiores investimentos, profissionalização da gestão e defesa daquela que é considerada a política pública que implica numa maior inclusão e exercício de cidadania.

Referências

- 1 - François M [Relatório Informativo]. Dados gerais da judicialização. **Relatório da Procuradoria-Geral do Município**. Juazeiro do Norte: Procuradoria-Geral do Município, Prefeitura Municipal, 2020.
- 2 - Henrique MDC, Mendonça MRL, Braga EA. NAT-JUS e desjudicialização da saúde. In: Santos AO; Lopes LT, organizadores. **Coletânea direito à saúde: boas práticas e diálogos institucionais**. Brasília: CONASS; 2018. pp. 280-291 [citado 27 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.conass.org.br/biblioteca/>>.
- 3 - Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet]. Brasília, 3 out 2017 [citado 27 mar 2020]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html>.
- 4 - Nunes CFO, Ramos Júnior AN. **Judicialização do direito à saúde na região Nordeste, Brasil: dimensões e desafios**. Cad. saúde colet [Internet]. 2016 [acesso em 30 jan. 2020] 24 (2): 192-199. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/86vDNpVqKCW6RRQZyTL49Km/?lang=pt>>.
- 5 - Pereira SPD. In: Santos AO; Lopes LT, organizadores. **Coletânea direito à saúde: dilemas do fenômeno da judicialização da saúde**. Brasília: CONASS; 2018. pp. 108-118
- 6 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n.º 31, de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. [internet]. Brasília, 7 abr. 2010 [citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=877>>.
- 7 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n.º 107, de 6 de abril de 2010**. Institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. [internet]. Brasília, 7 abr. 2020 [citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/173>>.
- 8 - Brasil. Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015. **Código de Processo Civil**. Brasília; 2015. [internet]; [citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-.htm>.

9 - Brasil. **Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015.** Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n.º 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997. Brasília; 2015. [internet]; [citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm>.

10 - Celestino FKR. (2019). **Judicialização da saúde: Novas perspectivas e os esforços para uma autocontenção no Estado do Ceará.** [publicação online]; 2019 [citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <<https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52561/judicializacao-da-saude-novas-perspectivas-e-os-esforcos-para-uma-autocontencao-no-estado-do-ceara>>.

11 - Tribunal de Justiça do Ceará. **Recomendação n.º 1 do Comitê Executivo de Saúde do Estado do Ceará.** Dispõe sobre a utilização de relatório médico para ajuizamento de ações em matéria de saúde suplementar. [internet]. Fortaleza, 22 set 2017 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2017/10/Minuta-de-Recomenda%C3%A7%C3%A3o-Relat%C3%B3rio-M%C3%A9dico-Sa%C3%BAde-Suplementar-1.pdf>>.

12 - Tribunal de Justiça do Ceará. **Recomendação n.º 2 do Comitê Executivo de Saúde do Estado do Ceará.** Dispõe sobre a utilização de relatório médico para ajuizamento de ações em matéria de saúde pública. [internet]. Fortaleza, 22 set 2017 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2017/10/Minuta-de-Recomenda%C3%A7%C3%A3o-Relat%C3%B3rio-M%C3%A9dico-Sa%C3%BAde-P%C3%ABlica-1.pdf>>.

13 - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. **Portaria n.º 1.536, de 8 de setembro de 2017.** Dispõe sobre a constituição e o funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS), voltado a auxiliar a instrução e o julgamento de demandas relacionadas à saúde. [internet]. 2017. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2017/10/Portaria-1536-2017.pdf>>.

14 - Queiroz, L. **Solicitação de informações a respeito da Judicialização da Saúde em Juazeiro do Norte.** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por Pereira, SPD. sylvia.dantas1976@gmail.com [2020 fev 14].



A judicialização da saúde e as estratégias adotadas no Município de Natal: Uma proposta de fortalecimento

Flávio Henrique Falcão Araújo¹

Guilherme Davi da Silva²

Heryland Martins³

Joselisses Abel Ferreira⁴

Luciane Curtinovi Nunes⁵

Lydiane Karla Lôbo Marques⁶

Sebastião Quaresma Júnior⁷

Terezinha Rêgo⁸

Orientadora: Profa. MSc. Ione Silva Barros

O município escolhido para o estudo é Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Isso porque o estado é um dos pioneiros na busca por soluções não contenciosas, no intuito de mitigar os impactos negativos da judicialização na saúde.

¹ Graduado em Direito pela UFRRJ. Assessor Técnico Setorial da Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba-MG.

² Graduado em Enfermagem pela PADRAO. Secretário Municipal de Saúde de Campos Belos-GO.

³ Graduada em Odontologia pela UFPA. Secretária Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão-MA.

⁴ Graduada em Direito pela UFPB. Assessora Jurídica do CONASEMS.

⁵ Graduada em Nutrição pela UNISINOS. Auxiliar Administrativa do Setor de Planejamento da SMS de Osório-RS.

⁶ Graduada em Farmácia pela UFAL e em Direito pela UNEB. Advogada e Farmacêutica da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso-BA.

⁷ Graduado em Direito pela ULBRA. Procurador do Município de São Francisco do Guaporé-RO.

⁸ Graduada em Farmácia pela UFRN. Secretária Municipal de Saúde de Parnamirim-RN.

A escolha pelo município do Natal também considerou, para além dos aspectos demográficos e elevado número de demandas judiciais existentes na localidade, a informatização dos processos judiciais e a existência de núcleo de judicialização ativo.

A metodologia adotada foi a de pesquisa qualitativa e quantitativa, coleta e análise de dados sobre demandas judiciais.

Após a obtenção – juntamente ao Núcleo de Demandas Judiciais (NDJ) da SMS/Natal – do número dos processos relativos às ações judiciais em que o município de Natal/RN figurou no polo passivo, durante o período de janeiro a novembro de 2019, os processos foram devidamente analisados e selecionou-se aqueles que foram distribuídos em 2019 e envolviam demandas judiciais na área da saúde. Em seguida, foi realizada pesquisa individualizada sobre o teor de cada processo junto ao sistema denominado Processo Judicial Eletrônico (PJE) adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e a Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN).

No intuito de fundamentar e validar o estudo, também foi realizada coleta de informações junto a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, além de sites e doutrina.

Na análise individualizada dos processos foram coletados dados específicos como: número do processo; local de tramitação; tipo de demanda (individual ou coletiva); tipo de representação; polo passivo; assunto; presença ou não de laudo/declaração/receita médica; laudo médico ou receita médica proveniente ou não de médico do SUS; presença ou não de parecer/nota técnica produzidos por núcleo de apoio/Conitec; paciente incluso ou não no SUS; tutela ou liminar (deferida/indeferida/parcialmente deferida/prejudicado); existência ou não de recurso contra decisão interlocutória interposto pelo município; decisão do recurso contra decisão interlocutória (provido/parcialmente provido/improvido/prejudicado); defesa apresentada ou não pelo município; sentença (procedente/parcialmente procedente/improcedente/extinto sem julgamento de mérito/prejudicado); recurso de sentença interposto ou não pelo município; acórdão (provido/parcialmente provido/improvido/prejudicado); existência de determinação de bloqueio judicial; valor do bloqueio judicial e existência ou não de decisão contendo determinação de prisão do gestor.

Os dados coletados foram devidamente transferidos para planilha de Excel para viabilizar uma análise categorizada, com montagem de tabelas e gráficos.

As estratégias para solução de conflitos em que a SMS/Natal figura como parceira também foram analisadas, visando a obtenção de dados que permitissem a verificação do grau de êxito da iniciativa e, ainda, dos principais entraves detectados.

O escopo do estudo foi o diagnóstico e estratificação da judicialização da saúde no município, objetivando a propositura de nova ação ou o aperfeiçoamento das estratégias já existentes com a finalidade de reduzir ou qualificar as demandas judiciais em saúde.

Diagnóstico da judicialização no município

Com a melhoria do aparelhamento das instituições em prol da facilitação do acesso à justiça, tais como a Defensoria Pública e o Ministério Público e, ainda, do próprio Poder Judiciário, é certo que o número de demandas judiciais passou a se ampliar com o decurso do tempo.

No que concerne à judicialização da saúde, os pedidos contidos nas demandas judiciais são os mais variados, pleiteando a parte autora desde o fornecimento de ações e serviços de saúde que estão previstos na política pública a demandas descabidas e, por vezes, cercadas de potencial nocividade em face da ausência de evidências científicas.

Considerando que a judicialização da saúde tem sido crescente nas três esferas de governo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou pesquisa em nível nacional divulgando seu resultado em 2019. Na referida pesquisa, restou evidenciado que o número de demandas judiciais relativas à saúde aumentou 130% entre 2008 e 2017, enquanto o número total de processos judiciais cresceu 50%. Além disso, verificou-se que dentre as demandas afetas à saúde em nível nacional apenas 3,62% foram ações coletivas (1).

Tais dados demonstram um crescimento extraordinariamente maior das ações que envolvem demandas da saúde quando comparado ao crescimento dos processos judi-

ciais em geral, bem como a predominância das demandas individuais em detrimento das coletivas.

O Judiciário brasileiro tem sido muito receptivo a demandas individuais que pleiteiam a concessão de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde pelo SUS. Sua posição mais frequente considera que o direito à saúde previsto na Constituição garante ao cidadão o direito de receber esses produtos sempre que houver a necessidade, por indicação médica, e a recusa de fornecimento pelo poder público (2).

Contudo, quando a indicação médica desconsidera a política pública vigente, deve ser questionada. “Não se deve conferir verdade absoluta às prescrições médicas quando se tratar de tecnologias ainda não incorporadas no sistema público [...], sob pena de desequilíbrio no planejamento, na organização e nas políticas de saúde” (3).

Ademais, os recursos da saúde são finitos, não havendo como se ofertar tudo a todos.

Observado o efetivo crescimento do número de demandas judiciais, a limitação de recursos e a competência de cada ente segundo as normas do SUS, verifica-se a necessidade de aprofundar a avaliação do perfil da judicialização no âmbito municipal.

Contudo, embora as discussões acerca dos impactos da judicialização venham se intensificando a cada dia, ao se efetuar uma busca por diagnósticos no âmbito municipal, depara-se com a escassez de estudos e sistemas que viabilizem o controle de demandas e, conseqüentemente, a propositura de medidas de enfrentamento.

Como propor novas estratégias ou, ainda, o fortalecimento das práticas em vigor se há desconhecimento das causas e efeitos da judicialização da saúde em um município específico?

Embora a ausência de implementação de práticas destinadas ao controle das demandas se dê, muitas vezes, pela sobrecarga de trabalho que acomete as procuradorias e assessorias jurídicas municipais e, ainda, pela ausência de um sistema de informação que viabilize o efetivo controle das demandas e facilite a análise dos dados, resta evidenciado que é partir do controle e análise de dados que a gestão local poderá adotar as medidas necessárias para qualificação das demandas.

Assim como no restante do país, o crescimento do número de demandas judiciais afetas à saúde tem sido uma realidade no Rio Grande do Norte (1) e sendo Natal a sua capital, possui grande concentração de demandas.

Na fase de levantamento de informações junto ao município de Natal/RN sobre as demandas judiciais observou-se que, apesar de existirem dificuldades, houve um pequeno avanço no controle das ações judiciais que envolveram a saúde no ano de 2018, pois a partir do segundo semestre o Núcleo de Demandas Judiciais da SMS passou a utilizar planilha de Excel para concentrar informações relativas ao número dos processos e ao assunto da demanda em um mesmo local e, desta forma, realizar o controle dos prazos.

Ocorre que, sendo a referida planilha voltada prioritariamente ao controle de prazos, sua alimentação é realizada sempre que a SMS é notificada ou intimada nos autos dos processos judiciais ou extrajudiciais. Ou seja, a cada notificação ou intimação percebida pela secretaria uma nova linha da planilha é preenchida, independentemente de tratar-se de demanda nova ou já cadastrada. Por tal motivo, comumente ocorrem múltiplos registros relativos a um mesmo processo na planilha de controle.

No que toca à delimitação do período da pesquisa, tendo o município passado a realizar um maior controle das demandas a partir do segundo semestre de 2018, no intuito de alcançar informações mais precisas, optamos por nos debruçar sobre o período de janeiro a novembro de 2019.

Após disponibilização dos dados de processos pelo NDJ e delimitação do período da pesquisa, foram aplicados filtros no intuito de excluir as demandas repetidas, as que não foram distribuídas dentro do período de janeiro a novembro de 2019, as extrajudiciais e, ainda, as que não envolviam demandas judiciais por ações e serviços públicos de saúde. Efetuada a análise, foram detectados 113 processos envolvendo temas afetos à judicialização da saúde nos quais o município integrou o polo passivo da ação, sendo 112 no âmbito da Justiça Comum e apenas 1 na Justiça Federal.

Para fins de diagnóstico da judicialização no município, os dados foram avaliados observando a variação de pedidos formulados, o tipo de representação da parte autora, o quantitativo de deferimento ou indeferimento das tutelas e liminares e, ainda, de pro-

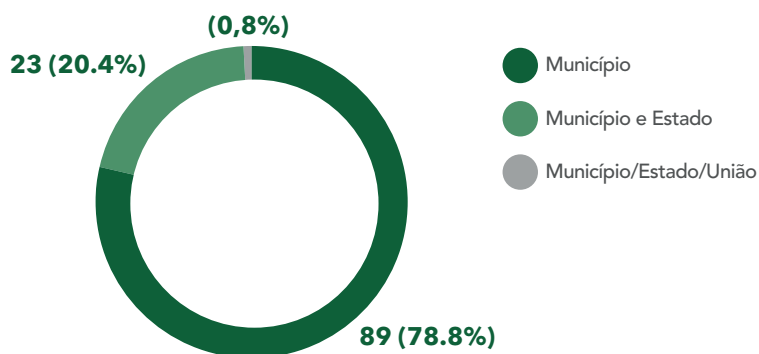
cedência ou improcedência das decisões de mérito, bem como a eventual interposição de recursos por parte da SMS.

Conforme restará demonstrado, as demandas analisadas no período foram predominantemente individuais e a representação da parte autora se deu prioritariamente por meio da Defensoria Pública, o que nos permite afirmar que a atuação da instituição no município é bastante intensa.

Ademais, constatou-se que o maior número de demandas e de bloqueios judiciais ocorreram em ações que pleitearam procedimentos e, ainda, que a maioria dos pedidos de liminar ou tutela foram deferidos pelos magistrados locais.

Da análise de dados relativos ao polo passivo das demandas, verificou-se que em 78,8% das ações apenas o município foi demandado, sendo que em 20,4% o estado também integrou a lide e em apenas 0,9% foi atestada a presença dos três entes (Figura 1).

FIGURA 1. Representação gráfica de ações judiciais por polo passivo no período de janeiro a novembro de 2019 em Natal.



Fonte: TJRN - 1ª Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Destaque-se que, puderam ser analisados apenas processos de acesso público, estando excluídos quaisquer processos sigilosos tendo em vista que tramitam em segredo de justiça.

Durante a análise dos processos foi possível perceber que alguns foram cadastrados no sistema PJE com assuntos que não condizem com o pedido realizado, como, por exemplo, o cadastramento do pedido de fornecimento de medicamentos quando, na verdade, tratava-se de pedido de fórmula infantil ou, ainda, o cadastramento do assunto de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) quando o pedido se referia à realização de exame. Dessa forma, os assuntos considerados no presente trabalho foram aqueles que, efetivamente, correspondem ao pedido das ações judiciais de forma a conferir maior confiabilidade aos dados.

Acerca do custo da judicialização da saúde para os cofres do município de Natal no período analisado, não se pôde inferir o valor efetivamente gasto com as ações judiciais, isto porque não havia sistema ou outro meio de registro na SMS que contabilizasse a totalidade dos gastos advindos de cada demanda.

Ademais, concomitantemente às ações distribuídas no período do estudo, permanecem em tramitação inúmeras outras ações de períodos anteriores que continuaram tendo reflexos financeiros nos cofres municipais durante 2019. Não bastasse isso, da análise dos processos, observou-se que poucas informações acerca do custo real de cada pleito podem ser verificadas.

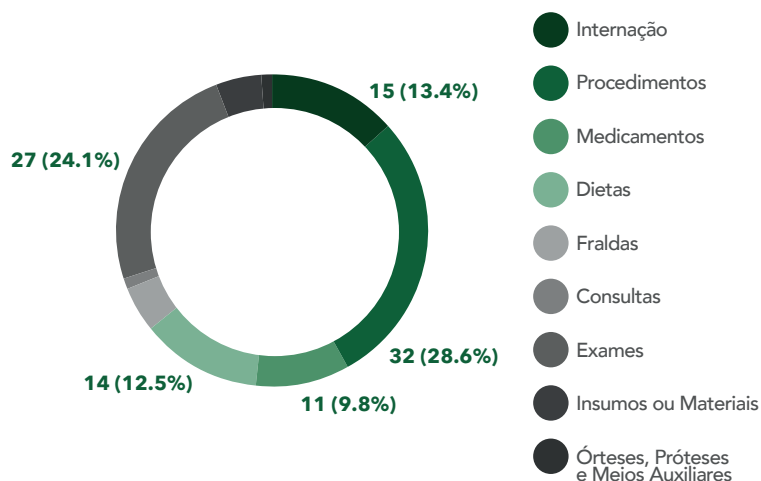
Com relação às determinações de bloqueio judicial determinadas nos processos avaliados, observou-se que atingiram o montante de R\$ 458.703,98 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e noventa e oito centavos) até o encerramento da pesquisa, em 2019.

Os pedidos observados nas ações judiciais analisadas foram classificados nos seguintes assuntos: consultas; dietas; exames; fraldas; insumos ou materiais; internação; medicamento; órteses, próteses e meios auxiliares; e procedimentos. Nos casos em que foram formulados pedidos cumulativos pela parte autora, a classificação foi realizada considerando o pedido principal da ação.

Conforme se depreende da Figura 2, na Justiça Estadual os pedidos relativos a procedimentos corresponderam a 28,6%, seguido de exames (24,1%), internação (13,4%), dietas (12,5%), medicamentos (9,8%), fraldas (5,4%), insumos e materiais (4,5%). Já

os pedidos relativos à consultas e órteses, próteses e meios auxiliares atingiram apenas 0,9%, cada.

FIGURA 2. Representação gráfica de ações judiciais por tipo de pedido detectado no período de janeiro a novembro de 2019, em Natal.



Fonte: TJRN - 1º Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Já na Justiça Federal o único pedido detectado no período dizia respeito à internação em leito de UTI.

Acerca dos pleitos judiciais por procedimentos, é oportuno registrar que estes atingiram o número de 32, dos quais apenas 1 não estava acompanhado de laudo médico. Ademais, dos 31 pleitos restantes, apenas 5 laudos médicos anexados aos autos não foram provenientes de profissionais médicos do SUS. Quanto às decisões interlocutórias proferidas, apenas uma foi indeferida.

No que toca à decisão que indeferiu a tutela, é importante registrar que foi exarada em pleito voltado à realização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, tendo o juiz solicitado parecer técnico ao NAT-JUS/RN e o mesmo informado que não havia evidência científica do tratamento.

Destaque-se, ainda, que os pleitos por procedimentos foram os responsáveis por cerca de 74% dos bloqueios judiciais identificados durante a pesquisa, já que somaram o montante de R\$ 343.692,80 (trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

No que concerne aos pleitos por exames, segundo pedido mais judicializado, das 27 demandas distribuídas, apenas 3 não foram instruídas com indicações médicas provenientes de profissional do SUS e, dentre as que possuíam decisão interlocutória exarada até o encerramento da pesquisa, nenhuma havia sido indeferida.

É de se notar que as demandas por serviços de média e alta complexidade foram predominantes no período (procedimentos, exames e pedidos de internação em leito de UTI). Analisando tal fato, em conjunto com a baixa cobertura da atenção primária no município, que atualmente gira em torno de 43,47% (4), pode-se concluir, assim como Spedo, que “a baixa resolutividade da atenção básica aumenta a demanda para a média complexidade” (5).

Outra informação relevante obtida, diz respeito aos pleitos por medicamentos, já que foram prioritariamente por Enoxaparina, conforme demonstra a Tabela 1.

TABELA 1. Ações Judiciais (A. J.), por tipo de medicamento pleiteado nas demandas judiciais distribuídas contra o município de Natal no período de janeiro a novembro de 2019.

MEDICAMENTO	NÚMERO DE A. J.
Enoxaparina 40mg	5
Enoxaparina 60mg	3
Ácido Valpróico/500mg	2
Topiramato/100mg	1
Total	11

Fonte: TJRN - 1º Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Acerca dos pleitos por Enoxaparina, verificou-se nos autos que os autores estavam inclusos no sistema e acostaram laudo ou receita médica proveniente de médico do SUS. Além disso, das 8 ações judiciais que envolveram o medicamento, 7 são voltadas

à pacientes gestantes sendo que apenas uma não possui quadro de trombofilia evidenciado nos autos.

A Enoxaparina 40mg foi incorporada ao SUS para o tratamento de gestantes com trombofilia por meio da Portaria n.º 10, de 24 de janeiro de 2018 (6). O referido medicamento é do componente especializado e pertence ao Grupo 1B. Assim sendo, seu financiamento é feito pelo Ministério da Saúde e sua aquisição compete à Secretaria Estadual de Saúde (SES). No entanto, em apenas uma das demandas pela Enoxaparina o estado também figurou no polo passivo.

Quanto ao Topiramato, o referido medicamento igualmente pertence ao componente especializado e sua aquisição cabe à SES. Já o Ácido Valpróico é do componente básico e sua aquisição é, em regra, do município.

Assim sendo, considerando que 9 das 11 demandas que envolveram medicamentos eram do componente especializado, que todas tiveram suas tutelas provisórias deferidas ou parcialmente deferidas e que até o final do estudo (2019) todas as tutelas estavam vigentes, pode-se concluir que em 81,8% das demandas que envolveram medicamentos foram exaradas decisões determinando que o município fornecesse o que era de responsabilidade do estado. Nesse sentido, se forem consideradas apenas as ações que envolvem medicamentos, a situação de Natal se demonstra mais complexa que a encontrada em Tubarão-SC em 2010, onde medicamentos presentes no componente especializado representaram 36,8% do custo total (7).

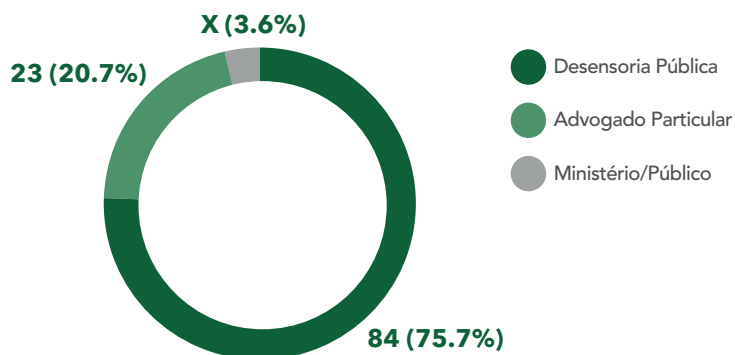
Além disso, verificou-se que em três das demandas foram determinados bloqueios judiciais que, somados, atingiram o valor de R\$ 36.283,95 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). Ou seja, aproximadamente 8% do montante total de bloqueios no período, enquanto os procedimentos foram responsáveis por cerca de 74%.

Outro dado relevante obtido na pesquisa diz respeito ao tipo de representação do autor nas ações judiciais distribuídas em Natal.

Na ação judicial em trâmite na Justiça Federal, a representação da parte autora foi realizada por advogado particular. Já na Justiça Estadual, excluída uma única ação

judicial em trâmite no Juizado Especial Cível em que a parte ingressou sem representação, a maioria da representação do autor/paciente foi feita pela Defensoria Pública do Rio Grande Norte (75,7%), ocupando a advocacia privada o segundo lugar (20,7%) e em terceiro e última posição encontrou-se a representação do Ministério Público (3,6%) (Figura 3).

FIGURA 3. Representação gráfica de ações judiciais por tipo de representação do autor/paciente detectado no período de janeiro a novembro de 2019 em Natal.



Fonte: TJRN e JFRN - 1º Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Situação bastante semelhante se apresentou em estudo realizado no município de Salvador/BA, no período de 2014 a 2016, no qual 75,5% das ações contaram com representação da Defensoria Pública. Em ambos os casos, “é possível inferir que um percentual significativo dos autores dos processos judiciais da amostra detém algum grau de vulnerabilidade, ainda que não seja socioeconômica” (8).

Em provável consequência do tipo de representação, observou-se que as demandas de caráter individual responderam por 97,4% dos processos judiciais distribuídos no período da pesquisa, enquanto as demandas coletivas atingiram apenas 2,6%, conforme demonstra a Tabela 2:

TABELA 2. Ações Judiciais, por caráter da demanda detectada nas ações distribuídas contra o município de Natal no período de janeiro a novembro de 2019.

CARÁTER DA DEMANDA	NÚMERO DE AÇÕES	PERCENTUAL
Coletiva	3	2,7%
Individual	110	97,3%
Total	113	100%

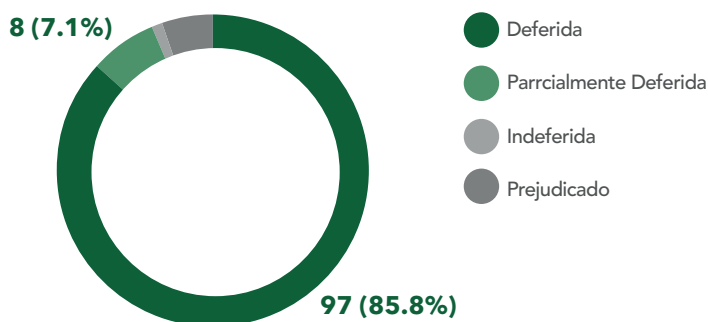
Fonte: Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande- PB.

Acerca das decisões interlocutórias exaradas, buscou-se classificá-las como deferidas, indeferidas, parcialmente deferidas e prejudicadas, entendendo como prejudicadas as situações em que o pedido de tutela ou liminar ainda não tivesse sido apreciado.

Conforme demonstra a Figura 4, após efetuada a classificação das 113 ações judiciais, observou-se que 97 pedidos de liminar ou tutela foram deferidos pelos magistrados (85,8%), 8 foram deferidos parcialmente (7,1%), 6 ainda não foram apreciados (5,3%) e apenas 2 foram indeferidos (1,8%). Sobre os referidos dados, é oportuno registrar que em nenhum processo a decisão interlocutória exarada foi questionada via recurso.

Em estudo realizado no município de Sobral/CE, referente a processos que tramitaram na comarca no período de 2014 a 2016, restou identificado que as decisões interlocutórias foram deferidas em cerca de 72% das ações (9). Desta forma, tanto o município de Sobral/CE como o de Natal-RN retratam a predominante tendência de deferimento dos pleitos já em caráter liminar, sendo que em Natal essa tendência foi ainda maior.

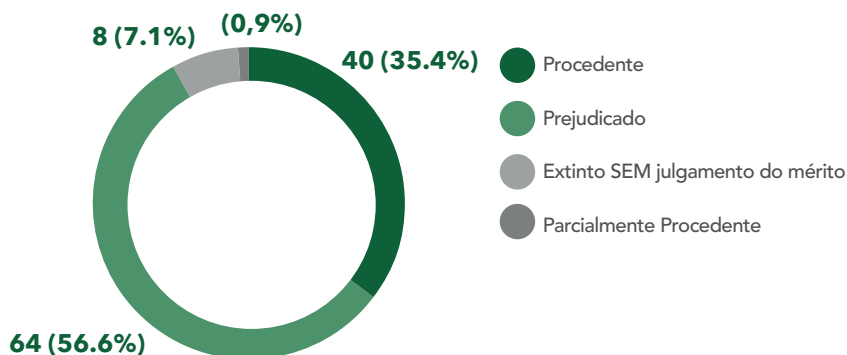
FIGURA 4. Representação gráfica de ações judiciais por apreciação do pedido de tutela ou liminar nas ações distribuídas contra o município de Natal no período de janeiro a novembro de 2019.



Fonte: TJRN e JFRN - 1º Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Considerando o lapso temporal analisado, até a data em que se encerrou a pesquisa (2019), 64 processos ainda não possuíam sentenças exaradas, o que corresponde a 56,6% das demandas. Dentre os processos restantes, 40 ações judiciais foram julgadas procedentes (35,4%), 8 foram extintas sem julgamento de mérito (7,1%) e 1 foi julgada parcialmente procedente (0,9%). Desta forma, verifica-se que em nenhuma das demandas analisadas o pedido autoral foi julgado improcedente (Figura 5).

FIGURA 5. Representação gráfica das sentenças exaradas nas ações judiciais nas ações distribuídas contra o município de Natal no período de janeiro a novembro de 2019.



Fonte: TJRN e JFRN - 1º Grau – Processo Judicial Eletrônico (PJE). Atualizado de 01/01/2019 a 15/12/2019.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Em 2009, foi criado em Natal-RN o Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), que visava solucionar administrativamente as demandas envolvendo o cidadão e o SUS.

Como prática de composição de litígios na área da saúde, em atuação conjunta com diversos órgãos públicos, a Procuradoria da União no Rio Grande do Norte (PU-RN) participava do CIRADS, o qual foi constituído por meio do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a PU-RN, a Defensoria Pública da União no Estado do Rio Grande do Norte (DPU-RN), a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE-RN), a Procuradoria Geral do Município do Natal (PGMN-RN), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP-RN) e a Secretaria Municipal de Saúde do Natal (SMS-Natal), cuja assinatura ocorreu em solenidade realizada na sede da PU-RN, no dia 22 de julho de 2009. Em julho de 2010 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao acordo, para incluir a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte no CIRADS (10).

Embora o CIRADS não esteja mais ativo, deixou sementes que foram desenvolvidas posteriormente em outros espaços de diálogo interinstitucional.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) criou o Comitê Estadual das Demandas da Saúde, cujas atividades estão disponibilizadas em seu sítio eletrônico (<http://comite.tjrn.jus.br/index.php>), com destaque para a publicação dos pareceres técnicos produzidos pela antiga Câmara Técnica da Saúde, atualmente Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário nas Demandas de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte (NAT-JUS).

Acerca das etapas que antecederam a implantação do Comitê Estadual das Demandas da Saúde do Rio Grande do Norte, resta especificado em seu portal o seguinte:

A partir dos resultados da Audiência Pública n.º 4, realizada pelo STF em maio e abril de 2009, o CNJ constituiu um grupo de trabalho ([Portaria n.º 650, de 20 de novembro de 2009](#)), objetivando orientação sobre a crescente demanda dos processos envolvendo saúde.

Os trabalhos do grupo culminaram na aprovação da [Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010](#), pelo Plenário do CNJ que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que envolvem a assistência à saúde.

Em 6 de abril de 2010, o CNJ publicou a [Resolução n.º 107](#), que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde – Fórum da Saúde.

O Fórum da Saúde é coordenado por um Comitê Executivo Nacional (atualmente a [Portaria n.º 8 de 2 de fevereiro de 2016](#)) e constituído por Comitês Estaduais.

A fim de subsidiar com informações estatísticas os trabalhos do Fórum, foi instituído, por meio da Resolução 107 do CNJ, um sistema eletrônico de acompanhamento das ações judiciais que envolvem a assistência à saúde, chamado [Sistema Resolução 107](#).

(...)

Em setembro de 2016 o CNJ, na presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, finalmente reconheceu a necessidade de manutenção e criação dos Comitês Estaduais, publicando a [Resolução n.º 238/2016](#) a qual efetivamente determinou que os Tribunais de Justiça e Regionais Federais criem e mantenham os Comitês Estaduais da Saúde, bem como a criação de uma vara especializada em demandas da saúde (11).

O Comitê Estadual do Rio Grande do Norte é composto por 13 membros, que representam as seguintes instituições: Justiça Estadual, Justiça Federal, Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Rio Grande do Norte, Defensoria Pública Estadual do Rio Grande do Norte, Defensoria Pública da União do Rio Grande do Norte, Advocacia-Geral da União do Rio Grande do Norte, Ordem dos Advogados do Brasil, Saúde Suplementar e Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte.

Ademais, o Comitê conta com uma Câmara Técnica, conhecida como Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que é responsável pela elaboração de documentos técnicos que

visam auxiliar os magistrados em suas decisões e realiza oficinas bimestrais voltadas aos profissionais do Direito e da Saúde e destinadas ao debate das principais questões jurídicas e médicas do período.

Em 6 de abril de 2011, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte instituiu, por meio da Resolução n.º 011/2011 (revogada pela Resolução n.º 015/2019), o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do Poder Judiciário do estado, cujo objetivo é implementar a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequados aos Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário (12).

Considerando as atribuições do referido núcleo, em 13 de maio de 2019, por meio da Portaria Conjunta n.º 18/2019-TJ (13), foi criado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em matéria de saúde (CEJUSC Saúde - Natal), com atuação no âmbito da Comarca de Natal e sede no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Natal.

O CEJUSC Saúde - Natal possui competência para conciliação e mediação, processual e pré-processual, para solução de conflitos relacionados às demandas de saúde. Atualmente o CEJUSC realiza audiências três vezes por semana, sendo dois dias voltados às demandas que envolvem os usuários do SUS e o estado e/ou município e um dia voltado aos usuários da saúde suplementar e os respectivos planos de saúde.

Já o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS) é composto por profissionais da Saúde e tem como função exclusiva o apoio técnico ao Judiciário por meio de pareceres elaborados a partir da medicina baseada em evidências.

Em 2014, foi firmado, no estado do Rio Grande do Norte, o Termo de Cooperação Técnica n.º 8/2014, de 9 de dezembro de 2014, entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), o Governo do estado, o município de Natal e o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), estabelecendo a criação da Câmara Técnica.

Já a adesão da Justiça Federal de 1º grau do Rio Grande do Norte ocorreu em 19 de junho de 2015, por meio da assinatura do Termo Aditivo n.º 01/2015 ao Termo de Cooperação Técnica n.º 8/2014. Após sua adesão, a JFRN passou a disponibilizar o banco de dados dos pareceres do NAT-JUS por meio do JudSaúde (<https://www.>

jfrn.jus.br/judsaude/pareceres.xhtml) acessível aos magistrados federais, estaduais e, ainda, usuários externos.

Posteriormente, a Portaria n.º 1.214/2016-TJ de 21 de setembro de 2016 (14), apresentou as regras para funcionamento do NAT-JUS.

A citada portaria define que a Câmara Técnica será composta, preferencialmente, por médicos e farmacêuticos do quadro de servidores efetivos dos órgãos e entes cooperadores, os quais elaborarão respostas técnicas rápidas para casos em que não haja necessário levantamento bibliográfico complexo e Notas Técnicas para casos específicos e complexos que demandam revisão bibliográfica, análise do cenário, informações sobre o custo unitário, recomendação sobre riscos e benefícios da liberação ou não de tecnologia fora do protocolo SUS.

A comunicação com a Câmara Técnica é feita por meio eletrônico e as demandas devem ser respondidas a partir da data do recebimento em até três dias no caso de Respostas Técnicas e em até cinco dias no caso de Notas Técnicas. Os grupos de trabalho devem atuar em semanas sucessivas, de acordo com escala semanal de trabalho, utilizando o espaço físico nas dependências de um dos prédios do Tribunal de Justiça do estado e seus membros devem se reunir na primeira semana do mês seguinte ao bimestre anterior para deliberar sobre os procedimentos internos e a formação de bancos de dados.

Conforme art. 4º da Portaria n.º 1.214/2016-TJ, os deveres dos profissionais que integram a Câmara Técnica são:

- I. atender às demandas dos magistrados de forma diligente e tempestiva, fornecendo-lhes os documentos de que trata o art. 2º desta Portaria;
- II. orientar o magistrado sobre a melhor alternativa de esclarecimento da questão técnica envolvida no processo judicial;
- III. garantir total sigilo sobre todos os dados e informações que a equipe tenha acesso durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- IV. prestar os esclarecimentos necessários aos magistrados sobre as informações relativas à natureza e ao andamento dos serviços executados ou em execução;

V. disponibilizar o acesso a todo o serviço produzido, além de informações necessárias sobre o mesmo, sempre que solicitado;

VI. elaborar relatórios contendo os serviços prestados e temas que foram objeto de consulta dos magistrados, contendo o número do processo e a identificação das partes, sempre que necessário; e

VII. garantir qualidade técnica dos documentos elaborados (14).

O município de Natal conta, ainda, com o SUS MEDIADO, cujo Acordo de Cooperação foi assinado em 10 de setembro de 2012, tendo como parceiros: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN); SESAP/RN; Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE/RN); Procuradoria Geral do Município de Natal (PGMN/RN); SMS/Natal e DPU/RN.

A parceria tem por objetivo o estabelecimento de ampla cooperação entre os parceiros, o intercâmbio de ações e a difusão de informações, visando garantir maior efetividade às políticas públicas de saúde no município do Natal, tais como evitar a propositura de demandas judiciais e assegurar o acesso aos usuários hipossuficientes do SUS a medicamentos e procedimentos médicos de responsabilidade do estado do Rio Grande do Norte e dos municípios participantes, previstos no SUS.

Segundo informações prestadas pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte em seu Portal, as sessões de mediação relativas ao programa ocorrem todas às terças-feiras na sede da Defensoria Pública, sendo a Câmara de Conciliação formada pelo assistido, por um farmacêutico, um médico, um Defensor Público Estadual, um representante da Procuradoria Geral do Estado e um representante do município (15).

Ocorre que em 2016, a SMS/Natal deixou de participar do programa, apenas retornando em dezembro de 2018. Segundo informações apresentadas pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, em tal período o número de demandas judiciais cresceu consideravelmente. Assim, o retorno do município em 2018 foi extremamente salutar e ampliou a resolutividade do programa, tendo o índice de resolução extrajudicial atingido 55,8% em 2019 (16).

Atualmente, participam do programa no Rio Grande do Norte a SMS/Natal, SESAP, DPE/RN, DPU e PGE/RN, sendo o programa também adotado nas Defensorias Públicas do Tocantins e de Rondônia.

Apesar de todos os esforços envidados no município de Natal visando, se não a resolução a minoração das demandas judiciais em face da Administração Pública na seara da saúde, não se pode olvidar que há ainda um longo caminho, repleto de percalços, a ser percorrido.

Isso porque, segundo consta da descrição quando da apresentação dos projetos desenvolvidos pelo Judiciário potiguar em parceria com o Município de Natal em conjunto como Instituto Innovare (17), as maiores dificuldades encontradas para o pleno desenvolvimento da proposta residiam na reticência dos profissionais de saúde em fornecer maiores esclarecimentos quanto à possibilidade de substituição ou mesmo a existência de insumos, medicamentos ou tratamentos similares na rede pública, devidamente reconhecidos pelos órgãos reguladores, que se mostrassem como alternativas viáveis para a solução dos problemas dos pacientes. E, ainda, a burocracia estatal e ausência de planejamento da Administração na aquisição célere e ordenada por meio dos processos licitatórios cabíveis (18).

E mais: apesar das amplas informações dando conta de que os métodos alternativos de resolução de conflitos em saúde desenvolvidos em Natal tenham sido capazes de solucionar cerca de 50% (cinquenta por cento) de conflitos potencialmente capazes de serem judicializados (19), as demandas por procedimentos, exames e internações ainda se encontram no topo do ranking de demandas em andamento no judiciário norte-rio-grandense.

Cumprе ressaltar, ainda, que um dos grandes óbices à efetividade do SUS Mediado foi o fato da Secretaria Municipal de Saúde ter retirado os profissionais que atuavam no programa sem designar substitutos ainda em 2016 (20). Tendo o retorno do município ao programa se demonstrado comprovadamente importante, resta evidenciada a constante necessidade de se reavaliar a interação entre os órgãos e entes que compõem o projeto para que ele permaneça com robustez e credibilidade.

Considerações Finais

A escolha do município de Natal considerou, para além dos aspectos demográficos, o número de demandas judiciais existentes, a informatização dos processos judiciais e a existência do núcleo de judicialização ativo, fatores que facilitariam o processo de coleta dos dados.

O resultado do diagnóstico, a partir da estratificação das demandas judiciais no município, evidencia que o número de demandas na Justiça Federal, na qual Natal vem sendo acionado no polo passivo, é bastante reduzido em relação ao montante de processos distribuídos na Justiça Estadual.

Constatou-se que a falta de sistematização das informações sobre demandas judiciais, tanto no âmbito dos serviços de saúde, como nos espaços estratégicos de gestão e articulação intersetorial, dificulta a visão geral do problema e, consequentemente, sua análise e a tomada de decisão. Podem ser apontados como efeitos dessa situação: a perda de oportunidade de implantação de processos de melhoria relativos às demandas efetuadas em decorrência da não realização de ações e serviços que já constam da política pública; cobranças duplicadas ou triplicadas em face das esferas gestoras do SUS; dificuldade de detecção de eventuais falhas nas defesas ou de perdas de prazo etc.

Outra dificuldade atestada e que, sem sombra de dúvidas, pode causar fragilidade nos argumentos apresentados nas defesas e/ou recursos é a ausência de comunicação ou, ainda, a comunicação tardia entre o setor jurídico e a área técnica ligada ao objeto da demanda judicial.

Desta forma, resta evidenciada a necessidade de desenvolvimento e implementação de um sistema com capacidade de agregação e articulação de dados, oriundos de áreas diversas, com capacidade de gerar a visão detalhada do caso concreto e dos aspectos gerais e impactos da totalidade das demandas vigentes.

No decorrer da análise observou-se, também, que a maioria das demandas é de caráter individual e buscam o acesso, variadas as proporções, aos mais variados objetos, tais como procedimentos, medicamentos, dietas, consultas, fraldas, internações etc.

O SUS é universal e igualitário, não havendo discriminação quanto à garantia do direito. No entanto, estabelece condições organizativas para garantir o acesso. As portas de entrada do sistema têm esse caráter e são previstas no Decreto n.º 7.508/2011, art. 9º. Desta forma, as demandas individuais propostas por indivíduos que sequer buscaram as portas organizativas do Sistema, na tentativa de utilizar-se do Judiciário como uma porta própria e rápida do acesso, precisam ser combatidas com esmero.

Ainda merece destaque, no estudo em tela, que na maioria dos processos a representação do autor/paciente foi feita pela Defensoria Pública e possuem caráter individual, fato que gera preocupação, pois tais pleitos visam assegurar interesses individuais em detrimento da coletividade.

A judicialização da saúde pode trazer distorções severas e graves ao equilíbrio do orçamento público e as decisões sobre casos individuais oneram sobremaneira o serviço público e interferem na política de saúde.

O município de Natal apresenta alguns fatores que concorrem para o fenômeno da judicialização, quais sejam: a baixa cobertura da Atenção Primária (43%), criando vazios assistenciais; a não efetivação do processo de regionalização estadual, mantendo a concentração de procedimentos de média e alta complexidade na Capital; os baixos valores remuneratórios da tabela nacional não são atrativos aos prestadores privados, causando escassez na oferta de serviços, o que força um grande desembolso financeiro para complementação dos valores de procedimentos.

Em que pesem as dificuldades citadas, Natal tem sido palco de estratégias inovadoras de construção de moldes institucionais para estruturação normativa e jurídica para a consolidação do SUS, como o extinto Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), que visava solucionar administrativamente as demandas envolvendo o cidadão e o SUS. Atualmente estão em pleno funcionamento o Comitê Estadual das Demandas da Saúde do Rio Grande do Norte, o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário nas Demandas de Saúde no Rio Grande do Norte (NAT-JUS), o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em matéria de saúde (CEJUSC Saúde - Natal) e o SUS Mediado.

Ressalte-se a notória importância da continuidade e fortalecimento dessas experiências exitosas, pois, em regra, os magistrados e demais operadores do direito não detêm o conhecimento técnico acerca da gestão do SUS. Tome-se como exemplo concreto o fato de que a ausência da SMS/Natal no SUS Mediado no período 2016-2018 teve como consequência o crescimento considerável do número de demandas no período, já o seu retorno gerou uma redução de 55,8% no Índice de Resolução Extrajudicial.

Como última reflexão: para encurtar o caminho entre o hoje e o futuro é necessário superar as dificuldades motivadoras das ações judiciais, possibilitando o reconhecimento dos excessos; e repensar se o modelo atual de judicialização atende aos preceitos constitucionais, já que escolhas difíceis precisam ser tomadas em um cenário de escassez de recursos.

O presente trabalho não pretendeu ser conclusivo. O importante é que estudos dessa natureza sejam realizados, com o intuito de subsidiar a sustentabilidade das políticas públicas, bem como qualificar a ação conjunta dos atores envolvidos na busca pela qualificação da judicialização da saúde.

Referências

- 1 - Conselho Nacional de Justiça. **Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução** [Internet]. São Paulo: Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper); 2019 [citado 13 out 2019]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf>>
- 2 - Wang, D. W., Vasconcelos, N. P., Oliveira, V. E., & Terrazas, F. V. (2014). **Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e organização federativa**. Revista de Administração Pública, 48(5), 1191-1206.
- 3 - Schulze CJ. **Novos parâmetros para a judicialização da saúde: critérios para a teoria da decisão judicial**. [Tese]. Itajaí: Programa de Pós-Graduação stricto sensu em ciência jurídica, Universidade do Vale do Itajaí; 2019.
- 4 - Prefeitura Municipal do Natal, Secretaria Municipal de Saúde. **Plano municipal de saúde. Natal/RN: 2018/2021** [Internet]. Natal: Prefeitura Municipal do Natal; 2018 [citado 02 out. 88 2019]. Disponível em: <<https://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/File/SMS-PMS2018-2021.pdf>>
- 5 - Spedo SM, Silva Pinto NR, Tanaka OU. **O difícil acesso a serviços de média complexidade do SUS: o caso da cidade de São Paulo, Brasil**. Physis (Rio J.) 2010; 20:953-72. [citado em 25 out 2019]; Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/physis/v20n3/v20n3a14.pdf>>.
- 6 - **Portaria n.º 10, de 24.01.2018**. [citado em 25 out 2019]; Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/01/2018&jornal=515&pagina=124&totalArquivos=158>>.
- 7 - Ferro AM, Santana LSS, Alves CA, et al. **Uma abordagem econômica de processos judiciais de medicamentos impetrados contra um município do sul do Brasil**. J. bras. econ. saúde (Impr.). [internet]. 2016 [citado em 10 abr. 20]; 8(1):39-46. Disponível em: <<http://files.bvs.br/upload/S/2175-2095/2016/v8n1/a5479.pdf>>.
- 8 - Rios, Sadraque Oliveira. **Judicialização do direito à saúde pública no município de Salvador - BA: principais aspectos neoinstitucionais que interferiram nas decisões liminares proferidas na justiça estadual entre 2014 e 2016**. [Tese] Salvador: Núcleo de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia; 2018.
- 9 - Vasconcelos, Francisco & Dias, Maria Socorro & Saraiva, Maria & Silva, Márcia. **Judicialização da saúde: análise de ações judiciais demandadas na comarca de Sobral, Ceará**. Sanare - Revista de Políticas Públicas. 16. 10.36925/sanare.v16i2.1172.

10 - Defensoria Pública da União (BR). **Defensor público-geral em exercício participa de reuniões no Rio Grande do Norte** [Internet]. Natal, 12 nov. 2012 [citado 28 out 2019]. Disponível em: <<https://www.dpu.def.br/noticias-rio-grande-do-norte/9839-defensor-publicogeral-participa-de-reunioes-no-rio-grande-do-norte>>.

11 - Comitê Estadual das Demandas da Saúde do Rio Grande do Norte (BR). **NAT-JUS** [Internet]. Natal, c2016 [citado 10 nov. 2019]. Disponível em: <<http://comite.tjrn.jus.br/index.php/nat-jus>>.

12 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (BR). **NUPEMEC** [Internet]. Natal, 2011 [citado 18 nov. 2019]. Disponível em: <<http://www.tjrn.jus.br/index.php/judicial/conciliacao2>>.

13 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (BR). **Portaria Conjunta n.º 18/2019-TJ, de 13 de maio de 2019**. Cria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em matéria de Saúde, denominado “CEJUSC SAÚDE -NATAL”, conforme o disposto na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, publicada em 29 de novembro de 2010 e Resolução 015 -TJ, publicada em 24 de abril de 2019. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte [Internet]. Natal, 10 out 2019 [citado 28 nov. 2019]. Disponível em: <<https://corregedoria.tjrn.jus.br/index.php/normas/atos-normativos/portaria-conjunta/portarias-conjuntas->>.

14 - Rio Grande do Norte. Tribunal de Justiça. **Portaria n.º 1.214/2016-TJ, de 21 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a formação e o funcionamento da Câmara Técnica voltada para auxiliar a instrução e o julgamento de demandas relacionadas com a saúde. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte [Internet]. Natal, 28 set 2016 [citado 25 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/126769717/djrn-administrativo-28-09-2016-pg-92?ref=topic_feed>.

15 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (BR). **SUS Mediado** [Internet]. Natal: Defensoria Pública; 2018 [citado 27 jan. 2019]. Disponível em: <<https://www.defensoria.rn.def.br/programa/sus->>.

16 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. **SUS Mediado registra 55,8% de resolutividade em 2019** [Internet]. Natal, 23 jan. 2020 [citado 30 jan. 2019]. Disponível em: <<https://www.defensoria.rn.def.br/noticia/sus-mediado-registra-558-de-resolutividade-em-2019>>.

17 - Instituto Innovare. **17º prêmio Innovare** [Internet]. Rio de Janeiro: Instituto Innovare; 2020 [citado 29 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.premioinnovare.com.br/>>.

18 - Queiroz CC, Gadelha CML, Bezerra JKS, Gaudêncio FC, Alves MVS. **O SUS mediado** [Internet]. Rio de Janeiro: Instituto Innovare; 2012 [citado 29 jan. 2019]. Disponível em: <<https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/o-sus-mediado>>.

19 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. **SUS Mediado evitou judicialização de 51% dos atendimentos no 1º semestre de 2019** [Internet]. Natal, 23 jul. 2019 [citado 29 jan. 2020]. Disponível em: <<https://defensoria.rn.def.br/noticia/sus-mediado-evitoujudicializacao-de-51-dos-atendimentos-no-1o->>.

20 - Tribuna do Norte. **Defensoria mediou 44% das demandas de saúde contra o Estado** [Internet]. Natal, 07 fev 2018 [citado 29 jan. 2020]. Disponível em: <<http://www.tribunado-norte.com.br/noticia/>>.



Judicialização: desafio em Nossa Senhora do Socorro no Estado de Sergipe

Adriana de Lima Costa¹

Anna Katarina Lima Pinheiro de Galiza²

Antônio Williams Vieira Vaz³

Carla Beatriz da Silva Rodrigues⁴

Maria Carolina F. de Lima⁵

Marlene de Fátima Sandri Oliveira⁶

Michelle Pimentel da Silva Dutra⁷

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Mara Campos Alves

O município escolhido como objeto deste trabalho de pesquisa foi Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, localizada na região metropolitana de Aracaju. As razões para a escolha se deram pelo fato de ser um município com uma população de até 200 mil habitantes, com facilidade para acesso à coleta de dados e a existência de vários casos de judicialização, elementos, portanto, essenciais para realização de todas as etapas da investigação.

¹ Graduada em Direito pela UMC, pós-graduada em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura. Assistente Jurídica da SMS de São Paulo.

² Graduada em Enfermagem pela FASER, pós-graduada em Saúde Coletiva e em Regulação em Saúde na Faculdade Sírio Libanês. Assessora Técnica do COSEMS-PB.

³ Graduado em Fisioterapia pela UNIFOR, pós-graduado em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela UFRN. Secretário Municipal da Saúde de Boa Viagem-CE.

⁴ Graduada em Direito pela FANESE. Membro do setor que executa as decisões judiciais da SMS de Nossa Senhora do Socorro-SE.

⁵ Graduada em Direito pelo Instituto Camillo Filho. Assessora Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.

⁶ Graduada em Pedagogia pela Universidade do Tocantins, pós-graduada em Gestão Pública pela UFT. Secretária Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

⁷ Graduada em Administração pela Faculdade do Vale do Juruena. Membro do setor de Controle e Avaliação na SMS de Juína-MT.

Além disso, os seus complexos problemas de ordem econômica, social e urbana interferem no volume de demandas judiciais.

A metodologia aplicada ao projeto de intervenção em relação aos objetivos foi do tipo descritiva, e em relação ao procedimento, a pesquisa foi documental. Para Gil (1):

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis.... e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como questionários, e a observação sistemática.

A pesquisa documental objetivou conhecer a judicialização do município. Realizada a partir da coleta de dados diretamente dos processos judiciais no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio de chave de acesso e dos relatórios da Procuradoria do Município de Nossa Senhora do Socorro. Foram pesquisadas as decisões de primeira instância, além da análise de todos os processos que constavam no *DataJuri*, observando: número do processo, partes envolvidas, pedido de liminar, sentença, bem como os relatórios da Procuradoria do Município de Nossa Senhora do Socorro, possibilitando verificar quais processos que eram em desfavor do município e do estado.

A Procuradoria de Nossa Senhora do Socorro, responsável pelos processos de judicialização conta com 12 procuradores, além da advogada da Secretaria Municipal de Saúde que acompanha todas as ações judiciais na área da saúde, dando subsídio e assessoramento ao Secretário Municipal de Saúde no jurídico, tendo acesso a todas as informações e sendo ponte para a Procuradoria Municipal.

Os procuradores utilizam um sistema denominado *DataJuri*, exclusivo da Procuradoria Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Cada município no Estado de Sergipe utiliza um sistema diferente. O sistema funciona desde 2016 e é alimentado com informações processuais. Assim, os procuradores podem consultar as informações dos processos que atuaram individualmente ou com outros procuradores.

Para esta pesquisa, foi autorizado o uso do sistema *DataJuri*, para a extração de alguns dados, extraindo-se informações dos processos movimentados em 2018, como:

o nome dos usuários que entraram judicialmente contra o município, o tipo de ação, além de informações sobre o andamento processual no sistema que ofereceu as opções ativo e encerrado. A busca foi realizada com o auxílio de um dos funcionários da procuradoria devido à quantidade de demandas judiciais referentes à saúde, no ano de 2018. Com esses dados, foi possível quantificar as ações ajuizadas no período e avaliar quais solicitações foram mais recorrentes no ano de referência.

Foram pesquisados exclusivamente processos judiciais ajuizados no ano de 2018 e com decisões de 1º grau e/ou liminar, constantes no sistema descrito. Foram coletadas informações sobre o quantitativo de demandas referentes a medicamentos, exames, cirurgias e insumos.

Ao final, os dados foram sistematizados e tabulados em planilha criada no word com o fim de compreender melhor o fenômeno da judicialização da saúde que ocorre no município de Nossa Senhora do Socorro para, ao fim, propor soluções para mitigar esse fenômeno.

Diagnóstico da judicialização no município

Quando se observa o fenômeno da judicialização da saúde pública no município de Socorro, este não difere daqueles apresentados em outras cidades brasileiras, em que há um predomínio do aumento das ações judiciais.

São inúmeros os desafios no enfrentamento desse fenômeno, especialmente na organização e tratamento desses dados, tendo em vista que quanto maior a garantia dos direitos concedidos pela judicialização há uma desestabilização financeira, pois o recurso disponibilizado para as ações e serviços de saúde, na maioria das vezes, são planejadas com a fatia mínima obrigatória aos municípios, ou seja, 15%.

Foi observado que existe uma falta de padrão de organização de dados e de sistemas de acesso público, a produção científica nesse assunto fica a cargo da Universidade Federal de Sergipe, mas as pesquisas publicadas não constroem panoramas gerais, e não foi observado qualquer tipo de interação entre a academia e a gestão para orientar

pesquisas sobre o tema da judicialização que pudessem atender especificamente às necessidades do município de Socorro.

É importante salientar que o repositório de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) não apresenta a classificação orientada pelo CNJ, desfavorecendo a pesquisa de informações no site.

No ano de 2018, segundo dados do *DataJuri*, a Procuradoria Municipal movimentou 222 demandas judiciais específicas da saúde.

Alguns problemas foram detectados. A pesquisa foi prejudicada pelo fato do sistema *DataJuri*, ser de acompanhamento de advogados e isso fez com que algumas informações não fossem coletadas porque a inserção dos dados é, muitas vezes, simplificada. Verificou-se que o sistema não disponibiliza o acompanhamento processual, são os procuradores que lançam as informações e não é interligado com o Tribunal de Justiça. As opções de cadastramento das ações são limitadas e em alguns casos tais lançamentos com os nomes das ações foram incluídos de forma diferente da descrição do processo, essa amplitude impossibilita que algumas informações para a pesquisas tenham sido atendidas, por exemplo, a existência ou não de litisconsórcio.

Os repositórios do Tribunal de Justiça não contêm a totalidade das decisões judiciais e a Secretaria de Saúde não dispõe de cópia dos processos em inteiro teor, apenas cópias das sentenças e dados pessoais dos pacientes, para cumprimento da decisão.

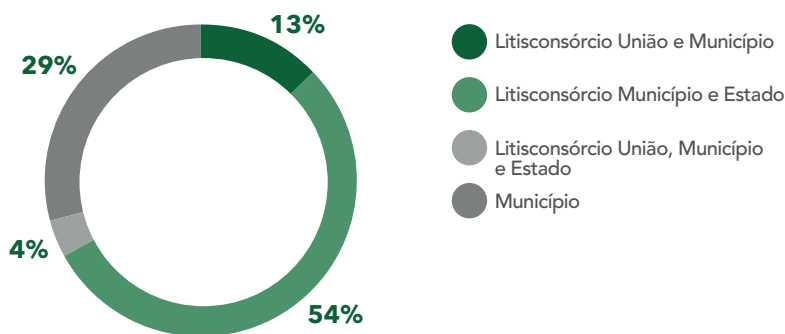
Diante dessas limitações e a partir do relatório do sistema *DataJuri*, emitido para pesquisa, foi feita uma análise individualizada dos números, fazendo comparações, classificações e calculando médias e porcentagens. As demandas judiciais que envolvem saúde pública ajuizadas em desfavor do Município de Socorro alcançaram, no ano de 2018, o número total de 222 ações.

O sistema emitiu uma relação com as seguintes classificações: a) tipo de processo, se é ou não judicial, já que o *DataJuri*, também acompanha as demandas extrajudiciais; b) número do processo, que se refere ao número emitido automaticamente pelo sistema dos tribunais; c) cliente, que nesse caso especificamente é sempre o município; d) parte adversa, que diz respeito aos usuários que demandam judicialmente o município; e)

tipo de ação, que é a opção de cadastramento do sistema para identificar a ação; f) status, que é utilizado para verificar se o processo está ativo, quando ainda não transitou em julgado ou encerrado, sendo outra ferramenta do sistema para classificação dos processos da saúde. É o sistema que emite os relatórios com as informações que foram utilizadas na presente pesquisa.

O sistema não possibilita a identificação de litisconsórcio. No entanto, por meio do número total de processos foi possível atestar que dos 222 existentes, 28 deles estão em litisconsórcio com a União, visto que o número de identificação processual utilizado pela Justiça Federal é diferente daquele utilizado pelo TJSE. A Figura 1 permite verificar também que – dos 194 processos restantes – o Estado de Sergipe consta no polo passivo em 120 deles, em litisconsórcio com o município. Dos 74 restantes, os três entes são provocados simultaneamente em 10 ações.

FIGURA 1. Litisconsórcio nos processos judiciais de saúde pública no município de Nossa Senhora do Socorro-SE, no ano de 2018.



Fonte: Autores da pesquisa com base nos dados obtidos na Prefeitura.

Na análise do relatório emitido pelo *DataJuri*, constatou-se que existem 10 tipos de pedidos cadastrados no sistema, no ano de 2018, a saber: a) medicamentos; b) exames; c) cirurgias; d) consultas; e) fornecimento de insumos; f) tratamento médico hospitalar; g) saúde pública, que são as demandas ajuizadas pelo Ministério Público por meio das Ações Cíveis Públicas em Saúde (ACPS); h) saúde mental, que abrange o tratamento

de pacientes com problemas mentais e sua interdição; i) internação compulsória; e j) serviço de saúde.

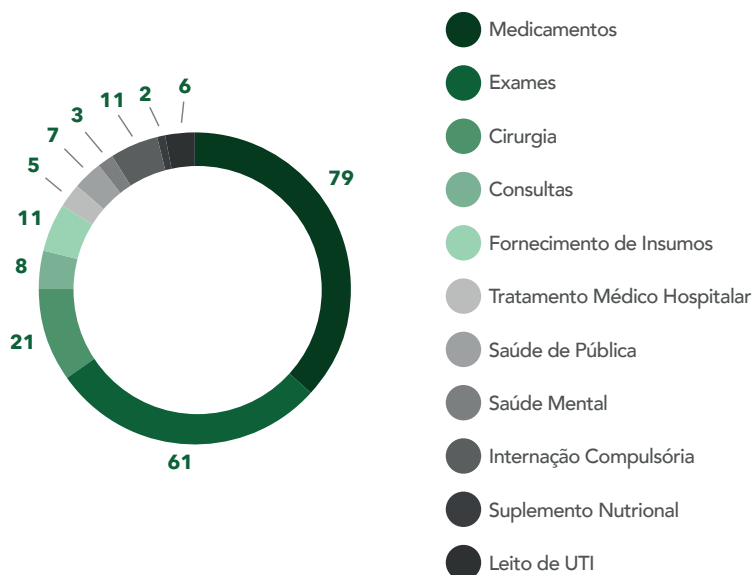
Por ser o *DataJuri*, um sistema alimentado pelos próprios procuradores, sem nenhuma espécie de padronização, existe um número bastante diversificado de classificações que constam no índice, e que às vezes repetem ou se sobrepõem a outras classificações.

Esse fato foi observado especificamente na categoria “serviços de saúde”, em que o sistema apontou 90 processos cadastrados, contudo, uma análise mais detalhada demonstrou que esse pedido é uma espécie de gênero que incorpora diversas solicitações, que são: medicamentos; exames; cirurgias; leito de UTI, internação compulsória e insumos. Dessa forma, por essa especificidade em termos de pesquisa, ele foi esmiuçado e incorporado na classificação a seguir, para demonstrar um diagnóstico mais real da judicialização em Socorro, no ano de 2018.

Os principais pedidos (Figura 2) foram: a) fornecimento de medicamentos -79; b) exames - 61; c); cirurgias - 21; d) consultas - 8; e) fornecimento de insumos - 11; f) tratamento médico hospitalar- 5; g) saúde pública - 7; h) saúde mental - 3; i) internações compulsórias - 11; j) suplemento nutricional - 2; l) leito de UTI - 6.

A classificação outros foi desenvolvida porque existem cerca de 7 pedidos que têm menos demandas. Foram considerados outros: a cessão, que na verdade é uma solicitação de tratamento hospitalar e demandas que correm em segredo de Justiça e não foram cadastrados com nenhum nome no Sistema.

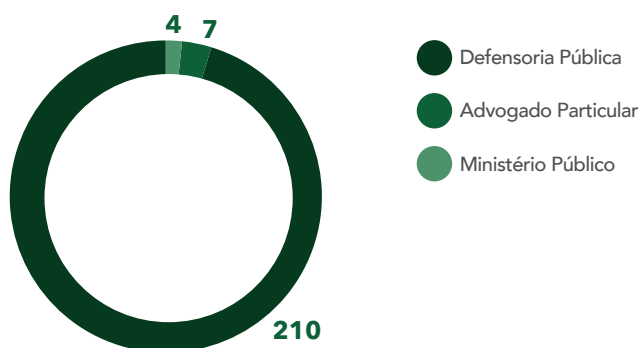
FIGURA 2. Principais pedidos de ações e serviços de saúde ajuizados em desfavor do município de Nossa Senhora do Socorro-SE, no ano de 2018.



Fonte: Autores da pesquisa com base nos dados obtidos na Prefeitura.

Na análise dos 222 processos no ano de 2018, o principal demandante (Figura 3) foi a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, com cerca de 210 (94%) ações por ela patrocinada, seguido do Ministério Público, que conta com cerca de 7 processos (3,1%), e por fim os advogados particulares, que contam com 4 processos (1,8%).

FIGURA 3. Principais representantes dos demandantes nas ações judiciais de saúde, ajuizadas em desfavor do município de Nossa Senhora do Socorro-SE, no ano de 2018.



Fonte: Autores da pesquisa com base nos dados obtidos na Prefeitura.

O número elevado de ações ajuizadas pela Defensoria Pública se justifica pelas condições econômicas da população do município de Socorro, que não possuem recursos suficientes para demandar com advogado particular e que procuram os órgãos públicos para que suas solicitações sejam atendidas.

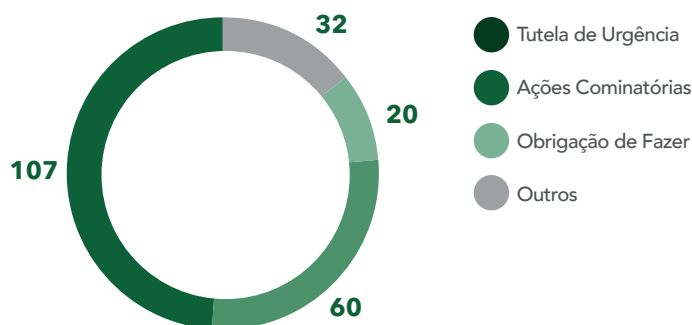
Sobre as ações ajuizadas pelo Ministério Público do estado, importante ressaltar que 100% se referem a ações civis públicas, não sendo observado ações individuais demandadas por esse ator institucional.

A Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual têm exercido um papel relevante como representantes dos usuários em ações judiciais, mas também recorrendo a resoluções administrativas para solucionar os conflitos por meio da Câmara de Resolução de Conflitos, contatando os gestores antes de instaurar qualquer processo.

O *DataJuri*, possui opção de cadastramento de uma diversidade de tipos de ações (Figura 4). Dentre as possibilidades de cadastramento estão as liminares. Constatou-se em análise do *DataJuri*, que as ações com liminares, que são as demandas com tutelas de urgência, são as mais recorrentes no cadastramento de ações. Ao todo, dos 222 processos examinados, 107 continham tutelas de urgência e se referiam a ações con-

denatórias, sendo o processo cadastrado no sistema como condenatória com tutela de urgência⁸.

FIGURA 4. Tipos de pedidos nas ações judiciais de saúde, ajuizadas em desfavor do município de Nossa Senhora do Socorro-SE, no ano de 2018.



Fonte: Autores da pesquisa com base nos dados obtidos na Prefeitura.

O segundo maior número cadastrado de ações foi de Ações Cominatórias⁹ que contam com 60 processos e correspondem a uma espécie de ação do processo civil que implica em uma cominação. Os dois principais tipos de ações impõem ônus ao município, além de exigência de movimentos contingenciais e emergenciais, implicando assim demandas orçamentárias não planejadas.

Outro tipo também presente são as Ações com Obrigações de Fazer¹⁰ que contam com 20 processos com pedidos que requerem que o polo passivo faça determinada ação. Os 32 processos restantes, que não possuíram tantas aparições assim, receberam a seguinte classificação: a) tratamento de saúde – 7; b) procedimento comum – 4; c) internação compulsória – 5; d) ordinária - 5.

Logo depois estão as Ações Civis Públicas (ACPs) que são ajuizadas pelo Ministério

⁸ É a medida processual que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo.

⁹ É a que obriga ou força ao cumprimento de uma obrigação positiva ou negativa. Corresponde às obrigações de fazer (alguma coisa) ou tomar alguma providência, ou de não fazer (abster-se de alguma ação ou atitude).

¹⁰ A obrigação de fazer consiste no comprometimento do devedor em realizar, praticar algum ato que resulte num benefício ao credor.

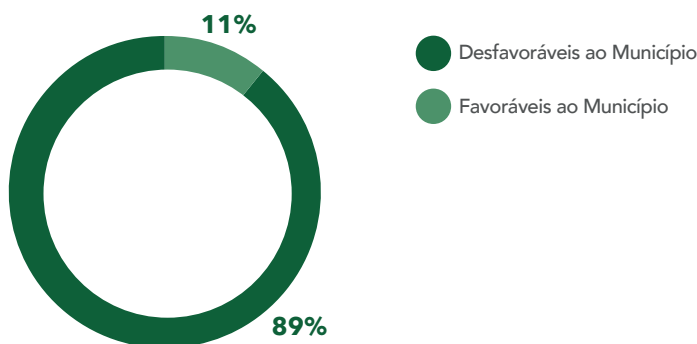
Público para salvaguarda de direito difuso e direito coletivo. O sistema identificou 7 ACPs cadastradas cujos processos referem-se a omissões do ente público da administração direta. Constatou-se no *DataJuri*, a predominância das ações individuais.

Durante o ano de 2018, dos 222 processos, 133 tiveram sua classificação no sistema *DataJuri*, como encerrados, o que significa que já houve uma sentença, de mérito ou não, encerrando o processo.

O número de sentenças (Figura 5) que extinguiram o processo com julgamento de mérito foram 100, significando 33% do total. Dos julgamentos de mérito, 89 foram favoráveis aos demandantes e 11 favoráveis ao município. Dos 33 processos extintos sem resolução de mérito, destacam-se a inércia das partes, ilegitimidade ativa ou passiva e incompetência do juízo como alguns dos motivos da extinção.

Os outros 89 processos permanecem ativos no sistema, seja aguardando audiência e/ou sentença.

FIGURA 5. Percentual de sentenças favoráveis ao município de Nossa Senhora do Socorro-SE, no ano de 2018.



Fonte: Autores da pesquisa com base nos dados obtidos na Prefeitura.

Constatou-se que grande parte dos processos, especificamente 107, continham cautelares e o que normalmente ocorre é que o ente público cumpre a tutela de urgência imposta em decisão preliminar e o processo acaba perdendo a razão de existir, já que o pedido foi cumprido antes mesmo da sentença. Quando a sentença é prolatada ela

confirma a decisão liminar e como a obrigação já foi cumprida, os processos são extintos. Como comentado, a questão de o *DataJuri*, não ser interligado com o Tribunal de Justiça e a inclusão de processos ser feita manualmente, faz com que ocorra uma espécie de retardamento das informações dos processos, só possibilitando verificar o andamento processual pesquisando, individualmente, cada número de processo no repositório do tribunal.

Fato importante observado é que das sentenças dos processos analisados, inseridos no *DataJuri*, não há qualquer menção à CONITEC. As decisões não têm seguido a medicina baseada em evidências e os juízes não mencionam o NAT/JUD.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

No Brasil, a política de saúde consiste no acesso da população aos bens e serviços de saúde, sendo uma condição essencial para o bem-estar e qualidade de vida, norteadas art. 196 da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado; ou seja, saúde é um direito social, de segunda geração, que pertence ao cidadão (2).

Tendo a saúde a dimensão de um direito social, inúmeros atores do Estado (gestores de saúde, Ministério Público e Poder Judiciário) se dedicam a promover e garantir o exercício desse direito.

Contudo, a efetivação social do direito à saúde por esses atores estatais, principalmente pelo Poder Judiciário, responsável pelo exercício da jurisdição, constitui grave desafio jurídico-prático na hermenêutica estruturante do direito sanitário. A inexistência (insuficiência) do adequado conhecimento técnico dos contornos científicos da saúde, enquanto ciência e ao mesmo tempo política pública programática, possui impacto direto no Sistema e na própria equidade do acesso às ações e serviços de saúde (3).

Elevar a saúde ao *status* de direito social desencadeou um fenômeno marcadamente relacionado ao Judiciário e alguns fatores foram determinantes para o desenvolvi-

mento e expansão do fenômeno: desigualdade social; falta de infraestrutura; e baixo investimento na área da saúde. Restando assim, ao cidadão, buscar o Poder Judiciário, a fim de reclamar o seu direito à saúde.

Especificamente sobre o fenômeno da judicialização da saúde, variados processos estratégicos têm sido criados com o intuito de garantir uma interlocução entre os diversos atores para auxiliar os magistrados nas decisões de saúde, tais como os Núcleos de Apoio Técnico-NAT; o Fórum Nacional de Saúde; os Fóruns Estaduais de Saúde etc.

Segundo Fonseca (4), os Núcleos de Assistência Técnica (NAT) são organizações com finalidade de promover consultorias e assessorias a determinadas entidades de diferente natureza na execução de determinadas atividades, no âmbito da saúde pública. São as mesmas que auxiliam o Poder Judiciário no julgamento de ações voltadas para a saúde pública.

Neste contexto, cabe citar a definição exposta por Mérici (5), para Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado de Sergipe em relação ao Núcleo de Assistência Técnica

O NAT/JUD tem natureza consultiva vinculada ao TJ, cuja finalidade consiste em assessorar o Poder Judiciário Estadual, dando subsídios técnicos aos magistrados nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, insumos, órteses, próteses, internações, procedimentos cirúrgicos ou ambulatoriais, exames diagnósticos e tratamentos médicos em face ao SUS.

Cabe ainda salientar que

O NAT possui estrutura criada para subsidiar os magistrados, sendo um núcleo de assessoramento técnico ao Judiciário. É um serviço muito importante para que o juiz possa ter um suporte de equipe multidisciplinar (formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas) antes de conceder (ou não) o pedido do usuário que ingressa com ação judicial (6).

Assim, no Município de Nossa Senhora do Socorro, as demandas são atendidas pela Secretaria de Municipal da Saúde, objetivando uma maior efetivação dos direitos à saúde e viabilidade dos processos judiciais. O município não é Comarca da Justiça Federal tampouco da Justiça Estadual de Sergipe.

O NAT foi implantado no estado de Sergipe em 2017, por meio da Resolução n.º 13/2017 (7). O município de Nossa Senhora do Socorro se beneficia das decisões que ocorrem na esfera estadual, porque as ações em desfavor do município acabam por ser analisadas pelo NAT/JUD.

A solicitação de parecer técnico ao NAT/JUD é feita pelo sistema de controle eletrônico do Tribunal de Justiça, sendo necessário que o magistrado realize essa solicitação com o fim de dirimir qualquer dúvida ou tornar uma decisão mais técnica. Ao solicitar esse parecer, é gerado, no processo, a informação que esse pedido foi feito e as partes do processo têm acesso a essa informação.

O ajuizamento das demandas em desfavor do Município de Nossa Senhora do Socorro é realizado por meio do sistema informatizado do tribunal. Ao ser distribuída, a ação é direcionada pelo sistema para as comarcas do TJSE no município, pelos critérios de competência territorial.

Da análise dos dados, foi observado que os magistrados não fizeram uso do apoio técnico do NAT/JUD para a emissão das sentenças. Do mesmo modo, constatou-se um elevado número de ações com cautelares, nas quais os juízes proferiram decisões desfavoráveis ao município, em sede de liminar, sem um julgamento mais técnico, que poderia ter sido realizado com o apoio do grupo do NAT/JUD.

Contudo, o que se tem observado na literatura é que o apoio do NAT possibilita uma melhor organização, padronização, otimização e qualificação das decisões proferidas nos processos. O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ou Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário, como ferramenta de suporte aos juízes, têm o condão de viabilizar o direito à saúde e a possibilidade de racionalização das demandas de saúde pública em busca do equilíbrio entre a efetivação desse direito com as reais capacidades do município (8).

A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), é um órgão da Defensoria Pública do Estado de Sergipe destinado a atender, entre outras competências, os desassistidos que demandem a prestação de produtos e de serviços do SUS tendo por objetivo o acesso destes pela própria rede do SUS com a devida redução/eliminação dos custos financeiro e temporal que envolvem uma demanda judicial, de acordo com

a Resolução n.º 10/2018 (9).

Foi instituída em 2018, e desde então, a Defensoria Pública do Estado encaminha todas as demandas que são apresentadas ao órgão que envolve o município para resolução administrativa. Como não existe um núcleo de Defensoria Pública em Nossa Senhora do Socorro, a comunicação entre o ente público e o núcleo é realizada por e-mails, telefonemas e a presença de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde duas vezes por semana na sede do núcleo.

A Câmara de Resolução de Litígios da Saúde é composta por equipe técnica do órgão que trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro, tendo como diretor o Defensor Público do Estado. Quando um desassistido busca auxílio da defensoria, esta atua inicialmente solicitando documentos de identificação do paciente e laudo médico contendo a enfermidade, o CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde), a solicitação do procedimento médico (exame, medicamento, cirurgia, suplementos, órteses, próteses, entre outros produtos ou serviços de saúde) a justificativa da necessidade deste e a urgência do procedimento, indicando expressamente as consequências que acarretarão ao paciente, caso o procedimento não seja fornecido com a maior brevidade possível.

Para que a população de Socorro possa recorrer aos serviços ofertados pela Defensoria Pública, o usuário/paciente necessita se deslocar para a Capital, Aracaju. Registre-se, porém, que a despeito do inconveniente no deslocamento, a pesquisa verificou que o maior percentual de representação dos autores que demandam o município por ações e serviços de saúde, foi da Defensoria Pública.

A Câmara de Resolução de Litígios da Saúde atua na perspectiva de garantir o direito constitucional de acesso à saúde para a população, não somente como um conjunto de instituições para processos preparativos de saúde humana. Essa promoção é realizada por meio da perspectiva da mediação e conciliação administrativa, impedindo que as demandas cheguem ao Poder Judiciário, com caráter de prevenir e promover com o objetivo final de garantir a qualidade de saúde de cada indivíduo que se utiliza da

justiça para efetivar seus direitos.

A Mediação trabalha na perspectiva da tríade Direito, Saúde e Cidadania, por acreditar que é possível a convergência do diálogo entre eles (Sistema de Saúde x Sistema Judicial). Parte do pressuposto de que a atuação solitária de quaisquer desses atores, que integram esse fundamental Sistema de Saúde, não contribui para a necessária efetivação do Direito à Saúde. Nesse sentido, não é razoável a atuação judicial divorciada dos pressupostos técnicos, assim como não é possível que a técnica esteja em dissintonia com a social (3).

Neste contexto, a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde tem sua atuação pautada em discutir ações voltadas para a coletividade para resolução de problemas em âmbito regional, assim, a partir da sua atuação, envolver todos os entes do sistema jurídico, saúde e população, com a finalidade de reduzir a tensão e o confronto entre eles, para construção de políticas públicas de saúde que sejam universais, integrais e igualitárias.

É necessário utilizar medidas que proporcionem a efetivação do direito à saúde respeitando o mínimo existencial e a reserva do possível, buscando o equilíbrio entre a via judicial e as políticas públicas.

Considerando a realidade da saúde pública atual no Município de Nossa Senhora do Socorro, percebe-se a importância de oferecer instrumentos que viabilizem uma boa gestão pública referente à promoção de políticas públicas. Essa gestão das políticas públicas deve ter a participação do Poder Judiciário, com o fim de garantir que os procedimentos de saúde sejam acessíveis para a população. Sendo assim, faz-se necessário uma aproximação entre a Assessoria Jurídica Municipal e os magistrados, demonstrando a importância desse diálogo, que juntos podem otimizar e agilizar os processos, racionalizar recursos e demonstrar que o NAT/JUD se faz uma ferramenta confiável e sem novos investimentos financeiros do Poder Judiciário, pois já está disponível em nível estadual.

Por meio do NAT/JUD, as decisões a serem tomadas pelos magistrados nas ações judicializadas poderão ser, de certa forma, uniformizadas/padronizadas, pois sempre levará em conta as informações técnicas de equipe especializada, apensadas ao processo, servindo de ferramenta simples para todas as decisões que serão proferidas.

Em âmbito municipal, objetivando minimizar os impactos da judicialização, uma importante estratégia seria a criação de um Comitê de Mediação Sanitária, capaz de reduzir as tensões e os conflitos, com respaldo técnico e jurídico, favorecendo o diálogo com defensores públicos, CRLS, juízes, e a população municipal, agilizando as tomadas de decisões na Comarca do município.

A implantação destas organizações no município estaria respaldada na Recomendação N.º 31, de 30 de março de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde, considerando o elevado número de litígios referentes ao direito à saúde, bem como o forte impacto dos dispêndios sobre os orçamentos públicos, na determinação de tratamentos de alto custo, quando o sistema possui alternativas já experimentadas e exitosas (3).

A utilização de um diálogo mediado e o fortalecimento do NAT/JUD proporcionaria ao Município de Nossa Senhora do Socorro um melhor tratamento ao tema da saúde pública, e as demandas dos munícipes, apoiadas não apenas na decisão técnica, mas principalmente no estabelecimento do diálogo entre todos os atores envolvidos nas demandas de saúde.

Considerações Finais

Conclui-se, após as análises possíveis dos dados coletados, que as decisões judiciais não passam por análises técnicas de profissionais da área, vez que tanto a Defensoria Pública, quanto a CRLS e os magistrados não utilizam o NAT/JUD para consultas e, conseqüentemente, tomar decisões de forma uniformizada.

Durante o ano de 2018, o município teve 222 demandas e o sistema utilizado não permitiu identificar litisconsórcio. Cerca de 60% continham tutelas de urgência e desse percentual de solicitações, as que mais ocorreram pleiteavam por medicamentos, exames e cirurgias. A Defensoria Pública é a principal representante dos usuários nos processos judicializados, alcançando quase 90% das representações em juízo.

Observou-se que, em virtude de 48% das ações judicializadas serem concedidas por meio de tutela de urgência, acaba ocorrendo um comprometimento da gestão administrativa e financeira e de certa forma, inviabilizando ou atrasando a oferta de outros serviços de saúde da Programação Anual de Saúde, promovendo o desequilíbrio econômico, visto que o financiamento não é uma fonte inesgotável.

Concluiu-se que a criação de um Comitê de Mediação Sanitária – que permita a ação integrada de representantes dos inúmeros atores envolvidos no fenômeno da judicialização da saúde. Em outras palavras, é a utilização da mediação como ferramenta para resolução administrativa das demandas dos usuários de saúde. Uma mediação calcada principalmente no protagonismo do gestor municipal, responsável pela organização e desenvolvimento das ações e serviços de saúde locais.

É necessário que os poderes atuem em conjunto e promovam diálogos que possam resultar em ações concretas de políticas públicas, especialmente as relacionadas ao direito à saúde.

Nesse sentido, o ideal é buscar um equilíbrio na judicialização, ou seja, contê-la com a diminuição da quantidade e do custo das demandas judiciais, mas sem prejudicar o exercício do direito à saúde por parte dos cidadãos.

A sugestão apresentada é possível, embora demande um trabalho conjunto de todos os atores envolvidos no processo: pacientes, profissionais de saúde, magistrados, membros do Ministério Público, advogados e sociedade em geral. Tudo isso, no entanto, deve caminhar lado a lado com a exigência de melhorias gradativas no SUS, em busca de um sistema público de saúde de qualidade, a fim de que, no futuro, a judicialização dessa prerrogativa não seja mais necessária.

Referências

- 1 - Gil AC. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas; 2008.
- 2 - Brasil. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. [Internet]. [Citado 21 mar 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>
- 3 - Assis G. Mediação sanitária: direito, saúde e cidadania. In: **CONASS: para entender a gestão do SUS**. [Internet]. [S. l.]: CONASS, 2015. [Citado 7 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/CONASS-DIREITO_A_SAUDE-ART_14B.pdf>.
- 4 - Fonseca JJS. **Fundamentos de saúde coletiva**. São Paulo: UECE; 2015.
- 5 - Mérici A. **Saúde e Tribunal de Justiça instituem o Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário**. [Internet]. Aracaju: Secretaria de Estado da Saúde; 1 dez 2016. [Citado 24 maio 2019]. Disponível em: <<https://www.saude.se.gov.br/?p=7247>>.
- 6 - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (BR). **Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS)** [Internet]. Palmas: TJTO; 2020. [Citado 24 mar 2020]. Disponível em: <<http://wwa.tjto.jus.br/saude/index.php/nat-nucleo-de->>.
- 7 - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (BR). **Resolução n.º 13, de 21 de junho de 2017**. Alterar o artigo 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 12 do Regimento Interno do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário para demandas de saúde – NAT/JUD, homologado pela Resolução n.º 31/2016. [Internet]. [Citado 24 mar 2020]. Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/tjnet/publicacoes/visualizar_publicacao.wsp?tmp.2>.
- 8 - Farias MA. **Judicialização da Saúde**. Rio de Janeiro: Lumen Juris; 2017.
- 9 - Defensoria Pública do Estado de Sergipe (BR). **Câmara de Resolução de Litígios da Saúde – CRLS**. Resolução n.º 10/2018. Dispõe sobre a Criação da Resolução de Litígios da Saúde [Internet]. Alagoas: DPE-SE; 12 dez 2018. [Citado 24 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.defensoria.se.def.br/?p=21249>>.



A judicialização na saúde no Município de Nossa Senhora do Socorro-SE proposta intervencionista

Carilane Laranjeira Tomiello¹

Clésio Alves da Silva²

Márcia Lúcia de Souza Lima³

Mara Eny Azevedo Amaral Braga⁴

Márcia Lúcia de Souza Lima⁵

Murilo Silveira Soares dos Santos⁶

Thais Gaspar dos Reis Ferreira⁷

Orientadora: Profa. Dra. Leticia Cabrini Girotto

A metodologia para a elaboração deste projeto de intervenção utilizou a pesquisa documental, em buscas de dados judiciais juntamente ao Tribunal de Justiça de Sergipe e suas respectivas comarcas, Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro - SE e os Sistemas de Informações do Ministério da Saúde. Também con-

¹ Graduada em Direito. Assessora da Procuradoria do Município de Nossa Senhora do Socorro-SE.

² Graduado em Enfermagem pela Universidade Brasil no Estado do Tocantins, pós-graduado em Auditoria em Saúde pelo INCAR, Especialista em Gestão em Saúde, pela Fiocruz. Secretário Municipal de Saúde do Município de Brasília do Tocantins-TO e membro da Diretoria do COSEMS-TO.

³ Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela UVA e Pós-graduada em Saúde da Família pelo Centro Universitário de Patos/PB e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela Fiocruz. Secretária Municipal de Saúde de Várzea-PB.

⁴ Graduada em Comunicação Social e bacharelada em Direito pela UCPel. Servidora da Prefeitura de Pelotas-RS.

⁵ Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela UVA e Pós-graduada em Saúde da Família pelo Centro Universitário de Patos-PB e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela Fiocruz. Secretária Municipal de Saúde de Várzea-PB.

⁶ Graduado em Direito pela UNIUBE e pós graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus. Gestor de Saúde no Município de Igarapava-SP e membro da Diretoria do COSEMS-SP.

⁷ Graduada em Enfermagem pela UCSAL. Assessora técnica do COSEMS-BA.

templa pesquisa descritivo-analítica, utilizando dados de fontes primárias e secundárias, com levantamento documental.

Caracterizou-se como estudo de caso do município de Nossa Senhora do Socorro, utilizando dados quantitativos e qualitativos, buscando integrar enfoques metodológicos diversos, e os diferentes olhares dos atores envolvidos.

O estudo foi realizado no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, referente às demandas judiciais do ano de 2018. Considerando as demandas relacionadas aos medicamentos, internações, cirurgias, órteses e próteses e exames considerados de alta complexidade.

As informações para tabulação dos dados contemplaram: perfil dos usuários que solicitam por meio de judicialização dados de identificação, sexo, idade, escolaridade, local de trabalho e vínculo empregatício; catalogação por demanda: exames, cirurgias, internações, Tratamento Fora do Domicílio-TFD, medicamentos, entre outras; respostas expedidas pela secretaria de saúde para tais demandas; características elencadas no Plano Municipal de Saúde do Município identificando as ações para enfrentamento dos problemas referentes à judicialização. Essa catalogação foi feita por meio de planilha do Excel, versão 2013.

Os dados obtidos foram analisados com o intuito de identificar as principais demandas em quantidades e propor ações para a organização e o acesso de dados judiciais, realizando o processamento dos dados, com os objetivos de discutir e propor possíveis ações que podem ser adotadas com a finalidade de aprimorar a qualidade e eficiência da assistência de saúde prestada aos usuários, a fim de evitar ações judiciais e/ou reduzir as solicitações via judicialização.

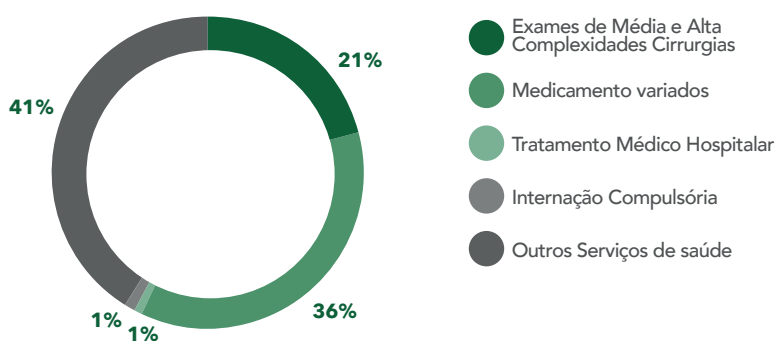
Diagnóstico da judicialização no município

Os municípios brasileiros vêm enfrentando uma significativa avalanche de ações judiciais, notadamente para o fornecimento de medicamentos, exames, tratamento médico hospitalar, internações compulsórias, bem como de insumos como fraldas, cadeira de rodas, suplemento alimentar, prótese, aparelhos auditivos, entre outros.

Com efeito, a judicialização no Município de Nossa Senhora do Socorro não está sendo diferente dos demais municípios brasileiros, tendo em vista que, somente no ano de 2018, foi evidenciado um total de 222 ações judiciais, nas justiças estadual e federal. Destas, 81 foram de medicamentos, 46 tratamentos de média e alta complexidade e tratamentos cirúrgicos, 3 tratamentos médico hospitalar, 2 internações compulsórias, outros “serviços de saúde” – insumos como fraldas descartáveis, aspirador, botton de gastronomia, cadeiras de rodas específicas, complemento nutricional, colchão de ar, entre outros – (90 processos) (1, 2).

As referidas ações intentadas em desfavor da municipalidade abarcaram diversos serviços de saúde, mas restou evidenciado, em apuração realizada na Procuradoria do Município, quais os principais pedidos, conforme demonstra a Figura 1 abaixo:

FIGURA 1. Principais pedidos de Processos Judiciais em Nossa Senhora–2018.



Fonte: <<https://www.jfse.jus.br/>>.

As ações intentadas pelos pacientes/autores contra o ente político ocorrem por meio da representação, na sua grande maioria, da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Quase 80% (oitenta por cento) das ações são ingressadas pela DPE.

Ocupam o segundo lugar as ações ingressadas por advogados privados, seguidos pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.

Cumpre anotar que as ações em desfavor da municipalidade, sempre constam pedidos de liminar, quase sempre deferidos (2):

(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar que os requeridos forneçam, de forma urgente, o exame de RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, indicado em relatório médico anexado aos autos, sendo as despesas arcadas por eles, tendo em vista a necessidade do autor, sob pena de causar-lhe prejuízo à saúde irreparável, contudo, é desprovido de recurso financeiro suficiente para arcar com a despesa particular, por se tratar de pessoa hipossuficiente. Se, eventualmente, após o lapso de 10 (dez) dias, não ocorrer o cumprimento da decisão, voltem os autos conclusos para que sejam tomadas outras providências cabíveis, sem prejuízo da sanção pecuniária a ser arbitrada. Determino a extração de cópia do relatório médico, devendo este acompanhar o mandado de citação e intimação. Defiro o benefício da justiça gratuita requerido nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intime-se o autor do teor desta decisão. Considerando os Protocolos firmados entre os requeridos e o TJSE, deixo de designar audiência conciliatória. Intimem-se. Citem-se os requeridos. Publique-se. Cumpra-se. Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2018002568333-06. fl. 3/4 em 17/10/2018 às 09:24:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Assinado eletronicamente por HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONCA, Juiz(a) de 1ª Vara Cível de Socorro, Nossa Senhora do Socorro (SE), TJ/SE- 16 de outubro de 2018. Processo n.º 201888001309 (2).

(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar que o requerido forneça, de forma urgente, os medicamentos XALATAN (LATANOPROSTA) E BRITENS (BRIMONIDINA+TIMOBOL), indicados em relatório médico anexado aos autos, sendo as despesas arcadas pelo requerido, tendo em vista a necessidade da autora, sob pena de causar-lhe prejuízo à saúde irreparável, contudo, é desprovida de recurso financeiro suficiente para arcar com a despesa particular, por se tratar de pessoa hipossuficiente. Se, eventualmente, após o lapso de 10 (dez) dias, não ocorrer o cumprimento da decisão, voltem os autos conclusos para que sejam tomadas outras providências cabíveis, sem prejuízo da sanção pecuniária a ser arbitrada. Determino a extração de cópia do relatório médico, devendo este acompanhar o mandado de citação e intimação. Defiro o benefício da justiça gratuita requerido nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intime-se a autora do teor desta decisão. Considerando o Protocolo firmado entre o requerido e o TJSE, deixo de designar audiência conciliatória. Intimem-se. Cite-se o requerido. Publique-se. Cumpra-se. Nossa

Senhora do Socorro (SE), 13 de novembro de 2018. Conferência em www.tjse.jus.br. Documento assinado eletronicamente por Eneida Lupinacci Costa, Juiz(a) de 1ª Vara Cível de Socorro, TJ/SE em 13/11/2018, às 11:54:30. Processo n.º 201888001450 (2).

(...) Ante tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, determinando ao ESTADO DE SERGIPE e ao MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, que forneçam ao reclamado o medicamento INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 150 MG, 2 AMPOLAS/MÊS, USO CONTÍNUO, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante prescrição médica, sob pena de sequestro da quantia necessária à realização do procedimento. Por fim, citem-se os reclamados para responderem em 30 dias, devendo em igual prazo, dizer se há possibilidade de acordo, apresentando, no mesmo ato, proposta de conciliação. Com o oferecimento da contestação, em não havendo interesse na conciliação, intime-se o reclamante para oferecer réplica, em 15 dias; em havendo interesse na conciliação pelo ente público, venham conclusos os autos para designação de audiência. Nossa Senhora do Socorro/SE, 29 de março de 2019. Documento assinado eletronicamente por Maria Diorlanda Castro Nobrega, Juiz(a) de 2ª Vara Cível de Socorro, TJ/SE em 29/03/2019, às 10:33:28 Processo n.º 201888101231 (2).

(..) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar que os requeridos forneçam, de forma urgente, INJEÇÕES INTRAVÍTEAS DE ANTI - VEGF – 3 APLICAÇÕES EM CADA OLHO, indicado em relatório médico anexado aos autos, sendo as despesas arcadas pelos requeridos, tendo em vista a necessidade do autor, sob pena de causar-lhe prejuízo à saúde irreparável, contudo, é desprovido de recurso financeiro suficiente para arcar com a despesa particular, por se tratar de pessoa hipossuficiente. Se, eventualmente, após o lapso de 10 (dez) dias, não ocorrer o cumprimento da decisão, voltem os autos conclusos para que sejam tomadas outras providências cabíveis, sem prejuízo da sanção pecuniária a ser arbitrada. Determino a extração de cópia do relatório médico, devendo este acompanhar o mandado de citação e intimação. Defiro o benefício da justiça gratuita requerido nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intime-se o autor do teor desta decisão. Considerando os Protocolos firmados entre os requeridos e o TJSE, deixo de designar audiência conciliatória. Intimem-se. Citem-se os requeridos. Publique-se. Cumpra-se. www.tjse.jus.br. Assinado eletronicamente por Eneida Lupinacci Costa, Juiz(a) de 1ª Vara Cível de Socorro, Nossa Senhora do Socorro (SE), TJ/SE 30 de outubro de 2018. Processo n.º 201888001281 (2).

(...) Ante tais considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que o Estado de Sergipe, através da Secretaria Estadual de Saúde, forneça o exame de e RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA à autora (...), no prazo de 05 (cinco) dias, consoante prescrição médica, sob pena de sequestro da quantia necessária à realização do procedimento. Intimem-se as partes desta decisão. Cite-se o reclamado para, querendo, apresentar no devido prazo legal contestação. Com o oferecimento da defesa, em não havendo interesse na conciliação, intime-se o reclamante para oferecer réplica, em 15 dias; em havendo interesse na conciliação, venham conclusos os autos para designação de audiência. No mais, a gratuidade judiciária será analisada posteriormente pela Turma Recursal, caso haja recurso. Nossa Senhora do Socorro/SE, 19 de novembro de 2018. md Documento assinado eletronicamente por Eneida Lupinacci Costa, Juiz(a) de 2ª Vara Cível de Socorro, em 19/11/2018, às 19:41:19 Processo n.º 201888101432 (2).

(...) III - D I S P O S I T I V O Pelos motivos de convencimento acima declinados e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido autoral, para condenar o Estado de Sergipe e o Município de Nossa Senhora do Socorro a fornecerem ao autor INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTI-VEGF-3 APLICAÇÕES EM CADA OLHO, sob pena de sequestro da quantia necessária a sua aquisição, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. Deixo de condenar os requeridos em custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de demanda processada pelo rito do Juizado da Fazenda Pública. Por fim, confirmo os efeitos da tutela de urgência concedida em 31/10/2018. Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Assinado eletronicamente por Maria Diorlanda Castro Nobrega, Juiz(a) de 1ª Vara Cível de Socorro, TJ/SE. Processo n.º 201888001281 (2).

As sentenças de mérito se fundamentam na premissa que a saúde é um direito garantido a todos os cidadãos e dever atribuído ao Estado (nas suas três esferas) pela Constituição Federal, sendo este responsável em cuidar e prover a saúde da população.

Por fim, cumpre observar que na maioria das ações contra o Município de Nossa Senhora do Socorro também consta no polo passivo o Estado de Sergipe e ambos são condenados solidariamente ao cumprimento da decisão.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Constituição Federal Brasileira (3), por meio de seu art. 5º, garante os direitos fundamentais aos cidadãos, contemplando os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em seu artigo posterior estão dispostos os direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Apesar de estar inserido na lista dos direitos sociais, o direito à saúde possui caráter fundamental por ser tão essencial quanto os direitos fundamentais, com ênfase para sua universalidade, cuja necessidade de sua eficácia deve ser imediata (3).

Com o advento da Lei n.º 8.080 de 1990 (4), é possível verificar o interesse do Estado em legislar a respeito do acesso ao direito à saúde por saber que é dever do ente público a garantia da concretização deste direito universal, essencial e imediato, conforme devidamente expresso no art. 196, da CF/1988.

A tentativa de garantir o acesso à saúde à população, por meio do Sistema Único de Saúde é reveladora no que diz respeito à carência perceptível na prestação do serviço.

O direito à saúde tem sido colocado na linha de frente do enfrentamento jurídico, mediante ajuizamento de ações pelo cidadão em face do Estado para reivindicar o direito universal.

Nesta perspectiva, o Judiciário brasileiro vem enfrentando o problema da crescente demanda de ações judiciais no âmbito da saúde, fato que compromete de forma alarmante o planejamento orçamentário dos entes governamentais, bem como a programação de políticas públicas coletivas, ocasionando sérios prejuízos ao Estado e a sociedade.

Atualmente, o Brasil está diante dos desafios contemporâneos de fortalecer um SUS democrático e com políticas democratizantes de acesso, a partir do ideário de Estado Democrático de Direito, na concretização de um acesso universal, igualitário, integral, descentralizado e participativo aos serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, de enfrentar

às tendências de cunho neoliberais e os comandos judiciais de obrigação de fazer na busca por soluções imediatas para o cumprimento de decisões em prol do cidadão que buscou, pela via do Judiciário, a concretude de um direito social.

Outro fator impactante é que a judicialização desorganiza o orçamento dos municípios, interferindo na política pública, atropelando as diretrizes e competências dentro do SUS, quebrando a isonomia e prevalecendo o direito individual em detrimento do coletivo.

Não é de hoje que se discute meios de enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde para se pensar em processos estratégicos, a fim de minimizar o impacto ocasionado ao planejamento estratégico-orçamentário de Secretarias de Saúde e, sobretudo, no prejuízo da implementação de políticas sociais coletivas.

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal realizou a Audiência Pública n.º 004, onde foi possível debater com diversos setores envolvidos na busca por soluções aos problemas da judicialização da saúde. Na ocasião, três assuntos principais foram elencados: a dispensação de medicamentos, a alocação de recursos, a função e a interligação entre os três poderes, iniciando a tese da solidariedade dos entes.

Impulsionado pela realização da audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça passou a se sensibilizar e se debruçar na análise da conjuntura estrutural dos Tribunais para o recebimento, e, sobretudo, para o julgamento de ações judiciais que envolvessem o direito à saúde.

O Ministro Gilmar Mendes, no exercício da Presidência do Conselho Nacional de Saúde (CNJ), sob a justificativa do grande número de demandas envolvendo a assistência à saúde em tramitação no Poder Judiciário brasileiro e o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos judiciais; publicou a Recomendação n.º 31, de 30/03/2010, direcionada aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais (5).

Conforme disposto na recomendação supramencionada, até dezembro de 2010, os Tribunais deveriam celebrar convênios que objetivassem disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de

um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais.

Na fundamentação da justificativa para a publicação da Recomendação n.º 31, o Ministro sustentou que ficou atestada na Audiência Pública n.º 4, realizada pelo Supremo Tribunal Federal para discutir as questões relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde, a carência de informações clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos autores dessas demandas o que justificaria o apoio técnico recomendado e que fosse considerando as reiteradas reivindicações dos gestores para que sejam ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência.

A Recomendação n.º 31, do Conselho Nacional de Justiça, orientou que os magistrados ouvissem, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência. Infelizmente, tal prática não vem sendo adotada desde então (5).

Ademais, no âmbito do Fórum Nacional, foram instituídos comitês executivos, sob a coordenação de magistrados indicados pela Presidência e/ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, para coordenar e executar as ações de natureza específica, que fossem consideradas relevantes, para os objetivos centrais do Fórum Nacional de Saúde.

Esses Comitês Estaduais de Saúde foram constituídos contendo, dentre as suas atribuições, a de auxiliar os tribunais na criação de Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituídos de profissionais da área da saúde que deveriam elaborar pareceres amparados na medicina baseada em evidências, observando-se na sua criação o disposto no parágrafo segundo do art. 156 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Foi a partir da publicação da Resolução n.º 238, de 06 de setembro de 2016, que restou instituído, no âmbito do Judiciário, a criação dos NAT-JUS, pelos quais os tribunais passaram a criar sítio eletrônico, objetivando o acesso ao banco de dados com pareceres, notas técnicas e julgados na área da saúde, para consulta pelos Magistrados e demais operadores do Direito mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e, nos casos desejados, pelos próprios tribunais locais (5).

Em 31 de novembro de 2017, durante o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi criado o projeto e-NATJUS, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), sistema gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O e-NATJUS é uma plataforma de pareceres técnicos, com base em evidências científicas, produzidos por profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas) e tem por objetivo central auxiliar os juízes no exercício da função jurisdicional alusivas à área da saúde. Foi idealizado e criado em 12 de setembro de 2015, na reunião do Fórum Nacional do Poder Judiciário.

Podemos apontar dois estados como pioneiros na instalação dos comitês ou câmaras de Mediação Sanitária, como Bahia e Rio de Janeiro, trabalhando na solução de conflitos de demandas por ações e serviços de saúde.

Os estados citados apresentam números positivos que comprovam efetivamente ser essa uma excelente estratégia para a redução da judicialização da saúde ou sua substituição, nos casos necessários, pela atuação refletida e resolutive de seus atores. Dessa forma, é possível concluir que essa nova ferramenta possibilita a construção de um diálogo institucional permanente da tríade: Saúde, Direito e Cidadania. A ação institucional de mediação sanitária é resultado, prioritariamente, de percepções político-institucionais.

A primeira, pelo aumento do fenômeno da judicialização da saúde, sobretudo pela atuação judicial reflexiva e demandista dos atores jurídicos, com impactos não somente nos custos orçamentários, mas, sobretudo, forte influência direta na lógica do planejamento coletivo em saúde.

A segunda percepção, essa mais relacionada aos objetivos da Câmara de Mediação, pela atestação da necessidade da organização das ações e serviços de saúde, no âmbito regional, com participação democrática, visando a elaboração desse mesmo planejamento de saúde numa perspectiva integrada e regional, e, sobremaneira, a fim de resolver administrativamente as demandas de saúde da população.

As sugestões necessárias para o enfrentamento da judicialização dentro do Município de Nossa Senhora do Socorro se traduz nos itens seguintes:

- A implantação do Núcleo de Assistência Técnica (NAT), com todos o quadro de profissionais habilitados com conhecimentos técnicos científicos em saúde pública como os gestores de saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, jurídicos e demais que venham apoiar o judiciário na tomada de decisões, como também, a publicação dos Pareceres Técnicos no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro/SG e no site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em atendimento às recomendações do Conselho Nacional de Justiça;
- Instituição de Câmaras de Mediação Sanitária, tendo em vista as experiências exitosas do Rio de Janeiro, com a criação da Câmara de Resolução e a Câmara de Mediação da Bahia;
- Criação do comitê de mediação em direito sanitário, para que haja uma parceria entre a gestão e o Judiciário na qual estes e demais atores envolvidos trabalhem em consonância com as políticas públicas de saúde e sob as legislações que regem o Sistema Único de Saúde objetivando a resolução dos conflitos de forma extrajudicial e administrativa, a fim de diminuir o impacto da judicialização da saúde na implementação de políticas públicas coletivas.

Sabe-se que a Secretaria Municipal de Saúde é a principal precursora do cuidado, promoção, prevenção e recuperação dos indivíduos por meio dos pontos assistenciais como a Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Média e Alta Complexidade, portanto a principal vítima de ações judiciais em saúde.

Sabe-se, ainda, que há uma deficiência por parte do Judiciário em conhecer a legislação do SUS, como a própria Lei Complementar n.º 141 (6), de 12 de janeiro de 2012, que aponta as responsabilidades sanitárias, fiscais e orçamentárias dos entes federados.

Diante de tais condutas foi possível estabelecer um plano de trabalho voltado para a prevenção de problemas que deixarão de culminar em ações judiciais, reduzindo assim o intervencionismo do Poder Judiciário na gestão do Sistema Único de Saúde no município.

Primeiro passo é entender o diagnóstico situacional e seus determinantes em saúde que impactam indiretamente ou diretamente a qualidade da saúde dos usuários de Nossa Senhora do Socorro/SE, que são:

- Complexidade territorial: O município de Nossa Senhora do Socorro/SE, representa um grande desafio organizacional dentro do Estado de Sergipe, devido aos conglomerados urbanos e ilhas rurais densas, matas de proteção ambiental, manguezais, extensão territorial de 155,018 Km², o que corresponde a 0,7 % da área do Estado de Sergipe, sendo um grande desafio assistencial para o setor saúde (7).
- Crescimento populacional desordenado registrando 52,4% da população da região em que compõe, sendo a segunda mais populosa do Estado de Sergipe com estimativa segundo IBGE/2018 de 181.503 habitantes, reflexo do crescimento do setor imobiliário atraindo vários imigrantes de regiões distintas a procura de oportunidades de empregos e assim contribuindo imprescindivelmente para a crise de falta de moradia, e saneamento básico, levando os munícipes a construir casebres as margem de rios e riachos sem saneamento básico adequado, afetando diretamente a saúde dos mesmos (7).
- O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, de acordo com o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013) foi de 0,664, ficando abaixo do IDH do estado que foi de 0,682. Esse índice leva em consideração três indicadores: renda, longevidade e educação (7).
- Renda: Segundo o IBGE 2010, 52,85% da população do município possui uma renda abaixo de ½ salário mínimo, a taxa de desemprego em maiores de 16 anos é de 14,50% e a taxa de trabalho infantil é de 6,27%. E 18.345 pessoas encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja com renda domiciliar per capita abaixo de R\$ 70,00, correspondendo a 11,4% da população (7).

- Baixa taxa de analfabetismo é de 10,6% dentre essas 72.746 com equivalência de 55,3% da população sem instrução e fundamental incompleto, 24.966 Fundamental Completo e Médio Incompleto, equivalente a 19,0%, 30.949 Médio Completo e Superior Incompleto equivalente a 23,5%, portanto só 2.228 Superior Completo, com equivalência de 1,7% (7).
- Saneamento básico: Nossa Senhora do Socorro/SE, no ano de 2017, 41.430 pessoas (22% da população) não possuíam acesso à água; 129.229 cidadãos (71% da população) não contavam com coleta de esgoto; e foram produzidos 2.741,25 mil m³ de esgoto não tratado (7).
- Aterro Sanitário: O Município de Nossa Senhora do Socorro-SE não possui Aterro Sanitário Instalado, de forma que toda coleta de lixo é levada para o aterro do Município de Rosário do Catete-SE. A população da comunidade utiliza a área da Flora como depósito de lixo a céu aberto mesmo após a realização de inúmeras palestras apontando o prejuízo dessa ação, tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente, além de campanhas de limpeza da área promovida pela Companhia de Limpeza Urbana.
- Baixíssimas coberturas vacinais: a cobertura vacinal geral, envolvendo todos os imunobiológicos do Calendário Nacional de Imunização para o ano base de 2018 (último ano com dados definitivos registrados), foi de 71% conforme dados do Programa Nacional de Imunizações, ficando abaixo da cobertura Nacional preconizada pelo Ministério da Saúde para todos os imunobiológicos.
- Baixa adesão de equipes de Estratégia de Saúde implantada no Município de Nossa Senhora do Socorro-SE, segundo a Nota Técnica do Ministério da Saúde o teto de implantação seria de 90 e atualmente só existem 61 implantadas gerando a desassistência dos serviços e perda de recursos que poderiam ser aproveitados com mais equipes e uma maior cobertura assistencial (8).
- Baixa adesão de credenciamento de Agente Comunitário de Saúde, que diante da nota Técnica do Ministério da Saúde existe um teto de implantação de 449 agentes e atualmente só existem 296 agentes implantado, assim tendo

perda financeira e má distribuição da cobertura das áreas e microáreas, gerando um grande vazio assistencial dentro do município (8).

- Baixa adesão de equipes de Saúde bucal que segundo Nota técnica é de 90 equipes e atualmente só existem 50 equipes implantadas (8).
- Resultados baixíssimos nas certificações dos ciclos do Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade (PMAQ-AB), tendo como resultados: 2 equipes com desempenhos “Acima da média” representado 11,1 %, e 16 equipes com desempenho “Mediano ou pouco abaixo da média” representando a 88,9% dos resultados esperados no segundo ciclo do ano de 2014, representando uma perda financeira muito considerável para o município e com certeza fazendo um retrato da qualidade assistencial dos serviços prestados (8).
- Resultados baixíssimos na certificação dos ciclos do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade referente a equipe de Saúde Bucal do Município que tiveram 01 equipe com desempenho “Acima da média, representando 8,3% do resultado e 9 equipes com desempenhos “Mediano ou um pouco abaixo da média” representando 75,0% dos resultados e com 02 Equipes desclassificadas, representando 16,7% para Equipe de Saúde Bucal (8).
- Baixa cobertura dos beneficiários do programa bolsa família no primeiro ciclo de 2019, ficando abaixo da média preconizada pelo Ministério da Saúde. O município de Nossa Senhora do Socorro/SE, possui 39.393 beneficiários do PBF com perfil saúde, destes na 1ª vigência de 2019 foram acompanhados 25.636 beneficiários pela Atenção Básica com 65,08 % (8).

Todos estes determinantes encontrados possuem um impacto negativo para a assistência à saúde ofertada pelo município aos residentes do município de Socorro, com isso, há o aumento das vulnerabilidades sociais que irão, por sua vez, aumentar as demandas por ações e serviços de saúde.

Quando o município, dada as limitações de infraestrutura, financeiras e/ou organizacionais não for capaz de garantir em tempo hábil a assistência solicitada, esta irá culminar com uma nova ação judicial, potencializando o problema para a gestão do SUS local.

As características das demandas judiciais da área da saúde em Socorro/SE no ano de 2018 apontaram para um total de 222 ações judiciais, nas justiças estadual e federal, destas, 81 foram de medicamentos, 46 tratamentos de Média e Alta Complexidade e tratamentos cirúrgicos, 3 tratamento médico hospitalar, 2 internações compulsórias, Outros “Serviços de saúde” – insumos como fraldas descartáveis, aspirador, botton de gastronomia, cadeiras de rodas específicas, complemento nutricional, colchão de ar, entre outros – (totalizaram 90 processos). Totalizando 222 processos judiciais, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

Analisando estas demandas, podemos observar que todas possuem relação direta ou indireta com os determinantes encontrados no diagnóstico situacional do município e que, a identificação dos mesmos nos permite a elaboração de proposições capazes de reduzir significativamente o problema estudado.

Conforme o cenário estudado iremos propor medidas de enfrentamentos capazes de minimizar o grande número de despachos judiciais destinados ao município de Socorro-SE, como também diminuir o sofrimento dos usuários que procuram o direito à saúde.

Portanto, apresentaremos abaixo propostas de enfrentamento dos determinantes que demandam a judicialização no Município de Nossa Senhora do Socorro-SE:

- Promover debate com os segmentos sociais, políticos e administrativos sobre estratégias para a criação de uma Política Habitacional Municipal voltada à qualificação de domicílios com condições adequadas para seus residentes em que haja a diminuição de casebres e moradias que apresentem risco aos que nela habitem;
- Formar um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) com todos os profissionais como, por exemplo: enfermeiros, farmacêuticos, médicos, secretário municipal de saúde, jurídico do município, visando filtrar os principais pedidos como, por exemplo, medicamentos que não estejam incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS;
- Elaborar a Relação Municipal de Medicamentos e adotar os protocolos clínicos e terapêuticos a serem utilizados por todos os profissionais prescritos

da Atenção Primária em Saúde como forma de padronizar as condutas, facilitando assim a aquisição de medicamentos e agilizando o acesso da população ao elenco de medicamentos padronizados;

- Instituir o Núcleo de Assistência Técnica (NAT), com um quadro de profissionais habilitados com conhecimentos técnicos científicos em saúde pública como os gestores de saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos jurídicos e demais que venham apoiar o Judiciário na tomada de decisões, como também, a publicação dos pareceres técnicos no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro-SE.
- Instituição da Câmara de Mediação Sanitária para que haja uma parceria entre a gestão e o Judiciário em que ambos e demais atores envolvidos com a temática trabalhem em consonância com as políticas públicas de saúde e sob as legislações que regem o Sistema Único de Saúde objetivando a resolução dos conflitos de forma extrajudicial e administrativa, a fim de diminuir o impacto da judicialização da saúde na implementação de políticas públicas coletivas.
- Fazer adesão ao Sistema de Ouvidoria Municipal como espaço de acolhimento para receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias podendo gerar informações para aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da organização em que todos os cidadãos socorrenses possam ter um canal de acesso direto com a Gestão Municipal, e por meio deste canal de comunicação o usuário possa fazer quaisquer reclamação e pedidos, exemplo medicamentos, consultas especializadas, pedidos de exames, Tratamentos Fora do domicílio (TFD) e assim minimizar os encaminhamentos de pedidos ao judiciário;
- Promover um amplo debate com todos os setores do município de Nossa Senhora do Socorro/SE, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Administração e demais setores ligados ao Governo de Sergipe em busca de investimentos em saneamento básico como estratégia de redução de danos ambientais, como também redução de transmissão de doenças de veiculação hídrica;

- Fazer um estudo do território de cobertura da Atenção Primária e fazer intervenção juntamente ao Ministério da Saúde visando a implantação de mais Equipes de Estratégias de Saúde da Família no Município de Nossa Senhora do Socorro-SE, possibilitando uma maior aproximação da população com o serviço de saúde, facilitando o acesso e diminuindo o vazio assistencial atual;
- Desenvolver uma grande ação municipal voltada para o aumento das coberturas vacinais, com atualização de dados vacinais da população, busca ativa em escolas e comunidades ribeirinhas dentre outras iniciativas que resgatem estes índices de cobertura e minimizem a exposição da população a doenças imunopreveníveis;
- Intensificação da atualização constante dos cadastros de usuários no sistema informatizado de atendimento da Atenção Básica (E-SUS AB) pelas equipes da Estratégia Saúde da Família para tornar possível o conhecimento de todos os usuários de cada área e microárea, tornando possível assim o devido acompanhamento e monitoramento destas pessoas, sobretudo os grupos mais vulneráveis como gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, crianças e adolescentes, conforme a Nova Política de Financiamento da Atenção Básica;
- Pedir apoio institucional ao COSEMS e CONASEMS, juntamente ao Ministério da Saúde sobre cadastros de novas equipes da Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes Comunitários Municipais de Saúde, para suprir o vazio assistencial que existem no município de Nossa Senhora do Socorro-SE.
- Desenvolver melhores processos de gestão e planejamento, considerando que alguns estudos evidenciam que o aumento de ações judiciais, seja, ao menos em parte, resultado das deficiências da própria administração pública nas instâncias do SUS.
- Intensificar as ações das equipes da Estratégia Saúde da Família por meio dos agentes comunitários de saúde na busca ativa desses usuários que por ventura não foram acompanhados pela saúde nas condicionalidades do Bolsa Família. Buscar um debate intersetorial como a Assistência Social e a

Educação, a fim de verificar informações sobre frequência escolar e exclusão, inclusão, mudanças, e acompanhamentos dos inscritos no CAD-único.

- Buscar juntamente com o Ministério da Saúde novas fontes de financiamento que melhore a qualidade e acesso da população do Município de Socorro-SE, diante da extinção dos ciclos do PMAQ;
- Intensificar a comunicação com as instâncias do Poder Judiciário, como Procuradores Estaduais e Municipais, Ministério Público e Defensoria Pública, a fim de que fique cada vez mais claro as competências e possibilidades, de poder garantir o direito à saúde do usuário, sem necessariamente recorrer ao poder Judiciário, por meio de ações articuladas e interdisciplinares;
- Propor um debate Intersetorial junto às Secretarias da Administração e Meio Ambiente do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, para que haja uma intervenção juntamente ao Governo de Sergipe em busca de recursos financeiros para a construção imediata de um Aterro Sanitário próprio no município, local este destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana, resíduos domésticos, comerciais, da indústria de construção e também resíduos sólidos retirados do esgoto;
- Buscar estratégia em conjunto com a Secretaria de Indústria e Comércio que possa possibilitar a vinda de empresas geradoras de empregos para dentro da região do Município de Nossa Senhora do Socorro-SE, de forma que o índice do desemprego possa cair e assim aumentar o número de trabalhadores com carteiras assinadas, elevando a renda per capita da população socorrense.
- Propor parceria com a Secretaria da Administração e Educação na busca ativa dos alunos faltosos e em vulnerabilidade social para que os mesmos possam voltar a estudar assim gerando inclusão social e diminuindo a taxa de alfabetização, gerando mais recursos dentro do município de Socorro-SE.

Considerações Finais

O Sistema Único de Saúde vive, praticamente desde sua criação, um constante movimento de aprimoramento e, sobretudo, de enfrentamento das dificuldades de ordem econômica, social e política.

A escassez de recursos tem seus efeitos agravados em momentos de crise quando também a população, fragilizada, passa a ser ainda mais dependente da Política Pública Universal. Situações como essa naturalmente refletem na intervenção e procura por outros meios, aqui inserido também a judicialização.

Noutro ponto, a falta de mecanismos de avaliação/controle, bem como a ausência de padronização procedimental, principalmente por meio de protocolos, faz com que outros setores deem utilização indevida para o Sistema.

Ademais, essa interferência externa, via de regra, serve como fator de maior prejuízo para o Sistema que, em que pese sua magnitude e ininterrupto processo de evolução, sai, ainda, maculado com a pecha de insuficiência ou incapacidade no integral atendimento dos anseios populares.

Por esses pontos, considerada gravidade dos efeitos dessa intervenção procedimental, considerando ainda a imperiosa necessidade de cumprimento de seus deveres institucionais, o SUS, por todos seus prepostos, busca aqui, também, uma reorganização de seus fluxos e serviços para, em fiel atendimento ao disposto no artigo 196 da Constituição da República e em respeito aos demais princípios Constitucionais, melhor atender o cidadão, com a finalidade de todas as peculiaridades do caso, do meio e da sociedade em sua amplitude máxima.

Com o fortalecimento dessa importante Política Pública Nacional, atendidos estarão os fundamentos e objetivos fundamentais da República.

Referências

- 1 - Portal da Justiça Federal – SE (BR). **Justiça Federal em Sergipe**. [Internet], Sergipe, 2019. [citado 12 de dezembro de 2019]. Disponível em: <<https://www.jfse.jus.br/busca-processual.html>>.
- 2 – Tribunal de Justiça Sergipe (BR). **Consulta Processual**. [Internet], Sergipe, 2019. [citado 12 de dezembro de 2019]. Disponível em: <<https://www.tjse.jus.br/portal/consultas/consulta-processual>>.
- 3 - Brasil. Constituição Federal (Artigos 196 a 200), Seção II da Saúde. [Internet]. **Brasil de fevereiro de 2020**. [Acesso em 31 de maio de 2020]. Disponível em: <http://www.conselho.saude.gov.br/legislacao/constituicao_federal>.
- 4 - Brasil. Presidência da República. **Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [Internet] Brasília, 1990. [Acesso em 30 de maio de 2020]. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>.
- 5 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010**, recomenda aos tribunais adoção de medidas para melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo à assistência à saúde. [Internet]. Brasil, 2010. [citado 13 de fevereiro de 2019]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf>.
- 6 - Brasil. Presidência da República. **Lei Complementar n.º 141, de 12 de janeiro de 2012** [Internet]. Brasil, 2012. [Acesso em 13 de fevereiro de 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm>.
- 7 - Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro (BR). PMS – **Plano Municipal de Saúde – 2018-2021** [Internet]. Nossa Senhora do Socorro – SE, 2017. [citado em 30 de maio de 2020]. Disponível em: <<http://file:///D:/DOCUMENTOS%20DA%20AREA%20DE%20TRABALHO%2020/ESPECIALIZAÇÃO%20HCOR/PLANO%20MUNICIPAL%20DE%20SAÚDE%20DE%20SOCORRO.pdf>>.
- 8 - Ministério da Saúde (BR). Departamento de Saúde da Família. **Sistema de Nota Técnica do DESF** [Internet]. Brasília, 2020. [citado 08 fevereiro 2020]. Disponível em: <<http://sisaps.saude.gov.br/notatecnica/frmListaMunic.php>>.



Judicialização da saúde: experiência da secretaria municipal de saúde de Parnaíba-Piauí

Ana Paula Custódio Carneiro¹

Bruna Fontenele de Oliveira²

Carla Patricia Batista dos Santos³

Cristiane Cruz dos Santos Mello⁴

João Rodrigues Neto⁵

Jucyara Apollyana Gomes Ramos⁶

Leonardo Alves Vilarino⁷

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Mara Campos Alves

O presente trabalho teve como objetivo identificar as causas da judicialização da saúde no Município de Parnaíba, no Estado do Piauí, ocorridas no ano de 2018, e propor estratégia de intervenção para mitigação do fenômeno.

¹ Graduada em Direito, pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Administrativo, pela PUC/GO, mestre em Direito da Saúde-Dimensões Individuais e Coletivas pela UNISANTA-SP. Chefe de Gabinete da SMS de Goiânia-GO.

² Graduada em Enfermagem pela FAP, com pós-graduação em Saúde da Família pela UFPI. Superintendente de Regulação e Auditoria de Parnaíba-PI.

³ Graduada em Direito pela FAMEC, pós-graduada em Direito Tributário pela FACEAR. Diretora de Departamento de Apoio Jurídico da SEMS de São José dos Pinhais-PR.

⁴ Graduada em Direito pela Universidade de Cuiabá-UNIC, pós-graduada em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela ESP-MT. Secretária Adjunta de Administração, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SES-MT.

⁵ Graduado em Farmácia pelo CESMAC, pós-graduado em Farmacologia Clínica pelo UNINTER. Responsável pelos pareceres técnicos provenientes das demandas judiciais para aquisição de medicamentos na SMS de Palmeiras dos Índios-AL.

⁶ Graduada em Direito pela FAI, pós-graduada em Direito Constitucional pela LFG e Gestão em Saúde pela FIO-CRUZ. Assessora no Setor Jurídico da SMS de Caxias-MA.

⁷ Graduado em Direito pela Faculdade de Minas Gerais. Assessor da SMS de Peçanha-MG.

Foi realizado um levantamento, seguido de um diagnóstico das demandas da judicialização da saúde, no ano de 2018. Todavia, ficaram excluídas da amostra, os processos não relacionados com a saúde, e datados de anos distintos ao adotado no estudo. A instituição fonte de pesquisas foi a Procuradoria Geral do Município.

Ademais, tratou-se de um estudo descritivo/exploratório/interventivo, de abordagem quantitativa, visando retratar um padrão de ocorrência da judicialização da saúde no município em referência.

A real problemática apontada na proposta de intervenção, se fundamenta nos pressupostos da realidade, motivo pela não prestação de serviços e ações de saúde à população; transformação nos paradigmas diagnosticados; mudança de conduta de profissionais técnicos, no sentido de dar resolutividade às demandas por saúde, excluindo a judicialização como única alternativa pelo usuário/cliente do SUS.

O instrumento de coleta utilizado, foi um roteiro previamente estruturado, com as seguintes variáveis a serem observadas: 1) objeto da ação judicial; 2) os processos instaurados no ano de 2018, que ainda estão em trâmite e os já encerrados; 3) a concessão de tutela antecipada; 4) os prazos para cumprimento da liminar; 5) os valores estipulados para multa de atraso no cumprimento.

Com o roteiro estabelecido, buscou-se o auxílio do Procurador da Saúde de Parnaíba, para coletar os dados referentes aos processos ajuizados que tivesse como réu o município. A investigação ocorreu por meio do PJe (Processo Judicial eletrônico), consistente no sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa atender às necessidades do Poder Judiciário brasileiro, e facilitar o acesso e o acompanhamento dos processos.

O PJe (Processo Judicial eletrônico) no município de Parnaíba-PI foi implantado em 2016, ano que iniciou a transição dos processos físicos para o eletrônico, no entanto a sua obrigatoriedade ocorreu nos últimos meses de 2017. Diante do exposto, e pela importância na confiabilidade dos dados analisados, o período do estudo foi limitado ao ano de 2018.

Após a análise das informações encontradas, foi possível identificar as causas da judicialização e, assim, pontuar as estratégias e planejamentos.

De modo complementar, foi realizada pesquisa bibliográfica que abrangeu artigos científicos, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses e material cartográfico. Ratificando, tomando por base a fundamentação e aspecto transformador da pesquisa, ainda como objetivo principal, foi importante contextualizar o município, conhecer alguns dos dados relacionados aos determinantes sociais da saúde, e que podem ter relação direta com o tema da judicialização.

Para tanto, especificamente sobre a pesquisa bibliográfica acerca do tema, por causa do volume excessivo de produção sobre este assunto, a pesquisa bibliográfica limitou-se às publicações veiculadas no período de 2017 a 2019.

Diagnóstico da judicialização no município

Segundo informações coletadas na Procuradoria da Saúde, o Município de Parnaíba-PI recebeu em média de 30 processos judiciais no ano de 2018, objetivando o acesso e assistência à saúde, precisamente no que se refere à aquisição de medicamentos e leite, realização de exames de diagnóstico, bem como de procedimentos cirúrgicos eletivos.

Levando em consideração o histórico de gastos com judicialização, no início de cada ano, o município realiza a dotação orçamentária anual para o cumprimento das sentenças judiciais. Em 2017 foi planejado o valor de R\$ 593.000,00, tendo sido utilizado, no entanto, somente o valor de R\$ 479.814,94. Já no ano de 2018, os gastos foram orçados em R\$ 510.000,00, mas gastou-se apenas R\$ 411.216,35 (1).

Nestas informações, obtidas por meio do Relatório Anual de Comparativo de Despesa (1), emitido pelo contador do Fundo Municipal de Saúde, podemos observar uma discreta redução dos gastos advindos da judicialização da saúde, o que pode ter sido fruto da instituição de algumas estratégias a fim de minimizá-los, por parte da gestão municipal e dos órgãos do Poder Judiciário.

Nos últimos anos, houve uma melhor comunicação entre a gestão municipal e o Poder Judiciário, o que se demonstrou um ótimo artifício para resolver as demandas administrativamente. Além disso, a secretaria da saúde realizou um levantamento no qual foram relacionados os objetos mais frequentes nas demandas judiciais, o que viabilizou a compra de tais itens de forma planejada.

Outra ação se refere à reestruturação e a qualificação dos serviços de saúde, que certamente foram ferramentas que minimizaram a procura da saúde por vias judiciais.

Vale salientar que, por causa do número de processos judiciais visando o acesso à saúde e ao aumento de solicitações de informações demandadas pelos órgãos do Poder Judiciário, foi criado o cargo de Procurador Adjunto para a Política de Saúde Pública vinculada à Procuradoria Geral do Município, por meio da Lei Complementar n.º 028, de 17 de outubro de 2013, para atuar juntamente com os órgãos das respectivas políticas públicas, como forma de estratégias do município no âmbito administrativo ou judicial (2).

A dinâmica da judicialização no município de Parnaíba-PI ocorre das seguintes formas:

- 1º- O paciente inicialmente solicita à Secretaria Municipal de Saúde, pela via administrativa, o medicamento ou exame que necessita. Caso o pedido seja negado, ele recorre à Defensoria Pública, a um advogado particular ou ao Ministério Público, para ingressar com a ação judicial; ou
- 2º- O paciente procura diretamente a Defensoria Pública ou o Ministério Público indicando o que necessita, para que estes acionem o município em juízo. Essas entidades formalizam o pedido administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de ofício e/ou recomendação ministerial, para que o município forneça o medicamento ou exame solicitado pelo paciente. No entanto, caso não sejam atendidos, procedem ao ajuizamento da ação competente; ou
- 3º- O paciente ingressa diretamente com pedido judicial por meio de advogado particular.

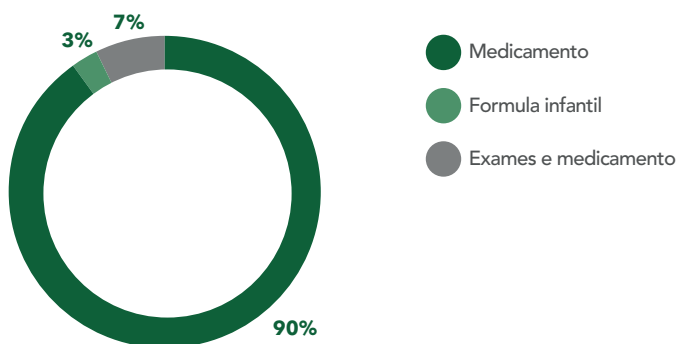
Diante dos dados processuais fornecidos pelo Procurador do município, por meio de planilha específica gerada pelo sistema PJE, referente ao ano de 2018, foi possível identificar 30 processos judiciais ajuizados no período, com objeto atinente à saúde, tendo como réu o município de Parnaíba e, distribuídos à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnaíba-PI.

Durante a avaliação dos processos, percebeu-se algumas constantes no que se refere ao objeto da ação, à representação do autor, à concessão ou não de tutela antecipada e o respectivo prazo de cumprimento e multa por descumprimento da ordem judicial.

Registre-se que do total de processos analisados, o município investigado figurou como litisconsorte, demandado juntamente com o Estado do Piauí, em apenas 16,66% dos casos, deixando claro que a maior parte das ações, 83,33%, foram endereçadas exclusivamente ao município.

Dentre os principais pedidos identificados foi possível extrair os dados constantes na Figura 1:

FIGURA 1. Objeto da demanda dos Processos Judiciais de 2018 do município de Parnaíba, PI, que versam sobre ações e serviços públicos de saúde.



Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí; 2018.

Dos processos analisados, quase em sua totalidade, as ações tiveram como objeto a solicitação de medicamentos. Importante salientar que, na maioria dos processos, o pedido principal se refere a mais de um medicamento.

Foram identificados, 33 fármacos diferentes solicitados nas ações judiciais em 2018, todos registrados pela Anvisa. Os fármacos solicitados foram classificados em três categorias: 1) os componentes básicos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 2) relação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF da RENAME) e 3) os medicamentos que não constam em nenhuma das duas listas, sendo estes não padronizados.

TABELA 1. Medicamentos solicitados nos processos judiciais.

LISTA	QUANTIDADE	%
Componente básico	8	26,66
CEAF	5	15,15
Não padronizado	20	60,60
Total	33	100

Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí; 2018.

Em 1998, com a aprovação da Política Nacional de Medicamentos, o Ministério da Saúde regulamentou o direito à população de acesso aos medicamentos considerados essenciais (3). Tais medicamentos estão discriminados nas listas oficiais do Ministério da Saúde, denominada RENAME.

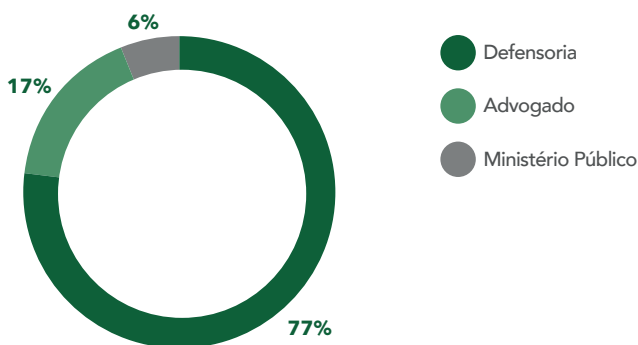
Contudo, a constância de pedidos de medicamentos pertencentes aos programas do SUS, pode ser explicada pela não aquisição por via administrativa, devido à documentação incompleta, não atendimento aos critérios exigidos, pelas fragilidades no gerenciamento da assistência farmacêutica em garantir a oferta, ou ainda, pela inclusão desses medicamentos na receita prescrita juntamente com outros medicamentos que não constam das listas oficiais, levando a inclusão nesses pedidos (4).

Necessário, portanto, proceder a uma avaliação mais acurada sobre a judicialização de medicamentos no município, para averiguar as reais causas desse acontecimento, e se há necessidade de uma atuação mais incisiva da gestão, com alteração no processo de aquisição.

Em relação aos medicamentos não padronizados, os resultados verificados no município não diferem daqueles apresentados pela literatura, que demonstra um predomínio nos pedidos de fármacos que não constam nas listas oficiais do SUS, embora registrados na Anvisa (4, 5).

Os pacientes que buscaram a via judicial utilizaram diversas opções de assistência jurídica para representá-los, sendo a Defensoria Pública a instituição mais atuante.

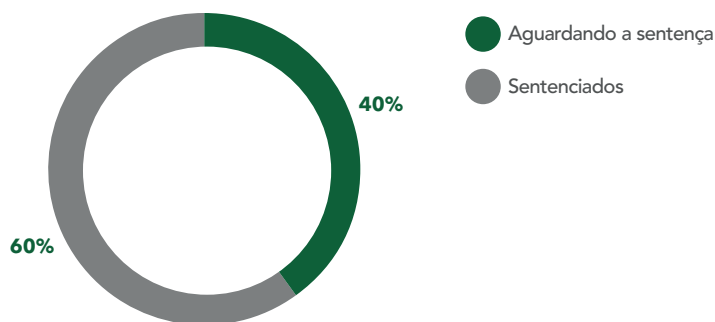
FIGURA 2. Tipo de assessoria jurídica utilizada para representar o autor em demandas judiciais de saúde pública, no município de Parnaíba, no ano de 2018.



Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí, 2018.

No que concerne às decisões judiciais foi observado que mais da metade dos processos analisados já possuíam sentença (60%). Isso demonstra a celeridade com que as demandas sobre saúde são julgadas.

FIGURA 3. Situação dos processos judiciais de saúde pública, no município de Parnaíba, no ano de 2018.



Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí; 2018.

Dos 30 processos pesquisados, outra variável analisada, foi quanto ao julgamento do mérito, em que 14 processos tiveram julgamento, enquanto 4 foram extintos sem julgar o mérito, em virtude da suspensão do tratamento do paciente/usuário e/ou por ausência de manifestação da parte autora, quanto a prestação de informações requeridas pelo juiz para dar prosseguimento ao processo.

No caso dos 14 processos sentenciados com análise de mérito, todos tiveram julgamento desfavorável em relação ao município de Parnaíba, obrigando-o a fornecer os medicamentos e/ou exames solicitados pela parte autora.

Quanto à concessão de tutela, foi possível identificar, que dos processos analisados, 23 tiveram concessão total de tutela antecipada, 1 concessão parcial, 2 não obtiveram a antecipação de tutela e 4 processos foram extintos sem o pronunciamento do juiz sobre esse pedido específico, apesar da existência de pedido de liminar.

TABELA 2. Prazo do cumprimento da tutela antecipada.

PRAZO	TOTAL DE PROCESSOS	%
Até 5 dias	15	62,5
Até 10 dias	5	20,83
Até 15 dias	4	16,66
Total	24	100

Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí; 2018.

Dentre os processos analisados, em mais da metade deles, o juiz concedeu liminar em favor do autor da ação, sendo o município obrigado, desde logo, a prestar atendimento ao usuário/paciente, em relação aos medicamentos ou exames. Os prazos conferidos para o cumprimento da decisão liminar variaram entre 5 e 15 dias, sendo fixadas multas diárias em caso de descumprimento que variaram entre R\$ 400,00 a R\$ 2.000,00, podendo, ainda, chegar ao máximo de R\$ 50.000,00.

TABELA 3. Valor da multa por atraso no cumprimento da tutela antecipada.

VALOR DE ATRASO DIA (\$)	QUANTIDADE	%
Sem valor estipulado	1	4,16
400	1	4,16
1.000	21	87,5
2.000	1	4,16
Total	24	100

Fonte: Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau, Tribunal de Justiça do Piauí; 2018.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

O NAT-JUS é uma unidade criada para dar suporte aos juízes do TJPI, incluindo o município de Parnaíba, quando do recebimento de demandas judiciais relacionadas à área da saúde que requeiram do magistrado o embasamento de conhecimentos técnicos e especializados, subsidiando as decisões judiciais.

O Tribunal de Justiça do Piauí no ano de 2019, por meio da Resolução n.º 131/2019 (6), alterou a denominação do Núcleo de Apoio Técnico ao Magistrado (Natem), para Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), visando adequar a nomenclatura frente às demandas judiciais no âmbito da saúde.

A Resolução n.º 131/2019 do TJPI (6) tem por base a Resolução n.º 238/2016 do CNJ (7), que dispõe sobre a criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) e sobre a instalação dos comitês estaduais de saúde nos tribunais de Justiça e tribunais federais, para atender às questões relacionadas à judicialização da saúde básica.

Cabe registrar, que os pareceres do NAT-JUS não são públicos, assim subentende-se que para conhecê-los, é por meio de acesso aos autos do processo, que se dá pelos magistrados e partes litigantes.

Assim, aos juízes que respondem na comarca de Parnaíba-PI, é disponibilizado o respectivo Núcleo já instituído, cujo número das demandas atendidas em todo estado do Piauí, se encontra disponível no site <http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/demanda-de-saude-publica/>.

A falta de publicidade dos pareceres emanados, não afasta a importância dos juízes da comarca de Parnaíba encaminharem ao NAT-JUS suas respectivas ações relacionadas à saúde, para emissão do competente parecer técnico, como exemplo, o acesso de medicamentos não padronizados, dentre tantos outros assuntos que comportam demandas da judicialização.

Ademais, ao acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Piauí, na demanda da saúde, no link <http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/demanda-de-saude-publica/>, é possível visua-

lizar, dentre os anos de 2016 a 2018, as demandas judiciais e tabelas de procedimentos de cada processo relativo ao antigo NATEM.

Ainda, em atenção à Resolução CNJ n.º 238/2016 (7), foi constituído o Comitê de Saúde do Estado do Piauí (COSEPI), que tem como integrantes diversos atores da área jurídica e da área de saúde, para debater alternativas relacionadas à judicialização da saúde, bem como, propiciar a garantia dos direitos básicos da população piauiense. O COSEPI é coordenado pelo juiz titular da 1ª Vara da comarca de Piripiri.

Por conseguinte, a criação de uma ampla estrutura de acesso ao NAT-JUS do PI, seja por meio dos sítios eletrônicos ou teletrabalho, revela-se como ferramenta facilitadora na tomada de decisão numa área com tamanha especificidade como a saúde.

No município de Parnaíba ainda não existe instituído o núcleo de Mediação Sanitária. Salienta-se que como estratégia municipal, visando à redução da judicialização, a Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba busca monitorar o objeto das ações com maior quantitativo, por meio da Procuradoria Adjunta da Saúde que faz o levantamento e encaminha para assistência farmacêutica, de forma que seja viabilizado o processo de aquisição com antecedência, reduzindo de forma significativa o dispêndio de recursos via indenizatório e/ou judicial (8).

Registre-se, ainda, que a Defensoria Pública e o Ministério Público são os órgãos que apresentam a maior demanda de ações juntamente ao município, contudo, previamente, realizam consulta à Secretaria Municipal antes o ajuizamento das demandas, por meio de ofício e/ou requisição endereçada a SMS, o que oportuniza resposta quanto à possibilidade de atendimento ao usuário/paciente pela via administrativa, antes do acionamento do Judiciário.

Da análise do fenômeno da judicialização no município de Parnaíba, observou-se que a questão de medicamentos é o item mais demandado, destacando-se, nesse tema, o número de fármacos que constam nas listas oficiais, mas que, mesmo assim, são objetos de ações judiciais. Tal fato indica a necessidade de uma intervenção precisa nesse aspecto, especialmente na gestão da aquisição e dispensação desses produtos.

Assim, a criação de uma Comissão Administrativa Técnica, seria um instrumento importante de gestão não apenas deste, mas de outros problemas que, porventura, sejam diagnosticados por meio de monitoramento constante das ações judiciais ajuizadas em desfavor do município estudado.

Ademais, a partir do estudo realizado, identificou-se a necessidade do município implementar uma Comissão Administrativa Técnica (CAT) para atuar no enfrentamento da judicialização da saúde pública.

A comissão seria responsável por identificar as falhas do sistema, implementar fluxos, elaborar notas técnicas orientativas, monitorar os prazos estabelecidos para resposta aos usuários e órgãos demandantes, dando resolutividade ao grande número de ofícios, requisições, recomendações e processos judiciais recebidos, em que a equipe deverá estar em plena comunicação com as áreas reivindicadas, atuando por meio de contato telefônico, e-mail e outros canais disponíveis, além de realizar reuniões com os gestores e técnicos da Secretaria de Saúde, para tomada de decisões.

Salienta-se que, em observância a autonomia administrativa dos entes, resguardada na Constituição Federal (9) em seu art. 23, inciso I, o município de Parnaíba, por meio do órgão da Secretaria de Saúde, partindo da premissa da descentralização do SUS, adotaria enquanto medida técnica e administrativa, implementação, formalização e atuação da CAT, primordialmente dentro da SMS, com intuito de zelar pela saúde dos usuários que necessita dos cuidados do SUS.

Destaca-se, que o objetivo principal da CAT, seria a vigilância dos conflitos de não acesso e assistência às ações e serviços de saúde do município, agilizando e mediando questões envolvendo conflitos.

Desse modo, a referida CAT, instalada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, terá como objetivo essencial viabilizar maior proximidade de seus integrantes com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, utilizando a tecnologia e os meios de comunicação mais céleres disponíveis, pretendendo assim, agilizar as análises das demandas, com intuito de responder tempestivamente a solicitação do usuário.

A comissão também ficaria responsável por criar um fluxo para análise das principais demandas judiciais que advém da Defensoria Pública e do Ministério Público, fazendo uma intervenção para que a demanda seja respondida tempestivamente e quando possível atendida na esfera administrativa, evitando assim novos pedidos.

Entende-se que soluções extrajudiciais são ferramentas eficazes para resolver os conflitos que visam o acesso à saúde, por meio da mediação sanitária, que possibilita a articulação e a construção de estratégias preventivas para diminuição da judicialização da saúde.

Já nos conflitos inevitáveis, a CAT ficaria responsável por responder em tempo hábil as decisões judiciais com prazo de tutela antecipada (até 48 horas), isto seria imprescindível para evitar possíveis bloqueios de contas públicas e transtornos à gestão.

Referências

- 1 - Prefeitura Municipal de Parnaíba (BR). Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório Comparativo Mensal da Despesa**. Parnaíba: secretaria Municipal de Saúde; Período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
- 2 - Prefeitura Municipal de Parnaíba (BR). **Lei Complementar n.º 028 de 17 de outubro de 2013**. Institui funções comissionadas técnicas e gratificações para servidores efetivos; Cria cargos de provimento efetivo e Institui órgãos e cargos de provimento em comissão, e dá outras providências. [Internet]. [citado 04 abr. 2020]. Diário Oficial do Município; (17 out 2013); Ano XV-N 1202, p. 1. Disponível em: <<http://dom.parnaiba.pi.gov.br/assets/diarios-antecedentes/DOM%201202%20-%2017102013.pdf>>.
- 3 - Pereira JR, Santos RI, Nascimento Jr JM, Schenkel EP. **Análise das demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos pela Secretaria da Saúde de Santa Catarina nos anos de 2003 e 2004**. Ciênc. saúde coletiva vol.15 supl.3 Rio de Janeiro Nov. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000900030>.
- 4 - Chieffi AL, Barata RB. **Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade**. Cad. Saúde Pública [Internet]. [citado 4 abr. 2020]; 25(8):1839-1849. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2009000800020>.
- 5 - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (BR). Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau;2018; data de acesso:04/03/2020; Disponível em: <<https://tjpi.pje.jus.br>>.
- 6 - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (BR). **Resolução n.º 131 de 18 de março de 2019**. Altera a denominação do Núcleo de apoio técnico ao magistrado –NATEM para Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – Nat-Jus. [Internet]. [citado 3 mar 2020]. Disponível em: <http://transparencia.tjpi.jus.br/uploads/legislacao_lei/file/2044/RESOLU%C3%87%C3%83O_131-2019_-_ALTERA_DENOMINA%C3%87%C3%83O_NATEM_-_NAT-JUS.pdf>.
- 7 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Resolução 238, de 6 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. [Internet]. [citado 21 jan. 20202]. Brasília: Diário Oficial da União; 9 set 2016. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.

8 - Prefeitura Municipal de Parnaíba (BR). Secretaria Municipal de Saúde. **Procuradoria Adjunta da Saúde, ofício 95, assunto: estratégias implementadas para redução da judicialização da saúde.** Parnaíba: Secretaria Municipal de Saúde; 2019.

9 - Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** [Internet]. [citado 2 ago. 2018]. Brasília (DF): Senado Federal; 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.



A judicialização da saúde em Patos-PB

Amanda de Andrade Lima¹

Indangélica Ribeiro²

Márcia Ferreira Leite Pereira³

Maycon Lucena Paulo⁴

Miriam Fabiana Rodrigues da Cruz Riberio⁵

Pedro Paulo Chrispim⁶

Ricardo Venero Soares⁷

Viviane Paula Fiorentin⁸

Orientadora: Profa. MSc Tarsila Costa do Amaral

Em razão da importância do município de Patos-PB e da viabilidade de se acessar os dados sobre demandas de saúde, optou-se por estudar os fluxos existentes no município no manejo das demandas de judicialização ligadas à saúde e seu quantitativo no ano de 2018.

A metodologia proposta para o estudo foi de cunho qualitativo, efetuando-se a análise do quanto a atuação, organização e fluxo de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde

¹ Graduada pela AESO, pós-graduada em Direito Constitucional pela Uniderp. Assessora Jurídica do COSEMS-PE.

² Graduada em Direito UNIFOR e pós-graduada em Processo Penal pela mesma instituição. Coordenadora Jurídica do Município de Fortaleza-CE.

³ Graduada em Direito pela UNIVAP, e pós-graduada em Direito Público pelo Damásio. Assessora Jurídica na SMS de Jacareí-SP.

⁴ Graduado em Direito pela FDCI. Consultor Interno na SMS de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

⁵ Graduada em Enfermagem, pela Faculdade Guarai e pós-graduada em Saúde Pública e Enfermagem do Trabalho pela Faculdade Guarai, pós-graduada em Auditoria Planejamento e Gestão em Saúde pela Faculdade Laboro. Diretora de Desenvolvimento de Políticas de Saúde no Município de Pedro Afonso-TO.

⁶ Graduado em Farmácia pela UFRJ, com Doutorado em Avaliação Econômica de Programas de Saúde pela ENSP. Pesquisador na área de Monitoramento e Avaliação em Saúde, do Hospital do Coração.

⁷ Graduado em Ciências Contábeis pela UFMT, Doutor em Contabilidade do Setor Público UNIR e pós-graduado em Gestão Pública pela AESA. Assessor na Secretaria de Saúde de Cuiabá-MT.

⁸ Graduada em Direito pela UNOCAPECO. Diretora do Controle e Avaliação da SMS de Caibí-SC.

de Patos-PB tem impactado na judicialização das políticas de saúde. Foi realizado também um estudo dos casos que tem ensejado o ajuizamento de ações judiciais versando sobre direito à saúde no município, ocasião em que foram analisadas as petições iniciais e decisões judiciais nas demandas em que fora postulado o fornecimento dos medicamentos, insumos, procedimentos, consultas, cirurgias e outros.

Foram avaliadas as ações movidas de janeiro a dezembro de 2018. Para tanto, foi efetuado um levantamento quantitativo de casos no ano citado, suas especificidades e estimativa de gastos com a judicialização.

Como base na pesquisa, foram tomadas as seguintes fontes de análise:

- I. Informações do quantitativo de demandas judiciais ajuizadas no período de janeiro a dezembro de 2018 fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde;
- II. Dados disponibilizados pelo município de Patos-PB em seu sítio eletrônico;
- III. Consulta processual no sítio ou processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e;
- IV. Visita *in loco* junto à Secretaria de Saúde de Patos-PB para coleta de demais informações pertinentes.

Foi padronizado um formulário para coleta de dados dos processos de sentenças judiciais para facilitar a sistematização e análise dos dados.

As variáveis pesquisadas foram: doenças informadas; tipos de procedimentos e insumos requeridos; classes terapêuticas dos medicamentos solicitados; origem da prescrição (SUS ou saúde suplementar); tipo de representação jurídica; existência de alternativa na Relação Municipal de Medicamentos; avaliação das políticas públicas de saúde, implementadas ou não; estudo dos fluxos administrativos para prestação de serviços e produtos de saúde.

Ao final da compilação e sistematização dos dados, foi realizada a análise da situação dos fluxos existentes para com os processos de judicialização e sumariado o quantitativo dos casos que ensejaram o ajuizamento de ações judiciais versando sobre direito à saúde. A partir desse momento, foi possível contabilizar também os valores orçamen-

tários onerados ao Fundo Municipal de Saúde e os possíveis impactos acarretados às ações de saúde, conforme demonstram os resultados apresentados.

Diagnóstico da judicialização no município

Em visita *in loco* no dia 23 de julho de 2019, ao Município de Patos-PB, em especial junto à Secretaria Municipal de Saúde, foi possível conhecer a organização do município para o enfrentamento do fenômeno da judicialização das políticas públicas de saúde. Identificou-se que as ações relacionadas sobre esse tema eram executadas por uma única servidora ocupante de cargo em comissão e a quem competia receber e responder todas as solicitações e ordens emanadas dos órgãos judiciais decorrentes de litígios propostos individualmente ou de forma coletiva por meios dos entes competentes.

Constatou-se com a visita à setorial de saúde do Município de Patos que tal órgão não tem setor específico que responda ou tenha aptidão técnica definida para atuar, responder, esclarecer ou deliberar sobre o atendimento das demandas referente a serviços e atendimentos de saúde e/ou ordens originárias do Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público, em suma, não se identificou a existência de setor específico apto a responder, de forma qualificada, sobre assuntos relacionados à judicialização da saúde.

Exemplificando a atestação apresentada, aponta-se a falta de estrutura ou fluxo para os atendimentos realizados no âmbito da Farmácia Municipal que não conta com o acompanhamento de profissional farmacêutico e onde as dispensações de medicamentos são realizadas unicamente por servidor auxiliar administrativo referente ao qual não se identificou qualificação técnica condizente com a função desempenhada.

As informações técnicas necessárias para esclarecimentos das ações e serviços de saúde são repassadas de maneira informal à servidora responsável pela confecção das respostas, o que *per si* já indicaria a dificuldade e prejuízos para esclarecimentos e respostas melhor qualificadas a elucidação dos litígios oriundos de demandas judiciais

ou, senão, um compartilhamento de informes que venha a promover uma maior publicação sobre os regramentos e estruturação do Sistema Único de Saúde.

Outro método utilizado para pesquisa dos dados foi a consulta ao Poder Judiciário do Estado da Paraíba referente aos números da judicialização da saúde no ano de 2018, o qual, por meio da Gerência de Pesquisas Estatísticas enviou relatório que trouxe indicações de demandas judiciais de direito à Saúde, em sua maioria do ano de 2019, sendo que, apenas uma única ação desta natureza foi distribuída no ano de 2018.

As informações inconsistentes dificultaram sobremaneira um maior alcance do que se propunha para fins de sugerirmos alguma intervenção naquele município, revelando uma fragilidade das informações que seriam imprescindíveis à proposta ou estratégia para o aprimoramento do processo de judicialização naquele foro quando se parte da premissa de que a obtenção de dados fidedignos viabilizaria o diagnóstico do fenômeno na localidade e proposição de uma estratégia própria considerando as variáveis, órgãos e demais atores envolvidos no assunto. Em outros termos, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba foram de pouco proveito diante da flagrante inconsistência dos dados apresentados.

Seguiu a mesma sorte as informações apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba que enviou planilha contendo os dados das demandas judiciais sobre direito à saúde em que estava sendo pleiteado fornecimento de medicamentos no ano de 2018 e que figuram no polo passivo o Estado e Município, não obstante ter-se permitido a realização de consulta processual individual em todas as ações constantes do relatório, o que viabilizou o estudo do perfil das demandas judiciais na comarca.

Não foi possível a obtenção de dados relacionados às outras ações e serviços de saúde objeto de ações judiciais nem, sobre o quantitativo, se existente, em que somente o Município de Patos figura no polo passivo da demanda.

Assim, constatou-se que a ineficiência do enfrentamento à judicialização da saúde naquele município se estendeu ao Poder Judiciário que pouco acionou o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS) para compreender os fatores técnicos dos casos específicos. Além disso, verificou-se que, na condução dos processos, os

magistrados não se valem da oitiva prévia do gestor a respeito da competência ou alternativa terapêutica.

A forma de condução dos processos relacionados às políticas públicas de saúde aliada a falta de estrutura de pessoal do Município de Patos para enfrentamento da judicialização, demonstrou que a superação ou, minimamente, a harmonização dos conflitos não será fácil de ser alcançada em face da ineficiência técnica e qualificada das questões envolvendo a judicialização da saúde, circunstâncias que tendem a agravar da situação.

Não foi atestado que o ente municipal se estruturou para o aprimoramento na prestação de esclarecimentos e informações técnicas qualificadas a orientar usuários, órgãos diversos e, principalmente, subsidiar os juízes como elementos para o julgamento das matérias relacionadas ao direito à saúde.

O Ministério Público, por sua vez, ajuíza ação civil pública para postular direito individual e também não provoca formalmente informações prévias do gestor e potencializa as iniquidades e o desequilíbrio do sistema.

Segundo os registros da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba no ano de 2018, foram ajuizadas 88 (oitenta e oito) novas ações relacionadas ao direito à saúde pública em face do Município de Patos e do Estado da Paraíba.

Se comparado com os dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba referente ao ano de 2019 e aquele disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde que abrange o ano de 2019, atesta-se a redução de 62,5% das ações judiciais que postulam fornecimento de medicamentos.

A média mensal é de 7 (sete) novas ações postulando fornecimento de medicamentos, o que significa que há cada quatro dias é ajuizada uma ação buscando o acesso a fármacos.

O estudo revelou ainda o elevado número de bloqueios de recursos financeiros decorrentes de descumprimento das decisões, o que corrobora a falta de estrutura organizacional para o cotidiano da judicialização da saúde.

A ausência de informações pelos atores envolvidos na judicialização da saúde em Patos impossibilitou dimensionar quais foram os principais pedidos de saúde judicializados, no ano de 2018.

Entretanto, a falta de detenção de dados pelos órgãos públicos, apesar de reprovável, demonstra o campo fértil para se propor intervenções nos processos estratégicos na judicialização da saúde do Município de Patos.

Assim, a quantificação dos principais pedidos ficou restrita ao perfil das demandas que se postulam o fornecimento de medicamentos, tais como, percentual de sentenças procedentes ou improcedência, os fármacos mais pedidos e o perfil dos medicamentos.

Os medicamentos mais judicializados são Enoxaparina e Lucentis® que correspondem, respectivamente, a 15% e 11% das ações. Ambos os fármacos não são padronizados. Os produtos possuem registros na Anvisa, sendo a Enoxaparina um anticoagulante injetável comercializado sob diversas marcas e o Lucentis® um medicamento (também injetável) de elevado custo para tratamento de lesões oculares.

TABELA 1. Percentual de ações postulando medicamentos padronizados e não padronizados.

MEDICAMENTO PADRONIZADO	MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
10% - 8 ações	90% - 80 ações

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secretaria Municipal de Patos.

A judicialização das políticas públicas de saúde traduz verdadeiro termômetro sobre a sua qualidade e efetividade em determinado território, de sorte que mensurar quais são os casos mais ajuizados seria de extrema valia para os gestores aprimorarem o acesso às ações e serviços de saúde.

Desta forma, embora lamentável que a ausência de informações viabilizasse a plenitude das propostas de enfrentamento, tem-se evidenciada a imprescindibilidade de adoção de estratégias ou ferramentas de controle de dados pelo Município, Poder Judiciário e Ministério Público local.

Diante dos dados dos processos fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde procedeu-se à consulta processual no site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (1), a fim de verificar a espécie de representação dos usuários (advogado, defensor ou promotor).

No ano de 2018, foram ajuizadas 88 novas ações judiciais sobre fornecimento de medicamentos, sendo a parte autora representada pelo Ministério Público Estadual em 77 delas, isto é, estima-se que 87,5% das pessoas são representadas por promotor de justiça.

Em 2018, a Defensoria Pública Estadual ajuizou 4 novas ações postulando o fornecimento de medicamentos, o que representa 4,5% do quantitativo do período.

Já as demandas em que a parte autora está representada por advogado particular foram 7, ou seja, em 7,9% das novas ações o usuário constituiu patrono.

Na perspectiva jurídico-normativa o sistema de assistência à saúde é revestido de amplitude e complexidade, envolvendo um considerável arcabouço de normativas que regem as centenas, talvez milhares, de ações e serviços de saúde ofertados pelo poder público.

A legislação estruturante do Sistema Único de Saúde é composta por mais de 9 mil artigos em leis, portarias e resoluções, mais amplo que a soma de todos os artigos codificados pelo direito pátrio (Código Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, entre outros).

Para a compreensão do fenômeno da judicialização da saúde é imprescindível identificar a ótica do Poder Judiciário na análise das demandas dessa natureza.

As atestações registradas neste estudo têm por base a análise individual das ações em que se postulou o fornecimento de medicamento no Município de Patos.

Também foram utilizados como parâmetro de análise os critérios do Relatório Analítico Propositivo denominado “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução” do Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 18 de março de 2019 (1).

De acordo com o referido relatório a política do CNJ sobre a gestão da judicialização, como é o caso dos NATs, normas específicas para as demandas de saúde e as respostas das políticas de saúde pela CONITEC são pouco mencionadas nas decisões judiciais (1).

Pontua-se que a pesquisa realizada pelo CNJ analisou a frequência de menções aos enunciados interpretativos relacionados à saúde e o resultado atestado indicou que, em primeira instância, foram mencionados 19 vezes em 107.497 decisões, e em segunda instância, 2 vezes em 82.233 decisões. O CNJ concluiu que os achados são estatisticamente irrelevantes e sugerem que há pouca utilização dos enunciados interpretativos (1).

Não se pode reputar razoável exigir amplo conhecimento do magistrado sobre a extensa legislação estruturante do SUS, principalmente daqueles cuja competência abarca outras matérias, como por exemplo, execução fiscal, cível, família e improbidade administrativa, porém, ao lidar com as demandas de saúde o juiz deve, minimamente, observar as recomendações dadas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de resoluções ou enunciados interpretativos.

Na comarca de Patos-PB as decisões exaradas pelos juízes com competência para processar e julgar demandas de saúde, no ano de 2018, demonstram a ausência de rigor tanto no juízo de cognição sumária quanto no juízo de cognição exauriente para análise das demandas judiciais de saúde.

As unidades judiciárias têm um padrão uniforme estabelecido para o processamento das demandas relacionadas à saúde pública e, em regra, após a demanda ser ajuizada, o juiz exara decisão concessiva de liminar e determina a intimação dos réus para contestarem e, em seguida, julgam os casos. Caso atestado o descumprimento da liminar, não há tolerância com atrasos e logo se efetua o bloqueio de numerários.

Algumas decisões não analisam o caso concreto, ainda que forma superficial, reproduzindo verdadeiros padrões decisórios que invocam motivos que se prestaria para justificar qualquer outra decisão, ou seja, o grau de aprofundamento dos magistrados sobre os casos concretos é estatisticamente insignificante.

Ainda que se respeite o princípio do livre convencimento motivado, as decisões interlocutórias e sentenças utilizam por base a mera prescrição médica, como se o laudo ou receituário médico tivesse força de título executivo extrajudicial e em alguns casos o juiz sequer faz menção aos laudos e exames que se encontram acostados aos autos.

TABELA 2. Julgamento das Varas Mistas de Patos sobre demandas de fornecimento de medicamentos.

JULGAMENTO	QUANTIDADE
Procedência	79
Procedência Parcial	1
Improcedência	1
Extinção por Desistência	1
Total de julgados	82

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Patos.

Os julgados de improcedência, extinção sem resolução de mérito e parcial procedência são estatisticamente irrelevantes, o que demonstra aparente ausência de senso crítico nos julgados no que se refere à análises das alternativas terapêuticas para os casos concretos.

Diante do resultado apresentado, pode-se afirmar que dificilmente o usuário perderá a ação na qual postula dos entes federativos o fornecimento de medicamentos, pois a escassez de elementos técnicos no bojo do processo aliada ao desconhecimento das questões técnicas que envolvem a Assistência Farmacêutica conduz o julgador a dar procedência indiscriminada aos pedidos desta natureza.

O estudo das decisões judiciais revelou que em alguns casos há o desconhecimento do julgador sobre a legislação estruturante do Sistema Único de Saúde, não sendo citado artigos ou princípios que regem a normativa afeta ao Direito Sanitário.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu arcabouço inovações relacionadas aos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, dentre elas, os direitos fundamentais que historicamente tiveram sua concretização de forma gradual e lenta, em um processo de redemocratização vivido no país, que assegurou aos cidadãos a expectativa de direitos para garantia de uma existência com dignidade e liberdade.

Para Bobbio (2), os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas pela conquista de novas liberdades e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.

Assim, cabe aqui salientar que dentre os direitos e garantias fundamentais encontram-se os direitos sociais dos cidadãos brasileiros assegurados no art. 6º, tais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Observa-se que a saúde está arrolada como um dos principais direitos sociais (3).

No que se refere ao direito à saúde pública, a Carta Magna cuidou de inaugurar no Título VIII, na seção II, dispositivos constitucionais que tratam deste assunto específico, onde consta o conhecido art. 196 que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (3).

Ocorre que a incompreensão do sistema por diversos 'atores' sobre a normatização da política pública de saúde, tem proporcionado uma excessiva e desenfreada busca do Judiciário para resolução das questões relacionadas às ações e serviços de saúde. Em sua grande maioria o Poder Judiciário é instado a prestar a tutela jurisdicional individual para assegurar direito social concernente à saúde pública objetivando o forneci-

mento de medicamentos, consultas, exames, cirurgias, entre outros, desvinculando-se do alcance universal que deveria orientar tal política.

É notório que o protagonismo do Poder Judiciário vem ganhando destaque nos últimos anos dado o crescente aumento de novas ações, sendo que o juiz, uma vez provocado, não pode se furtar de dizer o direito. No entanto, como o Direito Sanitário não está na grade de formação do magistrado e demais operadores do direito, é comum ver exaradas decisões ao arrepio da legislação federal e normas que regem o sistema público de saúde.

A ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde tem trazido incontáveis transtornos aos gestores, que são obrigados a mudarem o planejamento que visava a coletividade para atender demandas individuais.

O cenário da judicialização das políticas públicas de saúde tem fomentado o diálogo interinstitucional dos entes envolvidos no fenômeno e exigido a indispensável criação de estratégias para enfrentamento do crescente aumento de demandas judiciais sobre a matéria.

Com o aumento intenso dos processos de judicialização, em 2009 iniciaram-se os primeiros ‘movimentos’ com objetivo de subsidiar magistrados em ações judiciais na área de saúde, assunto que foi pauta da Audiência Pública n.º 4 promovida pelo Supremo Tribunal Federal e realizada ainda no ano de 2009.

O primeiro Tribunal de Justiça a idealizar um Núcleo de Assessoria Técnica foi o do Estado do Rio Janeiro, iniciativa que, em razão dos resultados satisfatórios, impulsionou o Conselho Nacional de Justiça a expedir a Recomendação n.º 31/2010, tendo como base a Audiência Pública n.º 04/2009.

A Recomendação n.º 31 do CNJ, recomenda aos Tribunais em geral a adoção de medidas que visem melhor subsidiar os magistrados e demais atores que atuam no âmbito da judicialização da saúde, para assegurar maior eficiência para solução dos conflitos que envolvam tal matéria. No mesmo ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça expediu uma nova resolução, a Resolução n.º 107 de 06/04/2010, que instituiu o Fórum

Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde (4).

Seguindo seu intuito de melhor orientar os atores que atuam junto às demandas judiciais da saúde, no ano de 2013 o CNJ emitiu a Recomendação n.º 43 que, por sua vez, recomenda aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam a especialização de Varas para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde pública e para priorizar o julgamento dos processos relativos à saúde suplementar.

Em 2016, foi finalmente, expedida a Resolução n.º 238 de 06/09/2016, que recomendou a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde cuja atribuição principal, dentre outras, está a de auxiliar na criação de Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) (5).

A Assessoria prestada pelos Núcleos de Assessorias Técnicas ocorre por meio da elaboração de pareceres técnico-normativos para análise de pedidos de liminar e tutela provisória nas ações que tenham por objeto o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos, insumos para saúde, insumos nutricionais, tratamentos médicos, procedimentos médicos. Tais núcleos utilizam, em sua grande maioria, equipes interdisciplinares compostas por farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, e outros profissionais da saúde que buscam oferecer auxílio técnico fundamentado.

Via de regra, a atuação dos Núcleos de Assessoramento Técnico ocorre após o ajuizamento da demanda, já que o solicitante da informação técnica é o magistrado.

Em maio de 2016, o Governo do Estado da Paraíba inaugurou, por meio da sua Secretaria de Estado da Saúde, o Núcleo de Apoio à Judicialização da Saúde (NAJUS), para dinamizar o trâmite das ações judiciais que envolvem Políticas Públicas de Saúde e são propostas contra o Estado (6).

O Município de Patos não instituiu Comitê de Mediação Sanitária ou outro componente destinado a solução administrativa do conflito de saúde, de modo que os usuários, por meio de seus representantes processuais (advogados, defensores públicos e

promotores de justiça), vem acionando indiscriminadamente o Poder Judiciário para alcançar determinada ação ou serviço de saúde.

Em dezembro de 2018, a Secretaria de Saúde de Patos participou do I Seminário Paraibano de Políticas Públicas de Saúde, com a participação do Conselho Nacional de Justiça, para discutir o financiamento da Saúde e a judicialização no estado da Paraíba com atenção à judicialização nos municípios (7). Na oportunidade, os juízes presentes recomendaram a realização de encontros regulares para definir estratégias de enfrentamento da questão. Contudo, após isso não foram encontrados registros de outros encontros ou atividades regulares voltadas para sistematizar o enfrentamento da crescente judicialização das Políticas Públicas de Saúde na localidade.

Com a inauguração do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Paraíba, em 5 de janeiro de 2020, no Município de Patos, a expectativa é que seja estabelecido um novo canal de mediação entre o Poder Público e o usuário do serviço de saúde, ora representado pela Defensoria Pública (8), todavia, por outro lado, caso a linha de atuação do núcleo seja a mesma seguida pela instituição nas outras regiões do país, a tendência é que cresça o número de novas ações sobre saúde pública.

Durante o estudo sobre o Município de Patos-PB constatou que não existem e nem foram implementadas estratégias de enfrentamento à judicialização da saúde, sequer tentativas que objetivem o maior controle e alcance da mitigação de demandas judiciais promovidas para obtenção de ações, serviços, medicamentos e insumos da saúde ou evitar o aumento da quantidade de processos. O município sequer possui dados quantitativos e qualitativos da judicialização, o que demonstra sua fragilidade no enfrentamento do fenômeno.

O Município de Patos não possui Núcleo de Assessoria Técnica do Judiciário, Comitê de Mediação ou setor específico para lidar com as demandas relacionadas à judicialização da saúde, ou seja, não há nenhuma estratégia que vise a redução da judicialização ou qualificação das demandas de saúde.

O cenário moderado da judicialização da saúde em Patos é propício para implantação de uma estratégia voltada e estruturação técnica de uma equipe com aptidão a enfrentar esse fenômeno.

Dada as circunstâncias específicas verificadas no Município de Patos, parece-nos inclusive, que a propositura de estratégias que permeiam implantação de Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) ou Comitê de Medicação Sanitária no município deveria ser precedidas pela orientação e convencimento da gestão local sobre a necessidade de prevenir um aumento crescente das demandas a exemplo do que vem ocorrendo no resto do país.

O Município de Patos ainda não adotou nenhuma medida destinada a obter o panorama da judicialização da saúde em seu território, contribuindo para o ajuizamento de novas ações e prolação de condenações indiscriminadas nas demandas de saúde, talvez um primeiro passo seja a implementação de setor específico e tecnicamente hábil em qualificar os informes/defesas/respostas ao Poder Judiciário, o que consequentemente refletirá na prolação de sentenças e decisões mais alinhadas à legislação estruturante do Sistema Único de Saúde.

A informatização dos processos administrativos também pode contribuir para a estruturação do município, pois assim será possível buscar informações fidedignas e transparentes sobre quais ações e serviços públicos de saúde o autor da ação já foi contemplado, como, por exemplo, quais medicamentos padronizados fornecidos pela Farmácia Municipal já foram utilizados.

No contexto da judicialização em Patos é necessário que o município adote estratégias de prevenção ao fenômeno como, por exemplo, a criação de Núcleo de Assessoramento Técnico vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a qual, por sua vez, poderia firmar termo de cooperação com o Ministério Público Estadual, que é o maior demandante, com o intuito de buscar alternativas dentro das políticas públicas de saúde e, de igual modo, educar o postulante acerca da legislação estruturante do SUS.

Existe uma lacuna que distancia consideravelmente o livre exercício pelo cidadão do direito à saúde dos meios e recursos disponibilizados pelo Estado por meio da gestão pública a quem compete, como dever, a garantia de tal direito.

O fenômeno da judicialização da saúde é considerado como a interferência do Poder Judiciário na administração do governo na gestão da saúde, o que fere a separação dos

poderes, em especial com relação à oferta de ações e serviços, que envolve diversas áreas do conhecimento.

Diante do atual contexto de aumento exponencial de demandas judiciais objetivando a garantia desse direito social fundamental, surge a necessidade de elaboração e implementação de processos estratégicos com a finalidade de qualificar as demandas envolvendo o tema.

A implementação do Comitê de Mediação Sanitária consiste em relevante instrumento cuja finalidade é propor alternativas para casos específicos, principalmente nas hipóteses cuja ação ou serviço postulado não esteja inserido nas políticas públicas de saúde. A atuação do comitê serve de baliza para que os usuários sejam inseridos dentro daquilo que as gestões se propuserem a executar.

O produto principal do Comitê de Medicação Sanitária é propor alternativas inseridas nas políticas públicas de saúde, mas também tem o caráter educativo na medida em que orienta o usuário sobre os protocolos e diretrizes de casos específicos.

Em muitos casos, a exemplo do acima referido, entendemos que a atuação de um Comitê de Mediação Sanitária poderia orientar o usuário a respeito da competência sobre a prestação daquele serviço de saúde ou, numa medida propositiva, os membros do comitê poderiam articular o fornecimento administrativo juntamente com o Estado. Esse modelo de atuação demonstra a necessidade do comitê ser composto por representantes dos entes municipal e estadual, sob pena ser caracterizado como baixa resolutividade ou de arcar com os custos de outrem.

No particular dos medicamentos judicializados, há que se ponderar a possibilidade do médico prescritor, uma vez provocado pelo Comitê, prescrever fármacos substitutos padronizados ou tratamentos protocolares em consonância com o Decreto n.º 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que instituiu os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o SUS (9).

Estas questões deveriam ser tratadas em caráter administrativo por meio de intervenção mediadora entre os entes (municipal e estadual), além das demais instituições que atuam como atores importantes na questão da judicialização da saúde (Defensoria,

Ministério Público, etc.), objetivando identificar a competência para atendimento da demanda pela via extrajudicial.

Assim, visando minimizar a lacuna e apresentar alternativa a demandas judiciais a serem propostas para garantia do direito à saúde, projetos de criação de Comitês de Mediação Sanitária vêm apresentando resultados até então positivos, por intermédio da atuação interinstitucional para resolução administrativa de conflitos versados em saúde, a exemplo dos constituídos pelo Ministério Público de Minas Gerais, no Distrito Federal, a Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde (CAMEDIS) e Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), no Rio Grande do Norte.

Se os modelos mais usuais e incentivados pelo próprio Poder Judiciário brasileiro não servirem para espelhar ou inspirar o alinhamento dos atores envolvidos na judicialização da saúde em Patos, há potencial risco do crescimento da judicialização da saúde.

Os dados levantados demonstram que a judicialização da saúde em Patos é moderada, cenário que, de outra sorte, favorece o crescimento do fenômeno naquela comarca, sobretudo diante da postura de negligenciar no planejamento do enfrentamento da questão, que agora ganha um agravante, a atuação da Defensoria Pública na cidade.

Outros meios de solução de conflitos que se pode citar são: conciliação, mediação, arbitragem, autocomposição e implantação de processo eletrônico.

Diferentemente do processo judicial, que tende a ser burocrático e moroso, além de demandar altos custos, o bom uso dos meios de solução de conflito tais quais os citados acima, podem ser práticos, ágeis e com impacto nos recursos financeiros menor que o decorrente de ações judicializadas.

A solução de conflitos por via extrajudicial, além de diminuir a judicialização, pode beneficiar todas as partes de forma muito mais rápida e satisfatória.

Considerações Finais

A ausência de gestão dos dados relacionados à judicialização no Município de Patos não possibilitou a compreensão precisa e integral de como as questões relacionadas ao direito à saúde têm sido levadas ao Poder Judiciário local, tendo o presente projeto se limitado à análise das demandas relacionadas ao fornecimento de medicamento e nas quais município e estado ocupam o polo passivo.

As dificuldades encontradas para robustecer o presente projeto demonstram a imprescindível necessidade do Município de Patos se organizar, no sentido de monitorar e avaliar o fenômeno da judicialização das políticas públicas, já que atualmente inexiste no organograma do município repartição responsável pela interlocução com os atores envolvidos no fenômeno, como o Poder Judiciário, Ministério Público e Procuradoria do Município.

A criação do Setor de Judicialização é uma indispensável ferramenta na qualificação das demandas judiciais de saúde pública, na medida em que atua no controle quantitativo e qualitativo das ações judiciais desta área e auxilia o gestor municipal do SUS nas respostas aos órgãos externos, além de monitorar e avaliar o fenômeno jurídico-social.

Por meio desse Setor, o Município de Patos poderia dimensionar os principais casos de saúde pública que são judicializados, avaliar a qualidade das decisões judiciais, definir o modus operandi da Promotoria de Justiça, compreender o perfil dos usuários que buscam acesso ao SUS por meio do Poder Judiciário, além de outra série de elementos que podem contribuir nas pautas de políticas públicas de saúde.

Com a criação do Setor de Judicialização, o Município de Patos poderá controlar os prazos judiciais para cumprimento das decisões, qualificar as respostas prestadas ao Poder Judiciário à luz da legislação estruturante do SUS e prestar subsídios contínuos à Procuradoria do Município para a defesa em juízo.

Como instrumento de diagnóstico o Setor de Judicialização poderá criar planilha ou ferramenta equivalente que informe o nome do usuário ou autor da ação, pedido, doença, origem da prescrição, representante processual, unidade judiciária, conteúdo da decisão e o julgamento da ação.

Na medida em que essa repartição consolide sua atuação com o registro dos dados e acompanhamento dos casos, será possível avaliar e criar novas estratégias que atendam à realidade peculiar do município.

Além disso, a atuação do Setor de Judicialização compreende a abordagem aos autores envolvidos na judicialização, como diálogo permanente com os magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, procuradores e, inclusive, com a Secretaria de Estado da Saúde.

Outra forma de controlar os dados da judicialização é a implantação de processo administrativo eletrônico (PAE) pelo Município, por meio do qual será possível obter relatórios específicos sobre o tema.

O uso do PAE é importante também para registrar as demandas administrativas, como, por exemplo, para fornecimento de medicamento seria necessária a abertura de um processo administrativo por meio do qual se avaliaria a possibilidade de atendimento e, caso possível, posteriormente ali seriam registradas todas as dispensações realizadas.

Com isso, em eventual ação judicial onde o autor postula fornecimento de medicamento não padronizado, seria possível identificar se em algum momento o usuário já procurou a Farmácia Municipal para utilizar os medicamentos disponíveis na rede pública para o tratamento de determinada patologia e caso negativo seria possível derubar a alegação de que já utilizou sem sucesso as alternativas do SUS.

Dentro do contexto da judicialização da saúde no Município de Patos não se pode imaginar, num primeiro momento, a criação de Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) ou Câmara de Mediação Sanitária sem que antes seja criado o Setor de Judicialização, já que é preciso partir da premissa de que a Secretaria Municipal de Saúde precisa primeiramente dimensionar as demandas judiciais de saúde em termos quantitativo e qualitativo e monitorar a atuação dos atores (juiz, promotores, advogado, defensores e procuradores) para, posteriormente, avaliar a viabilidade dessas ferramentas estratégicas.

A adoção de medidas preventivas à judicialização consiste em valiosa ferramenta para o enfrentamento da cultura do ajuizamento de ações relacionadas ao direito à saúde, todavia, como já registrado no presente estudo, sua implementação passa necessariamente pela estruturação de outros componentes e organização do fluxo interno.

O principal objetivo da Câmara de Mediação Sanitária consiste em propor alternativas de resolução de conflitos no âmbito do SUS em casos que potencialmente poderão ser judicializados, evitando a abertura de processos judiciais de caráter contencioso (10).

Se o Município de Patos obtiver condições de definir o perfil das demandas judiciais de saúde seria possível a criação de uma Câmara de Mediação Sanitária que conduziria o usuário a buscar as alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento de sua doença, o que consequentemente contribuiria para a otimização das políticas públicas de saúde pelo gestor municipal.

A sistemática a ser adotada poderia ser semelhante àquela aplicada pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal que busca melhoria na prestação do serviço ao indivíduo que necessita do SUS e ainda não acionou o Poder Judiciário, orientando o usuário a buscar os serviços que são padronizados (11).

A Câmara de Mediação Sanitária enquanto vinculada ao Município poderia ainda oferecer suporte ao Ministério Público – representante processual que mais ajuíza ações sobre direito à saúde em Patos – para racionalizar o acesso à saúde àquele que buscasse assistência fora do Sistema Único de Saúde.

Referências

- 1 - CNJ. **Demandas judiciais relativas à saúde crescem 130% em dez anos** - Portal CNJ [Internet]. São Paulo; 2019 [acessado em: 2019 Out 31]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem-130-em-dez-anos/>>.
- 2 - Bobbio N. **A Era dos Direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004
- 3 - Brasil. **Constituição Federal** [Internet]. Brasília, Brasil; 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
- 4 - CNJ. **Resolução no 107. Brasília; 2010**. Institui o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde.
- 5 - CNJ. **Resolução no 238**. Conselho Nacional de Justiça, editor. Brasília; 2016. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública.
- 6 - ClickPB. **Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde é inaugurado na Paraíba** [Internet]. 2016 [acessado em: 2020 Feb 14]. Disponível em: <<https://www.clickpb.com.br/saude/nucleo-de-atendimento-judicializacao-da-saude-e-inaugurado-na-paraiba-205003.html>>.
- 7 - Prefeitura Municipal de Patos - Coordcom. **Secretário Davi Nunes discute judicialização da saúde durante seminário em João Pessoa** [Internet]. Portal de Notícias. 2018 [acessado em: 2020 Feb 14]. Disponível em: <<http://patos.pb.gov.br/noticias/secretario-davi-nunes-a9147.html>>.
- 8 - Ascom-DPPB. **Defensoria Pública do Estado da Paraíba** [Internet]. Observatório Interinstitucional de violências por intolerância. 2020 [acessado em: 2020 Feb 11]. Disponível em: <<https://defensoria.pb.def.br/noticias.php?idcat=1&id=1409>>.
- 9 - Casa Civil da Presidência da República. **Decreto no 7.646** [Internet]. Brasília, DF: Presidência da República; 2011. Dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7646.htm>.

10 - Delduque MC, Castro EV de. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil.** Saúde em Debate. 2015;39(105):506–13

11 - Patrícia Paim, Alessandra Marqueto, Lopes I de O de O. **Câmara permanente distrital de mediação em saúde: experiência do Distrito Federal.** CONASS Para entender a Gestão do SUS [Internet]. 2015;1:534. Disponível em: <<http://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=253>>.



Projeto de intervenção para enfrentamento da judicialização da saúde no Município de Recife-PE: Diagnóstico situacional e novas estratégias

Andrei Popovski Kolaceke¹

Carmem Sílvia Guariente²

Diogo Rogers Pantoja Ferreira³

Fabiana Francisca Tavares Bezerra⁴

Leonardo Campos Simões⁵

Luciana Lima Pinheiro Caúla Reis⁶

Rondinelly da Silva e Souza⁷

Veruska Queiroz de Castro⁸

Orientador: Prof. MSc Moacyr Rey Filho

O Município de Recife-PE foi escolhido para o estudo porque é uma cidade de grande porte, com disponibilidade de dados confiáveis para a realização de análises e pro-

¹ Graduado em Direito pela UNIVILLE. Gerente de Processos da Secretaria Municipal de Joinville-SC.

² Graduada em Enfermagem pela EEUSP. Secretária Municipal de Saúde de Araçatuba-SP e Segunda Vice-Presidente do COSEMS-SP.

³ Graduado em Direito pela Faculdade Estácio FAMAP, pós-graduando em Direito Público pela ESP-AP. Assessor Jurídico do COSEMS-AP.

⁴ Graduada em Direito pela UFRN, pós-graduada em Ministério Público, Direito e Cidadania pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Membro da Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual de Saúde do RN.

⁵ Graduado em Direito pela UVV, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo. Assessor Jurídico no município de Colatina-ES.

⁶ Graduada em Direito pela Universo, pós-graduada em Direito civil e Processo civil pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Diretora Executiva de Assuntos Jurídicos da SMS de Recife-PE.

⁷ Graduado em Administração Pública pelo CEULP/ULBRA. Secretário Municipal de Saúde de Caseara-TO e Diretor Financeiro do COSEMS-TO.

⁸ Graduada em Odontologia pela UFC, mestre em Tecnologias Minimamente Invasivas em Saúde pelo Centro Universitário Unichristus, em Fortaleza. Assessora Técnica do NAIS, da SMS de Fortaleza-CE.

posição de medidas interventivas. Além disso, Recife vem enfrentando diversos problemas decorrentes da judicialização da saúde, uma vez que sua região de saúde concentra 42% das ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, propostas em todo o estado de Pernambuco (1).

Diante de tal cenário, definiu-se como objetivo do trabalho a realização de um diagnóstico situacional de Recife, envolvendo informações específicas sobre a judicialização da saúde e aspectos territoriais, ambientais, socioeconômicos e históricos, para a posterior proposição, com base nos dados levantados, de medidas para a redução e enfrentamento da judicialização no referido município.

Metodologicamente, foi realizada a pesquisa das informações relacionadas ao município, com dados referentes à população, território, histórico, clima e economia. Tais dados foram coletados a partir da *internet*, por meio de acesso aos *sites* oficiais da Prefeitura do Recife, do Conselho Municipal de Saúde do Recife e de consulta a relatórios publicados por outras instituições públicas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os materiais obtidos foram lidos na íntegra pelos autores, que resumiram as informações e selecionaram os dados relevantes para o desenvolvimento do trabalho.

Em seguida, procedeu-se ao levantamento dos dados referentes à judicialização da saúde. Para o levantamento desses dados, foram utilizados como fonte principal de informação os relatórios gerados pela Prefeitura Municipal de Recife por meio do sistema informatizado utilizado para o controle e monitoramento de ações judiciais, denominado Sistema de Automação da Justiça (SAJ). O referido sistema, utilizado pela Procuradoria Geral do Município de Recife, é integrado ao Processo Judicial Eletrônico, utilizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o que possibilita a troca de informações de processos judiciais entre as aludidas instituições (2). O levantamento limitou-se às ações judiciais que pleiteavam a disponibilização de produtos e serviços de saúde, propostas em desfavor do Município do Recife, em 2018.

Para a obtenção das informações referentes às ações judiciais, foi utilizada a funcionalidade de relatório de processos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), em sua versão 1.2, tendo sido aplicados os filtros “saúde”, “medicamentos” e “tratamento”, com

a seleção do período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018. As informações obtidas foram exportadas em planilha eletrônica em formato “xlsx”, gerada em 12 de dezembro de 2019, que continha, para cada ação judicial, os seguintes dados: o nome do produto ou serviço pleiteado, o representante do autor/paciente, os entes públicos incluídos no polo passivo e o resultado (procedência ou improcedência) do pedido.

A partir da análise dos dados, o grupo propôs uma forma de enfrentamento da judicialização consubstanciada na adoção, pelo Município estudado, de técnicas de mediação e procedimentos de resolução administrativa de litígios.

Diagnóstico da judicialização no município

Em conformidade com os dados levantados por meio do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), foi registrado um significativo número de ações judiciais de saúde propostas em face do município em questão, ao longo do ano de 2018. No ano de 2016, a Região de Saúde do Recife já concentrava 42% de todas as ações judiciais de medicamentos do Estado de Pernambuco (1).

De todo modo, o levantamento e a adequada compreensão dos dados referentes à judicialização da saúde no Município de Recife são indispensáveis para a proposição de melhorias que visem ao controle e à redução do número de demandas judiciais na área da saúde pública.

Durante o ano de 2018, foram registradas 165 ações judiciais na área da saúde nas quais o Município de Recife figurou no polo passivo, propostas perante a Justiça Estadual e a Justiça Federal. De tais processos, 84 tramitavam na Justiça Federal, em que o Município do Recife figurava no polo passivo em litisconsórcio com a União, e 81 tramitavam na Justiça Estadual, nos quais o município era o único réu ou estava em litisconsórcio com o Estado de Pernambuco.

Os referidos dados indicam que a União figurava no polo passivo em metade das ações que pleiteavam o fornecimento de produtos e serviços de saúde em Recife, o que pode indicar que a judicialização da saúde na referida cidade onerava desproporcio-

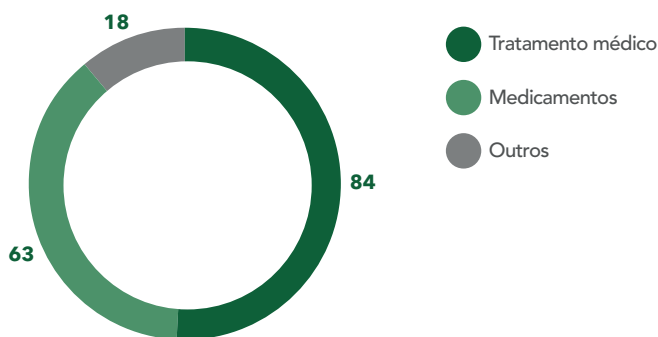
nalmente os entes municipal e estadual, que integravam sozinhos o polo passivo de aproximadamente 50% de todas as ações de saúde propostas em 2018.

Os requerimentos formulados nas ações judiciais de saúde propostas em face da municipalidade foram muito diversificados durante o ano de 2018, abrangendo o fornecimento de produtos e a prestação de serviços de saúde.

Das 165 ações judiciais computadas no período, 84 (50,9% do total) correspondiam ao assunto “tratamento médico”, ao passo que 63 processos (38,2% do total) eram sobre fornecimento de medicamentos. Juntas, as duas categorias correspondem a aproximadamente 90% do total de demandas judiciais de saúde.

No mesmo período, foram também registradas 5 ações referentes a “atendimento médico”, 4 ações referentes à internação, 3 ações que pleiteavam o fornecimento de próteses, 3 processos cujo assunto foi registrado como “equipamento e material de saúde”, 2 processos relacionados a atendimento profissional interdisciplinar e 1 processo que objetivava a realização de exames, conforme representado na Figura 1.

FIGURA 1. Assuntos das ações de saúde propostas contra o Município de Recife em 2018.



Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos relatórios gerados pela Prefeitura do Recife por meio do SAJ.

Verifica-se, assim, que no ano de 2018 predominavam as ações judiciais que pleiteavam medicamentos e tratamento médico, o que permite concluir que o caráter das demandas de saúde judicializadas no Recife no período analisado era predominan-

temente assistencial. Tais dados também podem refletir deficiências na rede de assistência à saúde, uma vez que a população local frequentemente recorria ao Poder Judiciário para garantir a obtenção e a continuidade de seus tratamentos.

O perfil assistencial das demandas judiciais registradas pelo Município de Recife é similar ao verificado em todo o Estado de Pernambuco durante o ano de 2016. À época, apurou-se que aproximadamente 65,5% das ações judiciais de saúde propostas contra o Estado de Pernambuco eram referentes ao fornecimento de medicamentos e 8,1% eram referentes à disponibilização de vagas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (1).

A análise das informações, entretanto, resta parcialmente prejudicada em razão da abrangência e da imprecisão das informações disponibilizadas pelo Município e dos assuntos vinculados aos processos, que impossibilitam a obtenção de dados mais precisos acerca dos objetos das ações. A ausência de maiores informações sobre o objeto das ações inviabiliza, sobretudo, a apuração da quantidade de ações judiciais que versam sobre tecnologias já incorporadas ao Sistema Único de Saúde, dado que é de fundamental importância para avaliar se a judicialização decorre da execução insuficiente ou ineficaz das políticas públicas de saúde já instituídas.

No período de 2018, em um total de 31 das 165 ações de saúde propostas contra o Município de Recife o autor/paciente foi representado pela Defensoria Pública da União. Em outros 27 processos, a representação judicial se deu por advogado particular. Por fim, em apenas um processo figurava como autor o Ministério Público Federal. A respeito dos demais processos, não estavam disponíveis, na planilha eletrônica obtida junto à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer informações referentes à representação do autor/paciente

A escassez de informações referentes à representação do autor/paciente em grande parte das ações judiciais é preocupante, uma vez que se trata de dado indispensável à compreensão do cenário da judicialização no Município e à consequente definição de estratégias de enfrentamento.

De todo modo, as informações disponíveis permitem concluir que há expressiva participação da Defensoria Pública no total de ações de saúde propostas contra o Município, o que pode indicar que a população hipossuficiente, usuária dos serviços prestados pela Defensoria Pública, é responsável pela propositura de grande parte das ações judiciais de saúde registradas no período analisado.

Entre as 183 ações de saúde propostas contra o Município de Recife no ano de 2018, em 162 (89% do total) o juízo competente já havia proferido decisão. Em 37 processos (20% do total), foi proferida decisão favorável ao município. As decisões desfavoráveis ao município prevaleceram no período, uma vez que em 105 processos (57% do total) foram proferidas decisões totalmente desfavoráveis e em, 20 processos (11% do total) as decisões proferidas foram parcialmente desfavoráveis ao referido ente público.

Fundamentando-se em tais dados, atesta-se que, no período analisado, a probabilidade de êxito total ou parcial do autor/paciente correspondeu a quase 80%, o que certamente estimulou a propositura de novas ações judiciais. A referida informação também pode indicar a necessidade de uma maior aproximação dos órgãos de saúde com o Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito à colaboração técnica, a fim de possibilitar uma atuação mais criteriosa e qualificada dos magistrados na análise das demandas de saúde.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

No ano de 2017, em atendimento ao disposto na Resolução n.º 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (3), o Tribunal de Justiça de Pernambuco, criou, por meio do Ato n.º 717/2017 (4), o Comitê Estadual de Saúde de Pernambuco, ao qual competia o fomento de acordos e a elaboração de pareceres em processos que requerem o custeio de medicamentos e tratamentos de saúde (5).

As atribuições do referido Comitê foram definidas pela Portaria n.º 5, de 29 de janeiro de 2018, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos seguintes termos:

Art. 2º Compete ao Comitê, dentre outras atividades necessárias a qualificação, monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde:

I. Solicitar informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho aos órgãos públicos e entidades privadas envolvidas na prestação de serviços de saúde;

Solicitar parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico ao judiciário (NATs), quando necessário;

II. Analisar as questões que lhe forem postas com subsídio, quando possível, na Medicina Baseada em Evidências, a fim de que os debates sejam imparciais e qualificados;

III. Emitir enunciados, com deliberação e anuência da maioria dos membros presentes, com o objetivo de orientar a atuação do poder judiciário, assim como dos órgãos integrantes deste comitê, qualificando, assim, as demandas de assistência à saúde;

IV. Emitir recomendações, com deliberação e anuência da maioria dos membros presentes, com o objetivo de uniformizar procedimentos a serem realizados por médicos e operadores do Direito, de modo a otimizar a assistência à saúde, garantir a organização do Sistema Único de Saúde e, principalmente, permitir que as políticas públicas sejam desenvolvidas de modo isonômico para todos aqueles que buscam o tratamento por intermédio do SUS (6).

O Comitê Estadual de Saúde de Pernambuco foi ampliado pela Portaria n.º 17, de 22 de março de 2018, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (7). Segundo o referido ato normativo, o Comitê é composto por um membro do Poder Judiciário Estadual, que exerce a função de presidente; um membro do Poder Judiciário Estadual com atuação em vara da fazenda pública; um membro do Poder Judiciário Federal; um membro do Ministério Público Estadual; um membro do Ministério Público Federal; um membro da Procuradoria-Geral do Estado; um membro da Advocacia-Geral da União; um membro da OAB; um membro da Defensoria Pública da União; um membro da Defensoria Pública Estadual; um membro da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; um membro da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PE); um membro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco; um membro do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco; e um membro do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco (7).

Entretanto, nos termos do § 2º do art. 1º da Portaria n.º 17, de 22 de março de 2018, o rol de integrantes do Comitê não é taxativo, sendo admitido o ingresso de novos integrantes mediante decisão do Presidente com anuência dos demais membros (7).

O Município do Recife participa do Comitê desde o ano de 2017, por meio de representante da Secretaria Municipal de Saúde (4). Tal participação pode ser considerada benéfica ao Município, uma vez que garante que o ente municipal seja ouvido no processo de formulação de enunciados e recomendações voltados à orientação dos magistrados de todo o Estado de Pernambuco.

Uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco resultou, em 2012, na criação do Núcleo de Assistência Técnica em Saúde (NAT-JUS), unidade responsável por “promover a elucidação das demandas oriundas de processos judiciais que envolvem questões de saúde pública, funcionando como uma ferramenta de apoio aos magistrados, para permitir maior esclarecimento a respeito do tema” (8).

Composto por um médico ortopedista e quatro farmacêuticos, o núcleo foi colocado à disposição dos juízes das varas da fazenda pública para prestar assistência imediata nos processos que envolvem solicitações de medicamentos (9).

A referida iniciativa, ao viabilizar uma melhor análise, subsidiada por uma equipe técnica, das ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos (8), pode beneficiar, por meio de uma atuação mais qualificada do Poder Judiciário na área da saúde, os entes públicos que comumente figuram no polo passivo de tais ações, tais como o Município do Recife.

Cumprindo ainda salientar que a iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco no sentido de aderir à Resolução n.º 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (3) e adotar um Comitê de Saúde foi acertada, uma vez que certamente fortaleceu os diálogos institucionais e abriu espaço para o debate de soluções intersetoriais para a judicialização da saúde e os problemas dela decorrentes. A estruturação do Comitê também contribuiu para tornar a atuação dos magistrados mais qualificada nas demandas de saúde, por meio da elaboração e divulgação de enunciados, recomendações e demais orientações.

Entretanto, chama a atenção o fato de não haver nenhum representante do Conselho Estadual de Saúde no referido comitê.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 198 (10), consagrou a participação da comunidade como diretriz do Sistema Único de Saúde. Valendo-se de tal disposição constitucional, os conselhos de saúde – estruturados nas esferas municipal, estadual e federal – foram incumbidos da representação dos segmentos mais relevantes no cotidiano da saúde pública: usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e governo.

Os conselhos de saúde são, portanto, os órgãos colegiados com maior legitimidade para a discussão de questões relacionadas à saúde pública, inclusive no que diz respeito à judicialização da saúde e às diversas questões a ela relacionadas, e de forma alguma poderiam ser excluídos de um espaço de debate tão importante quanto o Comitê de Saúde de Pernambuco.

Além disso, a despeito da previsão contida no art. 14-B, §2º, da Lei n.º 8.080/1990 (11), que reconhece os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) como representantes dos entes municipais no âmbito estadual, também não há, no referido comitê, qualquer representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) de Pernambuco, o que certamente prejudica a representatividade dos municípios pernambucanos no órgão e representa a perda de uma importante contribuição nas discussões por ele desenvolvidas.

É recomendável, assim, a revisão da Portaria n.º 17/2018 do Tribunal de Justiça de Pernambuco (7) para possibilitar a inclusão do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde entre os membros permanentes do Comitê de Saúde de Pernambuco.

Ademais, a partir do levantamento das iniciativas e processos estratégicos que visam a redução e o controle da judicialização da saúde no Município de Recife, verificou-se que, até o presente momento, não foi implantado no âmbito municipal qualquer projeto que tenha o objetivo de prevenir ou resolver administrativamente litígios na saúde pública, muito embora haja previsão específica para tanto na Lei n.º 13.140/2015 (12).

Assim, para diversificar os instrumentos de controle e prevenção da judicialização e para ampliar sua eficácia, sugere-se ao Município de Recife que implante uma Câmara de Mediação, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n.º 13.140/2015 (12), considerando as especificidades e os indicadores epidemiológicos e socioeconômicos locais, bem como o perfil das demandas judiciais mais comuns na área da saúde.

O desenvolvimento de medidas eficazes para a prevenção e o enfrentamento da judicialização da saúde requer, inicialmente, o delineamento de um perfil detalhado das ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de produtos e serviços de saúde, compreendendo, além do número de ações recebidas a cada ano, informações precisas acerca dos produtos e serviços pleiteados, as patologias que originaram os pedidos, as especialidades, locais de atuação e possível vinculação ao SUS dos prescritores, a representação judicial dos autores, entre outros dados (13).

De acordo com as informações judiciais levantadas junto à Secretaria Municipal de Saúde de Recife, a classificação dos itens pleiteados nas ações judiciais recebidas pelo município se dá por meio de denominações genéricas, como “tratamento médico” ou “medicamento”, ou seja, o referido órgão municipal não dispõe de informações referentes ao número de ações cujo objeto seja um determinado medicamento, procedimento insumo, material etc.

Além disso, a Secretaria não levanta e acompanha dados acerca da representação do autor/paciente na maior parte das ações judiciais propostas em face do município, nem tampouco dispõe de dados estatísticos acerca das enfermidades e dos prescritores envolvidos nos processos.

Por tais motivos, como medida inicial e norteadora das próximas ações, é recomendável que o Município de Recife aprimore o diagnóstico situacional da judicialização da saúde, levantando maiores informações sobre os processos cadastrados. Para tanto, sugere-se que seja adotado, no cadastramento, a classificação das ações judiciais exemplificadas no Quadro 1 abaixo:

QUADRO 1. Quadro com exemplo de planilha para cadastramento de ação judicial.

NÚMERO DOS AUTOS	AUTOR	REPRESENTAÇÃO	TIPO DE PEDIDO	OBJETO	VINCULAÇÃO DO PRESCRITOR	ESPECIALIDADE DO PRESCRITOR
123456-2020	João da Silva	Defensoria Pública da União	Produto	Medicamento Rivaroxabana	Particular	Cardiologia
567890-2020	Maria da Costa	Advogado particular	Serviço	Equoterapia	SUS	Fisiatria

Fonte: Elaboração própria.

A partir da realização das adequações propostas, é esperada uma maior compreensão (qualitativa e quantitativa) das demandas que resultam na judicialização, o que possibilitará a eleição de prioridades e a definição de estratégias eficazes de enfrentamento e prevenção.

Nesse contexto, a adoção de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos pode contribuir significativamente para redução da judicialização, uma vez que oportuniza a composição extrajudicial dos litígios que envolvem a Administração Pública e os pacientes que demandam atendimentos perante o Sistema Único de Saúde.

É por esse motivo que o Conselho Nacional de Justiça tem sustentado que os entes públicos “devem investir na criação de órgãos ou processos extrajudiciais de solução de conflitos sobre saúde, aptos a receberem as demandas por produtos e serviços que não estão previstos para serem fornecidos pelo SUS e analisarem essas demandas em etapa prévia à judicialização” (14). As vantagens proporcionadas por tais medidas são diversas, conforme segue:

Se as demandas forem previamente analisadas pelo órgão administrativo, elas podem ou ser solucionadas nesta via, o que já seria positivo, ou, não ocorrendo assim, e na hipótese de haver a judicialização do conflito, quando os processos judiciais forem impetrados serão instruídos com documentos mais robustos que analisarão a real necessidade daquele produto ou serviço pelo paciente e, também, a pertinência ou não de seu fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, considerando os critérios de custo e eficácia terapêutica. É importante ressaltar que essa política já vem sendo executada em alguns estados, como relatado nos estudos de caso desenvolvidos nesta pesquisa.

Nos locais, onde isso já ocorre, muitas vezes o processo judicial é evitado, porque as partes encontram soluções alternativas do conflito, seja pelo fornecimento do que é requerido, seja pelo fornecimento da alternativa terapêutica já disponível no sistema (14).

Entre as diversas técnicas de resolução extrajudicial de conflitos existentes, a mediação sanitária tem recebido destaque na doutrina especializada em judicialização da saúde, uma vez que se trata de um método eficaz na pacificação e administração dos conflitos sanitários. Acerca do tema:

Aproveitando esse momento em que os métodos consensuais ganham destaque na legislação brasileira, no âmbito do direito à saúde, o instituto da mediação pode se revelar uma alternativa eficiente ao excessivo número de demandas judiciais enfrentadas diariamente pelos tribunais. É consenso entre os estudiosos e juristas que é necessária a adoção de uma nova prática e uma nova cultura no âmbito do SUS, despontando a mediação sanitária como uma forma de se aplicar essa nova perspectiva acerca das demandas de saúde (15).

Para a aplicação e execução dos procedimentos de mediação na área da saúde, pertinente é a criação de Câmaras de Conciliação e Mediação, ambiente democrático e de debate sobre as demandas apresentadas pelos cidadãos que necessitam de acesso gratuito a produtos e serviços de saúde. Para que sejam atingidos os objetivos esperados, é imprescindível que as Câmaras de Conciliação e Mediação atuem de forma célere e desburocratizada, oportunizando a manifestação dos diversos interessados na solução consensual do problema, de forma que a composição dos interesses seja obtida em um prazo razoável.

Para que o potencial de resolução de conflitos das Câmaras seja ampliado, é desejável que os debates por elas promovidos envolvam a participação de representantes do Poder Judiciário, ministérios públicos, defensorias públicas, secretarias de saúde, da advocacia pública, de conselhos de classe e de conselhos de saúde. Igualmente importante é que as decisões sejam tomadas baseando-se em subsídios e pareceres produzidos por equipes técnicas multiprofissionais, compostas por integrantes de diversas categorias da área da saúde.

Registra-se, ainda, que as Câmaras podem assumir um papel relevante na resolução administrativa das situações corriqueiras levadas ao conhecimento do colegiado e na orientação aos órgãos da Administração na atuação em demandas sanitárias.

No caso específico de Recife, a criação de uma Câmara de Conciliação e Mediação é recomendável, uma vez que o município tem registrado um elevado número de ações judiciais de saúde. No entanto, conforme já apontado, o aprimoramento do diagnóstico situacional da judicialização da saúde no município é necessário para uma melhor definição da composição e do funcionamento da Câmara e para um melhor direcionamento de sua atuação.

De todo modo, caso a criação de uma Câmara de Conciliação e Mediação não seja considerada viável pelo gestor municipal, pode ser avaliada a alternativa de se instituir oficialmente, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, um núcleo interno cuja atuação seja voltada à resolução administrativa das demandas apresentadas pela população usuária do Sistema Único de Saúde, providência que exigiria um investimento menor e que contaria com procedimento simplificado.

Para tanto, pode ser utilizada como exemplo a experiência do Município de Fortaleza, que apresenta porte semelhante e está localizado na mesma região do Brasil. Desde 2016, o Município de Fortaleza conta com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), criado a partir de uma parceria firmada entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, por meio do qual têm sido obtidos bons resultados no atendimento administrativo das demandas de saúde (16).

No procedimento implantado em Fortaleza, o atendimento é iniciado pela Defensoria, por meio do Núcleo de Defesa da Saúde (NUDESA), em que é gerada uma demanda. Após esta fase, a solicitação é encaminhada aos setores responsáveis das Secretarias de Saúde, Municipal e/ou Estadual, de acordo com a responsabilidade do ente federado com relação à disponibilização do produto ou serviço pleiteado. Ao receber a demanda, o ente público responsável dispõe de um prazo preestabelecido para promover o atendimento administrativo da solicitação ou comunicar a impossibilidade de resolução do litígio ao órgão solicitante, o qual, ao avaliar a devolutiva da Secretaria de Saúde, decide se ajuíza ou não a ação (16).

As principais vantagens da adoção de um procedimento semelhante ao de Fortaleza são o custo reduzido de implantação; a celeridade de tramitação das solicitações, que são avaliadas por meio de um procedimento simplificado; a aproximação dos gestores de saúde com o órgão de representação judicial dos pacientes; a possibilidade de resolução administrativa das demandas; e, nos casos de insucesso das tentativas de resolução administrativa, a qualificação da atuação dos órgãos do Sistema de Justiça a partir das informações prestadas pela equipe técnica do ente público demandado.

Considerações Finais

O Município de Recife, capital do Estado de Pernambuco, localizado na Região Nordeste do Brasil, conta com uma rica história e belíssimas paisagens naturais, sendo considerado uma verdadeira metrópole, desenvolvida em termos econômicos e de desenvolvimento humano. Na área da saúde pública, dispõe de uma ampla rede de atendimento, que contempla diversos serviços básicos e especializados.

No entanto, o município tem registrado anualmente um elevado número de ações judiciais cujo objeto é o acesso a produtos e serviços de saúde, o que torna necessária a adoção de providências que permitam a redução e um adequado acompanhamento de tais processos.

Embora algumas iniciativas, como a implantação do Comitê de Saúde do Estado de Pernambuco e do Núcleo de Assistência Técnica em Saúde (NAT-JUS), tenham bene-

ficiado o Município do Recife na área da judicialização da saúde, o número de ações judiciais de saúde propostas contra o ente municipal permanece elevado.

Para solucionar o referido problema, propôs-se o aprimoramento do diagnóstico situacional e da introdução de processos de resolução extrajudicial de conflitos. Tais iniciativas, como já visto, dependem essencialmente da revisão de processos de trabalho e da instituição de rotinas que favoreçam o atendimento administrativo das demandas que comumente resultam na propositura de ações judiciais. Os investimentos necessários para a estruturação dos novos fluxos não são expressivos se comparados às dimensões do Município em questão e de seus serviços de saúde pública.

Entre as medidas propostas, destaca-se a necessidade de obtenção de informações confiáveis e fidedignas acerca da judicialização da saúde no município, o que pressupõe a necessidade de revisão dos procedimentos de registros e de levantamento de dados adotados pela municipalidade. Apenas com base nessa necessária revisão, será possibilitada a eleição de prioridades e a definição de estratégias eficazes na área da judicialização da saúde.

Por fim, reforça-se a necessidade de avaliação periódica das medidas adotadas em seus aspectos qualitativo e quantitativo, a fim de viabilizar a avaliação de sua eficácia, bem como a necessidade de eventuais ajustes e revisões.

Referências

- 1 - Oliveira FHC, Lorena Sobrinho JE, Montarroyos UR, et al. **Judicialização da saúde: uma análise da ação da justiça sob a gestão da saúde no Estado de Pernambuco** [Internet]. Campinas, 2018 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <<https://proceedings.science/ebit/ebit-2017/trabalhos/judicializacao-da-saude%3A-uma>>.
- 2 - Prefeitura do Recife (BR). **PGM homologa projeto de integração do SAJ com o PJe** [Internet]. Recife, 21 fev 2020 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <<https://pgm.recife.pe.gov.br/pgm-homologa-projeto>>.
- 3 - Conselho Nacional de Justiça. **Resolução n.º 238, de 6 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública [Internet]. Brasília, 9 set 2016 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos->>>.
- 4 - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. **Ato n.º 717/2017**. Institui, no âmbito da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o Comitê Estadual de Saúde [Internet]. Recife, 14 jul. 2017 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <<http://www.tjpe.jus.br/documents/1812710/0/-/a23fa42a-b6d5-5159-af1a-04e1de937964>>.
- 5 - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. **Comitê Estadual de Saúde de Pernambuco** [Internet]. Recife, 2018 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpe.jus.br/web/comite-estadual-de-saude/apresentacao>>.
- 6 - _____. **Portaria n.º 05, de 29 de janeiro de 2018**. Dispõe sobre a criação e manutenção pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco do Comitê Estadual da Saúde [Internet]. Recife, 30 jan. 2018 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpe.jus.br/documents/>>>.
- 7 - _____. **Portaria n.º 17, de 22 de março de 2018**. Altera a composição do Comitê Estadual da Saúde estabelecida pela Portaria n.º 05 do TJPE publicada no DJE do dia 29 de janeiro de 2018 [Internet]. Recife, 27 mar 2018 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpe.jus.br/documents/1812710/0->>>.
- 8 - _____. **Núcleo de Assistência Técnica em Saúde (NAT-JUS)** [Internet]. Recife, 2018 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.tjpe.jus.br/web/comite-estadual-de-saude/nats/apresentacao>>.

9 - Jusbrasil (BR). **Núcleo de Assessoria Técnica em Saúde é inaugurado no Fórum Des. Rodolfo Aureliano** [Internet]. Salvador, 2012 [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://tj-pe.jusbrasil.com.br/noticias/3014804/nucleo-de-assessoria-tecnica-em-saude-e-inaugurado-no-forum-des-rodolfo-aureliano>>.

10 - Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil** [Internet]. Brasília, 5 out 1988 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

11 - _____. **Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências [Internet]. Brasília, 19 set 1990 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>.

12 - _____. **Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n.º 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997 [Internet]. Brasília, 26 jun. 2015 [citado em 6 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-.htm>.

13 - Amaral TC. **O método apoio como ferramenta de prevenção e enfrentamento da judicialização da saúde no SUS: o caso de Jundiaí, SP**. [Dissertação]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas; 2019

14 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Relatório analítico propositivo: judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução** [Internet]. Brasília, 2019 [citado 19 fev 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/95da70941b7cd226f9835d56017d08f4.pdf>>.

15 - Cruz MTT, Neves. BAA. **Contribuição da Mediação Sanitária para a desjudicialização do Direito à Saúde** [Internet]. 2018 [citado 19 fev 2020]. Disponível em: <<https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/>>.

16 - Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (BR). **Ceará diminui em média 36% das demandas que seriam judicializadas na área da saúde** [Internet]. Fortaleza, 15 jul. 2019 [citado 6 jul. 2020]. Disponível em: <<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/ceara-diminui-em-media-36-das-demandas-que-seriam-judicializadas-na-area-da-saude/>>.



Projeto de intervenção baseado no estudo dos casos de judicialização em saúde, com recorte dos casos voltados para oncologia, Município de Salvador-BA, no ano de 2018

Clécio Pereira Lima¹

Daniela Minetto²

Diogo Demarchi Silva³

Felipe Paulino Alves Soares⁴

Mayara Teixeira Laurentino Acipreste⁵

Tenille de Azevedo Ramos⁶

Orientadora: Profa. MSc. Gisele de Jesus Silva

A cidade de Salvador possui como característica principal uma grande diversidade populacional, de modo que análises acerca dos problemas existentes no âmbito do direito à saúde devem considerar, também, os determinantes sociais da saúde, tais como fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais.

¹ Graduado em Direito pela UFBA, pós-graduado em Direito Público pelo UNYAHNA e JUSPODIVM. Coordenador jurídico do COSEMS-BA.

² Graduada em Farmácia Análises Clínicas e Toxicológicas pela UNIFENAS, pós-graduada em Farmácia Hospitalar e Atenção em Saúde pela UFG. Servidora pública da SMS de Cristalina-GO.

³ Graduado em Redes de Computadores pela Estácio de Sá, pós-graduado em Micropolíticas em Saúde Municipal pela UFF e Informática em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês. Assessor técnico do CONASEMS.

⁴ Graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito e Saúde pela ENSP Fiocruz. Coordenador do Departamento Jurídico da SMS de Duque de Caxias-RJ.

⁵ Graduada em Direito pela UnP, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá. Chefe de Gabinete da SMS de Natal-RN.

⁶ Graduada em Farmácia pela Fundação Educacional Jayme de Altavila. Farmacêutica na SMS de União dos Palmares-AL.

Partindo dessa premissa, o trabalho realizou um recorte dos casos do cotidiano da saúde pública em Salvador voltados para a oncologia, tendo como base o ano de 2018, por meio de uma pesquisa descritiva.

Assim, foram utilizados os processos judiciais do ano de 2018, que tinham como foco pedidos judiciais envolvendo a oncologia, coletados mediante pesquisa de processos judiciais que tivessem como assunto “fornecimento de medicamentos, tratamento médico-hospitalar” no sítio do Tribunal de Justiça da Bahia, autuados no período de 01/01 a 31/12/2018, tendo como parte demandada o Município de Salvador. Ainda, como fonte de pesquisa complementar, foram analisados os processos judiciais arquivados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.

Diagnóstico da judicialização no município

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde regulamentada pela Portaria GM/MS n.º 874, de 16 de maio de 2013, tem como objetivo a redução da mortalidade e incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos (1, 2).

Para ter acesso a todo seu tratamento oncológico pelo SUS no Município de Salvador, inclusive ao fornecimento dos medicamentos prescritos, o paciente deve estar cadastrado em uma das unidades relacionadas, que são habilitadas na Alta Complexidade em Oncologia no SUS (1):

- Hospital Professor Edgard Santos / Hospital Universitário – UNACON com Serviço de Hematologia;
- Hospital Aristidez Maltez / Liga Baiana Contra o Câncer – CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica;
- Hospital Santo Antônio / Obras Sociais Irmã Dulce – UNACON;
- Hospital Santa Isabel / Santa Casa de Misericórdia da Bahia – UNACON com Serviços de Radioterapia e de Hematologia;

- Hospital Geral Roberto Santos / CICAN – UNACON;
- Hospital Martagão Gesteira – UNACON exclusivo para serviço de Oncopediatria;
- Hospital Português – Serviço Isolado / Radioterapia.

As principais referências para o tratamento de Oncologia do Estado estão em Salvador. É o exemplo do Centro Estadual de Oncologia (CICAN), que funciona no Hospital Geral Roberto Santos e atende a população baiana há mais de 45 anos nas seguintes especialidades: ginecologia, mastologia, oncologia clínica, urologia, dermatologia, proctologia, anestesiologia, terapia da dor (Algologia) e cirurgia geral (2).

A Unidade oferece, ainda, serviços de psicologia, enfermagem, serviço social, fisioterapia, odontologia e nutrição, todos voltados para o paciente oncológico acompanhado no Centro. São realizados exames para detecção precoce dos diversos tipos de câncer, promovendo tratamentos quimioterápicos e atendimentos diagnósticos e terapêuticos em seu hospital/dia, realizando cirurgias de pequeno e médio porte. Realiza, também, exames de tomografia, raio-X, mamografia e ultrassonografia.

O acesso do paciente ao tratamento da unidade ocorre por meio da central de marcação, administrada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

Outra unidade de destaque na rede estadual de saúde para o tratamento oncológico na Capital baiana é o Hospital Aristides Maltez (HAM), instituição filantrópica sem fins lucrativos, especializada no tratamento de câncer, há 67 anos. Com mais 3.500 atendimentos diários, mais de 9.000 cirurgias por ano, mais de 12.000 internações ao ano e quase 200.000 consultas ano, sem dúvida alguma é a principal unidade de atendimento oncológico à população carente da Capital e Estado. O HAM atende exclusivamente pacientes do SUS.

Com essa folha de serviços oferecidos à população baiana na área de oncologia, o hospital é reconhecido como de utilidade pública pelo Governo Federal, pelo estado da Bahia e pela Prefeitura de Salvador.

A Secretaria de Saúde de Salvador, por meio da Comissão de Especialidades (Núcleo Responsável pelo atendimento ao usuário de Salvador e Municípios pactuados, com diagnóstico de neoplasia maligna), disponibiliza serviços de marcação de consultas oncológicas, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e iodoterapia.

Os agendamentos são para o Hospital Santo Antônio, Santa Isabel e São Rafael. Para a radioterapia inclui o Hospital Português. Os demais relacionados têm acesso direto no prestador. A coordenadoria Municipal de Regulação Ambulatorial e Hospitalar (CMRAH), realiza o atendimento presencial aos pacientes diagnosticados com câncer.

Ao analisar a rede pública de saúde instalada em Salvador, é fácil perceber que a rede temática de saúde *sub examine*, tem estrutura razoável para atendimento da população soteropolitana. A Rede de Atenção ao Câncer do Estado da Bahia se concentra na Capital, o que favorece o atendimento dos municípios. Os indicadores e oferta de Serviços e Sistemas de Informações em Saúde vem melhorando nos últimos anos, em que pese o subfinanciamento do SUS.

Ocorre que os municípios baianos que não possuem unidades cadastradas para o tratamento oncológico, localizados no interior do estado, direcionam os seus pacientes por meio da sua central de regulação, ou mesmo sem regulação, para a Capital, em vez de direcioná-los para a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou ao Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) mais próxima, para viabilizar o atendimento.

Se não bastasse, esses pacientes sofrem com a desinformação e falta de acesso a exames de alta complexidade para auxiliar no diagnóstico do câncer. Com isso, o início do tratamento é prejudicado nas unidades de referência de Alta Complexidade.

Ademais, existe o hábito cultural da população baiana de procurar por serviços na Capital, independente da oferta de serviços próximos a sua residência. Fato que sobrecarrega a rede de saúde e atrapalha o fluxo de atendimento oncológico das unidades referenciadas.

A judicialização em Oncologia no Município de Salvador está relacionada, principalmente, as seguintes causas: I - demora no diagnóstico da doença; II - desinformação

quanto ao ente (Estado da Bahia e/ou Município de Salvador) responsável pelos procedimentos em oncologia e áreas técnicas afins relacionadas ao tratamento; e III - falta de diálogo institucional entre as Secretarias Municipal de Saúde e Estadual de Saúde, órgãos responsáveis pela oferta dos serviços aos pacientes do SUS, que compromete o planejamento dos profissionais das unidades ambulatoriais especializadas.

A quantidade de processos judiciais no ano de 2018, envolvendo a especialidade oncologia em que figura como parte o Município de Salvador é pequena, quando comparado com outros municípios de menor porte do estado.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Município de Salvador (3), as seguintes ações judiciais afetas a especialidade oncológica tramitaram nos anos de 2018 e 2019:

TABELA 1. Ações judiciais da especialidade de oncologia, no Município de Salvador-BA, nos anos de 2018 e 2019.

Nº AÇÃO	ANO	QUAL A SOLICITAÇÃO DO PROCESSO	ESPECIALIDADE
1004698-65.2017.4.01.3300	2018	CIRURGIA CITORREDUTORA ASSOCIADA A QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTERMICA	ONCOLOGIA
1007994-61.2018.8.05.0001	2018	TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO	ONCOLOGIA
0328226-31.2017.8.05.0001	2018	PROSTATECTOMIA ABERTA	ONCOLOGIA
8006404-83.2018.8.05.0001	2018	ESTUDO DO LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO - LCR COM PESQUISA DE CÉLULAS NEOPLASICAS E DOSAGEM DE ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA	ONCOLOGIA
0564236-56.2018.8.05.0001	2018	CIRURGIA CITORREDUTORA	ONCOLOGIA
1010229-98.2018.4.01.3300	2018	CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR MALIGNO	ONCOLOGIA
8002025-65.2019.8.05.0001	2019	QUIMIOTERAPIA	ONCOLOGIA

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (<<https://pje.tjba.jus.br/pje>>).

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma assessoria jurídica especializada na área da saúde, mas quem representa em juízo o município é a Procuradoria Geral do Município. Observou-se que são diversos setores (medicamentos, cirurgias e exames) que não se comunicam. O processo de acesso à informação é marcado pela burocracia, o que dificulta um trabalho técnico dos profissionais envolvidos no problema.

Ao pesquisar no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do Processo Judicial Eletrônico e tendo como filtro o Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com jurisdição no município de Salvador, base de dados com acesso público, foram encontrados apenas dois processos no ano de 2018, conforme apresentado no Quadro 1 (4):

QUADRO 1. Processos registrados no ano de 2018, conforme Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Nº AÇÃO	REPRESENTANTE DO AUTOR	RÉU	DECISÃO
8002890-25.2018.8.05.0001	Advogado particular	Estado da Bahia e Município	Cumprimento, voluntário, pelo Estado da Bahia. Já o município pugnou pela improcedência.
80033121-52.2018.8.05.0001	Atendimento no Juizado	Estado da Bahia e Município	O Estado da Bahia e o município pugnaram pela improcedência. Processo arquivado devido à impossibilidade de intimar a parte autora.

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (<<https://pje.tjba.jus.br/pje>>).

A pesquisa foi prejudicada pelas dificuldades enfrentadas para obter a relação dos processos relacionados ao objeto da pesquisa. O meio tradicional de pesquisa, com acesso direto pela plataforma de acompanhamento processual na internet, demonstrou o baixo nível de informações disponibilizadas pelo TJBA.

Além disso, não há um setor específico ou protocolo próprio no tribunal para acesso de pesquisadores aos dados, a exemplo de ofícios, e-mails, ou outros mecanismos para extração das informações específicas para conclusão da pesquisa.

No mais, diante de um gigantesco número de dados, na hipótese aqui tratada, processos armazenados nos sistemas de acompanhamento virtual, o filtro para pesquisa é fundamental para colher bons resultados em uma extração automatizada de informações. Pode-se observar na pesquisa dos números da judicialização no TJBA que não há uma fidelidade no cadastro dos assuntos, no momento da distribuição dos processos. As falhas na classificação dos temas e pedidos dificultaram a pesquisa e, explicam em parte, o baixo número de processos encontrados.

Na análise dos processos, constam como principais pedidos: realização de exames de alta complexidade para o diagnóstico da doença (tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames laboratoriais específicos); realização de cirurgias de urgência na especialidade oncológica; e indenização por danos morais. Em parte das ações judiciais foram exigidos medicamentos e serviços não cobertos pelo SUS.

Na grande maioria das ações analisadas, o paciente do SUS está representado por advogado particular e tem como ponto comum o pedido de indenização por danos morais e a inclusão no polo passivo tanto do Estado da Bahia quanto do Município de Salvador.

A Defensoria Pública do Estado da Bahia propôs algumas “Ações Ordinárias de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória”, mas, apenas, em face do Município de Salvador e sem pedido de indenização por danos morais.

Os processos em que o autor não foi assistido por advogado particular ou defensor público tramitaram, mas sem a mesma resolutividade dos demais. Alguns deles foram arquivados sem resolução do mérito.

É marcante nos processos judiciais a negativa de responsabilidade entre os réus (estado e município). Em poucos processos o Estado da Bahia, por meio da sua Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), cumpriu voluntariamente o pedido de tratamento do paciente, após receber a citação.

Ademais, nos processos analisados, infelizmente, não se verificou a existência de núcleo de mediação sanitária na secretaria municipal.

Outro ponto importante nos processos analisados foi à participação decisiva do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) na qualificação do debate e orientação técnica ao magistrado dentro da lógica consagrada da medicina baseada em evidências. Em todos os processos o juiz, antes de analisar a tutela antecipada, encaminhou uma cópia dos autos ao Núcleo de Assessoria.

O NAT, por sua vez, acostou parecer técnico sempre que demandado, com celeridade e devidamente fundamentado, fato que favoreceu a tomada de decisão pelo Poder Judiciário.

Outro ponto que chamou a atenção ao analisar os processos foi a não prevalência da prescrição do médico assistente da parte autora, para concessão do pedido. O Juízo adotou o entendimento da indispensabilidade da demonstração pelo médico assistente (ou, na sua ausência, o autor) da necessidade do tratamento não previsto no SUS e seu custo-benefício, na hipótese de equivalente existente no SUS.

Nos autos do processo n.º 8006404-83.2018.8.05.0001, por exemplo, patrocinado pela Defensoria Pública, foi pedido à realização imediata de exames laboratoriais de estudo do líquido cefalorraquidiano (LCR) com pesquisa de células neoplásicas e dosagem de enzima conversora de angiotensina. Para fundamentar seu pedido, o autor anexou relatórios médicos, assinados pelo seu médico assistente, em que atesta o diagnóstico de melanoma, com quadro atual de paralisia facial grave à direita. Foi juntada ainda aos autos uma ressonância magnética de crânio do paciente, que evidenciou realce do nervo facial à direita.

Todavia, a parte autora não justificou cientificamente porque que “a não realização dos exames” implicaria em “risco irreversível” para saúde do paciente. Se limitou a dizer, apenas, que: “é dever do requerido – município de Salvador – garantir a realização dos exames, nos termos indicados pelo relatório médico”.

A Defensoria Pública afirmou, também, na petição inicial que buscou uma resolução extrajudicial para o litígio, mas não obteve resposta da Secretaria Municipal de Saúde (uma realidade presente nos demais processos).

O magistrado ao despachar a inicial encaminhou cópia dos autos ao NAT-JUS, a fim de emitir parecer técnico, com a brevidade possível, sobre: a) se os exames solicitados são oferecidos pelo SUS; b) em caso negativo, se há outros exames no SUS que substituem os requeridos; c) o valor estimado dos exames, caso não sejam feitos pelo SUS.

Em sua resposta, o NAT-JUS respondeu aos questionamentos do juízo, em síntese:

a. Se os exames solicitados são oferecidos pelo SUS;

1. Estudo do líquido com pesquisa de células neoplásicas.

Em resposta: Sim. O exame está listado na tabela de procedimentos oferecidos pelo SUS.

2. Dosagem de enzima conversora de angiotensina.

Em resposta: Não. A tabela de procedimentos do SUS não prevê a realização da dosagem da enzima conversora de angiotensina sérica.

b. Em caso negativo, se há outros exames no SUS que substituam os requeridos.

A dosagem da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA), é utilizada para investigação da doença sarcoidose. Pode ser útil se elevada, no entanto, este exame não é específico para a sarcoidose, e a concentração de ECA pode não ser necessariamente elevada se o paciente tiver neurosarcoidose isolada.

Se houver suspeita de neurosarcoidose (caso em questão), o paciente deve ser avaliado em busca de evidências de doença extraneural, porque a obtenção de tecido nervoso para avaliação diagnóstica é frequentemente difícil. A busca por sarcoidose extraneural deve incluir uma avaliação completa da pele, dos linfonodos e dos pulmões. Outros testes que podem ser úteis e estão disponíveis no SUS são:

- Exame oftalmológico;
- Exame endoscópico nasal e sinusal;

- Radiografia torácica ou tomografia computadorizada de tórax para procurar adenopatia hilar ou alterações parenquimatosas compatíveis com sarcoidose pulmonar.

Assim, a imprescindibilidade do exame requerido pode ser avaliada juntamente com o médico solicitante.

c. O valor estimado dos exames, caso não sejam feitos pelo SUS.

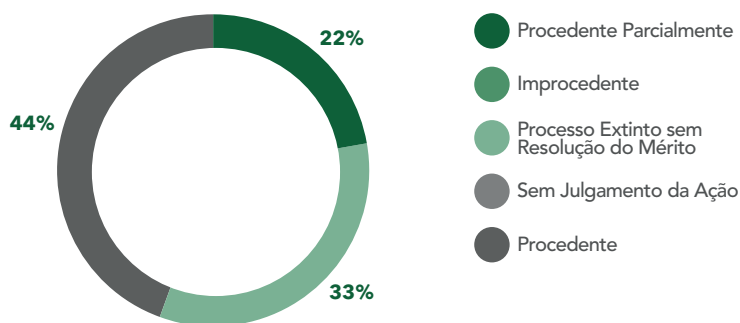
O preço estimado do exame de Dosagem de Enzima Conversora de Angiotensina, não coberto pelo SUS, é de R\$ 450,00 reais.

O magistrado, após analisar o parecer do NAT-JUS, determinou que o autor juntasse aos autos os relatórios médicos, justificando a imprescindibilidade do exame prescrito, bem como da possibilidade de definição de diagnóstico por outras vias. O autor juntou parecer complementar do médico assistente, mas sem manifestação expressa ao exame não previsto no SUS.

Em sua decisão, o juiz concedeu em parte a tutela pleiteada reconhecendo o direito ao exame de estudo de líquido com pesquisa de células neoplásicas, coberto pelo SUS. Contudo, no que tange ao exame de dosagem de Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), que não possui cobertura pelo SUS, seguiu o parecer do NAT e indeferiu o pedido. E mais: “respeitado, contudo, os casos de pacientes de igual ou maior gravidade que já aguardam na fila da Central de Regulação pelo mesmo procedimento”.

Ao analisar a movimentação processual supracitada, percebe-se que não basta ao Autor citar a previsão constitucional do direito à saúde para o deferimento da sua pretensão. É necessário, também, adotar uma fundamentação interdisciplinar do direito baseado em evidências. Um grande avanço em prol da qualificação da judicialização da saúde.

FIGURA 1. Processos Judiciais, Município de Salvador-BA, 2018.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

O grande desafio do Gestor do SUS nos últimos anos, sem dúvida alguma, é como prevenir e responder às demandas judiciais da saúde. Em especial com um sistema judiciário que prega, em seus julgados, até pouco tempo, a inviolabilidade absoluta do direito à vida e sua prevalência em face dos interesses financeiros do estado. Uma jurisprudência que precisa mudar e está mudando, no seu tempo, com o novo contexto da saúde baseada em evidências científicas. Esse contexto de mudança pode ser visto, recentemente, com decisões importantes do Supremo Tribunal Federal (STF) (vide, por exemplo, RE 657718/2019 / Tema 500).

Com isso, o Poder Judiciário sinaliza claramente para gestão o seu interesse de dialogar sobre evidência científica e política pública de saúde. Cabe ao gestor municipal da saúde observar a mudança de postura dos magistrados, entender o processo (judicialização e política pública de saúde) e agir estrategicamente com implantação de medidas efetivas de combate e solução de conflitos judiciais. Em algumas ações, com total sintonia com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advogados, Ministério Público

(estadual e federal), demais entes federativos e outros atores. Um agir baseado em estudos técnicos resolutivos e fluxo de trabalho delineado com responsabilidade.

Com a mudança de paradigma das decisões judiciais, principalmente pelos novos magistrados, que passaram a qualificar a discussão da Judicialização da Saúde, houve necessidade de uma análise mais aprofundada das questões técnicas de saúde no processo decisório (4).

Um importante movimento ocorrido no Estado da Bahia foi marcado pelo Decreto Judiciário n.º 287 do TJBA, de 14 de fevereiro de 2012, que instituiu o Plantão Médico de Assessoria ao Juiz, bem como pelo o Decreto Judiciário n.º 877 do TJBA, de 14 de outubro de 2015, que introduziu a denominação do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT), em substituição ao termo Plantão Médico, seus marcos regulatórios, conforme disposto na Resolução CNJ n.º 238, de 06 de setembro de 2016, que uniformizou a nomenclatura para Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), bem como estabeleceu diretrizes para o seu funcionamento (6).

Com o Decreto Judiciário n.º 685, de 10 de outubro de 2018, que “dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do NAT-JUS do Tribunal de Justiça da Bahia”, a reestruturação do NAT-JUS é consolidada na Corte Estadual, em especial com a qualificação do serviço de Assessoria Técnica em Saúde, composta preferencialmente por servidores do TJ da Bahia. Um órgão de apoio técnico-especializado em saúde, baseado em evidências científicas para suporte de informações aos magistrados na tomada de decisão em ações judiciais relativas à saúde, conforme o caso, política pública ou à saúde suplementar (7).

O assessoramento é prestado, por meio de respostas rápidas e notas técnicas, exclusivamente, ao Magistrado. As demandas ao NAT-JUS serão dirigidas e respondidas unicamente pelo Sistema NAT-JUS no endereço eletrônico <https://www.tjba.jus.br/natjus/>, no qual se consolidará banco de dados das informações tramitadas e das respostas oferecidas (7). As notas técnicas na área da saúde são disponibilizadas pelo NAT-JUS no endereço eletrônico https://www.tjba.jus.br/natjus/index.php/relatorio_consultapublica/index.

Ao realizar a consulta pública no portal do eletrônico do TJBA no link do NAT-JUS, disponível em https://www.tjba.jus.br/natjus/index.php/relatorio_consultapublica/gerar_relatorio, é possível visualizar as respostas com vinculação aos processos judiciais, separados em duas categorias (saúde pública e saúde suplementar).

A maioria dos documentos (respostas e notas técnicas) disponíveis na plataforma digital para consulta pública envolve o setor público SUS, conforme o caso, de medicamentos, produtos, insumos terapêuticos, procedimentos cirúrgicos e não-cirúrgicos, exames diagnósticos, internações ou afins. Na saúde suplementar, em menor número no cômputo geral das demandas, ganha destaque especial os seguros ou planos de saúde.

A equipe está vinculada, diretamente, à Presidência do TJBA sob a coordenação da Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais, a qual organiza o fluxo de trabalho da equipe técnica multidisciplinar em saúde, que tem por base a ordem cronológica do chamado, salvo situação de urgência.

Essa linha de comando bem definida e com servidores qualificados do quadro do tribunal garante uma resposta rápida e eficiente.

Cabe registrar, ainda, que o NAT-JUS também presta apoio aos magistrados do Tribunal Regional Federal – Seção Judiciária da Bahia, na forma do Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a União Federal, desde dezembro de 2016. Há também troca de informações entre o NAT-JUS e o grupo técnico da Câmara de Conciliação de Saúde, instituída no Município de Salvador pelo convênio de cooperação.

A mediação sanitária é considerada, atualmente, a melhor estratégia substitutiva do atual modelo individualista de acesso à saúde. Uma ação institucional, que ocorre dentro do ambiente do setor da saúde responsável pela demanda, com finalidade de satisfazer o interesse das partes em menor tempo e desgaste.

O trabalho tem uma perspectiva ampla do Direito, Saúde e Cidadania, por acreditar que é possível a convergência do diálogo entre eles (sistema de saúde x sistema judicial). Uma nova forma legal para a composição de conflito em que a participação da

parte na solução do problema é fundamental, diferentemente do modelo tradicional em que um terceiro intitulado “imparcial” é chamado para decidir unilateralmente o litígio.

A Secretaria de Saúde do Município de Salvador não possui um núcleo de conciliação em sua estrutura administrativa.

A Resolução CNJ n.º 107, de 6 de abril de 2010, institui no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Fórum Nacional de Saúde, para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos (8).

É resultado da recomendação CNJ n.º 31/2010, que sinaliza a necessidade da adoção de medidas para assessorar os magistrados na tomada de decisão em matéria de assistência à saúde, diante da carência técnica observada nos processos judiciais (9).

O Fórum Nacional é integrado por magistrados atuantes em unidades jurisdicionais, podendo contar com o auxílio de autoridades e especialistas com atuação nas áreas correlatas, especialmente do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público Federal, dos Estados e do Distrito Federal, das Defensorias Públicas, da Ordem dos Advogados do Brasil, de universidades e outras instituições de pesquisa.

Dentre as suas atribuições, há um destaque para o monitoramento das ações judiciais relativas ao SUS e a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à prevenção de conflitos judiciais e à definição de estratégias nas questões de direito sanitário.

As atividades do Fórum Nacional da Saúde, são coordenadas pelo Comitê Executivo Nacional, instituído por meio da Portaria CNJ n.º 91/2010. Trata-se de órgão com importante papel na elaboração do programa de trabalho e funcionamento do Fórum Nacional, além da produção e execução de políticas públicas relativas à judicialização da saúde.

Ademais, como o Fórum Nacional é constituído por comitês estaduais, compete ao Comitê Executivo Nacional promover a sua integração em rede, por meio de reuniões e encontros, assim como atuar na divulgação de boas práticas.

A Resolução n.º 238, de 6 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe sobre a criação e a manutenção de comitês estaduais de saúde, bem como a especialização em comarcas com mais de uma vara de fazenda pública (6).

O ato normativo visa dar efetividade à Resolução 107, de 6 de abril de 2010 do CNJ, que criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde e instituiu os comitês estaduais de saúde como instâncias adequadas para encaminhar soluções e garantir a melhor forma de prestação jurisdicional em área tão sensível (8).

Os colegiados devem ser compostos por magistrados de primeiro e segundo graus; gestores da área da saúde e demais participantes do sistema de saúde e de Justiça (Ministério Público, Defensoria Pública, advogados públicos ou um representante da Ordem dos Advogados do Brasil), além de dois integrantes do Conselho Estadual de Saúde: um que represente os usuários do sistema público e, outro, os usuários do Sistema Suplementar de Saúde.

Entre as atribuições dos comitês está a de auxiliar os tribunais na criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituídos de profissionais da saúde, para elaborar pareceres acerca da medicina baseada em evidências.

Aos tribunais compete a indicação dos magistrados, além da criação de sítio eletrônico com acesso ao banco de dados, criado e mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, com pareceres, notas técnicas e julgados na área da saúde, para consulta pelos magistrados e demais operadores do direito.

Na Bahia, o comitê é formado por 13 titulares e 6 suplentes representando o Tribunal de Justiça da Bahia, Justiça Federal, Promotoria da Justiça, Advocacia da União, Defensoria Pública da União, Procuradoria do Estado, Defensoria Pública Estadual, Procuradoria do Município de Salvador, Secretaria de Saúde do Município de Salvador e o segmento de Saúde Suplementar (9).

As reuniões são marcadas pelo debate plural e democrático, com opiniões sérias e diversas, a fim de, ter um produto sólido e consistente para orientação dos magistrados e atores do SUS. Aliás, a Bahia foi pioneira na efetivação do Comitê Estadual, Câmara de Conciliação de Saúde (CCS) e o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT JUS), estratégias eficientes no enfrentamento das causas da Judicialização da Saúde (10).

A Resolução n.º 238 de 6 de setembro de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, recomendou aos tribunais estaduais e federais, nas comarcas ou seções judiciárias onde houver mais de uma vara de Fazenda Pública, promovessem a especialização de uma delas em matéria de Saúde Pública. O mesmo deve ser seguido nas cortes que contam com mais de uma câmara de direito público (6).

Cabe registrar que, as Varas especializadas em processar e julgar ações judiciais que tenham como objeto a judicialização da saúde, além de garantir a qualificação do debate e humanização do processo, impulsiona a produtividade do Tribunal na medida que torna mais efetiva sua organização judiciária.

A Lei n.º 10.845, de 27 de novembro de 2007, que “dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia, a administração e o funcionamento da Justiça e seus serviços auxiliares”. As questões ligadas à fazenda pública envolvem ações de indenização contra o estado ou município; ações para obtenção de medicamentos, consultas, exames, cirurgias e demais ações e serviços de saúde por parte das entidades públicas; demandas relacionadas a concursos públicos, cobrança indevida ou abusiva de tributos, entre outras questões (11).

Na capital baiana, diante do número de processos que envolvem prestação de urgência na saúde, o Tribunal de Justiça da Bahia criou varas especializadas em demandas de saúde no âmbito dos juizados especiais do consumidor.

A Câmara de Conciliação de Saúde (CCS), é um espaço de cooperação entre órgãos públicos para promover o atendimento de usuários do SUS no Município de Salvador-BA. Uma forma de prevenir a judicialização da saúde, em especial a dispensação de medicamentos e fórmulas alimentares especiais.

A CCS foi instituída por meio do Convênio de Cooperação n.º 01/2015, de 29 de setembro de 2015, e conta como integrantes o Tribunal Regional Federal (TRF-1ª Região), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), os Ministérios Públicos Estadual (MPE) e Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública do Estado (DPE), a Secretaria de Saúde do Município de Salvador (SMS/SSA), a Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGM/SSA), a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) (8).

Em pleno funcionamento desde 24 de novembro de 2016, data da inauguração do espaço em Salvador-BA, o órgão vem ganhando destaque pelo canal de diálogo entre os principais atores do SUS, o que representa um aumento significativo da solução dos conflitos extrajudiciais – por meio da mediação e conciliação sanitária – viabilizando o acesso mais rápido do cidadão aos medicamentos e serviços prestados pelo SUS.

As demandas não solucionadas, principal destaque no fornecimento de medicamentos, são encaminhadas para Defensoria Pública da Bahia (DP/BA) e Defensoria Pública da União (DPU/BA), assim como para o Ministério Público, para adoção de medidas judiciais.

A iniciativa foi pioneira no Brasil, com foco inicial nos pedidos relacionados a entrega de medicamentos por parte do estado e do Município de Salvador, para pacientes de doenças crônicas, moradores de Salvador.

Com uma equipe técnica multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais e nutricionistas, a Câmara segue a orientação da Resolução n.º 107 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para “monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e a prevenção de novos conflitos” (8).

Na Bahia, todo o trabalho é coordenado pelo Comitê Executivo Estadual de Saúde, criado por Resolução do TJBA. Também integram o comitê, o Tribunal Regional Federal (TRF-1ª Região), Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, a Secretaria de Saúde do Município de Salvador,

Procuradoria Geral do Município de Salvador, Procuradoria Geral do Estado da Bahia e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

É fato público e notório a preocupação da Gestão Pública da Saúde com a judicialização do acesso a medicamentos, em especial daqueles que não têm aprovação ou registro de uso na Agência Reguladora competente.

Segundo dados da SESAB, os dez medicamentos mais pleiteados por via judicial são, respectivamente: Lucentis, análogos de insulina, fórmulas alimentares, cinacalcete, enoxaparina, ursacol, temozolamida, mesalazina e fosfoetanolamina sintética (10).

Dados da Defensoria Pública do Estado da Bahia no ano de 2017, apontam as principais demandas da população de Salvador na área de saúde, identificadas pela Câmara de Conciliação, o fornecimento de “medicamentos anticoagulantes e para doenças como a degeneração macular, que envolve a perda da visão, e retinopatia diabética, que também afeta a visão” (12).

As pesquisas e estudos realizados pelos comitês e fórum nacional precisam ser divulgados e em linguagem simples para os gestores e usuários do SUS, em especial as boas práticas envolvendo o enfrentamento do fenômeno da judicialização.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por exemplo, realiza, constantemente, audiência pública de abrangência nacional sobre a prestação jurisdicional em processos relativos à saúde. Nos encontros percebe-se a presença de autoridades públicas, especialistas e representantes qualificados da sociedade civil. Aliás, os debates e opiniões, em regra, são qualificados. Contudo, pode-se apresentar algumas críticas ao formato como essas informações são divulgadas, por meio de recomendações, enunciados e seus efeitos práticos.

Ao pesquisar o site do CNJ referente ao Fórum Nacional da Saúde obteve-se um considerável banco de dados, com resumo das audiências públicas e jornadas de direito à saúde com dezenas de enunciados e recomendações aprovadas. Ocorre que a linguagem utilizada nos documentos e seu formato de divulgação não permitem ao cidadão e ao gestor, sem formação jurídica, entender seu conteúdo.

Ocorre que estes documentos especializados não se destinam, apenas, a magistrados e operadores do direito. É necessário inserir os demais atores, em especial o usuário do SUS e o Gestor. A utilização de uma linguagem simples e no formato das redes sociais, por exemplo, pode ser útil para o entendimento de temas complexos.

Assuntos como acesso a serviços de saúde, princípio federativo e responsabilidade dos entes públicos, acesso a tecnologias em saúde e sua incorporação no SUS, a medicina baseada em evidências – impacto sobre a prestação jurisdicional, incorporação de tecnologias em caso de doenças raras e medicamentos órfãos – o agir do Poder Judiciário, desabastecimento de medicamentos essenciais e o papel do juiz; precisam ser tratados como de interesse coletivo com ampla divulgação para todas as camadas da sociedade.

A construção de manuais, informes e anúncios para atender demandas de usuários do Sistema único de Saúde, gestores públicos, autoridades dos poderes da República, representantes e usuários da saúde suplementar e da comunidade acadêmica, proporcionando não só ao Poder Judiciário uma análise mais acurada das diversas questões a serem julgadas, mas também a opinião pública.

Uma alternativa para enfrentar as causas da judicialização da saúde é a elaboração de respostas estruturadas aos pacientes da rede pública de saúde. Na prática, o gestor do SUS se limita a uma simples resposta negativa, sem apontar alternativas disponíveis e competência para atender a demanda. Pior, sem ter uma estrutura própria para mediação sanitária.

Com isso, criamos no imaginário do cidadão a falta impressão de descaso e ilegalidade quando, na verdade, é fruto de falhas graves de gestão. Uma comunicação errada que pode gerar um pseudo conflito.

É de conhecimento geral que a teoria geral do conflito, com foco na mediação, já demonstrou que a mediação sanitária é um método eficiente de resolução de conflitos, quando bem utilizado na secretaria de saúde. Uma alternativa viável para a maioria dos municípios, por meio de núcleos de mediação na própria gestão. No entanto, enfrenta grande resistência interna, até mesmo pela organização dos serviços e seus conflitos éticos.

Em Salvador, não temos um núcleo de mediação sanitária na secretaria municipal de saúde, nem uma câmara de mediação em âmbito estatal para solução extrajudicial de conflitos como determina a Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015.

Por fim, a Gestão da Saúde peca em não investir na constante atualização e monitoramento do mapa de conflitos no âmbito do SUS para antever as demandas. As demandas envolvendo as políticas públicas de saúde deveriam, em regra, ser solucionadas nas instâncias administrativas e de pactuação do SUS. Afinal, quem melhor, senão o secretário de saúde, que conhece sua estrutura e a política, para determinar onde e quando o paciente pode obter tratamento e/ou medicamento?

Com o avanço da judicialização da saúde no Brasil na última década, a questão que antes era vista apenas como um “problema do ente público” que, ao não cumprir seu papel, via-se compelido a cumprir por “determinação judicial”, passou a ser vista como uma questão que, tanto para origem quanto para eventuais soluções, recaía sobre diversos atores.

Se o ente federado “erra” ao não cumprir com seu dever constitucional, o Poder Judiciário, por sua vez, “erra” ao solucionar o “problema” sem considerar critérios importantes como, por exemplo, a eficácia do medicamento ou tratamento de alto custo pleiteado, por vezes, determinando bloqueios judiciais de alto vulto, capazes de gerar sério desequilíbrio financeiro nos entes.

Na perspectiva de disciplinar critérios que visassem garantir direitos aos usuários e também conferir embasamento técnico às decisões do Poder Judiciário, observaram-se movimentos que culminaram com a instituição de comissões e normas para atingir tal finalidade, baseadas em novas estratégias para enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde, permitindo a parametrização ao nível nacional, sem prejuízo que os entes estaduais ou municipais, criassem suas próprias estratégias, a partir da análise de sua realidade local.

Outra estratégia de enfrentamento da judicialização da saúde, repousa justamente na tentativa de mediação de conflitos, ou seja, prevê uma espécie de “prevenção ao agravo”, permitindo que situações de conflitos, que poderiam culminar em ações judiciais, sejam resolvidas de maneira mediada (13).

O caráter de rápida resolução é o que se confere a mediação extrajudicial altos índices de resolutividade, além de ser uma estratégia de enfrentamento de baixo custo, garantindo que o objetivo, ou seja, o acesso ao direito à saúde, seja alcançado mais rapidamente, sem a demora comumente atribuída às ações judiciais, principalmente se considerarmos que o objeto das demandas judiciais por vezes se delonga no tempo, a exemplo do fornecimento de medicamentos ou tratamentos.

Do ponto de vista legal, a mediação encontra respaldo na Lei Federal n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), com a previsão de estímulo à autocomposição das partes antes de um processo (14).

Em suma, a mediação na área de saúde é uma alternativa que empodera os envolvidos no conflito, garantindo praticidade, eficiência, qualidade e satisfação dos usuários que buscam a tutela jurisdicional. Porém, para que os resultados sejam satisfatórios, é importante que o processo de mediação seja conduzido por profissionais com capacidade técnica e conhecedores dos protocolos do setor saúde, para que não haja prejuízo das partes.

Por fim, verificada a ausência de um núcleo de mediação sanitária na Secretaria Municipal de Saúde, e também de uma câmara de mediação em âmbito estatal para resolução de conflitos extrajudicial, tratando-se ambos de propostas essenciais para a implantação no Município de Salvador, visto que há a necessidade de tratar em âmbito administrativo e de pactuação do SUS os requerimentos que envolvem as políticas públicas de saúde visando mitigar os conflitos, dirimir tempo e desgaste de ambos os polos interessados, usuário versus ente federativo, seria de suma importância estabelecer tais dispositivos para a resolutividade dos casos oncológicos no município.

Considerações Finais

O direito à saúde e sua contextualização moderna, com conhecimento jurídico-político-sanitário, é o desafio do direito sanitário com ênfase na judicialização da saúde. Compreender o fenômeno passa, inicialmente, por entender as políticas públicas de saúde sob aspecto coletivo e da economia de saúde. Uma realidade sanitária e consti-

tucional brasileira que precisa ser enfrentada não apenas pelo operador do direito, mas por todos, que de alguma forma precisam do SUS.

As pesquisas realizadas, foram baseadas nos casos de judicialização em saúde, com recorte dos casos voltados para oncologia no município de Salvador, no ano de 2018. O estudo de informações socioeconômicas e epidemiológicas do município, constatou uma rede de saúde pública com uma estruturada razoável para o enfrentamento da demanda. O que não elimina a necessidade de novas estratégias de enfrentamento da judicialização, diante do crescimento da pressão pelo acesso aos serviços.

A falta de investimento em um banco de dados transparente e administrado pela municipalidade, com informações transparentes sobre os pedidos negados de tratamento médico-hospitalar e de fornecimento de medicamentos oncológicos, compromete a gestão eficiente. Isso porque a carência de informação prejudica não apenas os pesquisadores, mas, também, o Gestor na tomada de decisão. A experiência demonstra que o processo decisório é qualificado com a participação de informações técnicas.

Com a experiência dos Comitês de Saúde do Judiciário, Núcleos de Apoio Técnico e alternativas semelhantes, que tenham por foco a qualificação do fenômeno da judicialização, é uma das estratégias possíveis de investimento pela municipalidade para redução dos litígios. No que pese isso, não foi observado nenhum projeto ou ação nesse sentido pela Secretaria de Saúde do Município de Salvador-BA.

Os protocolos de acesso aos serviços e tratamento oncológico, disponível no portal da Prefeitura, pecam por excessos de documentos e falta de objetividade. É preciso mudar o atual modelo de gestão e atenção à saúde e repensar as políticas públicas de saúde sustentadas na prevenção. O município de Salvador sofre, historicamente, com a baixa cobertura da atenção básica.

O diagnóstico no estágio inicial do câncer, além de assegurar um percentual maior de vitória no combate da doença, reduz a pressão de acesso dos pacientes por serviços médico-hospitalares de urgência. O fator tempo, passa a ser fundamental para o tratamento da doença quando diagnosticada tardiamente. Associada a isso temos uma doença com alta letalidade que causa desespero ao paciente e seus familiares, sem a estrutura assistencial necessária do Poder Público para o seu enfrentamento.

Ao analisar os processos judiciais pesquisados é possível perceber a mudança da visão tradicional do direito à saúde como direito absoluto, individual e de mercado. Contudo, falta ainda no Poder Judiciário em suas várias facetas o equilíbrio necessário para mudança na velocidade que clama a sociedade. A Procuradoria Geral do município não demonstra interesse na mediação das demandas. Em grande parte dos processos, inclusive, é informado nos autos o desinteresse do município na audiência de conciliação.

É impossível trabalhar no enfrentamento do fenômeno da judicialização em saúde sem mediação sanitária e respostas estruturadas das demandas. O gestor da saúde, em especial no município, sabe do impacto no orçamento da saúde, provocado pelas ações judiciais. Contudo, isso não foi observado no trabalho, diante dos poucos processos encontrados no ano de 2018.

Como explicado, houve dificuldade no acesso aos processos judiciais relacionados ao tema pesquisado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não conta com um setor específico para agrupar as informações e estratégias para o enfrentamento da judicialização da saúde. Os dados são fragmentados e seu acesso é marcado pela burocracia institucional. É preciso que sejam divulgados nos canais oficiais da SMS, disseminados nas redes sociais e socializados no meio científico.

Algo semelhante ocorreu com o sistema de informação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O *site* do TJBA não disponibiliza um mecanismo eficiente de pesquisa, com campos específicos, na busca do resultado definido. Aliás, quando se pensa em um sistema, deve-se ter em mente a sua existência para acesso dos usuários, não apenas para seus servidores. Obviamente, tais dificuldades prejudicam a pesquisa acadêmica, na medida em que limitam o registro completo das ocorrências.

Em que pese isso, nos processos judiciais analisados percebe-se, pela amostragem, um padrão na atuação das partes (entes públicos e cidadãos). A qualificação do debate com a participação, em regra, do NAT-JUS nos processos sobre fornecimento de medicamentos, exames e tratamentos oncológicos.

Por outro lado, considerando a estrutura do município de Salvador, acredita-se que pode avançar e muito as estratégias de enfrentamento de um tema tão delicado como a judicialização da saúde.

Referências

- 1 - Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria n.º 874 de 16 de maio de 2013**. Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 maio 2013. [citado em 20 nov. 2019]. Disponível em: <<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/PortariaGMMS87413.pdf>>.
- 2 - Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. **Informações sobre tratamento oncológico no SUS**. [Internet]. Salvador: Secretaria de Saúde; 2019. [citado em 24 nov. 2019]. Disponível em: <<http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/medicamentos/medicamentos-estrategicos/informacoes-sobre-tratamento-oncologico-no-sus/>>.
- 3 - Prefeitura de Salvador. **Secretaria Municipal da Saúde** [Internet]. 2019. [citado em 10 out 2019]. Disponível em: <<http://www.saude.salvador.ba.gov.br/secretaria/sobre-a-secretaria/>>.
- 4 - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). **Sistemas de juizados especiais na capital e Fazenda Pública** [Internet]. 2019. [citado em 24 nove. 2019]. Disponível em: <<https://pje.tjba.jus.br/pje>>.
- 5 - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). **Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário** [Internet]. 2019. [citado em 8 fev 2020]. Disponível em: <<http://www5.tjba.jus.br/porta/nucleo-de-apoio-tecnico-do-judiciario-realiza-primeira-reuniao-de-2019/>>.
- 6 - Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n.º 238, de 06 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 set 2016. [citado em 10 fev 2020]. Disponível: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_238_06092016_09092016173942.pdf>.
- 7 - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). **Decreto Judiciário n.º 685, de 10 de outubro de 2018**. Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do NAT-JUS do Tribunal de Justiça da Bahia [Internet]. Diário de Justiça do Estado da Bahia, 11 out 2018 [citado em 10 fev 2020]. Disponível em: <<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?>>.
- 8 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução n.º 107, de 6 de abril de 2010**. Institui o Fórum Nacional Judiciário para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 abr. 2010 [citado em 10 fev 2020]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_107_06042010_11102012191858.pdf>.

9 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010.** Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do Direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde [Internet]. Diário Oficial da União, 30 mar 2010 [citado em 11 fev 2020]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf>.

10 - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). **Câmara de Conciliação de Saúde (CCS)** [Internet]. 2020. [citado em 11 fev 2020]. Disponível em: <<http://www.saude.ba.gov.br/sobre-a-sesab/ccs/>>.

11 - Bahia. **Lei n.º 10.845, de 27 de novembro de 2007.** Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia, a administração e o funcionamento da Justiça e seus serviços auxiliares [Internet]. Diário Oficial do Estado da Bahia, 27 nov. 2007 [citado em 11 fev 2020]. Disponível em: <<http://www.tj.ba.gov.br/ipraj/Lei10845.pdf>>.

12 - Defensoria Pública do Estado da Bahia. **Demandas coletivas de saúde são identificadas pela Câmara de Conciliação em Saúde** [Internet]. 2017 [citado em 11 fev 2020]. Disponível em: <http://www.defensoria.ba.def.br/portal/index.php?site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod=17727>.

13 - Mediação Online – MOL. **Cinco vantagens da mediação de conflitos do setor de saúde** [Internet]. [citado em 7 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.mediacaonline.com/blog/5-vantagens-da-mediacao-de-conflitos-no-setor-de-saude/>>.

14 - Brasil. **Lei Federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mar 2015. [citado em 7 mar. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>.



Enfrentamento da judicialização da saúde do Município de São Luís-MA

Carlla Ribeiro Portugal da Silva¹

Dayane da Silva Lima²

Izaura do Bomfim Oliveira Ferreira³

Kaoye Guazina Oshiro⁴

Luciana Rodrigues Pereira⁵

Magaly Botelho Lemes Lopes⁶

Vanderlei Silva⁷

Vanessa da Silva Veiga⁸

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Mara Campos Alves

O município escolhido para estudo da judicialização da saúde foi o de São Luís-MA, por apresentar, segundo dados do Núcleo de Demandas Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde, um aumento considerável no número de demandas judiciais envolvendo a saúde, nos últimos anos.

¹ Graduada em Direito pela CEST, pós-graduada em Gestão Pública pela UEMA. Assessora Jurídica na SMS de São Luís-MA.

² Graduada em Medicina Veterinária pela UNAMA; pós-graduada em Gestão da Saúde pelo Grupo Educamaís. Secretária Municipal de Saúde de Santarém-PA.

³ Graduado em Direito pela UESPI, pós-graduada em Direito Constitucional pela UNIDERP e em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública pelo Instituto Damásio. Advogada na Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI.

⁴ Graduado em Direito pela UFMS. Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul.

⁵ Graduada em Farmácia pela UNIFRAN. Servidora na Prefeitura de Delfinópolis.

⁶ Graduada em Farmácia pela UNIPAR – Campus Umuarama. Coordenadora da Assistência Farmacêutica da SMS de Ubitatã-PR.

⁷ Graduado em Direito pela UniEVANGÉLICA – Anápolis-GO, pós-graduada em Regulação em Saúde no SUS, pelo Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa. Subprocurador jurídico da SMS de Goianésia-GO.

⁸ Graduada em Farmácia e pós-graduada em Citopatologia pelo CESMAC. Coordenadora do CEAF – Penedo-AL.

Buscou-se entender os motivos que levaram a judicialização da saúde a dobrar no município em um intervalo de dois anos (2017 a 2018) e quais mecanismos podem ser adotados para que esse fenômeno seja diminuído, ou mesmo evitado, buscando-se, assim, meios de orientar os gestores para que haja um fortalecimento do SUS e a melhor prestação das ações e serviços de saúde.

O projeto foi realizado em duas etapas: a análise dos dados do Município de São Luís-MA por meio de pesquisa em sítios que fornecem informações acerca de dados econômicos, geográficos, demográficos, de indicadores sociais, como o IBGE, IPHAN, bem como pesquisa nos seguintes sítios: CONASEMS, Datasus, Ipea data, TJMA, TRF 1ª Região, CNJ, CNM; consultas junto às Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA acerca de dados que não estão disponibilizados em sítios de internet ou em busca de relatórios disponíveis para agrupamento de informações que versem sobre o município; bem como a análise do Plano Municipal de Saúde 2018-2021; para em seguida realizar pesquisas no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como no Tribunal Regional Federal da 1ª Região para obter informações quanto a história desses órgãos e sua respectiva atuação no município. Assim, foi feito um levantamento das ações judiciais propostas em desfavor do Município de São Luís e, às vezes, em litisconsórcio com outros entes, quanto ao assunto saúde.

Para tanto, foram realizadas consultas ao sistema SIJUR, de uso interno das assessoras jurídicas que fazem parte do Núcleo de Demandas Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde. Tal sistema é alimentado manualmente pelas assessoras ao chegar demanda, e os campos preenchidos são: número de processo administrativo, número de processo judicial, (em caso de solicitação administrativa - apenas o número do ofício), o pedido, o nome da parte solicitante, e a tramitação dos setores internos. Foi utilizado um filtro de pesquisa, limitando as ações judiciais no ano de 2018 e as palavras-chave utilizadas quanto ao assunto foram: município, São Luís, medicamentos, Secretaria Municipal de Saúde, saúde, procedimentos, tratamentos de saúde, transferência para leitos de UTI, hospital público. Ressaltamos que, por serem ações novas, a maioria tem apenas decisões liminares.

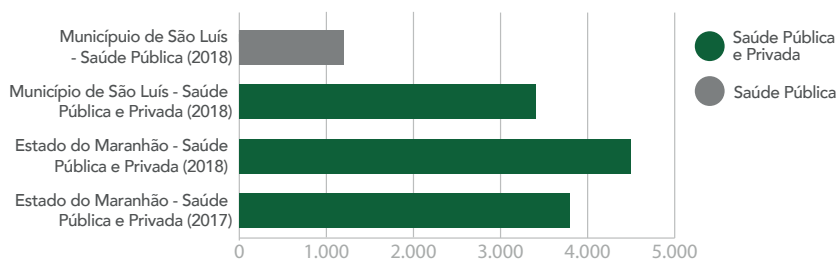
O estudo também analisou livros e artigos jurídicos que tratam das instituições que mais influenciam na judicialização da saúde no município: o Ministério Público, a

Defensoria Pública e a advocacia privada. O estudo baseou-se em artigo científico em que se fez um estudo de juízes federais e estaduais do Estado do Maranhão, em que se registrou a visão dessas instituições sobre seu entendimento acerca do significado de judicialização da saúde.

Diagnóstico da judicialização no município

O Município de São Luís apresenta muitas demandas judiciais em matéria de saúde. Dados encaminhados pelo TJMA demonstraram um crescimento de demandas na área de saúde (pública e privada), sendo que em 2017, contavam com 3.804 demandas de saúde e em 2018, contavam com 4.581 demandas de saúde em todo o estado do Maranhão. Destas, 3.491 foram ajuizadas na comarca de São Luís, sendo 1.215 relacionadas à saúde pública. Observa-se na Figura 1 as demandas de saúde do estado do Maranhão e do município de São Luís no período.

FIGURA 1. Comparação do número de demandas em saúde (pública e privada) no estado do Maranhão nos anos de 2017 e 2018.



Fonte: TJMA (Grupo UniverSUS).

Os gastos com saúde pública no Município de São Luís superaram o percentual obrigatório de 15%, atingindo um percentual de 21,28 %, visto que as decisões judiciais geralmente obrigam o Poder Público a fornecer medicamentos, insumos, realizar procedimentos e cirurgias, bem como ao fornecimento de equipamentos.

Segundo dados fornecidos pelo TJMA, o tribunal recebeu no ano de 2018 (de janeiro a agosto) 4.581 demandas envolvendo a saúde nas redes pública e privada. Ao se comparar as informações contidas na Tabela 1 acerca das demandas em matéria de saúde no estado do Maranhão em 2018, com os anos anteriores (2017 e 2015), vê-se que houve um aumento nas contendas referentes à rede privada de saúde, um aumento nas demandas de interesse difuso e uma diminuição nas demandas referentes à Fazenda Pública.

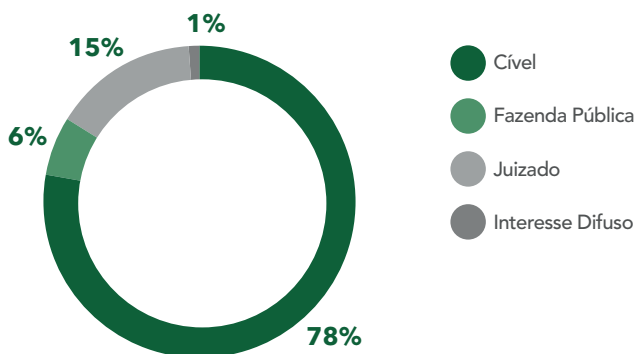
TABELA 1. Descrição da Judicialização da saúde no estado do Maranhão nos anos de 2018, 2017 e 2015.

TIPO DE DEMANDA	ANO DE 2018	ANO DE 2017	ANO DE 2015
Cível	3.328	1.894	2.147
Fazenda Pública	620	1.173	1.517
Interesse difuso	50	28	34
Infância e Juventude	3	3	214
Total por ano	4.581	3.804	3.934

Fonte: TJMA.

Com relação às demandas de saúde da comarca de São Luís, o tribunal somente disponibilizou os dados relativos ao ano de 2018 (de janeiro a agosto), distribuídas da seguinte maneira: a) na Vara Cível (rede privada) ajuizados 2.726 processos judiciais; b) na Vara da Fazenda Pública ajuizados 212 processos judiciais; c) nos Juizados especiais ajuizados 51 processos judiciais; e d) interesses difusos ajuizados 39 processos judiciais, conforme se observa a distribuição em percentual na Figura 2:

FIGURA 2. Demandas de Saúde na comarca de São Luís no ano de 2018.



Fonte: TJMA.

De acordo com a Figura 2, as demandas de saúde na comarca de São Luís em sua grande maioria são demandas cíveis, o que significa que os entes públicos não são os mais acionados nas questões envolvendo saúde. Contudo, importante ressaltar que por se tratar apenas de um levantamento numérico, não se pode avaliar o impacto orçamentário das ações judiciais sobre os entes públicos.

Em que pese esse quantitativo de ações judiciais registrados no TJMA, a pesquisa foi realizada utilizando os dados do sistema SIJUR, implantado em julho/2018, mas com um quantitativo, em seu banco de dados, de processos judiciais de janeiro a outubro/2018, totalizando 745. Com o recorte de temática na saúde pública, o sistema então apresenta 553 ações judiciais relativas à saúde.

Antes da implantação do SIJUR, o Núcleo de Demandas Judiciais (NDJ) utilizava uma planilha no Excel, no OneDrive, para controle da movimentação dos processos judiciais que a Secretaria tinha conhecimento. A planilha também era preenchida manualmente por cada assessor, todos ao mesmo tempo e por isso, algumas vezes, a atualização de dados se perdia, ocasionando perda de informações, duplicações em cadastro de processos e o levantamento dos quantitativos também eram feitos manualmente, contando célula a célula, pois na planilha havia processo judicial e administrativo.

Ademais, importante reforçar que os resultados aqui apresentados se baseiam na comparação do registro do estado das demandas de saúde pública do ano de 2018

(1.215 demandas) com as demandas de saúde pública registrada pelo sistema interno da secretaria de saúde do município de São Luís (553 demandas) – dados obtidos pelo grupo a partir da análise das informações encaminhadas pelo TJMA e pela SEMUS.

Nos dados do SIJUR, sistema que identifica as demandas judiciais de saúde pública no município de São Luís, há registro de ações de indenização, pedido de procedimentos, realização de exames, fornecimento de dieta enteral, fornecimento de medicamentos, fornecimentos de órtese e prótese, transferência de leitos, reforma e adaptações em unidades, internação compulsória, fornecimento de fraldas, tratamento de oxigenoterapia, transporte para tratamento de hemodiálise, tratamento de iodoterapia e radioterapia, entre outras. As demandas de saúde da SEMUS, identificado por assunto no ano de 2018, pode ser atestado por meio da Tabela 2 a seguir:

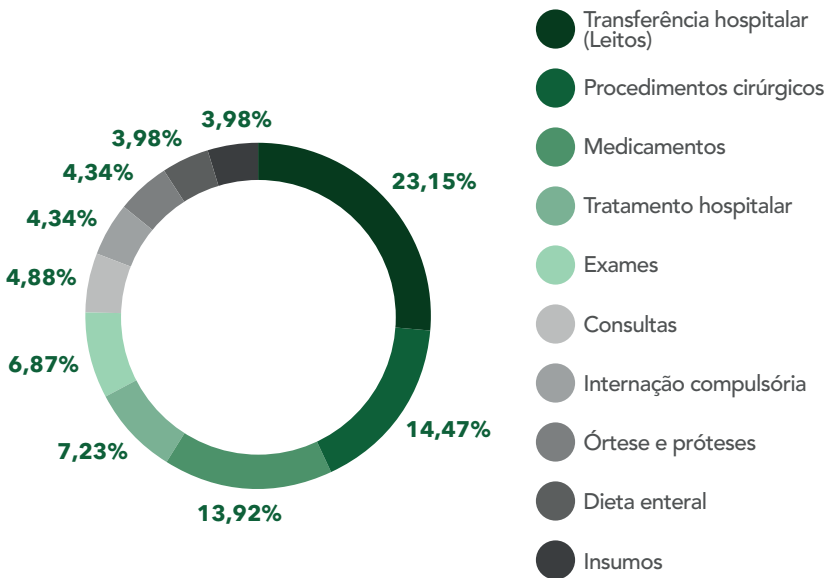
TABELA 2. Demandas de saúde pública do município de São Luís cadastradas no SIJUR, entre os meses de janeiro a outubro de 2018.

PRINCIPAIS ASSUNTOS	N.º	EM PERCENTUAL (%)
Transferência hospitalar (Leitos)	128	23,15
Procedimento cirúrgico	80	14,47
Medicamentos	77	13,92
Tratamento hospitalar	40	7,23
Solicitação de exames	38	6,87
Solicitação de Consulta	27	4,88
Solicitação de internação compulsória	24	4,34
Órtese e Prótese	24	4,34
Dieta enteral	22	3,98
Insumos	22	3,98
Iodoterapia	10	1,81
Bloqueio Judicial	10	1,89
Stent farmacológico	10	1,45
Indenização por danos morais/materiais	8	1,45
Solicitação de avaliação psicológica	8	1,45
Cobranças por empresas	7	1,27
Inclusão no programa Melhor em casa	6	1,08
Radioterapia	4	0,72

Solicitação de relatório médico	2	0,36
Oxigenoterapia	2	0,36
Irregularidades em unidades	1	0,18
Inclusão no programa saúde do idoso	1	0,18
Hemodiálise	1	0,18
Visita domiciliar	1	0,18
Total	553	100%

Fonte: SIJUR (SEMUS).

FIGURA 3. Ações Judiciais referentes às principais demandas de saúde em desfavor do município de São Luís, no período de janeiro a outubro de 2018.



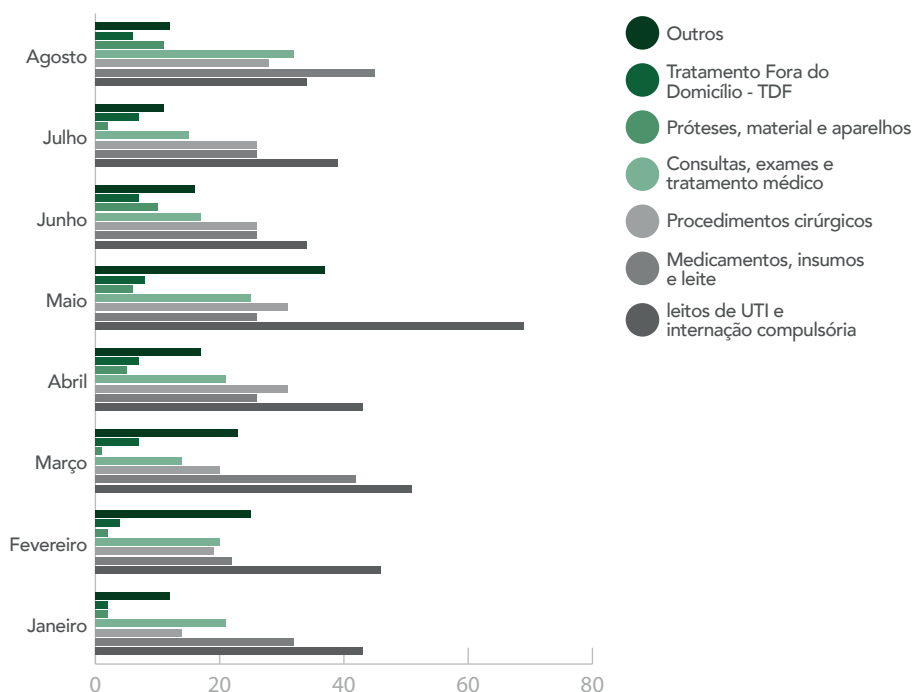
Fonte: SEMUS/SIJUR.

No estado do Maranhão, os 1215 processos referentes às demandas de saúde pública foram agrupados nas seguintes categorias: a) leitos de UTI (Transferência hospitalar) e internação compulsória; b) medicamentos, insumos e leite; c) procedimentos cirúrgicos; d) consultas, exames e tratamentos médicos; e) próteses, materiais e aparelhos;

f) TDF; e g) Outros - danos morais, mandados de intimação, carta precatória, informações, declarações, relatórios.

As categorias “a”; “b”; “c” e “d”, são as que possuem maior frequência no período analisado, conforme apresentado na Figura 4.

FIGURA 4. Demandas de Saúde pública no estado do Maranhão, de janeiro a agosto de 2018.



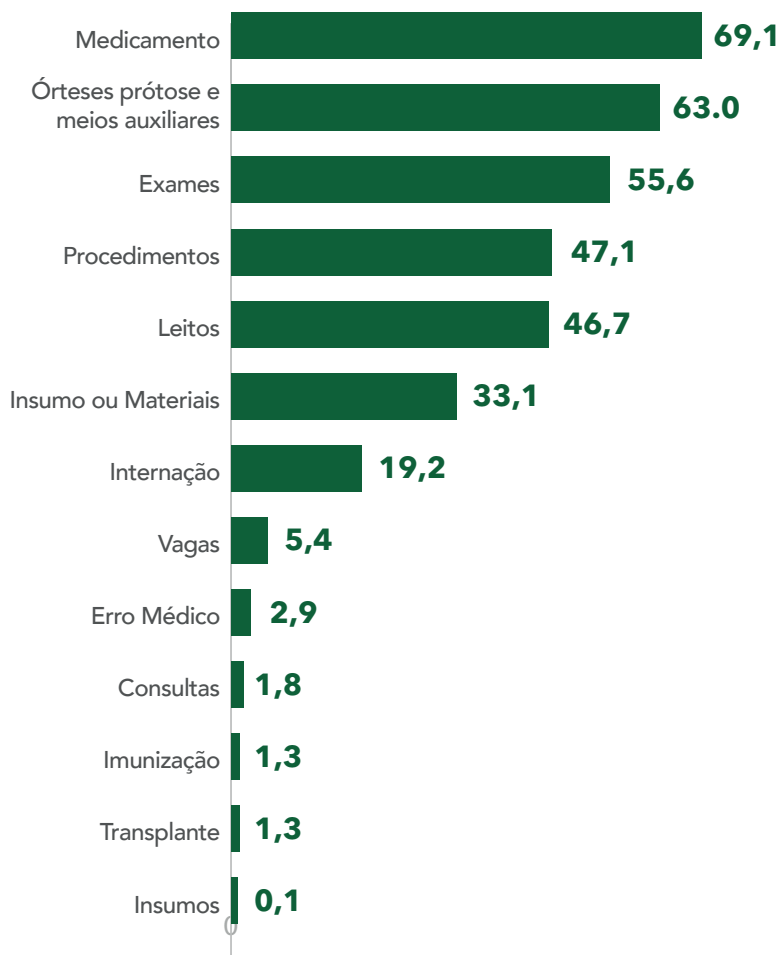
Fonte: TJ/MA.

Tanto os dados das demandas de saúde do município de São Luís, como os dados informados pelo estado do Maranhão permitem a mesma conclusão, que as ações relacionadas à leito de UTI, procedimentos cirúrgicos, órtese e próteses, exames e medicamentos são as que aparecem com maior representatividade.

Tais demandas em saúde que se verificam no município de São Luís, bem como no

Estado do Maranhão, estão compatíveis com o cenário nacional (1), como se verifica na Figura 5 a seguir:

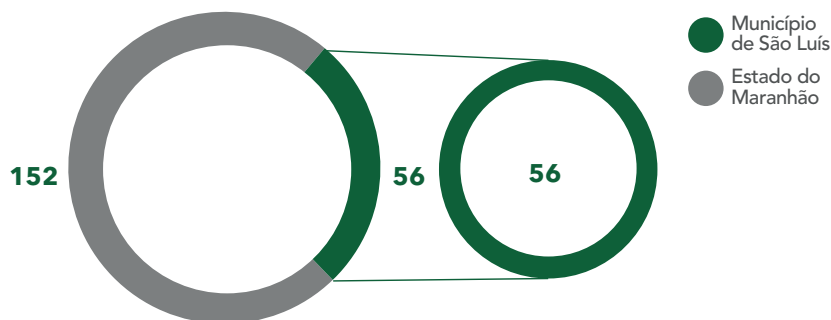
FIGURA 5. Principais demandas de saúde no Brasil decididas em segunda instância.



Fonte: <<https://www.insper.edu.br/conhecimento/direito/judicializacao-da-saude-dispara-e-ja-custa-r-13-bi-a-uniao/>>.

Da análise dos dados de demanda de saúde no ano de 2018 apresentados pelo TJMA e pelo sistema SIJUR da SEMUS observa-se que a média de ações em saúde pública ajuizadas no estado do Maranhão seria de 152 demandas por mês (1.215 demandas/8 meses) e destas, aproximadamente 56 demandas (553 demandas/ 10 meses) seriam ajuizadas em desfavor do município de São Luís. Assim, pode-se demonstrar a judicIALIZAÇÃO da saúde pública município de São Luís, conforme Figura 6:

FIGURA 6. Representação das demandas de saúde pública ajuizadas em desfavor do município de São Luís-MA.



Fonte: TJMA, Sistema SIJUR/SEMUS.

Para o estudo, foi feita uma análise pormenorizada, de cinco categorias de demandas de saúde pública do município de São Luís, por meio da análise de 25 (vinte e cinco) ações escolhidas de forma aleatória. Tal escolha se deu pela dificuldade de acesso do PJE.

Os assuntos escolhidos foram: i) transferência hospitalar - leitos (23,15%); ii) medicamentos (13,92%); iii) exames (6,87%); iv) órtese e prótese (4,34) e; v) dieta enteral (3,98%).

A análise dos processos selecionados se restringiu aos seguintes elementos: a) a representação do autor; b) existência de litisconsórcio passivo; c) decisão sobre o

pedido liminar; d) situação atual da ação judicial. A Tabela 3 apresenta as informações agrupadas.

TABELA 3. Análise de ações judiciais de saúde no município de São Luís-MA.

	LEITO	MEDICAMENTO	EXAMES	PROCEDIMENTOS	DIETA ENTERAL
AUTOR	80% DPE 20% adv. Particular	80% DPE 20% adv. Particular	100% DPE	60% MPE 40% DPE	80% DPE 20% MPE
RÉU	Município e Estado	Município e Estado	80% litis- consórcio passivo Estado e município 20% contra o muni- cípio exclusiva- mente	40% litisconsórcio passivo Estado e município 60% contra o município exclusivamente	40% litis- consórcio passivo Estado e município 60% contra o município exclusiva- mente
PEDIDO LIMINAR	Em todos- 100% deferido	Em todos- 100% deferido	Em todos - 100% deferido	60% deferido 40% indeferido	Em todos - 100% deferido
SITUAÇÃO ATUAL	80% extintas 20% pendente de recurso	100% pendente de recurso	40% extinto 40% pendente derecurso 10% sem sentença	40% com decisão judicial 60% sem decisão judicial	60 % pendente de recurso 40% cum- pridas por bloqueio judicial

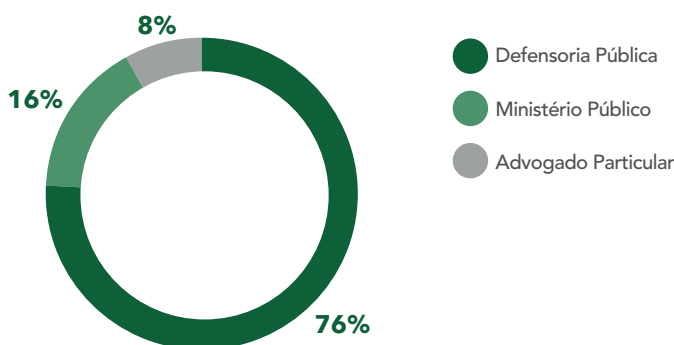
DPE: Defensoria Pública do Estado

MPE: Ministério Público do Estado

Fonte: TJMA.

Quanto à representação dos autores, a Defensoria Pública se destaca como instituição mais representativa, conforme se verifica na Figura 7.

FIGURA 7. Representação autor/paciente.



Fonte: SIJUR-SEMUS/ PJE.

Após, observa-se também uma forte atuação do Ministério Público do Estado (MPE) do Maranhão, e, por fim, uma tímida, mas presente ação dos advogados particulares.

Considerando a pouca participação de advogado particular, observou-se que os pedidos são formulados por pessoas que têm baixa condição financeira e ainda, que a representação mais ativa da Defensoria Pública está ligada à existência de uma DPE estruturada no estado e, especialmente, no município de São Luís, que é a capital do estado do Maranhão. O município possui 2 (dois) defensores públicos no Núcleo de Defesa do Idoso, da Pessoa Portadora de Deficiência e da Saúde.

Na CF/88 (2), em seu artigo 134, observa-se que incumbe à Defensoria Pública a defesa dos necessitados de forma integral e gratuita, nos seguintes termos:

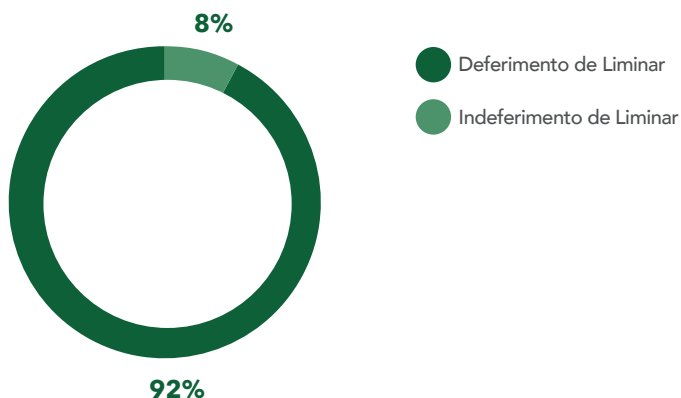
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos

e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal (2).

Com relação à atuação do MP nos 25 processos analisados, verificou-se a sua atuação somente em quatro processos, ambos em ações individuais, sendo destas, três com pedido de órtese e prótese e uma de dieta enteral.

As decisões são em sua maioria favoráveis ao demandante e em sede liminar, com prazos curtos para o cumprimento pelo ente público, normalmente em horas e com multas altas por descumprimento, como se verifica na Figura 8.

FIGURA 8. Deferimento de medida liminar nas demandas de saúde.



Fonte: SIJUR-SEMUS/PJE.

Em todas as ações analisadas foram deferidos os pedidos de assistência gratuita e ocorreu o bloqueio judicial em 20% delas, conforme pode-se observar na tabela a seguir. Em relação ao bloqueio, cabe salientar que nas ações em que o Estado também

figura no polo passivo o valor é dividido por igual, restando 50% da demanda para cada ente.

TABELA 4. Caracterização das decisões judiciais ajuizadas contra o município de São Luís, no ano de 2018.

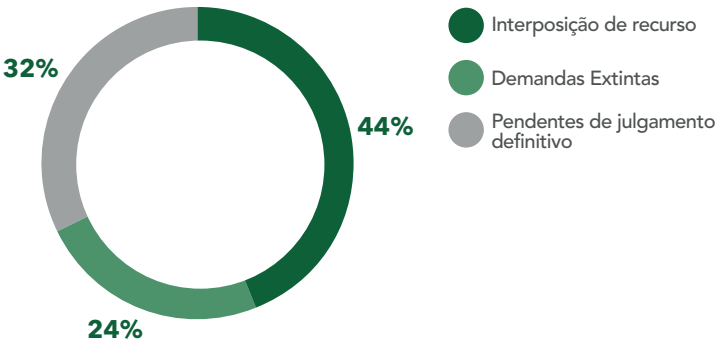
CARACTERÍSTICAS DAS DECISÕES JUDICIAIS ANALISADAS		
Decisão Liminar	8% não possuem decisão liminar	92% com deferimento de tutela provisória de urgência
Justiça Gratuita	100% assistência gratuita	
Bloqueio Judicial	20% com bloqueio judicial	

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Das 25 ações analisadas, somente uma delas, referente a órtese e prótese, não possui decisão proferida, seja em sede liminar ou julgada em definitivo.

Observou-se também que em 44% das demandas houve interposição de recurso pelos entes (seja ele estadual ou municipal e o ente estadual é mais eficiente nesse quesito); 24% das ações foram extintas ou por perda do objeto ou por desistência do autor e, 32% pendente de julgamento definitivo, apesar de serem ações de 2018 e se tratar de demandas urgentes.

FIGURA 9. Andamento Processual das demandas em saúde analisadas.



Fonte: PJE.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Por meio da Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010 (3), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sugeriu aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que:

- a) até dezembro de 2010 celebrem convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais.

A Resolução n.º 107, de abril de 2010 (4), do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Saúde com o escopo de estudar a judicialização da saúde e propor soluções para diminuir os conflitos nas demandas de saúde e dar efetividade ao direito à saúde, bem como “estabeleceu a necessidade de instituição de Comitês da Saúde Estaduais como instância adequada para encaminhar soluções para a melhor forma da prestação jurisdicional na área da saúde” (4).

O Fórum Nacional de Saúde é coordenado pelo Comitê Nacional de Saúde, criado em 11 de maio de 2010, pela Portaria n.º 91 do CNJ (5).

Uma vez que o município analisado é também a capital do estado do Maranhão, muitas das ações de enfrentamento da judicialização guardam estreita relação entre os entes da federação, motivo pelo qual é objeto de exame nas seções que seguem.

Os primeiros membros do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Maranhão foram nomeados por meio da Portaria n.º 25, de 22 de março de 2011 (6), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 2016, o CNJ editou a Resolução n.º 238 (7), que dispõe acerca da “criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de Fazenda Pública”.

Uma das atribuições do Comitê é auxiliar os tribunais na criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS).

Nos Comitês discute-se de forma prévia as demandas antigas, bem como as novas, e buscam a melhor maneira de se resolver as demandas de saúde, evitando-se custos com o Poder Judiciário, bem como a demora na resolução das demandas, de forma a se assegurar a urgência que o direito à saúde requer (3).

O Comitê está sempre aberto a sugestões e críticas, recebendo as pessoas que atuam na área de saúde pública, bem como a população.

As reuniões ordinárias do Comitê são mensais, e ocorrem, geralmente, na última quinta-feira do mês. Suas deliberações são informadas ao CNJ, ao TJMA e demais órgãos atuantes na saúde pública, para o fim de torná-las públicas e vincular os órgãos participantes quanto ao cumprimento das deliberações. Na maioria das reuniões há deliberações, haja vista o constante surgimento de novos tipos de demandas acerca da saúde pública no município.

No Estado do Maranhão, por meio do Projeto Lei Complementar n.º 005/2018 (aprovado em 21/03/2019), criou-se a 17ª Vara da Saúde na Comarca da Ilha de São Luís, Vara de Fazenda Pública especializada em saúde, estando pendente para sua implantação apenas o espaço físico para ocorrer o seu efetivo funcionamento (8).

Como estratégias de enfrentamento das demandas da área da saúde no município de São Luís, pode-se salientar a atuação do Comitê Estadual de Saúde, na busca da implantação da Vara Especializada da Saúde, Audiências de Mediação Sanitária, Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o município de São Luís e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, as ouvidorias, dentre outros, que se passa a analisar a seguir.

O Núcleo de Assistência Técnica (NAT) ainda não foi instalado no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). As justificativas do tribunal para a não instalação são de cunho financeiro, pois há divergências acerca da forma de remuneração dos integrantes do núcleo (criação de novos cargos ou pagamento de horas extras aos servidores existentes – banco de horas) (3).

Segundo o Presidente do TJMA, o projeto para a implantação do núcleo ainda está tramitando, entretanto, atualmente não possui orçamento para criação de novos cargos, contratação de novos servidores, estudando uma forma de compensação aos servidores por meio de banco de horas. Aguarda-se que a efetivação do NAT-JUS ocorra durante o ano de 2020 (3).

Mesmo diante das dificuldades apresentadas para a implantação do NAT-JUS no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o que traria impacto direto nas ações tramitadas em desfavor do município de São Luís, observa-se que a ausência do núcleo não evita que o magistrado decida, pois se utiliza de outros meios para decidir, como os pareceres dos NAT-JUS de outros estados por meio do E-NatJus (banco de dados do CNJ) ou a oitiva de gestores e outros profissionais que trabalhem com a saúde, dando-lhe ferramentas de como se posicionar nas demandas de saúde que se apresenta (3).

Quanto às formas extrajudiciais de resolução de conflitos, destaca-se a mediação e a mediação sanitária. As audiências de Mediação Sanitária são utilizadas no município de São Luís pelo Ministério Público, tendo como principal objetivo resolver de forma administrativa e, conseqüentemente, mais rápida às demandas de saúde.

No âmbito do município de São Luís, existem três promotorias especializadas na saúde, são elas as 18ª, 19ª e 20ª Promotoria de Justiça. Para as audiências elas agem encaminhando ofício à SEMUS, solicitando o comparecimento com data e horário marcados, especificando o objeto da demanda, na busca por conhecimento da situação do município e verificação das possibilidades de atendimento àquele determinado assistido (quando demandas individualizadas ou pedidos coletivos quanto a algo em específico, exemplo, consulta, dieta).

No geral, o Ministério Público recebe denúncias, e é por meio delas que entra em contato com o órgão. Tais denúncias versam sobre ausência de profissional especialista; equipamento quebrado e conseqüente não realização de um determinado exame; demora nas marcações de consultas; irregularidades nas unidades (que vão desde pintura, parte estrutural, quanto equipamentos ou acesso para pessoas com limitações físicas).

Com base nessas denúncias, o MP convoca a Secretaria Municipal de Saúde por meio de audiências de mediação sanitária para questionar sobre os pontos que foram denunciados e quais os meios que existem para solucionar o problema posto.

Caso seja possível a solução na via administrativa, e seja esta realizada, arquivam-se os autos, mas em caso negativo, buscam judicializar e promover a responsabilização do gestor.

Destaca-se, ainda, que no ano de 2018, visando à redução de ações judiciais, a Prefeitura Municipal de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (SEMUS), firmou parceria com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão por meio do Acordo de Cooperação Técnica, em que a SEMUS disponibilizou um profissional farmacêutico para assessoramento e análise de receituários em demandas que buscam medicamentos e insumos previstos na área farmacêutica para os assistidos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (9).

O resultado de tal acordo foi a celeridade nos encaminhamentos das demandas por medicamentos e outros insumos, evitando assim a judicialização.

Outro processo estratégico na resolução de conflitos de demandas de saúde é a implantação de ouvidorias municipais. O município de São Luís conta com uma Ouvidoria Municipal de Saúde, entretanto não se conseguiu obter dados acerca da sua atuação na redução da judicialização da saúde, pois a ouvidoria pode ser considerada uma importante ferramenta para tal redução, haja vista que coloca os administrados em contato direto com a Administração.

A ouvidoria permite que o cidadão exerça seu papel no controle social e na gestão pública de saúde. Permite também que o cidadão se manifeste acerca de como a administração pode melhorar a qualidade dos serviços prestados, bem como pode ser utilizada na tomada de decisões estratégicas na realização da saúde pública.

A Ouvidoria Municipal de Saúde foi implantada no município de São Luís-MA em 20 de dezembro de 2006. Por este canal, o usuário busca informações, realiza denúncias, reclamações, sugestões e elogios acerca da saúde no município.

A Portaria n.º 8 (10), de 25 de maio de 2007, regulamenta o Sistema OuvidorSUS, estabelecendo que as demandas recebidas pelo município devem ser respondidas no prazo mínimo de 3 dias após o seu registro, levando-se em consideração a gravidade do caso. O prazo máximo para conclusão das demandas é de até 90 dias.

Embora não se tenha concretizado na pesquisa como meio eficaz para se realizar uma Administração municipal mais eficiente, acredita-se que a Ouvidoria é uma ferramenta com bastante potencial para se alcançar a efetividade da defesa da saúde diretamente pelo cidadão.

De todos os estudos e pesquisas realizadas, destaca-se a importância do diálogo interinstitucional, este promovido entre as instituições envolvidas na efetivação do direito à saúde.

No Estado do Maranhão, as instituições e órgãos que compõem o Comitê Estadual de Saúde utilizam-se do aplicativo *WhatsApp*, em que mantêm comunicação para resolver as demandas de saúde o mais rápido possível e somente no caso de esse meio de comunicação não conseguir resolver a demanda de forma que atenda ao interesse de saúde pleiteado é que se busca ajuizar demanda judicial.

Destaca-se, também, a necessidade de realização de fóruns estaduais de saúde para mais uma vez promover o diálogo interinstitucional. Nestes espaços, discute-se os casos concretos em que se verifica a ocorrência da judicialização da saúde de forma mais frequente, o que pode estar causando-a e como evitá-la.

Os fóruns também são importantes para reforçar a utilização de meios extrajudiciais de resolução de conflitos, pois a boa técnica que o Poder Judiciário vem buscando e utilizando na resolução dos conflitos é a implantação de meios de conciliação das demandas entre o cidadão e o Poder Público.

Destaca-se, ainda, a gestão compartilhada que possui grande importância para a resolução de conflitos, não só de saúde. Esta se dá com a participação de trabalhadores e usuários dos serviços públicos de forma ativa, contribuindo bastante na resolução das demandas de saúde na Administração Pública.

Relevante ressaltar o incentivo à qualificação dos profissionais para um atendimento humanizado, minimizando o número de reclamações juntamente ao Ministério Público e órgãos competentes.

Outro fator que tem contribuído para diminuir a judicialização da saúde pública é o aumento da oferta do número de consultas médicas especializadas e outros serviços especializados, visando suprir as demandas e reduzir a quantidade de solicitações via regulação municipal, evitando possíveis conflitos judiciais.

Cabe, ainda, à Administração municipal apresentar em suas leis orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) um planejamento com base em estudos, de forma a identificar as necessidades da população e a implantação de uma atenção básica estratégica de forma muito mais efetiva.

Sobremaneira relevante é a implantação das Varas da Saúde no Poder Judiciário, pois promove a especialização, qualificação e intimidade dos juízes com o Direito Sanitário. Verificou-se a ocorrência de capacitações dos juízes no estado do Maranhão por meio da Escola da Magistratura com a realização de palestras e seminários. Entretanto, a capacitação dos juízes em Direito Sanitário seria bastante interessante, pois faria com que compreendessem melhor a sistemática da legislação de saúde e os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, contribuindo para a melhor compreensão das necessidades do Poder Público e da sociedade.

Um dos principais problemas identificados para se realizar o enfrentamento da judicialização da saúde no município de São Luís foi a dificuldade de se diagnosticar os quantitativos das demandas de saúde pública ajuizadas em desfavor dos entes municipal e estadual. Assim, os dados que são colhidos não demonstram a realidade exata da judicialização no município.

O grupo enfrentou grande dificuldade em obter dados acerca do número de ações judiciais em matéria de saúde no ano de 2018. Primeiramente, os dados fornecidos pela SEMUS não são exatos, mas já obteve uma melhoria, pois passou da alimentação de planilha do Excel para a implantação do Sistema do Jurídico (SIJUR). Apresentou melhora no acompanhamento, mas somente do tipo de demanda registrada no sistema, não permitindo uma análise do perfil das demandas de saúde.

De igual modo, os dados disponíveis no TJMA demonstraram uma deficiência de acompanhamento das demandas de saúde pelo próprio tribunal, que não possuem informações específicas sobre municípios e as que possuem, são incompletas. Assim, a pesquisa foi possível a partir de uma análise comparativa entre os dados registrados no SIJUR e os dados fornecidos pelo TJMA. Com isso pode-se identificar a fragilidade das informações e uma grande chance de falhas no processo de alimentação dessas informações.

Há, portanto, a necessidade de se criar um sistema de acompanhamento das ações judiciais que possa identificar as demandas, em tempo real, mas com uma padronização de nomenclatura de demanda, que possa ser usada tanto pelo Poder Executivo como pelos órgãos do sistema de justiça, o que contribuiria sobremaneira para tomadas de decisão de enfrentamento do fenômeno.

Quando se analisa o Relatório Analítico Propositivo acerca da Judicialização da Saúde no Brasil, do ano de 2018 (11), verifica-se que um dos principais obstáculos para uma análise real das demandas de saúde nos tribunais foi a forma como as informações são disponibilizadas pelos tribunais, muitas vezes incompletas e com classificações diversas, não havendo uma padronização. O CNJ informou que uma forma de enfrentar essa dificuldade é a implantação de um sistema de acompanhamento das ações nos estados que não possuem sistema ou, se possuem, seja falho ou ineficiente. O CNJ sugere a implantação nesses locais do sistema S-Codes (11), vejamos:

Em relação aos dados sobre judicialização, o S-Codes tem sido citado como um sistema de acompanhamento das ações judiciais e deve ser instituído nos estados que ainda não possuem um sistema próprio, ou que percebem o sistema existente como falho ou ineficiente. A importância de um sistema uniformizado para os diferentes estados se encontra na possibilidade de acompanhamento e melhores informações sobre a judicialização. Este, todavia, volta-se para os Executivos estaduais. Não há um único sistema de informação para o Judiciário e isso dificulta o acesso a dados dos diferentes estados, o que ficou claro pela pesquisa quantitativa aqui apresentada. Assim, a uniformização dos sistemas, não apenas nos Executivos, mas também nos TJs, parece essencial para aprimorarmos a gestão da judicialização. Esse aspecto foi apontado em diversas entrevistas, inclusive com a sugestão de um “livro de códigos” único a ser utilizado pelos tribunais de todo o país.

Embora o sistema S-Codes ofereça uma solução ao problema, ao analisar a situação atual do município, o grupo considerou que seria mais viável aperfeiçoar o sistema já utilizado pelo órgão que monitora as ações judiciais envolvendo a saúde, qual seja, o SIJUR.

Atualmente, o SIJUR não é suficientemente estruturado para fornecer um conjunto de informações, isto porque ele não foi criado para monitorar as ações judiciais do município, mas sim, para a secretaria conseguir quantificar pedidos (administrativos e judiciais) e fazer levantamento/relatórios dos itens mais demandados, que não são distribuídos por áreas, no sistema. Assim, o grupo sugere algumas alterações no sistema, de modo que este possa oferecer um controle mais preciso da situação da judicialização da saúde em São Luís.

O sistema SIJUR possui uma tela inicial, que apresenta processos que estão fora do setor e monitora audiências que estejam próximas, possui uma lista de processos e indica quantos estão abertos individualmente. Há aba de dados gerais, e identificação quanto à instância do processo (se judicial ou administrativo), data de inclusão no sistema, a origem do processo (número da vara – se for judicial) e descrição (se é pedido, decisão, nome da parte e o que está pedindo). Nas outras abas, as informações disponíveis são relacionadas ao nome das partes (requerente, requerido, beneficiário, assistido), sanção, multas, audiências, tramitação e *status*. A parte de multas e sanções nem sempre são preenchidas e a tramitação e *status* seria apenas para monitorar o processo de forma interna.

Assim, o que se percebe como uma ferramenta premente de acompanhamento da judicialização em tempo real - capaz de produzir acompanhamento e intervenção mais precisos - é a instalação de um sistema de informação que permita ao município acompanhar os processos e que possa identificar o perfil da demanda de forma detalhada, como os autores/pacientes, médicos, prescritores, os advogados que entram com as ações judiciais, juízes que emitem as sentenças, o perfil do produto ou tratamento requerido, bem como seus respectivos valores. Esses dados permitirão atuar preventivamente nas ações e serviços mais demandados, reorganizar tarefas e prioridades, se assim o gestor entender, e ainda, verificar o impacto financeiro da judicialização da saúde no município.

Essas ações coordenadas permitirão uma melhor gestão da saúde do município, por meio de um retrato real das demandas de saúde, com a possibilidade de identificação de erros ou falhas na gestão da saúde no município, bem como fraudes, e o dimensionamento real de quanto se gasta no município com a judicialização da saúde pública.

Como na SEMUS já existe um sistema de controle centralizado de processos, o SIJUR, o grupo propõe o aperfeiçoamento desse sistema, a partir da identificação das necessidades de aprimoramento apontadas por um grupo gestor, nomeado especificamente para essa finalidade.

Considerações Finais

Buscou-se com o presente trabalho diagnosticar a judicialização da saúde no município de São Luís, bem como apresentar estratégias de enfrentamento ao problema. A maior dificuldade apresentada foi a própria obtenção das informações, já que não existe um padrão de acompanhamento e monitoração das demandas de saúde, bem como o acompanhamento que existe é ineficaz e não permite retratar a realidade da judicialização da saúde no município e no próprio estado.

Os dados obtidos foram repassados pelo Tribunal de Justiça, mas com o alerta de que representam um diagnóstico e que não correspondem à realidade, devido às dificuldades de monitoramento dessas ações. Os dados obtidos por intermédio da SEMUS também foram repassados com o alerta de que se trata de um sistema implantado em julho de 2018 e não nos permitiria uma retratação real da realidade da judicialização da saúde no município, já que não possibilita o diagnóstico do perfil das demandas, somente um registro de controle das demandas.

Verificou-se que as instituições que atuam na judicialização da saúde no município de São Luís estão buscando se qualificar e entender cada vez melhor esse fenômeno que, como se trata da efetivação de um direito tão importante, mostra que veio para ficar e que não se trata de fenômeno passageiro.

Ao que tudo indica, no município de São Luís a judicialização da saúde não vai diminuir ao longo dos anos. O estado do Maranhão é um dos entes da federação com os índices de desenvolvimento humano (IDH) mais baixos do país, entretanto, o município de São Luís mostra-se bastante evoluído em relação aos demais municípios do estado.

Entende-se que a primeira necessidade é ter um levantamento do quantitativo real dessas demandas no município de São Luís, pois não há como trabalhar na prevenção, na tentativa de amenizar, diminuir ou quem sabe um dia erradicar, o que não se tem conhecimento fático.

Para isso, no presente trabalho, foi proposto o aperfeiçoamento do sistema de informações do município de São Luís, como uma medida para auxiliar o combate à judicialização no município. Pois assim, será possível uma identificação real das demandas no município.

Espera-se que esse trabalho traga benefícios ao município, permitindo celeridade na resolução das demandas da população por ele atendida, haja vista que a identificação real das demandas de saúde possibilitará o controle tanto das pessoas que devem ser atendidas pelo município, como a identificação das verdadeiras necessidades da população, permitindo, ainda, uma administração municipal efetiva com relação ao uso dos recursos públicos, com o remanejamento de verbas de uma área da saúde que está apresentando gastos desnecessários/desproporcionais para outra que possui mais demandas reprimidas. Espera-se, assim, que o município de São Luís possa atender sua população de forma mais universal, integral e equitativa.

Referências

- 1 - Insper Conhecimento. **Judicialização da saúde dispara e já custa R\$ 1,3 bi para a União** [Internet]. São Paulo, 2019. [citado 08 dez 2019]. Disponível em: <<https://www.insper.edu.br/conhecimento/direito/judicializacao-da-saude-dispara-e-ja-custa-r-13-bi-a-uniao/>>.
- 2 - Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília-DF: Senado Federal; 2019.
- 3 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 7 abr. 2010. [citado 18 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=877>>.
- 4 - _____. Resolução n.º 107, de abril de 2010. **Institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde** [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 7 abr. 2010. [citado 18 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/173>>.
- 5 - _____. **Portaria n.º 91, 11 de maio de 2010**. Organizadora do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. [Internet]. Brasília, Diário de Justiça Eletrônico/CNJ n.º 87/2010; 14 maio 2010. [citado 18 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/707>>.
- 6 - _____. **Portaria n.º 25, 22 de março de 2011**. Designa membros para compor os Comitês Executivos Estaduais no âmbito do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde. [Internet]. Brasília, Diário de Justiça Eletrônico/CNJ n.º 53/2010; 24 mar 2011. [citado 18 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/473>>.
- 7 - _____. **Resolução n.º 238, de 06 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês estaduais da saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de Fazenda Pública. [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 9 set 2016. [citado 18 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.
- 8 - Sarayva M. **Aprovado projeto que cria Vara da Saúde Pública no MA**. 2019. [Internet]. Maranhão, 2019. [citado 29 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.ma10.com.br/2019/03/21/aprovado-projeto-que-cria-vara-da-saude-publica/99>>.

9 - **Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís.** [Internet]. Maranhão: Diário Oficial do Município n.º 2, de 03 Jan de 2018. [citado 03 dez 2019]. Disponível em: <<http://sistemas.semاد.saoluis.ma.gov.br:8090/easysearch/cachedownloader?collection=default&docId=da42063e49465a05cac6f7d36e1c8b817f6ac9fb&fieldName=Download&extension=pdf#q=Acordo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica%20com%20a%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20do%20Estado%20do%20Maranh%C3%A3o>>.

10 - Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria N.º 8, de 25 de maio de 2007.** Regulamenta o Sistema OuvidorSUS [Internet]. Brasília, 2007. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html>.

11 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Relatório Analítico Propositivo acerca da Judicialização da Saúde no Brasil, ano de 2018.** [Internet]. Brasil, 2019. [citado em 30 jan. 2020]. Disponível em: <<https://static.poder360.com.br/2019/03/relatorio-judicializacao-saude-Insper-CNJ.pdf>>.

Capítulo 3

REGIÃO SUL



Município de Canoas-RS

Município de Curitiba-PR

Município de Fraiburgo-SC

Município de São Bento do Sul-SC

Município de São José-SC



Projeto de intervenção: um retrato da judicialização do sus no município de Canoas-RS

Fernanda Marroco¹

Henriete Santos²

Marcelo Poeys Dair³

Myllena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira⁴

Suzy Oliveira Ribeiro⁵

Thaís Silva de Moura Barros⁶

Vanessa Limeira de Azevêdo⁷

Orientador: Prof. MSc. Ivan Pricken de Bem

A escolha de Canoas para o estudo considerou a riqueza histórico-cultural do município, aliada ao fato de haverem indicativos da existência de materiais, softwares e sítios eletrônicos contendo informações importantes para o trabalho.

O nome do município possui representação histórica, pois os homens que trabalhavam na estação férrea se utilizavam de grandes árvores para construir canoas, para facilitar

¹ Graduada em Enfermagem pela FAEMA. Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela AVM Faculdade Integrada. Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família no município de Machadinho D'Oeste-RO.

² Graduada em Gestão Pública pela UNIJUI. Diretora de Vigilância em Saúde do Município de Canoas-RS.

³ Graduado em Direito pela FDC. Secretário Municipal de Saúde no Município de São José de Ubá-RJ.

⁴ Graduada em Pedagogia pela UVA. Especialista em Gestão Estratégica em Educação pela UVA. Secretária Municipal de Saúde no município de Santa Cruz-RN.

⁵ Graduada em Direito pela FMF. Especialista em direito público pela UEA e em Direito Civil e Processo Civil pela CIESA. Assessora Jurídica da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas-AM.

⁶ Graduada em Odontologia pela UNIBAN e Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental. Mestre em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela UNIVALI. Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco-AC.

⁷ Graduada em Direito pela UFPB. Assessora Jurídica do Município de Santa Rita-PB.

o transporte por meio do Rio dos Sinos, fazendo o lugar conhecido como Capão das Canoas, atualmente município de Canoas.

Como metodologia, a primeira etapa do trabalho utilizou método de investigação em material teórico sobre o município de Canoas, dando início a construção de um diagnóstico e possibilitando maior compreensão da localidade estudada.

Uma pesquisa descritiva buscou nortear o estudo, descrevendo o objeto, registrando fenômenos e fatos, um método dedutivo, conforme o entendimento clássico, que, “parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica” (1).

Para a realização da pesquisa se optou em aliar um método dialético, conforme proposto por Hegel, as contradições transcendem-se, dando origem às novas contradições que passam a requerer solução. Empregando em pesquisa qualitativa, método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. As coisas e os acontecimentos existem como um todo, ligados entre si, dependentes uns dos outros (1).

O intuito foi o de explicar os porquês da judicialização e suas causas, por meio dos registros, da análise, da classificação e da interpretação dos dados secundários, obtidos de planilhas fornecidas pela Procuradoria Geral do Município (PGM) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Para tabulação dos dados processuais, foi utilizado o software Microsoft *Excel* a fim de se obter uma melhor organização e análise de dados.

Diagnóstico da Judicialização no Município

Para o estudo, foram analisados os dados, como mencionado, recebidos da PGM e SMS sobre processos judiciais em desfavor do SUS municipal, que tramitaram de janeiro de 2018 a dezembro de 2019.

Verificou-se que não havia uma padronização na organização dos dados referentes à judicialização da saúde nem na PGM e nem na SMS, de modo que as informações foram recebidas de forma desordenada, faltando alguns itens, o que tornou necessário compilar em planilha para melhor entender, quantificar e qualificar as demandas judiciais contra o município. De outro turno, nos órgãos municipais não há profissionais que atendam com exclusividade demandas judiciais de saúde.

Após a compilação das informações, foi possível observar que não há um controle eficaz e padrão dos processos referentes à judicialização do SUS, cada um dos locais tem sua forma de agir.

Boa parte das demandas tramita entre os órgãos municipais por intermédio de memorando interno no sistema *intranet*. Apenas o autor e as pessoas para as quais o documento circulou podem ter acesso. Assim, por não serem os dados abertos ao público geral, sua coleta foi dificultada.

Outro sistema utilizado no município para processos administrativos é o Módulo de Processos Virtuais (MVP). Neste, é possível o acesso remoto, mas, para isso, é necessário que seja inserido algum dado como nome do autor ou o número do processo. Dessa forma, o MVP não foi suficiente, isoladamente, para obter os dados gerais, pois foram exigidas informações sobre a totalidade de processos judiciais.

Para o trabalho, a planilha final formada comparou e mesclou informações constantes na planilha de processos *intranet* que chegam para o Secretário de Saúde e na planilha fornecida pela PGM, ambas em formato *Excel*.

Foram identificados o total de 384 processos judiciais no ano de 2018 e 309 no ano de 2019, o que demonstrou uma redução de 19,32% nas demandas judiciais de um ano para o outro. De acordo com o Secretário de Saúde, esta redução se deu em virtude do atendimento das demandas no nível administrativo.

A judicialização de medicamentos atingiu o patamar de 71,35% das demandas judiciais no ano de 2018, tendo demonstrado uma redução no ano de 2019 para 49,84% das demandas. Em segundo lugar vem as demandas de internação de saúde mental, com 13,54% no ano de 2018 e 7,77% no ano de 2019, sendo a maior parte dessas

demandas solicitadas pelo Judiciário, por Vara de Violência Doméstica e Vara da Infância e Juventude para internações compulsórias de adolescentes em situação de drogadição. Poucos são os pedidos de internação para doenças psiquiátricas sem uso de substâncias psicoativas.

Tomando por base essa análise, foi possível observar que a maior parte dos pedidos versam sobre medicamentos não previstos na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), porém com registro na Anvisa. Observou-se também, que a grande maioria desses medicamentos fazem parte dos Componentes Especializados da Assistência Farmacêutica (CEAF). Em razão da transversalidade, o CEAF inclui três grupos de medicamentos que contemplam as linhas de cuidado para as doenças elencadas no componente. Sendo a responsabilidade de financiamento e aquisição diferenciados para cada esfera de gestão: federal, estadual e municipal (2).

Vale ressaltar que no ano de 2019, foi observado um crescimento na demanda de pedidos de internação em UTI, isso se deu em decorrência de Canoas ser referência para mais 156 municípios do estado, e ter enfrentado uma falta de repasses financeiros, o que levou o município a restringir atendimentos.

O estudo também apontou que a judicialização da saúde se tornou relevante não apenas para o sistema de assistência à saúde, mas para o próprio Judiciário, que tem que lidar com centenas de processos, vários dos quais sobre temas recorrentes e em sua maioria contendo pedidos de antecipação de tutela ou liminares (3).

Da leitura da Tabela 1, é possível perceber que os principais pedidos foram de medicamentos: no ano de 2018, foram 274 processos judiciais pleiteando fármacos, representando 71,35% e no ano de 2019, 49,84% da judicialização se destinava a atender pedidos de medicamentos.

As internações em saúde mental ficaram em segundo lugar dentre os pedidos mais frequentes, com 52 processos judiciais com este tipo de pleito no ano de 2018, representando 13,54% dos pedidos e 24 no ano de 2019, representando 7,77% dos pedidos.

TABELA 1. Relação dos pedidos judiciais do município de Canoas nos anos de 2018 e 2019.

PEDIDO	2019	%	2018	%
Erro Médico	1	0,32%	1	0,26%
Equipamentos	1	0,32%	5	1,30%
Insumos	4	1,29%	4	1,04%
Acolhimento Saúde Mental	6	1,94%	6	1,56%
Indenização	10	3,24%	6	1,56%
Cirurgia	14	4,53%	20	5,21%
Outros	21	6,80%	4	1,04%
Internação Médico-Hospitalar	22	7,12%	2	0,52%
Consultas e Exames	22	7,12%	4	1,04%
Internação Saúde Mental	24	7,77%	52	13,54%
Internação UTI	30	9,71%	6	1,56%
Medicamento	154	49,84%	274	71,35%
Total	309	100,00%	384	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos processos informados pela SMS e PGM.

Em 2019, o STF fixou tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário de n.º 855178, o qual trata da solidariedade dos entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial (4). Frente à solidariedade reconhecida a parte autora pode, em tese, ajuizar contra qualquer um dos entes que compõem o SUS.

Observou-se que as demandas judiciais na área da saúde, em desfavor do município de Canoas-RS, foram promovidas – em sua maioria – por intermédio da Defensoria Pública, o que aponta para a insuficiência de recursos dos representados.

Em segundo lugar, a representação é realizada por meio de advogados particulares. O Ministério Público aparece em terceiro lugar, sendo o responsável perante o Judiciário pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A Tabela 2 demonstra as representações dos autores de processos judiciais de saúde nos anos de 2019 e 2018.

TABELA 2. Relação de representação autor/paciente nos anos de 2018 e 2019.

REPRESENTAÇÃO DO AUTOR/PACIENTE	2019	%	2018	%
Serviço de Atendimento Jurídico na Universidade	1	0,32%	5	1,30%
Justiça Pública	8	2,59%	2	0,52%
Ministério Público	26	8,41%	34	8,85%
Advogado	65	21,04%	70	18,23%
Defensoria Pública	209	67,64%	273	71,09%
Total	309	100,00%	384	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos processos informados pela SMS e PGM.

Na Tabela 3, encontram-se relacionados os posições jurisdicionais sobre os pedidos nos processos de saúde, nos anos de 2019 e 2018.

TABELA 3. Relação das decisões judiciais nos anos de 2018 e 2019.

DECISÃO JUDICIAL	2019	%	2018	%
Parcialmente procedente	1	0,32%	2	0,52%
Extinto por resolução de mérito	1	0,32%	14	3,65%
Desistência	2	0,65%	6	1,56%
Óbito autor	3	0,97%	5	1,30%
Improcedente	4	1,29%	5	1,30%

Sem julgamento da ação	45	14,56%	91	23,70%
Procedente	253	81,88%	261	67,97%
Total	309	100,00%	384	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos processos informados pela SMS e PGM.

É possível observar que, como resposta às demandas judiciais, em sede de primeira instância, no ano de 2019, 81,88% das ações foram declaradas procedentes, contra 1,9% declaradas improcedentes, e 14,56% das ações sem julgamento.

No ano seguinte, foram 67,97% das ações declaradas procedentes e restaram 23,70% aguardando julgamento.

TABELA 4. Relação da distribuição dos processos nos anos de 2019 e 2018.

DISTRIBUIÇÃO	2019	%	2018	%
Vara de Família	4	1,29%	33	9%
Vara de Violência Doméstica	11	3,56%	2	1%
Vara Cível	37	11,97%	70	18%
Vara da Infância e Juventude	53	17,15%	76	20%
Vara Federal	56	18,12%	33	9%
Juizados Especiais Federais	148	47,90%	170	44%
Total	309	100,00%	384	100,00%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos processos informados pela SMS e PGM.

Pode causar estranheza o fato de constar no levantamento a presença de varas de família, varas de violência doméstica e varas de infância e juventude. Contudo, as determinações de internação em saúde mental, que representam o segundo objeto mais demandado judicialmente, são, em geral, oriundos dessas instâncias da organização judiciária.

Cumpramos ressaltar que a quase maioria dos processos foi distribuída para os juizados especiais federais: no ano de 2018, foram 170 processos, representando 44%; já no ano de 2019, foram 148 processos, representando 47,09% das ações judicializadas em face do município de Canoas.

O fato de muitas ações tramitarem na justiça federal pode ser visto como positivo, pois indica presença da União no processo, conforme art. 109 da Constituição Federal (5), o que possibilita uma repartição do ônus dos processos judiciais com os entes federados e, assim, uma carga não tão grande como a de costume em face do município.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A judicialização da saúde envolve questões complexas, exigindo das secretarias municipais de saúde a adoção de medidas que visem à redução do número de processos.

Uma das medidas adotadas é a instituição do Núcleo de Assistência Técnica (NAT), que tem por finalidade prestar informações e esclarecimentos adequados, emitindo laudos técnicos sobre itens demandados, baseado em evidências científicas, por equipe multiprofissional, composta especialmente por farmacêuticos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas e profissionais com conhecimento administrativo e jurídico.

Todavia, o Município de Canoas não tem um Núcleo de Assistência Técnica próprio, pois faltam trabalhadores para atuar nas demandas judiciais; o mesmo ocorre na Procuradoria Geral do Município.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio do Comitê Estadual da Saúde, já faz parte do NatJus, por meio de consultoria remota que auxilia os juízes na tomada de decisões dos processos relacionados com a atenção à saúde. O NatJus Nacional foi incorporado na plataforma digital do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (E-NatJus).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de um Termo de Cooperação, também integra a rede NatJus. Contudo, não foram encontradas informações sobre

a utilização do NatJus por município, tampouco especificamente sobre o Município de Canoas.

A mediação sanitária foi concebida como eficiente método de prevenção à judicialização, pois possibilita o alcance dos direitos dos cidadãos de maneira célere e eficaz, identificando e suprimindo falhas no sistema, sendo realizado por meio do diálogo entre os diversos atores envolvidos, priorizando a construção de soluções, graças à relação que se estabelece entre todos os envolvidos (médicos, usuários, gestores) (6).

No Município de Canoas, o Centro de Mediação e Conciliação foi instituído por meio da Lei n.º 6.292, de 11 de outubro de 2019, e foi vinculado à Procuradoria Geral do Município (PGM), com o “objetivo de estabelecer a conciliação e a mediação como meios para a solução de controvérsias administrativas ou judiciais que envolvam a Administração Pública Municipal” (7).

Tal instituição do Centro de Mediação e Conciliação é um importante passo, tendo estabelecido a citada lei os conceitos de mediação, conciliação e transação administrativa; princípios; diretrizes; competência e estrutura (Câmaras de Indenizações, de Conciliação de Precatórios e de Mediação e Conciliação) e procedimento.

Contudo, não foram encontrados registros de mediações realizadas no campo da saúde, também não foi localizado registro de composição de comissão para tal atividade por parte do Centro de Mediação e Conciliação ou de formação da Câmara de Mediação e Conciliação que tem previsão como parte da estrutura prevista na lei para o centro.

A judicialização da saúde tem sido crescente nos últimos anos no Brasil (8) e ainda possui altos números no Município de Canoas. É de se reconhecer que, por vezes, a via judicial é considerada a única forma encontrada pelo cidadão para garantir o seu direito à saúde; no entanto, não deve ser considerada uma porta de entrada aos serviços, mas, sim, a última opção de resolução das demandas. Desse modo, é preferível que o Poder Executivo identifique possíveis falhas e possibilidades de melhorias na saúde pública para não sofrer com imposições externas do Poder Judiciário.

Na busca de dados referentes à judicialização da saúde no município de Canoas, bem como quais as estratégias implementadas no enfrentamento dessas demandas, constatou-se: (a) a inexistência de um sistema de informação de controle processual (banco de dados); (b) a ausência de um Núcleo de Assistência Técnica (NAT) ou um setor específico de enfrentamento à judicialização do SUS, tanto na SMS, como na PGM; (c) relação de medicamentos desatualizada (REMUME); (d) falta de um Comitê de Mediação Sanitária.

Foi verificado que o município criou um Centro de Conciliação e Mediação, porém, o texto da lei de sua criação não consta o registro de que haverá um setor específico para atender aos processos sanitários (4).

Foi constatado que a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) está sendo estudada para fins de atualização; também foi informado que o município não possui Protocolo de Solicitação de Medicamento fora da REMUME ou de outros tratamentos extra SUS; os pedidos no município são realizados via Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) ou na Ouvidoria da Secretaria de Saúde Municipal. Os recursos humanos da SMS são muito escassos, dificultando a implementação de ferramentas de enfrentamento à judicialização.

Outra questão relevante é que, em se tratando de determinações judiciais, há risco de estabelecimento de curtos prazos para cumprimento, sob pena de multas pecuniárias desproporcionais e sequestro de verbas públicas, além de prever prisão para o gestor. Sendo assim, a judicialização excessiva promove uma verdadeira desestruturação do setor da saúde (8).

Dessa forma, como sugestões, é de se ressaltar a importância de o município criar um núcleo ou comitê que cuide especificamente das demandas da judicialização da saúde, o qual monitore as ações judiciais de saúde em face do município, preferencialmente por um sistema próprio, ou mesmo de maneira mais simples, com planilha que seja completa. Recomenda-se, no mínimo, a presença das seguintes informações: número de processo judicial e administrativo; data de recebimento de decisão; se decisão de tutela de urgência, antecipada ou sentença; se houve trânsito em julgado; prazo para cumprimento; objeto da demanda; se o objeto está previsto nas políticas do SUS; em

caso de estar previsto, se é de responsabilidade Municipal ou de outro ente; situação do cumprimento; se houve bloqueio de valores; se há imposição de multa diária e qual o valor. Além dessas informações, pode constar o valor aproximado do item demandado, quando possível, a fim de perceber o impacto financeiro de cada decisão.

A equipe com formação em áreas de saúde poderia, ainda, elaborar pareceres, notas e respostas técnicas com base em evidências científicas e se articular com a Procuradoria Geral para dar mais subsídios para os casos de conciliação e mediação e para as defesas nos processos judiciais de saúde já em trâmite, tornando crível o convencimento de juízes e até modificações favoráveis ao município.

Além do monitoramento das demandas e da emissão de documentos técnicos, o núcleo poderia estudar e indicar prioridades para o município no que tange aos processos, levando em consideração ser caso de procedimento de urgência, emergência ou eletivo, bem como as principais demandas locais e as preferências legalmente estabelecidas. É muito importante que este trabalho seja realizado de forma integrada, reunindo os principais atores envolvidos nestes processos, unindo os setores do Executivo internamente e, externamente, ao Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

Como exemplo de experiência exitosa e pioneira no Brasil, a Associação de Municípios do Centro do Estado (AMCENTRO) implementou em 2018 um Comitê Regional de Saúde, unificando 33 (trinta e três) municípios e 13 (treze) comarcas, o resultado foi positivo: apenas na cidade de Santa Maria foi constatada uma redução de 74% da judicialização na saúde mental e as ações na busca de medicamentos foram zeradas. Isto representou uma economia de R\$ 1,2 milhão ao ano (9).

É sabido que custo de um processo judicial vai muito além daquilo que é demandado, tornando-se muito maior do que seria um atendimento pela via administrativa, pois, além do custo do processo, há o custo da mão de obra operacional para o atendimento das demandas, isso faz que os gestores se vejam compelidos a arcar com despesas não previstas em seu orçamento, sem contar que acaba beneficiando um pequeno número de pessoas em detrimento de outras (10), prejudicando o planejamento orçamentário.

Não restou comprovado, por falta de dados, se o principal problema da judicialização da saúde para Canoas tem relação com o custo financeiro dos processos; porém, um

grande problema, por si só, é o envolvimento que cada um dos processos causa na rotina dos trabalhadores da saúde, o tempo e o desgaste.

O município, mesmo não tendo implementado as principais ferramentas para o enfrentamento da judicialização de forma adequada, demonstra que a gestão está se dirigindo a um caminho correto, tendo em vista a redução dos processos do ano de 2018 para o ano de 2019. No entanto, as sugestões deste trabalho podem contribuir consideravelmente com uma maior redução desses processos e, ainda mais importante, uma maior racionalização de recursos humanos e financeiros.

Assim é que se sugere, buscar um diagnóstico para o fenômeno da judicialização é um importante desafio a ser transposto, não só em cada município, mas também no nível estadual e nacional, conforme a realidade enfrentada em cada ente. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está desenvolvendo a pesquisa intitulada: “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução”, evidenciando o crescimento das demandas judiciais, bem como as deficiências do sistema de saúde.

No intuito de reverter o cenário de progressivo aumento da judicialização, estão sendo discutidas e praticadas, em âmbito nacional, ferramentas para diagnóstico e posterior enfrentamento às demandas judiciais relacionadas aos serviços de saúde pública no país, que nos últimos dez anos apresentaram um aumento de 130% (11).

Nessa perspectiva, políticas voltadas a auxiliar os magistrados vêm sendo implementadas, com destaque a Resolução CNJ n.º 238/2016 que “Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda pública” (12).

Vale citar ainda, a criação da plataforma e-NatJus, que muito tem auxiliado nas decisões dos magistrados; a criação dos NatJus (Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário); e a crescente realização de eventos e estudos sobre o tema com aproximação dos magistrados e da sociedade neste debate sobre a judicialização.

Os debates sobre judicialização vêm crescendo e aproximando os mais diversos setores na busca de um diagnóstico dessa situação no Brasil, bem como pela identificação de suas causas e soluções cabíveis.

Desse modo, para um diagnóstico mais fidedigno e preciso possível, é importante a existência e utilização de base de dados unificada. As plataformas de sistemas informatizados têm se demonstrado muito eficientes em diversos setores.

Além dos dados, que possibilitam perceber a situação da judicialização como um todo, é fundamental promover o diálogo com a população demandante e com seus representantes (Defensoria Pública, advocacia privada e Ministério Público), a fim de identificar os problemas, em especial com o uso da conciliação e mediação, o que possibilita, ainda, chegar a soluções e adequar melhor a política de saúde, evitando ações judiciais.

Considerações Finais

Este trabalho visou estudar a judicialização da saúde no SUS, do município de Canoas-RS, seus impactos e quais as formas de enfrentamento aos processos, como projeto de conclusão ao curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase na judicialização do SUS, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o HCor, no âmbito do PROADISUS, com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

Diante da proposta do curso, foi escolhido o município de Canoas-RS para a realização de diagnóstico da judicialização dos processos do SUS, para conhecer quais as principais causas que levam à judicialização da saúde e as principais formas de enfrentamento.

Foi realizado levantamento das comarcas e dos órgãos diretamente relacionados à judicialização existentes no município, tendo sido constatada a existência de Justiça Estadual (Fórum local), Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Federal. Assim, apenas não há mais sede no Município, para o

Ministério Público Federal, vez que a Procuradoria da República de Canoas passou a realizar atendimentos relativos a Canoas em Porto Alegre, no ano de 2019.

Foram apresentados os resultados do estudo com a adequação e cruzamento de dados de planilhas fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e pela Procuradoria Geral do Município (PGM), os quais, depois de compilados, possibilitaram um retrato da judicialização no município.

Nessa fase da pesquisa, foram encontradas diversas dificuldades em relação ao levantamento de dados, haja vista que não há, ainda, implementado no município um sistema de dados unificado e informatizado dos processos judiciais, havendo em cada um dos setores envolvidos (SMS e PGM) uma forma diferente de organização por meio de tabelas de *Excel*, as quais não têm as mesmas informações. Assim, foi necessária a comparação das duas, a compilação e a complementação adequada de dados, o que foi importante para servir de base para o trabalho.

No diagnóstico feito dos processos judiciais da saúde no município, foi contabilizado o total de 384 (trezentos e oitenta e quatro) processos em 2018 e 309 (trezentos e nove) no ano de 2019. A principal demanda judicial foi de medicamentos, que chegou a um patamar de 71,35% do total das demandas judiciais do município de Canoas no ano de 2018 e que foi de 49,84% no ano de 2019.

Constatou-se que a representação autor/paciente é, na sua grande maioria, feita por meio da Defensoria Pública, indicando que a procura se faz pela população com insuficiência de recursos. As decisões judiciais, na sua imensa maioria, são procedentes (81,88% em 2019).

Neste cenário, é possível dizer que há a necessidade da criação de um banco de dados único para os processos da saúde. Tal inovação poderia propiciar um maior controle da judicialização da saúde no município.

Diante dessa pesquisa, restaram como sugestões para prevenção e melhor enfrentamento da judicialização no Município de Canoas a implementação do Centro de Conciliação e Mediação, já criado por lei municipal; criação de Núcleo de Assistência Técnica (NAT); adoção de Protocolos de Solicitação administrativa de medicamentos

e procedimentos fora das listas oficiais do SUS; capacitação dos profissionais de saúde para melhor integração com as políticas da rede pública; periódica atualização da REMUME.

Restou reforçado que a judicialização da saúde no Brasil é um problema de consequências muito preocupantes aos estados e municípios; assim, a formação de profissionais na área de Direito Sanitário e o estudo baseado em evidências é necessário ao enfrentamento dessa situação.

Referências

- 1 - Prodanov, C C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico** [internet] Novo Hamburgo: Feevale; 2013. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1lp5R-RyTrt6X8UPoq2jJ8gO3UEfM_JJd/view>.
- 2 - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. **Promotorias de Justiça – Canoas**. [internet], 2020 [citado em 12 jul. 2020]. Disponível em: <<https://www.mprs.mp.br/promotorias/24/>>.
- 3 - Torres, JV. **Quanto custa para os municípios os processos judiciais de saúde**. [internet], 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/noticias/html>.
- 4 - Morozowski, A C; Oliveira, L V. **Da responsabilidade solidária na assistência à saúde no SUS**. [internet]. 2019. [citado em 06 fev. 2020]. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/305311/da-responsabilidade-solidaria>>.
- 5 - Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal**, [internet], 2019. [Citado em 27 nov. 2019]. Disponível em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_03.07.2019/CON1988.pdf>.
- 6 - Cruz, MTT; Nez, BA. **A contribuição da mediação sanitária para a desjudicialização do direito à saúde**. Disponível em: <<https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/>>.
- 7 - Canoas. Lei n.º 6.292, de 11 de outubro de 2019. **Institui o Centro de Conciliação e Mediação do Município de Canoas e dá outras providências**. Disponível em: <<https://leis-municipa.is.xonju>>.
- 8 - Delduque, MC; Marques, SB; Ciarlini, Á. **Judicialização das políticas de saúde no Brasil**. Biblioteca plataforma de ensino HCor (profissional externo), [internet], [data desconhecida]. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://eadensino.hcor.com.br/lms/#/aula/15880/>>.
- 9 - FAMURS. **Comitês reduzem 30% da judicialização da saúde no RS. 2019**. [online]. [citado em 06 fev 2020]. Disponível em: <<http://www.famurs.com.br/noticias/comites-reduzem-30-da-judicializacao-da-saude-no-rs/>>.
- 10 - Torres, JV. **Quanto custa para os municípios os processos judiciais de saúde**. [internet], 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/noticias/regiao/2019/06/2434655.html>.

11 - Conselho Nacional de Justiça. **Demandas judiciais relativas à saúde crescem 130% em dez anos. 2019.** [internet]. [Citado em 19 fev 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem-130-em-dez-anos/>>.

12 - _____. **Atos Normativos.** 2016. [internet]. [Citado em 19 fev 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2339>>.



Judicialização da saúde: A experiência do município de Curitiba-PR

Bárbara Puel Broering¹
Camilla Cristina de Oliveira Nunes²
Cydia Emy Pereira Ribeiro³
Evaldo Eufrásio Vasconcelos⁴
Jefferson Celli Honório⁵
Lorena Rodrigues de Oliveira⁶
Marcondes Soares Vanderlei⁷
Murilo Evangelista Barbosa⁸

Orientadora: Profa. Dra. Luciane Anita Savi

A escolha da cidade se deu mediante o conjunto de dados disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e na Procuradoria Geral do Município de Curitiba que cederam gentilmente as informações necessárias sobre o perfil das demandas judiciais

¹ Graduada em Direito pela UNISUL. Assessora Jurídica na Consultoria Jurídica da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina.

² Graduada em Enfermagem pela FCC. Pós-Graduada em Gestão Pública, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela UFRN. Diretora Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde de Coromandel-MG.

³ Graduada em Direito pela UNAMA, pós-Graduada em Saúde Pública pela UEPA e em Direito Médico pela IPOG. Diretora do Núcleo Jurídico da Secretaria Municipal de Belém-PA.

⁴ Graduado em Enfermagem pela UVA, pós-graduado em Saúde Pública pela UVA, Mestrado em Saúde da Família pela UVA. Gestor Municipal de Saúde de Cruz-CE.

⁵ Graduado em Farmácia pelo UniBrasil. Coordenador de Recursos Materiais - Assistência Farmacêutica na SMS de Curitiba-PR.

⁶ Graduada em História pela UNG e Pedagogia pela Uni-Ban, mestrado em Educação pela PUC-SP. Secretária de Saúde do município de Franco da Rocha-SP.

⁷ Graduado em Farmácia pela CESMAC, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas de Saúde pelo Hospital Sírio Libanês. Servidor da Assistência Farmacêutica da SMS de Santana do Ipanema-AL.

⁸ Graduado em Direito pela URSA. Pós-Graduado em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera e em Direito Penal e Processual Penal pela URSA. Analista Processual da SMS de Picos-PI.

em desfavor do SUS. Foi estabelecido o recorte temporal referente ao ano de 2018. Todo trabalho científico exige um rigor metodológico, limitando a pesquisa a um recorte espacial criterioso, o território escolhido foi o da cidade de Curitiba.

De forma preliminar, decidiu-se trabalhar o viés qualitativo e quantitativo para não restringir as formas de abordagem das informações. Para realizar o prosseguimento da proposta, optou-se pela pesquisa exploratória, que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (1).

Etapa inicial (exploratória): Buscou-se investigar e familiarizar-se com os dados disponíveis sobre os processos de judicialização do SUS, na cidade de Curitiba-PR. Para tanto, foi efetuado contato com o procurador geral municipal que realizou o detalhamento de todos os processos judiciais e disponibilizou-o em arquivos PDF. Posteriormente, foram realizadas análises visuais para cruzamentos das informações. Essas análises foram feitas com o auxílio dos programas *Microsoft Word* e *Excel* para esquematizar as necessidades e os requerentes de cada processo.

Etapa intermediária (descritiva): Essa etapa buscou aprofundar as informações em análise por meio da esquematização de cada processo. A seguir, foram realizadas consultas nas plataformas de Processos Eletrônicos do Judiciário do Paraná (PROJUDI), Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e justiça federal para acompanhar o andamento de cada processo. Com isso, foi criado um conjunto de informações fazendo uso de estatísticas descritivas, construindo gráficos e tabelas.

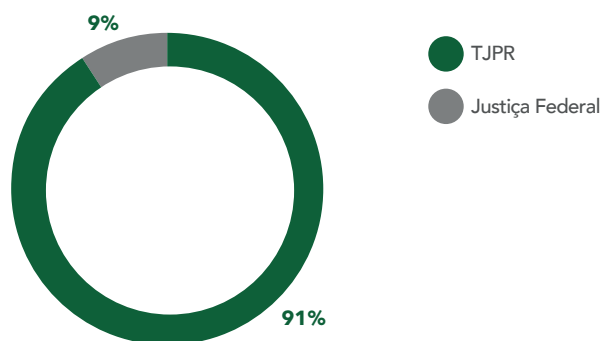
Etapa final (analítica): Buscou-se compatibilizar as informações encontradas na etapa intermediária, por meio do cotejamento de dados dos processos com a situação vigente no município em estudo, apresentando sugestões de melhorias para monitoramento e avaliação, gerando um diagnóstico.

Diagnóstico da judicialização no município

Foram coletados dados disponíveis sobre os processos judiciais na área da saúde, na cidade de Curitiba-PR, após contato com a Procuradoria Geral do Município que disponibilizou em arquivos PDF. Feita a análise individual de cada processo, realizou-se a compilação dos dados, construindo gráficos e tabelas.

No diagnóstico dos processos judiciais na área da saúde em 2018, no município de Curitiba-PR foram realizados 389 processos. Desse total, foram realizados 354 processos pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), o que representa 91% do total e 35 processos pela Justiça Federal, representando 9% do total, conforme a Figura 1.

FIGURA 1. Processos judiciais na área da saúde em 2018.



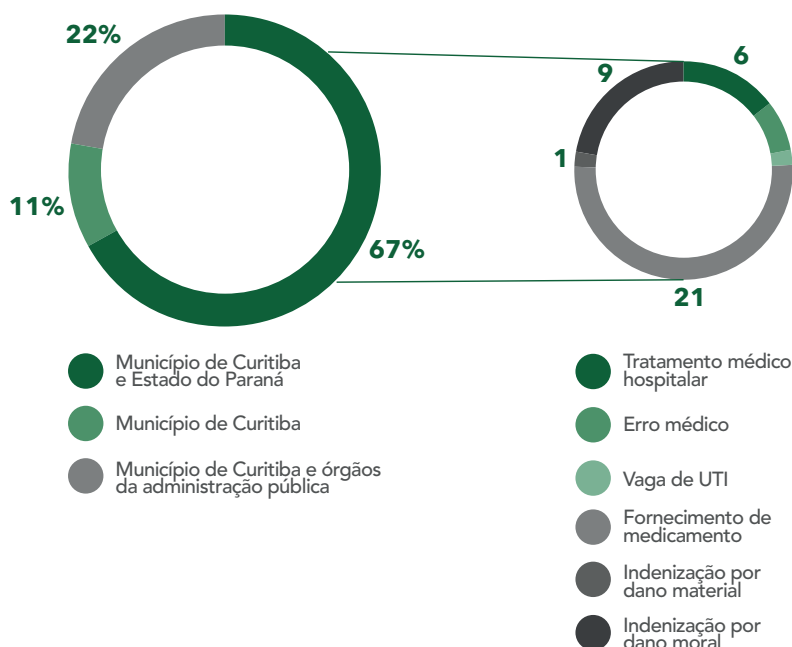
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município de Curitiba.

Dos 389 processos, somente em 41 o Município de Curitiba-PR é réu no polo passivo, obtendo um total de 11% do montante geral. Nos demais processos judiciais, o Município de Curitiba-PR é réu com o Estado do Paraná em 262 (67%) e em 86 com órgãos da administração pública (22%).

Analisando os 41 processos referente às demandas judiciais no Município de Curitiba-PR em 2018, foi possível atestar que o pedido mais frequente foi o fornecimento de medicamento, além de outros pedidos, como: tratamento médico hospitalar,

indenização por dano moral, erro médico, vaga de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e indenização de dano material, conforme demonstrado na Figura 2.

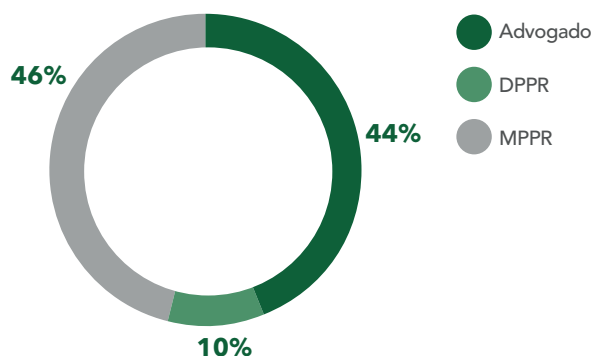
FIGURA 2. Réus e Demandas Judiciais no Município de Curitiba em 2018.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município de Curitiba.

No que concerne à representação do autor/paciente dos processos nos quais o município foi réu, 4 processos tiveram origem na Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), 18 processos de advogados privados e 19 processos do Ministério Público do Paraná (MP-PR), conforme disposto na Figura 3.

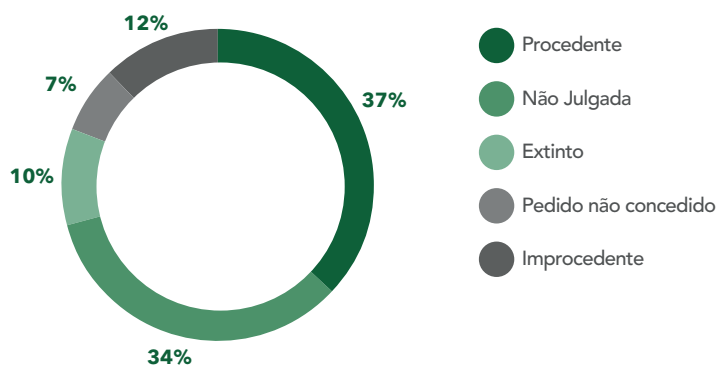
FIGURA 3. Representação Autor/Paciente.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município de Curitiba.

No tocante às decisões judiciais do município, 15 se configuraram como julgadas procedentes, 14 ainda não tinham sido julgadas, 5 improcedentes, nos quais não foram demonstradas razões suficientes para o pedido feito pelo autor, 4 extintos por desistência do autor e 3 tiveram pedido não concedido, quando o juiz ainda aguarda apresentação de laudo ou documentos necessários por uma das partes. A Figura 4 dispõe desses dados organizados.

FIGURA 4. Decisões judiciais no Município de Curitiba em 2018.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município de Curitiba.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A judicialização da saúde refere-se à busca do Poder Judiciário como a última alternativa para obtenção do medicamento ou tratamento pelo SUS ou pelas operadoras de planos de saúde, quando não obtido o serviço pelas vias normais. Assim, diante da crescente judicialização de temas relativos à saúde, o Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu a Audiência Pública n.º 4, entre abril e maio de 2009, para discussão do assunto com representantes técnicos e jurídicos vinculados à saúde pública, bem como à sociedade civil.

A audiência pública serviu de suporte para que o STF decidisse em grau recursal o pedido de Suspensão de Tutela Antecipada (STA n.º 175 AgR-CE), do relator Min. Gilmar Mendes, 17.03.2010), intentada contra o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos da Apelação Cível n.º 408729-CE (2006.81.00.003148-1), decisão esta que tem servido de orientação para muitos julgados.

Também, a partir daquela audiência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.º 31/2010, dirigida aos tribunais para que adotassem medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.⁽²⁾ Por fim, o CNJ, por meio da Resolução n.º 107, de 6 de abril de 2010, instituiu o Fórum Nacional para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos ⁽³⁾.

Para o funcionamento descentralizado desse fórum, foram criados os Comitês Executivos Estaduais, sob a coordenação de magistrados indicados pela Presidência e/ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, como o objetivo de coordenar e executar as ações de natureza específica, que forem consideradas relevantes (art. 3º da Resolução n.º 107/2010) ⁽⁴⁾.

O Fórum Nacional é composto por magistrados atuantes em unidades jurisdicionais, especializadas ou não, que tratem de tema relacionado à saúde pública, podendo contar com o auxílio de autoridades e especialistas com atuação nas áreas correlatas, especialmente do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público Federal, dos Estados e do Distrito Federal, das Defensorias Públicas, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Universidades e outras Instituições de Pesquisa, sob coordenação dos Conselheiros integrantes da Comissão de Relacionamento Institucional e Comunicação do CNJ.

No sítio do CNJ há uma página relacionada ao Fórum Nacional da Saúde, onde constam informações relevantes a respeito do tema, disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoess/forum-da-saude>. O Comitê Executivo de Saúde do Estado do Paraná foi criado em 2011, sendo um órgão plural onde são debatidas as questões pertinentes à saúde pública e suplementar. No sítio do TRF da 4ª Região também existe a página do Comitê Executivo do Paraná, disponível no endereço: <https://www.jfpr.jus.br/saude/>.

No Paraná, o Comitê Executivo foi instalado no dia 8 de abril de 2011, sob a coordenação do Dr. João Pedro Gebran Neto, então Juiz Federal e hoje Desembargador do TRF - 4ª Região. Participaram desde o início diversos representantes do Tribunal de Justiça do Paraná, Ministério Público Federal e Estadual, Secretaria de Saúde do Estado e de várias Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados do Paraná, Defensoria Pública Estadual e Federal, médicos ligados ao Hospital de Clínicas e planos de saúde. Atualmente o Comitê ainda é composto por representantes desses diferentes órgãos, e outros, que voluntariamente cumulam estas atividades com os seus respectivos trabalhos profissionais.

É uma composição bem plural, e as reuniões referentes à Saúde Pública ocorrem na sede da Justiça Federal de Curitiba, mensalmente, atualmente sob a coordenação da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira. No âmbito da Saúde Suplementar (as operadoras de planos de saúde, por exemplo) são realizadas reuniões também mensais, na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a coordenação da Des.^a Vilma

Régia Ramos de Rezende e da juíza Carla Melissa Atria, com participação dos juízes de direito substitutos em segundo grau Hamilton Rafael Marins Schwartz, Rogério Ribas e Anderson Ricardo Fogaça.

O foco do Comitê Estadual, como determinado na Resolução n.º 107 do CNJ, tem sido o monitoramento das ações judiciais e a busca pela resolução dos conflitos na área de assistência à saúde. Para tanto, têm sido realizados profícuos debates e buscado os consensos possíveis, que deram ensejo às publicações de recomendações e enunciados. Tanto as recomendações como os enunciados têm por escopo uniformizar procedimentos a serem realizados por médicos e operadores do Direito, de maneira que otimizar a assistência à saúde, garantir a organização do sistema público de saúde e, principalmente, permitir que as políticas públicas sejam desenvolvidas de modo isonômico para todos aqueles que buscam o tratamento por intermédio do SUS. Não há caráter vinculante, mas simplesmente orientativo, conforme os seguintes enunciados já publicados por este comitê estadual.

- Enunciado n.º 01 (Ata 06, de 12.09.2011): “Às ações que versem sobre pedidos para que o Poder Público promova a dispensação de medicamentos ou tratamentos, baseadas no direito constitucional à saúde, devem ser instruídas com prescrição de médico em exercício no Sistema Único de Saúde, ressalvadas as hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, sob risco de indeferimento de liminar ou antecipação da tutela” (05);
- Enunciado n.º 02 (Ata 06, de 12.09.2011): “Os pedidos ajuizados para que o Poder Público forneça ou custeie medicamentos ou tratamentos de saúde devem ser objeto de prévio requerimento à administração, a quem incumbe responder fundamentadamente e em prazo razoável. Ausente o pedido administrativo, cabe ao Poder Judiciário ouvir o gestor público antes de apreciar pedidos de liminar, se o caso concreto o permitir” (Ata 06) (05);
- Enunciado n.º 03 (Ata 07, de 11.10.2011): “A determinação judicial de fornecimento de medicamentos deve observar a existência de registro na ANVISA” (Ref. Legislativa: artigo 19-T, inciso II, da Lei n.º 8.080/90, com redação dada pela Lei n.º 12.401/11) (05);

- Enunciado n.º 04 (Ata 07, de 11.10.2011): “Ao impor a obrigação de prestação de saúde, o Poder Judiciário deve levar em consideração as competências das instâncias gestoras do SUS” (05);
- Enunciado n.º 05 (Ata 16, de 03.09.2012): “Às ações judiciais que versem sobre pedidos para que o Poder Público promova a dispensação de tratamentos e medicamentos oncológicos, baseadas no direito constitucional à saúde, devem ser instruídas com prova do cadastro do paciente/autor em rede pública de atenção oncológica (CACON/UNACON) e com cópia integral do prontuário do paciente” (05);
- Enunciado n.º 06 (Ata 32, de 13.06.2014): “Para a internação compulsória ou involuntária, em relação à transtornos mentais, inclusive quanto ao uso de álcool e drogas, é mister que a petição inicial venha instruída com laudo de solicitação de internação hospitalar firmado por médico, preferencialmente psiquiatra” (05);
- Enunciado n.º 07 (Ata 33, de 25.07.2014): “Considerando que o médico responsável pelo tratamento durante o período de internamento dispõe das melhores condições para aferir a pertinência de sua continuidade ou encerramento, é relevante que as decisões que imponham a obrigação de internamento psiquiátrico determinem que os efeitos da ordem judicial cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na unidade do internamento, devendo o fato ser imediatamente comunicado ao Juízo pela instituição” (05);
- Enunciado n.º 08 (Ata 42, de 17.04.2015): “Às prescrições de medicamentos e OPMEs, fora das listas do SUS, tais como RENAME, SIGTAP e farmácia especial, deverão conter declaração médica acerca da existência de conflito de interesse do prescritor, nos termos das resoluções dos Conselhos de Medicina” (05);
- Enunciado n.º 09 (Ata 42, de 17.04.2015): “Nas demandas individuais de saúde, a pretensão de fornecimento de medicamentos, produtos ou procedimentos deve vir instruída com dados técnicos fundamentados na Medicina Baseada em Evidências e o respectivo nível de evidência” (05);

- Enunciado n.º 10 (Ata 43, de 29.05.2015): “Tratando-se de escassez absoluta de recursos (como transplante de órgãos, internamento em UTIs, oferta de leitos, entre outros), o controle judicial pode recair apenas quanto aos fundamentos da decisão administrativa, indevida a intervenção judicial para substituir-se quanto aos critérios técnicos” (05);
- Enunciado n.º 11 (Ata 43, de 29.05.2015): “A ordem judicial que determina a importação de medicamentos ou produtos, com imposição de multa para o caso de descumprimento, deve levar em consideração, para fins de entrega efetiva do bem da vida pretendido, os prazos ordinários para os procedimentos de compra internacional, desembaraço aduaneiro, liberação da ANVISA e entrega do produto, de modo que a obrigação seja exequível” (05).

E as seguintes recomendações:

- Recomendação 01 - aprovada na Ata 04, de 04.07.2011 (solicitação aos médicos prescritores que são vinculados ao SUS) (06);
- Recomendação 02 - aprovada na Ata 24, de 16.08.2013 (paciente apresentar receituário atualizado a cada retirada de medicamento) (06);
- Recomendação 03 - aprovada na Ata 25, de 27.09.2013 (documentos necessários nas demandas relativas à Saúde Suplementar) (06);
- Recomendação 04 - aprovada na Ata 41, de 27.03.2015 (informações necessárias em demandas acerca de OPME: Órteses, Próteses e Materiais Especiais) (06);
- Recomendação 05 - aprovada na Ata 70, de 23.06.2017 (Considerações a respeito da determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos - Art. 1.037, II, CPC) (06).

O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n.º 31 de 30 de março de 2010 para recomendar aos tribunais a instituição de Núcleos de Apoio Técnico (NAT), visando dar suporte aos magistrados nas decisões pertinentes à judicialização da saúde (02). No Paraná, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná oficializou o seu NAT em 4 de novembro de 2013, pela Portaria n.º 1608/2013 da presidência, e desde então o nú-

cleo vem atuando mediante emissão de notas técnicas solicitadas pelos magistrados. A presidência do Tribunal de Justiça instituiu o Regulamento do NatJus pelo Decreto Judiciário n.º 648/2018 de 12.9.18 (07).

A partir da publicação da Resolução CNJ n.º 238/2016 de 6 de setembro de 2016 o núcleo passou a ser nominado de NAT-JUS, e se encontra vinculado à estrutura do gabinete do presidente do Tribunal de Justiça consoante Decreto Judiciário n.º 538/2017 de 21 de junho de 2017. O acesso ao NatJus é facultativo aos magistrados.

Desde a sua criação o NatJus já elaborou aproximadamente 8 mil pareceres e notas técnicas em diversas especialidades médicas e hospitalares. Além dos médicos do quadro do TJPR, o Núcleo conta com a contribuição de profissionais de órgãos conveniados, como a Assembleia Legislativa, a Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, a Prefeitura de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná.

O Comitê de Mediação Sanitária no estado atua juntamente ao Centro Médico do TJPR. É composto por uma equipe de médicos.

Frente à crescente judicialização da saúde, no Município de Curitiba, o Núcleo de Apoio Técnico (NatJus) tornou-se cada vez mais importante, pois os magistrados, diante de decisões judiciais, podem esclarecer dúvidas sobre determinado medicamento ou procedimento médico por meio de parecer ou nota técnica.

Por isso, é importante que os gestores de saúde invistam na ampliação da participação e capacitação de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais da saúde no NAT, por meio de oficinas e cursos.

É de muito valor a aproximação entre o Poder Judiciário, por meio dos operadores do direito, e o Poder Executivo, por intermédio dos profissionais de saúde, para que haja diálogo e entendimento sobre o que é de fato saúde e direito à saúde. Assim, este recurso pode ser útil para o devido embasamento técnico de decisões judiciais em processos que envolvam o tema da saúde, com evidências científicas de qualidade e demais subsídios que tragam mais segurança no momento de decidir sobre o fornecimento ou não de determinado medicamento ou tratamento médico.

Considerações Finais

A coleta de dados, por intermédio dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça do Paraná, e Justiça Federal, bem como por relatórios solicitados diretamente à procuradoria municipal, e ainda os dados coletados na secretaria municipal de saúde, nos setores jurídico e farmácia, possibilitaram o detalhamento preciso dos processos de judicialização, como ocorrem, sua finalidade, execução e resultados provenientes de cada ação, sendo essenciais e responsáveis por fundamentar e atingir o objetivo proposto pelo trabalho.

Embora tenha sido um momento com o envolvimento de muitas áreas institucionais e jurídicas, não houve limitação na extração dos dados, uma vez que, todos os profissionais envolvidos e os portais informativos utilizados foram acessíveis e cederam as informações solicitadas. Com isso, considera-se que os aspectos metodológicos implantados no desenvolvimento da pesquisa, especialmente os de viés quantitativo, conseguiram atender, de forma suficiente e oportuna, o objetivo almejado pela pesquisa, sem restringir o acesso de fontes confiáveis.

Assim, os resultados dos procedimentos utilizados demonstraram que a cidade de Curitiba apresenta aspectos de desenvolvimento social, econômico, ambiental, de infraestrutura e, especialmente, institucionais de saúde privilegiada. Esses fatos contribuem para um bem-estar e qualidade de vida que, consequentemente, se sobressaem nos âmbitos da saúde e processos da judicialização.

Em se tratando dos processos judiciais na área da saúde, ficou evidente que o município de Curitiba teve 389 processos envolvendo o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e a Justiça Federal (JF). A disposição desses requerimentos se dá por toda a extensão territorial do município, ou seja, envolve desde áreas rurais, como urbanas, com poder aquisitivo dos requerentes entre baixo e médio. Dentre esses 389 processos, somente em 41 o município de Curitiba se destaca como réu no polo passivo. Nos demais, a cidade é ré em litisconsórcio passivo com o estado do Paraná e em órgãos da administração pública. As demandas referentes a esses processos, geralmente, se

referem a busca pelo fornecimento de algum medicamento, além de outros pedidos como tratamento médico hospitalar, indenização por dano moral, erro médico, vaga de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e indenização de dano material.

A relação entre esses processos e a representação do autor de cada um, evidenciou a falta de aproximação entre as áreas do direito e a população no geral, uma vez que, os processos que Curitiba foi réu, apenas 4 constam como origem a Defensoria Pública (DPPR), 18 de advogados privados e 19 do Ministério Público do Paraná (MPPR). Embora apresentem números importantes e haja as mais diversas motivações pela escolha da representação, há a carência desse contato entre a representação pública nesses processos, pois é direito fundamentado nos moldes constitucionais.

Sendo assim, a aproximação entre o Poder Judiciário, por meio dos operadores do direito, e o Poder Executivo, por intermédio dos profissionais de saúde, é importante para que haja diálogo e entendimento sobre o que é de fato saúde e direito à saúde para toda a população, e que as discussões não se limitem apenas a uma parcela. Esse contato será importante ainda para o embasamento técnico de decisões processuais que envolvem o tema da saúde, com evidências científicas de qualidade e demais subsídios que tragam mais segurança no momento de decidir sobre o fornecimento ou não de determinado medicamento ou tratamento médico.

Os dados sobre as decisões desses processos também chamam a atenção e demonstram que Curitiba dispõe de um espaço importante de discussão sobre essa área, no entanto, ainda há muito o que evoluir, pois dos processos já julgados, apenas 15 se configuraram procedentes, 5 improcedentes, 4 desistências, 14 que ainda não foram julgadas e 3 tiveram pedido não concedidos. Com isso, tem-se visto uma ampla mobilização, não só de razão municipal de Curitiba, mas também de importância nacional para a avaliação desses processos, pois embora seja direito de cada cidadão ter saúde plena, nem todos os pedidos podem ser atendidos, devido às circunstâncias inconsistentes dos pedidos ou até mesmo o custo do serviço ou produto.

Por isso, no Paraná, ou aqui entendido apenas como o município de Curitiba, o Comitê Executivo de avaliação desses pedidos têm representação das mais diversas entidades,

como representantes do Tribunal de Justiça do Paraná, Ministério Público Federal e Estadual, Secretaria de Saúde do Estado, Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados do Paraná, Defensoria Pública Estadual e Federal, médicos ligados ao Hospital de Clínicas, planos de saúde e voluntários.

No que interessa a área da saúde, os gestores municipais de Curitiba têm implantado algumas ações de melhorias para expandir as ações referente a esses processos, como elaboração de equipes, seminários e atividades que divulguem a importância desses processos, no entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Com isso, o trabalho propõe a informatização e controle de acesso de medicamentos em almoxarifados, para informar os custos dos medicamentos e materiais fornecidos por usuário ou por período, o controle de validades dos produtos e medicamentos, para realizar inventário com mais agilidade e evitar erros. Sendo essencial para minimizar o impacto que esse tipo de demanda impõe ao serviço de saúde, além de contribuir na identificação de etapas que podem ser ajustadas para melhorar o atendimento do autor e cumprimento da ação ao menor custo possível.

Sugere-se ainda a criação de um Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde e o investimento na ampliação da participação e capacitação de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais, por intermédio de oficinas e cursos, como já vem sendo realizado em outros estados, como Rio Grande do Norte e Pará que apresentam resultados modelos de implantação desses serviços, como por exemplo, a conciliação administrativa com intuito de evitar a judicialização desnecessária de ações de saúde ou promover a conciliação em ações já ajuizadas.

De maneira geral, julga-se como aspectos limitantes, além da falta de informação sobre a cidade de Curitiba, a análise exclusiva de uma cidade, pois se houvesse a discussão de outra cidade, poderia haver a discussão de maneira comparativa, podendo traçar um perfil mais completo das demandas apresentadas e, com isso, propor medidas mais direcionadas ou que pudesse serem implementadas em outros sistemas.

Por meio desses delineamentos, constata-se que este trabalho com toda sua extensão alcançou o objetivo proposto, haja vista a riqueza de informações descritas durante sua execução.

Referências

- 1 - Gil AC. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas; 2007.
- 2- Conselho Nacional de Justiça. (BR). **Recomendação n.º 31 de 30 de Março de 2010**. [Internet]. 2019. [citado 30 out 2019]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao_31.pdf>.
- 3- Conselho Nacional de Justiça. (BR). **Recomendação n.º 107 de 06 de Abril de 2010**. [Internet]. 2019. [citado 30 out 2019]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_107.pdf>.
- 4- Supremo Tribunal Federal. (BR). **Audiência Pública**. [Internet]. 2019. [citado 30 out 2019]. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processo>>.
- 5- Tribunal de Justiça do Paraná. (PR). **Enunciados**. [Internet]. Curitiba. 2019. [citado 01 nov. 2019]. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/judicializacao-da-saude-comite-executivo-desauade>>.
- 6- Tribunal de Justiça do Paraná. (PR). **Recomendações**. [Internet]. Curitiba. 2019. [citado 01 nov. 2019]. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/judicializacao-da-saude-comite-executivode-saude>>.
- 7- Tribunal de Justiça do Paraná. (PR). **NatJus**. [Internet]. Curitiba. 2019. [citado 01 nov. 2019]. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/>.



Estratégias para redução da judicialização em saúde no município de Fraiburgo-SC

Adriana Martins de Paula¹

Grasiela Pomini²

Gustavo Vasconcelos Tannus³

Indaiára Viero Perazzoli⁴

Marcos Sena da Silva⁵

Mayra Kelly Pereira da Silva Rosa⁶

Viviane Augusta Maciel Baltar⁷

Orientadora: Profa. MSc. Leticia de Oliveira Fraga

A metodologia que foi utilizada para elaboração deste estudo, foi a descritiva, a qual segundo Triviños (1) exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. E esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.

O estudo iniciou por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados para apresentar as variáveis propostas, tais como pesquisas bibliográficas, em acervos oficiais do município, pesquisa documental, entre outras.

¹ Graduada em Enfermagem pela UMC, pós-graduada em Gestão Pública de Saúde pela Faculdade das Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Secretária Municipal de Saúde de Guararema/SP e Tesoureira do COSEMS/SP.

² Graduada em Direito pela FACCAR e pós-graduada em Gestão de Sistema de Saúde pela ENSP/Fiocruz e em Direito Administrativo pela Universidade Positivo de Curitiba/PR. Assessora jurídica do COSEMS/PR.

³ Graduado em Enfermagem pelo UNITRI. Secretário Municipal de Saúde de Monte Alegre de Minas/MG.

⁴ Graduada em Enfermagem pela FURB, pós-graduada em Gestão de Redes de Atenção pela FIOCRUZ. Diretora Geral da SMS de Fraiburgo/SC.

⁵ Graduado em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá. Assessor Jurídico da SMS de Macapá/AP.

⁶ Graduada em Serviço Social pelo IES. Membro da Comissão de demandas judiciais da SMS de Valença/PI.

⁷ Graduada em Direito pela UNICAP. Coordenadora jurídica do Núcleo de Ações Judiciais da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.

A coleta de dados foi fundamental para a construção do estudo e de um plano de intervenção, ferramenta que auxilia a conhecer os problemas e as necessidades sociais em um determinado território. Portanto, o diagnóstico situacional foi de fundamental importância para a posterior proposição de ações da saúde mais focais em relação aos problemas encontrados (2).

Assim, o foco principal deste estudo foi a judicialização de ações e serviços de saúde na cidade de Fraiburgo-SC, um problema a ser enfrentado em nível municipal.

Foi realizado um levantamento do volume e das características das demandas judiciais do município, no período compreendido entre 2013 e 2018. A coleta de dados foi realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo. Após a conclusão do levantamento de todos os dados e informações, foi realizado diagnóstico da situação da judicialização no município, possibilitando determinar qual o insumo da saúde mais reclamado judicialmente.

Este capítulo teve o intuito de trazer parte importante do projeto de intervenção para o enfrentamento do tema da judicialização no município estudado a fim de poder fortalecer a gestão em saúde, objetivando reduzir ou minimizar o volume de ações judiciais que eventualmente passam a ser incorporadas nos programas de saúde, tratando de forma equânime todos os usuários do SUS.

Diagnóstico da judicialização no município

No Município de Fraiburgo, até o ano de 2013, às ações judiciais que tinham por objeto assistência à saúde e se concentravam na promoção da defesa junto à Procuradoria Geral do Município. A partir do referido ano, a gestão municipal optou por criar uma Procuradoria junto à Secretaria Municipal de Saúde para atender todas as demandas administrativas e judiciais, com a designação de um procurador efetivo e de carreira que no ano de 2019 foi definitivamente lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Com a criação da Procuradoria da Saúde, houve uma estruturação e trabalho de equipe multiprofissional para o enfrentamento jurídico e técnico para as defesas das demandas judiciais. A partir daquele momento foram adotados critérios e estratégias

para melhor embasar as defesas da judicialização da saúde. Dentre eles, vale ressaltar: o parecer técnico de profissionais da saúde, a aproximação e o alinhamento com o Poder Judiciário e o Ministério Público da Comarca de Fraiburgo para defesa das teses técnicas e jurídicas sustentadas.

O levantamento dos processos judiciais por assunto nos permitiu traçar o principal perfil das demandas, bem como entender quais os principais questionamentos que têm motivado as pessoas a buscar assistência à saúde por meio do Poder Judiciário.

No Município de Fraiburgo, foi realizado um levantamento das ações judiciais constantes no acervo oficial da Procuradoria da Saúde desde o ano de 2013, bem como realizado consulta processual no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de maneira a garantir dados fidedignos no que tange às demandas judiciais do município.

Desse processo de coleta de dados, foi identificado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019 um total de 197 processos judiciais, cujo objetivo foi assistência à saúde, tendo uma variedade de 16 tipos de demandas/solicitações diferentes que foram objeto da ação, conforme pode ser observado na Tabela 1.

TABELA 1. Número de processos de saúde por assunto, no período de 2013-2019, do município de Fraiburgo.

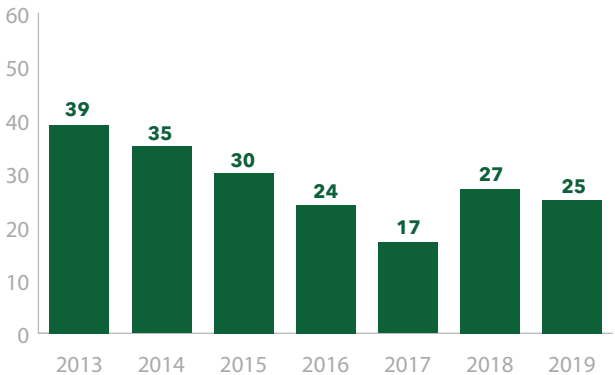
NÚMERO DE PROCESSOS DE SAÚDE POR ASSUNTO 2013-2019	
Abandono de material	01
Acompanhamento Familiar	01
Médico Psiquiatra para o CAPS	01
Ressarcimento de despesas médicas	01
Assistência à gestante	02
Consulta com médico especialista	02
Fralda geriátrica	02
Procedimento cirúrgico	02

Suplemento alimentar	03
Acompanhamento Médico	04
Aparelho auditivo	04
Erro médico	06
Transporte de paciente	09
Tratamento ambulatorial no CAPS	36
Internação Compulsória	50
Medicamento	73
Total	197

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao analisar os dados obtidos e segmentar as ações judiciais por ano em que foram protocolizadas juntamente ao Poder Judiciário da Comarca de Fraiburgo, obtivemos os números apresentados na Figura 1, demonstrando que no período de 2013 a 2017 houve uma redução no número de ações judiciais, que começaram a emergir novamente a partir do ano de 2018. O maior número de ações judiciais por demandas da saúde foi no ano de 2013.

FIGURA 1. Número de processos judiciais do município de Fraiburgo, por ano.

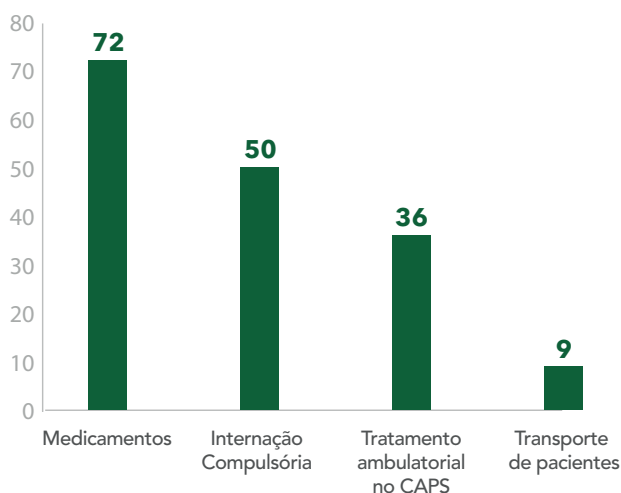


Fonte: Elaborada pelos autores.

Com relação as principais demandas de saúde que foram objeto de ações judiciais no período de 2013 a 2019, conforme a Figura 2, é possível afirmar que o fornecimento de medicamentos é o principal motivador de ações judiciais, correspondendo a 37% do total de demandas judiciais do município de Fraiburgo, seguido das demandas judiciais de internação compulsória que representam 25% das ações, dos tratamentos ambulatoriais no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que representam 18% das demandas e correspondendo a 4% temos as ações para transporte de pacientes.

Por fim, o percentual correspondente aos outros 16% de ações judiciais são das mais diversas demandas que não representam individualmente um volume a ser apresentado.

FIGURA 2. Principais demandas de processos judiciais do município de Fraiburgo.



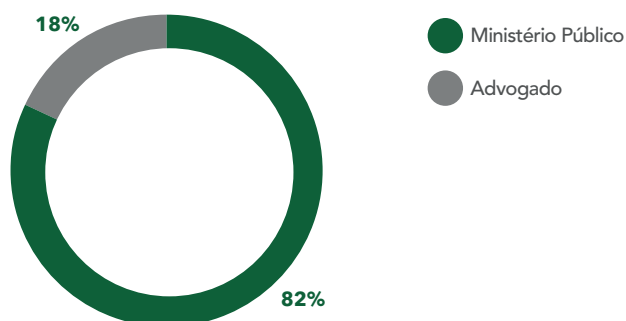
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em tese, as ações judiciais podem ser ajuizadas de quatro formas: por meio de advogado, Ministério Público, Defensoria Pública ou Núcleo da Assistência.

Ao analisar a demanda de ações judiciais do município de Fraiburgo no período de 2013 a 2019, foi possível analisar que 82% das ações judiciais tiveram como representação do autor/paciente o Ministério Público Estadual e em apenas 18% houve a representação por meio de advogado, conforme pode ser observado na Figura 3.

O Ministério Público foi criado com a função de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Uma das principais áreas de atuação do Ministério Público é a área de saúde, na busca de resguardar o direito à saúde à população, o que é corroborado com os dados apresentados Figura 3 (3).

FIGURA 3. Percentual de representação do autor nas ações judiciais do município de Fraiburgo.



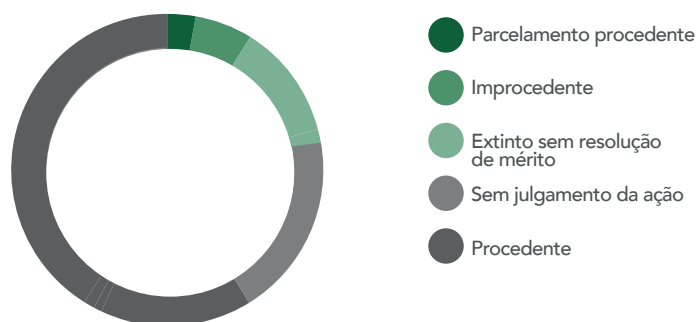
Fonte: Elaborada pelos autores.

Nas palavras do jurista e magistrado Nucci (4) o conceito de sentença é “a decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito, abordando a questão relativa à pretensão punitiva do Estado, para julgar procedente ou improcedente a imputação”. Portanto, após todo o percurso do processo, a sentença vai ser o marco final do conflito no primeiro grau de jurisdição. Com a sentença já conclusa o juiz se afasta da relação processual, ficando competente apenas para corrigir erros materiais e caso houver recurso, será submetido ao tribunal.

Analisando as ações judiciais do município de Fraiburgo com decisão terminativa/sentença, após realizar consulta processual no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no acervo da Procuradoria da Saúde identificamos que 59% possuem julgado procedente, 19% estão sem julgamento da ação, 13% tiveram o processo extinto sem re-

solução de mérito, 6% tiveram sentença improcedente e 3% parcialmente procedente, conforme Figura 4.

FIGURA 4. Percentual de ações judiciais do município de Fraiburgo com e sem julgamento.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santa Catarina foi implantado em novembro de 2015 no Estado, por meio da assinatura de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Tribunal de Justiça (TJ) de Santa Catarina. Inicialmente atuou em processos judiciais da Grande Florianópolis (5).

A criação do NAT atende a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como objetivo prestar assessorias técnicas e científicas aos magistrados nas demandas que tenham como objeto a assistência de saúde (5).

O município de Fraiburgo não possui implantado um Núcleo de Apoio Técnico. Os magistrados encaminham as demandas judiciais do município para parecer do NAT de Santa Catarina.

Também não estabeleceu um Comitê de Mediação Sanitária. A mediação é um método pacífico de gestão de conflitos, que busca evitar a abertura de processos judiciais de caráter incerto e finalizar os processos já iniciados e que poderia ser um processo estratégico a ser implantado no município para enfrentamento da judicialização (6).

No ano de 2013 o município criou uma procuradoria junto à Secretaria Municipal de Saúde para atender especificamente todas as demandas administrativas e judiciais da área da saúde, com a designação e lotação de um procurador efetivo e de carreira possibilitando desta forma a especialização profissional e aprimoramento das defesas.

Além do direcionamento de um procurador para tratar da judicialização da saúde, acontece concomitantemente um trabalho de equipe multiprofissional para a defesa das ações judiciais baseado em critérios técnicos, aliando desta forma os conhecimentos jurídicos e técnicos para enfrentamento das demandas judiciais.

No entanto, este processo de enfrentamento não possui uma formalização por meio de um documento oficial de nomeação que reconheça o papel fundamental do trabalho desta equipe, seria essencial, pois quando aproximamos o conhecimento jurídico com o técnico da área da saúde fortalecemos o processo de diagnóstico e de planejamento das principais demandas judiciais.

Como a maior demanda de ações judiciais se dá em virtude da solicitação de fornecimento de medicamentos, para maior enfrentamento da judicialização no município seria interessante que houvesse um acompanhamento mais detalhado das ações, objetivando identificar quais os medicamentos que demandam mais ações, bem como compreender se isso se dá por falta de alternativas medicamentosas pelo SUS, ou se trata de medicamentos que possuem justificativa para inclusão na Relação Municipal de Medicamentos, garantindo e ampliando o acesso da população a estes insumos.

O município de Fraiburgo faz parte da região de saúde do Alto Vale do Rio do Peixe. A câmara técnica de assistência farmacêutica da Comissão Intergestores Regional (CIR) está trabalhando para formulação e aprovação de uma Relação Regional de Medicamentos (REREME), o que sem dúvidas fortalecerá e ampliará o acesso da população aos medicamentos e consequentemente haverá redução das demandas judiciais.

Este mesmo trabalho de capacitação e aprimoramento dos municípios no enfrentamento da judicialização poderia ser foco de trabalho do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-SC), que por meio de um diagnóstico da judicialização poderia compilar os dados a nível estadual e propor a criação de estratégias para enfrentamento a nível estadual.

O planejamento estratégico depende de uma gestão descentralizada, a definição de objetivos com base em problemas e a análise da viabilidade e da estratégia de sua solução, prevendo que o mesmo deve acontecer em quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. Portanto, o primeiro momento é a seleção e análise dos problemas relevantes que pedem solução na visão dos atores envolvidos (7).

Neste trabalho foi realizado um diagnóstico inicial da judicialização no município de Fraiburgo, no entanto, durante a elaboração observou-se a necessidade de implantação de um sistema de registro e controle efetivo das demandas judiciais, para que chegasse a um banco de dados detalhado, necessário para a elaboração de estratégias de enfrentamento.

Portanto, emerge a necessidade de aprofundamento desta coleta de dados realizada, com maior detalhamento, especialmente dos principais fármacos demandados judicialmente pela população, já que a maior demanda de judicialização no município se dá em virtude do fornecimento de medicamentos.

Essa identificação permite realizar uma intervenção com os profissionais médicos prescritores, para verificar se estão ou não seguindo os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) existentes e adotados pelo Ministério da Saúde para tratamentos das doenças.

Para tanto, no sítio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) é possível ter acesso e realizar uma consulta minuciosa à diversos PCDT, que podem auxiliar os profissionais médicos na prescrição de medicamentos padronizados pelo SUS constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), evitando assim a prescrição de medicamentos não incorporados ao SUS.

Com o diagnóstico dos fármacos mais solicitados via judicial, é possível também ser realizado pela gestão um estudo técnico de viabilidade de inclusão dos fármacos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), desde que haja justificativa e disponibilidade financeira para tal incorporação.

Outra estratégia possível seria o diagnóstico detalhado não só do município, mas também da região de saúde onde ele se encontra, identificando os principais medicamentos prescritos que são solicitados judicialmente.

Com essas informações em mãos a região de saúde pode se organizar e construir por meio da câmara técnica de assistência farmacêutica instituída pela Comissão Intergestores Regional (CIR) a Relação Regional de Medicamentos (REREME), o que fortaleceria a região tendo em vista a constante migração de usuários entre os municípios, bem como dos prescritores que frequentemente atuam em mais de um município, facilitando a prescrição de remédios disponíveis nos municípios.

No caso da judicialização de fármacos não constantes na REMUME e REREME uma das estratégias seria a inclusão nas intenções de registro de preço (IRP) do Consórcio Público de Saúde, o rol dos principais medicamentos judicializados, alcançando assim uma melhor escala de compra. Essa estratégia não evita a judicialização, mas pode reduzir consideravelmente o custo da aquisição dos medicamentos e atender assim à economicidade, um dos princípios da Administração Pública.

De modo geral, no que tange a judicialização no município, seria possível realizar uma análise das demandas judiciais e identificação de quais são de competência municipal e estadual, buscando organizar esse fluxo e estratégias de dispensação destas demandas para otimização dos serviços de saúde e avaliando caso a caso.

Como estratégia de enfrentamento à judicialização da saúde, seria importante a criação e a regulamentação no âmbito Municipal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para acompanhamento dos processos judiciais em curso, para resolver administrativamente os litígios e diminuir o custo gerado com o cumprimento de determinações judiciais, bem como ser o responsável por subsidiar órgãos do sistema de justiça com informações referentes à saúde pública.

O NAT seria composto por uma equipe técnica de médico, farmacêutico, assessor jurídico, servidor com especialização em direito sanitário e ainda poderia utilizar o conhecimento técnico de qualquer servidor municipal da área de saúde, que poderia ser acionado para emitir um parecer técnico na sua área de conhecimento, conforme a demanda recebida no NAT.

O Núcleo teria como funções características: consultiva, opinativa, assessoria especializada, gestão básica e atuação preventiva para solução extrajudicial das demandas, podendo executar as seguintes ações:

- a. Avaliar a qualidade do acesso dos usuários aos serviços de saúde do município;
- b. Acompanhar os recursos financeiros destinados para o custeio da assistência farmacêutica, bem como a responsabilização de cada ente federado pela garantia do acesso, de acordo com a legislação vigente;
- c. Identificar as fragilidades do setor de regulação do município, realizando estudo de viabilidade de inclusão de novos serviços baseado na demanda, bem como capacitando a equipe para melhoria das informações prestadas aos usuários do SUS quanto ao acesso a exames, consultas especializadas e cirurgias por meio de do SUS;
- d. levantar dados e monitorar indicadores referentes à judicialização da saúde pública no município e seus reflexos financeiros, administrativos e assistenciais;
- e. realizar estudos, estimular debates e propor medidas de gestão que contribuam para a redução do número de ações judiciais no âmbito do SUS, bem como, para a melhoria da assistência à saúde municipal.
- f. conduzir os procedimentos voltados à prevenção e resolução administrativa de litígios na saúde junto à população, bem como orientar os serviços da Secretaria Municipal da Saúde no que diz respeito à legalidade de procedimentos administrativos internos;
- g. fornecer subsídios técnicos às manifestações do município nas ações judiciais e procedimentos administrativos relacionados à saúde pública;

- h. articular e promover o diálogo entre a Secretaria Municipal da Saúde, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgãos e instituições componentes do sistema de justiça, organizando um cronograma de reuniões continuadas para promover a aproximação, levantar propostas para organização das demandas encaminhadas por estes órgãos que resultavam em demandas judiciais; firmar acordos para facilitar a ampliação e execução dos serviços de saúde; apresentar os custos com medicamentos e o quanto a judicialização afeta diretamente o custeio da farmácia básica, e por fim dialogar sobre as responsabilidades e competências atreladas a cada ente federado na condução de sua política de saúde.

Quanto ao fluxo do usuário ante uma demanda que poderia vir a ser judicializada, o Núcleo de Apoio Técnico Municipal atuaria da seguinte forma:

1. O usuário buscaria o Ministério Público para pleitear em juízo medicamentos ou tratamentos de saúde;
2. Este órgão, antes de ajuizar as demandas, solicitaria administrativa-mente um parecer do Núcleo de Apoio Técnico;
3. O Núcleo de Apoio Técnico, antes de emitir o parecer, verifica a possibilidade de resolução administrativa do problema;
4. Havendo possibilidade de resolução na esfera administrativa, o caso seria encaminhado para o serviço de saúde do SUS correspondente, evitando a judicialização.
5. A Núcleo de Apoio Técnico funcionaria como um mediador do conflito e mola propulsora de resolutividade, servindo também como canal de comunicação para informações/orientações dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde aos usuários do SUS.

No caso de demandas já judicializadas, o Núcleo de Apoio Técnico agiria como um órgão consultor, auxiliando os juízes antes de decidirem os pleitos liminarmente, onde poderiam ser formulados quesitos, para os quais seriam dadas respostas com fundamentos técnicos da área da saúde e de acordo com as políticas públicas do SUS.

A proposta principal, na verdade, é não só criar, regulamentar e estruturar o Núcleo de Apoio Técnico Municipal. Mas revesti-lo de dinamicidade na busca por soluções ao fenômeno da judicialização e tornando a sua atuação limitada somente à decisão final do gestor e a realidade estrutural e financeira do órgão.

Considerações Finais

Pode-se concluir que a judicialização em saúde no Município de Fraiburgo vem sendo trabalhada, no entanto, sem a devida organização e formalização do processo, que se aplicada, com certeza será um marco para alcançar a eficácia na redução da judicialização da saúde.

Para tanto, se faz necessário a aproximação e o diálogo entre Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria Municipal de Saúde e usuários do SUS, para que haja efetividade no processo e se consolide a Política de Saúde a nível municipal, estadual e federal, sendo a comunicação a principal forma de se conseguir manter ativa as formas de potencialização das políticas públicas de saúde.

Os esforços devem ser conjuntos para que o entendimento seja positivo por todos os atores envolvidos. A desburocratização deve ser pensada como uma alternativa para afirmação das políticas de saúde, pois, ainda há dificuldades de acessar os serviços, por causa de numerosos protocolos que afastam por muitas vezes o usuário do SUS dos seus direitos a ter uma saúde de qualidade e efetiva.

Observa-se que atualmente as informações detalhadas sobre judicialização dependem da organização de cada ente federado e não permite desta forma que se tenha um panorama da situação a nível municipal, estadual e federal. Portanto, uma estratégia a ser adotada para a consolidação da redução da judicialização em saúde é a formulação e utilização de sistema de informação de âmbito nacional que possibilite a coleta de dados e a construção de indicadores para balizar os processos de tomada de decisão e reformulação de políticas públicas, com consequente redução da judicialização em saúde.

Referências

- 1 - Triviños ANS. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas; 1987.
- 2 - Silva CSSL, Koopmans FF, Daher DV. **O Diagnóstico situacional como ferramenta para o planejamento de ações na Atenção Primária a Saúde**. *Rev PróUniverSUS* [Internet]. 2016 [citado 5 maio 2019], jan./jun.; 07(2):30-33. Disponível em: <<http://editora.universidadedevasouras>>.
- 3 - Ministério Público de Santa Catarina (BR). **Comarca de Fraiburgo**. [Internet]. 2019 [citado 28 out 2019]. Disponível em: <<https://www.mpsc.mp.br/promotorias-de-justica>>.
- 4 - Nava C. Entendendo a sentença no processo penal: as decisões definitivas resultantes da atividade processual. [Internet]. Jus.com.br, out 2017. [citado em 10 dez 2019]. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/61379/entendendo-a-sentenca-no-processo-penal>>.
- 5 - Governo do Estado de Santa Catarina (BR). Secretaria de Estado da Saúde. **Secretaria da Saúde e Tribunal de Justiça assinam convênio para ações judiciais**. [Internet]. 23 nov. 2015 [citado 28 jan. 2020]. Disponível em: <<http://www.saude.sc.gov.br/?option=com>>.
- 6 - Delduque MC, Castro, EV. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil**. *Saúde debate* [Internet]. 2015. [citado 30 jan. 2020]. 39(105):506-13. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-pt>.
- 7 - Junges JR, Barbiani R, Zoboli, ELCP. **Planejamento estratégico como exigência ética para a equipe e a gestão local da Atenção Básica em Saúde**. *Interface (Botucatu)* [Internet]. 2015 Jun 19(53): 265-74 [citado 13 mar 2020]. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807->>>.



Judicialização no município de São Bento do Sul: Diagnóstico, dificuldades e estratégia de enfrentamento

Alessandra Aparecida Farias¹

Clarissa Almeida do Nascimento²

Djan Barbosa de Freitas³

Éric Dantas Azevedo⁴

Karen Cristina Giraldi Uhlick⁵

Maria Cristina da Silva Rocha Ferreira⁶

Mônica de Oliveira Lima⁷

Vinícius de Paula Gonzaga⁸

Orientadora: Profa. MSc Letícia Cabrini Girotto

O presente capítulo é fruto do plano de intervenção desenvolvido no município catarinense de São Bento do Sul e visa subsidiar o desenvolvimento de uma ferramenta

¹ Graduada em Nutrição pela Unipar. Diretora do Departamento de Saúde de Florai-PR.

² Graduada em Administração pela Faculdade Estácio de Sá. Diretora da Unidade de Saúde Especial da SMS de Saúde de São Luís-MA.

³ Graduado em Farmácia Bioquímica pela UNIDERP e em Direito pelo IESRIVER, pós-graduado em Saúde Pública pelo ICE e Auditoria em Serviços de Saúde, Gestão em Saúde e Controle de Infecção Hospitalar pela FAMESP. Gestor de Planejamento da SMS de Rio Verde-GO.

⁴ Graduado em Farmácia/Bioquímica pela UEPB. coordenador da Assistência Farmacêutica do Município de Bom Jesus- PI.

⁵ Graduada em Farmácia pela UNC. Membro do NAJS do Município de São Bento do Sul-SC.

⁶ Graduada em Enfermagem pela UEPA, pós-graduada em Obstetrícia, Saúde da Família, Gestão em Saúde e Micro-política em Saúde pela UFF. Secretária de Saúde em Pacajá-PA.

⁷ Graduada em Direito pela USCAL Coordenadora do Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

⁸ Graduado em Fisioterapia pela UniBH, pós graduado em Gestão de Redes em Saúde pela Fiocruz. Secretário Municipal de Saúde de Jeceaba-MG.

digital, lastreado no mapeamento de dados relativos à judicialização da saúde, classificado como um estudo de caso, com abordagem qualitativa e quantitativa, norteadada pela aplicação de um instrumento para coleta de dados.

Segundo Gil (1), “Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas”.

Outrossim, na dicção de Selltiz *apud* Gil (1).

Qualquer instrumento utilizado, trazem técnicas de interrogação possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. Assim, o levantamento apresentará sempre algumas limitações no que se refere ao estudo das relações sociais mais amplas, sobretudo quando estas envolvem variáveis de natureza institucional. No entanto, essas técnicas mostram-se bastante úteis para a obtenção de informações acerca do que a pessoa ‘sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das coisas precedentes.

Tal instrumento, elaborado pelos autores do presente trabalho, com base em seus conhecimentos prévios e revisão da literatura, fora submetido à farmacêutica e à chefe do Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde (NAJS), bem como a uma assistente jurídica da Procuradoria Municipal, responsáveis pela judicialização no referido município, para fins de coleta de dados relativos às ações judiciais no ano de 2018, além da tentativa de busca ativa de informações de processos juntamente ao órgão ministerial, sistemas do Poder Judiciário e Procuradoria Geral do Estado. Essas últimas, inexitasas.

Para Gil (1), a técnica do estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou pouco objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”, o que não seria possível por meio de outras técnicas de pesquisa acadêmicas reconhecidas.

A aplicação do aludido instrumento teve por objetivo primordial a realização de uma classificação objetiva das demandas judiciais, visando identificar representantes legais, polo passivo, objeto da ação e motivo da judicialização, de maneira a subsidiar o gestor municipal na futura construção de uma ferramenta digital com foco no mo-

nitoramento e acompanhamento dos processos, de maneira a conferir maior agilidade na identificação, diagnóstico situacional e melhor gerenciamento e custeio das demandas judiciais.

Desta maneira, viabilizou-se a adoção de medidas alternativas ao enfrentamento da judicialização, além do aperfeiçoamento e efetividade no planejamento das ações de saúde por parte da gestão.

Insta salientar que a ausência de informações disponibilizadas e pouco padronizadas, pelos diversos órgãos (classificação de assuntos e classes nos sistemas informatizados dos Tribunais de Justiça de todo o país, por exemplo), tornaram a pesquisa mais complexa.

Assim, foi proposta uma classificação objetiva, notadamente no que concerne à assistência farmacêutica, principal objeto das demandas judiciais no município, que permite aos gestores entender as causas da judicialização e, por conseguinte, melhor planejar e executar as medidas de controle e, por vezes, ajustes necessários, como melhor explanado adiante.

Considerando as dificuldades enfrentadas, de pronto, restou evidenciada a inexistência de uma unicidade de assuntos ou motivos da judicialização (classificados de forma difusa, em face da multiplicidade da indexação pelos Tribunais, seguida por diversos órgãos, atores ativos na Judicialização da Saúde), a exemplo de Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensorias Públicas e até mesmo Procuradorias de Estados e Municípios.

Disso decorreu a necessidade de identificar as características da judicialização da saúde, no intuito de melhor entender esse fenômeno e, a partir disso, fundamentar a proposição de ações para os diversos atores envolvidos.

Diagnóstico da judicialização no município

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul, até junho de 2015, não havia no órgão um setor específico para atendimento das demandas judiciais, de modo que a Procuradoria do Município adotava as providências necessárias à defesa do ente, cabendo a um servidor, farmacêutico, a dispensação dos medicamentos deferidos.

Nesse sentido, ante o crescimento do número de ações judiciais em saúde deferidas em desfavor do Município de São Bento do Sul, foi criado um setor no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, instituído por meio do Decreto Municipal n.º 1.265, de 9 de março de 2016 (2), o Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde (NAJS), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo, consoante o art. 1º do referido decreto, “é garantir o cumprimento das ordens judiciais relativas à área de Saúde”.

Assim, o gestor da pasta designou dois servidores, com conhecimento nas áreas de saúde, farmácia, direito e gestão pública, haja vista que as demandas judiciais substancialmente se referem a medicamentos. No Município de São Bento do Sul, o setor é composto por duas servidoras, a saber: uma farmacêutica e um chefe de divisão, cargo comissionado.

Cumprе salientar que o NAJS não representa o município em juízo, eis que de competência da Procuradoria Jurídica.

De acordo com Pinheiro (3), em sua monografia intitulada: Núcleos de Assessoramento Técnico: Estratégia à Judicialização da Saúde?

tradicionalmente, os NatJus foram implementados nos diversos tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz na formação de suas convicções nos litígios em saúde. Com essa atribuição, cabe à equipe do NAT emitir pareceres técnicos sobre prescrição de medicamentos, exames, consultas, procedimentos, cirurgias, alimentos nutricionais e insumos, acompanhados de informação sobre a organização do SUS, ou seja, atua como ferramenta de apoio, informação e orientação para os juizes, promotores e defensores públicos quando não há resolutividade administrativa (3).

Em 2019, foi promulgada a Lei Municipal n.º 4.203, de 23 de dezembro de 2019 (4), que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Vale ressaltar a criação do cargo de Chefe de Divisão do Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde, com a respectiva formalização das atribuições (Anexo VI), ora discriminadas, *in verbis*:

- i. promover, articular e coordenar todas as atividades administrativas vinculadas ao Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde (NAJS), com objetivo de garantir o cumprimento das ordens judiciais relativas à área da Saúde, de acordo com o Decreto Municipal n.º 1.265/2016;
- ii. promover as ações de assessoramento do Secretário de Saúde em relação aos fluxos da Política Pública da Saúde, evitando-se a judicialização;
- iii. promover devolutivas de todos os pedidos de informação provenientes do Poder Judiciário, Ministério Público, Delegacia de Polícia e Procuradoria Jurídica do Município;
- iv. atuar de forma articulada com a Secretaria de Estado da Saúde para o cumprimento das ordens judiciais em desfavor de ambos;
- v. acompanhar as atividades jurídicas, representação e interesse relativas às defesas judiciais e extrajudiciais;
- vi. emissão de negativas a eventuais pedidos realizados no setor de protocolos da Prefeitura para fins judiciais;
- vii. assessorar o Secretário de Saúde na operacionalização dos encaminhamentos referentes ao seu cargo.

Nesse contexto, as manifestações acerca das demandas administrativas – relativas aos pleitos de medicamentos e procedimentos na área da saúde, sejam oriundas de órgãos ministeriais, Poder Judiciário ou de usuários do SUS – são devidamente fundamentadas pela área técnica do setor, em conformidade com as diretrizes e princípios do SUS, e formalizadas por meio de ofício. Logo, tais manifestações técnicas, além do aperfeiçoamento do serviço, visam igualmente evitar a judicialização.

Infere-se, pois, que a finalidade precípua do NAJS é esgotar todas as vias administrativas para o atendimento a um direito fundamental, no caso, à saúde, seja ele relacio-

nado a medicamentos, insumos ou procedimentos, desde que atendam às políticas públicas em saúde vigentes e, sobretudo, em consonância com as deliberações de Comissões e Câmaras Técnicas temáticas (CONITEC, CIT, CIB etc.) em conformidade com a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores.

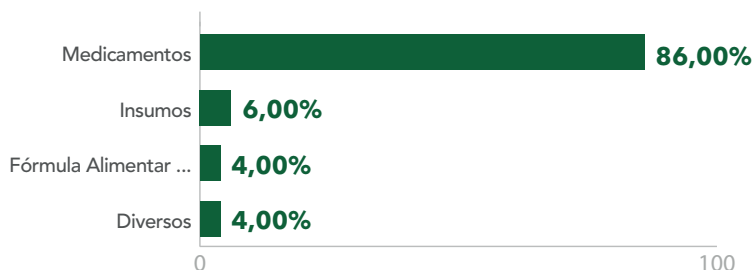
Por outro lado, de acordo com as informações prestadas pela farmacêutica do setor (uma das autoras do presente projeto), a gestão de documentos e armazenamento de informações ainda ocorre de forma rudimentar, com arquivamento em pastas físicas, individualizadas por paciente, evidenciando a carência no setor de recursos modernos para monitoramento e controle dos processos.

A partir da aplicação do formulário, junto à farmacêutica do NAJS da Secretaria de Saúde do Município de São Bento do Sul, responsável pelo controle e monitoramento das ações judiciais, foi possível coletar dados e elementos acerca das demandas do ano de 2018, dentre os quais destaca-se: classificação do objeto, motivo da judicialização, polo passivo, patronos, procedência ou improcedência das ações, bem como os custos com as ações judiciais.

Cumprе salientar que restou inviabilizada a coleta de outros critérios constantes do instrumento inicialmente submetido, por razões de proteção de dados e sigilo médico de algumas demandas. Cumprе ressaltar, contudo, que tal questão não prejudica a classificação que ora se passa a discorrer.

Nesse sentido, conforme dados coletados, no ano de 2018 foram ajuizadas 50 ações relativas à judicialização da saúde pública, cujo principal objeto residiu no fornecimento de medicamentos. O total foi de 43 demandas, o que corresponde a um percentual de 86% das demandas, conforme demonstra a Figura 1.

FIGURA 1. Classificação do Objeto da Ação.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul.

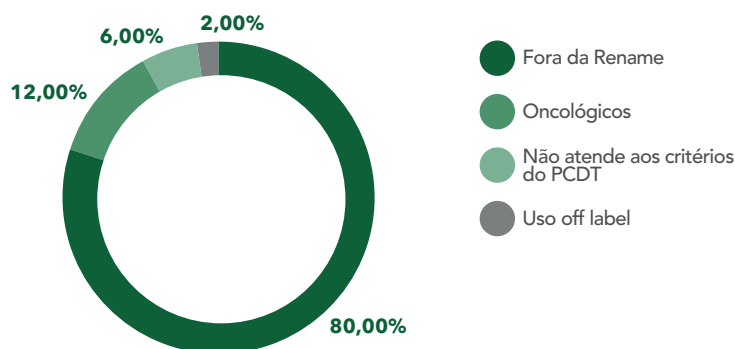
Uma questão relevante a ser analisada é o motivo da judicialização – contemplado ou não nas políticas públicas de saúde – notadamente no tocante à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e Política Nacional de Oncologia. Assim, foi proposta pelos autores do presente trabalho uma classificação objetiva, a seguir discriminada, que permite aos gestores entender as causas da judicialização e, por conseguinte, melhor planejar e executar as medidas de controle e, por vezes, ajustes necessários.

Classificação proposta:

- RENAME - Atenção Básica;
- RENAME - Componente Especializado;
- RENAME - Componente Estratégico;
- RENAME - Fluxo Indefinido;
- Fora da RENAME;
- Oncológico;
- Não atende aos critérios do PCDT;
- Uso *off label*.

Nesse sentido, as demandas judiciais do Município de São Bento do Sul, no ano de 2018, restaram assim classificadas, conforme a Figura 2:

FIGURA 2. Motivo da Judicialização.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul.

Conforme observa-se no gráfico acima, 80% das demandas referem-se a medicamentos que não constam na RENAME (6% que não atendem os critérios preconizados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e 2% pertencem ao uso *off label*). Destaca-se, ainda, que são prescrições provenientes tanto de unidades privadas, como da própria rede do Sistema Único de Saúde.

Vale ressaltar a inexistência da judicialização de políticas públicas já instituídas, do que se infere que o Município vem cumprindo com seu dever constitucional de prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos, de acordo com os critérios de hierarquização e descentralização e repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Isto eleva, portanto, à questão da eficácia, da evidência científica, do custo-efetividade e da integralidade e sustentabilidade do sistema. Essas premissas estas devem ser sope-sadas por todos os atores envolvidos, sejam eles da área da Saúde ou do Direito.

Outro aspecto que merece destaque consiste nas demandas judiciais voltadas ao forne-cimento de medicamentos oncológicos. Essa é uma temática que sistematicamente se apresenta – seja na via administrativa ou na judicial – e contudo, vem sendo olvidada pelo Ministério da Saúde.

Os medicamentos oncológicos não compõem a Relação Nacional de Medicamentos, eis que, no Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu a Política Nacional de Atenção Oncológica, que deve ser implantada em todas as unidades federadas, incluindo a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos com garantia de atenção integral aos pacientes, seja por meio de acompanhamento ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.

No SUS, a Oncologia é estruturada para atender de forma integral e integrada os pacientes que necessitam de tratamento, por meio da Rede de Atenção Oncológica, formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Isto é, quando o paciente está realizando o tratamento em um hospital habilitado na alta complexidade em oncologia pelo SUS, seja ele público ou privado, é a própria unidade hospitalar que deve fornecer os meios adequados ao tratamento de que o paciente necessita.

Vale ressaltar que cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde – devidamente credenciado e habilitado – a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição do tratamento, conforme diretriz de conduta adotada no hospital.

O SUS financia – sem, por ora, adentrar o mérito do subfinanciamento – o tratamento especializado do câncer como um todo, ou seja, tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, iodoterapia e transplantes (via Autorização para Internação Hospitalar – AIH ou Autorização de Procedimento de Alta Complexidade – APAC, majoritariamente).

Sucedo que, sob o viés do avanço e busca incessante por novas tecnologias na seara científica, os valores estabelecidos nas AIHs ou APACs não correspondem ao efetivo custo dos novos tratamentos ou fármacos, ensejando, pois, a judicialização.

Mister se faz pontuar, todavia, que, em se tratando de Oncologia como Alta Complexidade, os recursos financeiros advêm do Bloco da Atenção de Média e Alta

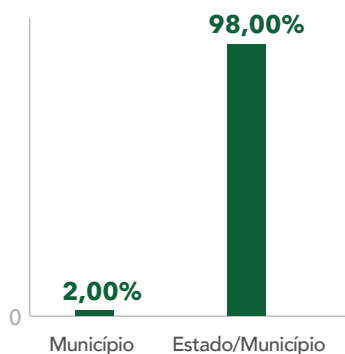
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, composto pelo Limite Financeiro da MAC (Média e Alta Complexidade) e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) (art. 173, da Portaria de Consolidação MS n.º 6/2017).

Nessa perspectiva, considerando que os recursos da MAC são federais, nos termos do § 2º, do art. 174, da referida Portaria e que os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, atualmente financiados pelo FAEC, serão gradativamente incorporados ao Componente Limite Financeiro MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 175, caput), não restam dúvidas quanto à natureza do custeio das APACs-Onco. É federal.

Nesse sentido, de acordo com Juiz Federal Clenio Schulze (5), a União deveria, necessariamente, compor o polo passivo de tais demandas, uma vez que a União, por intermédio do Ministério da Saúde é o responsável pela “avaliação e a incorporação de tecnologias em Saúde, especialmente aquelas de alta complexidade”, justificando a federalização de tais demandas, ainda que apenas vocacionada ao ressarcimento das despesas pelos entes municipal e estadual (5).

No que se refere ao polo passivo dos processos judiciais, a maioria das demandas foi intentada em face do Estado e do Município, enquanto, em apenas 2% das demandas, o Município de São Bento do Sul figura isoladamente, conforme Figura 3.

FIGURA 3. Polo Passivo.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul.

À luz das teses fixadas pelos tribunais superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes, nas demandas ajuizadas em desfavor do Estado e do Município, o Estado de Santa Catarina envia, mensalmente, ao Município os medicamentos referentes aos processos deferidos, devidamente discriminados em relação nominal dos pacientes e respectivos medicamentos, suplementos, fraldas, entre outros. Na hipótese de não cumprimento pelo ente estatal, o Município promove a dispensação do medicamento ou insumo.

Neste ponto, vale ressaltar o proveitoso diálogo institucional entre os entes, haja vista o contato constante, visando a verificação de eventual desabastecimento e necessidade de ressuprimento, cumprimento inicial da ação, dentre outros fatores, evitando-se assim gastos desnecessários ou a aquisição em duplicidade.

Importante salientar que, a despeito do ajuizamento de 50 processos novos no ano de 2018, existiam ainda 193 processos ativos relativos a medicamentos, haja vista a natureza de prestação continuada dessa espécie de demanda, a qual somente se encerra pela refratariedade ou não adesão do tratamento, substituição do fármaco, óbito do paciente ou improcedência da ação.

No ano de 2018, conforme informações obtidas do Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, os gastos com a judicialização da assistência farmacêutica perfizeram o montante de R\$ 732.235,77 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) – o que equivale a 50,76% do gasto com o Componente Básico da Assistência Farmacêutica no mesmo ano, que correspondeu a R\$ 1.442.450,98 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).

Importa salientar que, a despeito do valor mínimo estabelecido para os Estados e Municípios de R\$ 2,36 por habitante/ano, conforme preconizado na Portaria MS/GM n.º 1.555, de 30 de julho de 2013, o Município de São Bento do Sul investiu R\$ 17,41 – o que ultrapassa, de forma acentuada, o valor mínimo (cerca de sete vezes superior), uma vez que a base de cálculo foi a população do município em 2017, de aproximadamente 82.842 habitantes, conforme dados do IBGE (6).

Sob esse viés, acaso o ente municipal tivesse aplicado o valor mínimo estipulado na Portaria Ministerial retromencionada, o percentual de gastos com a Judicialização se inverteria de maneira vertiginosa, haja vista que a contrapartida financeira do Município, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, corresponderia a R\$ 195.507,12 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sete reais e doze centavos). Isto é: em detrimento da quantia de R\$ 732.235,77 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), o percentual do gasto com a judicialização equivaleria a 374,53%.

Outrossim, cabe ressaltar que o Município de São Bento do Sul, há mais de 5 anos, gasta quase o dobro do percentual estabelecido no art. 7º da Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, correspondente a 15% no mínimo da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. Senão, vejamos a Tabela 1:

TABELA 1. Percentual de aplicação em serviços de saúde (LRF).

2015	2016	2017	2018	2019
26,71%	27,79%	30,77%	29,96%	28,31%

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Sistema IPM. Sistemas de Gestão Pública (39).

Os principais pedidos foram:

- Ácido ursodesoxicólico – 03 demandas;
- Anticoagulantes – 08 demandas (Rivaroxabana 20mg – 04; Enoxaparina 40mg - 04);
- Medicamentos oncológicos – 06 demandas (Brentuximabe – 01; Rituximabe – 01; Pazopanibe – 02; Bevacizumabe – 01; e Bortezomibe - 01);
- Brometo de Tiotrópio – 03 demandas;
- Fórmulas Alimentares Especiais – 02 demandas.

TABELA 2. Relação discriminada de medicamentos objetos de cada ação.

OBJETO DA AÇÃO	QTD.
Ac. Ursodesoxicólico 300mg/Rifampicina 300mg/Cloestiramina 4g	1
Ac.ursodexicolico	2
Ácido Hialurônico	1
Alfatotropina 0,9mg	1
Baclofeno 10mg/fraldas/Pregabalina 75mg	1
Baclofeno 10mg/Omeprazol Magnésio 20mg/dieta/fralda/Tramadol gotas/ Neuleptil gotas 4%	1
Bevacizumabe 600mg (Oncologia)	1
Bomba de insulina/Insumos	1
Bortezomibe 3,5mg (Oncologia)	1
Brentuximabe 50mg (Oncologia)	1
Cilostazol 100mg/Maleato de Indacaterol 300mg	1
Citalopram 20mg/Glimepirida 4mg/Linagliptina 50mg/Noripurum Fólico/ Diosmina+Hesperidina 1000/Calde Magnésio/Rivaroxabana 20mg	1
Clonazepam 0,5mg/Paroxetina liberação controlada	1
Curativos de alto custo	1
Dieta elementar pediátrica (Neocate)	1
Divalproato de Sódio 500mg/Rosuvastatina 10mg/Rivaroxabana 15mg	1
Eltrobompague Olamina 25mg	1
Empaglifozina 25mg/Pioglitazona 30mg/Metformina 1000mg+Alogliptina 12,5	1
Enoxaparina 40mg	4
Estradiol 50mg	1
Fralda geriátrica	1
Iloprosta 100mg/Ambrisentana 10mg	1

Lacosamida 100mg	1
Levetiracetam 250mg	1
Linagliptina 2,5+Metformina 1000mg	1
Linagliptina 5mg/Ezetimibe 10mg/Insulina Degludeca/Insulina Lispro/ Pantoprazol 40mg,Valsartana 320+Hidroclortiazida 25mg/Tramadol 37,5+Paracetamol 325mg	1
Micofenolato de Mofetila 500	1
Mirabegrona 50mg	1
Neocate (Formula elementar)	1
Nintedanibe 150mg	1
Paroxetina 25mg/Clomipramina 75mg Liberação Lenta	1
Pazopanibe 400mg	1
Pazopanibe 800mg (Oncologia)	1
Pregabalina 150mg/Oxibutinina 5mg	1
Risperidona Susp/Fralda/Omeprazol Magnésio 20mg (Losec Mups)	1
Rituximabe 600mg (Oncologia)	1
Rivaroxabana 15mg, Brometo de Tiotrópio 2,5mcg e Olodaterol 2,5mcg	1
Rivaroxabana 20mg/Cilostazol 100mg	1
Solifenacina 10mg	2
Tiotrópio 2,5/Beclometasona 100mcg+Formoterol 6mcg	1
Tiotrópio 2,5mcg/Teofilina	1
Todos os medicamentos/procedimentos que se fizerem necessários	1
Topiramato 100mg	1
Tretinoína 10mg	1
Vedolizumabe 300mg	1
Total	50

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul.

De forma sucinta, no que concerne a alguns medicamentos mais demandados, convém esclarecer alguns aspectos referentes à postura da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC):

Ácido ursodesoxicólico: em julho de 2018, a CONITEC se manifestou, inicialmente, pela não incorporação do medicamento, por unanimidade, uma vez que “faltam evidências robustas de eficácia e segurança no tratamento de pacientes com colangite biliar primária” (40). Transcorridos cerca de três meses, por meio da Portaria n.º 47, 16 de outubro de 2018, houve a decisão pela sua incorporação (7).

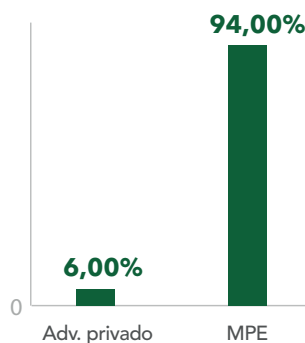
Anticoagulantes: O Ministério da Saúde, após publicação do Relatório de tornou pública a incorporação da enoxaparina sódica para o tratamento de gestantes com trombofilia no SUS, por meio da Portaria n.º 10, de 24 de janeiro de 2018 (8).

No que tange à rivaroxabana, o Ministério decidiu pela não incorporação ao SUS, notadamente em face da ausência de demonstração de superioridade de eficácia à varfarina – esta, disponibilizada pelo SUS e a um custo muito inferior (9).

Há que se ressaltar a expressiva atuação do Ministério Público Estadual nas ações judiciais individuais relativas à temática de saúde no Município de São Bento do Sul, haja vista que 94% das ações judiciais correm sob seu patrocínio, envolvendo tanto o ente estatal, quanto o municipal. Já as demandas ajuizadas apenas em face do Município têm como representante legal advogados da esfera privada, conforme Figura 4.

Mister se faz registrar que tão acentuado percentual também se justifica pela inexistência de representação da Defensoria Pública no município. Por isso não se vislumbra a instituição como proponente de demandas em âmbito local.

FIGURA 4. Representação nas demandas de saúde.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul.

Conforme dados coletados juntamente ao NAJS, vinculado à Secretaria de Saúde do Município de São Bento do Sul, os 50 (cinquenta) novos processos ajuizados em 2018 tiveram, em 100% dos casos, a tutela antecipada deferida, tendo sido identificado, entretanto, ainda que de forma muito tímida, a reversão da medida em alguns processos, após perícia médica designada pelo Juízo, no decurso dos processos, muitas delas corroborando as informações já prestadas pela gestão municipal nas negativas emitidas administrativamente, assim como a extinção de processos pelo óbito do requerente ou desistência.

Dentre todas as ações que foram ajuizadas contra o Município, vale ressaltar que 04 (quatro) pedidos foram protocolados na Comarca, todos consistentes no fornecimento de insumos terapêuticos para o tratamento de úlceras venosas, cujo valor do tratamento acarretaria uma despesa superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos cofres públicos em benefício de apenas quatro pacientes. Tal pedido causou surpresa ao gestor, uma vez que, no período de 12 (doze) meses, o valor gasto com toda a farmácia básica do Município correspondia a cerca de R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Após análise dos pedidos formulados e dos documentos que acompanharam a inicial, foi possível verificar algumas inconsistências nas prescrições médicas emitidas por único profissional médico, da rede particular, mesmo patrono (particular) e mesma causa de pedir.

Assim, imperioso salientar que o trabalho técnico aprofundado realizado pela farmacêutica do NAJS viabilizou o pleito de revisão judicial das demandas pela Procuradoria, com desfecho favorável ao Município.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Uma das expectativas presentes na literatura é a de que juízes e tribunais rejeitem ou citem evidências técnicas, especialmente aquelas relacionadas à incorporação de medicamentos e insumos pelo SUS (10).

A Resolução n.º 31, de 30 de março de 2010 constituiu um marco normativo inaugural das medidas de composição, consubstanciadas, notadamente, na implantação das Câmaras de mediação, conciliação e solução de conflitos na área de saúde (11).

O CNJ recomendou a criação dos Núcleos de Assistência Técnica (NAT) em 2011 e instituiu a obrigatoriedade destes núcleos em todos os Estados em 2016 (12). A experiência varia de Estado a Estado, mas em geral os NATs servem para orientar magistrados, quer emitindo nota técnica quer provendo juízes de orientações caso a caso (13).

Os núcleos têm como finalidade o auxílio aos magistrados no julgamento das demandas envolvendo prestações relacionadas ao direito à saúde, viabilizando a disponibilidade de um conhecimento técnico para o respaldo de uma decisão mais segura (13).

O Estado de Santa Catarina dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus-SC), que fornece dados científicos aos magistrados e colabora para o embasamento das decisões judiciais, tendo como princípio a Medicina Baseada em Evidências.

Malgrado a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça da criação dos NatJus, de acordo com pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), na região Sul do país, as decisões judiciais mencionam o NatJus em 0,07% das ações (14).

Contudo, mesmo sendo esse o objetivo primeiro dos núcleos, não podemos deixar de visualizar outras finalidades, como: a) melhor atendimento do cidadão, que pode vir a ter sua pendência resolvida em até 48 horas, deixando assim de percorrer todo o trâmite normal do judiciário; ou b) ainda a capacidade de diminuir o inchaço do Judiciário, uma vez que adota uma espécie de filtro (13).

Importa ainda registrar que a atuação do NAJS, a despeito da similaridade das atividades técnicas exercidas, não se confunde com o Núcleo de Assistência Técnica (NAT), nos moldes recomendados pelo CNJ, porquanto vinculados a órgãos distintos, um ao Poder Executivo e outro, ao Poder Judiciário.

A Mediação Sanitária, em sua acepção mais ampla – e com contornos e nomenclaturas diversas – vem ganhando espaço na discussão nacional acerca do fenômeno da Judicialização da Saúde como uma alternativa eficaz na redução das demandas, e visa discutir os desafios (problemas-causas) coletivos de saúde, no âmbito micro ou macrorregional, a partir do envolvimento dos diversos atores da seara sanitária, jurídicos ou não, mediante a construção de espaços democráticos, compartilhados, interdisciplinares, cujo resultado possa levar ao fortalecimentos ou à construção de políticas públicas de saúde universais, integrais e igualitárias (14).

A Mediação milita na perspectiva da tríade Direito, Saúde e Cidadania, por acreditar que é possível a convergência do diálogo entre eles (Sistema de Saúde x Sistema Judicial) (16).

A adesão a meios alternativos de solução de conflitos, especialmente a mediação, busca realizar “uma lenta transformação da sociedade brasileira, para criar a cultura do consenso e da cooperação na composição das disputas, aceitando-se um polissêmico conceito de justiça” (15).

Ainda para os mesmos autores, a mediação sanitária se apresenta como uma possibilidade de discutir as ilações na área da saúde, diante da natureza do tema envolvido, que transcende a ótica bilateral da relação entre médico e paciente e envolve vários outros indivíduos, instituições e interesses (15).

Ainda acerca da legislação pertinente ao tema, merece destaque a Resolução CNJ n.º 125, de 29 de novembro de 2010, que instituiu a mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos. Essa resolução tem como objetivo assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade (17).

A referida Resolução também determinou que aos órgãos judiciários incumbisse, além da solução obtida mediante sentença, oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, por meio de outros meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestarem atendimento e orientação à população.

O município de São Bento do Sul não possui Comitê de Mediação Sanitária.

O referido município possui apenas Comissão de Farmácia que foi instituída por meio da Comissão de Farmácia e Terapêutica instituída por meio do Decreto n.º 1.516, de 16 de dezembro 2016, que homologa a Resolução n.º 10, de 29 de novembro 2016, do Conselho Municipal de Saúde (18).

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT-SEMUS) é instância de caráter consultivo, deliberativo e de assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, cujas ações devem estar voltadas à promoção do uso racional de medicamentos. Tem por finalidade a seleção de medicamentos nos diversos níveis de complexidade do sistema, estabelecer critérios para o uso dos medicamentos selecionados, por meio de estudos de protocolos e avaliar a utilização dos medicamentos selecionados.

Possui como atribuições: assessorar os profissionais de saúde nos assuntos referentes a medicamentos, a atualização constante da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME, com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME), com emissão de parecer técnico sobre a inclusão, exclusão ou substituição dos medicamentos, a elaboração de Formulário Terapêutico, bem como outros materiais informativos sobre o uso racional de medicamentos e desenvolvimento e validação de protocolos terapêuticos.

A Comissão é composta por:

- Secretário da Saúde (ou representante da gestão);
- Diretor Técnico;
- Enfermeiro das UBS/ESF;
- Enfermeiro do Centro de Especialidades Médicas;
- Farmacêutico da Central de Abastecimento Farmacêutica;
- Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde;
- Responsável técnico pela Enfermagem;
- Responsável técnico pela Odontologia;
- Cirurgião dentista da Atenção Básica/Centro de Especialidades Odontológicas;
- Cirurgião dentista da Estratégia Saúde da Família;
- Vigilância Epidemiológica;
- Vigilância Sanitária;
- Núcleo de Educação Permanente em Saúde/Secretário Executivo.

As reuniões acontecem mensalmente na Secretaria de Saúde do município. Em 2017, foi criada uma Comissão interna, composta por uma médica, um farmacêutico, um enfermeiro e um assistente social para avaliação das solicitações de medicamentos não dispensadas na Atenção Básica. Por resistência de alguns profissionais a Comissão não obteve êxito. A saber: as solicitações de medicamentos eram realizadas diretamente à Assistência Social da Saúde. Sem conhecimento técnico, eram fornecidos diversos medicamentos, algumas vezes inclusive medicamentos da atenção Básica, mas que

eram prescritos por nome comercial, onerando o município. Foi então, resolvido juntamente com o Secretário de Saúde, que todas as solicitações relacionadas a medicamentos deveriam ser solicitadas diretamente no Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde, com a farmacêutica responsável.

Como pontuado, o município de São Bento do Sul possui um Núcleo de Atendimento Judiciário da Saúde (NAJS), um setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, composto por duas servidoras: uma farmacêutica e um chefe de setor, visando melhor orientação tanto no que se refere à área de saúde, quanto às questões jurídicas.

No que tange às demandas de medicamentos, as de natureza administrativa ou judicial, passam necessariamente pela avaliação do Núcleo, desde a solicitação do medicamento até a dispensa ao paciente.

De acordo com o fluxo atual, o paciente procede ao pedido de fornecimento do medicamento, cujo parecer, em suma, pode ser favorável à dispensação, quando há disponibilidade de estoque ou possível substituição por medicamentos incorporados ao SUS e em conformidade com Protocolos Clínicos e Diretrizes Farmacêuticas do Ministério da Saúde.

Na hipótese de o médico assistente não acatar a possibilidade de substituição, geralmente o paciente se dirige ao Ministério Público, que, por seu turno, a partir de outubro de 2019, orienta o paciente a retornar ao NAJS para fins de obtenção da negativa formal, munido de documentos médicos (relatório e prescrição médicos) e pessoais.

Sucedem, atualmente, essas solicitações não são registradas em planilhas, quicá sistema informatizado próprio, eis que inexistente, sendo tão somente arquivados em pastas físicas, contendo o protocolo de entrega do parecer ao paciente.

Ainda, inexistem um controle adequado e efetivo das negativas, tampouco sua motivação.

Assim é que, diante desse cenário, a primeira proposta de estratégia consiste no registro informatizado de tais demandas, de maneira a permitir ao gestor a melhor qualificação das demandas, registro dos pareceres emitidos e digitalização dos documentos. Com isso, será possível entender o motivo da judicialização de forma sis-

têmica, indicando inclusive o ente responsável pelo fornecimento, notadamente nos casos de medicamentos de alto custo, em conformidade com as recentes posturas dos Tribunais Superiores.

O segundo aspecto relativo à proposta de enfrentamento se refere à constituição de um Comitê Executivo, com participação dos atores da judicialização da saúde, isto é, Poder Judiciário e Ministério Público Estadual, uma vez que as demandas judiciais no Município de São Bento do Sul são intentadas, praticamente na sua totalidade (98%), pelo *Parquet*.

Isto porque, a despeito da existência de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público não a compõem.

A instituição do Comitê, tal como proposto pelo CNJ, permite a melhor compreensão das demandas da saúde, viabiliza o diálogo institucional e, por conseguinte, melhor racionalização dessa excessiva judicialização, calcada em evidência científica e sustentabilidade dos recursos.

Nesse sentido, à luz da experiência vivenciada no Estado da Bahia, que instituiu uma Câmara de Conciliação de Saúde, órgão vocacionado ao atendimento demandas pré-processuais, instituído por meio de Convênio, é possível criar um órgão colegiado voltado ao “amplo diálogo e à abordagem das temáticas mais relevantes, considerando o quantitativo, a complexidade e vulto financeiro das demandas, em constante busca da composição extrajudicial e viabilização de adoção de medidas menos gravosas aos usuários e aos cofres públicos” (14).

Valendo-se desse espaço de diálogo interinstitucional, podem ser fomentadas as discussões acerca das demandas relativas a medicamentos não incorporados à Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e a evolução dos estudos de evidências científicas, relação de custo-efetividade da incorporação de novas tecnologias, possibilidade de atendimento excepcional pelos gestores locais, além da ampliação do debate acerca da responsabilidade de cada ente, municipal, estadual e federal, à luz da legislação atinente à matéria, a qual envolve vasto arcabouço normativo-jurídico.

Consoante a pesquisa do INSPER (14), a iniciativa viabilizou o direcionamento mais adequado das demandas aos órgãos de defesa dos usuários do Sistema Único de Saúde (Ministério Público Estadual e Defensorias Públicas Estadual ou da União), repercutindo na diminuição da judicialização no âmbito estadual e municipal. Casos envolvendo medicamentos do Componente Especializado, por exemplo, em especial os de aquisição centralizada no Ministério da Saúde, foram encaminhados para judicialização na Defensoria Pública da União.

Por outro lado, ainda de acordo com a referida pesquisa, “o número de ações ajuizadas pela DPE caiu em cerca de 80% no período, o que, segundo a coordenadora, seria um indicador de que a atuação da CCS tem surtido efeito para diminuir os casos evitáveis de judicialização” (14).

Portanto, o enfrentamento do problema federativo na judicialização perpassa os atores do fenômeno da judicialização no que concerne à divisão de competências e réus na judicialização. Trata-se de um instrumento importante de diminuição da judicialização desnecessária e levando ao Judiciário apenas casos que os órgãos envolvidos não conseguem resolver extrajudicialmente.

Considerações Finais

O fenômeno da Judicialização da Saúde ainda encontra seus percalços, especialmente no que concerne aos medicamentos de alto custo, face à dinâmica e constante inserção pela indústria farmacêutica de novos fármacos e tratamentos, sem efetiva demonstração de superioridade de eficácia aos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

A criação de órgãos específicos na estrutura administrativa das secretarias municipais de saúde, bem como a criação de espaços de diálogos inter e intrainstitucionais, mormente quando é possível realizar um monitoramento preciso dos casos de judicialização, com identificação de temas de maior relevância, atrelada a um sistema automatizado eficiente, permite aos atores, em especial o gestor, o acompanhamento de processos judiciais, devidamente discriminados por objeto das demandas, patronos

das ações, motivação da judicialização etc., configurando-se como um passo importante para a racionalização da judicialização, de maneira a atenuar a quantidade de casos evitáveis.

Para além, ante a premente necessidade de “memória” de dados e processos da Administração Pública – os quais, antigamente, restavam relegados a informações de pessoas (leia-se servidores, efetivos ou comissionados), ou, na melhor das vezes, registrados em arquivos oficiais – um sistema informatizado permite, não só a qualquer gestor acessar informações e dados para uma melhor gestão, mas, especialmente, à população, devidamente representada pelos Conselhos de Saúde, a melhor entender onde o dinheiro público vem sendo aplicado.

Noutra senda, com a proposta de gestão informatizada dos processos e consequente geração de indicadores e dados da Judicialização – além do debate incessante, da promoção de diálogo interinstitucional concreto, na busca pela melhor compreensão e conscientização das classes envolvidas: médica, gestores, promotores, defensores públicos e privados, magistrados e sociedade civil organizada – é possível viabilizar assistência farmacêutica e médica de forma racionalizada e sustentável.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Bento do Sul ainda tem muitos desafios a enfrentar, como demonstrado ao longo do presente projeto – o que engloba, precipuamente, a criação de uma ferramenta digital como recurso necessário ao enfrentamento da judicialização, não dissociada do fortalecimento das parcerias entre todas as instituições envolvidas no processo de atendimento à população – quedando-se imprescindível para o êxito do trabalho realizado pela gestão local e até mesmo a mediação em prol do usuário do SUS.

Referências

- 1 - Gil AC. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas; 2002.
- 2 - São Bento do Sul (SC). **Decreto Municipal n.º 1.265, de 09 de março de 2016**, Criação do núcleo de atendimento judiciário da saúde - NAJS no Município de São Bento do Sul – SC. [Internet]. São Bento do Sul, 2016 [citado 16 maio 2020]. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-bento-do-sul/decreto/2016/126/1265/decreto-n-1265-2016-dispoe-sobre-a-criacao-do-nucleo-de-atendimento-judiciario-da-saude-najs-no-municipio-de-sao-bento-do-sul-sc>>.
- 3 - Pinheiro MC. **Núcleos de assessoramento técnico: Estratégia à judicialização da saúde?** [Monografia] [Internet]. Brasília: Escola Nacional Administração Pública-ENAP, 2016. [citado 12 jul. 2020]. Disponível em: <<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2490.pdf>>.
- 4- São Bento do Sul (SC). **Lei n.º 4.203, de 23 de dezembro de 2019**, dispõe sobre a estrutura administrativa do poder executivo municipal e dá outras providências. [Internet]. São Bento do Sul, 2019 [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-bento-do-sul/leiordinaria/2019/421/4203/lei-ordinaria-n-4203-2019>>.
- 5 - Schulze CJ. **Novo fundamento para federalização da judicialização da saúde**. [Internet]. São Paulo, 2019. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <<https://emporiiododireito.com.br/leitura/novo-fundamento-para-federalizacao-da-judicializacao-da-saude>>.
- 6 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo Demográfico 2017 [Internet]. Brasília, 2017. [citado 12 ago. 2019]. Disponível em: <www.ibge.gov.br>.
- 7 - Ministério da Saúde (BR). Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Relatório de Recomendação n.º 392 outubro de 2018. [Internet]. Brasília, 2018. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_2018.pdf>.
- 8 - Ministério da Saúde (BR). **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Relatório de Recomendação n.º 335 janeiro de 2018**. [Internet]. Brasília, 2018. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Enoxaparina.pdf>.
- 9 - Ministério da Saúde (BR). **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Relatório de Recomendação n.º 195 fevereiro de 2016**. [Internet]. Brasília, 2016. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Anticoagulantes.pdf>.

10 - Souza KA de O, Souza LE PF de, Lisboa ES. **Ações judiciais e incorporação de medicamentos ao SUS: atuação da Conitec.** *Saúde Debate* [Internet]. 2018; 42(119):837-48. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042018000400837&tlng=pt>

11 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Recomendação n.º 31 de 30/03/2010a.** Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde [Internet]. Brasília, 30 mar 2010 [citado 01 dez 2019]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf>

12 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução n.º 238, de 06/09/2016.** Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública [Internet]. Brasília, 06 set 2016 [citado 10 dez 2019]. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_238_06092016_09092016173942.pdf

13 - Ferreira SL, Costa AM. **Núcleos de Assessoria Técnica e Judicialização da Saúde: Constitucionais ou Inconstitucionais?** *Rev SJRJ* [Internet]. 2013; 20(36):219-40. Disponível em: <<https://www.jfrj.jus.br/sites/default/files/revista-sjrj/arquivo/371-1724-3-pb.pdf>>

14 - Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER (SP). Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Relatório analítico propositivo [Internet]. São Paulo, 2019. Série Justiça Pesquisa [citado 01 dez 2019]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/03/f74c66d46cfea933bf22005ca50ec915.pdf>>

15 - Delduque MC, Castro EV de. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil.** *Saúde em Debate* [Internet]. 2015; 39(105):506-13. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-pt>

16 - Assis G. **A ação institucional de mediação sanitária: Direito, saúde e cidadania.** *Cad Ibero-Americanos Direito Sanitário* [Internet]. 2013; 2(2):460. Disponível em: <<http://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/98>>

17 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução n.º 125, de 29/11/2010b.** Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências [Internet]. Brasília, 29 nov. 2010 [citado 10 dez 2010]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_125_29112010_03042019145135.pdf>

18 - São Bento do Sul. Prefeitura Municipal. **Decreto Municipal n.º 1.516, de 16 de dezembro de 2016**, homologa a Resolução n.º 10, de 29 de novembro 2016, do Conselho Municipal de Saúde. [Internet]. São Bento do Sul: Prefeitura Municipal, 2016. [Acesso em 16 de julho de 2020]. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a1/sc/s/sao-bento-do-sul/decreto/2016/151/1516/>>



Núcleo de mediação extrajudicial no município de São José: Um caminho para a parceria, o diálogo e a solução.

Adriana Falcão Raposo¹

Alex Rodrigues Freitas²

Alice Buss Cruz Ribeiro³

Henrique Luis Follador⁴

Marcos Hiago do Nascimento Oliveira⁵

Nivaldo Izidoro Alves Junior⁶

Rogério Rodrigues de Mendonça⁷

Simone Cortez de Sena⁸

Orientadora: Profa. MSc. Gisele de Jesus Silva

Como opção metodológica, idealizou-se um projeto de construção de um núcleo de mediação extrajudicial no município de São José. Apesar da existência de um setor

¹ Graduada em Direito pela UNICAP e em administração de empresas pela FCAP/UPE. Especialista em direito público pela Faculdade Estácio. Assessora jurídica da Secretaria de Saúde do Município do Paulista-PE.

² Graduado em Direito pela FASEC. Assessor Jurídico da SMS de Palmas-TO.

³ Graduada em farmácia pela UFSC, Especialista em Farmácia Oncológica pela LPCC/HEG-PR. Mestre em Química pela FURB, Santa Catarina. Membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF-SC. Gerente de Assistência Farmacêutica e do Núcleo Técnico de Ações Judiciais do Município de São José-SC.

⁴ Graduado em Administração de Empresas com habilitação em Análise de Sistemas pela UNESC, pós-graduado em Gestão em Saúde pela UFF e Gestão Pública pela UFES. Secretário Municipal de Saúde do Município de São Mateus-ES.

⁵ Graduado em Biomedicina pela FANORTE/RO. Gerente de Vigilância em Saúde do Município de Rondolândia-MT.

⁶ Graduado em Farmácia pela UFPB e em Direito pela UNIPÊ. Assessor Técnico Normativo da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba.

⁷ Graduado em Fisioterapia pelo INTA. Secretário Municipal de Saúde de Catunda-CE.

⁸ Graduada em Letras pela Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas, pós-graduada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela UCB. Assistente de diretoria do Setor de Ações Judiciais da SMS de Diadema-SP.

organizado e efetivo que gerencia as demandas judiciais, foi possível identificar que ainda não há uma ação para compor um acordo previamente à judicialização. O principal objetivo da mediação é melhorar a comunicação entre as partes a fim de restabelecer as relações sociais e reduzir as demandas judiciais.

O Município de São José possui um Núcleo Técnico de Ações Judiciais que acompanha todas as demandas judiciais que envolvem o Município e avalia que muitas destas demandas poderiam ser resolvidas sem a judicialização que traz enormes prejuízos ao Município.

O Poder Judiciário está longe de ser um padrão de excelência e efetividade em virtude dos altos custos das demandas e morosidade dos processos, portanto, a busca por condutas mais simples e eficazes para resolver as questões judiciais tem ganhado um espaço relevante. A formação de um núcleo de mediação tem como foco a conciliação das partes por meio de mecanismos bem elaborados que permitam privilegiar um debate construtivo que estabeleça interesses comuns entre as partes, e já é uma realidade em alguns estados e municípios (1).

Para implantação do Núcleo de Mediação Extrajudicial Municipal é necessário a articulação do Núcleo Técnico de Ações Judiciais (NUTAJ), do Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde e da Procuradoria Geral do Município, essa articulação interna é fundamental para a real implantação do Núcleo. Além da parte jurídica, a prática em mediação de conflitos inclui necessariamente conhecimentos metodológicos de caráter interdisciplinar (2), portanto como se trata de judicialização na área da saúde a presença de profissionais da saúde de diferentes áreas se torna fundamental na composição do Núcleo.

O principal objetivo do Núcleo de mediação é realizar audiências anteriores à distribuição de ações judiciais a fim de evitar demandas que possam ser solucionadas previamente, trazendo um melhor resultado às demandas dos usuários do SUS, tendo em vista que atualmente o SUS oferece diferentes linhas de cuidado e mantém um processo contínuo de ampliação do acesso aos medicamentos de alta complexidade (2).

Dentre as metodologias de mediação de conflito, o grupo pretende trabalhar com os modelos focados no acordo, especificamente com as metodologias de mediação satis-

fativa e de conciliação. Nessas metodologias a questão relacional não é prioritária, pois o interesse em reparações materiais é o foco natural e imediato da disputa. Os modelos de mediação focados no acordo priorizam as questões materiais objetivas, porém, durante o processo procura-se fortalecer a colaboração para que as partes evoluam das posições iniciais para a identificação dos interesses comuns subjacentes, e com isso à estruturação das opções, para chegar, quando possível, a um acordo fundado em dados da realidade (2).

A intenção é que após a estruturação do Núcleo de mediação, este estabeleça parcerias com outros órgãos públicos como a Defensoria Pública Estadual (DPE), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), e que o Núcleo de mediação passe a ser uma fonte de informação e consulta para esses órgãos, bem como um canal de comunicação com o usuário do Sistema Único de Saúde.

Este estudo foi realizado mediante pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, porém, com um olhar qualitativo no que diz respeito a interpretação dos dados e achados junto às fontes oficiais de busca, que são os arquivos da procuradoria Municipal, onde constam todas as demandas em que o Município foi citado como parte da lide, juntamente com os dados disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Diagnóstico da judicialização no município

O diagnóstico da judicialização no município, para elaboração de processos estratégicos de enfrentamento às demandas, é fundamental para uma maior diminuição dos processos judiciais e dos valores gastos com essas ações.

Por meio de da proposta de criação de um núcleo de mediação a ideia é que o município reduza o investimento de recursos e pessoal nas demandas judiciais e passe a resolver parte de suas questões de forma administrativa, ou seja por intermédio da mediação de conflitos, evitando assim o processo de judicialização para alguns casos específicos e o desgaste das partes envolvidas.

O Município de São José sentindo a necessidade de organizar as demandas judiciais e ter um diagnóstico mais preciso sobre as demandas mais frequentes, as causas e consequências da judicialização, otimizando as respostas e as defesas juntamente ao poder judiciário criou o Núcleo Técnico de Ações Judiciais (NUTAJ) (3).

O NUTAJ tem como objetivo organizar o fluxo de acesso aos medicamentos e insumos que não fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que são solicitados por meio de ações judiciais, bem como prestar suporte técnico à Procuradoria Geral do Município. Dessa forma, o NUTAJ é um setor específico para atender as decisões judiciais, elaboração de fluxo de distribuição de medicamentos, e para atender as ações com agilidade evitando multas pelo não cumprimento das ações relacionadas a medicamentos e insumos para saúde. O setor também é responsável por manter as informações dos pacientes e dos processos de forma organizada e monitorar a evolução das ações judiciais (3).

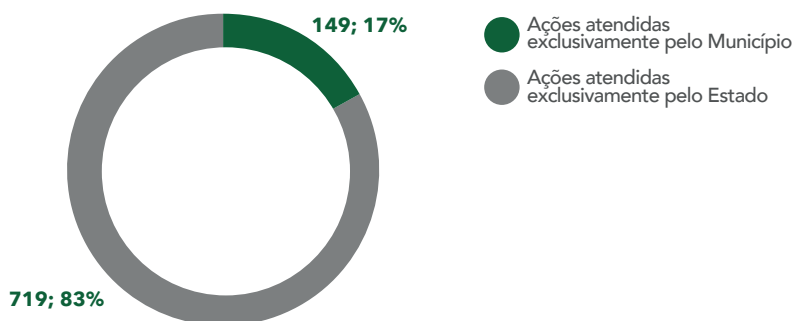
Situado na Prefeitura Municipal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São José, o NUTAJ é composto pelos seguintes profissionais: dois farmacêuticos, um assessor jurídico, dois técnicos de enfermagem e um técnico administrativo, todos os profissionais são servidores estatutários, e temporariamente recebem em seu quadro, estagiários das diversas áreas da saúde (3, 4).

O setor de Compras da Saúde atua em conjunto com o NUTAJ na realização dos procedimentos pertinentes aos processos de compras. As aquisições de qualquer natureza obedecem à Lei n.º. 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando princípios básicos, a fim de tornar os processos de compras mais transparentes (3, 4).

Mesmo em se tratando de decisão judicial, que impõe um prazo curto para o atendimento da demanda e inviabiliza o processo licitatório regular, o Município de São José obedece a todas as regras da Lei n.º. 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual estabelece a fim de atender as demandas judiciais em consonância com os dispositivos legais vigentes (4).

Em 2018, o número total de pacientes que utilizam o serviço e retiram medicamentos e insumos mensalmente juntamente ao NUTAJ foi de 149 usuários, de ações em que o município é único réu, sem os demais entes da federação. Já nas ações na qual o município divide a obrigação com outros entes como a Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, das quais algumas das ações os dois entes são réus solidários, somam 719 usuários, conforme ilustra a Figura 1 (5).

TABELA 1. Número de Processos atendidos pelo NUTAJ em 2018.



Fonte: Dados Internos do Núcleo Técnico de Ações Judiciais da Secretaria Municipal de São José-SC.

Quando a demanda tem como réus solidários o Município de São José e o Estado de Santa Catarina, os medicamentos são adquiridos pelo Estado e distribuídos pelo município. Ainda é possível observar na Tabela 1 alguns processos que incluem a União como réu, onde o município faz aquisição e distribuição e busca posteriormente o ressarcimento (5).

TABELA 1. Dados dos processos de medicamento do município de São José do ano de 2018.

ANO 2018	
Número de Processos Atendidos	149
Número de Processos Novos	9
Número de Processos Inativos	26
Número de Negativas realizadas pelo NUTAJ	206

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos processos informados pela SMS e PGM.

Com relação aos medicamentos mais solicitados quando separamos pelos entes que fazem a aquisição temos a seguinte informação:

- Medicamentos e insumos mais solicitados em ações contra o município: Infiximabe, Ranibizumabe, Insulinas análogas e Fórmulas alimentares específicas.
- Medicamentos mais solicitados em ações contra o Estado: Insulinas análogas, Tiotrópio, Aflibercepte, Duloxetina, Micofenolato de Mofetila, Ranibizumabe e Salmeterol + Fluticasona.

Sabe-se que os medicamentos mais judicializados são os medicamentos de alto custo, e a classe que melhor exemplifica os medicamentos de alto custo são os medicamentos biológicos, e esses são os que causam um maior impacto no orçamento público das instituições de saúde. É sabido que nos últimos anos dos dez medicamentos mais judicializados em média oito não estão disponíveis no SUS. Boa parte desses pacientes tem diagnóstico de doenças raras e dependem de medicamentos de alto custo. A via judicial se torna a única opção (6).

Ao longo dos anos, foi possível observar mudanças nas características das ações judiciais de medicamentos no cenário nacional, e no município de São José não tem sido diferente. Atribui-se essas mudanças ao surgimento de novas tecnologias disponibilizadas constantemente pela indústria farmacêutica. Outro ponto evidente da mudança no cenário é a classificação dos medicamentos judicializados que passaram de um

caráter mais básico para um caráter de alto valor aquisitivo, como foi exposto anteriormente, que não estão disponíveis nas listas oficiais do SUS. Essa característica mostra uma evolução do município nos processos relacionados à Assistência Farmacêutica bem como mostra que o município vem fazendo um trabalho importante na avaliação e atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Essa evolução atribui-se também pela consolidação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) ativa no município que faz estudos e revisões periódicas dos medicamentos padronizados e Avaliação de inclusão de novas Tecnologias em Saúde (ATS).

Importante ressaltar que um fluxo importante antes da demanda judicial é a solicitação da certidão negativa. Essa certidão negativa tem um papel muito importante para os órgãos públicos e são elementos fundamentais nos processos jurídicos. Na elaboração de uma certidão negativa os órgãos públicos têm a oportunidade de explicar e expor as informações pertinentes referente ao tratamento pleiteado pelo usuário. As informações que são prestadas são quanto a padronização ou não do medicamento nas listas oficiais (RENAME, REMUME e RESME) bem como as opções terapêuticas existentes disponíveis no SUS (7, 8).

Diante do exposto acima, podemos afirmar que as certidões negativas de medicamentos e produtos para saúde fazem parte de uma etapa importante no processo de racionalização das demandas judiciais. Onde o usuário procura o serviço de saúde com sua demanda e recebe as orientações quanto ao seu possível fornecimento do medicamento via SUS. No município de São José, conforme a Portaria n.º 002 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, as certidões negativas devem ser realizadas mediante a apresentação de prescrição médica, laudo justificando a necessidade de utilização do medicamento em questão, entre outros comprovantes (7, 8).

Em Santa Catarina, o Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência da Saúde, o COMESC recomenda esgotar as alternativas de medicamentos da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) antes de prescrever outros medicamentos (Figura 1). Algumas das informações que deve conter na justificativa estão listadas abaixo:

1. O esgotamento das alternativas de fármacos previstas na lista RENAME e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde;
2. O prescritor deve elaborar fundamentação técnica consistente, indicando quais os motivos da exclusão dos fármacos já eventualmente previstos;
3. Manifestação sobre possíveis vínculos, formais ou informais, do prescritor com o laboratório fabricante do remédio em questão;
4. A indicação do medicamento (princípio ativo) deve adotar, obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) (9).

FIGURA 1. Modelo de Formulário Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência da Saúde de Santa Catarina (COMESC).


Poder Judiciário
Conselho Nacional de Justiça
Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e
Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010)
COMITÊ EXECUTIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COMESC
FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE MEDICAMENTO
ANEXO I

DADOS DO REQUERENTE:

Nome:	
CPF:	Cartão SUS:
Contato (email/telefone):	
Atendimento que originou a prescrição: () Particular () Convênio - Qual? _____	
() SUS - Unidade de atendimento: _____	

DADOS DA PRESCRIÇÃO:

Medicamento (DCB/DCI¹): _____	
Posologia: _____	Duração do Tratamento: _____
Validade da Receita: _____	Registro na ANVISA: () Sim () Não
Indicação em conformidade com a aprovada no registro: () Sim () Não	
Previsto em PCDT ² da doença listada abaixo: () Sim () Não	
Consta em padronização oficial (ex. REMUME, RENAME ou listas regionais ou estaduais) ³ : () Sim () Não	

* O preenchimento do formulário deve ser feito pelo médico com **LETRA LEGÍVEL**, em atenção ao art. 11 do Código de Ética Médica (Resolução CFM Nº 1931/2009).

1. Qual(is) a(s) doença(s) que acomete(m) o requerente e que motivaram a prescrição?
CID: _____ Doença: _____
Características da Doença: _____

2. Quais as opções de tratamento oferecidas pelo SUS para a doença citada?

3. As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas? () sim () não. Em caso afirmativo:
3.1 Especifique o período de tratamento e a resposta do requerente:

3.2 O requerente faz uso de outro(s) tratamento(s) (farmacoterapêuticos ou não)? Qual(is)?

4. O tratamento indicado na sua prescrição pode ser substituído por alguma alternativa oferecida pelo SUS?
() sim* - Especifique qual(is): _____
() não - Justifique detalhadamente: _____

¹ DCB/DCI: Denominação Comum Brasileira ou, na falta desta, Denominação Comum Internacional.

² Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

³ REMUME: Relação Municipal de Medicamentos / RENAME: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais



Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e
Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010)
COMITÊ EXECUTIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COMESC

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE MEDICAMENTO

* Favor fornecer ao requerente NOVA PRESCRIÇÃO.

4.1 Se apontada inefetividade terapêutica (evento adverso) e/ou desvio de qualidade dos medicamentos (queixa técnica), ou sua suspeita, esclareça os motivos que levaram a esta conclusão:

4.1.1 Houve notificação à ANVISA - NOTIVISA⁴ dos eventos acima? () não () sim nº _____

5. Qual(is) a(s) consequência(s) ao requerente caso este não seja submetido ao medicamento(s) indicado(s) a curto, médio e longo prazo?

6. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em risco de morte?

() sim. Justificativa: _____

() não. Justificativa: _____

7. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em agravamento da doença?

() sim. Justificativa: _____

() não. Justificativa: _____

8. Declaro, por fim, que não possuo qualquer interesse na prescrição do medicamento/insumo, que não a saúde do paciente, bem como não mantenho qualquer vínculo com a indústria farmacêutica, de órteses, próteses e materiais especiais, distribuidores e em pesquisa clínica relacionada à esta prescrição: () Sim () Não.

Prescritor (carimbo e assinatura): _____ Data: _____

PARA PREENCHIMENTO PELO REQUERENTE:

9. O requerente possui convênio particular de saúde? () Sim. Qual: _____ () Não.

9.1. Em caso afirmativo, houve a tentativa de obter o medicamento pelo convênio? () Sim () Não.

9.2. Houve negativa? () Sim () Não. 9.3. Negativa: () Verbal () Escrita Data: _____

10. O requerente buscou obter o medicamento pelo SUS? () Sim () Não.

10.1. Houve negativa? () Sim () Não.

10.2. Em caso afirmativo:

() Município _____ () Verbal () Escrita Data: _____

() Estado _____ () Verbal () Escrita Data: _____

() União _____ () Verbal () Escrita Data: _____

TERMO DE CONSENTIMENTO:

Declaro que estou ciente das informações fornecidas e autorizo a exposição dos dados médicos em âmbito judicial e administrativo: () Sim () Não.

Assinatura do Requerente: _____ Data: _____

⁴ <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/apresenta.htm>.

Em 2018, o NUTAJ elaborou no total 206 certidões negativas, número que reflete uma média de 17 certidões elaboradas por mês, o prazo para disponibilizar a certidão ao usuário é de pelo menos 48 horas após a solicitação. Esse tempo é fundamental porque as negativas são avaliadas individualmente e a resposta é elaborada por um dos farmacêuticos no NUTAJ.

Além das certidões negativas, a equipe técnica do NUTAJ mantém uma relação próxima à Procuradoria Municipal a fim de desenvolver pareceres técnicos que auxiliem a Procuradoria Geral do Município nas defesas do município (5, 6). Os pareceres técnicos são desenvolvidos por profissional farmacêutico qualificado e toda manifestação tem como base evidência científica de qualidade.

Boa parte dos processos judiciais tem o Ministério Público\Defensoria Pública atuando como representação do autor/pacientes, porém em São José ainda é comum os processos provenientes de advogados particulares. É possível identificar essa característica nas ações em que o município é o único réu (4).

Há um fluxo de comunicação antes de judicialização, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público oficiam a Secretaria Municipal de Saúde sobre o motivo da falta ou não entrega do medicamento/insumo. Medicamentos e insumo dos quais estão disponíveis nas Farmácias municipais, que fazem parte da REMUME, e os medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) cuja responsabilidade de aquisição e distribuição aos municípios é do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de Saúde (9).

Uma boa relação com estes órgãos é muito importante no processo da racionalização da judicialização, pois em muitas vezes o entendimento destes representantes acerca dos limites Municipais pode evitar demandas judiciais (4).

A maioria das ações é de obrigação de cumprimento (mandado de segurança) e a procuradoria municipal, quando há uma decisão desfavorável, interpõe recurso a esta decisão ao órgão superior. Há uma comunicação ampla e um canal aberto entre o NUTAJ e a Procuradoria Geral do Município (PGM), principalmente nas defesas e elaboração de pareceres técnicos que auxiliam a PGM e quando há necessidade de

comunicar a inatividade de pacientes, ou seja, que não estão retirando seus medicamentos e insumos regularmente (9).

Por causa do fato de as solicitações seguirem sempre o caminho da judicialização, sendo atendidas ou não, acabam por tomar tempo e recurso do município e dos órgãos envolvidos, diante disso o grupo idealizou um projeto de construção de um Núcleo de Mediação Extrajudicial no município de São José. O principal objetivo da mediação a ser implementada é melhorar a comunicação entre as partes envolvidas em uma demanda de medicamentos ou insumos não padronizada nas listas oficiais, a fim de restabelecer as relações sociais e reduzir as demandas judiciais (10).

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Secretaria de Saúde de São José conta com o Núcleo Técnico de Ações Judiciais (NUTAJ), setor organizado e efetivo que gerencia as demandas judiciais de medicamentos e insumos movidas face à municipalidade, realizando controle das ações, aquisição dos itens para cumprimento das determinações, além de elaborar a avaliação técnica das solicitações de medicamentos que não fazem parte da REMUME e pactuar o atendimento das ações quando mais de um ente figura como réu (10).

Vale ressaltar ainda que, além das atribuições já mencionadas ao longo do trabalho acerca do NUTAJ que desempenha um papel fundamental no tratamento das demandas judiciais que chegam a Secretaria de Saúde do Município de São José-SC. Além das atividades desenvolvidas visando o cumprimento das determinações judiciais, o núcleo desenvolve pareceres técnicos, como já apresentado, auxiliando a defesa jurídica exercida pela procuradoria geral do município (10).

A apresentação de informações técnicas na forma de parecer, mesmo que em sede de defesa, vai ao encontro da orientação contida na Recomendação n.º 31 de 30 de março de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. O documento foi elaborado como resultado da Audiência Pública n.º 4, realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) onde foram discutidos temas relacionados à Judicialização da Saúde. Dentre as reco-

mendações, ficou consignado que antes de apreciarem medidas de urgência, os magistrados procurem ouvir os gestores sobre os casos demandados. Além disso, sempre que possível, os processos devem ser instruídos com informações técnicas acerca das doenças e tratamentos requisitados. No mesmo sentido tem-se o Enunciado n.º 13, elaborado pela III Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça que diz que “Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar) (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) (11, 12).

Sendo assim, fica claro o papel do NUTAJ como protagonista na troca de informações técnicas entre os atores envolvidos na judicialização da saúde. Ante a especificidade do tema, é fundamental que o poder executivo preste suporte técnico científico apresentando informações sobre eficácia e eficiência dos tratamentos requisitados, bem como as opções já existentes no Sistema Único de Saúde e sua repartição de competências. Informações essas que muitas vezes não são do conhecimento do Poder Judiciário (9).

O município de São José-SC, não possui um comitê de mediação sanitária, sendo esse o objetivo deste trabalho, a fim de melhorar a comunicação entre a Secretaria Municipal de Saúde e os órgãos demandantes das ações judiciais movidas em face do município: Defensoria Pública Estadual e Advogados privados, representando usuários, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), bem como os usuários que demandam contra o serviço público na esfera administrativa (13).

À princípio devemos considerar a mediação e a conciliação como sendo formas alternativas de solução de conflitos. Numa breve diferenciação, tem-se que na Conciliação haverá alguma forma de renúncia de vontade pelas partes para que se chegue a solução da controvérsia, o que numa primeira análise cria obstáculos à adesão do poder público a essa espécie de alternativa ante a aplicação dos Princípios da Indisponibilidade do Interesse Público e da Legalidade. Já em se tratando da Mediação, vê-se que essa prática se funda no exercício da vontade das partes envolvidas. Desta forma, podemos inferir que na mediação não há imposição de vontade, como, por exemplo, ocorre

numa demanda judicial. Visando benefícios mútuos, é alcançada uma solução consensual a partir do conhecimento das causas que geraram o possível conflito, o que facilita a obtenção do caminho para a solução. Sobre o tema, vale ressaltar o trazido pelo professor Daniel Assunção: (14)

A mera perspectiva de uma solução de conflitos sem qualquer decisão impositiva e que preserve plenamente o interesse de ambas as partes envolvidas no conflito torna a mediação ainda mais interessante que a autocomposição em termos de geração de pacificação social (14).

Sob esses aspectos, a Mediação se apresenta como o meio mais viável ao Poder Público para o exercício da solução consensual dos conflitos (13, 14).

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, Lei n.º 13.105 de 16 março de 2015, os institutos da Conciliação e Mediação ganharam previsão expressa na codificação processual brasileira. Logo no Capítulo 1 do referido diploma legal, que trata das normas fundamentais do processo civil, mais especificamente nos parágrafos 2º e 3º, fica consagrado que o Estado, podendo ser entendido como Poder Público de forma geral, promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, bem como que a conciliação e a mediação devem ser estimuladas por juízes, advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, sendo esses três últimos autores, os principais representantes e demandantes, em substituição processual, nos processos envolvendo o direito à saúde (15).

O Conselho Nacional de Justiça, por meio de da 14ª edição do relatório Justiça em Números, apresentou o quantitativo de demandas envolvendo prestações em saúde no ano de 2018. O resultado foi o quantitativo de 1.778.269 processos, tendo eles sido ajuizados entre os anos de 2014 e 2017. Além dos números, o próprio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça tem debatido sobre o tema e elaborado teses sobre a judicialização, o que mostra, além da importância do debate, a recorrência da matéria na realidade do Poder Judiciário Brasileiro. É nesse contexto que os institutos da Mediação e da Conciliação se apresentam como alternativa viável para a solução eficiente de possíveis litígios envolvendo o direito à saúde (16).

Mais do que isso, a implantação de práticas para solução consensual de conflitos, além de desafogar o próprio poder judiciário, cria a possibilidade de o Poder Executivo participar de forma mais ativa e efetivamente estabelecer diálogo com as partes. Na maioria dos casos judicializados, o ente público toma conhecimento da demanda já tendo sido, mesmo que liminarmente, determinado o seu cumprimento, seja visando fornecimento de medicamento ou aquisição de algum serviço ou produto de saúde. Sobre a aplicação do instituto no âmbito do direito à saúde, Delduque e Castro trazem que: (17).

Para além da resolução dos conflitos pela Mediação Sanitária, é possível, também, antever os conflitos, precavendo-se de seus efeitos por intermédio da construção e permanente atenção ao mapa dos conflitos no âmbito do SUS, fazendo com que o sistema possa operar antecipando-se aos conflitos futuros, solucionando-os.

No caso específico do Município de São José-SC, o número considerável de ações judiciais que, em sua maioria, requisitam medicamentos que não estão contemplados na padronização municipal têm o potencial de onerar o município ao longo do tempo, sendo a criação de uma Câmara de Mediação Sanitária uma alternativa para as situações existentes e uma ferramenta que pode subsidiar o ente municipal na construção de políticas de saúde futuras (18).

O papel da Câmara é de estabelecer um diálogo técnico sobre a requisição proposta, necessariamente em fase anterior à sua judicialização, esclarecendo sobre os fluxos existentes para acesso aos medicamentos, sejam eles padronizados ou não, a normatização do Sistema Único de Saúde e sua repartição legal de competências, informar a existência de alternativas terapêuticas e outros dados que forem pertinentes ao caso concreto (18).

Além de ser fonte de informações para o Judiciário, o comitê será um canal de comunicação com o usuário, orientando-o no mesmo sentido para que tenha acesso ao(s) medicamento(s) e insumo(s) necessários ao seu tratamento (18).

Já é possível identificar em todo o país iniciativas que privilegiam a composição consensual de conflitos com base em métodos alternativos à demanda judicial comum. Seja no âmbito no Ministério Público, seja no âmbito do Poder Judiciário, já é pos-

sível observar a criação de Centros especializados que visam a composição entre as partes em momento antecedente à instauração da demanda judicial. Sendo então a Judicialização da Saúde uma realidade de todo o sistema de justiça brasileiro, não seria surpresa ver essa matéria sendo tratada em centros de mediação e conciliação.

Acerca das iniciativas acima citadas podemos ressaltar a ação institucional da Mediação Sanitária: Direito, Saúde e Cidadania, criada pela Administração Superior do Ministério Público do Estado de Minas Geras, sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde (CAOSAÚDE), regulamentada pela Resolução PGJ n.º 78, de 18 de setembro de 2012. Já no âmbito no Poder Judiciário, podemos trazer o exemplo de Centro de Solução de Conflitos Fazendários (CEJUSC) do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde, além de outras matérias afetas ao Direito Público, trata, em âmbito pré-processual, de demandas envolvendo o fornecimento de medicamentos e serviços de saúde por parte do Poder Público (19).

Em se tratando de Poder Executivo, foi criado recentemente, no Estado de Pernambuco, a Câmara de Negociação, Conciliação e Mediação da Administração Pública Estadual. O decreto estadual que cria a iniciativa traz, como objetivo da Câmara, a adoção de medidas para autocomposição de controvérsias administrativas. Apesar da recente criação da iniciativa, já é possível observar que nesse ambiente de negociação criado, demandas relacionadas a medicamentos e serviços de saúde também serão objeto de discussão (20).

A realidade da Judicialização da Saúde no Brasil deve ser analisada não apenas levando-se em consideração a efetivação do direito à saúde. O elevado número de ações que tramitam juntamente ao Poder Judiciário, e suas consequentes determinações, também geram reflexos na organização do Poder Executivo. Na maioria dos casos, as decisões judiciais não consideram as já existentes políticas de saúde do Sistema Único de Saúde e sua repartição de competências, bem como as limitações financeiras e orçamentárias dos entes demandados.

Além disso, a elevação do direito à saúde ao patamar de direito constitucional e sua consagração como direito absoluto e de prestação obrigatória por parte do ente público, causa, como consequência reflexa, a diminuição do contraditório em termos

práticos. Observa-se, no dia a dia das ações contra prefeituras e estados, que há ainda pouco diálogo acerca das questões técnicas e regulatórias. Diversas são as demandas cujo objeto já é oferecido na rede pública de saúde e, em virtude das circunstâncias processuais, acaba por gerar, com base em decisões liminares sem a oitiva da gestão pública, onerosidade excessiva ou duplicada do erário.

Soluções como a criação de Núcleos de Auxílio Técnico ou Câmaras de Mediação devem visar, antes de qualquer coisa, a construção de um diálogo contínuo com os usuários do Sistema Único de Saúde e com todos os órgãos que hoje estão inseridos na realidade da Judicialização da Saúde, quais sejam, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e sociedade civil como um todo.

Consolidado o fenômeno da judicialização da saúde bem como suas consequências, mostrou-se necessário a adoção de práticas que pudessem enfrentar a problemática em todos os seus aspectos. As manifestações do Conselho Nacional de Justiça foram o marco inicial, principalmente no âmbito do Poder Judiciário, para a adoção de iniciativas que tentassem tratar do tema, não levando em conta apenas os aspectos processuais envolvidos nas demandas em saúde. A própria evolução da jurisprudência ao considerar como necessária a análise de questões clínicas e regulatórias, bem como a criação dos NATJUS no âmbito dos Tribunais de Justiça, se consolidam como um grande avanço no entendimento acerca do direito à saúde (3).

No entanto, vale ressaltar que tais práticas se aplicam a processos já instalados. Por mais que cada vez mais se possa considerar a racionalização na análise das demandas em saúde, o volume de ações ainda é deveras superior a capacidade técnica do próprio judiciário, bem como a consequência financeira desse volume para os entes demandados causa grande impacto aos cofres públicos. Além disso, visto a complexidade do tema, não é viável deixar apenas sob a responsabilidade do Poder Judiciário o enfrentamento da questão (21).

Todo o contexto verificado leva o gestor público em saúde a ser o protagonista das novas formas de enfrentamento à judicialização das prestações em saúde. Tanto a

legislação como as experiências já existentes são substratos que autorizam o Poder Executivo a tomar a dianteira na tentativa de minimizar os impactos da excessiva litigiosidade judicial, estabelecendo canais de diálogo com os atores envolvidos e espaços para negociação a fim de evitar a instalação de uma eventual demanda judicial (19).

Em estudo realizado com gestores municipais de saúde, Oliveira destaca que para os próprios secretários a possibilidade de diálogo tem potencial de solucionar as demandas previamente, valendo a transcrição: “É relevante ressaltar a mediação sanitária como alternativa eficaz à Judicialização, na qual 102 (63%) dos gestores, ao apontarem o diálogo, direcionam para a possibilidade de sentar-se à mesa com o cidadão e solucionar o problema antes de este chegar ao judiciário” (22).

Como já colocado anteriormente, alternativas ao modelo clássico de solução de conflitos já são uma realidade na legislação brasileira, devendo ser estimuladas pelo judiciário, demais funções essenciais à justiça e pela própria administração. Tribunais de justiça e entes do Poder executivo já possuem experiências nesse sentido e já colocam o direito à saúde como matéria a ser contemplada nessas iniciativas. A partir dos achados na literatura técnica, na legislação e nas experiências já existentes, é possível traçar pontos que possam estruturar a criação de um serviço alternativo para solução consensual de conflitos nas demandas em saúde no âmbito do município de São José-SC (15).

Em se tratando de composição, destaca-se que a legislação brasileira determina que toda representação judicial e extrajudicial seja feita pelos órgãos de advocacia pública dos entes públicos. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo n.º 182, traz como sendo incumbência dos citados órgãos, a representação da administração pública direta e indireta. Sendo assim, a construção de uma iniciativa de solução consensual de conflitos passa pela necessária participação, no caso concreto, da Procuradoria Municipal de São José, também eventualmente da Procuradoria do Estado de Santa Catarina e Advocacia Geral da União nos casos em que houver participação do Ente Federal e do Estadual.

Em termos de experiência existente e do papel da advocacia pública nessas iniciativas, vale ressaltar o decreto regulamentar da já citada Câmara de Negociação, Conciliação

e Mediação da Administração Pública Estadual de Pernambuco. Na norma regulamentar é possível identificar o papel do órgão de representação não apenas na defesa dos interesses do ente público, mas na preservação dos princípios da probidade e da legalidade dos acordos a serem celebrados como se observa na transcrição do artigo 5º do Decreto n.º 48.505 qual seja: “Art. 5º A CNCM atuará em consonância com os princípios da imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, boa-fé e garantia do contraditório” (23).

Noutro norte, visto seu caráter pré-processual, não é possível compreender o funcionamento da câmara de mediação apenas com profissionais ligados às ciências jurídicas. É de suma importância que profissionais da área técnica da saúde, com conhecimento também das diretrizes e funcionamento do SUS, possam compor a equipe desses espaços. Diversos modelos já existentes podem servir como parâmetro para a construção da equipe que terá caráter multidisciplinar e representatividade dos serviços envolvidos nas demandas.

Há a imprescindibilidade do suporte de um corpo técnico a fim de que os objetivos da mediação sejam alcançados. Em se tratando da realidade mais específica do município de São José, podemos considerar que o NUTAJ já existente, terá o papel fundamental no apoio a iniciativa, com informações técnicas e jurídicas bem como acerca das possibilidades de atendimento na rede municipal de saúde. (3).

Considerando a indispensabilidade de que, com a mediação, se criar um espaço de diálogo interinstitucional, deve ser indispensável a participação de órgãos como Ministério Público e Defensoria Pública visto suas funções constitucionais de defesa de direitos e interesses como o direito à saúde. Ao mesmo tempo que os casos sejam analisados e discutidos, um canal de fluxo de informações será criado com esses órgãos que passarão a conhecer melhor o funcionamento do SUS e as particularidades dos entes públicos envolvidos.

Como exemplo podemos citar a iniciativa criada no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, chamada SUS Mediado. Neste modelo, membros da Defensoria Pública, Ministério Público, Secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios de Natal, bem como membros da advocacia pública desses dois entes, compunham o quadro da

equipe que se reúne para analisar os casos que aportavam no serviço. Mais especificamente, quanto aos representantes da gestão saúde, a representação se dava por médicos e farmacêuticos com expertises não apenas em aspectos clínicos como também na assistência farmacêutica e na regulação de procedimentos.

Em se tratando de entes públicos, não há como excluir desta iniciativa a participação de representação da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, bem como de representantes da União, a depender dos casos que aportam no centro. Melhor colocando, este tipo de iniciativa tem mais eficiência ao mesmo tempo que a cooperação entre entes federados ocorre de forma concreta, pois é no espaço de mediação que cada um coloca suas responsabilidades estabelecidas pela legislação do SUS bem como suas possíveis dificuldades ou possibilidades de cumprimento.

Não menos importante, o espaço físico a ser utilizado deve considerar o já exposto no que diz respeito aos fins e premissas da mediação. Objetivando o diálogo, a mediação deve sempre ocorrer em locais que possam proporcionar aos envolvidos bem-estar e segurança a fim de despertar nos envolvidos o entendimento de que a experiência da mediação é positiva e tem eficiência.

Nesse aspecto, é possível se valer das orientações trazidas pelo Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no que diz respeito à organização dos espaços onde ocorrerão os encontros de mediação. As instruções enfatizam que a forma de organização do encontro pode diretamente auxiliar do bom desenvolvimento da sessão bem como no alcance de uma solução satisfatória, conforme pode-se extrair do exposto: “Mostra-se recomendável que a postura das partes seja realizada de modo que todos consigam ver e ouvir uns aos outros, como também participar dos debates. Uma segunda observação diz respeito à necessidade de se apartar qualquer aspecto que possa transparecer alguma animosidade entre as partes. Assim sendo, de preferência, as partes devem se sentar em posições não antagônicas (opostas). Um dos objetivos da mediação é tentar evitar um sentimento de rivalidade ou polarização, o que, no caso da disposição das mesas, é mais bem conseguido ao não colocar as partes de frente uma para a outra, mas, sim, lado a lado, no caso de mesa retangular, ou em posição equidistante, no caso de mesa circular. Ademais, deve-se frisar que as pessoas que representam uma parte devem conseguir se sentar juntamente com ela, caso assim

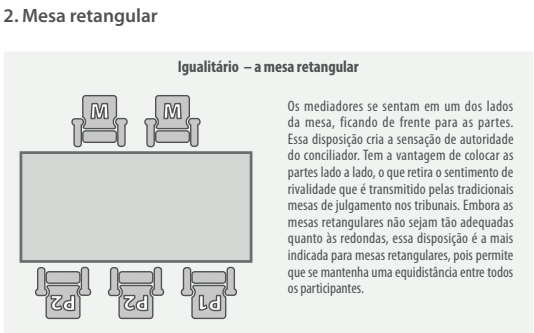
o desejem” (24). A seguir, a Figura 2 e a Figura 3 exemplificam o que foi exposto:

FIGURA 2. Utilização da Mesa Redonda na Mediação Judicial.



Fonte: Fonte: Manual de Mediação Judicial do MPDFT. Disponível em: <https://mpdft.mp.br/portal/pdf/programas_projetos/gase/Manual_de_Mediacao_Judicial_MPDFT_CNJ.pdf>.

FIGURA 3. Utilização da Mesa Retangular na Mediação Judicial.



Fonte: Fonte: Manual de Mediação Judicial do MPDFT. Disponível em: <https://mpdft.mp.br/portal/pdf/programas_projetos/gase/Manual_de_Mediacao_Judicial_MPdFT_CNJ.pdf>.

A autora Angélica Carlini, condensa o entendimento que a mediação deve acontecer com base em oito fases distintas, quais sejam: pré-mediação, abertura, investigação, agenda, criação de opções, avaliação das opções, escolha das opções e solução (25).

Nas fases iniciais de pré-mediação e abertura, é necessário que o mediador esclareça aos participantes todas as nuances que permeiam a mediação bem como os fins que essa busca. Assim, deve ficar claro que o objetivo da prática é a busca por uma solução que seja viável a todos os envolvidos sem caráter litigioso e obrigacional. Em seguida, deve ser o diálogo conduzido de forma que toda a demanda em particular seja esclarecida dando às partes oportunidade de expor suas posições acerca das especificidades do caso. Em se tratando de demandas em saúde, deve haver verdadeiramente uma investigação acerca das questões clínicas e técnicas do que é requisitado pelo poder público, como histórico do paciente, da patologia, tratamento por exemplo.

Nesse ponto, é de extrema importância a participação dos técnicos, como médicos, farmacêuticos e fisioterapeutas, por exemplo, a fim de haja uma completa análise do objeto demandado e da situação clínica do eventual paciente. Sem assumir caráter adversarial, as informações apresentadas pelo demandante devem ser analisadas à luz da medicina baseada em evidências de forma que a opção a ser oferecida seja revestida de eficácia e segurança conforme a literatura médica (25).

Vencidas as fases em que a demanda é conhecida e seus aspectos específicos são delimitados, surge o momento em que se faz necessária a construção de opções que satisfaçam todos os envolvidos, conforme ditam os princípios da mediação. Em se tratando desse momento, o já citado Manual do CNJ preconiza que: “na fase de elaboração do acordo, as partes devem identificar e avaliar todo o conjunto de informações, propostas eventualmente surgidas a partir da análise dos interesses e questões; realizar as negociações necessárias; desenvolver, testar e verificar a viabilidade das propostas apresentadas, como também dar às partes a sensação de estarem alcançando o acordo” (24).

Vale ressaltar que, mesmo com o auxílio das figuras mediadoras, são as partes que

devem construir a solução para a demanda. Pontos acerca de protocolos existentes e competências de atendimentos são esclarecidos e as opções postas à disposição do usuário considerando que deve haver esforço mútuo de ambos, inclusive dos entes públicos envolvidos, dentro dos limites legais. Finalizada a mediação, pode-se adotar procedimento semelhante ao proposto na regulamentação do Estado de Pernambuco, onde a autocomposição é reduzida a termo contendo os dados e resultados (23).

Considerações Finais

A proposta do projeto foi a implantação de um Núcleo de Mediação Extrajudicial, de forma a reduzir os casos de judicialização na cidade de São José no Estado de Santa Catarina. Obteve-se um panorama abrangente dos desafios, causas e efeitos da judicialização a partir da análise dos dados levantados, onde foi possível visualizar a importância do conhecimento sobre a judicialização da saúde, o diálogo institucional e a mediação sanitária.

Percebeu-se que nos últimos anos houve uma crescente demanda de litígios para a saúde, reivindicando o direito estabelecido na Constituição, que visa garantir os princípios do SUS: Universalidade, equidade e integralidade. Cada vez mais os cidadãos lançam mão desses direitos, quando não conseguem de alguma forma ter acesso aos tratamentos dos quais necessitam e buscam por meio de dos meios judiciais para conseguir-lo. E assim como a própria constituição estabelece a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios a fim de sanar as questões que o Sistema Único de Saúde (SUS) não dispõe.

Nos serviços de saúde há uma necessidade constante de implantação de medidas e alternativas a fim de reduzir os custos não só com a demanda judicial impetrada diariamente com medicamentos, mas também em todas as áreas da saúde, bem como em toda a administração pública. Primar pelo princípio da eficiência sempre será um alvo para a busca de soluções mais robustas diante da recorrente negativa de alguns medicamentos, insumos e outros serviços de saúde. O foco sempre será amenizar os problemas de saúde dos usuários, e proporcionar uma melhor qualidade de vida social e psicológica, muitas vezes comprometida decorrente da vulnerabilidade social em

que o indivíduo se encontre.

Dessa forma entendeu-se a importância de mitigar os casos, e conseguir reduzir os gastos imediatistas e imprevisíveis pela maioria dos municípios que ainda não dispõem de planejamento e orçamento específico para as demandas judiciais, o presente trabalho traz uma revisão dos aspectos geográficos, sociais e comportamentais do município de São José bem como uma visão macro de sua Secretaria Municipal de Saúde no intuito de conciliar essas demandas, e propor alternativas e soluções sem a necessidade de impetrar ação na justiça contra o município.

Com base em discussões ficou definido que diante de um serviço estruturado dentro da Secretaria Municipal de Saúde de São José, como o serviço que o Núcleo Técnico de Ações Judiciais do município (NUTA) já presta atualmente, seria o setor ideal para a construção de um Núcleo de Mediação Extrajudicial.

Sabe-se que a mediação de conflitos já está sendo adotada no ordenamento jurídico brasileiro de forma complementar e tem se mostrado muito eficiente para maioria das situações em que existam conflitos. A opção é tida como pacífica, democrática, pedagógica, e tem mostrado bons resultados em literatura nas demandas familiares, consumidores e outros conflitos sociais. Ao se levar em consideração os benefícios, incluindo a economia de recursos para os entes públicos, conclui-se que a mediação de conflito pode trazer resultados positivos também nas questões envolvendo a Administração Pública e o cidadão. Desta forma, o Núcleo de Mediação Extrajudicial seria um ganho para o gestor, usuários e assim como o sistema judiciário, que teria essa ferramenta para mediar os casos possíveis de judicialização, antes que seja deferida a sentença final.

Pode-se levantar que além do tempo investido nos processos judiciais, os gastos públicos que não foram previstos na lei orçamentária, também desequilibram a balança financeira dos entes federados, de forma desproporcional quando considerados outros recursos destinados à saúde. Há um grande investimento de recursos para cumprimento das decisões judiciais, montantes que poderiam ser utilizados de forma planejada para expandir a rede de acesso e cuidado da população, diminuindo consequente-

mente o subfinanciamento e equalizando assim as demandas na área da saúde.

No decorrer da construção do projeto algumas dificuldades se apresentaram, uma vez que a literatura não apresenta muita produção voltada diretamente para a mediação de conflitos dentro da administração pública em especial na área da saúde, portanto um tópico pouco explorado dentro da mediação de conflitos.

Como consideração final do projeto, salienta-se que a conclusão da revisão não apresenta um fim, mas sim o ponto de partida na construção de uma ferramenta que seja cada vez mais funcional aos entes públicos, onde os usuários, gestores e judiciário, possam estar gradativamente mais próximos, entendendo o fluxo e o funcionamento do SUS e assim garantindo a eficiência da gestão e da qualidade de vida do paciente, de forma rápida, resolutive e sem a necessidade de acionar o sistema judicial.

Futuramente com a possível implantação desta proposta pelo município, pretende-se validar a ferramenta e divulgar de forma ampla aos demais gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Referências

- 1 - Souza LT. **Mediação judicial como método alternativo de resolução de conflitos e a atuação da defensoria pública.** [Trabalho de Conclusão do Curso] Bacharel em Direito – Macaé: Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, Universidade Federal Fluminense; 2018.
- 2 - Vasconcelos CE. **Mediação de conflitos e práticas restaurativas.** São Paulo: Ed. Método; 2008.
- 3 - Schneider A. **Aquisição de medicamentos por determinação judicial: estudo de caso no setor de compras da Secretaria de Saúde de São José/SC.** [Trabalho de Conclusão de curso]. São José: Curso Bacharelado em Administração, Centro Universitário Municipal de São José (USJ); 2012.
- 4 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. **Lei n. 8.666 de 21 de junho, de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências [Internet]. Brasília, 6 jul. 1994. [citado 10 dez 2019]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>.
- 5 - Prefeitura Municipal de São José (BR). **Arquivos Internos Núcleo Técnico de Ações Judiciais (NUTAJ).** São José, SC: NUTAJ; 2019.
- 6 - Panorama Farmacêutico (BR). **Remédios Raros e Caros.** [Internet]. São Paulo; 14 mar 2018. [citado 12 dez 2019]. Disponível em: <<https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/03/14/remedios-raros-e-caros/>>.
- 7 - Pacheco J. **Perfil da judicialização de medicamentos para o tratamento do câncer de mama no Estado de Santa Catarina.** [Trabalho de Conclusão de Curso] Graduação em Farmácia [Internet]. Florianópolis: Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2019. [citado 20 jan. 2020]. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199223>>.
- 8 - Rocha TD. **Judicialização de medicamentos e outros tratamentos em Portão, 2013-2014.** 2015. [Trabalho de Conclusão] (Especialização em Gestão em Saúde) Novo Hamburgo: Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015.
- 9 - Prefeitura Municipal de São José (BR). **Portaria n. 002/2018/SMS/SJ.** Dispõe sobre a necessidade de apresentação de Formulário Preenchido por Médico para o Requerimento de Medicamento especial. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, 26 fev. 2018; Edição 2463, publicação 1536573, p. 982.

10 - Ministério Público de Santa Catarina (BR). **Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência da Saúde**. [Internet]. Florianópolis: Ministério Público de Santa Catarina; 2018. [citado 21 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.mpsc.mp.br/programas/comesc?ancora#recomendacoes>>.

11 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Recomendação n. 31 de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. [Internet]. CNJ. Brasília, 2010 [citado 27 jan. 2020]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf>.

12 - _____. **Enunciados I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça** [Internet]. Brasília, 2019 [citado 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf>>.

13 - Mouzalas R, Terceiro NJO, Madruga. **Processo Civil**. 8. ed. Salvador: JusPodivm; 2016.

14 - Neves DAA. **Manual de Direito Processual Civil**. Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivm; 2016.

15 - Brasil. **Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. [Internet]. Brasília, 16 de março de 2015. [citado 25 de jan. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>.

16 - Lima, JAHS, Schulze CJ. **Os números do CNJ sobre a judicialização da saúde em 2018**. [Internet]. Consultor Jurídico, Brasília, 10 nov. 2018. [citado 28 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2018-nov-10/opinio-numeros-judicializacao-saude-2018>>.

17 - Delduque MC, Castro EV de. **A mediação sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil**. Saúde debate. [Internet]. jun. 2015. [citado 25 jan. 2020]; 39(105):506-13. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0103-110420151050002017>>.

18 - Assis G de. **Mediação sanitária: direito, saúde e cidadania**. In: Santos L; Terrazas F, organizadoras. **Judicialização da saúde no Brasil**. Campinas: Saberes Editora; 2014. pp. 197-220. [citado 25 jan. 2020].

19 - Silva BA, Schulman G. **(Des)judicialização da saúde: mediação e diálogos interinstitucionais**. Rev. Bioét. [Internet]. ago. 2017. [citado 28 mar 2020]; 25(2):290-300. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422017000200290&lng=pt>.

20 - Resolução de disputas. **Decreto cria câmara de solução consensual de conflitos na PGE/PB.** [Internet]. Migalhas Quentes, 12 jan. 2020. [citado 28 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI318141,31047-Decreto+cria+camara+de+solucao+consensual+de+conflitos+na+PGEPE>>.

21 - Portal da Conciliação Tribunal de Justiça da Paraíba (BR). CEJUSC. **Fazendário realizará sessões de conciliação envolvendo demandas de saúde pré-processual.** [Internet]. João Pessoa, 2019 [citado 27 jan. 2020]. Disponível em: <<https://conciliar.tjpb.jus.br/cejusc-fazendario-realizara-sessoes-de-conciliacao-envolvendo-demandas-de-saude-pre-processual/>>.

22 - Oliveira MRM, Soares RAS, Sousa ME, Mendonça AVM, Delduque MC. **Mediação como prevenção à judicialização da saúde: narrativas dos sujeitos do judiciário e da saúde.** Esc. Anna Nery [Internet]. 2019 [citado 28 Feb 2020] ; 23(2): e20180363. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-pt>.

23 - Governo do Estado de Pernambuco (BR). **Decreto n. 48.505, de 6 de janeiro de 2020.** Regulamenta a Lei Complementar n.º 417, de 9 de dezembro de 2019, que cria a Câmara de Negociação, Conciliação e Mediação da Administração Pública Estadual - CNCM, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, e institui medidas para a redução de litigiosidade administrativa e judicial. [Internet]. Recife, Diário Oficial do Estado, 10 de janeiro de 2020, p. 8 coluna 2. [citado 29 fev 2020]. Disponível em: <<http://legis.alepe.pe.gov.br/Paginas/texto.aspx?id=48636&tipo=>>>.

24 - Azevedo AG. **Manual de Mediação Judicial.** [Internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 2016. [citado 27 fev 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>>.

25 - Carlini A. **Judicialização da Saúde Pública e Privada.** Porto Alegre: Livraria do Advogado; 2014. [citado 27 fev 2020].

Capítulo 4

REGIÃO SUDESTE



Município de Catanduva-SP

Município de Divinópolis-MG

Município de Rio de Janeiro-RJ

Município de Vila Velha-ES



Estratégias de enfrentamento da judicialização no sistema único de saúde: Um projeto de intervenção no município de Catanduva-SP

André Luiz de Lima Vaz¹

Francisco Glérison Vieira²

Francisco José Leal de Vasconcelos³

Lorrayna Magenski⁴

Mariza Kalix de Miranda⁵

Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior⁶

Sandro Rogério Cardoso de Paulo⁷

Orientadora: Profa. MSc. Maria Ione Silva Barros

O município de Catanduva foi escolhido para o trabalho investigativo considerando o seu porte populacional, perfil da judicialização da saúde e estrutura administrativa e operacional da Secretaria Municipal de Saúde – elementos importantes para o enfren-

¹ Graduado em Direito pela FDG, Pós-Graduado em Direito Previdenciário e Processo do Trabalho pela UNINASSAU. Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos do Município de Garanhuns-PE.

² Graduado em Enfermagem pela UEPB, Mestre em Saúde da Família pela UFRN. Assessor Técnico na SMS de Bernardino Batista-PB.

³ Graduado em Enfermagem pela UVA/CE e Direito pela FLF, pós-graduado em Gestão do SUS pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia/Sobral-CE. Coordenador Administrativo-Financeiro da SMS de Sobral-CE.

⁴ Graduada em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Estácio de Sá. Assessora Técnica na Vigilância Sanitária da SMS e da Prefeitura de Vitória-ES.

⁵ Graduada em Direito pela Universidade Cuiabá-MT. Coordenadora jurídica na SMS de Várzea Grande-MT.

⁶ Graduado em Farmácia pela Universidade Paulista e pós-graduado em Gestão da Assistência Farmacêutica pela UFSC. Secretário Municipal de Saúde de Catanduva-SP.

⁷ Graduado em Odontologia pela UNAERP e pós-graduado em Saúde Coletiva pela UnB. Secretário Executivo da SMS de Araguaína-TO.

tamento desse fenômeno. O fato deste município estar localizado na Região Sudeste e possuir um padrão diversificado no que diz respeito à economia, renda, clima, cultura etc., também despertou curiosidade sobre a hipótese de existir relação entre a judicialização e os determinantes sociais existentes no território.

Outro fato que motivou a escolha do município foi a existência de registro dos processos judiciais armazenados em Catanduva, dos quais foram extraídas as informações: natureza das demandas pleiteadas, casos resolvidos a favor do requerente e situações que por alguma razão não puderam ser solucionados.

Além disso, o município é receptivo quanto ao recebimento de auxílio e tem buscado, ainda que de forma incipiente, desenvolver estratégias administrativas voltadas para a desjudicialização.

O fenômeno da judicialização não é uniforme no território brasileiro, visto que o país possui uma grande diversidade sociocultural devido às suas dimensões continentais. Apesar da Lei Orgânica da Saúde – Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 –, que disciplina a organização e funcionamento do SUS, ter alcance nacional, cada município possui suas especificidades no que tange às necessidades locais, pretensões dos munícipes e formas de enfrentamento das demandas judiciais de origem sanitária, o que influencia na percepção do julgador.

Fez-se necessário o conhecimento da realidade local para tratamento adequado dos problemas, contudo, foi recomendado que se desenvolvessem estratégias padronizadas capazes de auxiliar os gestores quanto à administração eficiente da saúde, independente do lugar em que eles estejam.

Sem perder de vista o caráter universal de acesso ao SUS, com o enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde, será possível alcançar a redução de potenciais impactos no planejamento municipal, na execução de políticas públicas e nas finanças públicas.

Para a proposta metodológica, definiu-se por uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida na forma de intervenção. O estudo se propôs, com base no referencial teórico e na compreensão do contexto socioeconômico-geográ-

fico-demográfico-jurídico do território, a analisar as decisões judiciais proferidas nos anos de 2017 e 2018, que trataram de matéria relacionada à saúde, tendo o município de Catanduva ocupado o polo passivo do processo.

A proposta de intervenção foi alicerçada nos possíveis impactos que as demandas judiciais relacionadas ao fornecimento de tratamentos médicos, realização de exames, internações e fornecimento de medicamentos podem estar ocasionando na gestão do município e na vida da coletividade, na perspectiva quanti-qualitativa, assumindo o desafio de, com base em uma análise sociológica sobre as condições de vida das pessoas e sobre as estruturas políticas e institucionais dos setores público e privado do município, propor alternativas concernentes ao enfrentamento da judicialização no âmbito do SUS.

Sabe-se que a pesquisa-intervenção possui relações aproximadas com os campos de estudo das ciências humanas, tendo em vista que as investigações sobre o contexto das estruturas sociais e sobre a vida das pessoas podem produzir conhecimentos necessários às transformações da sociedade, ou seja, o exercício de pesquisar não representa somente coletar e analisar dados para descrever determinada realidade, mas também tem a finalidade de, a partir das descobertas, impulsionar modificações no objeto estudado (1).

Para que a pesquisa-intervenção tivesse condições de realizar uma transformação em determinada realidade, fez-se necessário romper as estruturas disciplinares do objeto analisado com o intuito de compreender as interfaces da institucionalidade política, sociológica, filosófica e antropológica, isto porque a mudança desejada vai acontecendo conforme a identificação dos problemas, e aquela poderá tanto melhor (e mais adequada) quanto mais conhecimento se tiver sobre os diversos movimentos que ocorrem dentro e fora do objeto estudado (2).

Assim, unida a essas características, a pesquisa-intervenção foi desenvolvida a partir da leitura analítica da realidade do município estudado associada ao cenário local da judicialização do direito à saúde, sendo esta última compreendida como um fenômeno institucional e social de elevada complexidade (3) e que merece ser mais bem compreendida.

O estudo foi desenvolvido durante o lapso temporal de junho de 2019 a fevereiro de 2020, a etapa da coleta de dados foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2019.

Os dados concernentes à judicialização do direito à saúde no município foram extraídos a partir da base documental disponibilizada pela Secretaria de Negócios Jurídicos e pela Secretaria de Saúde, vinculadas à prefeitura de Catanduva. A busca se deu com base em pesquisas em arquivos físicos dos órgãos. As informações coletadas foram organizadas em planilhas eletrônicas do aplicativo *Excel*, visando posterior análise.

Os Processos selecionados foram dos anos de 2017 e 2018 e se deu nesse contexto pelo interesse da pesquisa em dados mais recentes possíveis e que refletissem um panorama mais atual do fenômeno da judicialização da saúde, considerando a proposta de intervenção no cenário pesquisado.

Foram selecionados para análise somente os processos ativos, ou seja, aqueles que tramitaram desde a sua autuação no Poder Judiciário até a concessão de liminar (no mínimo) no período referente aos anos de 2017 e de 2018.

Dessa amostra, foram excluídos 28 processos judiciais por tratarem de arquivos que foram classificados como segredo de justiça e, portanto, suas informações são restritas aos advogados das partes, ao Ministério Público e ao juiz da causa.

Desta feita, os dados foram coletados e analisados a partir do universo de 90 processos, os quais estavam aptos para pesquisa nos arquivos físicos e nos arquivos eletrônicos. Todos foram julgados pelo Poder Judiciário de São Paulo. No período analisado não foram encontrados processos judiciais sobre saúde oriundos da Justiça Federal.

Os processos foram divididos entre as Varas Cíveis e o Juizado Especial Cível, todos sediados no território municipal. Não existe uma Vara Especializada para os processos relacionados à saúde, fato que explica a distribuição entre todas as varas competentes para julgar matérias relacionadas à garantia do direito à saúde.

De forma complementar, também foi realizada consulta no Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),

o qual disponibiliza, para os advogados previamente credenciados, informações detalhadas sobre os processos públicos.

A pesquisa permitiu a coleta dos seguintes dados: o tipo de ação, parte requerente, parte requerida, representação do autor, principais pedidos, fase processual, decisões judiciais e sentença.

Na fase posterior à coleta, foi realizada a análise e a interpretação dos dados, bem como a sistematização em gráficos, propiciando uma fotografia real e contemporânea do fenômeno da judicialização do direito da saúde no município de Catanduva.

Diagnóstico da judicialização no município

A judicialização da saúde vem sendo objeto de discussão entre os profissionais da área da saúde, juristas e gestores públicos, tendo em vista o aumento de demandas que chegam diariamente ao Poder Judiciário relacionadas ao fornecimento de medicamentos, de tratamentos médicos e realização de exames pelo estado. Diante das reiteradas ações judiciais com objetos similares, essa questão é vista com grande preocupação por toda a Administração Pública, principalmente sob a ótica dos impactos financeiro e orçamentário.

De acordo com os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, só no ano de 2018 foram aplicados R\$ 3.950.985,38 (três milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para adquirir itens da assistência farmacêutica, os quais foram transformados em 324.245 atendimentos à população durante o ano. No mesmo período, o município desembolsou o montante de R\$ 4.084.736,41 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) para atender somente demandas judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos, as quais foram revertidas em apenas 2.305 atendimentos (4).

De forma comparativa, cada atendimento padronizado na assistência farmacêutica (pela via administrativa) teve um custo médio de R\$ 12,19 (doze reais e dezenove cen-

tavos) por habitante/ano, enquanto os atendimentos relacionados às demandas judiciais tiveram um custo médio de R\$ 1.766,85 (um mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) por habitante/ano. Ou seja, cada atendimento de demanda judicial realizado poderia ser revertido em cerca de 145 atendimentos padronizados em assistência farmacêutica, demonstrando mais uma vez as iniquidades geradas pela judicialização do direito à saúde.

Sabe-se que o direito universal à saúde descrito na Constituição Federal é objeto de grandes controvérsias no que tange ao seu modo de interpretação e alcance, contudo, pesquisas recentes têm indicado que parte significativa dos operadores do direito têm concedido a tutela de pedidos, em ações judiciais sobre o direito à saúde, com base em uma interpretação literal e generalista das leis, desconsiderando os pormenores do caso concreto e os impactos sociais e multidisciplinares a eles relacionados (3).

É preciso ressaltar que, embora o direito à saúde seja dever do Estado, os recursos financeiros a ele destinados não são inesgotáveis, o que representa a grande dificuldade enfrentada pelos gestores públicos, os quais, ao receberem a decisão judicial, precisam fazer a difícil escolha de realocar os poucos recursos públicos do erário, muitas vezes em prol de uma pessoa apenas, ou seja, aquela beneficiada com a aludida decisão, prejudicando o fornecimento dos bens e serviços aos demais cidadãos (5).

É notório que, mesmo em um contexto hipotético de total ausência de judicialização da saúde, os municípios possuem limitações de ordem orçamentária e o dinheiro disponível para investimento em políticas públicas sanitárias não é ilimitado, fato que os obriga, em respeito aos princípios constitucionais da Administração Pública, a priorizar ações que possam beneficiar o maior número de pessoas.

Corroborando com os achados de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (3), e considerando a análise dos dados da amostra selecionada, foi possível identificar que, em Catanduva, as demandas judiciais estão relacionadas ao fornecimento de tratamentos médicos, realização de exames e internações, no entanto, as que mais prevalecem são aquelas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e demais insumos para saúde.

Percebeu-se ainda, com base nos dados analisados, que parte importante dos medicamentos e insumos pleiteados e fornecidos judicialmente não estão previstos nas listas oficiais do SUS, impactando sobremaneira o planejamento das ações e serviços de saúde.

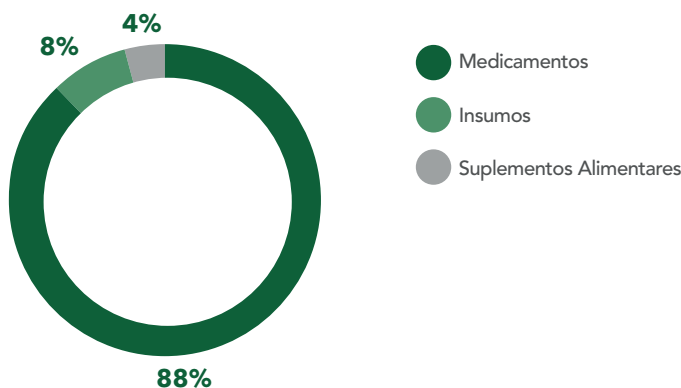
Ao ponderarem os impactos das decisões judiciais sobre o sistema público de saúde, os autores Clenio Jair Schulze e João Pedro Gebran Neto, no livro “Direito à Saúde”, apresentam diversos aspectos negativos tais como a desorganização do SUS, a influência negativa sobre as finanças públicas, as indevidas escolhas judiciais de políticas públicas e a fragilização da isonomia, bem como apontam a iniquidade gerada pela ação do Estado uma vez que uma reduzida quantidade de pacientes se beneficia, por meio da via judicial, com os escassos recursos públicos em detrimento da coletividade que também tem direito à saúde (5).

Noutro azo, existem juízes e doutrinadores que entendem que as decisões judiciais sobre o direito à saúde, apesar de não considerarem a integralidade dos critérios técnicos e/ou administrativos propostos pelos gestores públicos da saúde, acabam fazendo que o julgador contribua com a fixação de políticas públicas, socorrendo o que vê e prejudicando aquilo que não vê, ante o desconhecimento do quadro geral (6).

Foram analisados os processos ativos, ou seja, aqueles que estavam em trâmite em 2017 e foram finalizados em 2018, totalizando 71 (setenta e um) processos e ainda todos aqueles ajuizados em 2018, totalizando 47 (quarenta e sete) processos, o que proporcionou um volume de 118 (cento e dezoito) processos judiciais. Desse total, foram excluídos 28 (vinte e oito) processos, por se tratar de fólios que tramitaram em segredo de justiça e, por consequência, possuem restrição de acesso físico e eletrônico. Restaram, portanto, 90 (noventa) processos.

Da amostra selecionada, foram coletados e organizados os dados concernentes ao conteúdo dos pedidos apresentados à Justiça, conforme Figura 1.

FIGURA 1. Processos judiciais por assunto no município de Catanduva no ano de 2018.



Fonte: Arquivos físicos da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos do município de Catanduva-SP.

Após análise dos dados coletados, encontrou-se que 87,78% dos processos diziam respeito ao fornecimento de medicamentos, 7,78% correspondiam a insumos e materiais médicos e 4,44% tinham relação com dietas e suplementos alimentares.

Destaca-se o significativo percentual de processos judiciais que pediam medicamentos, em detrimento dos demais objetos. A quase totalidade daqueles tem relação com tratamentos de câncer. Do total de processos judiciais que pediam medicamentos, encontrou-se ainda que 31,39% das prescrições médicas que subsidiaram os pedidos aos Juízes correspondiam aos medicamentos enoxaparina sódica 40 mg e diversos tipos de insulina, o que se infere que pode estar acontecendo problemas na distribuição destes itens e/ou com divergências no tipo dos itens adquiridos pelo município e/ou no desalinhamento entre as prescrições médicas e os itens ofertados pelo município.

Foi possível observar também, ao se analisarem somente os processos sobre medicamentos, que apenas 8,88% destes últimos correspondiam a itens padronizados na relação de medicamentos padronizados pelo município para distribuição no SUS, evidência que enseja a reflexão de que o fenômeno da judicialização da saúde no município de Catanduva, no que diz respeito ao objeto medicamento, tem uma relação direta com itens estranhos ao planejamento da secretaria municipal da saúde e que podem estar sendo solicitados por profissionais médicos que desconhecem os itens

padronizados pelo município e/ou que pode ser que esta não esteja adequada ao contexto epidemiológico das doenças mais prevalentes no município.

Diga-se que os achados da Figura 1 guardam certa harmonia com os resultados de uma pesquisa sobre judicialização da saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (3), no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, por meio da qual se compilaram os dados dos processos que tramitaram entre 2008 e 2018, e se encontrou que 71,38% das decisões dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 4ª e 5ª regiões continham pedidos de medicamentos. Este representa o maior percentual de pedidos à Justiça brasileira, se comparado a outros objetos relacionados à saúde.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não tem sede própria na cidade de Catanduva-SP. Desse modo o atendimento à população economicamente hipossuficiente acontece na 41ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município Catanduva-SP, que atende à população por meio de convênio.

O atendimento da assistência judiciária ocorre de segunda-feira a quinta-feira às 8h, devendo o interessado/autor apresentar RG, CPF, Comprovante de Renda e Comprovante de Residência visando ingressar com ações judiciais.

Da análise realizada, encontrou-se que 15,55% das demandas judiciais impetradas em desfavor do município de Catanduva foram provenientes de pacientes representados por advogados constituídos por meio de do Convênio celebrado pela Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (Convênio n.º 003/2016), tendo em que vista necessitarem de assistência judiciária gratuita para garantir o acesso à saúde.

Noutro azo, encontrou-se que 84,45% das demandas judiciais analisadas foram oriundas de pacientes patrocinados por advogados privados/particulares que atuam no município. Isto posto, infere-se que o acesso ao Judiciário é mais fácil para a população com maior conhecimento e poder aquisitivo.

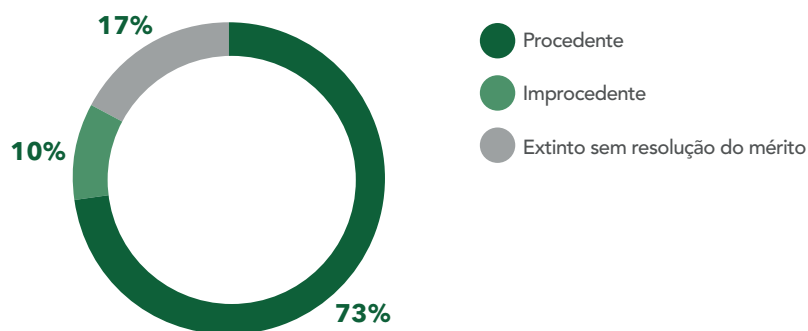
Este cenário pode ser reflexo do desenvolvimento cultural e educacional da população, assim como pode estar relacionado com os avanços industriais e comerciais da cidade (oferta de trabalho, distribuição de renda etc.), como bem demonstrado nos capítulos

iniciais deste estudo, fatos que elevam o nível intelectual das pessoas em direção ao conhecimento sobre seus direitos e ainda podem aumentar as chances de ter acesso mais rápido à justiça e também de ter a sua demanda atendida, considerando que a maioria dos pacientes da amostra se fizeram representar por advogados particulares e estes dedicam uma carga horária mais qualificada para seus processos.

Em geral, é importante salientar que os dados extraídos dos processos físicos também foram consultados no portal e-SAJ (Sistema de Automação da Justiça), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o intuito de permitir o acesso a dados mais atualizados dos processos. Existem restrições apenas para a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça. Esses casos não foram analisados devido às restrições do portal (7).

Da amostra analisada, encontrou-se que 73% dos processos correspondiam a liminares e sentenças procedentes e 10% que correspondiam a sentenças improcedentes, além de 17% que se referiam a processos extintos, sem resolução de mérito, conforme representado pela Figura 2 a seguir.

TABELA 2. Processos judiciais segundo desfecho da sentença judicial no município de Catanduva no ano de 2018.



Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090>>.

Foi possível observar que a maioria das ações julgadas improcedentes se deram em razão da falta da apresentação de documentos pelo autor, que comprovasse a necessidade do medicamento ou insumo de saúde pleiteado. Já os processos extintos sem resolução do mérito, a maioria ocorreu em virtude do falecimento do paciente (7).

A elevada quantidade de processos com julgamento procedente parece ser reflexo da interpretação positivista dos operadores do direito quanto à garantia do direito à saúde. Apesar das insatisfações dos gestores da saúde, o dado encontrado infere a proteção que este fundamental possui no âmbito do Judiciário brasileiro, fato que deve motivar os gestores de políticas públicas a buscarem alternativas à judicialização pela via da mediação ou mesmo da identificação permanente das razões que motivaram o paciente a buscarem a tutela do Judiciário com o intuito de criar meios que previnam que outros pacientes, em casos semelhantes e futuros, façam o mesmo.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Resolução de n.º 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou a criação do Comitê Estadual de Saúde e outorgou ao Comitê a incumbência de criar Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) para as demandas de saúde (8).

O NatJus visa subsidiar o julgador com informações técnicas da área de saúde que lhe permitirá decidir processos judiciais de forma mais segura com base em evidências científicas. Com essa ferramenta, pretende-se evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema, bem como se almeja compilar em um único banco de dados diversos Pareceres e Notas Técnicas sobre assuntos de saúde que sejam relevantes para o julgamento de um processo judicial (8).

No ano de 2018 foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça o Provimento de n.º 84 que regulamentou o uso e o funcionamento do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas.

É importante registrar que o município de Catanduva ainda não foi contemplado com a implantação do Núcleo de Assistência Técnica e que até a corrente data a Secretaria Municipal de Saúde não recebeu comunicação acerca da previsão de data para implantação do NatJus na Comarca.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em setembro do ano de 2018 foi estabelecido um projeto-piloto que atende da 41^a a 45^a varas cíveis do Fórum João Mendes Júnior e o Foro Regional de Santo Amaro, tendo uma expectativa de que o serviço contempla, de forma gradativa, todo o estado de São Paulo e, com isso, seja abarcado o município de Catanduva (9).

A Lei n.º 13.140/2015 disciplina a mediação como forma de resolução de conflitos, dispondo sobre a autocomposição inclusive no âmbito da Administração Pública.

De acordo com o que preconiza o artigo 2º da citada Lei, a mediação segue os princípios da imparcialidade do mediador, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé, o que a torna um ambiente seguro e eficaz para resolução de conflitos (10).

Além da mediação extrajudicial, o artigo 3º, § 3º do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), que se aplica de forma subsidiária e supletiva aos processos administrativos, deixa claro que a mediação deve ser incentivada nos processos judiciais (11).

Por meio da mediação que não será imposta às partes envolvidas em um conflito buscam o auxílio de um terceiro imparcial que os conduzirá na busca da melhor solução para o caso. Com a mediação, os envolvidos conversam, se escutam, ponderam as circunstâncias e constroem a resolução do problema. Com isso, diminuem-se os desgastes gerados por uma judicialização e as partes assumem a responsabilidade de cumprir o acordado, já que a solução do caso não será imposta por um terceiro, mas sim criada pelos próprios envolvidos, com auxílio de um mediador (12).

Alguns municípios e estados já se valem da mediação para resolverem os conflitos sanitários e tem obtido resultados positivos quanto às soluções administrativas encontradas e acerca da democratização das informações e da gestão. Os entes federados que

utilizam a mediação asseguram que ela é fundamental para que as estratégias extrajudiciais tenham efetividade (13).

Há relatos de que a mediação extrajudicial implantada para resolução de demandas de saúde ensejou mais do que a diminuição de judicialização, pois gerou no usuário do serviço um sentimento de valor, visto que ele se sente respeitado e considerado (13).

Por fim, cumpre o registro de que atualmente o município de Catanduva não conta com Comitê de Mediação Sanitária. Consta na Programação Anual de Saúde 2018 de Catanduva, a pretensão de criação de uma comissão intersetorial. A referida proposta está sendo estudada e dialogada de maneira informal com os potenciais integrantes dela, objetivando encontrar a melhor maneira para concretizar sua efetivação (14).

Pelo que foi apurado, percebe-se que o município de Catanduva está buscando estratégias que o auxiliem na diminuição das causas que originam a judicialização da saúde, como consta expressamente da sua Programação Anual de Saúde (14).

Além disso, constatou-se que o município atualmente não possui ferramenta eficaz para atingir a meta de enfrentamento da judicialização da saúde. Ferramentas como a implantação do NatJus, a instituição de comitê de mediação sanitária, realização de fóruns, melhor utilização da Ouvidoria e criação de controle interno de monitoramento das demandas judiciais por meio de sistema ou arquivo próprio podem auxiliar na realização da meta pretendida pelo município.

Sabe-se que o município de Catanduva não dispõe de planos formais de enfrentamento às demandas que motivam a judicialização da saúde. A diminuição da judicialização de causas concernentes à saúde pública é capaz ensejar o suprimento ou a minimização de diversos transtornos orçamentários e de gestão enfrentados pelo município de Catanduva.

Acerca da análise estratégica, sabe-se que ela consiste em analisar a pertinência da intervenção, ou seja, em avaliar a adequação estratégica existente entre a intervenção e a situação problemática que a originou (15).

No caso em exame, restou claro que o município de Catanduva sofre muitos impactos com a demanda de judicialização da saúde pública, o que por vezes tem ensejado a

prevalência do direito individual sobre o coletivo, pois o orçamento e serviço são diretamente afetados pela judicialização. Além disso, com o estudo feito por meio deste trabalho é possível concluir que o município não possui fonte aberta de diálogo com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público e não conta com meios práticos de enfrentamento do problema da judicialização.

É preciso considerar que o Direito Sanitário não é um conteúdo que compõe a grade de disciplinas do curso de Direito e tal matéria é pouco exigida na maioria dos concursos públicos destinados a provimento de cargos jurídicos e, diante da especificidade da matéria de saúde, o diálogo se faz necessário para que decisões coerentes sejam proferidas, bem como para que haja uniformidade de entendimento e segurança jurídica para todos os envolvidos (14).

Além disso, constatou-se na pesquisa realizada por este trabalho que Catanduva não possui vara especializada para julgamento de demandas sanitárias ou de fazenda pública. Sobre o assunto, o CNJ reconhece a importância da existência de varas especializadas em saúde coletiva, justamente para se evitar decisões contraditórias e interpretações genéricas. Nesse sentido, foi emitida a Recomendação de número 43, de 20 de agosto de 2013 pelo CNJ, onde os Tribunais foram orientados a promover a especialização de varas de processamento e julgamento de ações que tenham por objeto o direito à saúde pública (8).

A maioria dos operadores do direito desconhecem os instrumentos de regulação sanitários e a realidade enfrentada pelos gestores públicos no tocante à judicialização das demandas de saúde pública. É necessária a elaboração de estratégias de planejamento e ação a fim de que seja conquistado o diálogo pretendido e necessário.

Considerando o desconhecimento do sistema e a fragilidade do ensino acerca de direito sanitário, um caminho alternativo para propagar conhecimento, criar consciência sanitária e provocar o diálogo, é a proposta de realização de eventos em formato de fóruns ou palestras em que haja participação de todos os atores sociais, como o Ministério Público, Poder Judiciário (Magistrados e seus assessores), Defensoria Pública, Advocacia Privada, cidadãos em geral e estudantes de direito. Para ser efetivo, o diálogo deve ser permanente.

A implantação de uma comissão de mediação também é uma alternativa valorosa, considerando que os envolvidos conversam, se escutam, ponderam as circunstâncias e constroem juntos a resolução do problema. Com isso, diminuem-se os desgastes gerados por uma judicialização e as partes assumem a responsabilidade de cumprir o acordado, já que a solução do caso não será imposta por um terceiro, mas sim ajustada pelos envolvidos, com auxílio de um mediador (12).

Enquanto a comissão de mediação não for formalmente implantada, os usuários do serviço de saúde podem ser orientados a registrarem suas queixas e pedidos referentes a serviços e produtos de saúde por meio da Ouvidoria do município e, com isso, será possível buscar uma solução para o caso antes de sua judicialização, com o acolhimento e prestação de informação ao munícipe.

Uma outra opção é utilizar o site eletrônico da Prefeitura para comunicar aos munícipes os medicamentos disponíveis e ter um campo para reclamações sobre falta de determinado medicamento e, ao receber a aludida reclamação, o município se mobiliza para entrar em contato com o munícipe oferecendo uma solução que lhe atenda sem a necessidade de ajuizamento de ação judicial, o que minimizará ao mesmos os gastos de condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios numa eventual ação judicial, além de demonstrar boa-fé em resolver a questão. Mesmo não sendo possível resolver, o município poderá se valer das informações registradas para futuras deliberações de políticas públicas de saúde.

Além do exposto, mostra-se viável a adoção de medidas que promovam economia e permitam que, com o valor economizado, haja mais investimento financeiro nas ações que são capazes de reduzir as causas de judicialização da saúde. A título de exemplo, vale citar que a implantação de sistema de agendamento online e confirmação prévia de consultas permitiu que o Município de Vitória – ES economizasse mais de R\$16.000.000,00 (Dezesseis milhões de reais) com o reaproveitamento de consultas médicas (16).

Diante dos problemas enfrentados pelo município de Catanduva, conclui-se também pela pertinência da utilização de mecanismos como a implantação do NAT (Núcleo de Assistência Técnica), criação de comitê de mediação sanitária, realização de fóruns,

melhor utilização da Ouvidoria e criação de controle interno para monitoramento das demandas judiciais por meio de sistema ou arquivo próprio.

Com o NAT, os juízes que atuam nas causas em que o município de Catanduva figura como réu terão à sua disposição o conhecimento técnico específico da área da saúde, que inclusive os ajudará a deliberar sobre a viabilidade de deferimento de um medicamento ou outro, já que muitas vezes o requerente pleiteia um medicamento não fornecido pelo SUS, mas que há outro disponível com a mesma funcionalidade e que atenderia suas necessidades.

O NAT, ou outro mecanismo similar, auxiliam na formação do convencimento do magistrado com base em evidências científicas, respeitando-se o disposto no artigo 19-Q, § 2º, I da Lei n.º 8.080/90 (17).

A maior causa de judicialização do município de Catanduva é sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o Estado não tem obrigação de fornecer medicamento que não conste da lista do SUS, portanto, a regra é a de que seja fornecido apenas medicamentos já padronizados ao SUS. Para que o magistrado defira um medicamento não incorporado ao SUS, o que se admitirá apenas a título excepcional, é necessário que o requerente comprove a imprescindibilidade do medicamento, impossibilidade de sua substituição e incapacidade financeira do enfermo e dos membros de sua família. Com o NAT, o município de Catanduva terá mais facilidade demonstrar a prescindibilidade do medicamento não incorporado (18).

Inobstante o narrado, é preciso se atentar ao fato de que, por meio da Resolução n.º 225/16 o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a justiça restaurativa como forma de resolução de conflitos, inclusive na esfera extrajudicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Escola Paulista da Magistratura, oferece cursos de Justiça Restaurativa relacionados à implantação da cultura e círculos de paz. Considerando a frequente judicialização da saúde do município de Catanduva e a necessidade de promoção de um diálogo permanente e efetivo, mostra-se viável a preparação de servidores por meio da realização de cursos de justiça restaurativa e mediação sanitária (13).

De acordo com o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, a saúde é direito de todos e deve ser garantida mediante políticas sociais (19). Como já mencionado, a razão de ser do SUS é a vida humana e a dignidade da pessoa humana é o fundamento do Brasil, conforme declara o artigo 1º da Constituição da República.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades” (20). A utilização da justiça restaurativa e mediação de conflitos extrajudiciais são medidas que vão ao encontro do conceito da OMS, visto que ao valorizar o diálogo concede diminuição da cultura conflituosa adversária e propõe círculos de paz que podem contribuir para saúde mental e social.

Em âmbito processual, a defesa jurídica do município também pode se valer estrategicamente da celebração de negócios jurídicos processuais, na forma prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil, a fim de realizar ajustes e modificações no procedimento processual com a parte requerente, de forma que atenda melhor ao interesse de ambas. A doutrina entende que o poder público pode firmar negócios jurídicos processuais no sentido aqui proposto (21).

Sem prejuízo do que foi explanado até aqui, é válido refletir sobre as produções científicas realizadas até o momento, considerando as discussões feitas por operadores do direito e da saúde em Conselhos e Fóruns, bem como as experiências vivenciadas por outros municípios. (13)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem buscado estabelecer um diálogo entre Juízes e Técnicos em Saúde com o fito de encontrar soluções capazes de ensejar a minimização da quantidade de demandas judiciais envolvendo Saúde Pública.

Nesse diapasão, levando em consideração a pesquisa multicêntrica feita pelo Conselho Nacional de Justiça em 2013, desenvolvida com um enfoque interdisciplinar com base em uma estratégia metodológica que triangulou técnicas quantitativas e qualitativas de produção, coleta e análise de dados, conclui-se pela existência de experiências exitosas no tocante à estratégias de efetivação do direito à saúde (13).

O estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro no Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da Saúde (NAT) com caráter experimental nas Varas da Justiça. Após essa experiência, se proliferaram outros NATs no Brasil, como em Araguaína, Lages e Brasília. Duas dessas cidades (Araguaína e Lages) serviram de exemplos de experiências exitosas no diagnóstico e enfrentamento à judicialização para esse trabalho (22).

Em Araguaína, no estado do Tocantins, o NAT tem tido caráter consultivo e preventivo. É consultivo por ser uma ferramenta de apoio ao judiciário para tomada de decisão quanto ao direito sanitário e políticas públicas em saúde. Já o caráter preventivo revela-se principalmente por meio da resolução administrativa do conflito (23).

Pelo que se depreende da pesquisa de dados de experiências de enfrentamento à Judicialização, feito pelo Conselho Nacional de Justiça (13), é possível ressaltar os seguintes fatores de inovação em Araguaína (23): criação de equipe preparada para emitir pareceres e quaisquer outras opiniões; proatividade da Ouvidoria; integração entre o NAT e a Ouvidoria que favoreceu a resolutividade administrativa e elaboração de diálogo entre as partes envolvidas; constituição dos dados existentes no NAT e da Ouvidoria como ferramentas de gestão que auxilia na tomada de decisões.

Em Lages, além do NAT, consta o registro da experiência de um Consórcio Intermunicipal para minimização de seus problemas, que contou com a participação direta do judiciário. Entre suas finalidades, destaca-se a busca por atender com efetividade e eficácia às solicitações de medicamentos pelos usuários do SUS ainda não judicializadas, que é realizada por meio de uma central de conciliação pré-processual.

Com base nos dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (13), conclui-se que os municípios acima citados alcançaram os seguintes resultados: padronização da atuação; racionalização de gastos e investimentos; diálogo entre o poder judiciário e gestores de saúde; redução dos conflitos colaterais em decorrência da dificuldade de acesso à saúde pública; verificação da real condição do paciente por meio de inspeção presencial; integração do paciente aos programas e medicamentos oferecidos pelo SUS; integração entre os órgãos da saúde com o paciente, Defensoria Pública, advocacia pública e Ministério Público e Poder Judiciário; agilidade nos procedimentos

administrativos e nos processos judiciais; conscientização dos agentes políticos quanto às políticas públicas de saúde e a mudança de mentalidade para o diálogo institucional entre Executivo e Judiciário.

Face o exposto, conclui-se que muitas são as alternativas que podem auxiliar no enfrentamento das causas de judicialização da saúde, a fim de que haja diminuição da judicialização e consequente redução de interferência do Poder Judiciário no planejamento e execução de políticas públicas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Considerações Finais

A excessiva judicialização da saúde é tema de grande relevância, já que tem o condão de interferir no orçamento, o que por vezes enseja alteração de políticas públicas e prejuízo ao interesse coletivo.

A judicialização das demandas prestacionais sanitárias, na maioria dos casos, provoca individualização das ações de saúde e interferência no princípio da equidade.

No caso da judicialização em face do município de Catanduva, foi visto que prevalece o ajuizamento de ações por advogados particulares, o que se deduz que os requerentes são providos de condição financeira que permite a contratação de advogado, bem como aqueles atentos à busca da garantia dos seus direitos. Por outro lado, o mais vulnerável financeiramente acaba sofrendo reflexos dessa judicialização, pois o seu atendimento acaba sendo postergado, quando uma ordem judicial determina o atendimento prioritário ao requerente do processo judicial.

É preocupante o fato de que, apesar da existência de instrumentos normativos que regulamentam matérias de saúde, grande parte das autoridades que possuem poder de decisão e requisição conhecem superficialmente o direito sanitário e acabam profereindo decisões sem considerar o arcabouço normativo existente.

Nesse contexto, faz-se necessário que os membros do Poder Judiciário, cada vez mais incentivados pelo Conselho Nacional de Justiça, busquem não só conhecer a legis-

lação pertinente ao direito sanitário, cuja matéria nem sequer é ministrada no curso de bacharelado de Direito, e tampouco cobrada nos concursos públicos, como também dialoguem com os demais atores sociais, para que encontrem juntos as soluções que atendam a todos.

Os enunciados das Jornadas de Direito à Saúde, as reuniões do Fórum da Saúde, a criação dos NATs e a instituição dos Comitês de Mediação Sanitária, certamente são avanços a serem comemorados, pois promovem o diálogo entre os juristas, os profissionais da saúde e os gestores públicos, evitando-se o prosseguimento e trágico desfecho de ações judiciais que resultam em prejuízo ao erário público, não só por sobrecarregar o Estado, mas também por muitas vezes movimentar a máquina judiciária desnecessariamente.

Medidas como implantação no NAT, criação de comissão de mediação sanitária, melhor utilização da Ouvidoria, ações para redução de gastos financeiros, adoção de negócios jurídicos processuais, preparação de servidores para trabalharem com justiça restaurativa nos conflitos sanitários, ministração de palestras em faculdades e elaboração de fóruns que integrem e promovam o diálogo entre todas as partes envolvidas em um potencial litígio podem gerar bons resultados ao fim almejado pelo Município de Catanduva, que é a diminuição da judicialização da saúde.

Não se pode ignorar as dificuldades encontradas neste diálogo entre as instituições, mas é imprescindível que se mantenham para que a judicialização desmedida da saúde reduza substancialmente, possibilitando que os gastos públicos se destinem a efetivação das políticas públicas em consentâneo aos fundamentos e objetivos previstos na Constituição Federal.

Referências

- 1- Renault L, Ramos J. **Participar da análise, analisar a participação: aspectos metodológicos de uma pesquisa-intervenção participativa em saúde mental [artigo]**. [citado 13 jul. 2020] Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/sausoc/2019.v28n4/61-72/pt>>.
- 2- Mendes R., Pezzato LM, Sacardo DP. **Pesquisa-intervenção em promoção da saúde: desafios metodológicos de pesquisar “com”.** [artigo]. [citado 13 jul. 2020]. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/csc/2016.v21n6/1737-1746/>>.
- 3- Conselho Nacional de Justiça (BR). **Relatório Analítico Propositivo. Justiça Pesquisa. Judicialização da Saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução.** CNJ, 2019. [internet]. [Citado em 13 jul. 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2011/02/95da70941b7cd226f9835d56017d08f4.pdf>>.
- 4- Catanduva (SP). **Secretaria de Administração. Portal da Transparência, Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, Demonstrativo de Aplicação na Saúde.** [Internet]. Catanduva, 2019 [citado 12 set. 2019]. Disponível em: <<http://www3.catanduva.sp.gov.br/transparencia>>.
- 5- Schulze CJ, Gebran Neto JP. **Direito à Saúde. 2 ed. rev. e ampliada.** Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2019.
- 6- Oliveira EP, Douglas W. **Direito à saúde x pandemia.** Rio de Janeiro: Impetus, 2020.
- 7- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados-SEAD (SP), **Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo.** São Paulo: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados; 2018. [Internet] [citado 12 set. 2019]. Disponível em: <<https://perfil.seade.gov.br/>>.
- 8- Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n.º 238, de 06 de setembro de 2016.** Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. [Internet]. Brasília, 06 set 2016. [citado 25 set 2019]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atosnormativos?documento=2339>>.
- 9- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **TJSP na mídia: Justiça firma parcerias para instalação do NatJus.** [Internet]. Site oficial do TJSP. 18 ago. 2018. [citado 25 nov. 2019]. Disponível em: <<https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=52147>>.

10- Brasil. **Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n.º 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997. [Internet]. Brasília, 26 jun. 2015 [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm>.

11- _____. **Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. [Internet]. Brasília, 16 mar 2015. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03.htm>.

12- Scavone Junior LA. **Manual de arbitragem: mediação e conciliação**. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

13- Conselho Nacional de Justiça (BR). **Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência**. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 2015. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2018/01/4292ed5b6a888bdcac178d51740f4066.pdf>>.

14- Catanduva (SP), Secretaria de Saúde. **Programação Anual de Saúde 2019**. Catanduva: Secretaria de Saúde; 2019. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <<https://observa-saudecatanduva.sp.gov.br/planejamento-em-saude/programacao-anual-desaudef>>.

15- Champagne F *et al.* **A avaliação no campo da saúde: conceitos e métodos**. In: Brousselle A *et al.*, organizadores. Avaliação: conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2011. pp. 41-60.

16- Vitória (ES). **PMV economiza mais de R\$ 16 milhões com reaproveitamento de consultas médicas**. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <<https://m.vitoria.es.gov.br/noticia/pmv-economiza-mais-de-r-16-milhoes-comreaproveitamento-de-consultas-medicas-39978>>.

17- Brasil. **Lei n.º 8080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [Internet]. Brasília, 19 set. 1990 [citado 07 out. 2019]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>.

18- Brasil. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Especial n.º 566471**. Recorrente: Estado do Rio Grande do Norte. Recorrido: Carmelita Anunciada de Sousa. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, 11 mar 2020. Informativo 969, RG, Tema 6. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078>>.

19- Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. [Internet]. Brasília, 05 out 1988 [citado 07 out. 2019]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>.

20- Organização Mundial da Saúde (OMS). **Cuidados inovadores para condições crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial**. Brasília, 2003. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42500/2/WHO_NMC_CCH_02.01_por.pdf>.

21- Cunha, LC de. **Lei 13.105/15 e A fazenda pública em juízo**. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

22- Araguaína (TO), **Núcleo de Apoio Técnico – NAT**. [cartilha]. Araguaína/TO, maio de 2015. [Internet]. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://wwa.tjto.jus.br/saude/images/material/CARTILHA-NAT.pdf>

23- _____. **Portaria n.º 52, de 23 de julho de 2013**. Regulamenta o funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico – NAT na Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína-TO e dá outras providências. [Internet]. Araguaína, 23 jul. 2013. Diário Oficial do Município de Araguaína, Estado do Tocantins. Ano II, Ed. n.º 398. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <<http://wwa.tjto.jus.br/saude/images/material/PORTARIA-N-52-.pdf>>.



Desafios para o enfrentamento da judicialização de terapias nutricionais no município de Divinópolis-MG

Deborah Costa Silva¹

Heleneide Henrique Soares²

Josivan Carneiro Garcês³

Lilian Soares Gozi Scarpelli Ferro⁴

Selene Umeda Teruya⁵

Valéria Alexandrina Silva Batista⁶

Orientadora: Profa. Cássia de Fátima Rangel Fernandes

O presente trabalho visou a construção de um projeto de intervenção com proposta de implementar mudanças no cenário da judicialização da saúde no âmbito do SUS, no município de Divinópolis, Minas Gerais. Foi abordada a composição do judiciário na comarca, tanto da jurisdição estadual como federal, onde os processos acerca do tema são julgados.

¹ Graduada em Direito pela PUC de Goiás. Assessora jurídica no gabinete da SMS de Goiânia-GO.

² Graduada em Direito e Administração de Empresas, ambos pelo CESMAC de Maceió-AL, pós-graduada em Saúde Pública pela UNAERP/SP. Secretária Municipal de Saúde de Pindoba-AL.

³ Graduado em Enfermagem pela UniCeuma/MA, pós-graduado em Auditoria, Gestão e Planejamento pela Universidade Estácio de Sá. Assessor Técnico da SMS de Cantanhede-MA.

⁴ Graduada em Direito pela UEL. Assessora Jurídica da SMS de Londrina-PR.

⁵ Graduado em Direito e em Medicina Veterinária, pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Direito Penal e Ciências Penais pela Universidade Paris II – Panthéon-Assas. Assessora jurídica na SMS de Parauapebas-PA.

⁶ Graduada em Direito pela Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis. Secretária Executiva do Gabinete da SMS de Divinópolis-MG.

Ainda, foi traçado o panorama geral da judicialização no município e definido como recorte temporal, para análise das ações judiciais que seriam tratadas no projeto, os processos de 2018 que iniciaram a tramitação naquele ano (citação/intimação), ainda que propostas em 2017.

O objeto das ações judiciais definidas para pesquisa foi referente ao fornecimento de dietas/suplementos nutricionais e leite, haja vista a relevância econômica dos gastos e do número de ações recebidas. Durante o levantamento dos processos foi constatada a existência de processos com pedido cumulado com o fornecimento de fraldas, o que desencadeou, para checagem da magnitude da demanda, a triagem também dos processos cujo pedido era exclusivo de fralda.

A busca pelos processos judiciais e outros documentos foi realizada diretamente na Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) a partir da planilha de controle do setor de farmácia complementar. Com a obtenção dos nomes dos pacientes, por intermédio da referida planilha, foi consultado o Sistema de Informação da Saúde (SIS) – próprio da SEMUSA – que indicou o local onde os documentos relacionados aos processos estavam arquivados ou eram mantidos fisicamente, como cópia das liminares, mandados com petição inicial, sentenças, relatórios médicos, prescrições etc., cujas petições iniciais foram analisadas uma a uma, a fim de formar o acervo e base da pesquisa. Informações financeiras foram obtidas pelo setor de contabilidade da secretaria.

Foi investigada ainda, a existência prévia de liminares nessas ações, e se houve ou não a incidência de multa por eventual descumprimento de ordem judicial nos respectivos casos, bem como analisadas as variáveis de sexo, idade, condição de saúde dos autores, a representatividade processual (se advogado particular, defensor público ou Ministério Público), e as respectivas decisões, com análise de percentual de procedência dos pedidos.

Em seguida, foi analisada a existência de canais estratégicos no município, com o intuito de tratar previamente o objeto das demandas, que culminaram na proposta final do trabalho, a partir da implantação de soluções qualificadas para acolhimento e mediação dos pleitos, bem como pela criação de protocolos internos criteriosos e específicos para fornecimento do bem pretendido, com melhor gestão e programação

financeira, que possibilitarão, em tese, a contenção da judicialização, mas sem olvidar o atendimento à saúde do indivíduo, o que tais ações visam tutelar/proteger.

Diagnóstico da judicialização no município

Após a constitucionalização do direito à saúde no Brasil, o que se deu com a promulgação da Constituição da República em 1988 (1), e com as dificuldades e desafios da implantação do audacioso SUS no país, a efetivação daquele direito começou a ser submetida reiteradamente, ao Poder Judiciário, fenômeno conhecido como ‘judicialização da saúde’, com início entre o fim do Século XX e início do Século XXI (2). De acordo com a pesquisa realizada juntamente aos servidores da SEMUSA do município de Divinópolis, a lembrança mais longa deste fato é datada de 2005.

Cumprir ressaltar que, à época, as demandas judiciais apareceram de forma tímida (Tabela 1), cujo cumprimento e providências ficavam a cargo do gabinete da SEMUSA, dada sua excepcionalidade, sem um setor administrativo específico responsável.

TABELA 1. Gastos e objetos das demandas judiciais na área da saúde, em Divinópolis/MG, no ano de 2005.

OBJETO DA DEMANDA	GASTOS (R\$)
Internação / cirurgia	R\$ 8.950,00
Medicamentos	R\$ 273.757,10
Gasto total	R\$282.707,10

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis-MG (mimeo).

Em 2013, com o volume muito maior de processos (Tabela 2), decuplicando-se os gastos inicialmente indicados, especialmente porque a partir de 2012 a SEMUSA começou a realizar atendimentos das ações judiciais referentes aos pedidos de dispensação de suplementos e fraldas, os quais eram fornecidos anteriormente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foi necessária a criação de equipe específica para atendimento da atividade, visando à efetividade que o processo requeria, o que

se deu com a institucionalização da Diretoria Jurídica e Administrativa (3) na secretaria, contando com uma coordenadoria jurídica e dois servidores, com apoio direto da Procuradoria Geral do Município.

TABELA 2. Gastos e objetos das demandas judiciais na área da saúde, no município de Divinópolis-MG, em 2013.

TIPO DE DEMANDA	GASTOS (R\$)
Consultas Médicas	R\$ 73.545,45
Exames	R\$ 16.645,00
Internação/cirurgia	R\$ 438.567,47
Material Médico	R\$ 192.213,62
Medicamentos	R\$ 1.721.788,09
Fraldas e suplementos	R\$ 571.156,22
Pessoal e Encargos	R\$ 11.560,11
Total	R\$ 3.025.475,96

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis/MG (mimeo).

Em 2016, houve a necessidade de uma nova adequação na estrutura administrativa, sendo implementada a Diretoria Financeira, Administrativa e de Interface Jurídica, contando com uma Assessoria Administrativa e de Interface Jurídica (4) e uma Coordenadoria de Interface Jurídica, estrutura ratificada pela Lei Municipal n.º 8.480/2018 (5).

A coordenadoria conta efetivamente com um coordenador, um agente administrativo e cinco estagiários, além de dois procuradores jurídicos, que, embora ligados ao órgão de origem (Procuradoria Geral do Município), permanecem exclusivamente junto à SEMUSA, dado o volume de ações. A equipe detém o controle das ações propostas por intermédio de planilhas, em que são inscritos os processos em que a secretaria é citada, e posteriormente os dados são inseridos no Sistema de Informações em Saúde (SIS), conforme fluxo de trabalho estabelecido internamente.

Esta alteração se fundamenta em vista da análise de dados coletados na Diretoria Financeira da SEMUSA (Tabela 3), em que se constata um crescimento do gasto financeiro aproximadamente 13 vezes maior, se comparados os gastos do ano de 2005 com os de 2019.

TABELA 3. Gastos anuais com o cumprimento de ações judiciais na área da saúde, ajuizadas em Divinópolis-MG, entre 2005 e 2019.

ANO	OUTROS PROCESSOS *	DIETAS/SUPLEMENTOS LEITES E FRALDAS	TOTAL (R\$)
2005	282.707,10		282.707,10
2006	523.994,39		523.994,39
2007	718.362,55		718.362,55
2008	1.597.235,94		1.597.235,94
2009	2.199.232,55		2.199.232,55
2010	1.534.634,81		1.534.634,81
2011	2.764.028,67		2.764.028,67
2012	2.835.341,96	786.301,12	3.621.643,08
2013	2.454.319,74	571.156,22	3.025.475,96
2014	1.703.184,12	1.110.660,79	2.813.844,91
2015	1.596.193,13	1.073.799,94	2.669.993,07
2016	1.395.506,27	1.327.663,29	2.723.169,56
2017	3.035.033,49	1.283.254,23	4.318.287,72
2018	2.963.683,34	1.507.477,83	4.471.161,26
2019	1.386.833,58	2.210.221,43	3.597.055,01

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis/MG (mimeo).

* Nota: Consultas Médicas, Exames, Material Médico, Medicamentos.

Merece menção o fato de que, no orçamento municipal (6), se destinam R\$ 4.221.000,00 (quatro milhões duzentos e vinte e um mil reais) para aquisição de material de distribuição gratuita na manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica. Entretanto, a dotação orçamentária, dentro deste mesmo programa, provisionada para atendimento a sentenças judiciais, é de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ou seja, quase metade do que é destinado à atenção a todos os usuários do SUS, que envolve basicamente medicamentos.

Corroborando o destaque, ao se analisarem os valores gastos no ano de 2018 com este produto (Tabela 5), verifica-se que o município despendeu cerca de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que equivale em média a R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) *per capita*, considerando o universo de 527 (quinhentos e vinte e sete) autores de ações judiciais de medicamentos sendo atendidos. Por outro lado, o financiamento referido, para compor a assistência farmacêutica básica, é de R\$ 10,00 (dez reais) *per capita*, aproximadamente (7).

TABELA 5. Valores gastos e objeto das demandas judiciais na área da saúde, em Divinópolis-MG, em 2018.

OBJETO DA DEMANDA	GASTOS (R\$)
Consultas Médicas, Exames, Internação e Cirurgia	R\$ 503.145,60
Material Médico	R\$ 1.553.102,58
Medicamentos	R\$ 907.435,25
Fraldas e Suplementos	R\$ 1.507.477,83
Total (R\$)	R\$ 4.471.161,26

Elaborado pelos autores com base em dados coletadas no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis/MG (mimeo).

Em relação à quantidade de pessoas atendidas por ordem judicial, os números consolidados em 2018, foram de 527 pessoas para medicamentos, e 579 para suplementos e fraldas, informação obtida por intermédio de consulta aos arquivos do Sistema de Informação de Saúde e análise de demais planilhas existentes no setor de Farmácia

Complementar (subordinado a Gerência Farmacêutica da Diretoria de Atenção à Saúde), e que ainda está em construção para os demais insumos.

Outra equiparação conveniente se dá entre o *per capita* do orçamento da saúde com a população total do município (8), gerando um valor aproximado de R\$ 1.011,00 (um mil e onze reais) por habitante. Todavia, se considerarem os gastos com as demandas judiciais de dietas/suplementos/leites e fraldas conforme Tabela 5, o valor *per capita* é de aproximadamente R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Vale ressaltar que as apurações dos gastos com judicialização no município não discriminam dados apenas por fraldas, ou apenas por dietas/suplementos/leites, por isso são apresentados em conjunto (o que ocorre também com consultas médicas, exames, internação e cirurgia).

Visando o enfoque para além do financeiro, pode-se verificar, conforme dados apresentados na Tabela 6, o aumento vertiginoso da judicialização referente às demandas de dietas/suplementos/leites e fraldas, no período de 2012 a 2019, que, em 2019, correspondeu a 73,9 % do total dos processos de judicialização da saúde com demandas em atendimento no município de Divinópolis. O número de pacientes atendidos para dispensação de dietas/suplementos/leites e fraldas, consequentemente, acompanhou o crescimento da judicialização destes itens, chegando a 81,7% do total de pacientes atendidos perante as demandas judicializadas no município.

TABELA 6. Percentual de processos judiciais e de pacientes, referente ao cumprimento de decisões judiciais para dispensação de dietas/suplementos/leites e fraldas, em relação ao total de processos judiciais e de pacientes atendidos, em Divinópolis-MG, entre 2012 e 2019.

ANO	% DE PROCESSOS JUDICIAIS REFERENTES A PEDIDOS DE DIETAS/SUPLEMENTOS/LEITES E FRALDAS	GASTOS (R\$)
2012	19,8	27,3
2013	35,6	51,3
2014	43,9	57,1

2015	49,2	57,0
2016	56,8	64,9
2017	54,9	59,2
2018	61,4	69,0
2019	73,9	81,7
Total (R\$)	46,4	55,4

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no Sistema de Informações de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG (mimeo).

Assim sendo, como demonstrado nas tabelas, a motivação da escolha da judicialização de dietas/suplementos/leites para o presente projeto de intervenção se deu diante da supremacia dos gastos e número de processos relacionados ao objeto.

Foram levantados 195 processos judiciais com pedidos de dietas/ suplementos/leites e fraldas, por tratar-se da maior demanda judicial suportada pelo município. Com base em tal número foram selecionados 107 processos, que tiveram por objeto o ajuizamento dentro do recorte de fato proposto nesta pesquisa, qual seja, apenas os pedidos das dietas especiais que representam o quantitativo de 48 processos, bem como, aqueles que possuem pedido cumulado de fornecimento de fraldas, representando o montante de 59 processos (Tabela 7).

TABELA 7. Demonstrativo geral do número de ações judiciais, que iniciaram a tramitação (citação/intimação) em 2018.

TIPO DE DEMANDA JUDICIALIZADA	N.º DE AÇÕES JUDICIAIS	%
Dietas/suplementos/leites e fraldas	59	30,3
Dietas/suplementos/leites	48	24,6
Subtotal	107	54,9
Fraldas	88	45,1
Total	195	100

Fonte: Elaborada pelos autores com dados coletados no arquivo da Farmácia Complementar/ SEMUSA Divinópolis-MG (mimeo).

Destas 107 ações judiciais, ao se proceder a análise do conteúdo das petições iniciais, foi possível atestar que quase 70% das demandas são solicitadas por pacientes acima de 60 anos, exprimindo o quantitativo de 72 processos pertencentes a esse grupo de pacientes (Tabela 8).

TABELA 8. Demonstrativo do número de ações judiciais analisadas, por idade, que iniciaram a tramitação (citação/intimação), em 2018.

TOTAL DE PRO- CESSOS ANALISADOS: SUPLEMENTOS C/C FRALDAS	FAIXA ETÁRIA DE 0 A 10 ANOS	FAIXA ETÁRIA DE 11 A 19 ANOS	FAIXA ETÁRIA DE 20 A 59 ANOS	FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS
107	20	2	13	72

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no da Farmácia Complementar/ SEMUSA Divinópolis-MG (mimeo).

Quanto ao gênero, destaca-se que, do total de 107 ações manejadas, 58,87% das ações foram apresentadas pelo gênero feminino e 41,13% foram impetradas por usuários do gênero masculino, representando, respectivamente, o quantitativo de 63 e 44 processos, evidenciando certo equilíbrio, se compararmos ao quesito da faixa etária em que de forma expressiva as demandas apresentadas relacionam-se a pessoas em idade avançada, com mais de 60 anos.

Pautando-se em informações obtidas por consultas aos arquivos do Sistema de Informação de Saúde (SIS) e análise de dados levantados pelo setor de Farmácia Complementar da SEMUSA, permite-se analisar, de forma geral, os principais pedidos apenas sob o ponto de vista dos gastos financeiros com as demandas judiciais anuais, da quantidade de ações e seus objetos.

Sob o prisma dos gastos financeiros, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2018, registros da SEMUSA indicam que os principais dispêndios, com demandas judiciais envolvendo o serviço público de saúde, se concentram nos processos individuais de usuários que reivindicam o fornecimento de material médico, suplementos/fraldas, medicamentos e consultas/exames/internações, conforme demonstra a Tabela 9, a seguir.

TABELA 9. Valores gastos com as principais demandas judiciais na área da saúde pelo município de Divinópolis-MG, entre 2016 e 2018.

	2016	2017	2018
Consultas médicas e Exames	R\$ 48.231,32	R\$ 180.652,99	R\$ 503.145,60
Material médico	R\$ 393.651,14	R\$ 1.690.330,67	R\$ 1.553.102,58
Medicamentos	R\$ 953.623,81	R\$ 1.164.049,83	R\$ 907.435,25
Fraldas e Suplementos	R\$ 1.327.663,29	R\$ 1.283.254,23	R\$ 1.507.477,83

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis-MG (mimeo).

Esses dados revelam que, em 2018, houve um gasto de quase 4,5 milhões de reais com as demandas de saúde, tendo sido o pedido de maior impacto o de fornecimento de material médico (35%), seguido de fraldas/suplementos (34%), medicamentos (20%) e por último consultas e exames (11%), conforme ilustra Tabela 10, a seguir.

TABELA 10. Demonstrativo de gastos da SEMUSA de Divinópolis com demanda judicial, em 2018.

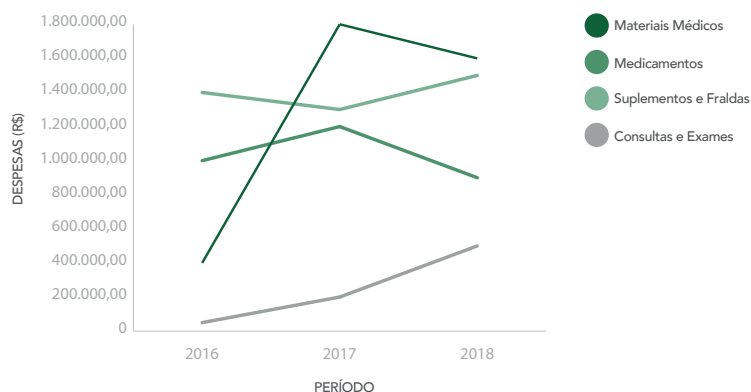
Gasto Total	Gasto com Consultas médicas e Exames	Gasto com Material médico	Gasto com Medicamentos	Gasto com Fraldas e Suplementos
R\$ 4.471.161,17	R\$ 503.145,60	R\$ 1.553.102,58	R\$ 910.435,16	R\$ 1.504.477,83
100%	11%	35%	20%	34%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados na Farmácia Complementar do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis-MG (mimeo).

Em que pese no ano de 2018 a maior despesa do município ter sido em relação aos gastos com fornecimento de materiais médicos, é preciso considerar-se a série histórica do período compreendido no Figura 1, em que se pode observar uma evidente estabilidade nos gastos com fornecimento de suplementos e fraldas, enquanto nos demais denota-se notória oscilação com os gastos entre os anos, com exceção das des-

pesas com consultas e exames que apresentou crescimento em todos os anos, sem, contudo, alcançar altos níveis como o do recorte em questão.

FIGURA 1. Evolução dos gastos com demandas judiciais de fornecimento de medicamentos x de fraldas e suplementos (2016 a 2018).



Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações coletadas no Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis-MG (mimeo).

A Tabela 10 revela ainda que, no ano de 2018, houve uma redução nos gastos do município com demandas envolvendo medicamentos e materiais médicos, se comparado ao ano anterior, em detrimento do aumento dos gastos com suplementos e fraldas. A evolução desses gastos está representada na Tabela 1.

Pois bem, sob o enfoque da análise dos pedidos apresentados nos 107 processos, observou-se o pleito de 21 nomenclaturas diferentes de dietas/suplementos. Quase 100% dos pedidos já indicavam as marcas comerciais que o município teria que fornecer, com exceção de 4 ações, que discriminavam apenas a fórmula nutricional da dieta, sem indicar a marca.

Constatou-se também que dessa lista de 21 dietas/suplementos prescritos, apenas 4 tipos se repetiram reiteradamente em outras demandas judiciais, acima de 10 vezes. Os outros 17 tipos tiveram relativamente pouca reincidência, 8 delas apareceram uma única vez no universo das demandas analisadas, e as demais em um número aproximado de 5 ações.

Salienta-se que a dieta mais prescrita é a de 1,2 Kcal/ml, de marca registrada Isosource Soya, seguida por dietas com composição de 1,5 Kcal/ml. Ambas, somadas, incidiram em mais de 50% das demandas.

Outro dado relevante é em relação ao quadro clínico do paciente, pois, não foram encontrados muitos pedidos em que o fundamento se baseou na desnutrição ou alergia crônica, o que poderia ao menos evidenciar a necessidade inequívoca da utilização da suplementação ou substituição alimentar. Muito pelo contrário, o que se percebeu, na maioria das ações, foi que as motivações se justificam por serem pessoas idosas e/ou acamadas, mas sem a demonstração daquelas patologias, o que faz crescer o desafio do município na qualificação das respostas perante o judiciário e também no aperfeiçoamento da gestão, haja vista a realidade que se apresenta.

Com base na análise dos 107 processos, pode-se atestar que a Defensoria Pública do estado de Minas Gerais foi o principal órgão representativo dos cidadãos nos processos judiciais (Tabela 11).

TABELA 11. Demonstrativo da representação jurídica, referentes aos processos de pedidos de dietas/suplementos/leites que iniciaram a tramitação (citação/intimação) em 2018.

REPRESENTAÇÃO JURÍDICA	N.º DE PROCESSOS
Defensoria Pública Estadual	73
Atermação (Juizado Especial)	15
Ministério Público do Estadual	12
Advogado Particular	7
Total	107

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da análise dos processos.

Assim, mais de 68% dos processos analisados são oriundos da Defensoria Pública Estadual, ente este que possui atribuição constitucional de orientar juridicamente e promover a proteção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos aos necessitados (1).

Sobre isso, cabe registrar que conforme previsão constitucional as defensorias públicas, sejam estaduais, sejam federais, têm como atribuição essencial a devida prestação de assistência jurídica de forma integral e gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência financeira do requerente – art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 (1), com isso, permite-se incluir que mais da metade dos processos analisados são comprovadamente provenientes de usuários que de fato não possuem condições financeiras para arcar tanto com os custos de um processo judicial, como com o tratamento de saúde pleiteado.

Nesse sentido, inclusive, insta consignar que a Lei Complementar Estadual n.º 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, prevê no § 2º do art. 4º que “à defensoria pública é conferido o direito de apurar o estado de carência de seus assistidos” (9). Assim, denota-se que o órgão preocupa-se em seguir os preceitos constitucionais acerca da prestação de assistência jurídica gratuita.

Não é de se olvidar que os usuários que buscam pela assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública de fato sejam hipossuficientes para arcar com os custos de uma terapia nutricional a base de dietas especiais industrializadas, contudo, em consulta ao *site* da Defensoria Pública do estado de Minas Gerais observa-se que o órgão estabeleceu um fluxo de atendimento às tutelas específicas ao SUS (10), de modo que dentre as exigências documentais são indicados os seguintes itens:

- Identificação das doenças com o respectivo código CID-10 (Classificação Internacional de Doenças);
- Identificação do princípio ativo do medicamento (e não apenas de seu nome comercial);
- Posologia completa e detalhada;
- Identificação do nome técnico, das especificações e da quantidade do insumo;
- Se o insumo é fornecido em número inferior ao necessário, com a identificação da quantidade dispensada pelo SUS;

- Especificações técnicas necessárias para identificação do aparelho médico prescrito (ex: funções que a máquina deve possuir para atender ao quadro do paciente);
- Identificação do nome técnico da cirurgia;
- Explicação das medidas preparativas já tomadas para a realização da cirurgia (ex: exame de risco cirúrgico);
- Identificação do grau de prioridade da cirurgia com a explicação dos riscos que corre o paciente na hipótese de atraso;
- Explicação das tentativas de marcação de cirurgia já realizadas;
- Identificação de entidades privadas ou de entidades de outras unidades da federação que realizam o exame prescrito;
- Identificação do nome da especialidade médica para consulta especializada necessária;
- Explicação das tentativas de marcação de consulta já realizadas;
- Identificação e explicação de todas as medidas alternativas que já foram tentadas com os recursos disponíveis no SUS;
- Declaração de que a providência médica prescrita é insubstituível por outra disponível no SUS;
- Objetivo da medida médica prescrita;
- Declaração de que o médico atende pelo SUS e acompanha o paciente pelo SUS;
- Explicação dos riscos que corre o paciente na hipótese de ausência da abordagem médica adequada (ex: risco de morte);
- Outros esclarecimentos técnicos que o médico entender importantes.

De tal exposição, observa-se que apesar de existirem certos requisitos arrolados pela defensoria pública no acionamento do Poder Judiciário, é preciso ressaltar que, nem sempre são apresentadas as documentações elencadas.

Inclusive, nas ocasiões em que foram proferidas sentença favoráveis, o magistrado ressaltou o dever da parte autora em apresentar relatórios médicos atualizados para manutenção do fornecimento e a única ação improcedente foi fundamentada no fato de o requerente não ter comprovado que o tratamento fornecido pelo SUS não produziu resultados favoráveis à situação de saúde do paciente.

Noutro ponto, mas ainda fazendo um paralelo com a questão da hipossuficiência financeira da parte autora, nota-se do registrado na Tabela 11 que o menor índice de representatividade se refere às ações judiciais postuladas por via de advogado particular constituído, que no ano de 2018 representou 6,5% das demandas ajuizadas, assim, resta claro que é mínimo o índice de usuários que possuem melhores condições financeiras.

Ademais, em que pese a representatividade pela Defensoria Pública Estadual importar em uma maioria esmagadora, é relevante registrar que as ações protocolizadas tanto por via do Juizado Especial da Comarca de Divinópolis, como pelo Ministério Público Estadual, também consideram a situação financeira do requerente para acionamento do Judiciário.

No que tange ao Juizado Especial é pertinente trazer à baila que a Lei Federal n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais (11), prevê no art. 54 que o acesso ao juizado especial, em primeira instância, será livre do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, e no art. 56 observa-se o incentivo pela disponibilização do serviço de assistência judiciária, tais pontos sem dúvidas representa a possibilidade de fácil acesso ao judiciário por aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com todos os encargos de um processo judicial, bem como, da contratação de um advogado particular para postular seu direito.

Do mesmo modo, o Ministério Público ao acolher os pedidos da população relacionados a pleitos individuais envolvendo demandas de saúde, cabe registrar que o órgão ministerial também promove considerações quanto à questão da vulnerabilidade financeira do usuário.

Assim, pode-se concluir que, pelo menos em tese, as pretensões apresentadas ao judiciário são provenientes de pessoas que de fato não possuem condições de arcar com

um tratamento de saúde as suas próprias expensas, já que a grande maioria das ações ajuizadas foram promovidas por entes públicos de representação prevista tanto na Constituição Federal como nas leis infraconstitucionais.

A partir da análise das decisões judiciais, restou identificado que a maior carga de judicialização suportada pelo município refere-se ao pedido de fornecimento de dietas/suplementos/leites, bem como, de fraldas descartáveis, cabendo registrar inclusive que tais insumos não são padronizados pela tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, e Órteses, Próteses e Materiais do Sistema Único de Saúde (SIGTAP/SUS) (12). A tabela reúne todos os procedimentos, medicamentos e insumos que podem ser dispensados tanto no âmbito ambulatorial como hospitalar no SUS, destarte, trata-se de um mecanismo de gerenciamento criado para o devido acompanhamento das alterações realizadas atinentes aos procedimentos e insumos ofertados pelo SUS (13).

Sobre isso, torna-se pertinente registrar que a Portaria de Consolidação n.º 6, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde (14), que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS, prevê em seu artigo 1º que “o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e aos serviços de saúde dar-se-ão na forma de blocos de financiamento com o respectivo monitoramento e controle” (14).

Assim, os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento, sendo eles: bloco de custeio e bloco de investimento, consoante verifica-se do art. 3º da portaria em comento (14).

Nesse sentido, esses recursos financeiros somente serão destinados às ações e serviços públicos de saúde que estejam contemplados nas normas estatuídas pelo SUS, ou seja, os recursos federais possuem destinação e somente poderão ser utilizados para o custeio de despesas com ações e serviços de saúde, conforme previsões contidas na já citada Lei Complementar n.º 141/2012, que estabelece os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde (15).

Com isso, pontua-se que a lei em epígrafe traz um rol de ações e serviços públicos de saúde os quais poderão ser destinados os recursos federais para fim de custeio, consoante apregoado no art. 3º (15), *in verbis*:

- I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
- II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;
- III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
- IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;
- V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
- VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;
- VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;
- VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;
- IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;
- X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;
- XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
- XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Nota-se que a aludida lei prevê no inciso II que trata-se de ação e serviço de saúde a “atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais” (15), contudo, ainda assim, não está a se falar do fornecimento de suplementos e dietas especiais, mas sim de ações de alimentação e nutrição com base na Política Nacional de Alimentação e

Nutrição, nos termos do Anexo III da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde (16), valendo registrar que, a referida política está inserida no bloco da atenção básica.

Cabe trazer à baila, inclusive, que a Portaria de Consolidação n.º 6/2017 supracitada, veda expressamente a utilização de tais recursos para compra de suplementos e dietas especiais, como se vê da redação do parágrafo único do art. 632 (17), vejamos:

Art. 632 *omissis*

(...)

Tratando-se de incentivo exclusivamente de custeio, voltado às ações estabelecidas no art. 632, fica vedada sua utilização para fins diversos aos ora previstos, tais como despesas de capital, tratamento de doenças ou reabilitação de pacientes, aquisição de alimentos, suplementos alimentares, fórmulas alimentares, de vitaminas ou minerais. (Origem: PRT MS/GM 1738/2013, Art. 2º, Parágrafo Único) (17).

Inclusive, tal redação é mantida nas portarias publicadas anualmente para estabelecerem os repasses de cada exercício. Como exemplo, veja-se a Portaria n.º 2.076, de 5 de agosto de 2019, do Gabinete do Ministro de Saúde, que por sinal contempla Divinópolis, e mantém a previsão da mencionada vedação, conforme art. 5º, parágrafo único, (18), *litteris*:

Art. 5º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria deverá ser utilizado exclusivamente no custeio de serviços e despesas relacionadas à efetiva implementação de ações de alimentação e nutrição nas Redes de Atenção à Saúde, principalmente no âmbito da Atenção Básica.

Parágrafo único. Tratando-se de incentivo exclusivamente de custeio, voltado às ações estabelecidas no artigo 2º desta Portaria, fica vedada sua utilização para fins diversos aos ora previstos, tais como despesas de capital, para tratamento de doenças ou reabilitação de pacientes, para aquisição de alimentos, fórmulas alimentares, suplementos alimentares, de vitaminas ou minerais.

Como se vê, em que pese o município receber recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde, tais recursos destinam-se à implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de modo que sobre esses recursos recai vedação expressa

quanto à aquisição de suplementos e dietas especiais (18).

Logo, nas ocasiões em que o município se vê compelido a adquirir esses produtos, fala-se de dispêndio de recursos próprios, eximidos de custeio federal, de modo que a oneração para aquisição desses itens representa para Divinópolis a demanda de maior peso no que diz respeito à judicialização, haja vista as determinações judiciais penderem mais em seu desfavor do requerido, conforme se verá a seguir.

Pois bem, nas buscas realizadas juntamente à SEMUSA e Procuradoria Geral do Município de Divinópolis, foi identificada, no ano de 2018, uma quantidade de 107 processos, os quais referem-se às ações que contém pedidos de fornecimento de suplementos/leite, cabendo registrar que em alguns destes foram identificados pedidos cumulados de fraldas descartáveis.

A seguir, a Tabela 12 demonstra um diagnóstico geral dos processos autuados no ano de 2018, de modo que as análises quanto ao andamento processual foram realizadas até o mês de novembro do ano de 2019.

TABELA 12. Levantamento geral acerca dos processos com pedido de fornecimento de dieta/suplementos/leite, Divinópolis-MG, em 2018.

TIPO	QUANTIDADE GERAL	STATUS	QUANTIDADE
Processos com Pedido Liminar	107	Liminares concedidas	98
		Liminares concedidas em parte	08
		Liminares não concedidas	01
Processos Suspensos	25	Retomaram andamento	20
		Não retomaram andamento	05
Processos Sentenciados (Sentença com resolução de mérito)	26	Sentenças Procedentes	23
		Sentenças Procedentes em Parte	02
		Sentenças Improcedentes	01

Recursos Interpostos pelo Autor	01	-	-
Processos Extintos (Sentença sem resolução de mérito)	34	Por Falecimento do Autor	30
		Por Perda do Objeto	04
Processos Arquivados Definitivamente	1.395.506,27	-	-
Total			107

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da análise das decisões judiciais dos processos.

Do que foi apresentado, tem-se que quase 100% dos processos analisados tiveram seus pedidos liminares deferidos, tendo ocorrido apenas um único caso de indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Ele se deu em virtude da ausência de demonstração pela parte autora de que os insumos fornecidos pela Rede Pública de Saúde não seriam capazes de produzir resultados eficazes ao tratamento da enfermidade que acometia o paciente.

Noutro ponto, é relevante registrar que oito processos tiveram seus pedidos liminares concedidos parcialmente, contudo, o fato gerador da parcialidade não faz parte do recorte em análise, tendo em vista que tais decisões foram parciais tão somente para diminuir a quantidade de fraldas descartáveis requeridas pelo autor, no entanto, no que tange ao pedido de suplemento/leite a liminar foi concedida integralmente.

Acerca das ações em que o pedido liminar foi concedido, cabe trazer que em nenhum dos casos houve revogação da decisão liminar na sentença de mérito, ou seja, nos processos julgados com resolução de mérito em todos os casos a decisão liminar foi mantida, assim, permanecendo a obrigação do município em arcar com o fornecimento da dieta/suplemento/leite.

Verificou-se, ainda, que aproximadamente 23% dos processos analisados tiveram sua tramitação suspensa, por ato do magistrado, em virtude de incidentes de resolução de demandas repetitivas.

Nesses casos de suspensão, o magistrado determinou a suspensão até que fosse julgado

o incidente do Recurso Repetitivo Tema 106, Recurso Especial n.º 1.657.156-RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, haja vista o recurso judicial ter determinado a suspensão em todo território nacional dos processos relacionados ao fornecimento de medicamentos/insumos não contemplados pelo SUS (19).

Vale ressaltar que o instrumento legal ressalvou os feitos que demonstrassem pertinência nos pedidos de urgência, diante disso, todos os processos submetidos à suspensão possuíam decisões liminares de deferimento, ou seja, independentemente da regular tramitação dos autos judiciais, bem como, da duração da suspensão, o município foi compelido a promover o fornecimento dos suplementos/leites nestes casos. Outrossim, conforme registrado nas tabelas, os processos submetidos à suspensão, até novembro de 2019, cinco não retomaram o andamento, em que pese possuírem decisões liminares deferidas.

Sanadas as análises quanto às decisões liminares proferidas, passa-se aos processos em que obtiveram sentenças proferidas, nessa órbita a quantidade de processos julgados sem resolução de mérito supera o número de ações em que de fato houve apreciação do mérito do pedido pelo agente julgador.

Iniciando pelos processos em que houve prolação de sentença sem resolução de mérito, que se trata daquelas ocasiões em que o juiz decide por extinguir o processo sem apreciar as alegações do demandante em virtude de algum fato superveniente advindo nos autos, no presente estudo foram identificadas duas causas para a extinção dos processos sem a devida apreciação de mérito dos pedidos apresentados, sendo elas: o falecimento do autor e a perda do objeto em virtude de do autor já não necessitar do insumo antes pleiteado. Assim, dos 35 processos extintos sem resolução do mérito, mais de 88% foram finalizados em virtude do falecimento do autor, sendo relevante registrar que tais casos se referem a pacientes idosos, os quais obtiveram os pedidos liminares concedidos no início da tramitação processual, logo, ressalta-se que, de qualquer modo, houve compilação ao município em fornecer os itens, ainda que por determinado período.

Já, em relação às ações em que houve prolação de sentença com resolução de mérito, isto é, quando o magistrado decide todas as questões trazidas no pedido inicial, das 26

sentenças proferidas, apenas uma julgou pela improcedência do pedido, tratando-se da mesma ação demonstrada acima em que houve o único pedido liminar indeferido.

Destarte, o magistrado ao apreciar o mérito confirmou o indeferimento do pedido de antecipação de tutela reafirmando o fato de que não foi devidamente comprovado nos autos que os insumos fornecidos pela Rede Pública não produziram efeitos no tratamento do paciente.

Acerca da única sentença julgada improcedente é válido registrar que o juiz trouxe em seu aresto considerações acerca da necessidade de se preservar o orçamento público:

Destarte, face a ausência de demonstração de que os insumos fornecidos pela Rede Pública não produzem os resultados necessários ao tratamento da enfermidade apontada pelo menor, julgar improcedente o pedido é a medida que se impõe, uma vez que é mister resguardar o orçamento dos Entes Públicos, inclusive, para que estes possam atender as inúmeras necessidades da sociedade, em consonância com os princípios norteadores dos atos administrativos, mormente o da razoabilidade e da eficiência (20).

Registra-se que a improcedência do pedido levou o autor a interpor respectivo recurso perante instância superior, contudo, até novembro de 2019 ele não havia sido julgado.

Pois bem, ressalta-se que o entendimento acima exposto não é acompanhado pela maior parte dos magistrados em Divinópolis, muito pelo contrário, a maioria maciça das sentenças de mérito traz que o fato de o insumo não ser padronizado pela Tabela SIGTAP/SUS não desobriga o poder público, declarando que a negativa por parte do município, sob tal justificativa, representa transgressão ao direito à saúde e à vida, observa-se:

O fato de a dieta não fazer parte da lista padronizada do SUS não exime o ente público de fornecê-la ao cidadão que dela necessita e que não dispõe de condições financeiras para adquiri-la. Eximir o Poder Público de fornecer a dieta comprovadamente indispensável ao tratamento do indivíduo, pela simples razão de não estar incluída na lista do SUS, é negar-lhe o direito à saúde, e, em última instância, à vida, em verdadeira ofensa à dignidade da pessoa humana e aos preceitos constitucionais (20).

Em complemento, restou verificado que as sentenças expressam, em sua maioria, que a utilização genérica do princípio da reserva do possível é insuficiente para eximir

o ente público da responsabilização, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a real incapacidade econômico-financeira do município.

Cabe registrar, ainda, que as sentenças proferidas de forma parcial dizem respeito apenas à quantidade de fraldas descartáveis requeridas, de modo que em relação aos pedidos de fornecimento de suplementos/leites foram concedidos de forma integral.

Por fim, do diagnóstico geral sobressaem as seguintes considerações: da totalidade de processos analisados, aproximadamente 24% tiveram sentenças proferidas com resolução de mérito; 32% foram extintos; e aproximadamente 45% já tiveram baixa definitiva de sua tramitação, ou seja, ocorreu o trânsito em julgado.

Ademais, à título de informação, restou constatado que um quinto das ações analisadas referem-se a pacientes menores de idade; a totalidade das liminares concedidas e das sentenças procedentes impõem aos autores a reapresentação dos relatórios médicos para manutenção do fornecimento em período não maior que a cada quatro meses; a totalidade das decisões judiciais permitem que o município tenha margem de escolha quanto à marca do suplemento/leite, desde que possua igual composição nutricional e concentração, bem como, que apresente os mesmos efeitos no tratamento do paciente; a totalidade das decisões judiciais consideraram a apresentação do devido relatório médico desde o pedido inicial, bem como, a hipossuficiência devidamente comprovada dos autores.

Outrossim, restou identificado que, por mais que alguns magistrados determinem a imputação de multa diária em desfavor do município diante do descumprimento da decisão judicial, na prática o que ocorre é o bloqueio judicial dos valores no montante necessário à aquisição dos itens pelo próprio autor.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Os Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), passaram a ter sua instituição definida com a Resolução n. 238 de 06/09/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispôs acerca da criação de Comitês Estaduais de Saúde, cujas atribuições também

incluíam “auxiliar os tribunais na criação de NatJus, constituído de profissionais da Saúde, para elaborar pareceres acerca da medicina baseada em evidências” (21).

A aludida resolução foi editada após a celebração do termo de convênio n.º 21/2016 (22), assinado em 23/08/2016, entre o Ministério da Saúde e o próprio CNJ, que teve como objetivo capacitar os profissionais da área médica dos NatJus. A seguir, alguns itens do termo em comento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo tem como objeto proporcionar aos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF) subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidências científicas nas ações relacionadas com a atenção à saúde, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para a solução das demandas, conferindo maior celeridade ao julgamento das ações judiciais nas quais figurem a atenção à saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Sugerir aos tribunais ou seus Núcleos de Apoio Técnico (NAT-JUS) o suporte técnico-científico de Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) selecionados, de abrangência regional, para a produção de notas técnicas e pareceres técnico-científicos e troca de informações.
- b) Disponibilizar uma assinatura da base de dados da Biblioteca Cochrane e suas ferramentas de buscas, sem prejuízo de outros acervos científicos, para análise de evidências científicas, com objetivo de apoiar os NATS selecionados e NAT-JUS em todo o Brasil em questões relacionadas à Medicina Baseada em Evidências.
- c) Disponibilizar, no sítio eletrônico do CNJ, o Banco de Dados com notas técnicas e pareceres técnico-científicos consolidados emitidos pelos NAT-JUS, TG-MG, NATS selecionados, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), além de julgados na área da Saúde, podendo ser consultado por Magistrados e demais operadores do Direito.

No estado de Minas Gerais, a Portaria Conjunta da Presidência do Tribunal de Justiça n.º. 643/2017 (23), estabeleceu que este tribunal criaria os NatJus, os quais seriam

“constituídos por profissionais de saúde, para prestar apoio técnico aos magistrados de Primeira e Segunda Instâncias, nas demandas que envolvam direito à saúde”, com as seguintes atribuições:

Portaria Conjunta da Presidência n.º 643/2017:

Art. 2º. (...)

I - elaborar “pareceres técnicos”, “notas técnicas” e “respostas técnicas” sobre saúde;

II - prestar esclarecimentos sobre a melhor evidência científica, de eficácia, eficiência, efetividade e segurança;

III - informar sobre a existência de produto ou serviço similar nos protocolos clínicos do sistema de saúde pública ou suplementar.

Conforme disposto no mesmo instrumento legal, os profissionais do NatJus podem ser do próprio tribunal, ou de outros poderes e órgãos, desde que celebrado convênio para tal finalidade. Insta ressaltar que no final do ano de 2017, o município de Belo Horizonte celebrou o referido convênio com o poder judiciário, ocasião em que cedeu dois de seus médicos de carreira, como contrapartida (24).

No ano de 2018, vários outros municípios – Contagem, Ervália, Ituiutaba, Juiz de Fora, Nanuque, Passos, Ribeirão das Neves e Três Marias – adotaram o mesmo procedimento e cederam profissionais médicos ao NatJus do estado, especialmente em vista do aumento das ações judiciais na área da saúde, e para a ampliação da estrutura e dos profissionais do NatJus (25).

Desde dezembro de 2019, a Portaria Conjunta n.º 915/2019 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu que as notas técnicas emitidas serão “elaboradas por meio de Câmaras Técnicas, compostas por um relator, um revisor e um vogal, designados mediante rodízio entre os profissionais integrantes do NatJus” (26), e encaminhadas à Biblioteca Digital do TJMG.

Ainda no mesmo ano, por intermédio do Provimento n.º 84, de 14 de agosto de 2019 (27), do CNJ, ficou ajustado o uso e funcionamento do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), que determina que os NatJus de cada Tribunal, quando

emitirem suas notas técnicas, deverão obrigatoriamente alimentar o aludido sistema.

Importante registrar que, de acordo com levantamento do relatório de gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do biênio 2016 a 2018, foram realizadas 213 notas, pareceres e respostas técnicas (28), o que denota que o NatJus vem atingindo seu propósito com a busca dos magistrados para qualificarem e fundamentarem seu juízo de convencimento também em aspectos técnicos da medicina baseada em evidência, e não somente em princípios absolutos.

No que tange ao município de Divinópolis, os juízes da comarca têm à sua disposição o NatJus do estado devidamente implantado e estruturado, a fim de os auxiliarem nas demandas da saúde que requerem decisões técnicas. Todavia, cumpre esclarecer que o magistrado não é obrigado a solicitar avaliação do NatJus para prolatá-las, mas que, caso haja acionamento do núcleo, ele deverá emitir o respectivo parecer técnico no prazo de 72 horas (22).

Quando o magistrado realiza tal requisição, primeiramente, o pedido passa por consulta junto à biblioteca digital do tribunal para verificação da existência de prévia solicitação análoga e, caso exista, é encaminhada ao requisitante, após atesto de médico do núcleo, para confirmação da similaridade, isso visando otimizar sua atuação (25).

Em Minas Gerais existe nota técnica específica (801/2018) (29), emitida pelo NatJus estadual, acerca do fornecimento de suplementos alimentares industrializados, tema do presente trabalho, o qual dispõe da seguinte forma:

O SUS, não trata as dietas e insumos como medicamentos, assim não existe legislação nacional determinando o fornecimento de dieta industrializada para uso domiciliar. Existem regulamentações loco-regionais, como a de Belo Horizonte, com diretrizes para regulamentar a disponibilização de dieta industrializada, apenas em situação excepcional, cientificamente justificada e se esgotadas todas as outras alternativas terapêuticas.

Ao analisar a referida nota, manifesta-se que a dieta artesanal, ou seja, de produtos in natura (triturados, peneirados), deveria ser a primeira opção para uso domiciliar, em vista do maior número de probióticos, sensação de estar alimentado, além do baixo custo. Ambas – artesanal e industrializada – são equivalentes do ponto de vista nutri-

cional, incumbindo à equipe técnica que acompanha o paciente avaliar a necessidade de suplementar a dieta artesanal com dieta industrializada provisoriamente.

Cumpre salientar que tal nota supracitada foi emitida em 25/09/2018, ou seja, nos últimos 3 meses do recorte temporal deste trabalho. Assim sendo, visando analisar se houve alteração nas decisões judiciais após sua divulgação, verificou-se que no período de outubro, novembro e dezembro de 2018 foram apresentadas 25 ações e sentenciados apenas 7 processos. Todos tiveram os pedidos liminares concedidos e as sentenças procedentes.

Com base em tal análise, denota-se que a referida nota técnica não impactou de imediato no convencimento dos magistrados, sobretudo porque dentre as patologias apresentadas naquelas ações citadas, apenas 4 delas mencionaram desnutrição do paciente, o que poderia ensejar a complementação da alimentação com dietas industrializadas por um período determinado.

Não existe o referido comitê implementado no município. Apesar de existir no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Ação Institucional de Mediação Sanitária, criada por intermédio da Resolução n.º 78/2012 (30), cuja finalidade é apoiar “na resolução das complexas demandas em saúde, com repercussão coletiva, principalmente no aspecto preventivo, de forma a encontrar soluções de consenso, substitutivas da evitável judicialização da política de saúde”.

Importante ressaltar que a finalidade do referido órgão é voltada na proteção do interesse coletivo, logo, fomentando a implantação de políticas públicas, motivo pelo qual pouco atua nas ações que tem como objeto suplementos alimentares, pois, se trata de direitos individuais, com exceção das ocasiões em que envolve interesse de menores de idade.

De acordo com informações obtidas por meio dos servidores da SEMUSA de Divinópolis, em meados de 2005, a gestão à época, visando otimizar o fluxo da judicialização imposta ao serviço de saúde, resolveu designar um profissional farmacêutico para ser responsável ao atendimento das demandas judiciais referentes aos medica-

mentos, inicialmente o setor foi denominado de Farmácia de Processos.

Em 2009, a denominação do departamento foi alterada para Farmácia Complementar, pois, tratava-se de um setor que complementaria os serviços da Rede SUS, além disso, visou-se a diminuição de impacto à assistência à população com a existência de um setor específico para processos judiciais. O referido setor sempre foi subordinado a Referência Farmacêutica, denominada Gerência Farmacêutica, inserida no organograma da Diretoria de Atenção à Saúde da SEMUSA.

O referido setor foi composto por um profissional farmacêutico, um nutricionista e dois agentes administrativos, todos servidores de carreira da SEMUSA, de modo que, a equipe teve por atribuição a elaboração dos termos de referência para os respectivos processos licitatórios, que tivesse por objeto a aquisição dos produtos, o controle de estoque, bem como, a incumbência de manifestar acerca da negativa dos pedidos administrativos que requeressem as dietas industrializadas.

Cabe ressaltar que, na via administrativa, o critério primordial para emissão de manifestação negativa por parte da Farmácia Complementar se dava em razão da ausência de previsão legal de determinado insumo na tabela do SUS, logo, não havia qualquer análise técnica acerca dos mesmos. De modo que, posteriormente, quando as ações eram ajuizadas em virtude dessa negativa administrativa, o setor elaborava pareceres técnicos com o intuito de amparar tecnicamente as defesas e recursos judiciais apresentados pela Procuradoria Municipal nas demandas impetradas contra o município.

Após as devidas verificações observou-se que o município não dispunha de protocolos para fornecimento, pela via administrativa, de suplementos e dietas especiais, além disso, não existiam quaisquer estratégias para evitar a continuidade dos altos gastos com despesas para aquisição de tais itens, no que tange ao atendimento individualizado fruto das demandas judiciais.

Também se observou que as avaliações da farmácia complementar, quando se depa-
ravam com pedido administrativo e até mesmo nos pareceres para subsidiar as defesas
judiciais, não analisavam o mérito do pedido do autor, ou seja, não se promovia qual-
quer juízo de valor quanto à real necessidade da dieta/suplemento prescrito.

Além de não ser identificada a adequação do insumo à patologia do paciente, ou ainda a existência de equivalente nutricional, considerando que quase 100% das demandas indicavam a marca comercial do produto. Tampouco havia um serviço que monitorasse a necessidade da continuidade do fornecimento dos insumos após o provimento judicial, considerando se tratar, como regra, de complemento provisório e excepcional.

Diante dessa questão indicou-se como sugestão primordial a elaboração de ações mais efetivas e eficazes nos serviços de saúde prestados aos munícipes, arquitetando protocolos e fluxos de atendimento de forma administrativa, com a intenção de se evitar o acionamento judicial, bem como, definindo rotas de enfrentamento caso a judicialização se efetive, com o intuito de evitar ao máximo que a mão pesada do judiciário imponha obrigações mais onerosas ao município.

Notou-se, por exemplo, que nos casos levados à justiça, não houve a devida consideração ao laudo médico apresentado pelo paciente, pois, em quase 100% dos processos judiciais houve o deferimento da liminar para concessão imediata do item solicitado, os pacientes sequer apresentavam a desnutrição como patologia. Logo, permitiu-se inferir que o requerimento do item na via judicial possuía um caráter mais assistencialista do que de proteção à saúde.

Traçar rotas para se esvair do fornecimento de determinado item, quase sempre mais dispendioso, buscando demonstrar ao magistrado a existência de alternativas auxiliares tão eficazes quanto às conhecidas marcas existentes no mercado, que na grande maioria das vezes são a primeira opção do jurisdicionado.

Pois bem, a partir da identificação dessa necessidade, para que fosse viabilizada uma forma mais resolutiva aos atendimentos à população, notou-se verdadeira readequação do serviço assistencial, a qual pode ocorrer a partir das sugestões:

1. Otimizar a utilização das dietas artesanais, que se trata de fórmulas não industrializadas a base de alimentos, mas que possuem mesmo valor nutricional;
2. Classificação dos processos existentes na Farmácia Complementar da SEMUSA, pelo tipo de serviço ou insumo requerido, no caso suple-

mentos e dietas, com o intuito de se identificar possíveis processos dissonantes ao objeto trabalhado, bem como, processos antigos, nos quais o paciente já não faz mais uso do item, e processos duplicados, realidade constatada quando do levantamento de dados para composição do capítulo anterior deste trabalho.

3. Composição de equipes multiprofissionais ligadas à Farmácia Complementar do município para realização de visitas prévias à concessão do item, bem como, periódicas para manutenção do fornecimento desses itens, além da contribuição na emissão de pareceres técnicos mais fidedignos;
4. Promover a revisão dos processos judiciais de pedidos de fórmulas industrializadas já existentes, para reinserção de dietas artesanais, observando a aceitação de cada paciente;
5. Nos casos em que restar identificado que o paciente possua cobertura particular por plano de saúde, tomar as providências legais cabíveis para a responsabilização dessas empresas, visando tanto a transferência de responsabilidade do público para o privado, como também o ressarcimento dos gastos já despendidos pelo município;
6. Normatizar formalmente, via publicação dos devidos atos normativos, com intuito de se estabelecer regras para o fornecimento dos suplementos e dietas especiais, em que se estabeleça de forma imperiosa que os laudos médicos e prescrições sejam emitidos por profissionais da rede do SUS, não se admitindo que as referidas prescrições contenham a indicação de marcas comerciais, mas tão somente as composições nutricionais;
7. Elaboração das defesas judiciais contestando efetivamente o pedido a partir da fundamentação técnica obtida por intermédio dos pareceres citados no item 3.
8. No que tange aos pedidos de fornecimento de fraldas descartáveis, já que restou identificado que o recorte do presente trabalho possui,

em sua grande maioria, a presença de pedido cumulado para tal item, evidencia-se também a necessidade de promover a inspeção de todos os processos judiciais que possuam tal pedido, visando a desvinculação dessa obrigação à SEMUSA, haja vista a existência de outros programas federais que abarcam referido insumo.

9. Implementação de mecanismos de composição extrajudicial de conflitos, que inclusive poderiam ser utilizados em outras demandas no município, mas com foco na judicialização da saúde, com a criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde (CEJUSC Saúde).

Embora a lista de sugestões elencadas não se apresentasse excessiva, a gestão da SEMUSA de Divinópolis teve que se empenhar no interesse e persistência em implementar as ações e serviços em assistência à saúde para atendimento das demandas de pacientes que necessitavam de terapia nutricional enteral ou oral.

Em vista do percentual de ações judiciais procedentes para fornecimento de dietas e suplementos nutricionais no município, foi possível inferir que apenas a ausência de previsão de tais insumos na tabela SUS, conforme abordado nos pareceres técnicos da farmácia complementar, não foi suficiente para modificar o resultado das decisões judiciais, o que requereu ponderação mais pormenorizada acerca da condição clínica do paciente, servindo de matéria para as defesas judiciais, e consequentemente, na necessidade dos magistrados de avaliarem de forma mais específica o mérito da demanda.

Ademais, percebeu-se que a carência de tais informações do paciente se fundamentava na inexistência de profissional competente para aquela avaliação, o que foi corrigido ao menos em parte, posto que, desde 2019, uma nutricionista reforçou a equipe de farmácia complementar.

Restou nítido também que o trabalho da equipe do setor de farmácia complementar e procuradoria jurídica com a judicialização visava apenas a operacionalização do cumprimento das sentenças e liminares, bem como dos prazos judiciais, mas sem um

olhar de atenção nesse cenário que vinha se construindo, analisando o que motivava tais ações e o que poderia ser melhorado no serviço para evitar o volume de ações, diagnósticos essenciais e que deveriam se tornar rotina para o desenho das estratégias de enfrentamento do problema.

Posto isto, este estudo permitiu o traçado de algumas dessas, conforme elencadas, e que poderiam ser seguidas como direcionamentos para o município de Divinópolis, a fim de tratar a questão da judicialização das dietas e suplementos alimentares de forma mais qualificada.

Para tanto, primeiramente foi necessário significar o conceito de dietas e suplementos no contexto da saúde, considerando que a ênfase do presente trabalho foi na judicialização do tema. No Brasil, há regulamento específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca da matéria, a RDC n.º 63/2000 (31), que fixa os requisitos para a Terapia de Nutrição Enteral, que se compreende como o “conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de NE” (Nutrição Enteral), prescrita e indicada por médico, sendo definida como:

alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.

Assim sendo, o objeto das demandas judiciais em estudo, embora não previsto na tabela SUS, precisa ser submetido à normativa que o regulamenta, a fim de delimitar a forma e fundamento de abordagem do tema, independentemente do pressuposto do direito à saúde justificado pelo judiciário, pois existem regras sanitárias e técnicas que precisam ser seguidas para sua correta prescrição e fornecimento.

Dessa forma, em relação às sugestões traçadas, apresentaram-se as respectivas estratégias de enfrentamento:

1) Otimizar a utilização das dietas artesanais, que se trata de fórmulas não industrializadas, a base de alimentos, mas que possuem mesmo valor nutricional;

Tal otimização poderia ser realizada com a estruturação de uma equipe com profissionais nutricionistas, contendo no mínimo três componentes, objetivando a implantação do serviço municipal de orientação e acompanhamento da dieta artesanal, tendo por atribuição o seguinte:

- Elaborar protocolo de assistência de dieta artesanal (fórmulas não industrializadas a base de alimentos com mesmo valor nutricional) para ações e serviços do município.
- Elaborar cartilha de manejo da terapia nutricional enteral artesanal;
- Prestar assistência aos usuários da dieta artesanal.

Assim, a SEMUSA poderá aplicar protocolo para utilização das dietas artesanais ou caseiras como primeira opção, pois, trata-se de alternativa muito vantajosa para o poder público, considerando a possibilidade diminuição dos gastos de recursos financeiros em virtude da diminuição da judicialização para requerimento de dietas industrializadas, bem como, em razão do fato de não se causar prejuízos à saúde do paciente, vez que produzem os mesmos resultados que as dietas industrializadas.

Relevante dizer que essas dietas são fórmulas não industrializadas, a base de alimentos naturais, que inclusive referem-se aos alimentos já utilizados em casa no dia a dia, e que são acrescidos a alimentos processados e/ou de suplementos alimentares que apresentam valor nutricional completo e com baixo custo.

Destaca-se que, de acordo com descrito na Cartilha de Terapia Nutricional Enteral do município de Belo Horizonte-MG (32), as fórmulas não industrializadas apresentam muitas vantagens aos pacientes, dentre elas pode-se citar:

São nutricionalmente equilibradas; podem ser preparadas com alimentos naturais, orgânicos e não geneticamente modificados; podem ser adaptadas a preferências ou restrições alimentares como dietas vegetarianas, veganas etc.; podem ser desenvolvidas sem alergênicos (livre de glúten, livre de caseína); apresentam boa fluidez, osmo-

lidade, estabilidade e odor característico dos alimentos utilizados no seu preparo; permitem que as refeições sejam administradas em horários controlados e regulares e que o usuário participe do preparo e escolha dos alimentos, executando receitas feitas com alimentos usualmente consumidos pela família; permitem que os cuidadores tenham o sentimento de estarem nutrindo a pessoa assistida; podem ser de fácil preparo e têm custo mais acessível, comparadas às dietas industrializadas.

É importante salientar que na utilização das fórmulas não industrializadas, para que seja adequada, é imprescindível que a prescrição e o modo de preparação sejam rigorosamente seguidos, conforme a orientação do profissional nutricionista.

Os pacientes que necessitam da dieta oral podem utilizar-se tranquilamente das fórmulas artesanais/caseiras, provavelmente não apresentarão qualquer intercorrência de saúde, por tratar-se de alimentos naturais, ocasionando inclusive um melhor resultado nutricional.

No entanto, é preciso fazer uma observação quanto àqueles pacientes que dependem da dieta enteral, estes carecem de um rigoroso cuidado da equipe de saúde com acompanhamento, orientações aos familiares e cuidadores para evitar os riscos de contaminação da sonda enteral, visando a total exclusão de qualquer possibilidade de dano ao quadro clínico deste paciente.

Importante ressaltar que, embora as vantagens nutricionais que a dieta enteral artesanal possa trazer aos pacientes, a utilização desta fórmula requer muito cuidado no manuseio, preparo adequado dos alimentos e no material utilizado. De tal maneira, que será necessário promover-se a devida capacitação dos familiares e cuidadores destes pacientes, é preciso ainda que a assistência prestada ao paciente esteja bem estruturada, que a equipe de saúde da Atenção Primária e Secundária, envolvidas com acompanhamento desses usuários, se organize suficientemente para evitar ocorrências inesperadas que, porventura, possam culminar na busca de atendimento na Rede de Urgência e Emergência, evitando assim um aumento nas demandas de atendimento nesta categoria de serviço.

Desde o ano de 2018, a CONITEC, por meio da Portaria n.º 67, de 23 de novembro de 2018 (33), deliberou sobre a incorporação de fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de ami-

noácidos, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca. Tal normativa ainda não foi implementada pelo município e, pelas ações propostas no ano de 2018, ocorreram a incidência de tão somente 4 ações judiciais relacionadas a esta patologia.

2) Promover a classificação por tipo de insumo requerido, no caso suplementos e dietas, dos processos existentes na Farmácia Complementar da SEMUSA, com o intuito de se identificar possíveis processos dissonantes, antigos e/ou duplicados.

Pelos processos dissonantes entende-se aqueles que fogem do objeto do presente recorte, por processos antigos evidencia-se a possibilidade de examinar situações em que os o paciente já não faça mais uso do insumo.

Já, a respeito da possibilidade de constatação de processos duplicados, tal situação é uma realidade verificada valendo registrar que em tais casos observa-se, inclusive, o acionamento conjunto do estado de Minas Gerais no polo passivo.

Vale ressaltar que essa medida teria como intuito principal a apresentação de proposta de intervenção ao poder judiciário, para as devidas correções ou extinção de ações judiciais que permitam tal conduta, que, inclusive, contribuirá com o poder judiciário na diminuição dos processos judiciais em andamento, efetuando verdadeira higienização no acúmulo de processos.

3) Composição de equipes multiprofissionais ligadas à Farmácia Complementar do município para realização de visitas prévias e periódicas para manutenção do fornecimento dos itens.

Referida equipe contribuiria também na emissão de pareceres técnicos mais fidedignos, ou seja, que de fato demonstrem a real situação de necessidade do paciente. Essas equipes se dariam no seguinte formato:

- Cada equipe de profissionais conteria, de preferência, um Nutricionista e um Assistente Social, para realizar visitas prévias à emissão das manifestações/ pareceres, em resposta às solicitações de informações quanto a dispensação pelo SUS de suplementos e dietas especiais, utilizando como parâmetro os

preceitos da RDC n.º 63/2000 (27), assim, cada equipe multidisciplinar teria por objetivo os seguintes pontos:

- Avaliar a condição nutricional do paciente;
- Avaliar a necessidade dos insumos prescritos no receituário médico, de acordo com a patologia do paciente e quantidade necessária;
- Avaliar a condição social (hipossuficiência, condição socioeconômica da família, se existe outro benefício para este fim);
- Avaliar a competência técnica do profissional do prescritor;
- Avaliar a existência de substituto equivalente;
- Avaliar a ineficiência da alimentação do paciente pela dieta artesanal;
- Avaliar a capacidade do cuidador de manusear, preparar e administrar a fórmula.

Neste ponto, importante registrar que alguns critérios deverão ser adotados pela equipe multiprofissional envolvida, inclusive, vários deles estão pautados na RDC n.º 63/2000 (27). Assim, vejamos quais seriam esses critérios:

- a. Avaliar se de fato existe deficiência nutricional que fundamenta o pedido;
- b. Indicar a dieta artesanal como primeira opção para uso domiciliar, de acordo com Nota Técnica n.º 801/2018 do NatJus, considerando o fato de possuir a mesma equivalência nutricional da dieta industrializada, de modo que esta somente seria indicada nos casos de suplementação, após uma análise cautelosa de cada caso, e de forma provisória;
- c. Avaliar se a dieta artesanal foi ineficaz e/ou se já foi aplicada, pois, nos termos do item 5.1.3 da RDC n.º 63/2000, são considerados candidatos à utilização da Terapia de Nutrição Enteral aqueles “pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, mas que possuam a função do trato intestinal parcial ou totalmente íntegra”;
- d. Avaliar a condição de manipulação da dieta industrializada, bem como, a pessoa que irá administrá-la, pois, por se tratar de uma terapia nutricional, a RDC em comento prescreve que seu preparo e administração deverão ser

- realizados por nutricionista e enfermeiro. Em tratamento domiciliar é preciso se submeter aos mesmos cuidados;
- e. Avaliar a existência e sugerir substitutos nutricionais a fim de evitar a indicação de marca e/ou melhores custos-benefícios para a administração pública, quando se deparar com pedido específico de marca;
 - f. Avaliar a competência do prescritor da dieta, pois, apenas o médico pode fazê-lo, podendo o profissional nutricionista fazer apenas a prescrição dietética, conforme observa-se dos itens 5.2.1 e 5.2.3 da RDC n.º 63/2000.
 - g. Verificar se o profissional que prescreveu a dieta faz parte de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), de acordo com RDC n.º 63/2000, e se possui treinamento específico em terapia nutricional;
 - h. Solicitar reavaliação do paciente a cada dez dias a fim de acompanhar a melhora nas condições nutricionais. Tal prazo está devidamente normatizado na RDC n.º 63/2000, conforme item 5.1.2, o qual prevê que “a indicação da Terapia de Nutrição Enteral deve ser precedida da avaliação nutricional do paciente que deve ser repetida, no máximo, a cada 10 dias”.

Neste ponto, cumpre salientar ainda que, dos 107 casos analisados, embora todos tenham obtido liminares procedentes, a desnutrição apareceu como patologia em apenas 4 processos, ou seja, menos de 4% das ações judiciais apresentadas no ano de 2018.

Outro fato, é que com base em julho do ano de 2019, a equipe técnica da Farmácia Complementar da SEMUSA passou a contar com uma profissional nutricionista, assim, permitindo a elaboração de manifestações e/ou pareceres técnicos atinentes à disponibilidade usual dos suplementos alimentares e dietas enterais, para resposta tanto ao Poder Judiciário quanto ao usuário interessado que apresenta requerimento na via administrativa. Com isso, a SEMUSA passou a promover um refino e embasamento técnico ainda maior às demandas apresentadas.

Ademais, em entrevistas realizadas junto à Farmácia Complementar da SEMUSA, restou informado que com a presença do profissional nutricionista na equipe da Farmácia Complementar também passou a ser realizado o levantamento de processos

para fins de análise da possibilidade de revisão, principalmente, daqueles processos em que as indicações dos insumos prescritos eram incompatíveis com as demandas nutricionais dos autores.

O intuito deste levantamento foi a identificação de possíveis erros de destinação de insumos, com o intuito de saná-los, a diminuição em maiores índices dos gastos com a dispensação de fórmulas infantis, as quais são prescritas em receituários médicos sem prazo determinado de uso e as que, porventura, não são eficazes de acordo com valor nutricional.

4) Promover a revisão dos processos judiciais de pedidos de fórmulas industrializadas já existentes, para reinserção de dietas artesanais, observando a aceitação de cada paciente;

Observa-se que não há no município fluxo estabelecido com a finalidade de requisitar a reavaliação do paciente, após o fornecimento da dieta/suplemento nutricional. Tal medida seria importante visando a possibilidade de sua reinserção à dieta artesanal, procedimento que poderia trazer economia com a cessação do fornecimento do suplemento industrializado, ou diminuição da quantidade, e até mesmo a extinção do processo pelo atendimento total do pleito, o que poderia se dar pela exigência de nova submissão do paciente ao protocolo (item 7), pelo médico prescritor, com periodicidade definida, uma vez que, nos termos da resolução da ANVISA (27), a reavaliação deve ocorrer a cada 10 dias.

Ademais, a RDC n.º 63/2000 (27) assim dispõe acerca das condições de período da submissão do paciente à terapia nutricional:

5.2.4. A TNE deve atender a objetivos de curto e longo prazos.

5.2.4.1. Entende-se como curto prazo a interrupção ou redução da progressão das doenças, a cicatrização das feridas, a passagem para nutrição normal e a melhora do estado de desnutrição.

5.2.4.2. Entende-se por longo prazo a manutenção do estado nutricional normal e a reabilitação do paciente em termos de recuperação física e social.

5.2.4.3. Em casos excepcionais a TNE pode substituir definitivamente a nutrição oral.

Conforme exposto pela nota técnica do NatJus, a literatura não aborda superioridade nutricional na dieta industrializada frente à artesanal, sendo de menor custo e mais rica em compostos bioativos antioxidantes, devendo ser a primeira escolha para o paciente em atenção domiciliar. Entretanto, há casos em que a suplementação se faz necessária, mas também com objetivos definidos. A prescrição sem prazo definido é uma exceção e pressupõe um quadro clínico específico do paciente, mediante avaliação médica justificada.

5) Nos casos em que restar identificado que o paciente possua cobertura particular por plano de saúde, tomar as providências legais cabíveis para a responsabilização dessas empresas, visando tanto a transferência de responsabilidade do público para o privado, como também o ressarcimento dos gastos já dispendidos pelo município;

Sobre tal questão, é importante salientar que promover tal conduta possui amparo legal expresso na Lei n.º 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, na Lei n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (89), bem como, na Resolução Normativa ANS n.º 358, de 27 de novembro de 2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos físico e híbrido de ressarcimento ao SUS (34).

A Lei n.º 9.656/1998, inicialmente, estabeleceu em seu artigo 32 e parágrafos a possibilidade de ressarcimento ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde referentes a serviços de atendimento à saúde que tenham sido realizados em usuários possuidores de cobertura privada de saúde em instituições públicas ou privadas integrantes do SUS (35). Assim, vejamos o dispositivo da lei, *in verbis*:

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 1o O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) (Redação dada pela Lei n.º 12.469, de 2011).

§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o 15o (décimo quinto) dia da data de recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS (Redação dada pela Lei n.º 12.469, de 2011).

§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será cobrado com os seguintes acréscimos: (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês ou fração; (Incluído pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

II - multa de mora de dez por cento. (Incluído pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos (Incluído pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de Saúde (Incluído pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 7o A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2o deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos (Redação dada pela Lei n.º 12.469, de 2011).

§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei (Incluído pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).

§ 9o Os valores a que se referem os §§ 3o e 6o deste artigo não serão computados para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos termos da Constituição Federal (Incluído pela Lei n.º 12.469, de 2011).

Mais tarde, com a edição da Lei criadora da ANS, instituiu-se como competência desta o estabelecimento de normas para a procedimentalização do ressarcimento ao SUS

(36). Assim, por tratar-se de competência legal, para regulamentar o instituto do ressarcimento ao SUS, a ANS editou algumas resoluções para definição do procedimento a ser seguido para realização dos possíveis ressarcimentos, de modo que a Resolução Normativa ANS n.º 358/2014 trata-se da normativa vigente para tal questão (37).

Da análise ao referido lastro normativo observa-se, em breves palavras, que caso o beneficiário de um plano de saúde privado seja atendido na rede de saúde do SUS, esse atendimento ficará registrado nos sistemas de informação do SUS, sendo tal registro remetido à ANS que, ao ser acionada, promove as constatações necessárias e cruzamento de informações para devida verificação e, em seguida, notifica a instituição privada, assegurando-lhe direito de manifestação, que caso não compareça ou não consiga impugnar de forma eficaz, terá de realizar o ressarcimento apresentado pela agência reguladora. O montante levantado será revertido ao Fundo Nacional de Saúde e reaplicado ações e serviços públicos de saúde.

Pertinente trazer à baila que o artigo 32 supratranscrito foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n.º 1931 perante o Supremo Tribunal Federal, para análise de constitucionalidade do referido dispositivo, tendo restado reconhecida pela Suprema Corte, com argumento de que referida norma legal impede o enriquecimento ilícito das operadoras de saúde, além de proporcionar a prevenção da fixação de modelos assistenciais no mercado de serviços de saúde que visem exclusivamente a obtenção de lucro (38).

A ação em questão teve como relator o Ministro Marco Aurélio, que assim expôs seu voto:

Embora o Poder Público atue gratuitamente em relação aos cidadãos, não o faz no tocante às entidades cuja atividade-fim é justamente assegurar a cobertura de lesões e doenças. Cabe distinguir os vínculos constitucional, entre Estado e cidadão artigo 196 da Constituição Federal, obrigacional, entre pessoa e plano de saúde, e legal, entre Estado e plano de saúde artigo 32 da Lei n.º 9.656/1998. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde, de forma concorrente com o Estado, pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. A norma impede o enriquecimento ilícito das empresas e a perpetuação de modelo no qual o mercado de serviços de saúde submeta-se unicamente à lógica

do lucro, ainda que às custas do erário. Entendimento em sentido contrário resulta em situação em que os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida (33).

No início de 2018, a constitucionalidade do ressarcimento ao SUS pelas operadoras particulares de saúde foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal com julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.064-RJ, em sede de repercussão geral (39), tendo sido consignado pelo Relator Ministro Gilmar Mendes o seguinte:

(...) se é certo que a sociedade financia a prestação de saúde pelo Poder Público por meio do pagamento de tributos, por outro lado não é possível que a coletividade venha a financiar o lucro das entidades privadas, que deixam de desembolsar valores previamente contratados no momento do atendimento, que vem efetivamente a ser prestado pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, pertinente registrar ainda que a ANS editou cartilha sobre orientações de procedimentos de cobrança para ressarcimento ao SUS, a qual expressa que “o ressarcimento pode ser visto como um importante mecanismo de regulação, que possibilita identificar como as operadoras estão procedendo em relação ao cumprimento dos contratos dos beneficiários e se possuem uma rede de atendimento adequada” (40).

Nesse aspecto, cabe ressaltar que pelas legislações expostas acima observa-se que a lei conferiu especificamente à ANS a competência de promover os devidos atos para efetivação desse ressarcimento, tanto que a cartilha editada pela Agência tem o condão de orientar o procedimento administrativo a ser instaurado, normatizando os atos a serem praticados desde a identificação do beneficiário até a cobrança dos valores devidos pelos planos de saúde (35).

Contudo, na esfera judicial constata-se que a jurisprudência pátria, a partir das pacificações do tema pela Suprema Corte, vem aplicando o mesmo entendimento quando o ente público – município, estado e união – que é o da busca por esse ressarcimento judicialmente.

Nesse sentido, o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação apresentada pelo município de Jundiá pleiteando o ressarcimento em virtude de fornecimento de medicamento a paciente beneficiária de plano de saúde particular:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Municipalidade que pretende o ressarcimento por parte de operadora de planos de saúde pelo fornecimento, na rede pública, de medicamentos à paciente conveniada à ré Possibilidade Lei n.º 9.656/1998 que prevê o ressarcimento ao SUS pelas operadoras de plano de saúde particular Constitucionalidade do ressarcimento que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - Vedação ao enriquecimento ilícito - Sentença mantida Recurso improvido (41).

Assim, como proposta de intervenção, a SEMUSA juntamente com a Procuradoria Geral de Divinópolis promoveria os devidos estudos quanto à utilização de tal recurso, primeiramente, avaliando se seria cabível tal entendimento em face dos pedidos de fornecimento de suplementos alimentares, isso considerando os ditames da Lei n.º 9.656/1998 (30), bem como o entendimento jurisprudencial em prática no ordenamento jurídico pátrio, para que, em seguida, praticar os atos necessários à apresentação da demanda judicial pertinente.

6) Normatizar formalmente, via publicação dos devidos atos normativos, com intuito de se estabelecer regras para o fornecimento dos suplementos e dietas especiais, em que se estabeleça de forma imperiosa que os laudos médicos e prescrições sejam emitidos por profissionais da rede do SUS, não se admitindo que as referidas prescrições contenham a indicação de marcas comerciais, mas tão somente as composições nutricionais;

Considerando o resultado das ações judiciais estudadas no tópico 5.1.5 deste trabalho, é importante que a gestão municipal encare que, por mais que tente implementar estratégias para evitar a judicialização de dietas e suplementos industrializados ao estimular o uso da artesanal, é possível que ainda assim as demandas permaneçam sendo propostas, e que o município continue sendo responsabilizado por tal fornecimento. Portanto, é primordial a organização dos serviços de saúde não apenas com a equipe para realizar a avaliação dos pacientes, mas também com a elaboração formal de critérios para o atendimento destes, caso necessitem de tais insumos, com a criação de protocolo, a exemplo dos PCDTs (Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas), conforme previsto no artigo 19-N da Lei Federal 12.401/2011 (42):

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.

Tal protocolo deveria regulamentar as condições técnicas que precisam ser analisadas e obedecidas pelo médico prescritor na rede do SUS, o que permitirá avaliação criteriosa acerca da indicação da complementação da alimentação do paciente, e a efetiva necessidade nutricional deste.

Em relação às prescrições da rede privada, que não passam pela porta de entrada regular do SUS, a partir do recebimento administrativo do pedido pela farmácia complementar, deverá ser feito o encaminhamento do paciente a fim de submissão ao protocolo, pelo critério de equidade.

Na hipótese de desinteresse do paciente de se submeter a tal avaliação, deverá ser elaborado relatório com a justificativa de ausência de histórico de atendimento do paciente pela rede SUS, que se negou a realizar avaliação clínica para submissão aos critérios do protocolo técnico para fornecimento dos insumos, o que impede a verificação da sua real necessidade, demonstrando que a SEMUSA se estruturou para permitir o fornecimento na via administrativa.

Por esse formato, não há negativa no fornecimento da dieta, mas a negativa é do próprio paciente em se submeter ao regramento previsto pelo SUS para o recebimento do insumo de que supostamente necessita.

Cumprе ressaltar que a avaliação clínica do paciente é necessária e obrigatória nos termos dos incisos 5.1.2 e 5.1.3 da RDC n. 63/2000, considerando que a terapia nutricional, no sentido técnico, é um tratamento a que o paciente se submete, e como tal deve ser tratado, uma vez que a prescrição da terapia “deve ser precedida da avaliação nutricional do paciente” cujos candidatos são “pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, mas que possuam a função do trato intestinal parcial ou totalmente íntegra”.

No que tange ainda à forma de prescrição, é preciso ficar disposto no referido protocolo que esta deve ser realizada pelo descritivo genérico do suplemento. Na SEMUSA, desde fevereiro de 2018, mesmo com os pedidos judiciais indicando marcas específicas, a Farmácia Complementar da SEMUSA passou a promover a substituição da dieta enteral 1,2 Kcal/ml de marca comercial (a mais solicitada nas ações judiciais) por equivalentes nutricionais. Tal conduta foi acompanhada de orientação de profissional nutricionista, e efetivamente realizada somente após a confirmação do profissional que realizou a prescrição do paciente. Vale salientar que tal medida ocasionou uma redução de cerca de 21% dos gastos com tal insumo (Tabela 13).

TABELA 13. Custos dieta enteral de marca comercial x equivalente nutricional.

DIETA	DIETA	QUANTIDADE DISPENSADA	GASTOS (R\$)
Dieta Enteral de Marca	Abr/2016 a dez/2017	46.356 litros	R\$ 922.484,40
Equivalente Nutricional	Fev/2018 a out/2019	57.216 litros	R\$ 725.493,76

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados nos registros da Farmácia Complementar do município de Divinópolis-MG (mimeo)

Analisando os dados da Tabela 13 acima, identifica-se que apesar de uma quantidade muito maior dispensada, ainda assim houve uma economia de R\$ 196.990,64 (cento e noventa e seis mil novecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos). Tal fato é importantíssimo a fim de demonstrar a incoerência da indicação da marca, considerando a existência de equivalente nutricional, bem como a impropriedade na

prescrição da terapia de nutrição do paciente, pois não se avalia sua necessidade individual, mas se prescreve a marca comercial de um produto disponível no mercado, que contém nutrientes que poderão contribuir para a suposta deficiência do paciente.

Não por acaso a RDC n.º 63/2000 indica que a equipe ou profissional que prescreve terapia nutricional deve possuir treinamento específico, e preferencialmente título de especialista reconhecido em área relacionada àquela, haja vista a complexidade e responsabilidade na prescrição deste tratamento.

Por último, caso um protocolo geral seja de difícil construção e implementação a curto prazo pela SEMUSA, seria conveniente se iniciar tal procedimento a partir da população idosa e crianças até 24 meses, considerando que mais de 70% das demandas judiciais do ano de 2018 foram propostas visando o atendimento a pessoas acima de 60 anos e a CONITEC, desde o final de 2018 incorporou fórmulas nutricionais para aquela faixa etária de crianças, que sejam alérgicas à proteína do leite de vaca, o que ainda não se incorporou no município. Embora a constatação desse objeto no ano de 2018 seja inferior a 5% das ações judiciais, o fato é que, com base em tal incorporação, que teve início em maio/2019, não há justificativa para seu não fornecimento.

Assim sendo, ambas as estratégias pontuais poderiam tentar conter, levando em consideração a tendência das ações judiciais de 2018, cerca de 75% das demandas, com solução pela via administrativa e criteriosa avaliação do paciente.

No entanto, para os pacientes que eventualmente não se enquadrarem no protocolo e que busquem o provimento jurisdicional para sua necessidade, a SEMUSA demonstrará em juízo a existência de implantação de uma política pública específica, com critérios técnicos e a motivação do não fornecimento do insumo, qualificando a resposta, e exigindo do magistrado o aprofundamento da análise de mérito, também técnico, para fundamentar sua decisão, posto que, neste caso, não poderá avocar o papel do executivo na forma de execução de tal política.

7) No que tange aos pedidos de fornecimento de fraldas descartáveis, em sua grande maioria com pedido acumulado, evidencia-se também a relevância de se promover a inspeção de todos os processos judiciais que possuam tal pedido, vi-

sando a desvinculação dessa obrigação à SEMUSA, haja vista a existência de outros programas federais que abarcam referido insumo.

Conforme foi possível atestar, grande parte das ações judiciais para fornecimento de dietas e fórmulas nutricionais foi cumulada com fraldas geriátricas, especialmente porque mais de 70% daquelas ações tinham como autores pessoas idosas, que necessitavam de ambos os insumos. Assim sendo, considerando a incidência em conjunto, é conveniente também traçar proposta de estratégia de enfrentamento para este último, haja vista que, ainda que se contorne a incidência das ações judiciais referentes às primeiras (dietas e suplementos), em tese, as segundas poderão continuar não trazendo o efeito positivo com a diminuição efetiva das ações.

Neste aspecto, relevante ponderar que a Portaria de Consolidação n.º 05/2017 (43) aprova as normas operacionais do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), conforme o Anexo LXXVII, em que o Ministério da Saúde subsidia a aquisição de determinados produtos mediante a apresentação de prescrição médica, dentre eles a fralda geriátrica para pacientes acima de 60 anos, que pode ser adquirida em 60 diferentes farmácias credenciadas/contratadas por aquele ente no município (44), com desconto de até 90% sobre o valor de referência (R\$ 0,71 centavos por tira), cabendo ao paciente o pagamento de apenas 10% do custo correspondente.

Por outro lado, de acordo com informações obtidas pelo setor de licitação do município, o preço obtido em processos licitatórios na aquisição foi quase o dobro (R\$ 1,24/tira), demonstrando que as regras de mercado para a aquisição individual são mais benéficas que para o Poder Público, haja vista que o universo de compras deste é muito menor, pois se vê obrigado a adquirir bens apenas de estabelecimentos que se proponham a participar de procedimentos licitatórios, enquanto o paciente tem à disposição 60 estabelecimentos para eleger e comparar preços.

Assim sendo, a proposta neste quesito seria de avaliar a condição socioeconômica do paciente por ocasião do pedido administrativo, incentivando a busca por tal alternativa junto às farmácias credenciadas, ou junto às câmaras de composições administrativas do conflito, ponderando a possibilidade de incluir o paciente no protocolo de fornecimento das dietas/suplementos, caso cumpra os critérios, mas negociando que

as fraldas sejam custeadas por ele, ou, em última hipótese, caso não sejam exitosas as alternativas anteriores, e ainda assim o paciente busque o judiciário para tal fornecimento, que o município, ao se deparar com propostas de preços nas licitações maiores que os praticados pelo PFPB para cumprimento das ordens judiciais, manifestar ao magistrado a desvantagem econômica de tal aquisição e propor o bloqueio de recursos das contas para que o próprio paciente consiga realizar a aquisição diretamente por aquele programa.

Tal alternativa encontra consonância e analogia com a previsão do Enunciado n.º 94 do CNJ (45) – “Até que possa ser concluído o processo da compra de medicamentos ou produtos deferidos por decisão judicial para regular fornecimento, o magistrado poderá determinar à parte ré o depósito judicial de valores que permitam à parte autora a aquisição”.

8) Elaboração das defesas judiciais contestando efetivamente o pedido a partir da fundamentação técnica obtida por intermédio dos pareceres.

Em vista do resultado das decisões judiciais, foram analisadas as respectivas defesas apresentadas pelo município e percebeu-se que não há abordagem acerca da condição clínica do paciente, se precisa ou não da complementação alimentar por dieta industrializada pleiteada, que é o mérito da lide, tampouco se questiona a ineficácia ou insuficiência ou impossibilidade de utilização da dieta artesanal regular, como primeira opção na nutrição do paciente. Conforme se depreende da fundamentação da nota técnica do NatJus, a dieta industrializada é suplementar, provisória e visa sanar um problema alimentar pontual do paciente; para tanto, esta deficiência ou necessidade precisa estar no mínimo evidenciada no processo, condição que foi mencionada em apenas 4 ações judiciais (desnutrição como patologia), demonstrando fragilidade na defesa.

Outro ponto importante que precisa ser abordado na defesa jurídica, é a ausência de indicação da necessidade nutricional específica do paciente. As prescrições se dão pela marca do insumo, o que vem acarretando diversos tipos de produtos (marcas) diferentes. Em 107 processos, foram requisitados 21 tipos/marcas diferentes de insumos

– as quais, em tese, poderiam ser supridas por fórmulas nutricionais equivalentes, se houvesse a prescrição genérica dos nutrientes, tal qual ocorre com medicamentos.

Assim sendo, a Procuradoria Jurídica, ao receber a inicial, precisa formular quesitos acerca da condição do paciente de acordo com seu laudo nutricional (se) apresentado, da necessidade da suplementação alimentar de acordo com este, da adequação da prescrição da fórmula/dieta/suplemento, existência de equivalente nutricional no mercado, inclusive questionando o período de tratamento e reavaliação do paciente, questões estas a serem analisadas por profissional competente, a fim de subsidiar a defesa do município, conduta que com base em 2019 se tornou possível, devido à integração de um profissional nutricionista na equipe de farmácia complementar, que elabora os pareceres técnicos a esse órgão jurídico.

Ainda por ocasião da defesa, embora tal consulta não seja obrigatória pelo magistrado, havendo subsídios técnicos que tragam dúvidas acerca da adequação da prescrição nutricional, seria conveniente que o procurador jurídico requisitasse a submissão da questão ao NatJus, a fim de que a lide seja avaliada tecnicamente por equipe imparcial criada especificamente para este propósito e à disposição do juízo.

Outrossim, como preliminar de defesa, a procuradoria jurídica precisa ter um rigoroso controle acerca das ações propostas, a fim de abordar eventual litispendência nas ações, o que extinguiria de pronto as ações propostas de forma repetida com o mesmo autor, objeto e causa de pedir.

9) Implementação de mecanismos de composição extrajudicial de conflitos, que inclusive poderiam ser utilizados em outras demandas no município, mas com foco na judicialização da saúde, com a criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos e CEJUSC Saúde.

Para efetivação desta medida, se mostra necessária a realização de um trabalho em conjunto, com os devidos estudos e discussões entre a SEMUSA, o Chefe do Poder Executivo, a Procuradoria do município e, claro, o próprio Poder Judiciário, para efetivação da criação de um CEJUSC específico para tratar das demandas que envolvam o serviço de saúde.

O referido centro, antes da efetiva judicialização da demanda, intermediaria por meio de realização de uma audiência de conciliação entre as partes, quais sejam, o paciente e o município, com o exclusivo intuito de que a pretensão autoral seja sanada na fase conciliatória, sem que se formalize o processo judicial.

Neste ponto, cabe trazer que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania são oriundos da Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010, do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário (46), sendo relevante registrar que o CNJ ao editar referida resolução considerou em seu preâmbulo que:

(...) a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças;

Ademais, há que se ressaltar que a criação de um centro de solução de conflitos específico para os litígios de saúde impactaria de forma ampla na demanda de judicialização atual, uma vez que poderiam ser abordadas todas as ações judiciais, independente do objeto, seja fornecimento de insumo, seja de medicamento ou algum procedimento pelo SUS, inclusive, os que fazem parte do recorte tratado neste trabalho, que por sinal fora escolhido em razão de ser o maior encargo suportado pela SEMUSA, atualmente, no que diz respeito à judicialização da saúde.

Pois bem, em que pese a criação do aludido Centro de Solução de Conflitos tratar-se de competência privativa do poder judiciário, por meio do respectivo Tribunal de Justiça local, cabe ressaltar que o município, identificando que a criação do referido instituto pode representar benefício ao paciente, bem como, vantajosidade à administração pública, haja vista a diminuição da judicialização, poderia dar início às tratativas junto com o poder judiciário visando a implantação do referido Centro.

Importante, ressaltar que para viabilização do aludido serviço, seria necessária a prática de alguns atos prévios por parte do município, como por exemplo:

- a. A SEMUSA promoveria a indicação do valor de alçada para os acordos, isso a partir dos dados coletados da realidade vivenciada pela secretaria, de modo que a Procuradoria do município, órgão que possui capacidade postulatória perante o judiciário, na ocasião da conciliação teria poderes de transacionar até o limite do valor estabelecido, sendo de suma importância a realização do estudo para identificação desse valor de alçada, isso com objetivo de dar possibilidade de atendimento à necessidade do paciente, mas, também, que seja razoável o suficiente para não se causar sobrecarga aos cofres públicos;
- b. A criação de uma lei, pelo Chefe do Poder Executivo municipal, para instituição de uma Câmara de Conciliação e Arbitragem no âmbito da Administração Pública Municipal, que disponha de forma específica sobre os limites de atuação dos procuradores do município, na ocasião das conciliações que envolvam o serviço de saúde, especialmente, em relação ao valor de alçada, a ser indicado pela Secretaria de Saúde, de modo que, caso os pedidos apresentados pela parte autoral superarem o valor de alçada, a conciliação ocorrerá somente com autorização do Chefe do Poder Executivo; e
- c. A celebração do respectivo convênio de cooperação técnica entre o município e o Tribunal de Justiça da Comarca de Divinópolis, visando a proceduralização e devido funcionamento do Centro a ser criado, havendo a devida cooperação mútua entre os partícipes.

Neste ponto, cabe trazer à baila que o município de Divinópolis conta com um CEJUSC desde 12 de agosto de 2016, instalado por via da Portaria Conjunta n.º 539/PR/2016, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (42). A portaria que instalou o CEJUSC em Divinópolis prevê que o centro integra os setores de cidadania, pré-processual e processual, assim, não se observa destinação específica para as demandas da saúde.

Assim, caso fosse implantado o CEJUSC para demandas da saúde, que volta-se a dizer, trata-se de competência privativa do poder judiciário, tal conduta passaria, então, à celebração de respectivo convênio entre o município e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, elencando direitos e deveres para ambas as partes, e assim promover-se um benefício duplo aos órgãos celebrantes, qual seja, diminuição da fila do judiciário e

possibilidade de desoneração do município / secretaria de saúde em relação à imposição de decisões judiciais atinentes ao fornecimentos de itens de saúde, no caso dessa pesquisa, os suplementos e dietas especiais.

Sobre o CEJUSC, importante registrar que a capital goianiense foi pioneira nacional no estabelecimento do referido centro exclusivo para demandas da saúde. Tal conduta se deu após a constatação de que no interregno de menos de 10 anos – entre 2008 e 2017 – foi identificado que o número de demandas judiciais atinentes ao serviço de saúde aumentou cerca de 130% no estado de Goiás (48).

Em notícia veiculada no *site* do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o juiz de direito Romério do Carmo Cordeiro, trouxe como finalidade para o CEJUSC da Saúde um caráter de “função estratégica para aproximar ao máximo a capacidade da necessidade, oferecendo um ambiente propício que estimula o diálogo e a interação, antes de aplicar a decisão judicial” (43).

Assim, nota-se que de fato trata-se de alternativa com grandes chances de eficácia na condução dos processos judiciais, bem como, na tentativa de se evitar que o pleito do paciente se torne, de fato, uma demanda judicial.

Outra forma de composição na via administrativa se daria a partir da criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, conforme previsão da Lei Federal n.º 13.140/2015 (49), que deve se dar no âmbito da Procuradoria Geral do município.

Tal criação também se daria por intermédio de lei, com a proposta de regulamento para seu funcionamento, e poderia ser instada quando o próprio serviço de farmácia complementar, ao receber o pedido administrativo de dietas e suplementos, constata-se a real necessidade de suplementação nutricional (submissão ao protocolo ou avaliação clínica do paciente), indicando à câmara a possibilidade da concessão do pedido, convencionando ajustes tais como: continuidade da utilização da dieta artesanal, fornecimento da dieta industrializada de forma complementar, o período de fornecimento, o prazo para reavaliação nutricional, o fornecimento de equivalente nutricional em vez de marca comercial eventualmente prescrita, dentre outras.

Tal medida é vantajosa tanto para o paciente, com a agilidade do fornecimento, como interessante ao município com o maior controle nas dispensações e períodos de fornecimento, e nos gastos de uma demanda judicial, com verbas sucumbenciais, por exemplo, e toda a movimentação da máquina administrativa e judicial, quando já se antevê a chance da procedência da ação.

Inclusive o estado de Minas Gerais é precursor da utilização de tal meio de solução extrajudicial de conflito, tendo criado no final do ano de 2018 a primeira câmara desta natureza no país (50), por via da Lei Estadual n.º 23.172, de 20 de dezembro de 2018 (51), cujo intuito é evitar a judicialização dos interesses que estejam em conflito com o estado. Assim, vejamos o que estabelece o artigo 5º da aludida lei:

Art. 5º – Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, vinculada ao Governador do Estado, com a finalidade de instituir a conciliação e a mediação como meios para a solução de controvérsias administrativas ou judiciais que envolvam a administração pública direta e indireta.

Parágrafo único – A coordenação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos caberá à Advocacia-Geral do Estado, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado, da Lei Complementar n.º 81, de 10 de agosto de 2004, e do art. 32 da Lei Federal n.º 13.140, de 26 de junho de 2015.

Esta modalidade de composição de conflitos, embora a implantação seja bem mais simples que a do CEJUSC para demandas da saúde, traz o desafio de garantir ao particular a segurança na imparcialidade nas decisões, sob pena de tornar-se um processo inócuo e sem credibilidade perante os administrados, que não são obrigados a aderir a qualquer composição nesta seara, especialmente se não sentirem o senso de justiça e adequação em relação à condução da mediação, que ficará a cargo apenas da administração pública.

Considerações Finais

Como restou demonstrado, as demandas judiciais relacionadas ao fornecimento de dietas e suplementos nutricionais são crescentes no município, e equivalem, no recorte temporal do estudo (2018), a aproximadamente 1/3 dos valores totais gastos com cumprimento de ordens judiciais. Observou-se pelo menos em sede de liminar, que os pedidos dessa natureza foram praticamente 100% concedidos, tanto nas liminares, como nas sentenças de mérito.

Este resultado pode ser justificado devido à falta de duas estruturas/análises estratégicas: a primeira, na avaliação técnica dos pedidos apresentados, visando à certificação se o quadro clínico do paciente, de fato, requer a dieta/suplemento prescrito, bem como se a prescrição dietética respectiva é condizente com a suposta necessidade (quantidade, tipo de dieta, marca específica etc.), fornecendo tais informações à procuradoria jurídica para construir a defesa de mérito das ações judiciais, mas também na resposta ao pedido administrativo do paciente. A segunda, na imprevisão de uma política pública voltada para tal finalidade no município, deixando a cargo do judiciário a decisão pelo fornecimento do insumo, de forma muitas vezes infundada, haja vista a ausência de subsídios na contestação do pedido do autor.

Destarte, considerando que a judicialização desse objeto remonta há no mínimo 8 anos na área da saúde no município de Divinópolis, de forma progressiva e difundida no país, é notório que se sedimentou o entendimento pelo Judiciário de que o Poder Público é responsável por tal fornecimento, competindo a este mesmo poder, consubstanciado na gestão do SUS local (SEMUSA), a tomada de providências a fim de construir a política pública correspondente para o fornecimento de dietas e suplementos industrializados. Para tanto, faz-se necessária a criação de critérios e protocolos com o intuito de avocar a responsabilidade na gestão deste tipo de assistência ao paciente, de forma técnica, o que muitas vezes não ocorre, haja vista a ausência de parâmetros a serem seguidos.

Por este motivo, a formalização dos critérios permitirá a avaliação técnica com maior objetividade, tanto para o médico que assiste o paciente, quanto para o profissional

incumbido do parecer técnico da demanda, que não tenha cumprido os requisitos previamente estabelecidos nos protocolos para seu fornecimento regular.

Ademais, não bastasse a tendência jurisprudencial citada, não se pode olvidar a existência de regulamentação que caracteriza a terapia nutricional como uma espécie de tratamento médico com uma finalidade específica, o que é legitimado pela nota técnica do NatJus mencionada, que ratifica que existem casos em que a dieta/suplemento industrializado se faz necessária, sendo inócua a reiteração de respostas que justifiquem o não fornecimento meramente fundamentado na imprevisão do insumo na Tabela SUS.

Assim sendo, a incorporação efetiva da política pública, com o monitoramento de seu funcionamento, permitirá que o judiciário qualifique a avaliação do pedido do autor com base nestes parâmetros previamente construídos, o que implica na possibilidade de improcedência de ações, caso não reste evidenciada a deficiência ou necessidade que as justifique.

Esta construção de política pública reflete ainda na diminuição de gastos no âmbito judicial (verbas sucumbenciais e no deferimento equivocado das ações), bem como na organização do atendimento assistencial na SEMUSA, com a previsão regular do insumo em casos específicos, o que induz ao tratamento mais célere e humanizado ao paciente, atendendo ao dever do Estado na garantia do direito à saúde e à finalidade do SUS.

Referências

- 1 - Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília (DF): Senado Federal, 2019.
- 2 – Dutra FDA, Pinheiro R, coordenadores. **Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência**. [Internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 2015. [citado 10 dez 2019]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/6781486daef02bc6ec8c1e491a565006.pdf>>.
- 3 – Prefeitura do Município de Divinópolis (BR). **Lei n. 7.676, de 04 de junho de 2013**. Dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos e dá outras providências. [Internet]. [citado 15 dez 2019]. Divinópolis: Diário Oficial do Município; 04 jun. 2013. Disponível em: <<https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/media/sapl/public/norma-juridica/2013/10395/10395.pdf>>.
- 4 – _____. **Lei n. 8.255, de 16 de dezembro de 2016**. Dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos e dá outras providências. [Internet]. Divinópolis, 17 dez 2016 [Citado 15 dez 2019]. Disponível em: <<https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/media/2016.pdf>>.
- 5 – Câmara Municipal de Divinópolis. **Lei ordinária n.º 8.480, de 23 de julho de 2018**. Dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do poder executivo do município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos, altera do anexo I, GH 2 à 8, da lei n.º 6.655, de 01 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do poder executivo do município de Divinópolis e dá outras providências [Internet]. Divinópolis, 23 jul. 2018. [acesso 1º jul. 2019]. Disponível em: <<https://www.lexml.gov.br/urn>>.
- 6 – Prefeitura do Município de Divinópolis (BR). **Lei Ordinária n. 8.398, de 28 de dezembro de 2017**. Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018 [Internet]. Divinópolis, Diário Oficial do Município, 28 dez 2017 [citado 10 mar 2020]. Disponível em: <https://www.divinopolis.mg.leg.br/leis/copy_of_legislacao-municipal>.

7 – Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação n. 6 de 28 de setembro de 2017**. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 29 set 2017. [citado 7 fev 2020]. Disponível em: <http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Legislacoes/Portaria_Consolidacao.pdf>.

8 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (BR). **Panorama Cidades e Estados, Divinópolis 2019** [Internet]. [citado 01 jul. 2019]. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/panorama>>.

9 – Governo do Estado de Minas Gerais (BR). **Lei Complementar n. 65, de 16 de janeiro de 2003**. Organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências. [Internet]. Belo Horizonte, Diário Oficial do Estado; 17 jan. 2001. [citado em 10 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.almg.gov.br/consulte>>.

10 – _____. (Defensoria Pública. Documentos necessários / Saúde: Tutela Específica SUS. [Internet]. **Belo Horizonte: Defensoria Pública de Minas Gerais; 2016**. [citado 10 mar 2020]. Disponível em: <<https://www.defensoria.mg.def.br/documentos-necessarios/>>.

11 – Brasil. **Lei Federal n. 9.099, de 26 de setembro de 1995**. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 27 set 1995. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.htm>.

12 – Ministério da Saúde (BR). **Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS** [Internet]. Brasília, 2019. [citado 10 jan. 2020]. Disponível em: <<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>>.

13 – Brasil. Ministério da Saúde. **Manual Técnico Operacional do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP** [Internet]. Brasília 2011. [citado 10 Jan 2020]. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search.gov.br>>.

14 – _____. **Portaria de Consolidação n. 6, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet] Brasília: Diário Oficial da União; 03 out 2017. [citado 10 jan. 2020]. Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis>>.

15 – Brasil. **Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012**. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 16 jan. 2012. [citado 15 dez 2019]. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil>>.

16 – Brasil. **Portaria de Consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet] Brasília: Diário Oficial da União; 03 out 2017. [citado 10 jan. 2020]. Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis>>.

17 – _____. **Portaria de Consolidação n. 6, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet] Brasília: Diário Oficial da União; 03 out 2017. [citado 10 jan. 2020]. Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis>>.

18 – _____. **Portaria n. 2.076, de 05 de agosto de 2019**. Habilita Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição, com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNaN, referente ao exercício financeiro de 2019. [Internet] Brasília: Diário Oficial da União; 16 ago. 2019. [citado 10 jan. 2020]. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2076_16_08_2019.html>.

19 – _____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1657156 / RJ (2017/0025629-7)**. Recorrente: Estado do Rio de Janeiro. Recorrido: Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Brasília, 2 ago. 2019. [citado 11 dez 2019].

20 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (BR). **Vara da Infância da Juventude Comarca de Divinópolis. Autos n.º 0108979-39.2017.8.13.0223**. Sentença. Juiz titular Francisco de Assis Correia. [Internet]. [citado 11 dez 2019]; Disponível em: <<http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc>>.

21 – Brasil. **Resolução n. 238 de 06 de setembro de 2016**. Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara da Fazenda Pública. [Internet]. Brasília, 09 set. 2016 [citado 16 jan. 2020]. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos->>.

22 – _____. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Justiça. **Termo de Cooperação Técnica n. 21/2016**. Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça para os fins que especifica. [Internet]. Brasília, Conselho Nacional de Justiça; 23 ago. 2016. [citado 21 jan. 2020]. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/.pdf>>.

23 – Poder Judiciário de Minas Gerais (BR). **Tribunal de Justiça. Portaria Conjunta n. 643 de 31 de maio de 2017**. Dispõe sobre a regulação dos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário para as demandas de saúde – NAT-JUS, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG. [Internet]. Belo Horizonte, Diário da Justiça; 31 maio 2017. [citado 16 jan. 2020] Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc06432017.pdf>.

24 – Tribunal de Justiça e Prefeitura de BH firmam cooperação técnica. [Internet]. **Portal do Diário Oficial de Minas Gerais, Noticiário. 02 dez 2017**. [citado 16 jan. 2020]. Disponível em <http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/192052>.

25 – **Médicos vão integrar equipe que fará notas técnicas para subsidiar decisões judiciais na área da saúde**. [Internet]. Portal de Transparência COSEMS-MG. 08 mar 2018. [citado 17 jan. 2020]. Disponível em <https://www.cosemsg.org.br/site/index.php/todas-as-noticias-do-cosems/1614-tjmg-e-municipios-mineiros-firmam-cooperacao-tecnica>.

26 – Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (BR). Tribunal de Justiça. **Portaria Conjunta n. 915 de 12 de dezembro de 2019**. Designa servidor para auxiliar na coordenação dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário para as Demandas de Saúde - NAT-JUS, durante o período experimental de que trata a Portaria Conjunta da Presidência n.º 901, de 15 de outubro de 2019. [Internet]. Belo Horizonte, Diário da Justiça; 13 dez 2019. [citado em 17 jan. 2020]. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc09152019.pdf>.

27 – Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Provimento n. 84 de 14 de agosto de 2019**. Dispõe sobre o uso e o funcionamento do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus). [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 15 ago. 2019. [citado em 18 jan. 2020]. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_84_14082019_22082019175759.pdf.

28 – Tribunal de Justiça de Minas Gerais (BR). **Relatório de Gestão biênio 2016-2018: judicialização da saúde**. [Internet]. Belo Horizonte: Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário; [2019]. [citado 19 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2016-a-2018/judicializacao-da-saude.htm#.XiTCjfrKt8>.

29 – _____. **Nota Técnica NAT-JUS n. 801/2018.** Analisa fornecimento de suplementos industrializados para pacientes com câncer de boca [Internet]. Belo Horizonte; 25 set 2018. [citado 25 jan. 2020]. Disponível em: <https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/9302/1/NT%20801%20-%202018%20-%20Dieta%20Nutren%2C%20Ensure%20ou%20Nutriental%20e%20insumos%20na%20neoplasia%20maligna%20de%20boca%20-%20NATJUS%20TJMG.pdf>.

30 – _____. **Resolução PGJ n. 78, de 18 de setembro de 2012.** Dispõe sobre a criação da Ação Institucional de Mediação Sanitária – Direito, Saúde e Cidadania no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAOSAÚDE) [Internet]. Belo Horizonte, 18 set 2012. [Citado em 26 jan. 2020]. Disponível em: https://mpnormas.mpmg.mp.br/files/1/1/1-1-C64A-28-res_pgj_78_2012.pdf.

31 – Brasil. Ministério da Saúde. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 63 de 06 de julho de 2.000.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral. [Internet]. Brasília, Diário Oficial d União, 06 jul. 2000. [citado 19 fev 2020]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2000/rdc0063_06_07_2000.html.

32 – Pereira AF *et al.* **Cartilha de Terapia Nutricional Enteral: manual do paciente, cuidador.** 2. ed. [Internet]. Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte; 2018. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/Cartilha_terapia_nutricional_enteral-25-6-2018.pdf.

33 – Brasil. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. **Portaria n. 67, de 23 de novembro de 2018.** Torna pública a decisão de incorporar as fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União, 26 nov. 2018. [citado 15 fev 2020]. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/PortariaSCTIE_67_2018.pdf.

34 – _____. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Resolução Normativa n. 358, de 27 de novembro de 2014.** Dispõe sobre os procedimentos administrativos físico e híbrido de ressarcimento ao SUS, previsto no art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e estabelece normas sobre o repasse dos valores recolhidos a título de ressarcimento ao SUS. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 28 nov. 2014 [citado 02 mar 2020]. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MjgyNw==>.

35 – Brasil. **Lei Federal n. 9.656, de 3 de junho de 1998**. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 4 jun. 1998. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19656.htm.

36 – _____. **Lei Federal n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000**. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências. [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 29 jan. 2000. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19961.htm.

37 – _____. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Resolução Normativa n. 358, de 27 de novembro de 2014**. Dispõe sobre os procedimentos administrativos físico e híbrido de ressarcimento ao SUS, previsto no art. 32 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e estabelece normas sobre o repasse dos valores recolhidos a título de ressarcimento ao SUS. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 28 nov. 2014 [citado 02 mar 2020]. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MjgyNw==>.

38 – _____. Supremo Tribunal Federal. **ADI n. 1931 DF / 0004171-82.1998.1.00.0000**. [Internet]. 7 fev 2018. Relator Ministro Marco Aurélio. [citado 02 mar 2019]. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314542313&ext=.pdf>.

39 – _____. Supremo Tribunal Federal. **RE 597.064 RJ**. [Internet]. 7 fev 2018. Relator Ministro Marco Aurélio. [citado 02 mar 2019]. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14817081>.

40 - Agência Nacional de Saúde Suplementar (BR). **Aspectos financeiros do Ressarcimento ao SUS: orientações sobre os procedimentos de cobrança** [Internet]. Rio de Janeiro: ANS; 2017. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/cartilha_aspectos_financeiros_do_ressarcimento_ao_sus.pdf.

41 – Governo do Estado de São Paulo (BR). Tribunal de Justiça. 5ª Câmara de Direito Público. **Autos n.º 1012823-08.2018.8.26.0309**. Acórdão. [Internet]. Desembargador Relator Maria Laura Tavares. [citado 2 mar 2020]; Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal>.

42 – Brasil. **Lei Federal n. 12.401, de 28 de abril de 2011**. Altera a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. [Internet]. [citado 28 fev 2020]. Brasília, Diário Oficial da União; 29 abr. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12401.htm.

43 – _____. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 29 set 2017. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html.

44 – Ministério da Saúde (BR). **Programa Farmácia Popular do Brasil: Estabelecimentos Credenciados no Estado de Minas Gerais** [Internet]. Brasília, Ministério da Saúde; 22 jan. 2020. [citado em 03 fev 2020]. Disponível em <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/23/MG.pdf>.

45 - Conselho Nacional de Justiça (BR). **Enunciado Interpretativo n. 94. In: Jornada de Direito da Saúde, 1, 15 maio 2014**. [Internet]. São Paulo; 15 maio 2014. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2014/03/ENUNCIADOS_APROVADOS.

46 - Brasil. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010**. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. [Internet]. Brasília, Diário Oficial da União; 1 dez 2010. [citado 17 fev 2020]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=156>.

47 - Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (BR). Tribunal de Justiça. **Portaria Conjunta n. 539, de 08 de agosto de 2016**. Instala o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Divinópolis [Internet]. Belo Horizonte, Diário da Justiça; 12 ago. 2016 [citado em 17 fev 2020]. Disponível em: <https://eadensino.hcor.com.br/lms/#/aula/16123/c/8411>.

48 - Becker D. TJGO inaugura primeiro CEJUSC do Brasil exclusivo para demandas de saúde. [Internet]. Agência de Notícias do Tribunal de Justiça de Goiás. Goiânia, 5 set 2019. [citado 02 mar 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/17-tribunal/18143-tj-de-goias-inaugura-primeiro-cejusc-do-brasil-exclusivo-para-demandas-de-saude>.

49 - Brasil. **Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n.º 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997. [Internet]. [citado 19 fev 2020]. Brasília, Diário Oficial da União; 29 jun. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm.

50 - Correia BSS, Spuch R. **Primeira câmara de resolução de conflitos administrativos precisa de imparcialidade**. [Internet]. Consultor Jurídico. 15 fev 2019. [citado 19 fev 2020]. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/opinioao-mg-cria-camara-resolucao-conflitos-administrativos>.

51 - Governo do Estado de Minas Gerais (BR). **Lei Estadual n. 23.172, de 20 de dezembro de 2018**. Autoriza a Advocacia-Geral do Estado a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto nos casos que especifica e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. [Internet]. [citado 19 fev 2020]. Belo Horizonte, Diário Oficial do Estado, 21 dez 2018. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2018&num=23172&tipo=LEI>.



Município do Rio de Janeiro: Estratégias para o enfrentamento à judicialização de procedimentos cirúrgicos

Antonio Julio Dias Junior¹

Érlin Rasniévski²

José Alfredo Curado Fleury Júnior³

Larissa Maria Kerber⁴

Lidia Maria Dantas⁵

Marcus Senna Calumby⁶

Orientadora: Profa. MSc Gisele de Jesus Silva

O presente estudo, cujos resultados estão aqui publicados, foi realizado mediante pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, porém, com olhar quantitativo no que diz respeito à interpretação dos dados e achados junto às fontes oficiais de busca no *site* do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/>. Teve a finalidade de descrever o perfil da judicialização dos procedimentos cirúrgicos no Estado do Rio de Janeiro.

¹ Graduado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira. Assessor jurídico do COSEMS-RJ e do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Fundação Municipal de Saúde de Niterói-RJ.

² Graduada em Direito pela Unesc-Faculdades Integradas de Cacoal. Controladora Geral na Prefeitura do Município de São Francisco do Guaporé-RO.

³ Graduado em Direito pela UniEvangélica-GO. Secretário Municipal de Saúde de Ceres-GO.

⁴ Graduada em Direito pela UNISC-RS. Assessora Jurídica da SMS de Alegre-RS e representante da Secretaria no Comitê Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul do CNJ.

⁵ Graduada em Pedagogia pela FAEPI. Agente de saúde pública do município de Tenente Laurentino Cruz-RN.

⁶ Graduado em Direito pela UFRJ. Superintendente de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Saúde do Tocantins.

Para melhor curadoria dos achados com foco no município, foi realizada nova busca juntamente ao Departamento de Informações Gerenciais da Prestação Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (DEIGE-DICOL), responsável por gerenciar os dados estatísticos do TJRJ.

Para otimizar a pesquisa, foi definida a palavra-chave “procedimento cirúrgico”, a partir da qual chegou-se aos códigos de cadastramento dentro do tribunal, para a delimitação dos processos do Município do Rio de Janeiro e suas regionais.

Foram analisadas 300 decisões nos anos 2016 a 2018, relativamente aos julgados em primeira instância, com pedido de procedimentos cirúrgicos, em um universo geral, sem identificar qual tipo de procedimento. Todavia, nessa primeira busca, foram encontrados 3.938 processos que tinham como polo passivo o estado, o que tornou a busca mais complexa. Não foram contemplados nas análises os processos em desfavor da Fazenda Pública do estado.

Foi realizado um recorte temporal, no período de 2016 a 2018, com foco nos processos de competência cível, utilizando a palavra-chave “Procedimento Cirúrgico” para triagem e qualificação.

Por fim, foi realizada a organização, consolidação e análise dos achados, estruturando os dados em planilhas, e apresentando-os em forma de gráficos, propiciando uma identificação das demandas judiciais, a fim de oferecer um diagnóstico da situação da judicialização da saúde no Município do Rio de Janeiro-RJ, nos anos 2016 a 2018 relativos à pesquisa direcionada para demandas por procedimentos cirúrgicos.

Diagnóstico da judicialização no município

O município do Rio de Janeiro, atualmente (2019), enfrenta uma crise histórica na saúde. Conforme os gráficos demonstram, o número de demandas judiciais para procedimentos cirúrgicos cresce exponencialmente.

Ao buscar informações para a quantificação das ações deparou-se com diversos impasses, devido não haver controle (quantificação específica) das ações judiciais pela

Prefeitura do Rio de Janeiro. Por intermédio de contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e em pesquisas no respectivo *site* pode-se verificar informações relevantes referentes à judicialização da saúde no município.

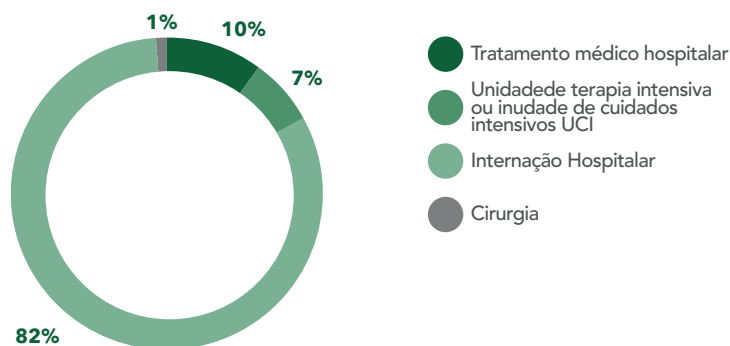
Observou-se que a judicialização tornou-se porta de entrada ao pedido de procedimento cirúrgico, mesmo porque a medida judicial tende a individualizar a solicitação que, por sua vez, se sobrepõe à coletividade, levando os pacientes a procurar a via judicial para obter o procedimento.

A transparência na lista de espera para estes procedimentos cirúrgicos, proporcionariam ao magistrado um olhar qualificado e com mais informações, pois sendo o principal pedido o de internação hospitalar, medida identificada nos pedidos com urgência, a via judicial passou a ser um meio para garantir o acesso tornando-se porta de entrada ao procedimento cirúrgico.

Os números de processos distribuídos no Município do Rio de Janeiro, entre os anos de 2016 e 2018 foram quantificados por meio de material pesquisado e pode-se identificar uma quantidade expressiva de processos. Dessa forma foram selecionados 300 processos para serem analisados, não houve acesso a inicial, somente à decisão final.

Em seguida foi aplicado o filtro “procedimento cirúrgico”, nos processos referentes aos anos citados, fazendo assim essa seleção de 300 processos a serem ponderados, excluídos os que não tinham como polo o município do Rio de Janeiro e os que não envolviam procedimentos cirúrgicos, sendo todos da justiça comum.

FIGURA 1. Análise de 300 processos referente aos anos de 2016-2018 no município.



Fonte: DEIGE-DICOL⁷. Dados organizados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A Figura 1 esboça os quatro assuntos delimitados dentro do tema principal deste trabalho, procedimentos cirúrgicos e quantificação dentro dos anos de 2016 e 2018.

Foram analisados quatro tipos de pedidos no âmbito do Poder Judiciário no Município do Rio de Janeiro em desfavor do SUS. Não foi debruçado em tipo específico de procedimento cirúrgico, por conseguinte conforme Figura anterior, os maiores pedidos foram para internações hospitalares, tendo em vista que levam o paciente ao procedimento cirúrgico, conforme se observou nas ações analisadas. Ou seja, a porta de entrada para o procedimento cirúrgico foi a da internação hospitalar.

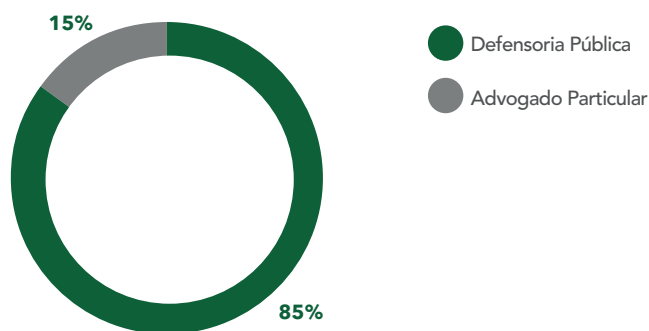
Em virtude do grande número de ações do Município do Rio de Janeiro, foi realizado um recorte de 300 ações para que se pudesse auferir um quantitativo de representação nestas ações.

A Figura 2 mostra que, em relação à representação do autor, 85% dos pedidos de cirurgia ocorreram pela Defensoria Pública do Estado. As ações pleiteadas em sua maioria são de obrigação de fazer⁸, com pedido para que o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro participem solidariamente como réus na ação.

⁷ Departamento de Informações Gerenciais da Prestação Jurisdicional – DEIGE- Instituído pela Resolução TJ/OE n.º 1/2017 que organiza o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

⁸ A obrigação de fazer consiste no comprometimento do devedor em realizar, praticar algum ato que resulte num benefício ao credor.

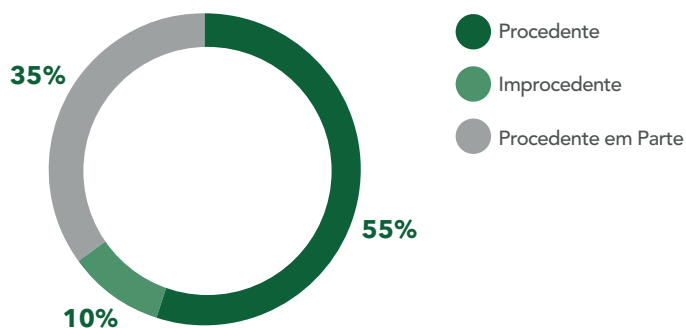
FIGURA 2. Representação do autor/paciente referente à decisão judicial sobre pedidos de cirurgias aos anos de 2016 a 2018 no município do Rio de Janeiro.



Fonte: Consulta Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em análise da Figura 3, é possível identificar que a maior parte das decisões judiciais foi pela procedência dos pedidos, ou seja, as decisões judiciais foram francamente favoráveis aos autores/pacientes que buscavam o Poder Judiciário em 55% dos casos, somente 10% dos pedidos foram indeferidos e 35% dos pedidos foram deferidos parcialmente.

FIGURA 3. Porcentagem de sentenças judiciais nos anos de 2016-2018 do município.



Fonte: Consulta Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os gráficos demonstram que a justiça se tornou uma porta de entrada para o SUS, pois há uma tendência para procedência da ação.

Pode-se observar que as medidas legais tendem a expressar uma das estratégias para manifestar a cidadania. As demandas dos usuários são ouvidas e atendidas suas necessidades e expectativas, que nem sempre são bem-vindas no contato com os serviços de saúde. As decisões judiciais tornam-se expressão da voz e do poder do cidadão sobre sua saúde, que nem sempre são aceitas em ambientes onde a hegemonia dos profissionais de saúde prevalece na condução de casos clínicos. Essas divergências e incompatibilidades, às vezes mediadas pela comunicação precária, são terreno fértil para a disseminação de ações judiciais em saúde (1).

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, constante representante de autores nas demandas sobre saúde, desenvolveu um projeto denominado “Construindo o SUS com a Defensoria Pública”, que por meio de da Câmara de Resolução de Litígio em Saúde Pública, diminuiu em 50% dos casos recebidos na câmara de litígios da Capital, sendo resolvidos na esfera administrativa. Proporcionando um fácil acesso ao assistido que necessita de auxílio. Em conjunto com a câmara de resolução de litígios, o município do Rio de Janeiro tem resolvido suas questões na esfera extrajudicial (2).

O Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde do Rio de Janeiro (NATJUS/RJ), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde/SES, foi criado em 2009, para subsidiar tecnicamente os magistrados da Comarca da Capital nas ações judiciais que envolvem fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, alimentos e tratamentos médicos. Surgiu com base em projeto piloto em apenas duas Varas de Fazenda Pública da Capital e, posteriormente, graças a seu sucesso, foi ampliado para todas as Varas de Fazenda da Capital, para todas as Câmaras Cíveis e para a Justiça Federal (3).

Tem uma composição multidisciplinar (médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas) determinada pelo acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Seção Judiciária do Rio de Janeiro composta por técnicos da área da saúde indicados pela Secretaria Estadual de Saúde. Tem a função de subsidiar os magistrados, por meio de parecer técnico, nas ações relativas à área de saúde propostas em face do Poder Público (3).

A respeito das questões técnicas que envolvem tratamentos médicos, O NAT baseia sua atuação em dois pilares fundamentais: celeridade e imparcialidade. Os pareceres são dados no prazo máximo de 72 horas na Justiça Federal e quando há hipótese de urgência, o magistrado pode solicitar que esse prazo seja reduzido (3).

Além disso, os técnicos do NAT, apesar de, em sua grande maioria, terem sido cedidos da Secretaria de Estado de Saúde, têm a plena consciência que eles exercem um papel puramente técnico e de auxílio ao magistrado. Logo, eles possuem total independência para efetuar pareceres favoráveis ou contrários ao interesse do autor ou do(s) réu(s) (3).

O NAT-Justiça Federal visa a subsidiar os magistrados federais do Estado do Rio de Janeiro, para análise de pedidos de liminar, com informações técnico-normativas sobre pedidos de medicamentos, insumos para saúde, alimentos e tratamento médico, bem como em pedidos de internação, situação em que o órgão atua como ponte com as centrais de regulação de leitos (3).

Nos casos de ações com litisconsórcio entre município e estado do Rio de Janeiro, as defesas respeitam as competências constitucionais e os acordos ajustados em CIB (Comissão Intergestores Bipartite), bem como o município do Rio de Janeiro participa do Núcleo de Assessoria Técnica em ações de saúde, e se beneficia promovendo conversas com os atores sociais⁹, com o intuito de achar soluções administrativas para o atendimento aos cidadãos sem infringir os princípios do SUS e evitar judicialização.

Criada em setembro de 2013, a CRLS é o resultado da aproximação institucional entre as Procuradorias do Estado e do Município do Rio de Janeiro, Secretarias do

⁹ Atores sociais são os indivíduos (usuários, trabalhadores do SUS, gestores) ou coletivos (instituições, órgãos, comunidades, equipes de trabalho etc.) que participam, de forma organizada, dos processos de gestão, interferindo técnica, política ou eticamente no planejamento e monitoramento da saúde pública.

Estado e do Município e Defensorias Públicas. Um projeto de cooperação que reúne as Procuradorias Gerais do Estado e do Município do Rio de Janeiro, além das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, das Defensorias Públicas Estadual e da União, e o Tribunal de Justiça do Estado (3).

A Procuradoria Geral do Estado mantém procuradores para orientação da SES, coordenação e manutenção do espaço, um administrador e os contratos para realização de serviços de limpeza, copa e ascensorista. Já a Procuradoria Geral do Município mantém procuradores para orientação da Secretaria Municipal de Saúde (4).

A ideia é buscar soluções administrativas para o atendimento de cidadãos que precisam de medicamentos, exames, internações, tratamentos e transferências do Sistema Único de Saúde (SUS), evitando o ajuizamento de ações.

Funciona na Rua da Assembleia, 77-A, no Centro, das 10h às 15h. Na chegada, os assistidos passam por uma triagem para conferir se o caso, de fato, está relacionado à saúde. Em seguida, são recebidos por assistentes sociais que fazem o cadastro e definem se o atendimento será feito pela Defensoria Pública do Estado ou da União. É necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovantes de renda e residência, laudo ou receita médica atualizada (até 60 dias) e exames médicos pertinentes (se houver).

A Câmara recebe os pedidos por prestações sanitárias que são levados às Defensorias, para que as Secretarias de Saúde possam avaliar a disponibilidade no SUS, ou ainda uma alternativa para a oferta do tratamento. Em caso positivo, o paciente já sai, no mesmo dia, com uma guia de encaminhamento para a unidade de saúde onde receberá o atendimento. O órgão conta com uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais e médicos para elaborar pareceres técnicos, de acordo com o quadro clínico apresentado e os tratamentos solicitados (2).

Reunindo representantes das Defensorias Públicas da União e Estado e de Secretarias de Saúde, a CRLS tenta resolver administrativamente as demandas da área de Saúde para que elas não parem na Justiça (2).

De acordo com a Portaria GM/MS 1.559/2008 (5), os Complexos Reguladores ou Centrais de Regulação são a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso à assistência à saúde, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos:

III – Complexo Regulador Municipal: gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação. Cabe à União Federal: a) operacionalizar a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC; b) apoiar e monitorar a implementação e a operacionalização das Centrais Estaduais de Regulação da Alta Complexidade – CERAC; c) disponibilizar e apoiar a implantação, em todos os níveis de gestão do SUS, de sistemas de informação que operacionalizem as ações de regulação, controle, avaliação, cadastramento e programação.

Aos Municípios compete: a) operacionalizar o complexo regulador municipal e/ou participar em cogestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais; b) viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, provendo capacitação, ordenação de fluxo, aplicação de protocolos e informatização; c) coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e nacionais; d) regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos; e) garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada e integrada; f) atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade – CERAC; g) operar o Centro Regulador de Alta Complexidade Municipal conforme pactuação e atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade – CERAC; h) realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; i) realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde; j) contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e k) elaborar normas técnicas complementares às das esferas estadual e federal. (5).

Todavia, notou-se que cada vez mais se torna frequente o requerimento de leitos de internação, especialmente para procedimentos cirúrgicos. Observou-se que o sistema disponibiliza, de forma universal, os recursos, entretanto, não consegue atender as demandas em sua totalidade. Assim, essa representação do SUS parece influenciar a procura, pela via judicial, do hospital, dos leitos e procedimentos cirúrgicos, nem sempre disponíveis na rede pública de saúde (6).

O Núcleo de Regulação Avançada (NR) foi instituído em março de 2015, nas principais unidades hospitalares do Município do Rio de Janeiro, com objetivo principal de promover a organização do acesso aos leitos hospitalares e o atendimento de urgência e emergência da rede SUS na cidade. Embora lotados nas unidades hospitalares, estão sob a coordenação do Complexo Regulador (CR), atuando diretamente nas principais etapas do processo regulatório (7).

Os profissionais dos núcleos de regulação exercem atividades como manter o Censo Hospitalar da unidade na plataforma SMS Rio atualizado, monitorar o setor de emergência promovendo as internações de pacientes nos leitos livres da unidade e auxiliando na identificação de pacientes com indicação de transferência, discutir com os chefes de clínica possíveis transferências para hospitais de menor complexidade, liberando leitos para os casos graves, viabilizar a inserção, acompanhamento e atualização de laudos no SISREG e Sistema Estadual de Regulação (SER), promover a alta referenciada para a atenção primária, entre outros (7).

A Regulação de Internação foi instituída para dar acesso à internação aos usuários da rede SUS no âmbito do Município do Rio de Janeiro. A solicitação de internação é realizada ao Complexo Regulador (CR) por meio da inserção do laudo de solicitação no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) realizada pelas unidades da rede SUS (8).

A Regulação Médica analisa o laudo da unidade solicitante e, se houver informações adequadas à regulação no laudo da solicitação, o inclui na lista de prioridade para internação, na Plataforma Prioriza Internação disponível no *site* da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que é vinculado ao Sistema Nacional de Regulação (SISREG), o que otimiza o processo de regulação. Esta priorização se dá por especialidade e os laudos são ranqueados obedecendo a critérios clínicos e do tempo de solicitação. Os laudos que apresentam dados insuficientes são devolvidos pelo sistema para a unidade solicitante com as orientações necessárias para uma adequada regulação. Já os laudos em que seu conteúdo não justifique a internação ou contenham erros que impeçam a internação, são negados pela Regulação Médica com o motivo e/ou orientação necessária para reinserção (8).

No momento em que as vagas de internação são cedidas pelas Unidades por meio do Sistema de Leitos, os pacientes prioritários são internados no sistema. Este sistema, que é acessível 24 horas por dia pelas unidades solicitante e executante, exibe em tempo real a regulação do leito e informa, às unidades solicitantes e executantes sobre a internação realizada, por intermédio de e-mail automático (7).

As solicitações de alta complexidade nas especialidades de Oncologia, Hematologia, Ortopedia e Cardiologia são reguladas pela Central de Regulação Estadual, por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). As unidades da rede SUS têm acesso ao sistema e inserem estes laudos e exames complementares que justifiquem a solicitação.

As solicitações de internação da Atenção Primária de Saúde (Clínicas de Família e Centros Municipais de Saúde) são encaminhadas ao Complexo Regulador via e-mail. Estas solicitações são avaliadas pela regulação e quando priorizadas, são inseridas no SISREG para a regulação imediata.

O Setor de Mandados é responsável por apoiar as ações do complexo regulador, coordenando a elaboração das respostas dos mandados judiciais, de maneira que estes tenham efetividade em seu cumprimento e respeitem à Constituição Federal e toda a legislação brasileira. Nesse sentido, atuam em equipe multidisciplinar a fim de assessorar tecnicamente a regulação ambulatorial e hospitalar (7).

As determinações judiciais relacionadas à regulação ambulatorial são agendadas, cumpridas e respondidas por aquele setor, com o apoio do Setor de Mandados. Em caso de ordem de internação, os mandados judiciais são registrados no Sistema de Mandados, uma plataforma desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RIO). Trata-se de uma ferramenta tecnológica que faz a Gestão Eletrônica de Documentos (GED) e estabelece um *workflow* entre os médicos do setor de internação, permitindo que o fluxo de trabalho não seja interrompido na troca de plantão. Assim, é garantido o controle das demandas judiciais, por meio da evolução clínica dos pacientes e do acompanhamento do caso até o cumprimento efetivo da ordem judicial. Uma vez cumprida a ordem judicial, as respostas aos mandados de internação são respondidas pela equipe do Setor de Mandados, (7). Além dos mandados, o setor

também é responsável pela resposta às demandas do Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) e demais ofícios relacionados com a internação (7).

A criação dessa estrutura voltada ao atendimento de comandos judiciais seja no que diz respeito ao fornecimento de informações aos órgãos de controle seja quanto ao agendamento de procedimentos cirúrgicos, embora voltada a evitar sanções processuais à gestores e à propiciar maior agilidade no atendimento a obrigações de fazer, acaba por institucionalizar ou materializar um dos maiores impactos da judicialização da saúde, que é a inversão da ordem de acesso daquele que obteve o amparo judicial perante o usuário que aguarda sua posição nas filas da regulação, uma violação clara à equidade no tratamento dos usuários do Sistema Único de Saúde. Esta situação aumenta a importância dos diálogos institucionais como ferramenta para mitigar a excessiva judicialização da saúde materializados como Política por meio da recomendação n.º 31 de 30 de março de 2010 editada pelo Conselho Nacional de Justiça e dirigida aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais sugerindo a adoção de medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados e os demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência da solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde (9).

Como efeitos decorrentes da preocupação com os diálogos institucionais, pode-se citar a criação pelo Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da resolução CNJ n.º 107 de 06 de abril de 2010, do Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, composto por magistrados, membros do Ministério Público Estadual/Distrital e Federal, das Defensorias Públicas, da Ordem dos Advogados do Brasil e de universidades e outras instituições de pesquisa; a criação, em atendimento a recomendação CNJ n.º 36 de 12 de julho de 2011, dos Núcleos de Assessoramento Técnico (NATs), órgão consultivo composto por profissionais de saúde capazes de subsidiar os julgadores na tomada de decisões em processos judiciais envolvendo a assistência ao usuário; a criação das Jornadas de direito à saúde, por meio de da Portaria CNJ n.º 40 de 25 de março de 2014, visando ampliar as discussões institucionais e o conhecimento sobre a temática, sendo este fórum de discussão responsável pela edição de enunciados norteadores à decisão de magistrados e à atu-

ação dos operadores do Direito, com nítida preocupação quanto a preponderância do número de ações individuais sobre as coletivas, circunstância facilitadora ao desrespeito ao tratamento equânime do usuário do SUS no acesso à assistência (8).

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS foi criada pela Lei 12.401 de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS), tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde (MS) nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) (6).

Tendo em vista maior agilidade, transparência e eficiência na análise dos processos de incorporação de tecnologias, a nova legislação fixa o prazo de 180 dias (prorrogáveis por mais 90 dias) para a tomada de decisão, bem como inclui a análise baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes. A lei ainda estabelece a exigência do registro prévio do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para que este possa ser avaliado para a incorporação no SUS (6).

A grave situação vivida nos últimos anos no município do Rio de Janeiro no setor da saúde é amplamente divulgada e corroborada a falta de leito. A judicialização se tornou uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde, para a real eficácia das necessidades da população em geral que buscam vaga para realização de procedimento cirúrgico.

Com relação ao problema do procedimento cirúrgico, as estratégias elaboradas para diagnóstico e enfrentamento foram:

- a. Identificação e contratação de sistema informatizado para gestão da regulação de leitos, com total transparência nas listas de espera;
- b. Aproximação da gestão ao Judiciário para demonstração transparente do cenário e proposição de alternativas ao enfrentamento à judicialização, com adesão e valorização ao NatJus e da Câmara de Conciliação em Saúde;

É de suma importância a transparência nas listas de espera, pois os leitos deverão ser conferidos de maneira *on-line* pela regulação, que poderá cobrar dos seus colaboradores metas quantitativas e qualitativas como principal resultado, reduzindo filas de espera.

Faz-se necessário desenvolver um sistema informatizado eficiente. Para atender tal necessidade, a equipe de Tecnologia da Informação está disponível no município ou contratando empresa especializada. Além do desenvolvimento do sistema, é necessário que se proceda à aquisição de equipamentos de informática necessários à instalação em todos os setores que ficarão responsáveis pelo cadastramento dos dados.

É oportuno registrar a aproximação da gestão ao judiciário, tendo em vista que as decisões pautadas em conjunto com uma equipe que possa respaldar tecnicamente o magistrado ou até mesmo buscar soluções administrativas junto às câmaras de conciliação evitando o ajuizamento de ações.

Considerações Finais

No curso do trabalho, alguns dados relevantes foram demonstrativos da gestão dos leitos hospitalares, num cenário de escassez como fator determinante ao sucesso ou fracasso de uma política de acesso do usuário à realização do procedimento cirúrgico, sejam os de urgência/emergência, sejam os eletivos.

Verificou-se que, embora dotado de uma rede robusta e complexa de unidades hospitalares, com a participação municipal, estadual e até federal, unidades de referência em especialidades ainda continuam com déficit de leitos hospitalares.

Notou-se a redução de recursos humanos que levou o município a experimentar significativa redução do número de leitos de internação e crise de abastecimento no município.

Mereceu atenção o fato que, embora demonstre uma redução no volume de atendimentos de urgência e emergência nos principais hospitais municipais, isso não representa a diminuição da demanda de atendimentos de pronto socorro, sendo reflexo,

.....

isso sim, da mudança da política de saúde no Rio de Janeiro, com a incorporação de um bom número de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A razão do aumento nos atendimentos de emergência/urgência em dados gerais, seja pelo crescimento da população, seja pela migração de usuários de planos privados para o sistema público de saúde, seja em razão da melhoria das condições de acesso a veículos automotores como motocicletas e automóveis, responsável pelo aumento de números de acidentes e das urgências ortopédicas em que pese o esforço legislativo gerador do recrudescimento das sanções aplicadas às infrações de trânsito.

Tratando-se o Município do Rio de Janeiro de um ente com gestão plena, responsável tanto pela baixa, quanto pela média e alta complexidade, por causa do grande volume de urgências/emergências, as dificuldades de abastecimento e de gestão das unidades, a redução do número de leitos de internação, associados a pequena capacidade de investimento do município foram determinantes ao incremento do número de ações judiciais envolvendo a realização de cirurgias. Isso porque, no cenário de escassez, o ente público acaba por dedicar-se à realização de cirurgias de emergência/urgência por envolverem situações de maior risco ao paciente, necessitando de atenção imediata. Por outro lado, a falta de materiais, equipamentos e leitos, prejudicam a convocação em tempo razoável dos pacientes cadastrados na regulação para a realização de procedimentos cirúrgicos de natureza eletiva.

O aumento do tempo de espera leva ao crescimento também do número de demandas judiciais que, como consectário, desequilibra a equidade entre aqueles que buscam o Judiciário e os que não ajuízam demandas judiciais, determinando uma classe de privilegiados que não pode existir nem ser aceita.

Nesse sentido, o que se propõe, é a melhora na qualidade de gestão dos leitos públicos, ao mesmo tempo que haja uma maior eficiência na rotatividade dos pacientes, com a redução do tempo de internação, tende a potencializar a capacidade das estruturas públicas já existentes ao enfrentamento das demandas de cirurgias na regulação.

Importa ainda à gestão, a manutenção de um diálogo transparente e franco perante o Judiciário e aos órgãos de controle, dentre eles o Conselho Estadual de Saúde, que deve ser envolvido na discussão das estratégias de enfrentamento ao problema, mesmo

.....

porque é a instância que apreciará a eventual celebração de convênios com entidades filantrópicas e/ou o credenciamento de unidades privadas capazes de aumentar o potencial de disponibilização de leitos de internação que sirvam à assistência e à retaguarda cirúrgica.

No mesmo sentido, é necessária a aproximação ao Legislativo a fim de propor a destinação de emendas parlamentares para o custeio da saúde, permitindo assim adoção de programas de incentivo às equipes para a realização de cirurgias fora de sua carga horária como forma de ampliar também a força de trabalho, ou até mesmo para viabilizar o abastecimento de itens necessários ao incremento do número de cirurgias realizadas.

Viabilizar alternativas para aumento da produção hospitalar, é fundamental a adesão e valorização a alternativas de solução de conflitos ainda na via administrativa, como por meio da Câmara de Conciliação. Necessário também a demonstração transparente do cenário, sensibilizando o Judiciário na aplicação esmerada da Jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores acerca do acesso e do necessário respeito à repartição das competências entre os entes federativos no SUS, e ainda, à equidade no tratamento dos usuários a fim de evitar a concessão de privilégios judiciais à demandantes ante os usuários que aguardam pelo atendimento a procedimentos cirúrgicos.

As medidas identificadas neste trabalho não são fáceis de serem implementadas, demandando resiliência por parte dos gestores e a busca de apoio juntamente a outros atores envolvidos na temática da saúde, mas são viáveis e ajustadas ao aumento do potencial de produção e à melhora na rotatividade dos leitos públicos, dois dos indicadores mais importantes para o resultado almejado com este trabalho, a redução no tempo de acesso ao procedimento cirúrgico.

Conclui-se que, por mais que se consiga reduzir a judicialização, ela nunca será zerada. Sempre que alguma pessoa se sentir insatisfeita com uma solução administrativa do seu caso, esta vai acessar o poder judiciário para questioná-lo. E é apropriado, pois a saúde é um direito e a judicialização é um instrumento democrático.

Referências

- 1 – Ramos RS, Gomes AMT, Oliveira DC, Marques SC, Spindola T, Nogueira VPF. **Access the Unified Health System actions and services from the perspective of judicialization.** Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016;24:e2797. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689>.
- 2 – Rio de Janeiro (Estado). **Câmara de resolução de litígios** [internet]. 2020. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/28268-camara-de-resolucao-de-litigios-de-saude-recebe-visita-de-comitativa-do-estado-da-bahia.html>.
- 3 – Rio de Janeiro (Estado). **Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde do Rio de Janeiro** [internet]. 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6323928>.
- 4 – Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro. **Conheça a procuradoria** [internet]. 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/pgm/conheca-a-procuradoria>.
- 5 – Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria n.º 1.559, de 1 de agosto de 2008.** Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS [internet]. Brasília, 1 ago. 2008. [citado em 16 dez 2019]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html.
- 6 – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC. **Entenda a Conitec 2** [internet]. 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://conitec.gov.br/entenda-a-conitec-2>.
- 7 – Rio de Janeiro (Estado). **Regulação de leitos** [internet]. 2019. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.informacaoemsaude.rj.gov.br/contatos/23-central-estadual-de-regulacao.html>.
- 8 – Rio de Janeiro (Município). **Complexo Regulador Secretaria Municipal de Saúde** [internet]. 2017. [citado em 27 jan. 2020]. Disponível em: <http://complexoreguladorsmsrio.blogspot.com/2017/05/central-de-regulacao-de-internacao.html>.
- 9 – Macedo, de Batalini Maiara. **A judicialização da saúde pública e o diálogo institucional como garantia de equidade social.** 2016. Rev. Revista Cidadania e Acesso à Justiça, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-026X/2016.v2i1.352>.



A judicialização medicamentosa no município de Vila Velha-ES no ano de 2018

Bárbara Florêncio¹

Eloise Fragnani Medeiros²

Maria Ermínia Ciliberti³

Paulo Roberto da Silva Abrahao⁴

Sabrina Nascimento de Freitas⁵

Orientadora: Profa. MSc. Cássia de Fátima Rangel Fernandes

A escolha do município de Vila Velha, se baseou no fato do grande aumento do fenômeno da judicialização da saúde, na quantidade de habitantes, na possibilidade de acesso às informações e por ser o segundo município do Estado do Espírito Santo, com o maior número de demandas judiciais na área da saúde.

O projeto de intervenção teve como segmento a análise de dados da judicialização da saúde no município de Vila Velha-ES, com foco nas ações judiciais referentes a medicamentos, no ano de 2018.

Para obtenção dos processos de judicialização da saúde foi realizada consulta junto à Procuradoria Geral do Município, que forneceu planilha contendo os processos ajuí-

¹ Graduada pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida. Chefe de Gabinete e Assessora Jurídica do Gabinete da SMS de Caruaru-PE.

² Graduada em farmácia-bioquímica, formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Farmacêutica da Prefeitura Municipal de Tubarão-SC.

³ Graduada pela PUC-SP. Assessora do COSEMS-SP.

⁴ Graduado em direito e farmácia pela UFPR. Secretaria de Estado da Saúde-PR.

⁵ Graduada em Direito pela FAESA. Assessora Jurídica do COSEMS-ES. .

zados em face do município, no período de 2015 a 2018. Após a análise preliminar dos dados, foi feito o recorte das ações impetradas no ano de 2018 e, dentre esses processos, foram identificados os pedidos de medicamentos, objeto do estudo.

Foram consultados 45 processos judiciais constantes na planilha, cujo pleito fosse por medicamentos. A consulta foi realizada no sistema PROJUDI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, e adotado pelos tribunais de justiça dos estados federados.

Na consulta individualizada foram identificadas as seguintes informações: a) tipo de ação, b) parte autora, c) forma de representação (advogado particular, Ministério Público, Defensoria Pública e advogando em causa própria nos juizados especiais), d) parte requerida, e) pedido/objeto da ação, f) decisão liminar/tutela de urgência, g) sentença, h) fase processual e i) classificação do medicamento solicitado se está ou não padronizado pela RENAME e REMUME.

Após esta etapa foi construído o diagnóstico da situação da judicialização da saúde no município, em relação ao fornecimento de medicamentos e propostas medidas para o seu enfrentamento.

Diagnóstico da judicialização no município

O direito à saúde não é apenas um direito social previsto na Constituição Federal como os demais, sua previsão é regulamentada por um conjunto de artigos que apresentam os nortes gerais de como deve funcionar sua prestação de serviço, tanto como política pública, como na oferta privada. O tema da saúde, por estar diretamente ligado com prestação de serviços à população e por envolver recursos financeiros limitados, gera frequentes embates políticos e judiciais, uma vez a situação do país (1). Neste contexto, foi essencial o diagnóstico da judicialização da saúde, no âmbito do SUS, para entender seu impacto na implementação das políticas públicas, bem como para definir estratégias para seu enfrentamento.

A Assistência Farmacêutica (AF) judicializada é um dos grandes desafios da administração pública nas três esferas de governo, porque envolve a compra pública de itens diversificados. Além do impacto aos cofres públicos, a compra pública para a

assistência farmacêutica judicializada esbarra ainda na dificuldade da aquisição de um medicamento para um único paciente. Geralmente, as compras da REMUME são realizadas para um número grande de pacientes. A prestação jurisdicional de medicamentos judicializados drena cada vez mais o orçamento anual da AF municipal, estadual e federal, frente às decisões judiciais que chegam à administração pública, exigindo, por vezes, o fornecimento de medicamentos não padronizados para determinada patologia. A judicialização de medicamentos é um grande debate no contencioso judicial e é um dos principais temas das decisões judiciais nos Tribunais Superiores como o STF e STJ.

A Tabela 1 apresenta 1501 processos identificados, estratificados por ano, demonstrando um aumento de 24.7% (76 processos), no ano de 2018, em relação ao número de processos do ano anterior, e, um aumento de 44% (136 processos) nas demandas judiciais ajuizadas em face do município, em comparação ao ano de 2015.

TABELA 1. Dados dos processos judiciais do município de Vila Velha de 2015 a 2018.

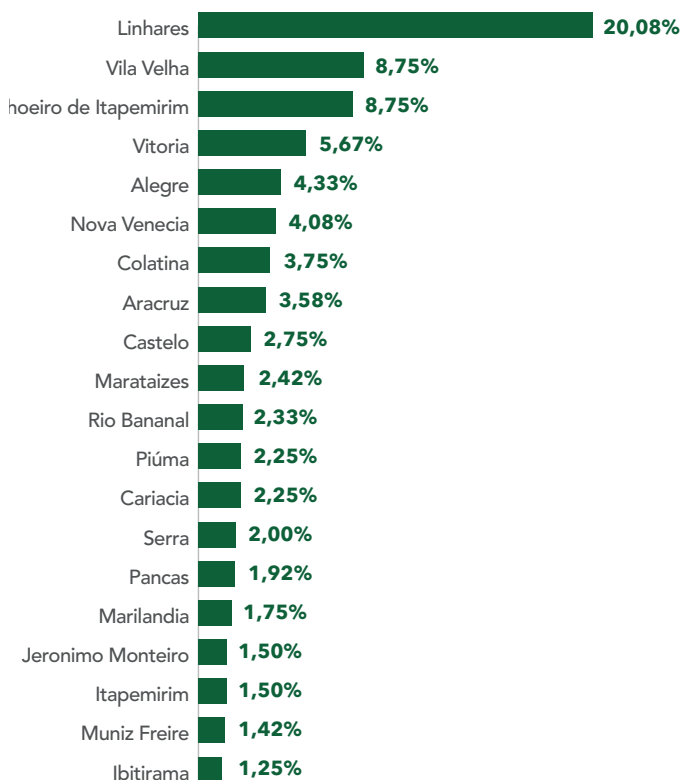
ANO	TOTAL DE AÇÕES
2015	308
2016	381
2017	368
2018	444
Total	1.501

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da análise dos processos fornecidos pela Procuradoria Geral de Vila Velha-ES.

Todas as ações propostas contra o município de Vila Velha são solidárias no polo passivo ao Estado do Espírito Santo.

Em relação ao ano de 2018, dentre todos os municípios do estado, Vila Velha aparece como segundo colocado no cenário da judicialização em saúde no estado (Figura 1) (2).

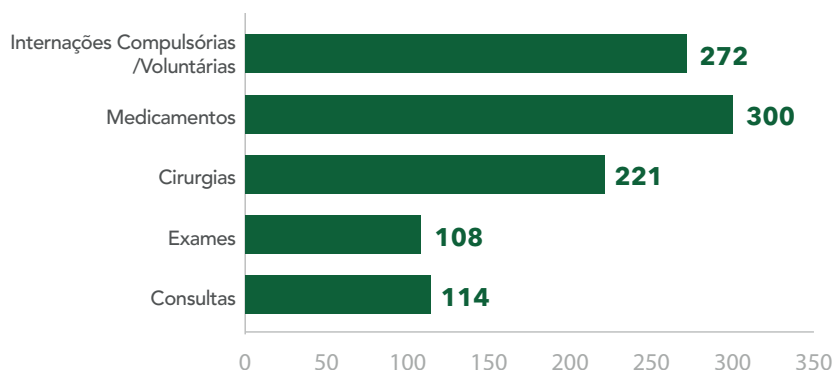
FIGURA 1. Indicadores de demanda judicial no estado do Espírito Santo, no ano de 2018.



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Disponível em: <https://farmaciacidade.es.gov.br/Media>.

Dado interessante e que merece destaque é que, considerando o somatório das ações judiciais dos anos de 2015 a 2018, o fornecimento de medicamento é o que possui a maior dificuldade de execução perante outras demandas que também estão ganhando força, como por exemplo, o fornecimento de fraldas, a realização de cirurgias e as internações compulsória/voluntária. Os itens em saúde como internações, cirurgias, exames e consultas possuem maior facilidade e celeridade de execução porque são serviços já prestados na rotina dos serviços do SUS. O fornecimento de medicamentos implica na compra pública regida por legislação própria para a aquisição do bem.

FIGURA 2. Distribuição por tipo de objeto, das principais ações judiciais de 2015 a 2018.



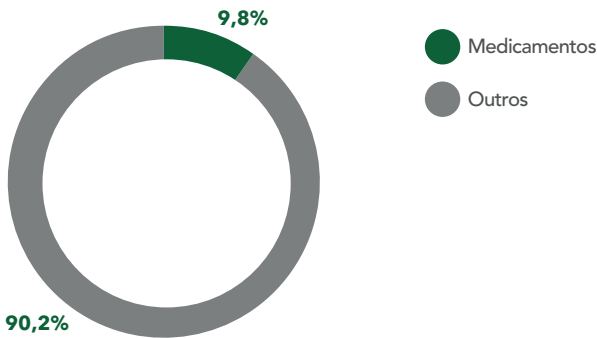
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir da análise dos processos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município de Vila Velha-ES.

Não houve o fornecimento pelo município dos dados das ações judiciais com objeto de fornecimento de fraldas durante o recorte temporal analisado, não podendo este ser incluído na Figura 2.

Segundo a Procuradoria do Município de Vila Velha, durante o ano de 2018, foram movidas em face da Prefeitura de Vila Velha um total de 444 ações com objeto de acesso à saúde. Dos processos ingressados pleiteando objetos da esfera da saúde, 45 ações possuem como objetivo o fornecimento de medicamentos, tramitando 41 ações na Justiça Estadual, das quais três tramitam em segredo de justiça, não sendo possível colher maiores informações e 4 ações declinadas à Justiça Federal.

A Figura 3 apresenta o comparativo das ações com pedidos de medicamentos (3) em relação às demais ações que compõem o rol dos 444 processos referente à judicialização da saúde, no município de Vila Velha, no ano de 2018.

FIGURA 3. Comparativo do número de processos de medicamentos versus outras demandas judicializadas em 2018.



Fonte: Gráfico elaborado pelos autores, baseado em informações da Procuradoria Geral do município de Vila Velha-ES.

Pode-se resumir as principais demandas judiciais da área de saúde no município de Vila Velha, no ano de 2018, da seguinte forma:

TABELA 2. Dados das principais demandas judiciais do município de Vila Velha em 2018.

PEDIDO	N.º DE AÇÕES	%
Fornecimento de Fraldas	103	23,1%
Cirurgias	91	20,4%
Internação Compulsória/Voluntária	83	18,6%
Consultas	53	11,9%
Medicamentos	45	9,8%
Internação em UTI	36	8,1%
Exames	33	7,4%

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir da análise dos processos fornecidos pela Procuradoria Geral do município de Vila Velha-ES.

Como se pode verificar pelos dados da Tabela 2, as demandas judiciais do município de Vila Velha são variadas. Em primeiro lugar, no ano de 2018, temos o fornecimento de fraldas. A judicialização do fornecimento de fraldas chegou a ser avaliada pelo grupo para ser o recorte do trabalho, vez que está aumentando de forma gradativa e existe a problemática de administração do estoque, pelo volume do material, porém optou-se por não escolher este recorte, por ainda possuir debates judiciais e sanitários quanto à possibilidade de fornecimento de fraldas com verba do SUS.

Merece destaque também o crescente número das demandas judiciais de internação compulsória/voluntária, que também geram um ônus relevante para o município, vez o alto valor dos tratamentos de internações.

Em relação às demandas judiciais de consultas, cirurgias, internação em UTI e exames, se está diante do número insuficiente de procedimentos e/ou leitos e da população, tanto originária como flutuante do município de Vila Velha. Na análise da rede de saúde do município é perceptível que pela proximidade com a capital Vitória, a rede municipal acaba por não ter oferta suficiente para sua população.

No entanto, o recorte de medicamentos foi escolhido em virtude do alto custo que gera para o município e pela solidariedade existente entre os entes públicos no Sistema Único de Saúde, vez que em análise dos 45 processos de medicamentos, temos a solidariedade figurando em todos eles e por muitas vezes chamando o município para uma lide que não seria de sua complexidade. Os medicamentos mais buscados na demanda judicial são os das especialidades médicas da endocrinologia, cardiologia e psiquiatria (antidiabéticos, anticoagulantes e controlados).

Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, além da questão da solidariedade, foi informado que as ações judiciais na área da saúde mais onerosas ao município estão relacionadas à Assistência Farmacêutica (AF), ou seja, acesso aos medicamentos que não estão disponíveis na rede pública, seja em razão da: falta de estoque; falta de padronização na RENAME ou na REMUME; ausência de registro no país; ausência de comprovação científica de eficácia, entre outras razões que levam à judicialização.

Um dos motivos pelos quais o valor das ações buscando o fornecimento de medicamentos ser maior deriva de prescrições originadas do serviço privado, o que leva a afirmar a existência de um público misto, capaz de custear consultas e eventuais exames, mas recorre ao SUS para a obtenção dos medicamentos (4).

Os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Vila Velha demonstram que 52% das ações judiciais movidas em face do município para fornecimento de medicamentos são oriundos da rede privada e que tal fato acontece rotineiramente pela condição financeira da população de Vila Velha, que consegue arcar com plano de saúde ou ter sua consulta no particular, mas que procura o Sistema Único de Saúde para fornecimento de medicamentos pelo alto valor desses.

Representação do autor/paciente

O direito à saúde está previsto na Constituição Federal de 1988 como um direito social, e, portanto, um direito fundamental de segunda dimensão. Foi apenas com o advento da Carta Magna vigente que o direito à saúde passa a ser um direito fundamental, estando no rol das cláusulas pétreas e que não pode ser suprimido, sendo para muitos juristas o direito humano mais importante e que possui caráter universal, essencial e inafastável (5).

A democracia brasileira permite que qualquer cidadão que não esteja satisfeito com o direito concedido, possa recorrer ao judiciário. Ao recorrer, o Poder Judiciário assume uma posição de alterar o destino do caso apresentado. O crescimento das decisões judiciais gera impacto nas políticas públicas, no planejamento de programas e ações e orçamentos (6).

Do ponto de vista da representação dos autores/pacientes, das 45 ações analisadas, pode-se identificar que as representações foram feitas pela Defensoria Pública na Justiça Estadual e Federal e por advogado particular. As Tabelas 4 e 5 apresentam o demonstrativo dos processos por tipo de representação.

TABELA 3. Demonstrativo do quantitativo de processos por representação jurídica na esfera estadual 2018, com litisconsórcio entre o estado e o município.

REPRESENTAÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
Defensoria Pública	33
Advogado Particular	8
Total	41

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da análise dos processos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município de Vila Velha-ES.

TABELA 4. Demonstrativo do quantitativo de processos por representação jurídica na esfera federal 2018 com litisconsórcio entre a união, o estado e o município.

REPRESENTAÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
Defensoria Pública	1
Advogado Particular	3
Total	4

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da análise dos processos fornecidos pela Procuradoria Geral do município de Vila Velha-ES.

A Defensoria Pública foi o principal órgão representativo dos cidadãos em processos judiciais no município de Vila Velha, havendo um destaque para o percentual de representação pela Defensoria Pública na Justiça Estadual (aproximadamente 79%) e na Justiça Federal (25%).

A informação que merece destaque é de que não foram identificadas ações impetradas pelo Ministério Público, ou seja, as iniciativas tomadas pela Secretaria de Saúde com o Ministério Público, qual seja a principal de manter um diálogo aberto, foram positivas.

Há que se ressaltar que a partir do ano de 2018, o declínio de competência da Justiça Estadual para a Federal passou a fazer parte da rotina dos tribunais quando o objeto processual era um medicamento. O mesmo processo pode ter duas numerações distintas na Justiça Estadual e Federal. Isso ocorre porque muitos medicamentos padro-

nizados ou não da REMUME ou RENAME, o juiz entende mediante a sua convicção que determinado medicamento deve ser remetido a determinada esfera de governo. Portanto, os dados do sistema PROJUDI podem estar conectados ao sistema e-roc da Justiça Federal. Esse fato por si só não interfere na análise de dados, mas pode gerar um grau de não entendimento para aquele leitor não pertencente à área de direito.

As decisões judiciais passam por momentos de instabilidade, gerados inclusive pelo próprio Superior Tribunal Federal, que altera suas decisões, sem gerar repercussão para os demais casos similares. Muito da instabilidade vivenciada está relacionada à dívida moral, que o magistrado acredita ter na situação posta, em que as decisões são tomadas para que a vida seja salva, independentemente do valor financeiro que será gasto pelo órgão público; das limitações financeiras que são vivenciadas pelos entes públicos; e das evidências científicas quanto a real efetividade dos tratamentos prescritos (7).

Dos 45 processos analisados, tem-se 4 deles com decisões liminares procedentes, encontrando-se em fase de apresentação de contestação pelo município e pelos demais entes solidários; 31 processos com sentença confirmando a liminar procedente para fornecimento de medicamentos, estando 10 processos dos 31 em fase recursal, sem suspensão do fornecimento do objeto; um processo teve a decisão liminar revogada por abandono da causa, merecendo destaque o fato do autor ser representado pela Defensoria Pública; e um processo extinto por óbito do autor.

Na análise, oito das decisões existentes (sendo sete ações com sentenças procedentes para o fornecimento com resolução de mérito e 1 decisão liminar) condenam os entes públicos a fornecimento de fármacos que constam na REMUME. Os demais processos são de fármacos que constam na RENAME ou que não consta em nenhuma das duas relações, mostrando que o município de Vila Velha está sendo constantemente sendo chamada a solidariedade com o ente estadual e com o ente federal por medicamentos que estão acima da sua capacidade organizativa e financeira, sendo condenado de forma solidária ao fornecimento de tais fármacos.

Em relação às decisões judiciais, de forma geral, muito se discute acerca da possível injustiça cometida pelo judiciário quando privilegia um cidadão que ingressou com uma

ação judicial para ter o seu tratamento garantido, especialmente por estarmos diante de decisões onde o direito é decidido em sede de liminar, sequer dando oportunidade para apresentação de provas/defesa pelo réu (8).

Também deve ser considerado a interferência do Poder Judiciário no orçamento e planejamento do Poder Executivo, vez que os entes públicos não realizam seu orçamento aguardando que demandas judiciais de altíssimos valores utilizem o recurso financeiro da pasta da saúde porque muitas vezes ocorre do tratamento prescrito pelo médico, não necessariamente médico do Sistema Único de Saúde, possuir alternativas preconizadas pelo SUS, gerando um gasto que pode ser considerado desnecessário, caso seja comprovado que as alternativas existentes no SUS seriam suficientes para o tratamento do autor (8).

É necessário que seja concedido ao Poder Judiciário um direcionamento quanto às decisões concedidas, para tentar um mínimo de homogeneidade nas ações do âmbito da saúde, devendo inclusive ser estipulados limites às decisões que envolvam tecnologias em saúde e que por muitas vezes ainda não possuem eficácia comprovada, são de alto custo e possuem tratamento similar no Sistema Único de Saúde (9).

Outra questão que traz um aspecto negativo para as decisões judiciais no âmbito da saúde são as multas fixadas para o cumprimento das decisões liminares. As astreintes, popularmente conhecida como multa, são fixadas nas decisões judiciais liminares ou nas sentenças para cumprimento da obrigação imposta pelo Poder Judiciário (10).

Nos 45 processos analisados do município de Vila Velha foi estipulado o pagamento de multas pelo não cumprimento das liminares procedentes para o fornecimento de medicamentos e/ou pelo não cumprimento das sentenças.

Para os entes públicos, a astreintes é fixada com o objeto já mencionado anteriormente, podendo inclusive ser decidido pelo bloqueio judicial das contas até o cumprimento da decisão, vez que diante de um conflito do direito à saúde e da impenhorabilidade dos bens público, prevalece o de direito fundamental (10).

As multas inclusive foram a pauta de decisão do Superior Tribunal de Justiça com efeito repetitivo, sendo aplicada para todos os entes. Ocorre que muitas vezes, os

gestores estão diante de um conflito de difícil solução: é determinada a aplicação de multa diária para o fornecimento de um medicamento ou para a realização de um procedimento em tempo que não pode ser cumprido. Não havendo nesse caso, falta de interesse do réu em cumprir com a obrigação para qual foi condenado, mas falta de tempo hábil para que a decisão seja cumprida, podendo haver o bloqueio judicial das contas do ente, o que prejudicaria o sistema como um todo, caso não a cumpra (11).

Nos casos do conflito apresentado, muito se discute se a fixação da astreintes serviria para que houvesse o cumprimento de imediato da decisão judicial ou se geraria uma pressão maior no ente, que já não possui orçamento para perdas e que a multa só atingiria sua função se o medicamento ou procedimento pleiteados estivessem dentro do rol preconizado pelo ente (11).

Outro dilema enfrentado pelos gestores públicos com as decisões judiciais é a possibilidade de o magistrado determinar a prisão do gestor pelo não cumprimento da decisão. Porém, como já colocado anteriormente, algumas decisões não são passíveis de cumprimento dentro do prazo determinado pelo Poder Judiciário, o que pode levar a prisão do responsável pela saúde pública por crime de desobediência. O Poder Judiciário acaba muitas vezes por determinar a prisão dos gestores, mesmo sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o Juízo Cível não possui competência para decretar prisão, gerando temor e instabilidade na gestão pública e sendo um aspecto negativo das decisões judiciais (12).

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Os Núcleos de Apoio Técnico (NAT) foram criados para auxiliar os magistrados. Com o crescente número de demandas judiciais contra os entes públicos foi necessário um amparo técnico para fortalecer a decisão judicial. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de da Resolução n.º 31/2010, com base na Audiência Pública n.º 04, realizada em 2009, adotou algumas medidas para viabilizar este apoio (13).

Desde então, o CNJ vem fomentando a criação de núcleos ou câmara de apoio técnico, órgão composto por profissionais da área médica, farmacêutica, assistência social e por membros das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para auxiliar os magistrados na deliberação sobre processos que envolvam temas de saúde (14).

Visando oferecer bases científicas para as decisões dos Magistrados em relação às ações judiciais, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça assinaram o Termo de Cooperação n.º 21/2016, criando o projeto Banco Nacional de Pareceres – Sistema e-NatJus, fornecendo fundamentos científicos para a tomada de decisões, conferindo uma maior celeridade no julgamento das demandas da saúde (15).

No estado do Espírito Santo foi regulamentado, por meio do Ato Normativo n.º 135/2011, o funcionamento do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) para demandas que exijam do Poder Público o fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais (16).

A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha não possui estrutura própria de Núcleo de Apoio Técnico.

A Mediação Sanitária é um dos modelos de resolução de conflitos e representa a adesão à cultura da pacificação, solucionando os conflitos sociais pelo próprio meio social, o que gera maior conscientização política e participação popular. É um meio eficiente para resolução de impasses e promoção de justiça, gerando respostas ágeis, promovendo o diálogo e criando a possibilidade de antever e se antecipar evitando maiores gastos de tempo e dinheiro público com a judicialização (17).

Assim, a mediação sanitária poderia ser considerada para a diminuição dos processos judiciais em Vila Velha, vez que seria um meio de substituir a judicialização das demandas, com resolução interna do conflito, mas o município ainda não possui este referido comitê instalado.

No município de Vila Velha, do ponto de vista de enfrentamento da judicialização, têm sido feitos investimentos na formação de seu pessoal. Em maio de 2018, os farmacêuticos da rede foram capacitados sobre os cenários estadual e municipal da judicía-

lização em saúde, especialmente relacionados a medicamentos, além disso, os profissionais foram orientados sobre as informações que devem ser passadas aos munícipes para que tenham maior acesso aos medicamentos, visando reduzir o número de ações judiciais em medicamentos da rede básica e especializada (18).

O portal *web* da secretaria municipal mantém atualizada a lista de abastecimento de medicamentos. Vila Velha possui 161 medicamentos de distribuição gratuita na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) que são dispensados aos pacientes nas 18 farmácias das Unidades de Saúde do Município.

No ano de 2019, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), lançaram o Mandado Judicial Online (MJO), um Portal Eletrônico de Intimação para dar maior celeridade ao cumprimento de ações judiciais da área de saúde, por meio de do envio online de intimações relativas a pedidos de medicamentos, internações e procedimentos cirúrgicos (19).

Em março de 2020, a secretaria estadual assinou um Acordo de Cooperação Técnica junto à Justiça Federal, visando encaminhar subsídios técnicos-normativos aos magistrados, em relação a ações no âmbito da saúde (20).

Estas últimas abordagens do estado em relação à preocupação com as ações judiciais, podem, futuramente, desencadear em algum impacto na Secretaria Municipal de saúde de Vila Velha, devendo ser monitoradas nos próximos períodos.

É necessário que, para haver o real enfrentamento da judicialização em saúde no município de Vila Velha, sejam elaboradas instâncias que promovam métodos e instrumentos de resolução dos conflitos por meio de da mediação sanitária.

Após a análise do município, pode-se atestar que este não possui uma equipe técnica para a análise das ações judiciais, não possuindo estratégias para diminuí-las, aumentando gradativamente os números de ações e gastos com medicamentos por via judicial. Sugere-se a criação de uma comissão para a análise dos processos e busca de alternativas para a sua diminuição.

Sugere-se também a criação de ações e protocolos administrativos, criando fluxos pré-determinados para o atendimento aos pacientes, seja para o fornecimento de medi-

camentos, como para o fornecimento de negativas embasadas em critérios clínicos, analisando possíveis alternativas terapêuticas existentes na REMUME, procurando evitar a judicialização. É importante também ressaltar que a atualização constante da REMUME é de fundamental importância para a diminuição das ações, sendo baseada em protocolos clínicos, e embasada em critérios epidemiológicos.

Considera-se a necessidade de revisão e inspeção dos processos judiciais já deferidos contra o município, a fim de avaliar se o medicamento solicitado já foi incorporado a REMUME, ou a algum outro programa do ministério, avaliação se o paciente está retirando periodicamente a medicação, e considerar a necessidade de uma reavaliação médica. Estes itens garantem a segurança do paciente e a garantia do sucesso do tratamento solicitado.

Em análise realizada pela Ordem dos Advogados do Espírito Santo, pela Comissão de Direito à Saúde, em setembro de 2019, foi indicado a falta de diálogo como uma das causas da crescente judicialização da saúde no estado (21). É considerável que ocorra o mesmo com o município de Vila Velha.

O debate com diversos atores pode colaborar na criação de consensos sobre os critérios para atendimento inicial e para a judicialização. Utilizando a experiência de outros entes federados podemos citar exemplos de critérios pactuados com o judiciário para fornecimento de medicamentos: uso de formulário de justificativa médica para uso de medicamento não padronizado; exigência de negativa administrativa para o ingresso de demandas judiciais; contatar a pessoa de referência da rede para a solução de determinada situação para agilizar o atendimento; construção de listas padronizadas, entre outros. A questão primordial é a avaliação por parte do município de adoção da metodologia de planejamento e de gestão sistêmica e a construção coletiva de processos (22).

Pelas características apresentadas nas ações analisadas, destaca-se a necessidade de diálogo com a Defensoria Pública, que em conjunto com Ministério Público Estadual; Secretaria Estadual da Saúde, Ministério Público Federal; Magistratura Estadual; Procuradoria do Estado; Procuradoria do Município; Advocacia Geral da União;

Conselho Municipal da Saúde; Coordenadores Municipais de Saúde e dirigentes dos hospitais, dentre outros, podem influir de forma positiva para garantia do direito à saúde dos munícipes de Vila Velha.

Esta aproximação entre todos os entes, aumentando a comunicação, fornecendo informações sobre os pareceres técnicos e fluxos administrativos que forem adotados podem influenciar muito nas decisões judiciais e criar um canal para comunicação entre os envolvidos, procurando agilizar e otimizar o sistema.

Existe, ainda, a necessidade de ações de educação permanente, voltadas tanto para os trabalhadores, como aos usuários do sistema de saúde, que promovam a consciência sobre os prejuízos que o SUS sofre com a falta de racionalidade das demandas judiciais por medicamentos.

Diante do aumento das demandas judiciais na saúde foi necessário realizar buscas por mecanismos que ajudassem os usuários, a Gestão Pública e o Poder Judiciário. Baseado nisso foi criado o movimento da desjudicialização da saúde. Tal movimento visa a mudança comportamental dos atores da relação de saúde e da forma pela qual as demandas de saúde são tratadas. A busca da solução para os conflitos, segundo o movimento de desjudicialização, estaria na própria sociedade, havendo uma necessidade de conceder maior valor a solução pacífica administrativa dos conflitos, diminuindo o contencioso da saúde (23).

O aumento das demandas judiciais na área da saúde, sem que o Poder Judiciário possua conhecimento técnico suficiente para julgar os casos, transforma a justiça em um ciclo vicioso, havendo fornecimento de medicamentos e de serviços de saúde de forma a prejudicar o sistema (24).

Diante da realidade do município de Vila Velha/ES, onde o número de demandas judiciais na saúde tem aumentado significativamente, se faz necessária a determinação de novas estratégias e ações para serem tomadas visando o enfrentamento dessa realidade, com a consequente diminuição desses índices.

Dentre essas novas estratégias a serem tomadas pelo município de Vila Velha sugere-se a criação de uma comissão para atuar em demandas judiciais, que seria responsável por analisar e discutir os casos, buscando formas de evitar que as lides se repetissem, e de um núcleo de mediação sanitária.

Assim, deve-se levar em consideração que já foi constatado, pela Prefeitura de Vila Velha em várias diligências e situações cotidianas que a falta de comunicação entre os atores envolvidos nas questões envolvendo saúde são consideradas causas primárias da judicialização (24).

Neste sentido, importante considerar que, no instrumento da mediação, diferente do Judiciário, não há busca pela verdade, mas sim pela abertura de um diálogo, por compreensão das diferenças, interação e responsabilidades, respeitando os princípios éticos dos casos. A abertura do diálogo é realizada pelo mediador, facilitando a relação, mantendo a equidade entre as partes e as integrando, fazendo que haja um equilíbrio de poder capaz de superar as violências e exclusões existentes (25).

A mediação sanitária traz justamente o objetivo de evitar que seja necessário um processo judicial para que a demanda do paciente seja atendida, sendo um modelo alternativo que possui o mesmo valor de uma decisão judicial. Uma característica positiva da mediação sanitária é que a utilizando é possível prever alguns conflitos e evitá-los, vez que a gestão pode construir e acompanhar o mapa de conflitos do seu sistema de saúde, evitando que algumas demandas se repitam (26).

Uma vez realizada o planejamento e aprovação do projeto de implantação das novas estratégias, a comissão seria composta pelos atores relacionados à demanda judicial da área de saúde os quais iriam focar em realizar as revisões das ações e serviços de saúde oferecidos a nível municipal e estadual, revisando também as ações programáticas, para a elaboração de parecer técnico de forma integrada com as áreas envolvidas, de acordo com cada demanda judicial, para obtenção de resultados práticos e estratégicos para resolução das causas-raízes dos problemas.

No planejamento das reuniões deve-se abranger no mínimo, uma reunião mensal de mediação sanitária em cada uma das microrregiões e macrorregiões determinadas pelo município. A divisão por micro e macrorregiões visa melhor organização no

que tange a realidade e necessidades da população do município com base em suas peculiaridades. Os relatórios dessas reuniões devem ser encaminhados para o gestor municipal do núcleo de mediação sanitária, para fins de consolidação e análise crítica a serem realizados na reunião de caráter municipal, buscando a tomada de ações necessárias para solucionar possíveis problemas identificados.

Nessas reuniões da comissão de mediação sanitária devem ser levadas todas as demandas de serviços de saúde em que foram registradas ocorrências no que tange a impossibilidade de fornecimento pela PMVV, seja por quaisquer motivos, bem como de novas ocorrências de demandas judicializadas. Deve-se analisar cada caso, as demandas, e determinar ações necessárias para serem tomadas em caráter imediato, bem como analisar a causa-raiz do problema, de forma a determinar as ações corretivas suficientes para tratamento da ocorrência, de forma a evitar que casos semelhantes sejam reincidentes. Assim, todas as reuniões que tiveram registros de ocorrências em suas atas devem conter as ações a serem tomadas para tratamento daquelas.

Então, a execução das deliberações da comissão de mediação sanitária permitirá a definição de melhor identidade dos demandantes; de elaboração de protocolos operacionais assistenciais; a atualização de informações nos sistemas oficiais; de medidas preventivas para evitar potenciais ocorrências, como a insuficiência de estoque de medicamentos etc.

Desta forma, tem-se a mediação como um instrumento alternativo de resolução de conflitos, representando a adesão à cultura da pacificação, em oposição à cultura existente que gira em torno da necessidade de uma decisão judicial para obtenção de soluções, além de representar um meio menos oneroso que o aparato judicial (27).

Além da criação da comissão para mediação, outra estratégia que o município de Vila Velha poderia adotar para evitar demandas judiciais, especialmente as demandas de medicamentos, vez que em grande maioria das ações do ano de 2018 que possuía como objeto o fornecimento de medicamento, o fármaco não compõe a REMUME e seria de responsabilidade estadual ou federal o fornecimento, seria a implantação de um Núcleo de Apoio Técnico municipal.

O Núcleo de Apoio Técnico Municipal possuiria a missão de oferecer assessoria e consultoria técnica aos magistrados para apoiá-los em suas decisões; compostos por equipe multidisciplinar com atribuição de elaborar pareceres técnicos, para explicar tanto aspectos clínicos como de políticas públicas em saúde relacionadas à demanda judicial (27).

Considerando que a SESA/ES disponibiliza uma equipe para prestar informações aos magistrados em casos de demandas da saúde, mesmo durante o recesso do judiciário, subsidiando a tomada de decisão (28). Seria de suma importância que o município também tivesse sua equipe multiprofissional para auxiliar os magistrados, podendo assim evitar condenações e processos similares aos já vivenciados e que não são de sua responsabilidade.

Considerações Finais

Diante da realidade do município de Vila Velha-ES, onde o número de demandas judiciais na saúde tem aumentado significativamente, se faz necessário a determinação de novas estratégias e ações para serem tomadas visando o enfrentamento dessa realidade, com a consequente diminuição desses índices.

A partir do fornecimento de dados pela Procuradoria Geral do município de Vila Velha – ES e pela Secretaria Municipal de Saúde foi possível vislumbrar o aumento das demandas judiciais, em diversas áreas, e feito um recorte nas ações judiciais do ano de 2018, cujo objeto seria o fornecimento de medicamentos, foi possível analisar e concluir que com a implantação de novas estratégias seria possível reduzir as ações movidas em face do município.

Tal conclusão é possível baseado nas características dos processos que foram o recorte do trabalho, fornecimento de medicamentos no ano de 2018, onde o município figura em litisconsórcio com o ente estadual nas ações ingressadas perante a justiça estadual e com os entes federal e estadual nas ações ingressadas perante a justiça federal.

Além dos litisconsórcios, foi possível chegar à conclusão de que a implantação de novas estratégias no município seria bem-sucedida, pelos dados repassados pela Secretaria

Municipal de Saúde, onde os medicamentos pleiteados nas ações seriam de responsabilidade estadual ou federal, ou seja, medicamentos de maiores complexidades e que não estariam presentes na REMUME.

Dentre essas novas estratégias a serem tomadas pelo município de Vila Velha a criação de uma comissão para atuar em demandas judiciais e de uma comissão de mediação sanitária, possibilitariam o monitoramento e avaliação das demandas judiciais, fornecendo suporte técnico tanto para a Secretaria de Saúde aprimorar o diagnóstico e o acompanhamento das demandas judicializadas, como para permitir mediações, sempre que possíveis, com o Poder Judiciário, quando não for possível a solução pacífica do conflito.

Outra estratégia que poderia ser adotada pelo município seria a criação de um Núcleo de Apoio Técnico Municipal, que daria suporte aos magistrados, inclusive para a retirada do município do litisconsórcio, vez que os medicamentos pleiteados não seriam de responsabilidade do ente municipal, evitando assim um prolongamento na ação como parte e evitando que em ações futuras o município fosse citado como litisconsórcio nas lides de medicamentos que não integrem a REMUME.

O Núcleo de Apoio Técnico Municipal seria o canal de aproximação entre o município e o Poder Judiciário, que em sua grande maioria não possui conhecimento técnico para as decisões tomadas e que já possuem o apoio do Núcleo Técnico do estado do Espírito Santo, que está presente para corroborar as defesas estaduais nos processos.

Com a análise das demandas judiciais e com a possibilidade de implantação de novas estratégias é necessário que Vila Velha atualize sua gestão e crie fluxos de atendimento à população. A judicialização não é a causa, porém, uma consequência da ausência de novas estratégias de gestão pública. A conciliação teria a finalidade de mediar o interesse privado dirimindo a pretensão resistida do poder público. Se a judicialização ocorre como regra e não como exceção, Vila Velha ainda não desenvolveu os mecanismos suficientes e necessários para dirimir o contencioso judicial. Isso vale para todos os entes federados.

Conclui-se que há a necessidade que se estabeleça a curto ou em médio prazo, a conciliação entre os usuários do SUS e a Secretaria Municipal de Saúde, bem como a criação

de um núcleo técnico de apoio judiciário próprio, para subsidiar o Poder Judiciário em suas decisões. Praticamente, no ano de 2018, todas as ações propostas contra o município de Vila Velha foram procedentes e condenaram solidariamente o município e o estado a fornecer qualquer item de saúde enquanto houver a necessidade, estipulando inclusive o pagamento de multas pelo não fornecimento do medicamento.

A conciliação surge como forma alternativa ao processo endêmico da judicialização. Porém, há que se considerar, que Vila Velha precisa que o movimento conciliador seja pactuado dentro das comissões intergestores de todo o Sistema Único de Saúde.

Já o Núcleo de Apoio Técnico Municipal seria o caminho de aproximação entre o ente municipal e o Poder Judiciário, podendo subsidiar os magistrados de forma mais técnica, aplicando as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Os resultados apresentados no presente trabalho mostram que há um caminho na mediação e no Núcleo de Apoio Técnico, a ser percorrido por Vila Velha, que poderá iniciar com as ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamento, mas que necessita transpassar para os demais pedidos, vez que a análise mostra um crescente aumento da judicialização por outras demandas, como o fornecimento de fraldas, por exemplo.

O usuário ou o titular de direito constitucional à saúde deve ter a sua pretensão resistida atendida pelo poder público. Esse direito constitucional existe e não pode ser deixado em segundo plano. A Administração Pública deve responder adequadamente aos interesses do cidadão e cabe a juízes ou conciliadores mediar soluções quando não houver uma resposta a contento da Administração.

Referências

- 1 – Conselho Nacional de Justiça. **Relatório analítico propositivo Justiça pesquisa. Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução.** [Internet]. Brasília: CNJ; 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/03/relatorio-judicializacao-saude-Insper-CNJ.pdf>.
- 2 – Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Saúde. **Farmácia cidadã. Judicialização** [Internet]. Vitória: Secretaria de Estado da Saúde; 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://farmaciacidadada.es.gov.br/judicializacao>.
- 3 – Silva JO. **Noções gerais de administração municipal.** [internet]. Curitiba: Unipublica; 2019 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em <https://www.unipublicabrasil.com.br/uploads/materiais/3f156613019df3bad52791894a89228d24012017192843.pdf>.
- 4 – Pereira JR, Santos RI, Nascimento Junior JM, Schenkel EP. **Análise das demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina nos anos de 2003 e 2004.** Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2010 [citado 14 jul. 2020], 15(supl. 3):3551-60. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000900030>.
- 5 – Reis NBM. **Judicialização da Saúde no Brasil** [Internet]. Rede Juntos; 2019 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://wiki.redejuntos.org.br/busca/judicializacao-da-saude-no-brasil-sobre-lei-no-80801990-e-o-sistema-unico-de-saude>.
- 6 – Cruz A. **O direito à saúde exigido na justiça.** Revista CONSENSUS [Internet]. 2015 [citado 14 jul. 2020], (15). Disponível em: <http://www.conass.org.br/consensus/o-direito-saude-exigido-na-justica/>.
- 7 – Paixão ALS. **Reflexões sobre a judicialização do direito à saúde e suas implicações no SUS.** Ciênc. saúde coletiva [internet]. 2019 [citado 14 jul. 2020], 24(6):2167-72. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018246.08212019>.
- 8 – Advocacia Geral da União. **Intervenção Judicial na Saúde Pública** [Internet]. Distrito Federal: AGU; 2013 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---2012---modificado-em-junho-de-2013.pdf>.
- 9 – Morozowski A. **Judicialização da saúde** [Internet]. Valor Econômico. 12 jun. 2019 [citado 14 jul. 2020]. <https://valor.globo.com/opiniao/coluna/judicializacao-da-saude.ghtml>.

10 - . Melo G. **Astreintes: multas diárias forçam partes a respeitar decisões judiciais** [Internet]. Belo Horizonte: Gilberto Melo; 2019 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://gilbertomelo.com.br/astreintes-multas-diarias-forcam-partes-a-respeitar-decisoes-judiciais/>.

11 – Moraes BT. **Multa pelo não fornecimento de medicamentos** [Internet]. JOTA. 20 ago. 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=/www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/multa-pelo-nao-fornecimento-de-medicamentos-20082018.

12 – Prefeitura Municipal de Vila Velha. **Decreto n.º 188, de 20 de agosto de 2002**. Convoca a IV Conferência Municipal de Saúde de Vila Velha, a realizar-se neste Município e dá outras providências [internet]. Vila Velha: Câmara Municipal; 2002. [Citado em 19 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/norma.aspx?id=5959>.

13 – Bomfim VMM, Graça Neto A, Danelli Júnior CA, Ramalho HS. **Os núcleos de assessoria técnica (NATs) como auxiliares na concretização do direito fundamental à saúde no Brasil** [internet]. 2017. [Citado em 28 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.unibalsas.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/vitoria-artigo.pdf>.

14 – Schulze C. **Direito à Saúde: análise à luz da judicialização**. Porto Alegre: Verbo Jurídico; 2015.

15 – Conselho Nacional de Justiça. **Sistema e-NatJus** [Internet]. Brasília: CNJ; 2020 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/forum-da-saude-3/e-natjus/>.

16 – Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Ato Normativo 135/2011** – Regulamenta o funcionamento do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juizes (NAT) para demandas que tenham por objeto compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais [Internet]. Vitória: TJES; 2011 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.tjes.jus.br/atos-normativos-135-2011/>.

17 – Delduque MC, Castro EV. A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil. *Saúde debate* [Internet]. 2015 [citado 14 jul. 2020];39(105):506-13. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042015105000217>

18 – Prefeitura de Vila Velha. **Farmacêuticos fazem treinamento sobre judicialização da saúde** [Internet]. Vila Velha: Prefeitura de Vila Velha; 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/05/farmaceuticos-fazem-treinamento-sobre-judicializacao-da-saude-20678>.

19 – Conselho Nacional de Justiça. **Judicialização da saúde: portal online agiliza demandas no ES** [Internet]. Brasília: CNJ; 2019. [Citado em 06 fev 2020]. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/judicializacao-da-saude-portal-online-agiliza-demandas-no-es/>.

20 - Governo do Estado do Espírito Santo; Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. **Sesa assina acordo de cooperação técnico-normativa para subsidiar judicialização de serviços e medicamentos** [Internet]. Vitória: SESA; 2020 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/sesa-assina-acordo-de-cooperacao-tecnico-normativa-para-subsidiar-judicializacao-de-servicos-e-medicamentos>.

21 - Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 9001/2015:Sistemas de Gestão da Qualidade**. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.

22 - Marion D, Maas RH. **A experiência brasileira no combate a judicialização da saúde – alguns casos referentes ao fornecimento de medicamentos**. In: Anais do XI Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea [Internet], 2014. Santa Cruz do Sul; UNISC, 2014 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/11743>.

23 - Cruz MTT, Nez BA. **A Contribuição da mediação sanitária para a desjudicialização do direito à saúde**. In: Anais do V Seminário Internacional de Direitos Humanos e Democracia, V Mostra de Trabalhos Científicos [Internet], 2018. Ijuí; UNIJUÍ, 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em <https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/8658/7846>.

24 - SEMSA Vila Velha. **Comunicado 1142/2015** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por Freitas SN. Disponibilizado pela SEMSA. [22 set 2015].

25 - Parisi L, Silva JM. **Mediação de Conflitos no SUS como Ação Política Transformadora**. Saúde debate [Internet]. 2018 [citado 14 jul. 2020], 42(4):30-42. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018s402>.

26 - Cardoso APP. **Mediação nos Relacionamentos do Setor de Saúde** [Internet]. In: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Série Aperfeiçoamento de Magistrados 8. Judicialização da Saúde Parte II. Rio de Janeiro: EMERJ; 2018 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/8/judicializacaodasaudeII_18.pdf.

27 - Gomes DF, Souza CR, Silva FL, Pôrto JA, Moraes IA, Ramos MC *et al.* **Judicialização da saúde e a audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009: o que mudou de lá para cá?** Saúde Debate [Internet]. 2014 [citado 14 jul. 2020], 38(100):140-56. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-104.20140008>.

28 - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. **Comitê Estadual de Saúde realiza reunião com juízes sobre as demandas durante o recesso** [Internet]. Vitória: TJ-ES; 2019 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.tjes.jus.br/comite-executivo-estadual-de-saude-realiza-reuniao-com-magistrados-sobre-o-atendimento-de-demandas-durante-o-recesso/>.

Capítulo 5

REGIÃO

CENTRO-OESTE



Município de Bataguassu-MS

Município de Goiânia-GO

Município de Jataí-GO

Município de Campo Grande-MS



Judicialização da saúde em Bataguassu-MS: mediando a garantia do acesso justo

Alex Vinícius Nunes Novaes Machado¹

Fernando Rocha²

Juliana Gonçalves Oliveira³

Luciana Emília de Carvalho Torres Galindo Coutinho⁴

Maria Angélica Benetasso⁵

Nicoli Prado Bugoni⁶

Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior⁷

Orientadora: Profa. MSc. Tarsila Costa do Amaral

A escolha do município de Bataguassu, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, para ser a base territorial para a qual foi desenvolvido o Projeto de Intervenção deu-se tendo em vista a viabilidade de acesso às informações sobre a gestão municipal, bem como de levantamentos de campo facilitados, além de ter sido um município que soube lidar e enfrentar a judicialização de modo inovador e competente, na visão dos autores.

¹ Graduado em Direito pela UEPB, e pós-graduado em Direito Público pela UNYAHNA e em Direito Eleitoral pela Faculdade Maurício de Nassau de Salvador. Procurador Geral do Município de Irecê-BA.

² Graduado em Direito pela UNIVERO, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá e em Gestão Pública de Saúde, pela UERJ. Chefe de Gabinete da Subsecretaria da Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro-RJ.

³ Graduada em Enfermagem pela FEEVALE. Enfermeira do município de Osório-RS.

⁴ Graduada em direito pela UNIPÊ, pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública pelo IFPB. Chefe da Assessoria Jurídica do Município de João Pessoa-PB.

⁵ Graduada em Serviço Social pela UNIFEV, especialização em Gestão de Saúde Pública e Gestão Pública Municipal pela UFMS. Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu-MS.

⁶ Graduada em direito pela UNITAU, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e Direito Empresarial pela Faculdade Damásio de Jesus. Assistente de projetos no HCOR-SP.

⁷ Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB). Assessor técnico do CONASEMS.

As informações coletadas na pesquisa foram obtidas juntamente a fontes oficiais e de acesso público. Nesse contexto, o Painel de Apoio à Gestão, disponível no portal do CONASEMS, apresentou conteúdo que atendeu aos requisitos da pesquisa, tanto no que se refere a um conjunto de indicadores de saúde selecionados e determinantes sociais, como estimativa populacional, percentual de beneficiários de plano de saúde, percentual de beneficiários de planos de saúde atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS), percentual da população atendida por coleta de lixo em domicílios urbanos, número de óbitos de crianças de até 5 anos de idade, percentual de óbitos por causas mal definidas, quanto no que se refere a repasses federais, saldo de contas, rede assistencial e emendas parlamentares.

Foram priorizados os dados abertos provenientes de fontes oficiais como o Poder Judiciário e Ministério Público, dados quantitativos das ações propostas no município, além de informações junto à administração municipal sobre o orçamento e gastos decorrentes do atendimento às decisões judiciais. Esse universo documental serviu à caracterização do perfil da judicialização da saúde no município e mostraram o diagnóstico do problema, além dos principais números das demandas judiciais no ano de 2018.

Com a análise dos dados coletados na primeira fase da pesquisa, foi proposta uma estratégia de enfrentamento da judicialização da saúde no município, a partir da base de elementos objetivos levantados na etapa anterior, que forneceu meios de monitoramento e avaliação da sua implementação.

Conhecida como a Morada dos Tucunarés, no Mato Grosso do Sul, Bataguassu se situa num importante corredor rodoviário de acesso ao estado, na divisa com o estado de São Paulo, a 330 km da Capital Campo Grande, a 45 km Presidente Epitácio e a 120 km de Presidente Prudente-SP.

No último Censo, em 2010 (1), o município registrou a população de 19.839 habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1), a população estimada de Bataguassu para 2018 é de 22.717 habitantes.

Diagnóstico da judicialização do município

O município de Bataguassu é sede de comarca de segunda entrância, e está na área de jurisdição da Quarta Circunscrição Judiciária, sediada no município de Três Lagoas, que abrange, além de Bataguassu, os municípios de Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Rio Pardo e Selvíria (2).

Bataguassu é ainda a sede de comarca regional com jurisdição no município de Santa Rita do Rio Pardo.

As ações judiciais propostas na comarca no ano de 2018, versam, majoritariamente, sobre o fornecimento de medicamentos, além de pedidos relacionados a Assistência Médico Hospitalar e realização de procedimento cirúrgico.

Além disso, as ações propostas têm, em sua maioria, como réus, os Municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Foram verificadas ainda ocorrências, em menor número, de processos tendo o Estado do Mato Grosso do Sul no polo passivo.

Descontados os 2 processos em segredo de justiça, foram registradas 6 ações com o Município de Bataguassu no polo passivo. Tal quantitativo pode parecer inexpressivo, se analisado fora do contexto local. Porém, seu impacto no financiamento da saúde é relevante.

Por um lado, deve-se levar em conta que o valor somado das 6 ações foi de R\$ 32.493,68, o que corresponde a aproximadamente 14,8% do valor total dos repasses federais para financiamento da média e alta complexidade no município sob análise em 2018, que foi de R\$ 219.497,00 (3).

Entretanto, cabe apontar que o valor declarado nas petições iniciais nem sempre corresponderam aos impactos do provimento dos pedidos nas contas municipais. Com efeito, a Defensoria Pública atribui, arbitrariamente, o valor de R\$ 954,00 para todas as ações que envolviam realização de cirurgias, o que não corresponde aos gastos efetivos realizados pela municipalidade com a realização de tais procedimentos.

Além disso, pode-se apontar uma tendência de crescimento na judicialização da saúde na comarca, visto que, entre janeiro e dezembro de 2019, houvera a proposição

de 23 ações judiciais relacionadas à saúde (4), cujos valores somados chegam a R\$ 132.348,00, superando em 64% o volume de ações registrado em 2018, e em 75% o valor das demandas.

O Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, publica periodicamente estatísticas sobre a judicialização da saúde no estado. A Tabela 1 apresenta o número total de processos registrados no ano de 2018 (5):

TABELA 1. Lista das Comarcas e Número de Processos (ordenadas da maior quantidade para a menor).

COMARCA	PROCESSOS
Juizado Especial Central de Campo Grande	2616
Campo Grande	512
Dourados	273
Paranaíba	211
Corumbá	191
Naviraí	152
Nova Andradina	145
Juizado Especial de Dourados	144
Três Lagoas	137
Amambai	122
Aquidauana	117
Ponta Porã	109
Fátima do Sul	97
Sidrolândia	91
Bela Vista	89

Rio Brilhante	79
Caarapó	77
Ivinhema	70
Itaporã	68
Jardim	68
Juizado Especial de Três Lagoas	63
Bandeirantes	61
Batayporã	56
Anastácio	56
São Gabriel do Oeste	53
Ribas do Rio Pardo	51
Cassilândia	49
Camapuã	47
Bonito	43
Maracaju	40
Eldorado	39
Deodápolis	38
Glória de Dourados	36
Chapadão do Sul	35
Sete Quedas	34
Coxim	31
Terenos	29
Miranda	25
Rio Verde de Mato Grosso	23

Mundo Novo	23
Água Clara	21
Itaquiraí	20
Bataguassu	19
Costa Rica	19
Aparecida do Taboado	18
Rio Negro	16
Iguatemi	15
Dois Irmãos do Buriti	14
Inocência	14
Nioaque	13
Porto Murtinho	12
Sonora	11
Pedro Gomes	9
Angélica	8
Anaurilândia	7
Brasilândia	7
Nova Alvorada do Sul	6
Total	6.429

Fonte: Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT).

Assim, de um total de 6.429 ações propostas, no ano de 2018, registraram-se 19 processos na Comarca de Bataguassu. Após consulta ao referido Comitê Estadual, foi fornecida relação com os números de protocolo dos citados documentos.

Constatou-se, entretanto que, dos 19 processos listados na estatística oficial, havia 2 números de protocolo repetidos, assim como 2 processos do ano de 2017. Resultou, portanto, um total de 14 ações judiciais propostas na Comarca de Bataguassu em 2018, conforme consta da Tabela 2.

TABELA 2. Dados das principais demandas judiciais do município de Vila Velha em 2018.

NÚMERO DO PROCESSO	RÉU	VALOR (R\$)
0801933-57.2018.8.12.0026	Segredo de Justiça	
0802153-55.2018.8.12.0026	Município de Santa Rita do Pardo	954,00
0900024-85.2018.8.12.0026	Estado do Mato Grosso do Sul	954,00
0801473-70.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	954,00
0801875-54.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	1.522,08
0801594-98.2018.8.12.0026	Estado do Mato Grosso do Sul	15.960,00
0801174-93.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	954,00
0801167-04.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	954,00
0800817-16.2018.8.12.0026	Município de Santa Rita do Pardo	2.920,32
0800784-26.2018.8.12.0026	Município de Santa Rita do Pardo	954,00
0800427-46.2018.8.12.0026	Segredo de Justiça	
0800057-67.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	954,00
0900020-48.2018.8.12.0026	Estado do Mato Grosso do Sul	954,00
0800065-44.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	27.155,60

Fonte: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Consulta Processual.

Restou claro, diante dos dados constantes da Tabela 2 que, dos 14 processos registrados na Comarca de Bataguassu, dois encontravam-se em segredo de justiça, enquanto seis tinham o Município de Bataguassu como réu.

Como já afirmado, os pedidos apresentados versavam, majoritariamente, sobre o fornecimento de medicamentos.

TABELA 3. Ações propostas em face do Município de Bataguassu, com assunto (2018).

NÚMERO DO PROCESSO	RÉU	ASSUNTO
0801473-70.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Fornecimento de medicamentos
0801875-54.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Fornecimento de medicamentos
0801174-93.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Assistência médico-hospitalar
0801167-04.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Fornecimento de medicamentos
0800057-67.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Fornecimento de medicamentos
0800065-44.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Fornecimento de medicamentos

Fonte: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Consulta Processual.

Dentre as seis ações propostas que têm como réu o Município de Bataguassu, cinco tratavam do fornecimento de medicamentos, e apenas uma dizia respeito à assistência médico-hospitalar.

A relevância do trabalho da Defensoria Pública ficou evidenciada quando analisada a representação dos autores das ações judiciais propostas na comarca, no ano de 2018. Conforme demonstraram os dados do Quadro 4, a totalidade dos processos que tiveram o Município de Bataguassu no polo passivo, tiveram seus autores representados pela referida instituição.

TABELA 4. Representação do Autor/Paciente, nas ações propostas do Município de Bataguassu (2018).

NÚMERO DO PROCESSO	RÉU	ASSUNTO
0801473-70.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS
0801875-54.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS
0801174-93.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS
0801167-04.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS
0800057-67.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS
0800065-44.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Defensoria Pública do Estado do MS

Fonte: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Consulta Processual.

No que se refere às decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição, foi notada uma tendência pela improcedência dos pedidos de fornecimento de medicamentos.

Ocorre que foram registradas três sentenças pela improcedência e duas pela procedência, das quais uma tratava de assistência médico-hospitalar. Assim, de quatro pedidos de fornecimento de medicamentos, apenas um foi julgado procedente.

Além disso, verificou-se um caso no qual a tutela de urgência não foi concedida (decisão que foi reformada em sede recursal) e que manteve-se aguardando o julgamento de mérito.

TABELA 5. Decisões proferidas nos processos judiciais em face do Município de Bataguassu (2018).

NÚMERO DO PROCESSO	RÉU	URGÊNCIA	MÉRITO
0801473-70.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Indeferida	Improcedente
0801875-54.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Deferida	Procedente
0801174-93.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Deferida	Procedente
0801167-04.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Indeferida	Improcedente
0800057-67.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Indeferida	Improcedente
0800065-44.2018.8.12.0026	Município de Bataguassu	Indeferida	Aguarda julgamento

Fonte: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Consulta Processual.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é a instância colegiada de assessoramento técnico ao Judiciário nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (6).

O referido Núcleo foi criado e implementado com base em convênio, celebrado em 2016, entre o Estado do Mato Grosso do Sul, o Município de Campo Grande e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (7).

Os profissionais que integram o NAT são: (8) Alexandre Augusto Tutes, farmacêutico do Estado do Mato Grosso do Sul; Bernardete Gomes Lewandowski, farmacêutica do Estado do Mato Grosso do Sul; Tatyana Weber Leite, enfermeira do Município de Campo Grande/MS; Dra. Lilian Maria Maksoud Gonçalves, médica do Município de Campo Grande/MS; Dr. Jorge Guillermo La Torre Heredia, médico do Município do Estado de Mato Grosso do Sul; Vania Lucia Della Justina da Silva, servidora judiciária; Rinaldo Gomes Garcia, servidor judiciário; e Rute Ribeiro de Quadros, servidora judiciária.

Vê-se, portanto, que o NAT conta com oito profissionais, o que representa um aumento em relação à composição registrada ao fim do biênio 2017-2018 (6). Contudo, houve uma redução no quantitativo de médicos cedidos ao NAT: eram dois farmacêuticos e quatro profissionais médicos, mas, conforme o termo aditivo ao convênio, firmado em agosto de 2019 (9), coube ao Estado do Mato Grosso do Sul a designação de dois farmacêuticos e dois médicos para atuação exclusiva juntamente ao NAT.

Verificou-se que o NAT se manifestou em todas as ações propostas em face do Município de Bataguassu, constantes da Tabela 5. Com efeito, em todas as decisões pela improcedência, o magistrado utilizou os elementos trazidos pelo núcleo em seus fundamentos para decidir, acompanhando o entendimento esposado pelos técnicos.

Tais elementos evidenciam a relevância do trabalho desenvolvido pelo NAT, bem como a sua influência no conteúdo das decisões prolatadas pelo judiciário.

Em reunião realizada em 29 de novembro de 2019 (10), o coordenador do Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde realizou balanço das atividades desenvolvidas no ano de 2019. Na ocasião, destacou a implementação do e-NatJus como um dos maiores avanços, além de abordar a necessidade de se adotar medidas para a imediata designação de médicos para o NAT, bem como para a sua implementação para a saúde suplementar.

Em caráter geral, a adoção de métodos consensuais para a composição de conflitos versando sobre direitos disponíveis é prática institucionalizada no Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, desde 2011, data da criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), por meio do Provimento nº 230, de 30 de março de 2011. Em 2012, foi instalado o primeiro centro do referido núcleo, seguidos da instalação de outras duas unidades em 2013 (11).

Há nove Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, sendo quatro localizados em Campo Grande, e outras cinco unidades nos municípios de Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

No campo específico da Mediação Sanitária, cabe citar a experiência em curso no Município de Ponta Porã. Em 10 de abril de 2017, a Comissão Intergestores Bipartite

homologou a adesão dos municípios integrantes da microrregião de saúde de Ponta Porã à mediação sanitária coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (12).

Com efeito, a Comissão de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde de Ponta Porã foi instituída pela Resolução n.º 77/SES/MS, de 24 de setembro de 2018, conforme consta do Regimento Interno aprovado mediante a Resolução n.º 78/SES/MS, de 8 de outubro de 2018 (13).

Consoante o regimento (13), a Comissão é composta por representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Geral do Estado em Ponta Porã, do Conselho Estadual de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde da microrregião de Ponta Porã, dos Conselhos Municipais de Saúde de cada município, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Mato Grosso do Sul, do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho Regional de Enfermagem e do Conselho Regional de Medicina.

Na microrregião de saúde de Naviraí, da mesma forma, há registro de atuação de Comissão de Mediação Sanitária, que realizou, em setembro de 2019, reunião com gestores municipais de saúde da microrregião, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, além de representantes do Ministério Público em Naviraí e do Ministério Público Estadual (14).

Contudo, em que pese a existência das experiências, não há Comissão de Mediação Sanitária em Bataguassu.

No contexto da judicialização da saúde no Estado do Mato Grosso do Sul, cabe ressaltar a atuação do Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde, cujas funções são: aconselhamento aos entes federativos, magistrados, classe médica e demais operadores do direito envolvidos com a saúde pública; proposição de medidas que visem amenizar os problemas decorrentes da judicialização da saúde; e estreitamento de laços com as principais esferas políticas, por meio de política judiciária voltada ao gerenciamento da área de saúde (7).

O Comitê Estadual é composto por magistrados federais, magistrados estaduais, representantes do Ministério Público, das Procuradorias, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos gestores públicos, dos médicos, dos farmacêuticos, dos gestores da medicina suplementar e da sociedade civil em geral (7).

Dentre as principais iniciativas adotadas pelo Comitê desde 2015, destacam-se a confecção de enunciados contemplando resumo de medidas e providências a serem adotadas por magistrados e entes públicos, a realização de cursos, a promoção de eventos, a confecção de cartilhas informativas, a informatização dos processos de trabalho do NAT, a elaboração de estudos e o levantamento das ações que versam sobre direito sanitário (7).

Ademais, são resultantes das atividades do comitê diversas recomendações, como a suspensão de processos por determinação do Superior Tribunal de Justiça e a adoção de medidas para melhorar o atendimento à população nos hospitais do Estado (6).

No balanço, apresentado pelo coordenador do comitê em novembro de 2019 (10), foi salientada a importância da regionalização do comitê, com a instalação de unidades regionais nas cidades-polo, destinadas ao tratamento das questões peculiares a cada uma das regiões do estado do Mato Grosso do Sul.

A principal crítica constituiu-se da ausência de Comissão de Mediação Sanitária no município de Bataguassu. Diante disso, foi sugerido sugestão que fosse instituída tal instância de solução consensual das demandas sanitárias no município.

Como já exposto, deve-se levar em conta que o valor somado dessas seis ações judiciais em desfavor do município, em 2018, foi de R\$ 32.493,68, o que corresponde a aproximadamente 14,8% do valor total dos repasses federais para financiamento da média e alta complexidade no município, que foi de R\$ 219.497,00 (3).

Ademais, como igualmente já mencionado, verificou-se uma tendência de crescimento na judicialização da saúde na comarca estudada, visto que, entre janeiro e dezembro de 2019, já houve a propositura de 23 ações judiciais relacionadas à saúde (4), cujos valores somados chegavam a R\$ 132.348,00, superando em 64% o volume de ações registrado em 2018, e em 75% o valor das demandas.

Nesse contexto, considerou-se imperiosa a instituição de um espaço democrático que reúna as diversas esferas de governo, autoridades judiciárias e entidades representativas de gestores e profissionais de saúde, com a finalidade de legitimar a solução consensual de demandas sanitárias.

É forçoso reconhecer que novas estratégias de enfrentamento à judicialização da saúde passam por instrumentos como a mediação, visto que, como pontuam Delduque e Castro “Por desconhecer as políticas públicas formadoras do SUS, a jurisdição não tem solucionado o acesso a bens e serviços de saúde.” (15)

A mediação sanitária, com efeito, caracteriza-se como método consensual de solução de conflitos que se presta a evitar instauração de processos de caráter contencioso, além de reduzir o alcance ou mesmo extinguir as lides já submetidas ao Judiciário.

Delduque e Castro, acrescentam ainda:

O SUS tem recebido preciosa ajuda dessa forma de resolução de conflitos, com dignas iniciativas de juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados da União e procuradores, que, instituindo grupos de Mediação, realizam um trabalho a partir da demanda individual, para mediar o conflito entre o paciente/autor e o gestor da saúde, com o intuito de evitar a ação judicial (15).

Alcântara (16) anota que:

As mediações na saúde permitem que o conflito seja resolvido no âmbito da administração pública, com a participação ativa dos responsáveis pela elaboração e execução das políticas públicas do setor, além de contar com a participação de representantes dos usuários do Sistema, legitimando ainda mais o processo, por cumprir preceito constitucional da participação popular no SUS (16).

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais implementou iniciativa que pode ser tomada como referência para o município de Bataguassu. Assis (17) apontou com propriedade os fatores que justificaram a criação da Mediação Sanitária:

Em Minas Gerais, podem ser citados: a) o vasto território mineiro com 853 municípios; b) as grandes diferenças demográficas e socioeconômicas; c) o subfinanciamento público da saúde; d) a judicialização reflexiva da saúde, sobretudo em ações individuais; e) a falta do conhecimento técnico sanitário pelos seus atores jurídicos; f) a política partidária destacada na lógica municipal em detrimento da perspectiva

regionalizada; g) concorrência entres os prestadores (hospitais) sem racionalização dos custos e definição de uma vocação (identidade) sanitária; h) a falta da racionalização dos finitos recursos financeiros pelo não enfrentamento adequado da Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte; i) a insuficiência ou falta de qualificação técnica de seus gestores, inclusive pelo fato da sua constante rotatividade; j) ausência de legislação de responsabilidade sanitária; k) ausência do planejamento regional da saúde; l) fragilidade do controle social do SUS; m) processos fracos de regulação, monitoramento, fiscalização e auditoria; n) pressão pela incorporação tecnológica às avessas, muitas das vezes respaldadas por decisões em ações judiciais reflexivas; o) ausência de política pública eficaz sobre o prescritor, muitas das vezes abordado nos próprios setores públicos; p) fragilidade da cidadania coletiva ativa na tutela do direito à saúde; q) dificuldade no avanço da implantação do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde (COAP), sobretudo pela deficiência de sua técnica e proposta institucional, haja vista a utopia de sua consolidação e regulação em contrato único, versando sobre as ações e serviços de saúde das diferentes Redes(17).

Diante de todo o exposto, a intervenção proposta no trabalho foi a institucionalização de Comitê de Mediação Sanitária, com atuação não apenas no município de Bataguassu, mas em todos os municípios da microrregião de saúde de Três Lagoas, da qual também fazem parte os municípios de Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Selvíria, Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo (18).

A intervenção por meio de uma forma institucionalizada de mediação encontra como paradigmas as experiências promovidas pelo Ministério Público de Minas Gerais (já mencionada), pela Câmara Distrital de Mediação em Saúde (CAMEDIS) do Distrito Federal, e do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), no Rio Grande do Norte.

Em Minas Gerais, as ações de mediação sanitária foram promovidas por meio do Centro Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde (CAO/Saúde), que realizava encontros entre o Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, gestores e conselheiros municipais, entidades do terceiro setor e comunidades. Por outro lado, no Distrito Federal, a mediação foi instituída por ação conjunta da Secretaria de Estado da Saúde e da Defensoria Pública, na qual a última atuava como mediadora nos conflitos entre cidadãos e a Secretaria de Saúde.

Já no Rio Grande do Norte, a mediação envolveu a Procuradoria da União, a Defensoria Pública da União, procuradores estaduais e municipais, além da secretaria estadual e das secretarias municipais de saúde, que buscavam, em conjunto, soluções administrativas para as demandas envolvendo os cidadãos e o SUS.

No Mato Grosso do Sul, como já citado no capítulo anterior, a Comissão Intergestores Bipartite homologou a adesão dos municípios integrantes da microrregião de saúde de Ponta Porã à mediação sanitária coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (12).

Um exemplo prático da atuação de tais instâncias puderam ser observado na experiência no município de Jataí, no Estado de Goiás, no qual a 2ª Promotoria de Justiça, por meio do Programa de Mediação Sanitária, desenvolveu propostas de implementação de novos fluxos de atendimento às demandas por prestação de saúde e realizou audiências de mediação pré-processuais e facilitando a interlocução direta entre usuários e gestores do SUS. Tudo visando a construção de soluções negociadas e a consequente redução da judicialização (19).

Na referida Comarca do Estado de Goiás, o Ministério Público atuou em parceria com o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), do Judiciário, que disponibilizava sua estrutura física, e com o Poder Executivo local, com a participação efetiva de servidores, procuradores e do titular da Secretaria de Saúde.

Em Jataí, nos primeiros dois meses de funcionamento, o programa realizou 30 audiências, resultando em 24 acordos, prezando sempre pela mínima formalidade: as demandas eram recebidas tanto pelo ministério público, quanto pela secretaria municipal de saúde, ou mesmo pelo CEJUSC. Enquanto os dois primeiros, constatando a pertinência da demanda, procediam ao encaminhamento para a mediação e agendamento de audiências semanais, comunicando aos interessados, o CEJUSC, além de igualmente recepcionar as demandas, deve dispor de profissional para atuar como mediador e dar os encaminhamentos pertinentes ao pré-processo, submetendo eventual acordo à homologação judicial (19).

Por meio da mediação sanitária, espera-se aproximar os atores públicos e privados envolvidos com a prestação da saúde na microrregião, como defensoria pública, mi-

nistério público, procuradorias estaduais e municipais, além da secretaria estadual de saúde e das secretarias municipais de saúde. Desta forma, busca-se construir soluções negociadas e sustentáveis, viabilizando o acesso dos cidadãos aos serviços públicos de saúde, reduzindo a judicialização.

Considerações Finais

Propor uma estratégia de intervenção para enfrentamento da judicialização da saúde foi uma tarefa desafiadora e esclarecedora, em iguais proporções.

O desafio não estava, contudo, relacionado aos grandes números nacionais de demandas em desfavor do SUS, como se poderia imaginar, o diagnóstico da judicialização da saúde em Bataguassu pode parecer irrelevante, se considerados apenas os dados quantitativos, no entanto, para as contas municipais, tais episódios têm impacto direto na prestação de serviços e controle regular do orçamento.

De fato, é no confronto dos números com o contexto que se demonstra a relevância dos problemas que se pretende enfrentar. Por outro lado, embora a judicialização possa, no começo, evidenciar desafios no acesso aos serviços de saúde, há que se considerar que a solução não cabe apenas ao gestor municipal do SUS.

Vale ressaltar que outros atores, como, por exemplo, a Defensoria Pública e o Ministério Público, além do Judiciário têm sua parcela de responsabilidade. Muito mais do que explorar indefinidamente as causas das dificuldades de acesso, que são verdadeiras e levam os cidadãos a buscar a proteção de seus direitos, é no encontro das capacidades e visões distintas, é no exercício democrático e participativo das atribuições institucionais, que se encontra a solução e o caminho para concretizar as disposições constitucionais que asseguram ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

Referências

- 1 - Brasil. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Cidades IBGE [citado 16 set 2019]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>.
- 2 - Mato Grosso do Sul. **Lei 4.904, de 24 de agosto de 2016**. Regulamenta a Emenda Constitucional que acrescenta o art. 112-A à Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul; promove a elevação de comarcas à categoria de segunda entrância; altera e acrescenta dispositivos à Lei 1.511, de 5 de julho de 1994, e dá outras providências. [Internet] Campo Grande: 2016. [acesso em 30 out 2019]. Disponível em: <https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro1243506/lei%20n%C2%BA%204.pdf>.
- 3 - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). **Painel de Apoio à Gestão** [Internet]. Brasília: 2019 [acesso em 23 dez 2019] Disponível em <https://www.portalgestaoconasems.net/teto-mac>.
- 4 - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Processos 2019, janeiro a novembro**. Assessoria de Planejamento. [Internet] Campo Grande: 2019. [acesso em 23 dez 2019]. Disponível em https://tjms.jus.br/_estaticos_/nat/estatisticas/processos-2019-01-a-11.pdf.
- 5 - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Processos 2018, janeiro a dezembro**. Assessoria de Planejamento. [Internet] Campo Grande: 2019. [acesso em 12 dez 2019]. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/nat/estatisticas/processos-2018-01-a-12.pdf.
- 6 - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Relatório Biênio 2017-2018: Uma gestão voltada para pessoas. Secretaria de Comunicação do TJMS**. [Internet] Campo Grande: 2019. [acesso em 30 out 2019]. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/sc/publicacoes/relatorio-gestao-2017-2018.pdf.
- 7 - Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. **A importância do Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde e do Núcleo de Apoio Técnico NatJus**. [Internet] Campo Grande: data desconhecida [citado em 20 jan. 2020]. Disponível em: https://tjms.jus.br/_estaticos_/nat/cartilha.pdf 7.
- 8 - Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. **Membros do Núcleo de Apoio Técnico. Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde**. [Internet] Campo Grande, 2019. [acesso em 20 jan. 2020] Disponível em <https://tjms.jus.br/nat/membros.php>.
- 9 - Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. **Terceiro Termo Aditivo ao Convênio, 02.008/2016**. [internet]. Campo Grande: 2019. [acesso em 20 jan. 2020]. Disponível em: https://tjms.jus.br/_estaticos_/nat/TermoAditivoIII.pdf.

10 – Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. **Coordenador do Comitê de Saúde do TJMS faz balanço do 2019**. [Internet]. Campo Grande: 2019. [acesso em 20 jan. 2020]. Disponível em: <https://tjms.jus.br/noticias/visualizarNoticia.php?id=57105>.

11 – Brasil. Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário. **Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação no Brasil**. [Internet] Brasília: 2014. [acesso em 20 jan. 2020]. Disponível em: <http://mediacao.fgv.br/wp-content/uploads/2015/11/Estudo-qualitativo-sobre-boas-praticas-em-mediacao-no-Brasil.pdf>.

12 – Mato Grosso do Sul. Secretaria de Estado da Saúde. **Resolução n.º 3/CIB/SES/MS, de 10 de abril de 2017**. Aprova as decisões da Comissão Intergestores Bipartite. [Internet]. Campo Grande: 2017. [acesso em 20 jan. 2020]. Disponível em: <https://sistemas.saude.ms.gov.br/eArquivos/op/op.ViewOnline.php?documentid=2847&version=1>.

13 – Mato Grosso do Sul. Secretaria de Estado de Saúde. **Resolução n.º 78/SES/MS, de 8 de outubro de 2018**. Aprova o Regimento Interno da Comissão de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde de Ponta Porã. [Internet]. Campo Grande: 2018. [acesso em 20 jan. 2020]. Disponível em: http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9760_10_10_2018.

14 – Brasil. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul. **Ministério Público realiza reunião inédita de Mediação Sanitária em Naviraí**. [internet]. Campo Grande: 2019. [acesso em 29 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/noticias-ms/ministerio-publico-realiza-reuniao-inedita-de-mediacao-sanitaria-em-navirai>.

15 – Delduque Maria Célia, Castro Eduardo Vasquez de. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil**. Saúde debate [Internet]. Rio de Janeiro: 2015 [acesso em 22 fev 2020]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042015000200506&lng=en. <https://doi.org/10.1590/0103-110420151050002017>.

16 – Alcântara Luiz Paulo Rice Puti. **Contribuições das mediações sanitárias para o SUS: estudo de caso**. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações [Internet]. Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG. Alfenas: 2018 [acesso em 22 fev 2020]. Disponível em: <https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1110>.

17 – Assis Gilmar de. **Mediação Sanitária: Direito, Saúde e Cidadania**. Conselho Nacional de Secretários de Saúde- CONASS. [Internet] Brasília: 2015 [acesso em 22 fev 2020]. Disponível em: http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/CONASS-DIREITO_A_SAUDE-ART_14B.pdf.

18 – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). **Painel de Apoio à Gestão** [Internet]. Brasília: 2019. [acesso em 22 fev 2020] Disponível em <https://www.portal-gestaoconasems.net/estabelecimentos-saude>.

19 – Goiás. **Ministério Público do Estado de Goiás. Programa de mediação sanitária é inaugurado com 80% de resolução em Jataí.** [Internet] Goiânia: 15 maio 2018 [acesso em 6 mar 2020]. Disponível em: <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/programa-de-mediacao-sanitaria-e-inaugurado-com-80-de-resolucao-em-jatai#.XmJ7Z6hKiUk>.



Estudo sobre a judicialização de leitos de unidade de terapia intensiva no município de Goiânia-GO no exercício de 2017

Amanda Medeiros¹

Amarildo de Sousa²

Elisiane Bello Jakybalis³

Jussinaldo Duarte Santos⁴

Kátlei Magáli Kussler⁵

Maria Lucilene Ribeiro das Chagas⁶

Rodrigo César de Moura Castro Alves⁷

Orientadora: Profa. MSc. Cássia de Fátima Rangel Fernandes

O presente artigo se refere ao projeto de intervenção, realizado no Município de Goiânia em que se privilegiou o diagnóstico da judicialização da saúde e possibilidades de intervenção para seu enfrentamento. O projeto privilegiou a análise das ações judiciais que demandavam leitos de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no ano de 2017.

¹ Graduada em Direito pela UESPI e pós-graduada em Direito Administrativo pela Escola do Legislativo do Piauí. Assessora Jurídica da SMS de Timon-MA.

² Graduado em Enfermagem pela UEMG. Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis-MG.

³ Graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba e pós-graduada em Direito Administrativo Aplicado pelo Instituto Romeu Felipe Bacellar. Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul.

⁴ Graduado em Farmácia pela Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF).

⁵ Graduada em Direito pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Equipes Gestoras de Saúde pela UFRGS e mestre em Gestão de Políticas Públicas de Saúde pela Universidade de Bologna. Membro da Assessoria Jurídica da SES-RS.

⁶ Graduada em enfermagem pela UEPA e pós-graduada em Educação Profissional na Área da Saúde pela ENSP- Fio-cruz. Secretária Municipal de Saúde de Abaetetuba-PA.

⁷ Graduado em Farmácia pela UFAL. Servidor da SMS de São Miguel dos Campos-AL.

A fonte secundária para a obtenção dos dados quantitativos da pesquisa foi fornecida pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em que foi fornecida planilha contendo 179 (cento e setenta e nove) processos ajuizados em face do município, todos relativos a leitos de UTI.

Foi realizada análise individualizada dos processos bem como pesquisa juntamente aos *sites* dos Poderes Judiciários estadual e federal, visando obter as seguintes informações: a) número dos autos, b) juízo, c) tipo de ação, d) parte autora, e) forma de representação, f) parte requerida, g) pedido/objeto da ação, h) decisão liminar/tutela de urgência, i) sentença, j) fase processual; oportunidade em que se constatou que apenas 87 (oitenta e sete) processos possuíam o referido objeto.

Por sua vez, as fontes utilizadas para a obtenção dos dados qualitativos, no que diz respeito às estratégias de enfrentamento à judicialização da saúde atualmente existentes, foram a Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde da Comarca de Goiânia (CEJUSC) da Saúde.

A definição da estratégia metodológica orientou-se, também, pela articulação das técnicas quantitativas e qualitativas, nas quais buscam, no estudo em questão, quantificar as ações judiciais que demandam à saúde, considerando os processos protocolados no ano de 2017, com o citado objeto, relativamente aos julgados de primeira instância.

Em seguida foi realizada a análise e consolidação dos dados, propiciando uma classificação objetiva das demandas judiciais, a fim de oferecer um diagnóstico da situação da judicialização da saúde no município de Goiânia/GO, no ano de 2017, relativa ao objeto fornecimento de vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), assim como foi realizada a análise acerca estratégias de enfrentamento à judicialização da saúde atualmente existentes, para ao final apresentar novas alternativas de resolução de conflitos que não sejam aquelas impostas pelo Poder Judiciário.

Diagnóstico da judicialização no município

A judicialização da saúde não é um fenômeno observado apenas no Brasil. Contudo, em nosso país tem se revelado como um dos maiores problemas para os gestores da saúde que, diante do crescente número de decisões judiciais que concedem desde medicamentos, internações, cirurgias e até mesmo aulas de *pilates*, retirou do Poder Executivo (e seus agentes) a autonomia administrativa e a capacidade financeira para executar os planejamentos realizados e atender grande parte da população que necessita de assistência à saúde, demonstrando a desconexão das decisões judiciais com as políticas públicas de saúde e as diretrizes do SUS (1).

Ações judiciais individuais vêm, ao longo dos últimos anos, impactando e comprometendo sobremaneira os recursos na área da saúde (2). Tal situação possui diversas causas, sendo possível citar como uma das principais a dificuldade que o Poder Judiciário tem, por meio da atuação de seus agentes, de entender o funcionamento do SUS (3).

O SUS é um sistema inovador de organização da saúde, criado a partir do movimento sanitário (1986), que implantou uma lógica de funcionamento que prevê competências e recursos para os três entes federados, funcionamento em forma de redes, e percentuais mínimos de financiamento, para o qual nem todos os agentes públicos foram preparados.

A lógica do Sistema não foi, imediatamente, difundida juntamente ao Poder Judiciário. Os princípios do SUS passaram a ser utilizados diariamente em conjunto com o Judiciário, com aplicabilidade imediata e, com base neles, as concessões judiciais passaram a se avolumar e produzir o que hoje conhecemos como o “fenômeno da judicialização” da saúde” (4).

Ordens de cumprimento, ordens de prisão, sequestro e bloqueios de bens se tornaram a realidade da saúde pública brasileira nas três esferas de governo, e diminuíram sensivelmente a possibilidade de assistência à saúde de milhares, por meio da execução de políticas públicas planejadas, em detrimento de poucos, com base em supervalorização de laudos médicos, autorizando concessão de liminares em larga escala (1).

Entre 2008 e 2017, segundo dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da pesquisa “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução”, o número de demandas judiciais relativas à saúde registrou aumento de 130%. O estudo apontou que a judicialização da saúde se tornou relevante não apenas para o sistema de assistência à saúde, mas também para o próprio Poder Judiciário, que tem que lidar com numerosos processos quase sempre sobre temas recorrentes e, invariavelmente, com pedidos de antecipação de tutela ou liminares (5).

No Município de Goiânia a judicialização da saúde, como em todo o Brasil, merece destaque, e vem sendo objeto de debates e construções internas na Secretaria de Saúde, e também com os demais atores envolvidos na questão, representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da representação social, por meio de reuniões e também de workshops e Fórum cujo objeto é a temática da “Judicialização” da saúde” (6).

Tal temática foi também objeto de análise de projeto de pesquisa da Universidade Federal de Goiás, coordenado pela professora Mércia Pandolfo Provin. Na pesquisa, foram analisadas as novas institucionalidades criadas para racionalizar o fenômeno da judicialização da saúde em Goiânia, abordando questões relacionadas ao enfrentamento dos gestores da saúde e dos juristas frente às distorções provocadas pela judicialização, bem como suas implicações para a Gestão do SUS e para a sociedade (7).

A pesquisa analisou 969 processos administrativos (458) e judiciais (511), cujo objeto era solicitação de medicamentos. Processos judiciais no período de 2003 a 2015, e processos administrativos, no período de 2010 a 2015. Foram avaliadas características sociodemográficas dos usuários, as enfermidades, as características dos medicamentos, o custo total dos processos e origem da prescrição na abertura do processo (público ou privado) (7).

Como conclusão, a pesquisa identificou a existência de sete institucionalidades no município, sendo quatro criadas pelo executivo e três pelo judiciário. Dentre elas estavam departamentos, comissões, câmaras técnicas e termos de cooperação técnica. Segundo a análise realizada, as institucionalidades solucionaram alguns problemas na gestão da assistência farmacêutica, oferecendo assessoria técnica ao Judiciário para análise

das demandas judiciais e promovendo o diálogo e a aproximação entre as instituições envolvidas no processo. Houve entendimento de que auxiliaram na garantia do acesso integral à saúde e reduziram o número de demandas judiciais por medicamentos propostas pelo Judiciário ao priorizar a resolução dos conflitos de acesso a medicamentos de forma administrativa (7).

Da mesma maneira, verificou-se, pela análise do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, do ano de 2017, que foi dada, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ênfase à judicialização da saúde apenas no que tange às decisões judiciais que envolvem fornecimento de medicamentos. Tal conclusão decorre do fato de ter sido realizado registro de valores gastos com mandados judiciais determinando aquisição de medicamentos e insumos, e com medicamentos não padronizados, que alcançaram o montante de R\$ 2.421.202,58, e não ter sido identificado nenhum registro relativo a custos com internações ou outros procedimentos determinados por meio de decisões judiciais (8).

Apesar da atenção à saúde englobar um conjunto grande de ações e serviços, verifica-se que a maioria dos estudos publicados sobre judicialização da saúde no Brasil abordam aspectos sobre garantia de acesso a medicamentos. Revisão integrativa publicada em 2016, que teve como objetivo sintetizar produção científica nacional sobre as demandas judiciais para acesso às ações e aos serviços de saúde, de 2005 a 2015, analisou 26 publicações agrupadas por similaridade de conteúdo, e comprova tal situação, vez que, das 26 publicações analisadas, 21 consideraram demandas envolvendo apenas acesso a medicamentos (1).

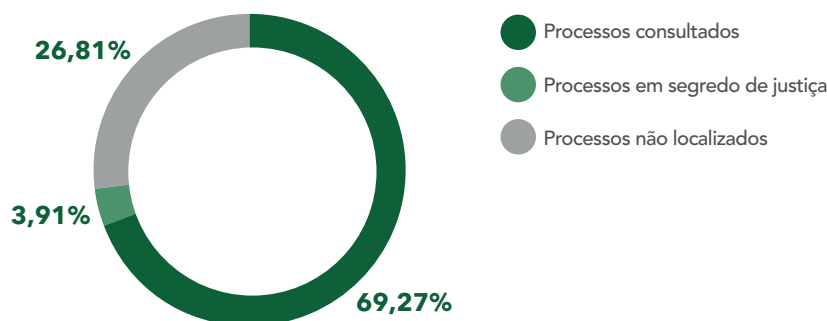
Ciente dessa situação, documentada inclusive no Relatório de Gestão do Município de Goiânia, optou-se por realizar recorte na análise das demandas judiciais, verificando apenas ações iniciadas em 2017, que tiveram como objeto busca de internação hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Tal recorte foi realizado após relato de servidora da Superintendência de Regulação, que mencionou a dificuldade de cumprimento de tais decisões judiciais no tempo definido pelo juízo, a ausência de manifestação da secretaria antes da concessão da liminar e, muitas vezes, a desnecessidade de tratamento da situação do paciente por meio de tutela de urgência.

Considerando que os dados apresentados estavam fora de ordem e sem seguir um padrão quanto às informações relativas a cada processo, bem como que havia repetição na anotação dos processos, foi realizada consulta individualizada de cada processo constante na planilha, juntamente aos *sites* dos poderes judiciários estadual e federal, visando obter as seguintes informações: a) número de autos, b) juízo, c) tipo de ação, d) parte autora, e) forma de representação, f) parte requerida, g) pedido/objeto da ação, h) decisão liminar/tutela de urgência, i) sentença, j) fase processual.

Após análise da planilha fornecida, verificou-se um total de 179 processos ajuizados em face do município. Destes, foi obtido o êxito na consulta pública de 124, por meio dos *sites* anteriormente citados. Do restante dos processos, sete estão tramitando em segredo de justiça, e por esta razão não estão disponíveis para acesso por meio da consulta pública, e 48 não puderam ser localizados por intermédio dos parâmetros informados na planilha.

Assim sendo, concluiu-se que, da quantidade total de processos indicados pela Secretaria Municipal de Goiânia na listagem fornecida, somente 69,27% puderam ser consultados para fins de levantamento das informações indicadas. Tal situação restou retratada pela Figura 1:

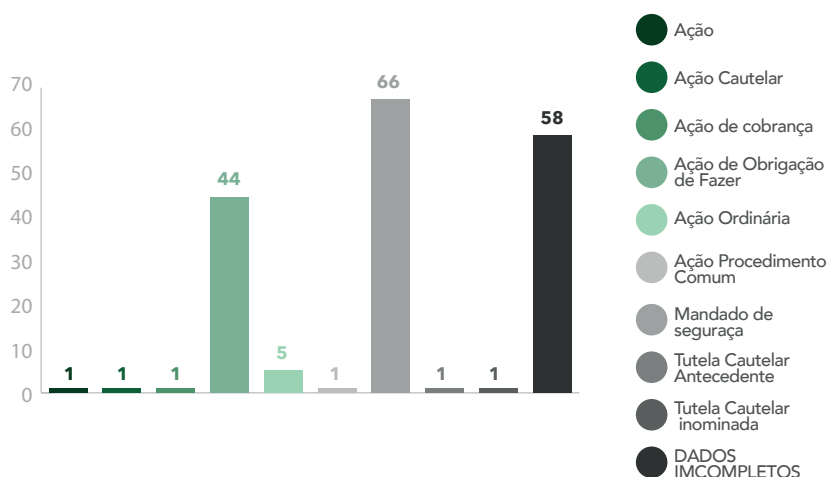
FIGURA 1. Integralidade de dados processuais informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (N=179).



Fonte: Elaborado pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Da análise realizada nos processos constantes na planilha fornecida, verificou-se o ajuizamento de ações classificadas da seguinte forma:

FIGURA 2. Distribuição das ações levantadas junto à Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no ano de 2017, por tipo de ações ajuizadas (N=179).



Fonte: Elaborado pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Pela classificação extraída dos dados da planilha não foi possível identificar, de pronto, se os dados eram referentes apenas ao objeto delineado, qual seja, fornecimento de vagas em UTI. Aliás, o registro não denomina corretamente os tipos de ações, chegando a classificar uma apenas como ação, outras como ações ordinárias, outra ainda como ação procedimento comum. Tal situação demonstra que os registros realizados pelo Município não respeitam forma, padronização ou critérios definidos.

Igualmente, o fato de que 48 processos – que correspondem à aproximadamente 26,81% do total dos processos informados –, não puderam ser localizados, por meio dos parâmetros informados na planilha, para fins de consulta pública, evidencia que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – seja por intermédio da Superintendência de Regulação ou de outro setor – não possui um registro confiável, demonstrando, do

mesmo modo, ausência de controle e monitoramento das demandas de saúde judicIALIZADAS em face do município, ao menos no que diz respeito aos leitos de UTI.

Para se chegar à análise das ações que efetivamente tratam do objeto definido foi necessário avaliar criteriosamente todos os pedidos das ações.

Não obstante a Superintendência tivesse informado que todos os processos constantes na planilha de controle fornecida eram relativos ao fornecimento de vagas em UTIs, ao analisar as informações obtidas por meio de da consulta, verificou-se que, no ano de 2017, pelos dados apurados, o município sofreu o ajuizamento de 87 ações com o referido pedido, o que não correspondente à totalidade dos 124 processos que puderam ser consultados.

Desses 87 processos, foi possível observar que os pedidos demonstraram-se variados. Alguns pacientes requereram a disponibilização de leito de UTI puro e simples e outros formulam pedido de leito de UTI específico, eventualmente com tratamentos de suporte, conforme Tabela 1:

TABELA 1. Levantamento dos pedidos formulados nos processos consultados.

VAGA DE UTI PLEITADA	QUANTIDADE DE PROCESSOS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCESSOS CONSULTADOS (87)
UTI (sem especificação)	60	68,96%
Pediátrica	02	2,29%
Coronariana	01	1,15%
Neonatal	02	2,29%
Com suporte em hemodiálise	06	6,89%
Com suporte em cirrose hepática e insuficiência cardíaca	01	1,15%
Com suporte em neurologia	02	2,29%
Com suporte em hematologia	01	1,15%
Com suporte em urologia	01	1,15%

Com suporte em cardiologia	06	6,89%
Com suporte em cardiologia e hemodíalise	01	1,15%
Com suporte em hematologia e mielograma	01	1,15%
Com suporte dedialítico	01	1,15%
Com suporte em nefrologia	01	1,15%
Com suporte em hemodinâmica	01	1,15%
TOTAL DE PROCESSOS	87	

Fonte: Elaborada pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Igualmente, mediante consulta pública individualizada de cada processo constante na planilha, também foi possível observar que 41 ações foram propostas por pessoas do gênero feminino, 45 ações por pessoas do gênero masculino. Somente em uma ação não foi possível fazer essa distinção, em razão de não constar o nome da parte autora.

Esses números demonstram certa paridade entre os ajuizamentos, pois o gênero masculino representa 51,72% dos pedidos de leitos de UTI, enquanto o gênero feminino representa 47,12% dessas ações.

Por fim, oportuno observar que, ainda que o pedido de fornecimento de vagas em UTI não seja responsável pela integralidade das ações intentadas em face do município relativas às ações e serviços de saúde no ano de 2017, sobretudo no que diz respeito a ações que visam vaga de internamento, o resultado atinente a 87 ações com pedido de disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva demonstra que esse objeto se configura como um relevante componente da alta demanda de judicialização do município de Goiânia.

Em análise das informações disponibilizadas pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, notadamente quanto às ações que tiverem como objeto pedido de vaga de leito em UTI, relativos ao exercício de 2017, é possível observar a variedade na representação do autor/paciente.

Conforme a Tabela 2, das 87 ações relativas à leito de UTI, 45,97% foram ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual da parte, 34,48% pela Defensoria Pública do Estado, 6,89% pela Defensoria Pública da União e 11,49% por advogado privado.

TABELA 2. Demonstrativo acerca da forma de representação do paciente.

REPRESENTAÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS	PERCENTUAL
Ministério Público em Substituição da Parte	60	68,96%
Defensoria Pública Estadual	02	2,29%
Defensoria Pública da União de Goiás	01	1,15%
Advogado privado	02	2,29%
Não identificado	06	6,89%
TOTAL	87	100%

Fonte: Elaborada pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Como se vê, a grande maioria das ações foi proposta ou pelo Ministério Público Estadual ou pelas Defensorias Públicas (seja Estadual ou da União), sendo reduzidas ações onde a parte é assistida por um patrono da esfera privada.

Assim, diante do crescente aumento da judicialização das ações e serviços de saúde, em muitos estados tem se verificado a especialização do Ministério Público e da Defensoria Pública para atendimento dessas demandas, bem como para realizar ações conjuntas para a melhoria dos serviços de saúde pública, em atendimento ao direito à saúde. No Estado de Goiás, não tem sido diferente.

Conforme se verifica do texto do art. 134 da Constituição Federal, em síntese, à Defensoria Pública incumbe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, consoante art. 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna (9).

Desta forma, nas ações relativas ao direito à saúde, às defensorias públicas competem atuar em favor dos usuários e/ou consumidores que se enquadrem como necessitados, nos termos dispostos na Constituição Federal.

No que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), é possível afirmar que a instituição vem atuando em larga escala no que se refere à matéria de saúde, pois, consoantes dados estatísticos da defensoria pública do referido estado, em 2017 foram propostas pela instituição 313 (trezentas e treze) ações relativas ao Direito da Saúde, de janeiro a dezembro de 2017 (10).

Não foi possível vislumbrar o percentual dessas ações que se referem ao serviço público de saúde, vez que, “o atendimento da DPE-GO abarca o acesso à saúde quando há negativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e ou planos de saúde, podendo atuar, administrativamente ou judicialmente” (11), e nos dados estatísticos disponibilizados via internet, não há diferenciação entre ações de saúde pública e de saúde suplementar.

Possivelmente, a elevada quantidade de ações propostas pela defensoria estadual, relativas ao Direito à Saúde, decorre do fato de que, em Goiânia, existe núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial em Saúde, bem como porque a DPE-GO atende em regime de plantão, inclusive 24 (vinte e quatro) horas aos finais de semana e feriados. Nos “casos de urgência (como internação em leito de UTI) o atendimento é realizado pela Central de Plantão da DPE-GO” (11).

Com relação à Defensoria Pública da União (DPU), não obstante atue com muita frequência na área da saúde, com auxílio gratuito ao cidadão de baixa renda na busca por atendimento (12), não foi possível verificar no site da instituição dados estatísticos sobre a quantidade de atendimentos e ações propostas tendo como objeto o direito à saúde, tendo sido localizado tão somente que, em 2017, a DPU em Goiânia-GO realizou 26.883 atendimentos (13), sem maiores discriminações sobre os dados.

O Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO), por sua vez, também tem atuado como substituto processual de usuários do Sistema Único de Saúde, diante da caracterização da saúde como direito individual indisponível, que atrai a competência ministerial prevista pela Lei Orgânica do Ministério Público (14), dando legitimidade para o órgão atuar até mesmo em favor de beneficiários individualizados, em ações propostas contra entes federativos (15).

Para demonstrar a preocupação do MP-GO em realizar atuação especializada, é relevante ressaltar que, “para organizar sua atuação, o MP-GO conta com os Centros de Apoio Operacional (CAOs) definidos para as áreas mais demandadas” (16).

A área da saúde é uma delas, razão pela qual foi criado o CAO Saúde, que dentre outros, dá apoio técnico-jurídico à atuação dos procuradores e promotores de Justiça (17):

A área da Saúde integra o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Goiás, encontrando-se, dentre suas atribuições, dispensar apoio técnico-jurídico às Promotorias e Procuradorias de Justiça, nas demandas individuais e coletivas, consolidando, inclusive, as políticas públicas de saúde; proporcionar a aproximação do MPOG dos demais órgãos, buscando a solução de conflitos e o desenvolvimento de projetos em comum, bem como elaborar programas e projetos de relevância social (17).

Desta forma, percebe-se que a atuação do Ministério Público Estadual tem sido muito além da judicialização, englobando também ações visando à melhora do serviço público de saúde, mediante, inclusive, realização de reuniões com representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Goiânia para aprimoramento de ações e serviços de saúde (18), o que, consequentemente, influencia diretamente no número de ações propostas perante o Poder Judiciário.

Da mesma forma que a DPE-GO, o MP-GO contaram com atendimento de Plantão Saúde, mediante contato telefônico, com serviço “específico para atendimento das solicitações de urgência/emergência, especialmente de internações na rede pública de saúde, que chegam ao Ministério Público do Estado de Goiás fora do horário do expediente” (19).

Diante de toda essa exposição e considerando que o direito à saúde se trata de garantia constitucional, verificou-se que o atendimento aos usuários do SUS foi facilitado junto às Defensorias Públicas e ao Ministério Público Estadual, fato esse que pode estar relacionado à representação dos pacientes ser realizada em maior quantidade por estas instituições.

Inicialmente, por meio de uma análise a âmbito nacional, percebeu-se que na área da terapia intensiva não há qualquer equidade na distribuição de leitos, existindo desigualdades regionais e limitações de acesso e de excelência dos serviços prestados, assim, tal disparidade prejudica as classes mais carentes da população.

Por meio de da Portaria de Consolidação n.º. 2, de 28 de setembro de 2017, que em seu anexo XXVI institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), as centrais de regulação surgem objetivando, especialmente, a melhoria no acesso justo e igualitário do usuário no SUS, trabalhando com o estabelecimento de critérios e escalas das situações de saúde do paciente, além de organizar os recursos da pasta, funcionando assim, como verdadeiros instrumentos de gestão de demandas na saúde (20). Até então, ouvia-se falar de regulação no âmbito da saúde apenas por meio de da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 01/2002 (21).

A PRC MS/GM 02/2017, em seu art. 2º do anexo XXVI, afirma que as ações constituintes da estruturação dos processos regulatórios no SUS compreendem três dimensões de atuação, entre elas, nos termos (20):

III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.

Assim, diante do exposto, entende-se que a Regulação do Acesso à Assistência compreende alternativas que mais se adequem às necessidades do cidadão no que se diz respeito ao atendimento de urgências, consultas e leitos, nos termos de seu art. 5º (20):

I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências; (Origem: PRT MS/GM 1559/2008, Art. 5º, I)

II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados; (Origem: PRT MS/GM 1559/2008, Art. 5º, II)

III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais; e (Origem: PRT MS/GM 1559/2008, Art. 5º, III)

IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes.

Atendendo as Diretrizes para a Implantação de Complexos Reguladores, mostra-se necessário que toda demanda da qual se tenha conhecimento apresente parâmetros previamente definidos para gerência e organização da distribuição de leitos, consultas e exames. Ainda, deve haver uma pactuação com os prestadores, por meio de formalização contratual, atualização cadastral constante dos estabelecimentos, profissionais e usuários, assim, haverá sempre uma manutenção dos fluxos internos para acesso o que se é pedido pelo usuário (22).

Para padronização das solicitações de internação, especialmente, mostra-se necessária a adoção de protocolos para realização dos encaminhamentos, para criar fluxos ágeis e sem o mínimo de interferências possíveis em sua execução para a rápida autorização do procedimento solicitado em questão (23).

Além disso, faz-se imprescindível que haja um controle técnico na admissão desses pacientes, visando impedir a “fura de filas” e que a necessidade prioritária dos pacientes seja respeitada.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução n.º 2.516 de 2016 (24), estabeleceu os critérios de admissão e alta em unidades de terapia intensiva, especialmente pela elevada demanda de decisões judiciais sem o entendimento

técnico necessário.

A priorização da admissão na UTI, deve, segundo a resolução, respeitar critérios nivelados de 1 a 5, onde os pacientes mais necessitados são aqueles que atendem ao grau 1 de prioridade, ou seja, necessitam de intervenções de suporte à vida e com alta probabilidade de recuperação em seu prognóstico (24).

A normativa em questão foi utilizada como principal embasamento na confecção do Parecer n.º 00213/2017 (25) proposto pela Advocacia-Geral da União (AGU), Consultoria-Geral da União (CGU), Consultoria Jurídica juntamente ao Ministério da Saúde (CONJUR-MS) e Advogados da União (CODEJUR) que possui como ementa o acesso aos leitos de UTI.

Ele teve como principal objetivo demonstrar que a União deveria ser retirada do polo passivo de tal demanda, visto que não possui acesso e controle dos dados geridos pelas redes regulatórias municipais e estaduais, ambas responsáveis por prestar os serviços de saúde de forma material (25).

O parecer também deixa clara a necessidade do uso racional de tais leitos, uma vez que o número de unidades, disponibilizadas nacionalmente, é muito abaixo do esperado e não há distribuição regional igualitária, além de recursos escassos para implementação desse quantitativo. Assim, o documento evidencia em sua conclusão que cabe ao médico classificar a prioridade do paciente além de faltar ao Poder Judiciário um conhecimento técnico na tomada de decisões quanto a essas demandas, a fim de garantir o respeito a ordem cronológica dos pacientes presentes na fila de espera (25).

Segundo a PRC MS/GM 02/2017, é dever dos municípios operacionalizarem o complexo regulador municipal e/ou participar em cogestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais; coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e nacionais; regular a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos; garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada e integrada e

elaborar normas técnicas complementares às das esferas estadual e federal (20).

Goiânia, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apresenta uma Central de Regulação com atendimento presencial, por telefone e internet. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), o fluxo de atendimento do usuário consiste, primeiramente, na consulta em uma unidade básica de saúde, hospital municipal ou regional. Comprovada a necessidade de assistência especializada de maior complexidade pelo especialista na consulta inicial, a requisição é encaminhada para a Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde e analisada de acordo com a pactuação entre o município de origem do usuário e a cidade que ofereceu o atendimento. Entre as demandas mais comuns, está a disponibilização de vagas em UTI (26).

Analisando detidamente os 87 processos, que puderam ser consultados, os quais se referem às ações que apresentam pedidos de disponibilização de leitos em UTI, relativos ao ano de 2017, verifica-se que em absolutamente todos eles, a parte autora formulou pedido de liminar ou de tutela de urgência. As decisões, em primeira instância, sobre esses pedidos ficaram distribuídas na forma constante na Tabela 3 a seguir.

TABELA 3. Levantamento das decisões judiciais proferidas em primeira instância sobre os pedidos de liminar ou de tutela de urgência dos processos que requerem a disponibilização de vaga de internamento em leito de UTI, no município de Goiânia, no ano de 2017.

DECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA	QUANTIDADE DE PROCESSOS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCESSOS CONSULTADOS (87)
Liminar ou Tutela de Urgência Deferida	84	96,55%
Liminar ou Tutela de Urgência Deferida Parcialmente	01	1,15%
Liminar ou Tutela de Urgência Indeferida	02	2,30%
TOTAL	87	100%

Fonte: Elaborada pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Em consulta ao teor dessas decisões que concederam as liminares ou tutelas de urgência requeridas, percebe-se que, no geral, a fundamentação adotada pelos magistrados tem como base os artigos 6º e 196º da Carta Magna (9) e, ainda, o artigo 2º da Lei n.º 8.080/90 (27), afirmando que o direito à saúde se constitui em cláusula constitucional pétrea, sendo um direito fundamental do indivíduo, assim como um dever do Estado, para garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visam a prevenção de doenças e outros agravos, bem como ações que assegurem sua promoção, proteção e recuperação.

Fundamentam, também, que nas situações em que pacientes necessitem de vagas em hospitais, inclusive em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou equivalentes, o Poder Judiciário possui legitimidade para determinar ao Poder Público que as forneçam ou, na hipótese de inexistirem leitos disponíveis na rede pública, que custeie os gastos realizados em estabelecimento privado.

Observou-se das decisões, que o entendimento dos magistrados de primeira instância é o de que a obrigação dos entes da federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde aos pacientes é solidária.

Por fim, para justificar a urgência necessária para a concessão do pedido em análise perfunctória, motivam as decisões liminares em laudos médicos juntados aos autos pela parte autora e, quando existente, em informações obtidas junto à Central de Regulação.

A partir do exame desses processos, cujo objeto refere-se à vaga em leito de UTI, foi possível levantar que 81,60% das ações foram extintas sem resolução de mérito, ou seja, mediante decisões de caráter simplesmente terminativo, sem análise do objeto em discussão pelo magistrado.

Conforme dados apresentados na Tabela 4, na maioria dessas decisões terminativas, sem resolução de mérito, foi reconhecida a perda do objeto (ou ausência de interesse processual), diante do atendimento do pedido, com o cumprimento da decisão liminar

ou de tutela de urgência ou, ainda, em razão do óbito do paciente.

TABELA 4. Levantamento das sentenças proferidas sem resolução de mérito nas ações com objeto de fornecimento de leito em UTI no município de Goiânia, em 2017.

SENTENÇAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO	QUANTIDADE DE PROCESSOS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCESSOS CONSULTADOS (87)
Perda do objeto – atendimento do pedido	31	35,63%
Perda do objeto – falecimento da parte	33	37,93%
Desistência da parte autora	05	5,75%
Abandono do processo pela parte autora	02	2,29%
TOTAL	71	81,60%

Fonte: Elaborado pelos autores com base na análise dos processos informados pela Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Apenas 14 das 87 ações tiveram sentenças proferidas com resolução de mérito, relativo ao recorte em estudo, correspondendo ao percentual de 16,09%. Em todas essas sentenças, os pedidos foram julgados integralmente procedentes.

Vale ressaltar também que foram apurados apenas dois processos que, até janeiro de 2020, não tinham sentença proferida.

Quanto à extinção dos processos sem resolutividade do mérito, apesar da quantidade de processos cujos pedidos pleiteados foram atendidos satisfatoriamente, salienta-se também o número elevado de processos extintos por perda do objeto ou por óbito da parte autora.

Quanto à primeira situação (perda do objeto), denota-se que muitas das decisões liminares ou de tutela de urgência foram proferidas em caráter satisfativo, ou seja, concedendo a imediata realização do direito buscado pela parte.

Assim, foi possível observar que o cumprimento das referidas decisões pelo município

influenciou nas sentenças proferidas, vez que com a perda do objeto, em muitas demandas houve a extinção do processo sem a análise do mérito do pedido.

A segunda situação (óbito da parte autora), por sua vez, reacende duas discussões: a) se as decisões judiciais estão de fato embasadas em critérios técnico, conforme preceitua a Resolução CRM n.º 2.516/2016 (24), e são satisfatórias no que diz respeito ao custo-utilidade, trazendo efetivo benefício ao paciente ou, pelo contrário, se estão servindo para dar atendimento à obstinação terapêutica; e b) a problemática de vagas insuficientes em leitos de UTI, não somente em Goiânia, mas em todo o Brasil.

No que concerne a esta última problemática, destaca-se que em junho de 2016 a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia afirmou que, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de leitos de UTI aumentou cerca de 45,35%, passando de 269 para 391 leitos entre 2010 e 2016 (28).

O referido fato, apesar de muito positivo, deixa de surpreender quando se analisam dados relativos a um ano após a publicação da notícia, fazendo que se torne visível que a resolutividade de toda essa problemática se encontra longe de possuir um fim.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

Após a realização do diagnóstico da judicialização da saúde no município de Goiânia, também se demonstrou necessário o estudo acerca das estratégias de enfrentamento que vinham sendo adotadas pelo referido município, assim como outras que eventualmente poderiam ser adotadas, visando assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde, a resolução dos conflitos ainda na esfera administrativa, evitando o ajuizamento de novas demandas judiciais, a prevenção de novos conflitos e, consequentemente, a redução do comprometimento da receita com despesas decorrentes da judicialização das políticas de saúde.

Em abril de 2009, foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a Audiência Pública n.º 4, para “ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões técnicas, cien-

tíficas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de saúde” (29).

A partir dos resultados obtidos na referida audiência pública, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) organizou um grupo de trabalho, culminando na aprovação da Recomendação n.º 31, de 30 de março de 2010 (30), pelo Plenário do CNJ, que trouxe recomendação aos Tribunais, para adotar medidas objetivando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, com a finalidade de se obter maior eficiência na resolução das ações judicializadas que envolvem a assistência à saúde.

Posteriormente, em 6 de abril de 2010, o CNJ publicou a Resolução n.º 107 (31), que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde – Fórum da Saúde.

Consoante destaca o CNJ (32):

O Fórum da Saúde é coordenado por um Comitê Executivo Nacional e constituído por Comitês Estaduais. A fim de subsidiar com informações estatísticas os trabalhos do Fórum, foi instituído, por meio da Resolução 107 do CNJ, um sistema eletrônico de acompanhamento das ações judiciais que envolvem a assistência à saúde, chamado Sistema Resolução 107. Após realizar dois encontros nacionais, o Fórum da Saúde ampliou sua área de atuação para incluir a saúde suplementar e as ações resultantes das relações de consumo.

No âmbito do estado de Goiás, nos termos da Recomendação n.º 36, de 12 de julho de 2011 – CNJ (33), foi constituída a Câmara de Saúde do Judiciário (CSJ), por meio de do “Termo de Cooperação Técnica n.º 001/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, a Justiça Federal em Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, a Secretaria de Saúde do Município de Goiânia e o Comitê Executivo Estadual” (34). A referida câmara atualmente denomina-se Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) (34).

O NATJUS é composto por três membros titulares de reconhecido saber e competência profissional, sendo dois médicos e um farmacêutico, colocados à disposição do Tribunal de Justiça pela Secretaria de Estado da Saúde e com vínculo direto com o Diretor do Fórum da Comarca de Goiânia. Conta também com uma secretaria com-

posta por um secretário e por um secretário substituto, que serão disponibilizados pelo TJ/GO com a incumbência de fornecer o apoio administrativo necessário ao funcionamento do Núcleo (35).

Conforme o Regimento da Câmara de Saúde do Judiciário (artigo 3º), compete a CNS/NATJUS, na sua análise, manifestar-se quanto à definição de métodos, de procedimentos científicos e tecnológicos relativos particularmente à análise de eficácia e de segurança de materiais e/ou medicamentos, por meio de da medicina baseada em evidências e com base nas diretrizes médicas da Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM); avaliar o objeto da demanda consoante os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, literatura médica com evidências científicas estabelecidas, exames e prontuários médicos dos paciente e relatórios do médico prescritor e assistente; avaliar os critérios diagnósticos do tratamento pleiteado, observando ética e tecnicamente a prescrição médica, verificando a regulamentação de suas indicações, se há mecanismos de uso e monitoramento de resultados além de informar ao Magistrado em caso de parecer técnico favorável, com base na legislação de regência da matéria, o gestor responsável pelo fornecimento do respectivo tratamento/serviço/medicamento (35).

Desta forma, denota-se que o NatJus é um órgão do Comitê Executivo Estadual que tem por finalidade privativa assessorar os magistrados, emitindo pareceres técnicos/científicos nas consultas formuladas pelos membros do Poder Judiciário nos procedimentos relativos à saúde(34).

Vale ressaltar que as atribuições do NatJus não se confundem com as competências de magistrados e outros órgãos/entidades, vez que os pareceres do Núcleo são estritamente de essência consultiva, com o fito de assistir aos magistrados, que decidem com fulcro no princípio do livre convencimento motivado do juiz (36).

Portanto, “não compete ao NatJus a interpretação jurídica da situação descrita nos autos, ou a manifestação sobre procedência ou improcedência do pedido”, ao passo que os “pareceres técnicos não se valem de poder decisório, ou normativo vinculante sobre as questões da judicialização consultada” (36).

No entanto, é importante ressaltar que o NatJus tem se demonstrado um importante

instrumento, no município de Goiânia, para o enfrentamento da judicialização da saúde, pois, diante do acesso pelos magistrados a pareceres com base em evidências científicas, suas decisões podem ser qualificadas, ante ao aprimorando o conhecimento técnico dos juízes para a solução das demandas, imprimindo racionalidade às decisões judiciais na área da saúde, questão essa fundamental para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, porquanto, viabiliza o equilíbrio entre o direito individual e o direito coletivo à saúde.

Outro tema importante é a mediação, que se trata de um método alternativo de resolução de conflitos, não adversarial, confidencial e voluntário, conduzido por uma terceira pessoa (mediador) que, de modo imparcial e neutro, auxilia no diálogo entre as partes envolvidas no conflito, objetivando obter um ajuste, isto é um acordo quanto à querela existente. Nas palavras de Pinho, “mediação é um processo decisório conduzido por terceiro imparcial, para auxiliar as partes a identificar ou desenvolver soluções consensuais” (37). Assim, por se tratar procedimento consensual, a autonomia da vontade das partes deve pautar a mediação.

Conforme ponderado por Delduque e Castro (38), “a mediação, como método pacífico de gestão de conflitos, pretende evitar a abertura de processos judiciais de caráter contencioso e pôr fim àqueles iniciados ou reduzir o seu alcance”. Ainda, segundo os mesmos autores, a mediação sanitária, por sua vez, é “um modelo alternativo de resolução de conflitos na área da saúde” (38).

Desta feita, chama-se de mediação sanitária quando esse método de resolução de conflitos ocorre dentro do ambiente de saúde, buscando soluções para conflitos relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às políticas de saúde, que eventualmente possam ser judicializados. Uma particularidade da mediação sanitária refere-se à possibilidade de o mediador sugerir soluções para a controvérsia.

Na legislação brasileira, a mediação está disciplinada no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) (39) e na Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) (40), os quais, dentre outros, trazem a mediação como meio de autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.

Analisando as referidas legislações, verifica-se a existência de dispositivos no sentido

que os entes federados, incluindo aí os municípios, constituam câmaras de mediação e conciliação, visando à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo.

Nesse sentido é possível citar o disposto no artigo 174 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) (39) e o artigo 32 da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) (40).

Existe ainda uma corrente de doutrinadores e estudiosos do SUS que sustentam e defendem que o sistema pode se favorecer das medidas progressistas trazidas pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Mediação, mediante a constituição de câmaras de mediação sanitária no âmbito das secretarias de saúde (sejam estadual, municipal ou distrital), assim como no âmbito federal (Ministério da Saúde).

Nessa linha de entendimento destacam-se Delduque e Castro, os quais ressaltam que “a construção de núcleos de Mediação Sanitária, no âmbito das Secretarias de Saúde, em todos os níveis, para operar a mediação interna ao sistema e externa com seus usuários, há de ser um novo paradigma a substituir a litigância e a judicialização” (38).

Ainda que a técnica da mediação não seja recente, pois, conforme explica Moore, as “culturas judaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, budistas, confucionistas e muitas culturas indígenas têm longa e efetiva tradição na prática da mediação” (41), no Brasil e, sobretudo, no âmbito das Secretarias de Saúde, a aplicação do referido meio de auto-composição ainda caminha a passos lentos, conforme leciona D’Antonio (42):

A resolução extrajudicial de conflitos sanitários é realidade em diversos países e tem sido estudado no direito comparado, muito embora no Brasil ainda seja tímida a produção acadêmica sobre o assunto, em que pese a crescente demanda judicial advinda de usuários do sistema de saúde brasileiro, público ou privado.

No âmbito sanitário, o termo ‘mediação’ vem se atando à capacidade do mediador de propor soluções, inclusive de forma expressa. As soluções trazidas pelo mediador são construídas mediante elementos trazidos pelas partes durante procedimento dialogado.

Em países europeus como França, Hungria e Suécia, e ainda, países latino-americanos como México, Chile e Argentina as experiências são mais amplas no campo da resolução de conflitos sanitários extrajudiciais.

No caso do município de Goiânia, inexistente legislação criando uma câmara de mediação, conforme disciplina o art. 174 do Código de Processo Civil (39) e o art. 32 da Lei 13.140/2015 (40), o que impossibilita a realização da mediação no âmbito da Secretaria de Saúde do referido município.

No entanto, em levantamento realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, verificou-se que, não obstante a mediação não seja um método utilizado, no âmbito da referida secretaria são realizados alguns procedimentos que visam resolver, na via extrajudicial/administrativa, alguns conflitos de saúde antes de ocorrer a judicialização.

Para informações quanto à forma de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para resolução das demandas ainda na esfera administrativa e extrajudicial, consultou-se a assessora jurídica na Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a qual explicitou que, desde outubro de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde passou a ter uma boa relação com o Ministério Público e a Defensoria Pública, posto que os referidos órgãos começaram a ouvir a Secretaria, buscando, dentre outros, entender o fluxo do Sistema Único de Saúde, assim como as responsabilidades dos usuários.

A mencionada servidora destacou que algumas Promotorias, Defensoria Pública do Estado e também da União costumam entrar em contato Superintendência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia solicitando informações da situação do paciente, previamente à eventual ajuizamento de ação. Quando a Secretaria demonstra, por exemplo, a inexistência de urgência ou emergência no atendimento do referido paciente e que está sendo observada a ordem de fila espera, muitas questões não têm sido judicializadas.

Informou-se também que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia adotou a medida de disponibilizar acesso ao sistema de regulação municipal aos órgãos como Ministério Público e Defensoria Pública, oportunizando que eles visualizem com mais

fidedignidade o trabalho realizado pela administração municipal.

No que diz respeito à referida iniciativa, que pode ser entendida como um processo estratégico para enfrentamento da judicialização, em uma segunda consulta à Superintendência de Regulação foi explicitado que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu uma ferramenta de acompanhamento do sistema do Complexo Regulador de Goiânia, criando *login* e senha para os servidores tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público, viabilizando que eles tenham acesso aos dados acerca das filas de esperas, assim como, que verifiquem os usuários que estão pendentes de atendimento. Igualmente, essa ferramenta possibilita que eles acompanhem em tempo real, inclusive, as solicitações realizadas pela regulação e como está se desenvolvendo a regulação das vagas.

Segundo informações da Superintendência, em termos simplificados, os profissionais da área de tecnologia da Secretaria pegaram o módulo utilizado pela regulação municipal e disponibilizaram para as referidas instituições, ressaltando-se, no entanto, algumas informações que estão acobertadas pelo sigilo, como por exemplo, quadro clínico do paciente. Por sua vez, “o acesso é feito com senha específica a três telas: lista de espera de consulta especializada, lista de espera de cirurgia eletiva e leitos de UTI. A última será pública” (43).

Ainda que em quantitativo não seja possível mensurar, a informação dada pela Superintendência de Regulação, é a de que o diálogo prévio e acesso a informações pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública tem ajudado a reduzir a judicialização da assistência à saúde, assim como que possibilitou aos referidos órgãos perceber que o paciente também tem que atuar conforme preconizado pelo fluxo do Sistema Único de Saúde.

Outro processo estratégico adotado pela Secretaria Municipal de Saúde Goiânia foi a implementação da Lei Estadual n.º 19.792, de 24 de julho de 2017 (44), que dispõe sobre a transparência das listas de espera dos pacientes do SUS que aguardam consultas, exames, cirurgias eletivas, bem como internações de urgência e emergência, mediante disponibilização diversas informações à população em geral, no portal da

prefeitura, na aba “transparência regulação”. Lá é possível consultar: a) pactuação de leitos; b) aguardando vaga consulta especializada; c) Censo de Leitos de UTI, Lista de Espera Consulta Especializada; e d) Lista de Espera Cirurgia Eletiva (45).

Assim, ao consultar o site da prefeitura de Goiânia na área da Secretaria de Saúde, o paciente, mediante inserção do número do cartão SUS ou do CPF, consegue localizar a posição dele na fila de espera pelo atendimento, assim como também consegue verificar todo o histórico de data de solicitação do serviço, unidade e a posição (46).

Igualmente, a população pode consultar todos os leitos hospitalares de UTI ofertados pelo município de Goiânia – atualmente no total de 421 leitos (47) –, como também se os referidos leitos estão ocupados ou não e, ainda, se for o caso, porque estão desocupados, pois, por meio de uma lupa na área de buscas de informações sobre leitos de UTIs, há possibilidade de identificar o motivo de determinado leito estar disponível, ocupado ou reservados (46).

Desta feita, consoante se depreende das informações obtidas, a Secretaria Municipal de Goiânia vem buscando desenvolver estratégias de enfrentamento objetivando a resolução dos conflitos ainda na esfera administrativa, bem como prevenir novos conflitos e evitar o ajuizamento de novas demandas judiciais, mediante adoção de ferramentas que trazem transparência quanto ao sistema do Complexo Regulador de Goiânia, tanto aos órgãos de controle, como também à população em geral.

Superadas informações acerca das medidas adotadas pelo município para combater a judicialização, se faz oportuno ressaltar que uma nova forma de enfrentamento dessas demandas advém de medida adotada pelo Poder Judiciário Estadual de Goiás.

Conforme se verificou anteriormente, o município de Goiânia não tem adotado a mediação no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, recentemente, o Poder Judiciário do Estado de Goiás, por meio de do Decreto Judiciário n.º 2.195/2019 (48),

criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde da Comarca de Goiânia (CEJUSC) da Saúde, o qual se configura como primeiro no país com exclusividade no atendimento das demandas de saúde (49).

O Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania da Saúde – CEJUSC da Saúde é uma unidade do Poder Judiciário, vinculada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), órgão de assessoramento da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás-TJ/GO, implementada para realizar justiça por meio de da utilização adequada dos métodos consensuais de soluções de disputas, assegurando à sociedade um serviço de tratamento dos conflitos de saúde de forma acessível, ágil, eficaz e efetiva, garantindo o direito de acesso à soluções justas e à cidadania (50).

Em contato realizado com a Chefe do CEJUSC da Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, obteve-se a informação de que o referido centro foi instalado no dia 3 de outubro de 2019, iniciando atendimento ao usuário no dia 6 de fevereiro de 2020.

Foi ressaltado que, com o CEJUSC, o Poder Judiciário goiano pretende aprimorar a qualidade e eficiência da intervenção judicial em assuntos de direito sanitário, assim como que as funções do centro perpassam o registro das reclamações e realização de audiências e aprofundam-se a estudar e tratar adequadamente o conflito de saúde, com interinstitucionalidade, governança pública e uso adequado dos métodos consensuais de solução de disputas, por meio de da promoção do diálogo entre todos os atores envolvidos no conflito ou na sua possível solução, inclusive, se necessário, com o médico que acompanha o assistido.

Ao questionar acerca de quais são métodos para solução de conflitos utilizados no CEJUSC da Saúde, destacou-se que o centro é um sistema inovador, desenhado por meio de da metodologia do Design de Sistemas de Disputas, customizado para abordar, de forma mais adequada, os conflitos que envolvem a judicialização da saúde no Estado de Goiás, em toda sua complexidade, natureza e peculiaridade, os métodos autocompositivos utilizados são a Negociação Assistida, Conciliação e Mediação, e são sequenciados e empregados estrategicamente, caso a caso. Inclusive, a atuação do CEJUSC da Saúde pode ser tanto prévia quanto após a judicialização do conflito (51):

O acesso ao CEJUSC da Saúde se dará por via processual, pré-processual *on-line*,

pré-processual presencial e extrajudicial;

PROCESSUAL: Por meio de do encaminhamento dos autos, via Processo Judicial Digital – PROJUDI ao Centro, para realização da audiência do artigo 334 do Código de Processo Civil, pelas Varas vinculadas;

PRÉ-PROCESSUAL *ON-LINE*: Por meio de do registro da reclamação pelo usuário na plataforma do CEJUSC da Saúde no Portal do TJGO;

PRÉ-PROCESSUAL PRESENCIAL: Por meio de do registro da reclamação presencialmente via atendimento de balcão na sede do CEJUSC da Saúde;

EXTRAJUDICIAL: Por meio de do encaminhamento de acordos extrajudiciais entabulados pelas entidades conveniadas ao CEJUSC da Saúde de forma virtual ou presencial, para homologação judicial.

Enfatizou-se ainda que cabe ao CEJUSC da Saúde, por meio de sua equipe técnica, identificar corretamente o paciente na receita; verificar o CID que justifica o tratamento; verificar a disponibilidade de medicamento ou insumo pretendido na rede SUS; verificar a possibilidade de promoção de intercambialidade de medicamento na rede SUS; verificar a qualificação do objeto pretendido na receita e sua urgência médica, orientando assim o usuário-jurisdicionado a seguir o caminho mais adequado à solução do seu conflito.

O centro conta com a colaboração direta do Núcleo de Assessoramento Técnico em Saúde (NATJUS), que é responsável pela emissão de notas técnicas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, auxiliando para que as decisões, mesmo que entre as partes, sejam tomadas baseadas, também, em evidências científicas.

Considerando que o início das atividades do centro foi recente, ainda inexistem dados sobre o impacto na judicialização da saúde na comarca de Goiânia, no entanto, a Chefe do CEJUSC da saúde destacou que as metas esperadas são:

Diminuir, em 30% (trinta por cento), os protocolos de novas ações de saúde pública até 2021; manter um bom nível de satisfação do usuário; coletar, organizar, analisar, compartilhar e monitorar as informações sobre a judicialização e autocomposição dos conflitos de saúde em Goiás, em BI (*Business Intelligence*), até 2020; criar, alimentar e disponibilizar banco de notas técnicas e legislação na página do CEJUSC

da Saúde (52).

Entretanto, salientou-se que, na fase teste do protótipo, foram apreciados pelo CEJUSC dois casos reais com estatística de 50% (cinquenta por cento) de êxito, ou seja, acima da meta esperada.

A equipe técnica do CEJUSC da Saúde, formada por servidores públicos do Judiciário e do Poder Executivo estadual e do município de Goiânia, por meio de do convênio de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e demais entes, são especializados na área de saúde, direito, políticas públicas e gestão pública.

O CEJUSC da saúde implantado na comarca de Goiânia, portanto, se trata de um novo instrumento voltado ao enfrentamento da questão da judicialização da saúde, o qual, se executado da forma como disciplinado, tratando adequadamente os conflitos ligados à saúde, poderá diminuir o acervo dos processos de saúde em tramitação, trazer maior celeridade processual e descongestionamento Poder Judiciário Goiano, obter maior economia de recursos públicos, assim como possibilitar a análise dos conflitos em matéria de saúde baseada em evidências, trazendo, se for o caso, maior efetividade à decisão judicial (52).

Conforme pôde ser constatado ao longo deste capítulo, o município de Goiânia já conta com algumas medidas estratégicas para enfrentamento do problema da judicialização da saúde.

No entanto, existem algumas outras ações e procedimentos que poderiam ser adotados, tanto para obtenção de maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde, como para a resolução dos conflitos ainda na esfera extrajudicial. No presente trabalho duas sugestões estão sendo apresentadas.

A primeira, considerando que Goiânia se trata de uma capital, com alto índice de demandas judicializadas na área de saúde, seria a criação de um núcleo, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, para elaboração de pareceres administrativos acerca da medicina baseada em evidências, composto por profissionais de saúde (médicos e/ou farmacêuticos), para apoio técnico do jurídico na elaboração das defesas, assim como para as respostas administrativas que são direcionadas ao Ministério Público e

Defensoria Pública.

Essa medida estratégica foi adotada no município de Campo Grande-MS, que obteve redução de 75% nos gastos com a judicialização na saúde a partir da criação Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização da Saúde (CatJus), ligada a Superintendência de Gestão do Cuidado da SESAU (53).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem adotado a postura de solicitar evidências científicas para a tomada de decisões nas demandas relacionadas à área de saúde (54). Inclusive, por meio de das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ foram aprovados diversos enunciados que tratam da medicina baseada em evidência, tais como os de número 12, 18, 29, 59,89 e 103, visando orientar as decisões judiciais.

Ressalte-se que a medicina baseada em evidências também deve ser aplicada em nas demandas judiciais que tenham como pedido a disponibilização de leito de UTI, pois, como os referidos leitos são limitados, devem ser direcionados à população que verdadeiramente apresente indicação e que possa obter melhora clínica com a referida internação neste tipo de leito, conforme protocolos científicos que avaliam, dentre outros, gravidade, emergência terapêutica e prognóstico, nos termos da Resolução n.º 2.516 de 2016 do Conselho Federal de Medicina (CFM) (24).

Demonstrar ao Poder Judiciário que, em determinadas ações, o pedido de leito de UTI configura como uso injusto de recurso escasso, diante da inexistência de perspectiva de melhora clínica, assim como que eventual decisão favorável tão somente prejudicaria a isonomia coletiva no que concerne à fila de espera pelo referido leito, pode ser considerada como uma forma de enfrentamento da judicialização desta natureza.

Assim, a emissão de parecer fundamentado por equipe técnica na área de saúde, poderia auxiliar na instrução processual das demandas judicializadas e, eventualmente, obter decisões favoráveis ao município, bem como, na esfera extrajudicial, por meio de da elaboração de respostas estruturadas aos pedidos administrativos formalizados, evitando novos conflitos e o ajuizamento de novas demandas judiciais.

A segunda sugestão foi a criação da Câmara de Mediação Sanitária, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme disciplina o art. 174 do Código de Processo Civil (39) e o art. 32 da Lei 13.140/2015 (40), bem como a instauração de procedimentos de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos (38), designando um mediador capacitado para exercício da função.

Conforme exposto, a mediação permite às partes construir a solução por meio de diálogo e acordo mútuo, bem como tem se mostrado muito eficaz para a resolução de conflitos sanitários extrajudiciais em países europeus e, ainda, em países latino-americanos.

Nessa ordem de ideias, a mediação sanitária, no município de Goiânia, se apresentaria como uma opção viável à judicialização das políticas de saúde, pois as discussões que são levadas para a esfera judicial poderiam “ser dirimidas em fóruns e instâncias que não o Poder Judiciário, sem perder de vista o Direito de Acesso à Justiça das partes, consagrado na Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXV”, como pontuam Delduque e Castro (38).

No entanto, uma boa estratégia é aquela que melhor se adapta as particularidades de cada região, portanto, é preciso analisar os pontos negativos e positivos de cada situação.

No caso específico do município de Goiânia, observou-se uma deficiência na tratativa das informações de modo geral, pois a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia não possuía um registro confiável das demandas judiciais da área de saúde promovidas em desfavor do município, ao menos no que diz respeito aos leitos de UTI, o que demonstra ausência de controle e monitoramento destas ações.

Uma boa estratégia, tanto de diagnóstico como de enfrentamento, seria a designação de servidores dentro da secretaria de saúde para tratar dos processos judiciais com capacidade de analisar as peculiaridades de cada processo e adotar todas as medidas pertinentes, conferindo agilidade ao andamento.

A implantação de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação (TIC)

podem proporcionar maior controle e análise sobre os dados existentes, facilitar o monitoramento e interação aos processos. Ou seja, permitiria a criação de um banco de dados, com informações fidedignas e seguras que possam auxiliar na realização dos mais variados diagnósticos como, por exemplo, quais são os tipos de leitos de UTI mais demandados judicialmente, de acordo com a realidade local, para posteriormente, se for o caso, fazer ajustes na prestação do serviço, como, eventualmente, realizando a contratação de novos leitos específicos, impactando diretamente na diminuição da judicialização do serviço. Assim, a tomada de decisão pelo Gestor será baseada em dados tratados corretamente, como também fundada em planejamento estratégico.

Igualmente, poderá viabilizar a estruturação de um programa de monitoramento dos resultados dos leitos de UTI fornecidos em razão de decisões judiciais, de maneira a apurar a eficácia do tratamento ofertado, assim como o percentual de melhora clínica dos pacientes que foram atendidos pela via judicial, até mesmo para realizar levantamentos estatísticos que possam ser apresentados aos órgãos de controle, como Ministério Público e Poder Judiciário, demonstrado a real efetividade das decisões proferidas.

Ainda no intuito de proceder ao enfrentamento da judicialização, poder-se-ia trabalhar com a adaptação de medidas já conhecidas, a exemplo da câmara de mediação sanitária, estimulando o estabelecimento de uma cultura de prevenção e resolução administrativa de litígios nos serviços de saúde, bem como com a criação de um núcleo, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, composto por profissionais de saúde (médicos e/ou farmacêuticos), para elaboração de pareceres e respostas estruturadas, fundamentadas em evidências científicas, assim como para proceder ao apoio técnico ao corpo jurídico do município na elaboração das defesas judiciais.

Considerações Finais

Os resultados evidenciados no estudo podem contribuir amplamente para garantir um *feedback* acerca do fluxo de acesso das demandas em saúde à via judiciária de Goiânia. Além disso, os dados encontrados puderam ser utilizados visando a modi-

ficção do cenário observado durante a coleta de informações, especialmente em relação ao tempo elevado de espera, a prevalência de doenças crônico-degenerativas e o alto índice de óbitos.

Existem menos leitos de UTI no Brasil do que o preconizado pelo Ministério da Saúde (55). Além disso, a distribuição desses leitos no país é desigual, com predominância na Região Sudeste (56).

Apesar de ter ocorrido aumento de 19% no número de leitos de UTI adulto no país de 2010 a 2015, a quantidade ainda é insuficiente, especialmente em virtude da demanda crescente da população por serviços que garantam assistência adequada ao paciente grave ou gravíssimo, em situações de urgência/emergência, que representam risco à vida (56).

Sabendo da escassez de leitos de UTI em nível nacional, situação na qual também está enquadrado o município de Goiânia, e considerando o número crescente de demandas ajuizadas por pacientes buscando internações em UTI, que tem transformado o acesso a leitos de UTI em um dos principais bens judicializados, a pesquisa serviu como um indicador aos gestores dos serviços de saúde, da necessidade de que seja realizada uma análise mais coerente dos processos de trabalho que envolvem regulação de leitos de UTI (56).

A indicação de necessidade de internação em UTI é estritamente técnica e deve respeitar, protocolos, a fim de propiciar segurança e efetividade ao paciente. Os operadores do Direito não possuem conhecimento das questões técnicas que envolvem a saúde do paciente, esses elementos são fornecidos, defendidos e discutidos por profissionais médicos. A atuação dos Comitês de Saúde e dos NATJUS pode garantir maior eficiência aos comandos judiciais (57). Contudo, a aproximação dessas instâncias, no que tange ao processo regulatório, ainda é inicial, e deve ser aprimorada, vez que se observa que as concessões de pedidos de internação em leitos de UTI são realizadas em caráter liminar, sem permitir ao Município qualquer tipo de manifestação que não seja o cumprimento da decisão.

Tal situação de falta de aproximação das instâncias pode estar relacionada à atuação automática e desorganizada tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deferindo de forma automática os pedidos, sem consultar o requerido (município), e o Poder Executivo cumprindo automaticamente os comandos judiciais sem se debruçar sobre sua forma de tratar administrativamente o processo regulatório, sem realizar a inserção de abordagens mais inclusivas e igualitárias focadas na eficiência dos serviços (57).

Cabe aos gestores fomentar, construir conjuntamente com as centrais de regulação a produção de relatórios de indicação de UTI, redimensionar os serviços destes leitos, além de utilizar indicadores para avaliação do tempo de internação dos pacientes e dados relacionados ao prognóstico dos mesmos, buscando alcançar uma maior eficiência ao acesso e uso dos leitos de UTI, bem como, também, realizar efetiva triagem para justificar a internação, definindo claramente o(s) benefício(s) esperado para o paciente com a internação em leito de UTI (56).

O fluxo de informação no acesso à via judiciária e unidades de saúde pode garantir que as demandas de acesso aos leitos de UTI sejam embasadas do ponto de vista técnico-científico. Ainda assim, é válido ressaltar que o planejamento de suporte das unidades de cuidados semi-intensivo e paliativos deve funcionar sem intercorrências para que haja o correto direcionamento dos pacientes que necessitam verdadeiramente de cuidados nesses ambientes.

O que se observa, diante da interferência do judiciário por meio da judicialização, em um panorama municipal e nacional, é que a gestão de leitos de UTI por parte das centrais de regulação tornou-se, cada vez mais, figurativa, ficando totalmente a cargo dos órgãos jurídicos. São recursos valiosos (leitos de UTI) e escassos, com acesso dificultado, situação que termina por gerar, diariamente, acúmulo de demanda das centrais, demanda essa que termina não sendo respeitada no dia a dia, pelo ingresso de decisões judiciais que, utilizando-se da lei, passam na frente da fila de espera organizada pelo serviço (55).

Assim, diante de ações judiciais que demandem internação, o magistrado, além do demandante, deve pôr o olhar sobre todos os demais pacientes que aguardam nas filas

de espera. O juiz deve manter-se aberto ao conhecimento dos princípios em saúde e mostrar-se favorável a troca de experiências com profissionais da área, embasando as decisões proferidas de forma justa e respeitando normas técnicas, especialmente com recursos a disposição como o NATJUS. E para que o magistrado tenha esse olhar, é necessário que o Executivo busque, por meio de ações juntamente ao Poder Judiciário, sensibilizá-lo e orientá-lo, seja por meio do Comitê de Saúde ou por outros caminhos administrativos que vier a encontrar.

Foi considerado um fator limitante da pesquisa o alto número de processos que não puderam ser visualizados, indicando possível falha no controle da Secretaria de Saúde de Goiânia. Assim, constata-se que a tecnologia da informação é imprescindível para garantia de um diagnóstico concreto dessa demanda, tendo em vista que, diante da forma como a Secretaria da Saúde lida, atualmente, com os dados relativos a ações judiciais, não é possível identificar sequer quais são os motivos das intimações judiciais para poder elaborar plano de ação visando atacar tal realidade, construindo soluções administrativas concretas para qualificar o processo regulatório.

A utilização adequada de leitos de UTI, indiscutivelmente, pode salvar muitas vidas. É necessário, porém, que a Secretaria de Saúde de Goiânia, com a maior brevidade possível, se debruce sobre as questões que vem sendo objeto de judicialização de leitos de UTI, conhecendo os reais motivos das internações solicitadas e propondo atuação administrativa nos pontos já identificados pelo grupo como exigentes de intervenção.

Referências

- 1 - Chagas VO, Provin MP, Amaral RG. **Demandas judiciais para acesso às ações e aos serviços de saúde: uma revisão integrativa.** Varia Scientia [internet]. 2016 [citado 20 fev 2020], 2(1):67-79. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude/article/view/13433>.
- 2 – Ventura M *et al.* **Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde.** Physis. [internet]. 2010 [citado 20 fev 2020], 20(1):77-100. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312010000100006.
- 3 – Cruz A. **O direito à saúde exigido na justiça.** Revista Consensus [internet]. 2015. [citado 20 fev 2020], 15. Disponível em: <http://www.conass.org.br/consensus/o-direito-saude-exigido-na-justica/>.
- 4 – Faria L. **O Direito à Saúde entre o Poder Judiciário e a Administração Pública: do ativismo judicial às medidas administrativas.** In: Anais da Jornada de Iniciação Científica de Direito UFPR, 2014. [internet]. Curitiba; UFPR, 1(5):28-57.[citado 20 fev 2020]. Disponível em: <http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/Artigo-Luzardo-Faria-classificado-em-2%C2%BA-lugar1.pdf>.
- 5 – Ministério Público do Estado de Goiás (BR). **Demandas judiciais relativas à saúde crescem 130% em dez anos.** [internet]. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem-130-em-dez-anos#.XoZrcB9Kh8y>.
- 6 – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (BR). **Judicialização da saúde é tema de workshop realizado pelo TJGO em parceria com a EJUG.** [internet]. Agência de notícias. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/17-tribunal/1145-judicializacao-da-saude-e-tema-de-workshop-realizado-pelo-tjgo-em-parceria-com-a-ejug>.

7 – Ferreira H. Especial PPSUS: **Pesquisa analisa as novas institucionalidades para racionalizar a judicialização da saúde.** [internet]. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 16 nov. 2017. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: <http://www.fapeg.go.gov.br/especial-ppsus-pesquisa-analisa-as-novas-institucionalidades-para-racionalizar-a-judicializacao-da-saude/>.

8 – Prefeitura Municipal de Goiânia (BR). Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório de Gestão ano 2017.** [internet]. Goiânia: Prefeitura Municipal de Goiânia; 2018 [citado 20 fev 2020]. Disponível em: https://www12.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2019/09/Relat%C3%B3rio-Anual-de-Gest%C3%A3o-da-SMS-de-Goi%C3%A2nia-Ano-de-2017_Final_compressed.pdf.

9 – Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** [internet]. Brasília: Senado Federal; 5 out. 1988. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

10 – Defensoria Pública do Estado de Goiás (BR). **Dados Estatísticos das Defensorias Públicas em 2017.** [internet]. Goiás: Defensoria Pública do Estado de Goiás; 2018. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/images/pdf/Dados_estatisticos_2017_e_comparativo_com_2016%202.pdf.

11 – _____. Notícias: Defensoria Pública realiza 500 atendimentos na área de saúde em um mês em Goiânia. [internet]. Goiás: Defensoria Pública do Estado de Goiás; [data desconhecida]. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/index.php?option=com_content&view=article&id=1822:defensoria-publica-realiza-500-atendimentos-na-area-de-saude-em-um-mes-em-goiania&catid=8&Itemid=180.

12 - Defensoria Pública da União (BR). **Saúde.** [internet]. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <https://www.dpu.def.br/saude>.

13 - _____. **Quadro resumido por órgãos da DPU, Exercício de 2017.** [internet]. [acesso 21 fev 2020]. Disponível em: <https://www.dpu.def.br/transparencia/atendimento-da-dpu>.

14 – Brasil. **Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.** Brasília. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 15 fev 1993. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8625.htm.

15 – Ministério Público do Estado de Goiás (BR). **STJ fixa legitimidade do Ministério Público em pleitear remédios e tratamento para beneficiários individualizados.** [internet]. Goiânia: Ministério Público do Estado de Goiás; 7 maio 2018. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpgp.mp.br/portal/noticia/stj-fixa-legitimidade-do-ministerio-publico-em-pleitear>

.....

-remedios-e-tratamento-para-beneficiarios-individualizados#.Xk7EIShKjIU.

16 – _____. **Centros de Apoio Operacional**. [internet]. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpgp.mp.br/portal/noticia/centros-de-apoio-operacional#.Xk7GMChKjIU>.

17 – _____. **Saúde**. [internet]. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpgp.mp.br/portal/pagina/saude>.

18 – Rosa C. **MP reforça articulação para melhorar fluxo de atendimento da saúde pública**. Notícia. [internet]. Goiás: Ministério Público do Estado de Goiás; 13 set 2018. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpgp.mp.br/portal/noticia/mp-reforca-articulacao-para-melhorar-fluxo-de-atendimento-da-saude-publica--2#.XknrrShKjIU>.

19 – Ministério Público do Estado de Goiás (BR). **Plantão Saúde**. [internet]. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: <http://www.mpgp.mp.br/portal/conteudo/plantao-saude#.XknsXShKjIU>.

20 – Ministério da Saúde (BR). **Portaria de Consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 30 set 2017. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017_comp.html.

21 – Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria n. 373, de 27 de fevereiro de 2002**. Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 28 fev 2002. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html.

22 – _____. **Diretrizes para a implantação de Complexos Reguladores**. [internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: <http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/DiretrizesImplantComplexosReg2811.pdf>.

23 – Delalibera LF. **Análise de decisões judiciais que demandam leitos de UTI contra o Distrito Federal**. [Monografia] [Internet]. Brasília: Graduação em Saúde Coletiva, Universidade de Brasília; 2013. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/7730/1/2013_LorenadeFreitasDelalibera.pdf.

24 – Conselho Federal de Medicina (BR). **Resolução CFM n. 2.156, de 28 de outubro de 2016**.

.....

Estabelece os critérios de admissão e alta em unidade de terapia intensiva. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 17 nov. 2013(1):138-9. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/CFM_resolucao_2156_2016.pdf.

25 – Advocacia Geral da União (BR). **Parecer n. 00213/2017/CONJURMS/CGU/AGU**. [internet]. Brasília: Ministério da Saúde; [2017]. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/01/00213%202017%20acesso%20aos%20leitos%20de%20uti.pdf>.

26 – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (BR). **Hospitais e Unidades de Saúde Estaduais**. [internet]. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: <http://www.saude.go.gov.br/unidades-de-saude/hospitais>.

27 – Brasil. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990. [citado 21 fev 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.

28 – Ferreira P. **Em seis anos, número de leitos de UTI SUS em Goiânia aumenta 45,35%**. [internet]. Goiânia: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; 6 jun. 2016. [citado 12 fev 2020]. Disponível em: http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/16/06/Em_seis_anos_numero_de_leitos_de_UTI_SUS_em_Goiania_aumenta_45_35.shtml.

29 – Supremo Tribunal Federal (BR). **Despacho de Convocação de Audiência Pública, 5 de março de 2009**. [internet]. Brasília: Supremo Tribunal Federal; 2009. [citado 27 fev 2020]. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Despacho_Convocatorio.pdf.

30 – Conselho Nacional de Justiça (BR). **Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010**. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. [internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 30 mar 2010. [citado 27 fev 2020]. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf.

31 – _____. **Resolução n. 107, de 6 de abril de 2010**. Institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. [internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 6 abr. 2010. [citado 27 fev 2020]. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_107_06042010_11102012191858.pdf.

32 – _____. **Fórum da Saúde**. [internet]. [citado 31 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.>

cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-2/.

33 – _____. **Recomendação n. 36, de 12 de julho de 2011.** Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, com o intuito de assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde suplementar. [internet]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça; 12 jun. 2010 [citado 27 fev 2020]. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files//recomendacao/recomendacao_36_12072011_22102012170026.pdf.

34 – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (BR). **Apresentação: NATJUS: Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário.** [internet]. [citado 27 fev 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/nucleo-da-judicializacao-da-saude/apresentacao>.

35 – _____. Núcleo da Judicialização da Saúde. **Regimento da Câmara de Saúde do Judiciário.** [internet]. [citado 1 fev 2020]. Disponível em: http://docs.tjgo.jus.br/judicializacao/Docs/regimento_csj.pdf.

36 – _____. **Atribuições do âmbito do NAT JUS.** [internet]. [citado 31 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/nucleo-da-judicializacao-da-saude/atribuicoes>.

37 – Pinho HDB. **A mediação e o Código de Processo Civil projetado.** [internet]. Portal Academia; 2012. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: https://www.academia.edu/4246510/A_MEDIACAO_E_O_CPC_PROJETADO_280612.

38 – Delduque MC, Castro EV. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil.** [internet]. Saúde Debate. Rio de Janeiro, abr./jun. 2015, 39(105):506-13. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n105/0103-1104-sdeb-39-105-00506.pdf>.

39 – Brasil. **Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015.** Novo Código de Processo Civil. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 17 mar 2015. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm.

40 – _____. **Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015.** Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. [internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 29 jun. 2015. [citado 30 jan. 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm.

41 – Moore CW. **O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos.** Trad. Lopes MF. Porto Alegre: Artmed; 1998;2:32

42 – D’Antonio S. S. **Mediação Sanitária: diálogo e consenso possível**. Cad Ibero-americano de Direito Sanitário, Brasília, abr./jun., 2016, 5(2):8-22.

43 – Moraes A. **Defensoria Pública pode acompanhar regulação em tempo real**. [internet]. Portal Prefeitura Municipal de Goiás. Notícias:saúde. 11 set2019. [citado 28 fev 2020]. Disponível em: <https://www12.goiania.go.gov.br/defensoria-publica-pode-acompanhar-regulacao-em-tempo-real/>.

44 - Governo do Estado de Goiás (BR). **Lei n. 19.792, de 24 de julho de 2017**. Dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas eletivas na rede estadual de saúde. [internet]. Goiânia: Diário Oficial do Estado; 27 jul. 2017. [citado 28 fev 2020]. Disponível em: http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21672.

45 – Prefeitura Municipal de Goiânia (BR). **Secretaria Municipal de Goiânia**. Portal de Serviços [internet]. [citado 28 fev 2020]. Disponível em: <https://www12.goiania.go.gov.br/sms/servicos>.

46 – Straiotto S. **“Tela de transparência” visa identificar posição de pacientes na espera por leitos de UTIs**. [internet]. Diário de Goiás. 11 dez 2019. [citado 28 fev 2020]. Disponível em: <https://diariodegoias.com.br/tela-de-transparencia-visa-identificar-posicao-de-pacientes-na-espera-por-leitos-de-uti-s/>.

47 – Prefeitura Municipal de Goiânia (BR). **Leitos de UTI disponibilizados pela Rede Pública Municipal**. [internet]. [citado 28 fev 2020]. Disponível em: http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/siscv/asp/siscvg0930f0.asp?sel_tp_lto=0.

48 – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (BR). **Decreto Judiciário n. 2.195, de 27 de agosto de 2019**. Dispõe sobre a instalação do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde na Comarca de Goiânia. [internet]. Goiânia: 28 ago. 2018. [citado 08 fev 2020]. Disponível em: http://docs.tjgo.jus.br/institucional/projetoseacoes/conciliacao/cejusc/DEC_02092019.pdf.

49 – Becker D. **TJGO inaugura primeiro CEJUSC do Brasil exclusivo para demandas de saúde**. [internet]. Agência de notícias TJGO. [citado 31 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/17-tribunal/18143-tj-de-goias-inaugura-primeiro-cejusc-do-brasil-exclusivo-para-demandas-de-saude>.

50 – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (BR). **O que é o CEJUSC da saúde?** [internet]. [citado

08 fev 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/o-que-e-cejusc-da-saude>.

51 - . _____. **Como conciliar**. [internet]. [citado 08 fev 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/como-conciliar>.

52 - _____. **Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania da Saúde**. Manual do CEJUSC da saúde. [internet]. Goiás: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; [201?]. [citado 08 fev 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/images/docs/CCS/manualcejusc.pdf>.

53 - **Medidas estratégicas garantem redução de 75% nos gastos com judicialização na saúde**. [internet]. A crítica: saúde. 25 nov. 2019. [citado 29 jan. 2020]. Disponível em <https://www.acritica.net/editorias/saude/medidas-estrategicas-garantem-reducao-de-75-nos-gastos-com-judicializa/419695>.

54 - Sampaio GC, Pinheiro FC. **Medicina baseada em evidência: uma solução para o litígio em demandas na área de saúde**. [internet]. Rev Eletr FACP, mar 2019, 7(15):23-42. [citado 29 jan. 2020]. Disponível em: <http://fapc.com.br/revista/index.php/reFACP/article/viewFile/66/pdf>.

55 - Ferraz AR, Carreiro MA. **Reflexão teórica sobre a regulação de leitos de terapia intensiva em um Município do Rio de Janeiro**. [internet]. Rev Pró-UniverSUS, 2018; 9(1):47-80. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: <http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1227>.

56 - Oliveira CI. *et al.* **Motivos da internação por ordem judicial na terapia intensiva: perspectiva do enfermeiro**. [internet]. Enferm. Foco, 2019; 10(1):99-104. [citado 20 fev 2020]. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Motivos-da-interna%C3%A7%C3%A3o-por-ordem-judicial-na-terapia-intensiva-perspectiva-do-enfermeiro.pdf>.

57 - Luz KR. *et al.* **Advocacia na terapia intensiva diante da internação por ordem judicial: qual a perspectiva dos enfermeiros?** Texto contexto - enferm. [Internet]. 2019; (28):1-15. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072019000100375&script=sci_arttext&tlng=pt.



Projeto de intervenção para enfrentamento da judicialização da saúde no município de Campo Grande/MS: diagnóstico situacional e novas estratégias

Caroline de Castro Feller¹

Lícia Mara Nascimento de Vasconcelos Fidelis²

Patrícia da Silva Ferreira³

Raul Sousa Silva Jr⁴

Sergio Missirian⁵

Orientador: Prof. MSc. Moacyr Rey Filho

Este artigo, retrata um trabalho consubstanciado em um projeto de intervenção no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Foi realizado um levantamento de dados geográficos, epidemiológicos, administrativos etc., para embasar as informações sobre a judicialização da saúde no município. A fonte dos dados foram artigos, relatórios e documentos disponíveis na internet.

Optou-se por obter as informações relativas ao ano de 2018 sobre a Judicialização da Saúde junto à Secretaria de Saúde do município, que tem em funcionamento um setor

¹ Graduada em Direito pela UNIJUI. Assessora Jurídica da SMS de Pejuçara-RS.

² Graduada em Enfermagem pela UNINORTE/AC, Pós-graduada em obstetrícia e ginecologia pela UNINORTE-AC. Secretária Municipal de Saúde de Bujari-AC.

³ Graduada em Direito pela UNIPÊ. Assessora Jurídica do COSEMS-PB.

⁴ Graduado em Direito e História pela UNIFAP. Pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Público e Educação Profissional. Procurador do Estado do Amapá.

⁵ Graduado pela UCDB, Pós-graduado em Direito Processual pela PUC-MG. Gestor de Processos na SMS de Campo Grande-MS.

denominado Divisão de Demanda Judicial em Saúde, que administra todas as decisões judiciais em desfavor do SUS municipal.

Com base nos dados fornecidos pela Divisão de Demanda Judicial da Secretaria Municipal de Saúde, foi realizada pesquisa processual no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no segundo semestre de 2019, obtendo-se informações sobre o andamento processual, representação do autor, requeridos, pedidos principais e juízo responsável pelo julgamento. Após essa análise, foi realizado o diagnóstico da judicialização da saúde no município e foram desenvolvidas propostas de enfrentamento da judicialização, em forma de projeto de intervenção para o município, devidamente descrita ao longo do trabalho.

Diagnóstico da judicialização no município

Verifica-se, em todo território brasileiro, um aumento significativo da judicialização do direito à saúde, visando à obtenção de atendimento médico, medicamentos, insumos e procedimentos para concluir diagnósticos e tratamentos. No município de Campo Grande/MS, essa situação é também refletida nos moldes do cenário nacional, tendo o município enfrentado uma grande quantidade de demandas judiciais em saúde.

O município de Campo Grande, somente no ano de 2018, gastou aproximadamente R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) com a judicialização, para atender cerca de 3 mil usuários (1).

Ao se fazer um diagnóstico da situação da judicialização, verificou-se que, até o segundo semestre de 2018, a secretaria de saúde utilizava uma planilha no programa *Excel*, para manter o controle das demandas judiciais recebidas em desfavor do município. Observou-se, contudo, que essa planilha não era precisa, pois constavam duplicidades de registro de pedidos, faltavam informações quanto ao andamento processual, quanto ao custo da demanda, dentre outras falhas.

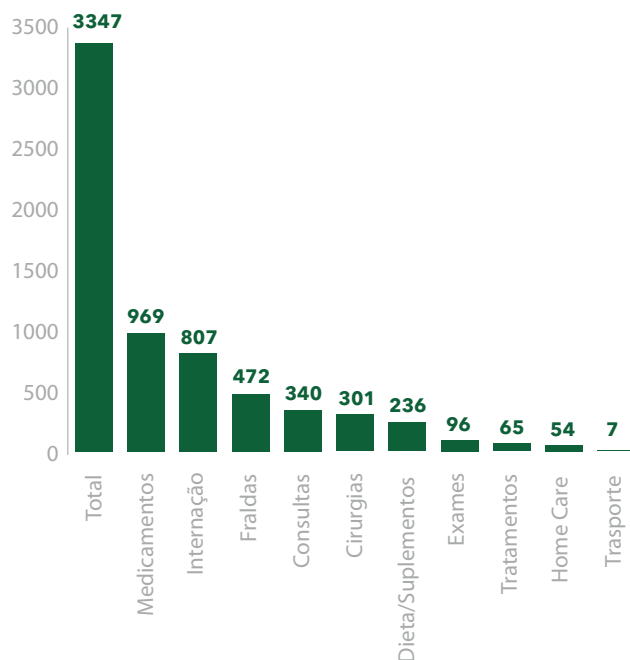
Somente no segundo semestre de 2018, o município começou a implementar o Sistema Integrado da Judicialização na Saúde - Campo Grande-MS SIJUS-SESAU, deixando, portanto, de atualizar a planilha no programa *Excel*. Referido sistema informatizado

foi desenvolvido pela Coordenadoria-Geral de Suporte Tecnológico e Informação (CGSTI, dentro da SESAU), em parceria com a AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) (2).

Todo o trabalho de pesquisa baseou-se nos processos que constavam na planilha disponibilizada pelo Setor de Demandas Judiciais do Município. Com base nos dados processuais, ainda se consultou o *site* do TJMS de cada processo, para obtenção de informações mais precisas e diagnóstico correto.

O município de Campo Grande, durante todo o ano de 2018, foi demandado em 3.347 processos judiciais (2), tendo como pedidos principais alcançar algum objeto relacionado com a saúde, tais como, tratamentos, internações, medicamentos ou insumos, conforme Figura 1.

FIGURA 1. Assuntos por processo judicial em Campo Grande (2018).



Fonte: Relatório da Divisão de Demanda Judicial em Saúde/Coordenadoria-Geral Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande.

Considerando que os dados constantes da planilha e do sistema informatizado, com relação aos principais pedidos, conteúdo das decisões e indicação de autores e pacientes, não estavam organizados de forma fidedigna, foi realizada busca no site do TJMS, de forma aleatória, para análise de 205 processos, nos quais foram verificados pedidos de mais de 80 tipos de medicamentos, destacando-se com maior incidência os seguintes, conforme Tabela 1. Os demais medicamentos não tiveram mais que a incidência de três pedidos.

TABELA 1. Lista de Medicamentos com maior incidência em 2018 (Pesquisa TJMS).

MEDICAMENTO	QUANTIDADE DE PEDIDOS
Enoxoparina	29
Xarelto	21
Insulina	19
Rivaroxabana	13
Deloxetina	8
Enzalutamina	7
Sulfato de Glutossamina	7
Sulfato de Condroitina	6
Eylia	5
Prolia	5
Oxibutinina	4
Brometo de Tiotrópio	4
Somatropina	4
Citalopram	4

Fonte: Elaborada pelos autores.

Desse universo de 205 processos analisados, todos ajuizados em 2018, em desfavor do Município de Campo Grande, com relação ao critério de “representação/paciente”, observaram-se que, em 29 ações judiciais, o autor fora assistido por advogado particular contratado, enquanto nos outros 176 processos, os autores tiveram a assistência da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (2).

Ainda foi identificado que, dos 205 processos analisados, em 100 deles figurava no polo passivo apenas o município de Campo Grande. Nos outros 105 processos, além do município, o estado do Mato Grosso do Sul figurava juntamente no polo passivo da ação.

Em nenhum dos processos analisados se encontrou a União figurando no polo passivo da ação. Importe reforçar que o recorte de pesquisa no *site* do TJMS foi de apenas 205 processos de um total de 3.347 informados no relatório de demanda judicial em saúde. Portanto, não se pode afirmar que a União não figurou no polo passivo em nenhuma das ações ajuizadas no ano de 2018.

O Município de Campo Grande e o estado do Mato Grosso do Sul foram representados, em todas as ações analisadas, por seus departamentos jurídicos próprios.

Ao analisar os 205 processos, observa-se a situação atual de tramitação, que, da análise de seu andamento, totalizam 17 processos aguardando sentença de mérito; 86 processos com sentença de mérito já proferidas e arquivados após o trânsito em julgado; outros 64 processos em fase de cumprimento de sentença; 26 processos em grau de recurso; e 12 processos com sentença aguardando o trânsito em julgado.

Em todos os 205 processos pesquisados, houve decisão de antecipação de tutela pleiteada. Em 188 processos, houve confirmação da decisão antecipatória por sentença de mérito. Pode-se concluir, dessa amostragem, que quase a totalidade dos processos tem sentença de mérito favorável, acarretando a condenação da administração pública municipal, para providenciar diversas medidas da implementação da política pública de saúde. Com efeito, caso a administração pública se antecipasse e houvesse um melhor planejamento para realização de licitações, compras e contratações, poderia evitar essa excessiva judicialização e, ainda, reduzir os gastos destinados ao cumprimento das decisões judiciais.

O Conselho Nacional de Justiça autorizou a criação dos Comitês de saúde pelos tribunais e os Núcleos de Apoio Técnico (NatJus). O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul os implantou no âmbito da sua atuação para subsidiar as decisões dos magistrados nas demandas de saúde. O referido Comitê tem representantes do Judiciário estadual, das Secretarias de saúde, da Advocacia pública, da Defensoria pública e do Ministério Público, servindo como um órgão que estabelece enunciados e orientações para questões administrativas e judiciais em matéria de saúde (3).

O TJMS, considerando a elevada demanda da matéria, implantou no âmbito da sua atuação diversos meios de estudo e solução destes conflitos. Entre eles está o NAT – Núcleo de Apoio Técnico, para subsidiar as decisões dos magistrados na matéria de saúde, composto por profissionais de saúde, em convênio com os Municípios e o Estado, conforme Portaria n.º 881, de 12 de fevereiro de 2016 (4).

Além do NAT/TJMS, há ainda projetos de câmaras, diálogos deliberativos, dentre outros projetos, que visam melhorar a prestação da saúde como um todo à população, daqueles judicializados, bem como para evitar que seja necessário judicializar as questões afetas à temática (5).

Da mesma forma, a realização do Diálogo Deliberativo trouxe como objetivo a demonstração da importância do uso sistemático de evidências científicas na formulação e implementação das políticas de saúde, a fim de melhorar a aplicação de recursos e a eficiência do sistema de saúde (6).

Há ainda projeto para implantação de vara especializada em saúde no Juizado Especial da comarca, para atendimento específico das demandas de saúde (7).

A Figura 1 exemplifica o tamanho da judicialização da saúde pública no município. Os dados divulgados pelo NAT/TJMS, para o período que abrange o ano de 2018 foram os seguintes (8):

FIGURA 2. Estatísticas do Núcleo de Apoio técnico (NatJus/TJMS).



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Assessoria de Planejamento

Período: Janeiro 2018 à Dezembro 2018

Total de Documentos por Comarca		
10 Maiores		
Comarca	Qtde de Documentos	%
Juizado Especial Central de Campo Grande	2.616	58,09%
Campo Grande	512	11,37%
Dourados	273	6,06%
Paranaíba	211	4,69%
Corumbá	191	4,24%
Naviraí	152	3,38%
Nova Andradina	145	3,22%
Juizado Especial de Dourados	144	3,20%
Três Lagoas	137	3,04%
Amambai	122	2,71%
Total Geral	4.503	100,00%

Fonte: https://www.tjms.jus.br/_estaticos/_nat/estatisticas/processos-2018-01-a-12.pdf.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

O Município de Campo Grande dispõe de uma Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização na Saúde (CATJUS), instituído a partir do Decreto 13.918, de 9 de julho de 2019, nos seguintes termos (9):

Art. 1º A alínea “c”, do Inciso IV, do art. 4º, do Decreto n. 13.530, de 29 de maio de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º

.....

IV

.....

c) Superintendência de Gestão do Cuidado:

1. Gerência de Gestão de Casos Complexos;
2. Gerência de Material e Esterilização;
3. Gerência de Hotelaria;
- 3.1. Divisão de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Atenção à Saúde.
4. Gerência de Segurança do Paciente;
5. Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização na Saúde.” (NR)

Art. 2º O Decreto n. 13.530, de 29 de maio de 2018 passa a vigorar acrescido do Art. 89-A, com a seguinte redação:

“Art. 89-A. À Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização na Saúde, diretamente subordinada à Superintendência de Gestão do Cuidado, compete:

I - analisar, sob o ponto de vista técnico, os requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Saúde, que tenham por objeto o fornecimento de bens e serviços de saúde não incorporados ao SUS, com base na medicina baseada em evidências e nos seguintes critérios:

a) possibilidade da substituição por bens e serviços já oferecidos regularmente pelo SUS; e

b) adequação quantitativa dos pedidos.

II - prestar subsídios ao gestor, às áreas técnicas da SESAU e aos órgãos municipais envolvidos no fenômeno da judicialização, em qualquer de suas fases, incluídas as instâncias de solução extrajudicial de conflitos, mantendo banco de dados dos laudos e pareceres produzidos;

III - realizar estudos e adotar medidas tendentes à otimização dos gastos públicos decorrentes da judicialização;

IV - articular-se com os conselhos de fiscalização do exercício profissional;

V - elaborar relatórios mensais na sua área de atuação.

Parágrafo único. No exercício de suas funções, a Coordenadoria de que trata o caput poderá:

I - requisitar informações e/ou auxílio técnico de outros profissionais da rede municipal de saúde;

II - propor a celebração de convênios com instituições de ensino e outras entidades afins, visando à realização de estudos técnicos sobre matérias afetas à sua área de atuação, com incentivo à pesquisa acadêmica acerca do tema.”

Art. 2º O Anexo II-B do Decreto n. 13.530, de 29 de maio de 2018, passa a vigorar com a redação do Anexo deste Decreto.

A CATJUS foi criada com a função principal de avaliar tecnicamente a necessidade de atendimento dos pacientes que judicializaram uma demanda em saúde em face do Município de Campo Grande, ou que tenham a pretensão de ajuizar, quando procuram a esfera administrativa inicialmente.

A avaliação técnica da CATJUS busca verificar, por meio da sua equipe de profissionais de saúde e estudos científicos, se há alternativa viável para o atendimento ao paciente, bem como auxiliar a defesa do Município nestes processos, de modo que a conciliação seja concretizada, evitando-se o prolongamento da demanda.

O atendimento da equipe da CATJUS consiste nos servidores da SESAU designados a atuarem dentro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por ser o maior demandante em saúde, tirando os pacientes que procuram a defensoria com a finalidade de judicializar qualquer questão envolvendo a saúde.

Por outro lado, a equipe técnica interna do CATJUS realiza o estudo dos processos já ajuizados, bem como intercedendo junto às diversas áreas da Secretaria, procurando dar maior resolutividade aos casos apresentados.

O relatório da CATJUS apresenta solicitação de consultas, cirurgias, exames, medicamentos, fraldas, dietas enterais, órteses/próteses, atendimento domiciliar (*home care* e Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD), terapias diversas, insumos e aparelhos de controle (glicosímetro, controle respiratório etc.).

Conforme as estatísticas da CATJUS, entre julho e dezembro de 2019, houve a resolutividade de, aproximadamente, 30% das demandas apresentadas, evitando-se a judi-

cialização dos pedidos solicitados pelos pacientes, gerando uma economia de 425 mil em relação ao mesmo período do ano de 2018 (10).

No relatório ficou demonstrado ainda demonstrou que a resolutividade direta dos casos evitou a judicialização, fazendo o município deixar de destinar parte dos recursos para a judicialização, de acordo com os valores dos pedidos realizados pelos pacientes.

A CATJUS vem se mostrando como importante ferramenta de enfrentamento da judicialização, tanto pela resolutividade dos casos, quanto pelo fornecimento de dados para o melhor planejamento das ações e serviços de saúde para evitar a judicialização excessiva em saúde no Município de Campo Grande.

Em 26 de julho de 2017, o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde-MS, por deliberação de seus integrantes e, em consonância com as diretrizes propostas pelo Comitê Nacional e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), emitiu a recomendação de n.º 03/2017 aos Entes Públicos – União, Estado de Mato Grosso do Sul e seus municípios – para que fossem criadas câmaras de conciliação para questões de saúde, ou órgão assemelhado, para atuação prévia e preventiva, de forma a resolver ditas questões e evitar a judicialização, e, alternativamente, a utilização das Câmaras de Conciliação e Mediação já criadas (11).

No juizado especial de Campo Grande, por onde tramita o maior número de processos judiciais sobre a temática de saúde, há o projeto capitaneado também estado de Mato Grosso do Sul e pela Defensoria Pública, para criação de uma Câmara de Conciliação e Mediação, a fim de que, antes do ajuizamento de demandas, houvesse, mediante concessões ou o que for possível, diálogos e acordo na tentativa de se evitar ações judiciais.

Além disso, o que não pudesse ser resolvido em conciliação e/ou mediação seria normalmente processado na justiça. Entretanto, o projeto de criação das câmaras de mediação e conciliação não avançou, tanto que o município de Campo Grande/MS acabou implantando a CATJUS, que é um órgão de avaliação técnica, suporte à defesa e resolutividade das demandas, não propriamente de conciliação e mediação (9).

Em 26 de julho de 2017, o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde-MS,

por meio de deliberação de seus integrantes e em consonância com idêntica conclusão do Comitê Nacional e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), emitiu a Recomendação n.º 02/2017 aos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que fosse criado no âmbito de suas competências e para a Comarca e Circunscrição Judiciária de Campo Grande – MS, ao menos uma Vara Especializada com competência exclusiva em questões de saúde ou, enquanto não criada esse juízo, a designação de um Magistrado com competência para referidas questões, independentemente de valor de ação ou outra limitação quanto ao juízo ou juizado especial. Todavia, até a realização deste trabalho, o projeto ainda se encontra em tratativas administrativas, não concretizado no âmbito da Justiça Estadual (7).

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande tem envidado esforços para mitigar a judicialização da saúde, por meio da implementação da Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização na Saúde (CATJUS), o que possibilitou a resolução de demandas pela via administrativa (10).

No município houve um canal de diálogo bem estabelecido entre a SMS e as instituições do Sistema de Justiça, a exemplo da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público, demonstrando protagonismo por parte da SMS e interesse genuíno na resolução das demandas de saúde dos seus munícipes.

O objetivo maior do município deve ser o de evitar a judicialização das questões de saúde. Entretanto, a partir do momento em que essa judicialização ocorre, verifica-se que o NatJus desempenha importante papel de estabelecer parâmetros e critérios objetivos, por meio de pareceres médicos, para subsidiar as decisões judiciais.

Dessa forma, outras medidas, além das mencionadas, podem ser tomadas diretamente pelo município, tais como a criação de câmaras de mediação e/ou conciliação das demandas individuais ou coletivas propostas pelo Ministério Público ou por defensores e advogados.

O gestor público municipal pode, ainda, propor ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a criação de vara ou juizado especializado em matéria de saúde, onde as demandas não resolvidas administrativamente pela CATJUS ou pelas câmaras de me-

dição e conciliação poderão ser discutidas de forma coletiva, já que todos os atores do sistema de justiça alcançarão uma visão sistêmica e racional do problema da judicialização da saúde.

Uma proposta estratégica para o enfrentamento das demandas judiciais de saúde é a implementação, ou seu aperfeiçoamento, caso já instalado, de um sistema informatizado de registros das ações judiciais, constando os nomes dos demandantes, os tratamentos pleiteados, os médicos prescritores, as patologias que fundamentam os pedidos, o custo administrativo da demanda, entre outros dados, a fim de se organizar melhor com informações não apenas para a defesa do ente público com eventual litispendência (quando há duas ações com as mesmas partes e sobre o mesmo fato), mas também evitar o crescimento de pedidos do mesmo tratamento e/ou medicamentos por diversos jurisdicionados, por anos seguidos.

A título de exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo criou o S-Codes e já o disponibilizou gratuitamente para outras secretarias de saúde. Tal sistema está vinculado à Coordenação de Demandas Estratégicas do SUS. A coordenadora Paula Suê afirma que o sistema “gerencia em completo a demanda judicial, além de alertar o gestor quanto à possibilidade de haver medidas administrativas, não para conter essa judicialização, mas para reconhecer alguma falha no SUS, ou seja, serve também para trazer indicadores de gestão.” (12)

Conforme mencionado, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande iniciou, em meados de 2018, a implantação de sistema informatizado para controle das demandas judiciais e pedidos realizados na área de saúde em face do município. Até essa época, o controle era feito por meio de planilhas em *Excel*, o que poderia causar falhas de lançamentos dos dados e impossibilitava a emissão de relatórios de diagnóstico, mas no ano desta pesquisa (2020), referido sistema ainda não tinha sido concluído e não está submetido ao controle social, visto que apenas alguns servidores podem acessá-lo (2).

Como estratégia de enfrentamento dos efeitos da judicialização da saúde, sugeriu-se a realização de um sistema de registros de preços dos itens mais demandados judicialmente no ano anterior, o que evitaria bloqueios judiciais para compra de remédios

.....

acima da tabela de preço máximo de venda ao governo (PMVG). Conforme art. 2o, inciso I do Decreto 7.892/2013 (13), o sistema de registro de preço é um “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”.

Um diagnóstico com informações precisas, por meio de um sistema informatizado, permitiria à Secretaria Municipal de Saúde emitir relatórios detalhados sobre os produtos e serviços de saúde mais demandados e mais acatados judicialmente, para, de posse desses dados, elaborar uma programação de licitação e compras mais eficiente, por meio de processo licitatório de ata de registros de preços, realizado no início de cada ano.

Consoante art. 3º do referido decreto, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (13).

Os produtos, insumos, medicamentos e serviços fornecidos pelo SUS, por terem a natureza de prestações continuadas e sucessivas, impõem a necessidade de contratações frequentes (incisos I e II). Ademais, as recorrentes decisões judiciais, determinando a compra de medicamentos ou fornecimento de tratamentos, dificultam sobremaneira que a Administração Pública municipal estabeleça previamente o quantitativo de produtos e serviços a que estará obrigada a fornecer, em determinado período (inciso IV).

Conforme relatório da Divisão de Demanda Judicial em Saúde/SESAU (2), as despesas

.....

com aquisição de produtos e serviços foi, em 2018, no importe de R\$ 15.727.733,08 (Quinze milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos). Da mesma forma, as despesas decorrentes de sequestros judiciais foram, no mesmo período, na quantia de R\$ 7.503.451,94 (Sete milhões quinhentos e três mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

Com a implementação de um sistema de registros de preços, por meio de atas anuais de registro de preços, a Secretaria Municipal de Saúde, ao receber a determinação judicial para compras de produtos, insumos e/ou medicamentos, bem como fornecimento de serviços de saúde, já poderia efetuar os pedidos para as empresas previamente selecionadas no processo licitatório com melhor preço e, de forma rápida, iniciar as fases da execução da despesa pública, mediante empenho, liquidação e pagamento, exigindo-se a entrega dos bens de saúde no menor prazo possível.

Dessa forma, o órgão municipal de saúde evitaria realizar dispensas de licitações, cujos preços de compras, em razão da urgência, são sempre maiores que os valores normais de venda aos governos, bem como impediria que houvesse bloqueios judiciais de contas públicas, o que, quando ocorre, acaba por dificultar a prestação de contas pelo indivíduo beneficiado e, ainda, a fiscalização dos órgãos de controle internos e externos.

Durante a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 18 de março de 2019, “segundo pesquisa divulgada pelo CNJ, o crescimento da judicialização foi de 130% em dez anos, trazendo um cenário que preocupa tanto na esfera pública, quanto privada” (14), conforme afirmou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse sentido, Delduque e Castro (15) afirmam que:

O conflito entre as necessidades individuais e coletivas que permeiam a garantia de um direito complexo, como o direito à saúde, vem mostrando que os sistemas político, jurídico e médico-sanitário chegaram ao esgotamento e que o Poder Judiciário não responde mais, com a eficácia esperada, à pacificação dessas controvérsias.

Concorda-se com a opinião de Paulo Modesto: “as críticas à judicialização da saúde não são críticas ao judiciário ou ao magistrado, mas sim ao Estado brasileiro”(16),

uma vez que são necessários avanços no plano das práticas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos campos de divulgação das escolhas, dos critérios de escolha, a abertura dos processos de decisão, isto é, na implantação de novos protocolos administrativos e médicos para o direito à saúde de todos, considerando-se, inclusive, que há escolhas trágicas para alocação de recursos públicos num contexto de crise com escassez financeira.

Em outras palavras, no processo de tomada de decisão, faz-se necessária a participação de todos os atores envolvidos na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de saúde. É preciso haver uma maior integração entre os atores do sistema de saúde (gestores públicos e profissionais de saúde) e do sistema de justiça (judiciário, ministério público e advogados públicos e privados). Nesse sentido, esses atores devem interagir de forma periódica e extraprocessual, evitando-se, ao máximo, a judicialização das demandas por ações e serviços de saúde.

Dessa forma, como estratégia de enfrentamento da judicialização da saúde, propõe-se a criação de câmara de conciliação e mediação na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde de Campo Grande (art. 32, Lei 13.140/2015) (17), a fim prevenir a incidência de demandas judiciais e de intensificar a resolução extrajudicial dos pedidos já contemplados nas políticas públicas de saúde e alertar os atores do sistema de justiça, dentre outros efeitos da judicialização, acerca do prejuízo social e financeiro resultante de sentenças e acórdãos que concedem pedidos inexistentes nas listas oficiais do SUS (relação nacional de medicamentos – RENAME e relação nacional de serviços – RENASES).

Conforme visto, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande implementou a criação da CATJUS, órgão formado por servidores da secretaria que atuam na Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, com a finalidade de avaliar tecnicamente a necessidade de atendimento dos pacientes que já judicializaram uma demanda em saúde em face do município, ou que tenham a pretensão de ajuizá-la. De acordo com relatório da CATJUS, entre julho e dezembro de 2019, houve a resolutividade de, aproximadamente, 30% das demandas apresentadas, evitando-se a judicialização dos pedidos solicitados pelos pacientes, bem como uma economia de 425 mil

em relação ao mesmo período do ano de 2018 (10).

Ou seja, a criação da CATJUS já trouxe benefícios ao Município de Campo Grande, com a redução de demandas judiciais, bem como dos recursos financeiros destinados ao cumprimento de decisões judiciais. Observa-se, entretanto, que a resolutividade extrajudicial pode ser maior se (i) o ambiente de mediação e conciliação for no próprio órgão municipal, com a participação de advogados públicos e servidores da secretaria de saúde, e não em órgão pertencente a outro ente federado (Defensoria Pública Estadual) e, ainda, se (ii) houver a participação de outros atores do sistema de saúde e de justiça, tais como, representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, de conselhos de saúde, de conselhos de classe e de especialistas em saúde coletiva. Nesse sentido:

Em processos nos quais se discutem problemas relacionados ao conteúdo e execução de políticas públicas, parece fundamental incluir na mediação, que tem por objetivo construir um acordo fundamentado na proteção de todos os interesses legítimos envolvidos, com respeito à ordem jurídica e cuja implementação seja viável: a) o Ministério Público, como autêntico representante da coletividade; b) a Defensoria Pública, como representante das pessoas carentes, cujos interesses são prioritários em matéria de políticas públicas; c) todos os entes, na esfera do Poder Executivo, que detenham competência para atuar na matéria, incluindo-se notadamente agentes públicos com competência técnica na matéria, além de advogados públicos de cada ente; d) representantes do Poder Legislativo, tendo em vista possíveis repercussões orçamentárias e eventuais necessidades de alterações normativas, inclusive em razão de possíveis inconstitucionalidades por ação ou por omissão; e) entidades representativas de setores afetados pelas políticas públicas; f) representantes de titulares de direitos individuais homogêneos envolvidos no conflito; g) entes privados que tenham responsabilidades relacionadas ao conflito; h) instituições acadêmicas e de pesquisa que detenham notórios conhecimentos sobre a matéria envolvida no litígio (18).

A presença desses demais atores, além de representar uma participação mais democrática e plural, com visões complementares das controvérsias em matéria de saúde, possibilitaria a ampliação do diagnóstico situacional da judicialização sanitária, já que cada um desses representantes contribuiria com os dados e informações de suas res-

pectivas instituições, alcançando-se uma tomada de decisão mais eficaz e eficiente.

Na III Jornada de Direito da Saúde, o CNJ constatou que a maioria dos processos judiciais de saúde não se utiliza dos enunciados aprovados durante as Jornadas de Direito da saúde do referido conselho, bem como muitos magistrados não consultam os Núcleos de Apoio Técnico (NatJus) para julgar as demandas relativas a cirurgias médicas, exames e medicamentos (14).

Diante deste cenário e visando dar mais coerência, uniformidade e segurança jurídica para as determinações judiciais em demandas de saúde, sugere-se a criação de varas ou juizados especializados em saúde, assim ensejando soluções não meramente individualizadas, mas especialmente, observando-se o caráter coletivo do direito à saúde.

Nessa linha de análise, Gustavo Amaral argumenta que o Poder Judiciário, o qual estaria vocacionado a concretizar a justiça do caso concreto (microjustiça), muitas vezes não teria condições de, ao examinar determinada pretensão individual à prestação de um direito social, “analisar as consequências globais da destinação de recursos públicos em benefício da parte, com invariável prejuízo para o todo” (19).

Dessa forma, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação das necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas.

Tais escolhas seguiriam critérios da justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça, ou seja, a escolha da destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração fatores como o número de indivíduos atingidos pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser prestado e a maximização dos resultados.

Como já mencionado, o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde-MS recomendou aos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Tribunal Regional

Federal da Terceira Região (Recomendação n.º 02/2017) a criação, no âmbito de suas competências e na Circunscrição Judiciária de Campo Grande-MS, de ao menos uma vara especializada com competência exclusiva em matéria de saúde ou, enquanto não criada esse juízo, a designação de um magistrado com competência para referidas questões, independentemente de valor de ação ou outra limitação quanto ao juízo ou juizado especial (7). Referida recomendação não foi implementada pelo TJMS e pelo TRF3.

O objetivo do trabalho foi apresentar propostas de enfrentamento da excessiva judicialização sanitária. Todavia, é inegável que sempre haverá, em maior ou menor grau, judicialização das políticas públicas garantidoras do direito à saúde. Assim, a criação de uma vara especializada em questões de saúde permitiria ao magistrado e aos demais atores do sistema de justiça uma visão mais sistêmica e racional das demandas por ações e serviços de saúde, bem como possibilitaria uma melhor compreensão das consequências fáticas e jurídicas das decisões judiciais.

Nessa vara especializada estariam concentrados todos os processos judiciais em que se demandam produtos, insumos, medicamentos e serviços em saúde, o que proporcionaria aos atores do sistema de justiça, mediante levantamentos estatísticos, a verificação das demandas individuais e, diante da repetição de pedidos, a transformação das demandas individuais em coletivas. Acerca do tema:

As ações individuais que versem sobre a proteção de direitos fundamentais afetados por políticas públicas devem ser convertidas em ações coletivas sempre que se verificar a possibilidade de um universo de pessoas se encontre na mesma situação do autor, chamando-se o Ministério Público para o polo ativo da ação; as ações individuais posteriormente ajuizadas devem ser extintas sem julgamento do mérito por litispendência, justamente pela impossibilidade de tratamento individualizado da questão, devendo eventuais pedidos de antecipação de tutela ser apreciados na ação coletiva (18).

Dessa forma, a concentração de demandas de saúde em uma única vara ou juizado permite aos atores do sistema de justiça a percepção das questões sanitárias não só sob

seus aspectos jurídicos, mas também sob os prismas políticos, de gestão e técnicos. Ou seja, o levantamento de dados e informações estatísticas concentradas em um único juízo, oportunizaria a esses atores do sistema de justiça uma visão quantitativa das demandas por ações e serviços de saúde, mas também qualitativa, relativa aos impactos técnico-científicos, administrativos e financeiros sob a responsabilidade do gestor público.

Considerações finais

O trabalho apresentou o diagnóstico processual estratégico da judicialização em Campo Grande com o número total de feitos em 2018, bem como descrição dos principais pedidos, a representação autoral do paciente e algumas decisões judiciais. Constatou-se que o sistema de controle de demandas judiciais à disposição do município ainda se mostra incipiente, o que pode ocasionar o aumento da judicialização em matéria de saúde, caso não sejam adotadas medidas de seu enfrentamento.

Verificou-se que, dentre os processos estratégicos de que dispõe o município para o enfrentamento da judicialização, o Município de Campo Grande já conta com uma Coordenadoria de Apoio Técnico-Científico nos Processos de Judicialização na Saúde (CATJUS), com a finalidade monitorar as demandas judiciais em saúde cujo município seja parte requerida. Observou-se que a implementação da referida coordenadoria já trouxe benefícios ao município no enfrentamento da judicialização, com alguma redução do quantitativo de processos e dos recursos financeiros dispendidos no cumprimento de decisões judiciais.

A fim de aperfeiçoar os instrumentos de controle da judicialização da saúde, autores apresentam novas formas de diagnóstico e enfrentamento da judicialização, não contempladas ou contempladas parcialmente pelo município. Foram sugeridas as seguintes medidas: (i) aperfeiçoamento do controle de demandas judiciais, por meio de um sistema informatizado para coletas de dados referentes aos principais pedidos, representação judicial, decisões proferidas, evidências fundamentadoras dos pedidos; (ii) realização de processo licitatório mais eficiente, consubstanciado num sistema de registro de preços de produtos e serviços já determinados por decisões judiciais em

exercícios anteriores, a fim que o município possa realizar uma programação prévia e despender valores menores na aquisição de bens e serviços de saúde; (iii) criação de câmara de mediação e conciliação vinculada ao órgão municipal de saúde, onde seja possibilitada a participação de todos os atores do sistema de saúde (gestores públicos, profissionais de saúde e especialistas), bem como agentes do sistema de justiça (membros do Judiciário e do Ministério Público e advogados públicos e privados); e (iv) instalação pelo TJMS e TRF3 de vara ou juizado especializado em questões de saúde, possibilitando, dessa forma, a inexistência de decisões conflitantes originadas de diversos juízos, bem como que os magistrados e demais atores do sistema de justiça tenham uma visão sistêmica e racional das demandas sanitárias.

O projeto de intervenção ora lavrado serviu como um instrumento de pesquisa e análise da realidade socioeconômica, histórica, geográfica e jurídica do sistema de saúde pública no município de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de expor a imperiosidade da resolução dos conflitos judiciais que pretendem cirurgias, exames, medicamentos dentre outros pedidos para atender o direito fundamental à saúde.

As propostas colocadas objetivam a diminuição do número de demandas judiciais em que se pleiteia cirurgias, exames, medicamentos e OPME (órtese, prótese e materiais especiais) ausentes das listas oficiais do SUS (sistema único de saúde) ou em desacordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a fim de que haja uma maior racionalidade na judicialização destes tipos de processos.

Neste contexto, o referido projeto de intervenção buscou ser uma tutela do Sistema Único de Saúde, expondo a necessidade de implantação das sugestões propostas para um enfrentamento da judicialização na cidade de Campo Grande, cuja população usuária pretende ter atendimento eficiente sem necessidade de buscar a solução via sistema judiciário.

Como observado, a judicialização da saúde apresenta-se como um grande desafio para todos os agentes do sistema de saúde e de justiça, tanto para os gestores públicos, os quais são obrigados a cumprir mandamentos judiciais, sem o devido planejamento prévio e mediante bloqueios de recursos públicos, bem como para o próprio Poder

Judiciário, em razão da quantidade expressiva de demandas judiciais em tramitação nas varas e juizados de fazenda pública.

Ao adotar as medidas de diagnóstico e enfrentamento da judicialização ora propostas, o Município de Campo Grande se aproxima da concretização do direito à saúde em sua dimensão coletiva, por meio da implementação de políticas sociais e econômicas que sirvam a todos usuários do SUS e não somente aos indivíduos que recorrem ao Poder Judiciário.

Referências

- 1 - Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS. **Medidas estratégicas garantem redução de 75% nos gastos com judicialização na saúde.** Agência Municipal de Notícias de Campo Grande [Internet]. [citado 31 de março de 2020]. Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/medidas-estrategicas-garantem-reducao-de-75-nos-gastos-com-judicializacao-na-saude/>.
 - 2 - Elias PMF, Magro RL. [Relatório Informativo]. Dados Gerais da Judicialização. **Relatório da Divisão de Demanda Judicial em Saúde.** Campo Grande: Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria Geral Jurídica; 2019.
 - 3 - Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS. **Comitê Estadual do Judiciário para a saúde.** Membros [Internet] [citado 29 de outubro de 2019]. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/comitedasaude/membros.php>.
 - 4 - Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS. **Portaria n.º 881, de 12 de fevereiro de 2016.** Aprova o Regulamento Interno do Núcleo de Apoio Técnico – NAT. Diário da Justiça N.º 3515 [Internet] [citado 29 de outubro de 2019]. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos/_nat/Portaria_NAT.pdf.
 - 5 - Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS. Secretaria Municipal de Saúde Pública. **Coordenadoria Jurídica - CATJUS e Defensoria Pública de MS discutem protocolos para análise de judicialização.** [Internet]. [citado 2 de abril de 2020]. Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/noticias/coordenadoria-juridica-catjus-e-defensoria-publica-de-ms-discutem-protocolos-para-analise-de-judializacao/>.
 - 6 - Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS. **Notícias. Evidências científicas subsidiam discussão sobre Judicialização da Saúde** [Internet] [citado 29 de outubro de 2019]. Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/evidencias-cientificas-subsidiaram-discussao-sobre-judicializacao-da-saude/>.
-

7 – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. **Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde. Núcleo de Apoio Técnico – NAT.** Projeto de Implantação dos Juizados Especiais da Saúde [internet]. Recomendação nº 02/2017. [citado 29 outubro 2019]. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/nat/recomendacoes/recomendacao_02-2017.pdf.

8 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS. **Núcleo de Apoio Técnico – NAT Jus.** Assessoria de Planejamento [Internet] [citado 31 de março de 2020]. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/nat/estatisticas/processos-2018-01-a-12.pdf.

9 – Município de Campo de Grande – MS. **Decreto 13.918, de 09 de julho de 2019.** Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial de Campo Grande n. 5620 [citado 31 de março de 2020]. Disponível em: <http://portal.capital.ms.gov.br/diagrande/diarioOficial>.

10 – Prefeitura Municipal de Campo Grande. Secretária Municipal de Saúde. Superintendência de Gestão do Cuidado. **Relatório – CATJUS/SGC/SESAU – Ações e Quantitativo de serviços e materiais não judicializados de julho a dezembro de 2019** - São Paulo, 2020 [citado 16 de janeiro de 2020]. Disponível na Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS.

11 – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde. **Núcleo de Apoio Técnico – NAT.** Projeto de Implantação dos Juizados Especiais da Saúde. São Paulo, 2019 [citado 29 outubro 2019]. Recomendação nº 03/2017. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/nat/recomendacoes/recomendacao_03-2017.pdf.

12 – Rosa, Tatiana. SES/SP compartilha software para organizar demandas judiciais. **Saúde em foco.** Outubro, novembro e dezembro de 2016. Edição 21. Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde. [citado em 20 fev 2020]. Disponível em: <http://www.conass.org.br/consensus/sessp-compartilha-software-para-organizar-demandas-judiciais/>.

13 – Brasil. Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 [Internet]. Brasília [citado em 20 maio 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm.

14 – Conselho Nacional de Justiça (CNJ). III Jornada do Direito à Saúde aprova 35 novos enunciados [Internet] [citado em 20 fev 2020]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/iii-jornada-de-direito-da-saude-aprova-35-novos-enunciados/>.

15 – Delduque MC, Castro EV de. **A Mediação Sanitária como alternativa viável à judicialização das políticas de saúde no Brasil**. Saúde Debate [Internet]. Rio de Janeiro, 2015 [acesso em 20 maio 2020], 39 (105): 506-513. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n105/0103-1104-sdeb-39-105-00506.pdf>.

16 – Modesto P, Cunha Junior LAP (coordenadores). **Terceiro Setor e Parceiras na Área de saúde**. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pp. 266-267.

17 – Brasil. **Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública [Internet]. Brasília [citado em 20 maio 2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>

18 – Souza LM. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos e a mediação de conflitos coletivos [Tese] [Internet]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. [citado 20 maio 2020]. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/94327/292011.pdf?owed=y>.

19 – Amaral G. Direito, **Escassez e Escolha**. Renovar: Rio de Janeiro, 2001, p. 270.



Projeto de intervenção em Jataí-GO

Diego Maurício Portela Dutra¹

Marcelo Almeida Fonseca Azevedo²

Márcio Rogério Silva Barros³

Maria José Machado de Souza⁴

Mona Lisa dos Santos Góes⁵

Renata de Melo Belarmino⁶

Vanessa Siqueira Aquiar⁷

Orientadora: Profa. Dra. Leticia Cabrini Giorotto

O presente trabalho de intervenção utilizou de uma metodologia de abordagem qualitativa, por meio de pesquisa de campo. Inicialmente foi realizado o mapeamento das demandas judiciais da saúde no município de Jataí-GO, desenvolvido diretamente nos processos judiciais relativos aos anos de 2018. Para essa finalidade foi utilizado um instrumento para coleta de dados, desenvolvido pelos autores deste trabalho, com base em seus conhecimentos prévios e revisão da literatura e aplicado junto à Secretaria Municipal de Saúde.

¹ Graduado em Enfermagem e Direito pela UESPI. Enfermeiro em Terapia Intensiva Pré-hospitalar no Município de Piripiri-PI.

² Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogado do COSEMS-MG.

³ Graduado em Direito pela Universidade de Rio Verde. assessor jurídico da SMS de Jataí-GO.

⁴ Graduada em Medicina Veterinária pela UFRA, e pós-graduada em Gestão da Vigilância Sanitária pelo Instituto de Ensino Sírio-Libanês/ PROAD-SUS. Médica Veterinária na Vigilância Sanitária de Marituba-PA.

⁵ Graduada em Farmácia pela URNE. Farmacêutica responsável pelo setor de judicialização de medicamentos da SMS de Maceió-AL.

⁶ Graduada em Direito pela FAMA. Assessora Técnica da Ouvidoria da SMS de Ferreira Gomes-AP.

⁷ Graduada em Direito pela Faculdade de Santa Terezinha em São Luís do Maranhão; e pós-graduada em Direito Público e em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade CEUMA. Advogada da SMS de Coratá-MA.

Após a aplicação do instrumento de coleta de dados, foi promovida a análise e consolidação dos dados, viabilizando uma classificação objetiva das demandas judiciais, apontando quais demandas são mais frequentes. Com base nesse levantamento, o trabalho foi desenvolvido em duas frentes, a primeira, na qual buscou responder se as demandas de judicialização de medicamentos no município possuem alternativas terapêuticas no SUS, qual gestor é responsável pela demanda e se já foram alvos de postura do Ministério da Saúde acerca de sua incorporação no SUS. Em outra frente, o trabalho identificou as demandas passíveis de correção, aperfeiçoando o planejamento das ofertas de serviço por parte da gestão.

Dessa forma, o trabalho tem como proposta, levantar, de maneira simples e de fácil replicação, a complexidade das demandas da saúde e a necessidade de, sempre que necessário, amparar-se em subsídios técnicos prévios à sentença judicial.

Diagnóstico da judicialização no município

O Direito à Saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 (32). Por meio de seus artigos 6º, que narra a saúde como um direito social; 196, que estabelece a garantia deste direito por meio da elaboração de políticas públicas sociais e econômicas; e 198 que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o direito das ações e serviços assistenciais universais, iguais e integrais. Nesse sentido, foi instituída também a Lei 8.080/1990 (33), que em seus artigos 2º, § 1º e 7º, inciso I, regulamentou a matéria respaldada pelo princípio básico da Universalidade, contribuindo com diversos fatores, para o aumento gradual da judicialização da Saúde no Brasil ao longo dos anos.

O fornecimento de medicamentos aos usuários do SUS também encontra previsão na Lei n. 8.080/90, art. 6º:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

- a) de vigilância sanitária;
- b) de vigilância epidemiológica;
- c) de saúde do trabalhador; e
- d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

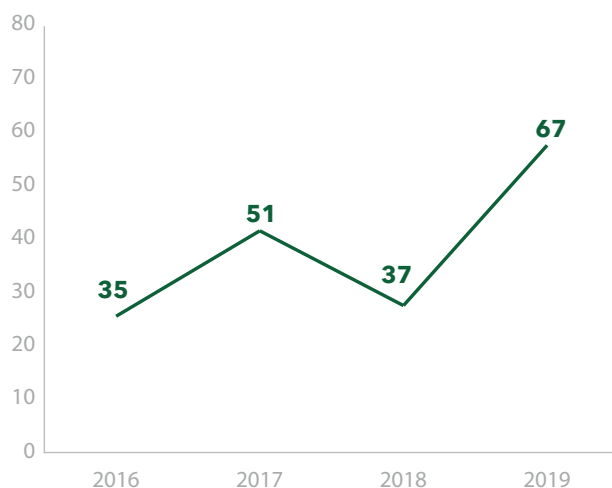
Embora todos os entes (União, Estados e Municípios) tenham papéis definidos no SUS, optou-se por atribuir especialmente aos municípios a execução das políticas de saúde, podendo ser conferido no art. 18, inciso I e III da Lei n.º 8.080/1990 e art. 30, VII (1).

Em razão disso, a judicialização da saúde, que é a busca ao Poder Judiciário, como última alternativa para obtenção de algum serviço de saúde indisponível no SUS, seja por falta de previsão legal, seja por questões orçamentárias, tornando-se muito significativa em face dos municípios, e vem preocupando gestores e juristas, pois pode conduzir a um desequilíbrio do orçamento, prejudicando políticas públicas já avançadas e efetivas (2).

Em Jataí, as determinações judiciais envolvem medicamentos, tratamento médico/cirurgias, exames, entre outros.

De 2016 a 2019, o número de ações judiciais que demandam tratamentos de saúde, segue uma trajetória crescente com uma média de 47,5 processos/ano (Figura 1). Em 2018, foi verificado o menor número de ações: 67, reflexo de iniciativas de mediação (3).

FIGURA 1. Número de ações judiciais em Jataí, de 2016 a 2019.



Fonte: Procuradoria Jurídica SMS de Jataí-GO.

Foi analisado o ano de 2018, e verificou-se que o município foi alvo de 37 processos judiciais que determinaram o fornecimento de medicamentos, cirurgias, exames e procedimentos médicos (Tabela 1). Com uma população estimada de 99.674 habitantes (4), o que representou um processo a cada 2.693 habitantes.

Dos 37 processos do ano de 2018, 31 representaram demandas de saúde por medicamentos e cirurgias, atingindo o percentual de 84% da demanda. Exames, suplementos e tratamentos médico-hospitalar representam apenas 16% das ações judiciais recebidas (Tabela 2).

TABELA 2. Número de Processos sobre Saúde/assunto (2018).

PLEITOS	QUANTIDADE
Fornecimento de medicamentos – SUS	15
Tratamento médico-hospitalar	02
Suplementos/dieta alimentar	02
Exames	02
Cirurgias	16
Total	37

Fonte: Procuradoria Jurídica SMS, Jataí-GO.

Foram analisados 15 processos que determinavam o fornecimento de medicamentos no ano de 2018, e verificou-se que foram solicitados 58 medicamentos no total, atingindo a média de 3,62 medicamentos por ação judicial. Dentre os medicamentos solicitados, merece destaque o pedido de seis ampolas de Nusinersena (Spinraza), cuja ampola, possui preço unitário de aproximadamente R\$ 300.000,00, totalizando R\$ 1.800.000,00, o tratamento (Tabela 3).

Considerando a Portaria de Consolidação N.º 6, de 28 de setembro de 2017 (5), que trata das transferências de recursos tripartite para o componente básico de assistência farmacêutica, o município de Jataí teve previsão anual de R\$10,3 *per capita*, totalizando R\$ 1.026.642,20.

Portanto, a ação judicial determinando o fornecimento do medicamento Nusinersena, para um único indivíduo, consumiu todo recurso do município para a assistência farmacêutica ofertada aos 99.674 habitantes.

O autor desse processo entrou com uma ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar com tutela de urgência, colocando o Município de Jataí/GO e o Estado de Goiás no polo passivo da ação (réu).

Assim, a Procuradoria Municipal apresentou contestação, pedindo a exclusão do município do polo passivo da demanda, justificada pela alta complexidade da patologia que acometia o autor e o alto custo do medicamento. Nesse sentido, foi apontada a

atribuição para o gestor estadual do SUS, e não do município, transferindo a competência para o estado, que pleiteou o direito de regresso contra a União, verdadeira responsável pelo ato.

As ações judiciais de cirurgias excederam as ações de medicamentos com 16 processos no ano de 2018. Todas essas ações judiciais foram cumpridas dentro da própria Rede de Saúde do Município. Esse fato caracterizou a procura do Poder Judiciário para o adiantamento do procedimento e não por ausência de oferta na Rede de Saúde, o que popularmente é denominado de “fura fila”.

Dentre essas ações, 62,5% (10) referiam-se a cirurgias ortopédicas. Para o município, a demanda judicial por cirurgia ortopédica trouxe a necessidade de rever o planejamento da oferta, os mecanismos de regulação e a elaboração de estratégias para conhecimento desta demanda previamente ao Poder Judiciário.

Ao analisar as duas únicas demandas por suplementos, foi verificado que ambas solicitavam o suplemento/fórmula nutricional destinado a dieta de portadores de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). Esse suplemento já teve avaliação da Conitec que recomendou a incorporação ao SUS, desde novembro de 2018, e até o presente momento não houve definição de qual ente seria responsável por sua aquisição. Considerando a complexidade do diagnóstico e tratamento da APLV, bem como, o custo de cada fórmula, dificilmente essa responsabilidade seria dada ao gestor municipal

No tocante aos exames, apenas foram solicitados eletrocardiograma, realizado na própria rede de saúde e o exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica que necessitou de aquisição extra, onerando os cofres públicos o montante de R\$10.700,00.

Dos tratamentos médicos judicializados, um determinou a realização de bloqueio facetário lombar, que é utilizado para aliviar a dor lombar do paciente e outro de tratamento de Ataxia Espinocerebelar. Esse último tratamento deve ser conduzido por equipe multidisciplinar, constituída idealmente por neurologista, oftalmologista, fisioterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista. Esses casos, deveriam possuir a cooperação de todos os entes gestores de saúde, por sua complexidade.

TABELA 3. Caracterização das principais solicitações judiciais para fornecimento de medicamento em Jataí.

MEDICAMENTO	INDICAÇÃO	OPÇÃO TERAPÊUTICA NO SUS (2018)
Nusinersene (Spiranza)	Atrofia Muscular Espinhal (AME)	NÃO
Cetuximabe	Câncer de colón	SIM
Omalizumabe	Asma alérgica/urticária crônica	SIM
Insulina Lantus	Diabetes	SIM
Ranibizumabe	Degeneração macular	SIM
Macitentan	Hipertensão arterial pulmonar	SIM
Icatibanto, Acetato	Angioedema Hereditário	SIM
Canibidiol	Epilepsia	SIM
Abiraterona	Câncer de próstata	SIM
Teriparatida	Osteoporose	SIM
Levetiracetam	Epilepsia	SIM
Bomba de Insulina	Diabetes	SIM
Solifenacina + Tansulosina	Hiperplasia Próstata	SIM

*preço máximo de venda de governo;

S/D: Sem definição

Fonte: Procuradoria Jurídica SMS Jataí-GO.

POSIÇÃO CONITEC	RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO	CUSTO MENSAL (R\$)
Recomendação de Incorporação com restrições no ano de 2019	Gestor federal	1.800.000,00
Não recomendado 2017	S/D	2.958,20
Não recomendado 2019	S/D	3.349,74
Não recomendado 2018	S/D	155,40
Incorporado o bevacizumabe	Tabela SUS	3.153,75 3
Não avaliado	S/D	2.755,88
Não recomendado 2015	S/D	37.477,58
Não avaliado	S/D	
Recomendação de Incorporação 2019	A definir	8.918,09
Não avaliado	S/D	2.070,35
Recomendação de Incorporação 2017	Gestor federal	336,29
Não recomendado 2018	S/D	18.000,0
Não avaliado	S/D	100,46

QUADRO 1. Demandas judiciais por cirurgias em Jataí.

	DESCRIÇÃO
1.	Cirurgia Ortopédica
2.	Cirurgia Ortopédica
3.	Cirurgia Ortopédica
4.	Cirurgia Vascular
5.	Cirurgia Cardiovascular
6.	Cirurgia Vascular
7.	Cirurgia Cardiovascular
8.	Cirurgia Ortopédica
9.	Cirurgia Ortopédica
10.	Cirurgia Oftálmica
11.	Cirurgia Oftálmica
12.	Cirurgia Ortopédica
13.	Cirurgia Ortopédica
14.	Cirurgia Ortopédica
15.	Cirurgia Ortopédica
16.	Cirurgia Ortopédica

Fonte: Procuradoria Jurídica SMS (25).

CARACTERIZAÇÃO

Fratura do calcâneo esquerdo

Fratura de Plato Tibial esquerdo e Fratura de Radio Distal esquerdo

Fratura de joelho

Doença arterial oclusiva e necrose de calcâneo e 5º pododáctilo do membro inferior esquerdo

Cirurgia de correção da Dissecção de Aorta Torácica Ascendente

Correção Doença aterosclerótica

Quadro grave de dissecção de aorta torácica descendente

Fratura da cabeça do Rádio esquerdo

Artroplastia total de quadril esquerdo

Catarata -opacidade parcial do cristalino

Catarata -opacidade parcial do cristalino

Artroplastia total de quadril esquerdo

Fratura perna direita, reconstrução do osso

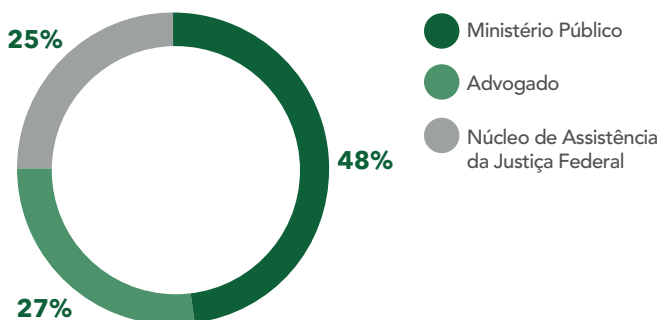
Fratura punho esquerdo

Artroplastia Toraco - Lombo - Sacra

Artroplastia total do Joelho direito

Da somatória das ações dirigidas ao Município de Jataí, 53% foram provenientes da Justiça Estadual de Goiás (TJGO) e os 25% restantes da Justiça Federal em Jataí (TRF-1). No tocante às modalidades para representação do autor, verificou-se que a maior demanda de processos judiciais é oriunda do Ministério Público (48%). Não existiu demanda proveniente da Defensorias Públicas. A Figura 2 é a representação gráfica do percentual de processos judiciais.

FIGURA 2. Percentual de processos judiciais por modalidade de representação em Jataí.

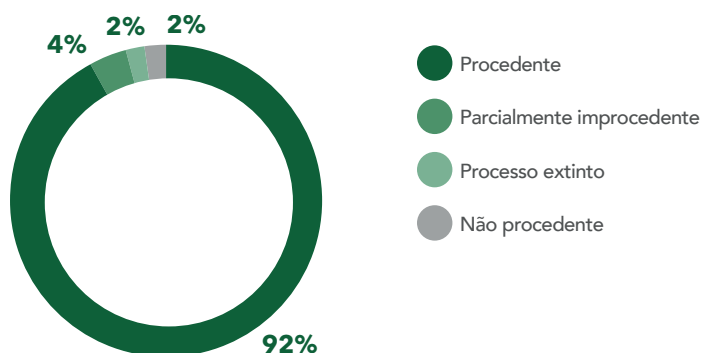


Fonte: Procuradoria Jurídica SMS Jataí-GO.

Levantou-se o questionamento de não haver demanda proveniente de Defensoria Pública, e por meio de pesquisa foi possível entender que não há defensoria pública em Jataí, em todo o Estado de Goiás, existe apenas quatro defensorias públicas, e, por causa dessa escassez, o Ministério Público assume essas demandas (7).

Dos 67 processos judiciais, 61 (92%) possuíam sentença favorável, declarando o pedido do autor procedente (decisão em primeiro grau). A Figura 3 representa essa distribuição.

FIGURA 3. Distribuição de processos por resultado da sentença final em Jataí.



Fonte: Procuradoria Jurídica SMS Jataí-GO.

Processos estratégicos de enfrentamento da judicialização

A Constituição Federal de 1988 (1) orienta que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros, concedendo-a de forma integral por meio de políticas sociais e econômicas. Contudo, por falta de ações no fornecimento a assistência a esse direito, o Poder Judiciário vem sendo acionado, ocasionando a judicialização desenfreada (8).

Assim, para atenuar tais incidentes, foi proposta a criação de um apoio técnico, o Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) ao Poder Judiciário (9)

O Núcleo de Assistência Técnica do Poder Judiciário (NatJus) foi originado com o intuito de auxiliar os magistrados na análise de demandas referente à área de Saúde, por causa do questionamento da ineficiência do Poder Executivo tendo em vista a crescente judicialização da Saúde, contudo, registra-se que não há existência do NatJus no município em estudo, sendo a estratégia desse projeto para diminuição da judicialização (10).

O primeiro NAT do país foi criado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nas 9ª e 10ª varas de fazenda pública, à frente da intensa judicialização da saúde no Estado, com a principal função de prestar auxílio técnico aos magistrados, o núcleo foi formado por uma equipe multidisciplinar, composta de médicos, farmacêuticos, nutricionistas e enfermeiros, as demandas ao chegar ao NAT seguem os seguintes trâmites (9):

São cadastrados e distribuídos à equipe multiprofissional para análise e posterior parecer técnico;

São posteriormente, encaminhados para uma revisão pela coordenação do Núcleo para serem destinados ao juiz que os enviou;

Tratando-se de requerimento de medicamentos, se os mesmos forem padronizados pelo SUS e estiverem disponíveis para aquisição, o paciente é orientado a de direcionar ao local responsável para sua entrega, impedindo, desta forma, que seja ajuizada uma ação para um procedimento acolhido pelo SUS (9).

Em análise a este episódio pode-se atestar que a adoção de medidas destinadas a melhor subsidiar os magistrados para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde, dentre as quais a criação de Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), é a forma concreta de aperfeiçoar procedimentos, reforçar a efetividade dos processos judiciais e prevenir novos conflitos.

Pode-se declarar, que a implementação dos NATs em alguns estados ocasionou uma economia aos cofres públicos e o combate a judicialização descontrolada pelo Poder Judiciário (9)

O CNJ, em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-libanês, lançou, em 31 de novembro de 2017, durante o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, o projeto e-NatJus (11).

O e-NatJus é uma plataforma de pareceres técnicos, com base em evidências científicas, produzidos por profissionais na área da saúde e visa auxiliar os juízes em suas decisões alusivas à área da saúde. Porém, diferente do NatJus, que possui alcance estadual, esta ferramenta tem abrangência nacional (9).

Convém enfatizar que o Tribunal de Justiça de Goiás instalou a Câmara de Saúde do Judiciário (CSJ) em 30 de janeiro de 2012, por meio da Portaria n.º 13/2012. Já o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário foi criado em 9 de abril de 2012, perante o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Justiça Federal, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e o Comitê Executivo Estadual do Fórum de Saúde do Judiciário (12).

Assim sendo, percebe-se, que o NatJus é um serviço de natureza consultiva que possibilita aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública subsídio técnico para solução das demandas judiciais. Ademais, o crescimento da judicialização da saúde em nosso país tem sido exponencial. O que certifica a importância no NatJus e do e-NatJus para auxiliar os operadores do direito a gerir tais demandas (9).

A mediação no município de Jataí teve início no dia 16 de março de 2018, com o intuito de legitimar a solução consensual das demandas sanitárias e ainda reduzir o fenômeno da judicialização da política pública da saúde (13).

Valendo-se do Programa e a Política Nacional de Incentivo à Atuação Resolutiva do Ministério Público Brasileiro – Recomendação CNMP n.º 54/2017 e Resolução CNMP n.º 118/2014 – a 2ª Promotoria de Justiça de Jataí, desenvolveu o programa de mediação sanitária, com a proposta de realizar audiências de mediação pré-processuais. Contou com a colaboração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCC), o qual colocou sua estrutura à disposição para o desenvolvimento das atividades, e o Poder Executivo local, com a participação de servidores, procuradores e do titular da Secretaria de Saúde. O objetivo era a construção de soluções negociadas e mais adequadas, reduzindo, como resultado, a judicialização. O atendimento era realizado semanalmente, com média de 5 a 6 audiências de mediação (13).

A Promotora Lucinéia Vieira Matos é uma estudiosa na área de saúde, e destacou que o processo é dinâmico e trata de procedimentos do SUS no âmbito do município. Segundo a promotora, as demandas mais comuns eram referentes a fornecimento de medicamentos, realização de exames, cirurgias, consultas, tratamento médico e até mesmo acompanhamento social ou psicológico (13).

Segundo a promotora Lucinéia Vieira Matos (13), os resultados têm se mostrado bem-sucedidos, e ressalta para o Ministério Público que:

O resultado estava sendo muito bom, inclusive porque o cidadão tinha a possibilidade de ser ouvido, com perspectiva de solução. E que este sistema também era vantajoso para a gestão. Isso porque ele tem como programar as demandas e a melhor forma de atendê-la, com planejamento administrativo e financeiro. Não sendo como uma ordem judicial que dá ao gestor da Secretaria Municipal de Saúde 24 horas. Para ela, outro aspecto positivo é que o gestor, ao conversar com o usuário, pode detectar as falhas no processo de atendimento, e, de posse dessas informações, melhorá-la (13).

A ideia foi, conforme a evolução do programa, o CEJUSCC passasse a atender diretamente o usuário, iniciando o pré-processo, mediante a intimação da Secretaria Municipal de Saúde. Essas expectativas não se cumpriram e a Promotora, a frente da comissão, representava o paciente e fazia o papel de mediadora, o que resultava na maioria das demandas uma desvantagem ao município (13).

Por fim, o Comitê de Mediação Sanitária realizou 141 audiências, 86 dessas no ano de 2018 e 55 somente no primeiro trimestre de 2019, quando teve paralisadas todas as atividades do Comitê de Mediação Sanitária, em virtude de mudanças na Promotoria de Justiça de Jataí, alterando a Promotoria que cuidara da pasta da Saúde, saindo da 2ª Promotoria de Justiça para a 4ª Promotoria de Justiça (14).

Com isso, é possível atestar que existia um núcleo que funcionava na Capital, esse fato levou à tentativa de manter a Comissão de Mediação do Ministério Público do Estado de Goiás com suas atividades em funcionamento, porém foram extintos em 2019.

Nesse sentido, constatou-se que a mediação foi um instrumento válido para conduzir conflitos das políticas públicas de saúde. A intervenção do mediador possibilitou equilibrar poderes e restabelecer o diálogo entre usuários e gestores. Por outro lado, a mediação não pode reparar todas as demandas, é preciso identificar também que as mediações analisadas foram realizadas e dirigidas pela Promotoria. Por isso, a defesa da mediação de conflitos no SUS deve revestir-se de importância como método de resistência em defesa de valores inclusivos, democráticos, de solidariedade e de equidade.

É importante lembrar que muitos usuários que dependem exclusivamente do SUS, frequentemente têm baixa capacidade de organização e de mobilização, e raramente têm suas reivindicações atendidas e seus direitos representados. Dessa forma, cabe ao Ministério Público, enquanto agente de transformação social, promover sua inclusão, para que eles sejam representados perante o SUS, e não sendo certo o Ministério Público fazer o papel de driblar a fila do SUS.

Outra relevante forma de atuação extrajudicial do Ministério Público consiste em tratativas com o ente municipal e aos profissionais de saúde, sendo possível ao Promotor de Justiça atuar para conscientizar os profissionais de saúde a dar preferência aos medicamentos previstos pelo SUS, sem, obviamente, limitar-lhes a liberdade de prescrição médica de acordo com as peculiaridades de cada paciente, bem como recomendar o ente municipal para que faça gestões para cumprir e fazer cumprir as normativas do SUS.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que os países estabeleçam uma lista básica de medicamentos para uso nos diversos níveis de atenção, dado que o volume cada vez maior de drogas disponíveis, a crescente complexidade da farmacoterapia, a maior sofisticação das técnicas de marketing pelas empresas farmacêuticas e os limitados recursos econômicos fazem que a definição de lista com critérios de racionalidade seja uma tarefa primordial (15); (16).

Assim, tanto a seleção como as atividades de programação, aquisição, armazenamento e distribuição constituem os pilares para garantir o acesso e o uso racional de medicamentos.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS (17).

Conforme o Decreto n.º 7.508/2011 (2) no art. 26. cita:

O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Além disso, a cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo Formulário Terapêutico Nacional e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (2).

O município de Jataí optou por utilizar a RENAME, com isso, cada nível de atenção solicita medicamentos que fazem parte da seleção da RENAME.

Como forma de ampliar o acesso a medicamentos e suplementos no âmbito do município de Jataí e de forma a garantir o uso racional de medicamentos e suplementos, foi criado o formulário de solicitação de medicamentos e o de fórmula nutricional, que consiste no requerimento de itens não disponibilizado pelo SUS, em caráter de excepcionalidade, esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas, sendo importante apresentar na literatura científica forte nível de evidência para sua utilização (anexo I e II).

A solicitação foi analisada e após deferimento foi realizado o processo de licitação. Os usuários que solicitam itens que foram licitados anteriormente recebem seu pleito imediatamente.

Esses formulários foram implantados como forma de reduzir a busca do judiciário pela população, tão logo, seja portador de uma prescrição médica. É um instrumento que visa acolher o cidadão sem a intermediação do judiciário e entrega ao gestor a possibilidade de oferecer assistência integral com respaldo científico.

Muitas falhas na gestão devem ser identificadas, debatidas e minimizadas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Outras que escaparam desse processo e foram acolhidas pelo poder judiciário, podem ser solucionadas no comitê com base em uma articulação entre os diferentes gestores.

Sanar o desconhecimento, por parte dos juízes, de como o SUS funciona e suas normativas é imprescindível, seja por meio de núcleos consultivos, comitê mediador ou audiências, para que haja uma redução no número de judicialização em face do município.

Sugere-se como estratégia, o NatJus, com finalidade de prestar auxílio técnico aos magistrados e promotores, promovendo conhecimento e informações específicas sobre saúde pública e município judicializado, facilitando as decisões judiciais, ou promovendo acordos e resoluções administrativamente.

Da mesma forma, propõe-se o melhoramento no funcionamento do Comitê de Mediação Sanitária, com propósito de resolução dos conflitos de forma administrativa, entende-se que assim, possa haver uma redução na judicialização em Jataí-GO

Por fim, tão importante como as medidas expostas, é analisar a maior demanda da população, uma vez que a judicialização pode ser utilizada como um indicador de acesso aos serviços de saúde e de alerta para novas necessidades de saúde. O resultado dessa análise deve subsidiar o planejamento e programação de Saúde do Município.

As demandas judiciais se transformaram em um problema de grande proporção, não só para o Judiciário, mas também para os Gestores do SUS e operadores do sistema de saúde, comprometendo a equidade do acesso aos serviços de saúde e a lógica financeira do sistema. A ausência de estratégia para acolher os anseios da população e a facilidade encontrada para acessar o Poder Judiciário acarreta um fluxo de usuários ao SUS sem previsibilidade, sem programação e por vezes sem critérios técnicos e científicos. Em todos esses casos, exige-se uma alocação extra de recursos que podem enfraquecer políticas públicas de saúde já efetivadas, sob a argumentação rasa garantia de efetivação de direitos e maior acesso do usuário do sistema público de saúde.

Como exemplo, podemos citar as demandas judiciais por cirurgias, no ano de 2018. Motivadas por ausência de vaga nas Instituições Hospitalares do município, seu cumprimento ocorreu inserindo-os na própria rede de saúde, porém, desrespeitando a fila de espera ou a existência de casos mais urgentes, trazendo consigo uma inversão no modus operandi do acesso, que doutrinariamente deve ser por nível de urgência ou programática.

Para Castro (18), cabe o questionamento: Só tem direito à saúde os que recorrem ao judiciário? E os que não tiveram esse recurso (o de levar seu problema à justiça)? Cabe aos magistrados determinar quem tem direito à saúde, quem pode ou não viver?

Diante desses fatos, não há dúvidas que o gestor de saúde precisa intensificar seu diálogo com o sistema de justiça – Judiciário e Ministério Público – na busca de soluções que não resultem em judicializações, soluções e acesso por via administrativa. Em casos inevitáveis e pontuais, onde a Judicialização seja estritamente necessária, que sejam decisões racionais elaboradas após instrumentalização dada por um corpo técnico.

Nesse sentido, é importante conhecer os direitos sociais, assegurado pela Constituição (1), as normativas do SUS e o processo de judicialização da saúde no município de Jataí/GO para elaborar estratégias que possam:

1. propiciar maior racionalização do uso dos recursos públicos.
2. sanar inconsistências técnicas nas demandas judiciais.
3. instrumentalizar os magistrados para garantir racionalidade nas decisões.
4. reduzir judicialização de medicamentos por “nome de marca do medicamento”
5. reduzir determinações judiciais para cumprimento de um ente, quando a responsabilidade já está definida para outro ente.
6. reduzir a busca da população para o poder judiciário.
7. incorporar demandas da população que se comprovam como realmente necessárias e que se fundamentam em bases científicas.
8. elaborar a Relação Municipal de medicamentos do Município – REMUME.
9. divulgar a REMUME elaborada no âmbito da Secretaria de Saúde, conselhos de classe, associações profissionais, população e poder judiciário.
10. divulgar a estratégia do município para reduzir a judicialização que são: o formulário de solicitação de medicamentos e o formulário de solicitação de suplementos, ambos padronizados pelo município.
11. redimensionar a demanda de leitos do município, identificando carências e ou necessidades de referências e/ou novas pactuações com o Gestor Estadual.

Uma das estratégias para o enfrentamento dessa problemática corresponde aos Núcleos de Apoio Técnico (NAT), constituídos para subsidiar tecnicamente os magistrados na

elaboração de um julgamento mais justo e por vezes, para oferecer uma solução administrativa ao paciente que utilizou o poder judiciário como porta de entrada do SUS.

O NAT teria a função de emitir pareceres técnicos sobre medicamentos, exames, consultas, cirurgias, procedimentos, dietas, suplementos e fórmulas infantis, entre outros insumos pleiteados. Seria também responsável, por informar ao poder judiciário sobre a organização do SUS.

Neste contexto, o NAT apresenta-se como a melhor estratégia de diálogo entre gestor e judiciário e sua atuação pode contribuir para:

1. reduzir o uso irracional de medicamentos por meio da elaboração de parecer com base em medicina de evidência.
2. Apresentar as opções de tratamento existentes no SUS.
3. inserir o usuário na Rede SUS do município.
4. identificar inconsistências nos pleitos de tratamento (exemplo: pleitos de alimentos, tratamentos que não tem correlação com CID apresentado etc.).
5. solicitar ao Poder Judiciário que os medicamentos pleiteados estejam prescritos pelo nome do princípio ativo, dentre outras propostas de ordenamento.
6. elaborar um banco de dados para o registro das principais demandas da população.
7. Desencadear a discussão sobre a necessidade da elaboração da REMUME - Jataí.
8. Identificar demandas de maior complexidade e encaminhar para discussão e possível pactuação nos canais de negociação do SUS.
9. Subsidiar a padronização de medicamentos, dietas, fórmulas e suplementos.
10. Subsidiar o processo de contratualização de serviços de saúde.

Deveras importante ressaltar que, apesar da criação do Núcleo de Mediação Sanitária e do seu resultado útil demonstrado com base em 2018, como meio de resolução e

maior acesso ao serviço de saúde, essa medida necessita de outras que potencializem os resultados, como criação de protocolos administrativos e Consultoria técnica para uma infinidade de situações, muita das vezes imprevisíveis, que só um corpo técnico qualificado pode atuar com embasamento necessário a resolução controversa.

A criação do NAT mesmo sendo vislumbrada no ano de 2012, não foi efetivada até o momento. O que é proposto e sugestionado pelo trabalho é a necessidade imperiosa de formação, composição e início das ações pelo NAT no município de Jataí-GO.

Considerações finais

Foi apresentado o diagnóstico da judicialização no município de Jataí-GO e os processos estratégicos de enfrentamento da judicialização no município.

Dessa forma, o trabalho teve por objetivo identificar a dimensão do processo de judicialização da saúde no município de Jataí-GO e sua complexidade para propor estratégias que reduzam ou superem os conflitos entre justiça e gestão da saúde.

No estudo foi reconhecido que os problemas da judicialização passam por desconhecimento das instituições, frente às disciplinas de direito sanitário, gestão pública e até de conhecimento científico.

Essa hipótese foi evidenciada, quando os dados da judicialização apontaram para grande parte da demanda judicial compreendendo os medicamentos não essenciais e de alto custo. Os medicamentos com essa complexidade, não são elencados para o ente municipal nas instâncias de pactuação do SUS e promove a desorganização da distribuição de competências dentro do sistema SUS, sobrecarrega a gestão municipal.

Como forma de reduzir a judicialização, o município implantou os formulários de solicitação de medicamentos e suplementos. Esses formulários representaram o compromisso da gestão em garantir o acesso a medicamentos não padronizados e o respeito aos profissionais que elaboraram prescrições fundamentadas em evidências científicas.

Foi destacada a iniciativa adotada pela municipalidade no enfrentamento da matéria em 2018, especialmente com a formação do corpo do Comitê de Mediação Sanitária o

NAT (Núcleo de Assessoria Técnica). Essa iniciativa apresentou resultados positivos, tendo contribuído para uma relevante redução das demandas.

O trabalho ofereceu a oportunidade de aprimorar a estratégia por meio de novas atribuições para o NAT, impedindo que os conflitos gerados no âmbito do SUS não chegassem a ser resolvidos necessariamente pelo Poder Judiciário (judicialização), já que não tem o domínio do conhecimento técnico para interferir na efetivação e gestão da política de saúde.

Sabemos que a judicialização da saúde é um meio legal que o cidadão utiliza para reclamar o não cumprimento do governo com os preceitos constitucionais. Porém, a judicialização excessiva pode ser um obstáculo para a consolidação da política de saúde.

Concluimos este trabalho, sugerindo estudo aprofundado das determinações judiciais, sua efetividade e impacto na redução da morbimortalidade, especialmente no tocante ao tratamento do câncer e doenças raras. Que esses estudos sejam apresentados e debatidos em todas as instâncias de controle social.

Referências

- 1 – Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- 2 – Nakamura FC. **Judicialização da saúde: em busca de uma contenção saudável Jusbrasil**. 2015 [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://nandaninna.jusbrasil.com.br/artigos/179349219/judicializacao-da-saude-em-busca-de-uma-contencao-saudavel>.
- 3 – Jataí. **Procuradoria Geral** [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.jatai.go.gov.br/procuradoria-geral/>.
- 4 – IBGE. Brasil: **Área Territorial Oficial 2011** [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/jatai/panorama>.
- 5 – Brasil, Ministério da Saúde. **Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011** [Internet]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html.
- 6 – Ministério da Saúde - Conitec. **Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca**. [Internet]. 2014 [citado 14 jul. 2020]. Disponível em: <http://conitec.gov.br>.
- 7 – Goiás Defensoria Pública do Estado de Goiás. [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: http://www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=115.
- 8 – Diário Oficial da União. **Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990**. [Internet]. 1990 [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.
- 9 – Conselho Nacional de Justiça. **Sistema e-NatJus** [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/e-natjus/>.
- 10 – Costa RS. **A judicialização da saúde no Brasil: uma análise à luz do acesso a medicamentos de alto custo e da propriedade intelectual**. Anápolis-GO.
- 11 – Duarte MPDBCS. **Judicialização da saúde: a visão do poder executivo**. São Paulo: Saraiva; 2017. 738 p.
- 12 – Goiás T de J do E de. **Apresentação** [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.tjgo.jus.br/index.php/nucleo-da-judicializacao-da-saude/apresentacao>.

13 - Goiás Ministério Público do Estado de Programa de mediação sanitária é inaugurado com 80% de resolução em Jataí [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/programa-de-mediacao-sanitaria-e-inaugurado-com-80-de-resolucao-em-jatai#.Xw7wuyhKhPZ>.

14 – Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação no 6, de 28 de setembro de 2017. [citado 15 jul. 2020];668. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf>.

15 – Brasil Ministério da Saúde. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-basico-da-assistencia-farmaceutica-cbaf>.

16 – Brasil. Anvisa. preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para compras públicas preço fábrica e preço máximo de venda ao governo [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em www.bps.saude.gov.br.

17 – Brasil Ministério da Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) [Internet]. [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/rename>.

18 – Castro KR de. Os juízes diante da judicialização da saúde: o NAT como instrumento de aperfeiçoamento de decisões judiciais na área da saúde [Internet]. Rio de Janeiro; 2012 [citado 15 jul. 2020]. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9769>.





